

ICS
INDONESIAN CODING STANDARD
PEDOMAN
PENGGKODEAN IDRG
VERSI 1 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR GAMBAR.....	14
DAFTAR TABEL.....	16
DAFTAR SINGKATAN.....	17
GLOSARIUM.....	18
CHAPTER I INDONESIAN DIAGNOSIS RELATED GROUP (iDRG).....	19
CHAPTER II KETENTUAN UMUM KODING iDRG.....	23
2.1 Ketentuan Umum Pengkodean (Coding) iDRG.....	23
2.1.1 Diagnosis Utama.....	23
2.1.2 Diagnosis Sekunder.....	28
2.1.3 Sumber Daya.....	31
2.1.4 Penyebab Luar (External Cause).....	31
2.2 Aturan Koding Morbiditas ICD-10 Versi Tahun 2010:.....	33
2.2.1 Rule MB1.....	33
2.2.2 Rule MB2.....	34
2.2.3 Rule MB3.....	35
2.2.4 Rule MB4.....	36
2.2.5 Rule MB5.....	37
2.2.6 Aturan Koding Spesifik.....	37
2.3 Pengodean Prosedur / Tindakan.....	53
2.3.1 Aturan dalam pengodean Tindakan / Prosedur.....	53
2.3.2 Kode Tindakan / Prosedur Operasi.....	56
2.4 Pendokumentasian Klinis.....	58
2.4.1 Gunakan Istilah Diagnosis Paling Spesifik.....	58
2.4.2 Hindari Penggunaan Singkatan.....	59
2.5 Hal - Hal yang harus dilakukan Pengode dalam memberikan kode diagnosis atau tindakan/prosedur.....	59
2.5.1 Prinsip Pengodean Diagnosis.....	59
2.5.2 Penentuan Kode Berdasarkan Dokumentasi.....	61
2.5.3 Bukti Pendukung yang sah saat menentukan kode diagnosis:.....	62
2.5.4 Bukti pendukung yang Tidak Sah untuk menentukan kode diagnosis:.....	62
2.6 IM Pada ICD-10 dan ICD 9 CM.....	62
CHAPTER III KETENTUAN & PERHATIAN KHUSUS KODING iDRG.....	65
3.1 MDC 11 Sistem Syaraf.....	65
PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 11.....	65
PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 11.....	66
3.1.1 Meningitis (G00-G03).....	66
3.1.2 Encephalitis And Myelitis (G04-G05).....	66
3.1.3 Intracranial And Intraspinal Abscess And Granuloma (G06-G07).....	67
3.1.4 Sequelae of inflammatory diseases of central nervous system (G09).....	67
3.1.5 Parkinsonism (G20-G22).....	68

copyright@ Pusat pembiayaan kesehatan Kemenkes RI.

Dilarang mengcopy atau memperjualbelikan dokumen ini dalam bentuk apapun

3.1.6 Dystonia (G24).....	69
3.1.7 Alzheimer's Disease (G30).....	70
3.1.8 Epilepsy, Seizures, and Convulsion (G40-G41, R56.8).....	70
3.1.9 Migraine and Headache (G43-G44).....	71
3.1.10 Transient Ischaemic Attack (TIA) (G45).....	71
3.1.11 Sleep Apnea Obstructive and Snoring (G47.3, R06.5).....	71
3.1.12 Cranial Nerve Disorders (G50-G53).....	72
3.1.13 Polyneuropathy (G61-G63).....	73
3.1.14 Myopathy (G70-G73).....	74
3.1.15 Sindrom Paralitik (G81–G83).....	74
3.1.16 Hydrocephalus (G91, G94, Q03).....	76
3.1.17 Cerebrovascular Accident (CVA) (I60-I64).....	77
3.1.18 Other Cerebrovascular Disease (I65-I68).....	78
3.1.19 Sequelae of Cerebrovascular Diseases (I69.-).....	78
3.2 MDC 12 MATA & ADNEXA.....	80
PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 12.....	80
PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 12.....	80
3.2.1 Conjunctivitis (H10.-).....	80
3.2.2 Pinguecula and Pterygium (H11.0–H11.1).....	81
3.2.3 Corneal Scar (H17).....	83
3.2.4 Contact Lens Intolerance.....	83
3.2.5 Ice Syndrome (H18.2, H21.2).....	83
3.2.6 Uveitis (H20-H22, H30, H32).....	84
3.2.8 Retinal Procedures.....	88
3.2.9 Cataract (H25-H26).....	89
3.2.10 Aphakia (H27.0).....	92
3.2.11 Refractive Error (H52).....	92
3.2.12 Visual Impairment (H54.-).....	92
3.2.13 Operasi Trabekulotomi.....	94
3.3 MDC 13 TELINGA, MULUT, TENGGOROKAN.....	95
PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 13.....	95
PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 13.....	99
3.3.1 Otitis Externa (H60.-).....	99
3.3.3 Cholesteatoma (H71).....	100
3.3.4 Perforation Of Tympanic Membrane (H72.-).....	101
3.3.5 Vertigo (H81, R42).....	101
3.3.6 Hearing Loss (H90-H91).....	102
3.3.7 Rhinitis (J00, J30, J31.0).....	104
3.3.8 Sinusitis (J01, J32).....	104
3.3.9 Tonsillectomy.....	106
3.3.10 Hoarseness.....	106
3.4 MDC 14 SISTEM PERNAFASAN.....	108
PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 14.....	108
PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 14.....	109

3.4.1 Influenza (J09-J11).....	109
3.4.2 Pneumonia (J12-J18, J69).....	109
3.4.3 Bronchitis (J20, J40-J42).....	112
3.4.4 Stenosis Laryngotracheal (J38.6, J39.8, J95.5).....	112
3.4.5 Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) (J44.-).....	113
3.4.6 Asthma (J45-J46).....	114
3.4.7 Bronchiectasis (J47).....	114
3.4.8 Lung Diseases Due To External Agents (J60-J66).....	114
3.4.9 Hypersensitivity Pneumonitis Due To Organic Dust (J67.-).....	114
3.4.10 Respiratory Conditions Due To External Agents (J68.-, J70.-).....	115
3.4.11 Adult Respiratory Distress Syndrome (ARDS) (J80).....	115
3.4.12 Abscess Of Lung (J85).....	115
3.4.13 Pleural Effusion (J90-J91).....	116
3.4.14 Pneumothorax (J93.-).....	117
3.4.15 Chylothorax (J94.0, J95.6).....	117
3.4.16 Haemothorax (J94.2).....	117
3.4.17 Granuloma Laryngeal Due To Intubation (J95.8).....	118
3.4.18 Respiratory Failure (J96.-).....	118
3.4.19 Emphysema Subcutan (J98.2).....	118
3.5 MDC 15 JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH.....	119
PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 15.....	119
3.5.1 Heart Valve Disease (I05-I09, I34-I39).....	123
3.5.2 Primary and Secondary Hypertension (I10 dan I15).....	123
3.5.3 Hypertensive Heart and Renal Disease (I11-I13).....	125
3.5.4 Acute Myocardial Infarction (I21-I22).....	126
3.5.5 Complications Following Acute Myocardial Infarction (I23.-).....	127
3.5.6 Chronic Ischaemic Heart Disease (I25.-).....	128
3.5.7 Pulmonary Heart Disease (I27.-).....	129
3.5.8 Pericarditis (I30-I32).....	129
3.5.9 Infective Endocarditis (I33, I39).....	130
3.5.10 Myocarditis (I40-I41).....	131
3.5.11 Cardiomyopathy (I42-I43).....	132
3.5.12 Heart Block (I44-I45).....	132
3.5.13 Cardiac Arrest (I46).....	133
3.5.14 Ventricular Fibrillation and Flutter (I49.0).....	133
3.5.15 Heart Failure (I50.-).....	134
3.5.16 Peripheral Vascular Disease (I70, I73).....	134
3.5.17 Arterial Embolism and Thrombosis (I74.-).....	135
3.5.18 Phlebitis and Thrombophlebitis (I80.-).....	135
3.5.19 Oesophageal Varices (I85.-, I98.2 - I98.3).....	136
3.5.20 Gastric Varices (I86.4).....	136
3.5.21 Circulatory Disease Procedures.....	137
3.6 MDC 16 SALURAN PENCERNAAN.....	140
PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 16.....	140

PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 16.....	141
3.6.1 Embedded and Impacted Teeth (K01.-).....	142
3.6.2 Dental Caries (K02.-).....	142
3.6.3 Diseases Of Pulp And Periapical Tissues (K04.-).....	143
3.6.4 Cellulitis And Abscess Of Mouth (K12.2).....	143
3.6.5 Oesophagitis And Oesophageal Ulcer (K20, K22.1).....	144
3.6.6 Oesophageal Obstruction (K22.2).....	145
3.6.7 Perforation Of Oesophagus (K22.3).....	145
3.6.8 Dyskinesia Of Oesophagus (K22.4).....	146
3.6.9 Diverticulum Of Oesophagus (K22.5).....	146
3.6.10 Gastro-Oesophageal Laceration-Haemorrhage Syndrome (K22.6).....	146
3.6.11 Tuberculous Oesophagitis (K23.0*).....	146
3.6.12 Ulcer And Dyspepsia (K25-K28, K30).....	147
3.6.13 Gastritis And Duodenitis (K29.-).....	147
3.6.14 Other Diseases Of Stomach And Duodenum (K31.-).....	148
3.6.15 Appendicitis (K35-K37).....	148
3.6.16 Hernia (K40-K46).....	149
3.6.17 Noninfective Enteritis And Colitis (K50-K52).....	149
3.6.18 Allergic And Dietetic Gastroenteritis And Colitis Due To Cow's Milk Protein (K52.20)	149
3.6.19 Vascular Disorders Of Intestine (K55.-).....	150
3.6.20 Paralytic Ileus And Intestinal Obstruction Without Hernia (K56.-).....	150
3.6.21 Diverticular Disease Of Intestine (K57.-).....	150
3.6.22 Other Functional Intestinal Disorders (K59.-).....	150
3.6.23 Diseases Of Anus And Rectum (K60-K62).....	151
3.6.24 Other Diseases Of Intestine (K63.-).....	151
3.6.25 Peritonitis (K65, K67).....	152
3.6.26 Hemoperitoneum (K66.1).....	152
3.6.27 Intestinal Malabsorption (K90.-).....	152
3.6.28 Postprocedural Disorders Of Digestive System (K91.-).....	152
3.6.29 Gastrointestinal Haemorrhage (K92.0-K92.2).....	153
3.6.30 Gastrointestinal Procedures.....	153
3.7 MDC 17 HEPATOBILIER DAN PANKREAS.....	154
PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 17.....	154
PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 17.....	156
3.7.1 Alcoholic Liver Disease (K70.-).....	156
3.7.2 Toxic Liver Disease (K71.-).....	156
3.7.3 Hepatic Failure And Encephalopathy (K72.-).....	157
3.7.4 Cirrhosis of Liver (K74.3-K74.6).....	157
3.7.5 Abscess Of Liver (K75.0).....	158
3.7.6 Peliosis Hepatis (K76.4).....	158
3.7.7 Liver Disorders In Diseases Classified Elsewhere (K77.-*).....	158
3.7.8 Cholelithiasis And Diseases Of Biliary Tract (K80-K83).....	159
3.7.9 Pancreatitis (K85, K86.0, K86.1, K87).....	159

3.8 MDC 18 MUSKULOSKELETAL DAN JARINGAN IKAT.....	162
PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 18.....	162
PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 18.....	164
3.8.1 Pyogenic Arthritis (M00-M01).....	164
3.8.2 Reactive Arthropathies (M02-M03).....	165
3.8.3 Rheumatoid Arthritis (M05-M06).....	165
3.8.4 Psoriatic And Enteropathic Arthropathies (M07).....	165
3.8.5 Juvenile Arthritis (M08-M09).....	166
3.8.6 Gout And Crystal Arthropathies (M10-M11).....	166
3.8.7 Polyarthritis And Monoarthritis (M13.0 - M13.1).....	167
3.8.8 Coxarthrosis [Arthrosis Of Hip] (M16).....	168
3.8.9 Gonarthrosis [Arthritis Of Knee] (M17).....	172
3.8.10 Acquired Clawhand, Clubhand, Clawfoot, And Clubfoot (M21.5, Q66.0).....	175
3.8.11 Disorders Of Patella (M22).....	176
3.8.12 Chronic Instability Of Knee (M23.5).....	177
3.8.13 Haemarthrosis (M25.0).....	179
3.8.14 Polyarteritis Nodosa And Vasculopathies (M30-M31).....	180
3.8.15 Systemic Lupus Erythematosus (M32).....	180
3.8.16 Systemic Sclerosis (M34).....	181
3.8.17 Scoliosis (M41).....	181
3.8.18 Spondylolisthesis (M43.1, Q76.2).....	186
3.8.19 Spondylosis (M47).....	187
3.8.20 Intervertebral Disc Disorders (M50-M51).....	189
3.8.21 Spine Fusion And Instrumentation.....	192
3.8.22 Spontaneous Fracture (M48.4, M48.5, M80, M84.3, M84.4).....	195
3.8.23 Fracture In Neoplastic Disease (M49.5, M90.7).....	196
3.8.24 Rhabdomyolysis (M62.8).....	196
3.8.25 Radial Styloid Tenosynovitis [De Quervain] (M65.4).....	196
3.8.26 Necrotizing Fasciitis (M72.6).....	197
3.8.27 Fibromyalgia (M79.7).....	197
3.8.28 Myofascial Pain Syndrome (M79.8).....	197
3.8.29 Osteoporosis (M80-M82).....	198
3.8.30 Nonunion Of Fracture [Pseudarthrosis] (M84.1, M96.0).....	198
3.8.31 Periprosthetic Fracture (M96.6).....	198
3.9 MDC 19 KULIT DAN SUBKUTAN.....	200
PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 19.....	200
PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 19.....	201
3.9.1 Impetigo (L01.-).....	201
3.9.2 Cutaneous Abscess, Furuncle, and Carbuncle (L02.-).....	201
3.9.3 Cellulitis (L03.-).....	202
3.9.8 Pemphigoid (L12.-).....	202
3.9.9 Atopic Dermatitis (L20.-).....	203
3.9.12 Irritant Contact Dermatitis (L24.-).....	203
3.9.13 Dermatitis due to Substances Taken Internally (L27.-).....	203

3.9.14 Psoriasis (L40.-).....	204
3.9.15 Lichen Planus (L43.-).....	204
3.9.16 Urticaria (L50.-).....	204
3.9.17 Erythema Multiforme (L51.-).....	204
3.9.18 Erythema Nodosum (L52).....	205
3.9.19 Other Erythematous Conditions (L53-L54).....	206
3.9.24 Alopecia (L63-L66).....	206
3.9.26 Hypertrichosis (L68.-).....	206
3.9.28 Vitiligo and Other Disorders of Pigmentation (L80-L81).....	207
3.9.29 Epidermal Thickening (L82-L86).....	207
3.9.30 Transepidermal Elimination Disorders (L87).....	207
3.9.31 Pyoderma Gangrenosum (L88).....	208
3.9.32 Decubitus Ulcer and Pressure Area (L89).....	208
3.9.33 Atrophic Disorders of Skin (L90).....	209
3.9.34 Hypertrophic Scar (L91.0).....	209
3.9.35 Granulomatous Disorders (L92).....	210
3.9.36 Lupus Erythematosus (L93).....	210
3.9.37 Localized Connective Tissue Disorders (L94).....	211
3.9.38 Vasculitis Limited to Skin (L95).....	212
3.9.39 Ulcer of Lower Limb (L97).....	212
3.9.40 Disorders of Skin and Subcutaneous Tissue (L98).....	213
3.10 MDC 20 ENDOKRIN, NUTRISI DAN METABOLIK.....	214
PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 20.....	214
PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 20.....	215
3.10.1 Hypothyroidism (E03.-).....	215
3.10.2 Thyrotoxicosis [Hyperthyroidism] (E05.-).....	215
3.10.3 Thyroiditis (E06.-).....	216
3.10.4 Diabetes Mellitus (E10-E14).....	216
3.10.5 Hypoglycaemic (E15-E16).....	222
3.10.6 Disorder of Pancreatic Internal Secretion (E16.3-E16.9).....	223
3.10.7 Hyperparathyroidism (E21.0-E21.3, E83.5).....	223
3.10.8 Hyperfunction of Pituitary Gland (E22, E24.0).....	223
3.10.9 Cushing' Syndrome (E24.-).....	223
3.10.10 Hyperaldosteronism (E26.-).....	224
3.10.11 Primary Adrenocortical Insufficiency (E27.1).....	224
3.10.12 Adrenomedullary Hyperfunction (E27.5).....	224
3.10.13 Androgen Excess (E28.1).....	225
3.10.14 Testicular Hypofunction (E29.1).....	225
3.10.15 Disorders of Puberty (E30.-).....	225
3.10.16 Carcinoid Syndrome (E34.).....	225
3.10.17 Sequelae of Malnutrition and Other Nutritional Deficiencies (E64.-) & Sequelae of Hyperalimentation (E68).....	226
3.10.18 Disorders of Lipoprotein Metabolism (E78.-).....	226
3.10.19 Hyperuricemia (E79.0).....	226

3.10.20 Disorders of Calcium Metabolism (E83.5).....	226
3.10.21 Amyloidosis (E85.-).....	227
3.10.22 Volume Depletion and Fluid Overload (E86, E87.7).....	227
3.10.23 Hypernatremia and Hyponatremia (E87.0-E87.1).....	227
3.10.24 Acidosis (E87.2).....	227
3.10.25 Alkalosis (E87.3).....	227
3.10.26 Hyperkalemia and Hypokalemia (E87.5-E87.6).....	228
3.10.27 Lipodystrophy (E88.1).....	228
3.11 MDC 21 DISEASE AND DISORDERS OF THE KIDNEY AND URINARY TRACT.....	229
PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 21.....	229
PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 21.....	230
3.11.1 Glomerular diseases (N00-N08).....	230
3.11.2 Obstructive And Reflux Uropathy (N13.-).....	231
3.11.3 Renal Tubulo-Interstitial Disorders (N14-N16).....	231
3.11.4 Acute Renal Failure (N17.-).....	232
3.11.5 Chronic Kidney Disease (N18.-).....	233
3.11.6 Urolithiasis N20-N23.....	233
3.11.7 Contracted And Small Kidney (N26-N27).....	235
3.11.8 Cyst Of Kidney (N28.1, Q61).....	235
3.11.9 Neuromuscular Dysfunction Of Bladder (N31.-).....	235
3.11.10 Bladder-Neck Obstruction (N32.0).....	236
3.12 MDC 22 SISTEM REPRODUKSI PRIA.....	237
Perhatian Khusus Terkait Penginputan iDRG MDC 22.....	237
Dalam proses pengkodean tindakan medis di MDC ini, terdapat kode Indonesian Modification (IM) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mendokumentasikan tindakan khusus dengan lebih akurat. Beberapa kode Indonesian Modification yang digunakan antara lain:.....	237
60.50 Laparoscopic radical prostatectomy (IM).....	237
64.970 Revision artificial erection device (IM).....	237
17.25 Laparoscopic repair inguinal hernia (IM).....	237
63.10 Microligation for varicocele (IM).....	237
63.11 Laparoscopic varicocele ligation (IM).....	237
86.060 Insertion prostatic stent/coil with ultrasound control (IM).....	237
86.061 Insertion prostatic stent/coil with visual (IM).....	237
60.22 Transurethral needle ablation prostate (IM).....	237
60.23 Cryoablation of prostate (IM).....	237
60.24 Transurethral electric vaporization prostate (IM).....	237
60.25 High intensity focused ultrasound prostate (IM).....	237
51.120 Laparoscopic biopsy gonad (IM).....	237
60.290 Transurethral resection of ejaculatory duct (TURED) (IM).....	237
62.31 Laparoscopic orchiectomy (IM).....	237
62.50 Laparoscopic orchidopexy (IM).....	237
62.52 Laparoscopic orchidopexy fowler stephen (IM).....	237
99.960 Microsurgical testicular sperm extraction (micro-TESE) (IM).....	237

Detail lengkap mengenai kode Indonesian Modification dapat dilihat dalam daftar yang telah diterbitkan oleh Kemenkes RI. Penggunaan kode IM wajib dilakukan sesuai dengan tindakan yang terdokumentasi dalam rekam medis pasien untuk memastikan akurasi dan validitas data.....	237
Pemanfaatan kode IM ini sangat penting dalam pengembangan sistem DRG (Diagnosis Related Group) kedepannya, untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data pembiayaan kesehatan nasional.....	237
Selain itu, terdapat DRG khusus untuk tindakan pada MDC 22 yang dilakukan dengan teknik laparoskopi, khususnya untuk tindakan prostatektomi, yaitu "Radical Prostatectomy Proc. w Laparoscopy". Untuk tindakan radikal prostatektomi yang dilakukan dengan teknik laparoskopi, diwajibkan menggunakan kode tindakan 60.50 Laparoscopic radical prostatectomy (IM).....	238
3.12.1 Hyperplasia of Prostate (N40).....	238
3.13 MDC 23 SISTEM REPRODUKSI WANITA.....	239
PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 23.....	239
PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 23.....	239
3.13.1 Inflammatory Disease Of Female Pelvic Organs (N70-N74).....	239
3.13.2 Female Pelvic Peritoneal Adhesions (N73.6).....	242
3.13.3 Disease Of Bartholin's Gland (N75).....	242
3.13.4 Other Inflammation Of Vagina And Vulva (N76-N77).....	245
3.13.5 Endometriosis (N80.-).....	246
3.13.6 Prolapsus Genital (N81).....	246
3.13.7 Torsion Of Ovary, Ovarian Pedicle And Fallopian Tube (N83.5).....	247
3.13.8 Cyst Of Ovary (N83.0-N83.2).....	249
3.13.9 Hyperplasia Endometrial (N85.0-N85.1).....	249
3.13.10 Dysplasia Of Cervix Uteri (N87.-).....	250
3.13.11 Leucorrhoea (N89.8).....	250
3.13.12 Postcoital And Contact Bleeding.....	251
3.13.13 Vaginal Bleeding (N93.8-N93.9).....	253
3.13.14 Menopause (N95).....	254
3.13.15 Habitual Aborter (N96).....	254
3.13.16 Female Infertility (N97.-).....	254
3.14 MDC 24 KEHAMILAN, PERSALINAN DAN NIFAS.....	256
PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 24.....	256
PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 24.....	258
3.14.1 Ectopic Pregnancy (O00).....	258
3.14.2 Abortion (O03-O08).....	260
3.14.3 Termination of Pregnancy (O04.- O05).....	267
3.14.4 Gangguan Hipertensi (O10-O16).....	268
3.14.5 Excessive Vomiting in Pregnancy (O21.-).....	269
3.14.6 Infections of Genitourinary Tract in Pregnancy (O23, O41.1, O85, O86, O98).....	270
3.14.7 Diabetes Mellitus in Pregnancy (O24).....	273
3.14.8 Maternal Care for Known or Suspected Malpresentation of Fetus (O32.-).....	274
3.14.9 Maternal Care For Known Or Suspected Disproportion (O33.-, O64-O66).....	275
3.14.10 Maternal Care for Tumour of Corpus Uteri (O34.1).....	277

3.14.11 Maternal Care for Other Abnormalities of Cervix (O34.4).....	278
3.14.12 Premature Rupture of Membranes (O42.)-.....	279
3.14.13 False Labour (O47,-).....	280
3.14.14 Preterm Labour and Delivery (O60.-).....	282
3.14.15 Intrapartum Haemorrhage and Postpartum Haemorrhage (O67,-, O72.-).....	284
3.14.16 Fetal Distress (O68.-).....	286
3.14.17 Perineal and Vaginal Laceration during Delivery (O70.-, O71.4).....	286
3.14.18 Delivery (O80-O84).....	286
3.14.19 Caesarean section (O82.-).....	290
3.14.20 Maternal Diseases Classifiable Elsewhere but Complicating Pregnancy, Childbirth and The Puerperium (O98.-, O99.-).....	294
3.14.21 Penjelasan Kombinasi Kode yang Tidak Dapat Diterima pada MDC 24.....	297
3.15 MDC 25 PERINATOLOGI.....	309
PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 25.....	309
PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 25.....	309
3.15.2 Neonatus (Bayi baru lahir).....	309
3.15.3 Fetus and Newborn Affected by Maternal Factors and by Complications of Pregnancy, Labour and Delivery (P00-P04).....	310
3.15.4 Slow Fetal Growth and Fetal Malnutrition (P05).....	311
3.15.5 Disorders Related to Short Gestational Age and Low Birth Weight, Not Elsewhere Classified (P07.-).....	313
3.15.6 Birth Injury to Spine (P11.5, P13).....	314
3.15.7 Birth Asphyxia (P21.-).....	314
3.15.9 Congenital Pneumonia (P23.-).....	315
3.15.10 Neonatal Aspiration of Meconium (P24.0).....	316
3.15.11 Haemolytic Diseases of Fetus and Newborn (P55, P58-P59).....	316
3.15.12 Syndrome Of Infant Of Mother With Gestational Diabetes (P70.0-P70.1).....	317
3.16 MDC 26 PENYAKIT PADA DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK DARAH... 318	
PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 26.....	318
PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 26.....	318
3.16.1 Pengambilan dan Transplantasi Sel Induk / Sumsum Tulang.....	318
3.16.2 Anemia (D50-D64).....	319
3.16.3 Other Aplastic Anaemias (D61.)-.....	320
3.16.4 Gangguan Koagulasi (D65-D69).....	321
3.16.5 Non-Thrombocytopenic Purpura (D69.0-D69.2).....	322
3.16.6 Agranulocytosis.....	322
3.17 MDC 27 PENYAKIT DAN GANGGUAN PROLIFERATIF.....	324
PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 27.....	324
PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 27.....	324
3.17.1 Malignant Neoplasms Of Lymphoid, Haematopoietic And Related Tissue (C81-C96)....	324
3.18 MDC 28 PENYAKIT INFEKSI DAN PARASIT.....	326
PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 28.....	326
PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 28.....	333

3.18.1 Other Salmonella Infections (A01-A02).....	333
3.18.2 Enteroinvasive Escherichia Coli Infection (A04.0-A04.4).....	334
3.18.3 Enterocolitis Due To Clostridium Difficile (A04.7).....	334
3.18.4 Other Bacterial Foodborne Intoxication, Not Elsewhere Classified (A05.-).....	334
3.18.5 Amoebiasis (A06.-).....	334
3.18.6 Adenoviral Enteritis (A08.0-A08.4).....	335
3.18.7 Other Gastroenteritis And Colitis Of Infectious And Unspecified Origin (A09.-).....	335
3.18.8 Tuberculosis (A15-A19).....	336
3.18.9 Infection Due To Other Mycobacteria (A31.-).....	338
3.18.10 Listeriosis (A32.-).....	339
3.18.11 Diphtheria (A36).....	339
3.18.12 Meningococcal Infection (A39.-).....	339
3.18.13 Sepsis (A40-A41).....	340
3.18.14 Congenital Syphilis (A50.-).....	344
3.18.15 Syphilis (A51-A53).....	345
3.18.16 Gonococcal Infection (A54.-).....	345
3.18.17 Chlamydia Infection (A55-A56, A70-A74).....	345
3.18.18 Anogenital Herpesviral [Herpes Simplex] Infection (A60.-).....	346
3.18.19 Anogenital [Venereal] Warts (A63.0).....	346
3.18.20 Viral Meningitis (A87.-).....	346
3.18.21 Dengue Fever [Classical Dengue] (A90-A91).....	346
3.18.22 Measles (B05.-).....	347
3.18.23 Human Immunodeficiency Virus [Hiv] Disease (B20-B24).....	347
3.18.24 Cytomegaloviral Disease : B25.-.....	351
3.18.25 Aspergillosis (B44.-).....	351
3.18.26 Malaria (B50-B54).....	351
3.18.27 Toxoplasmosis (B58.-).....	352
3.19 MDC 29 PENYAKIT DAN GANGGUAN MENTAL.....	353
PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 29.....	353
PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 29.....	354
3.19.1 Dementia in Alzheimer's Disease (F00-F03).....	354
3.19.2 Delirium, Not Induced by Alcohol and Other Psychoactive Substances (F05).....	354
3.19.3 Other Mental Disorders due to Brain Damage and Dysfunction and to Physical Disease (F06.-).....	355
3.19.4 Mental and Behavioural Disorders due to Psychoactive Substance Use (F10-F19).....	356
3.19.5 Skizofrenia (F20.-).....	357
3.19.6 Somatoform Disorders (F45.-).....	357
3.19.7 Neurasthenia (F48.0).....	357
3.19.8 Sindrom Depersonalisasi-Derealitas (F48.1).....	358
3.19.9 Eating Disorders (F50.-).....	358
3.19.10 Nonorganic Sleep Disorders (F51.-).....	359
3.19.11 Sexual Dysfunction, not caused by Organic Disorder or Disease (F52.-).....	359
3.19.12 Mental and Behavioural Disorders Associated with The Puerpeium, Not Elsewhere Classified (F53.-).....	360

3.19.13 Abuse of Non-Dependence-Producing Substance (F55.-).....	360
3.19.14 Specific Personality Disorders (F60.0).....	360
3.19.15 Schizoid Personality Disorder (F60.1).....	361
3.19.16 Dissocial Personality Disorder (F60.2).....	361
3.19.17 Emotionally Unstable Personality Disorder (F60.3).....	362
3.19.18 Histrionic Personality Disorder (F60.4).....	363
3.19.19 Anankastic Personality Disorder (F60.5).....	363
3.19.20 Anxious [Avoidant] Personality Disorder (Avoidant) (F60.6).....	364
3.19.21 Dependent Personality Disorder (F60.7).....	364
3.19.22 Other Specific Personality Disorders (F60.8).....	364
3.19.23 Enduring Personality Changes, Not Attributable to Brain Damage and Disease (F62.-) 365	
3.19.24 Habit and Impulse Disorders (F63.-).....	365
3.19.25 Gender Identity Disorders (F64.-).....	366
3.19.26 Disorders of Sexual Preference (F65.-).....	366
3.19.27 Retardasi Mental (F70-F79).....	367
3.19.28 Tic Disorders (F95.-).....	367
3.19.29 Enuresis Nonorganik (F98.0).....	368
3.19.30 Enkopresis Nonorganik (F98.1).....	368
3.19.31 Feeding Disorder of Infancy and Childhood (F98.2).....	369
3.19.32 Pica of Infancy and Childhood (F98.3).....	369
3.19.33 Stereotyped Movement Disorders (F98.4).....	370
3.19.34 Stuttering [Stammering] (F98.5).....	370
3.19.35 Cluttering (F98.6).....	371
3.20 MDC 30 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN.....	372
PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 30.....	372
PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 30.....	373
3.20.1 Encounter For General Medical Examination (Z00-Z01).....	373
3.20.2 Examination And Encounter For Administrative Purposes (Z02).....	374
3.20.3 Medical Observation And Evaluation For Suspected Diseases And Conditions (Z03).... 375	
3.20.4 Examination And Observation For Other Reasons (Z04.-).....	375
3.20.5 Follow-Up Examination After Treatment For Malignant Neoplasms (Z08-Z09).....	376
3.20.6 Routine General Health Check-Up Of Defined Subpopulation (Z10).....	377
3.20.7 Special Screening Examination (Z11-Z13).....	377
3.20.8 Contact With And Exposure To Communicable Diseases (Z20.-).....	378
3.20.9 Asymptomatic Human Immunodeficiency Virus [HIV] Infection Status (Z21).....	378
3.20.10 Carrier Of Infectious Disease (Z22.-).....	379
3.20.11 Immunization (Z23-Z28).....	379
3.20.12 Need For Other Prophylactic Measures (Z29.-).....	380
3.20.13 Contraceptive Management (Z30.-).....	380
3.20.14 Sterilisasi (Z30.2).....	382
3.20.15 Procreative Management (Z31.-).....	383
3.20.16 Pregnancy Examination And Test (Z32.-).....	384

3.20.17 Pregnant State, Incidental (Z33).....	384
3.20.18 Supervision Of Normal Pregnancy (Z34-Z35).....	385
3.20.19 Antenatal Screening (Z36).....	385
3.20.20 Outcome Of Delivery (Z37.-).....	386
3.20.21 Liveborn Infants According To Place Of Birth (Z38.-).....	386
3.20.22 Postpartum Care And Examination (Z39.-).....	387
3.20.23 Prophylactic Surgery (Z40.-).....	388
3.20.24 Procedures For Purposes Other Than Remedying Health State (Z41.-).....	388
3.20.25 Other Surgical Follow-Up Care (Z42-Z48).....	389
3.20.26 Care Involving Use Of Rehabilitation Procedures (Z50.-).....	390
3.20.27 Donors Of Organs And Tissues (Z52.-).....	391
3.20.28 Persons Encountering Health Services For Specific Procedures, Not Carried Out (Z53.-).....	391
3.20.29 Convalescence (Z54.-).....	392
3.20.30 Occupational Exposure To Risk Factors (Z57-Z58).....	392
3.20.31 Problems Related To Housing And Economic Circumstances (Z59).....	393
3.20.32 Counselling Related To Sexual Attitude, Behavior And Orientation (Z70-Z71).....	393
3.20.33 Explanation Of Investigation Findings (Z71.2).....	393
3.20.34 Problems Related To Lifestyle (Z72.-).....	393
3.20.35 Problems Related To Life-Management Difficulty (Z73.-).....	393
3.20.36 Problems Related To Care-Provider Dependency (Z74.-).....	393
3.20.37 Problems Related To Medical Facilities And Other Health Care (Z75.-).....	393
3.20.38 Persons Encountering Health Sevice In Other Circumstances (Z76.-).....	394
3.20.39 Family History Of Certain Disabilities And Chronic Diseases Leading To Disablement (Z80-Z84).....	394
3.20.40 Personal History Of Malignant Neoplasm (Z85-Z88, Z91-Z92).....	394
3.20.41 Acquired Absence Of Limb (Z89-Z90).....	394
3.20.42 Artificial Opening Status (Z93.-).....	395
3.20.43 Transplanted Organ And Tissue Status (Z94.-).....	395
3.20.44 Presence Of Cardiac And Vascular Implants And Grafts (Z95.-).....	395
3.20.45 Presence Of Other Functional Implants (Z96-Z97).....	395
3.20.46 Other Post Surgical Status (Z98.-).....	395
3.20.47 Dependence On Enabling Machines And Devices, Not Elsewhere Classified (Z99).....	395
3.21 MDC 31 MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA.....	396
PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 31.....	396
PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 31.....	397
3.21.1 Fracture of Skull and Facial Bones (S02.5).....	398
3.21.2 Patah Tulang (Fracture) (S12, S22, S32, S42, S52, S62, S72, S82, S92).....	401
3.21.3 Fracture of Other Parts of Neck (S12.8).....	403
3.21.4 Ruptured, Slipped, and Herniated Disc (S13, S23, S33).....	403
3.21.5 Sprain and Strain (S13, S23, S33, S43, S53, S63, S73, S83, S93).....	404
3.21.6 Injury Of Brachial Plexus (S14.3).....	405
3.21.7 Cedera Sumsum Tulang Belakang (Spinal Cord Injury) (S24, S34, T90-T98).....	406

3.21.8 Injuries To The Wrist And Hand (S60-S69).....	406
3.21.9 Dislokasi Prostesis Hip (S73.0, T84.0).....	407
3.22 MDC 32 LUKA BAKAR.....	409
PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 32.....	409
PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 32.....	410
3.22.1 Burns And Corrosions Of External Body Surface, Specified By Site (T20-T25).....	410
3.23 MDC 33 INJURIES, POISONING & CERTAIN OTHER CONSEQUENCES OF EXTERNAL CAUSES.....	411
PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 33.....	411
PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 33.....	412
3.23.1 Poisoning By Drugs, Medicaments And Biological Substances (T36-T50).....	412
3.23.2 Angioedema (T78.3).....	413
3.23.3 Post-Traumatic Wound Infection, Not Elsewhere Classified (T79.3).....	414
3.23.4 Compartment Syndrome (T79.6, M62.2).....	415
3.23.5 Mechanical Complication of Internal Fixation Device of Bones of Limb (T84.1).....	415
3.23.6 Infection and Inflammatory Reaction due to Internal Fixation Device [Any Site] (T84.6).....	416
3.23.7 Reaksi Penolakan atau Gagalnya Transplantasi Kornea (T85.3, T85.7, T86.8).....	417
3.23.8 Penyebab Eksternal.....	417
3.24 MDC 34 NEOPLASMA.....	442
PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 34.....	443
PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 34.....	447
3.24.1 Diagnosis keganasan.....	447
3.24.2 Komplikasi Terkait dengan Keganasan.....	450
3.24.3 Kode Morfologi Neoplasma.....	453
3.24.4 Mass, Cyst, Dan Tumor.....	454
3.24.5 Tumor Stroma Saluran Pencernaan (Gastrointestinal Stromal Tumor) C15-C26.....	455
3.24.6 Karsinoma Peri-Ampular (C17.0, C24.0, C24.1, C25.0).....	455
3.24.7 Tumor Hati (C22.-).....	456
3.24.8 Ewing's Sarcoma (C40-C41).....	456
3.24.9 Kanker Payudara (C50.-).....	456
3.24.10 Kanker Serviks (C53.-).....	457
3.24.11 Kanker Uterus (C54-C55).....	457
3.24.12 Neoplasma Ovarium (C56, D27, D39.1).....	458
3.24.13 Keganasan pada Lokasi Tidak Jelas (C76).....	458
3.24.14 Pengodean Kanker Primer dan Sekunder.....	459
3.24.15 Exostosis (D16).....	460
3.24.16 Leiomyoma of Uterus (D25.-).....	460
3.24.17 Craniopharyngioma (D35.3, D44.4).....	460
3.24.18 Gestational Trophoblastic Tumour (D39.2).....	460
3.25 MDC 35 REHABILITASI MEDIS.....	462
3.26 MDC 36 UNGROUPABLE ATAU UNRELATED.....	465
3.26.1 Error Codes.....	465
3611199 Primary Diagnosis code is not valid for Female or Male.....	465

3611299 Diagnosis code is not valid for patient's age.....	466
3600019 Unrelated OR Procedure.....	466
3614129 Error: Respiratory Drug Resistance TB w/o Drug Type.....	467
3614229 Error: Respiratory Drug Resistance TB w/o Episode Type.....	468
3615029 Error: Missing Code Also: Angiocardiology Proc.....	469
3615129 Error: Missing Code Also: Catheterization Proc.....	469
3615229 Error: Stent Insertion wo/ Number of Stent or Number of Vessels.....	469
3615329 Error: Number of Stent wo/ Insertion Proc.....	471
3615429 Error: Angioplasty wo/ Number of Vessels.....	471
3615529 Error: Missing code also (00.56 or 00.57).....	472
3634819 Error blood transfusion for neoplasm without anemia.....	472
36001x9 Ungroupable: Radiotherapy Session w/o Radiotherapy Proc.....	473
36002x9 Ungroupable: Radiotherapy w/o Z51.0.....	474
36003x9 Ungroupable: Chemotherapy Proc. without Z51.1.....	474
3635129 Ungroupable: Rehabilitation without Procedures.....	475
3.27 MDC 90 PROSEDUR DIAGNOSIS.....	479

DAFTAR GAMBAR

DRAFT V1

DAFTAR TABEL

DRAFT V1

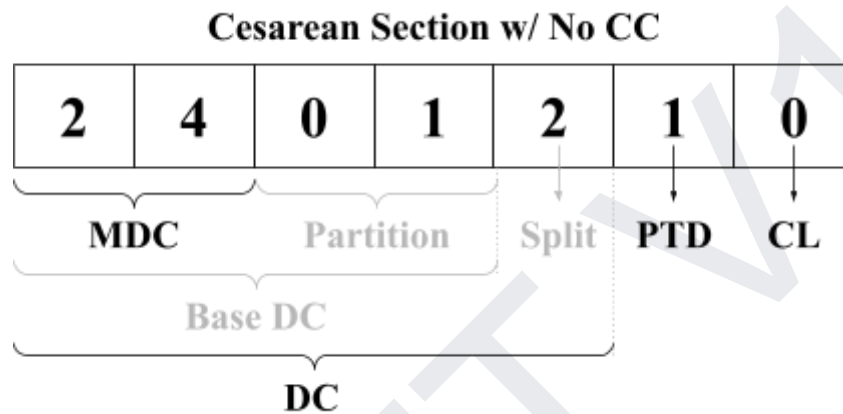
DAFTAR SINGKATAN

DRAFT V1

GLOSARIUM

CHAPTER I INDONESIAN DIAGNOSIS RELATED GROUP (iDRG)

Indonesian Diagnosis Related Group (iDRG) adalah suatu sistem pengelompokkan kasus berdasarkan kesamaan klinis (diagnosis, pengobatan dan/atau prosedur) atau kemiripan penggunaan sumber daya. Dalam sistem terbaru, kode iDRG terdiri dari 7 digit kode yang mencakup *Major Diagnostic Category (MDC)*, *Disease Cluster (DC)*, *Patient Type Designation (PTD)* dan *Complexity Level (CL)*.



Gambar 1. Penulisan kode iDRG

Keterangan:

1. Digit ke-1 dan 2 menunjukkan kode MDC (*Major Diagnostic Category*)
2. Digit ke-3 dan 4 menunjukkan kode *Treatment Partition*
3. Digit ke-5 menunjukkan kode *Split*
4. Digit ke-6 menunjukkan PTD (*Patient Type Designation*)
5. Digit ke-7 menunjukkan CL (*Complexity Level*)
6. MDC + *Partition* menunjukkan kode *Base DC (Disease Cluster)*
7. MDC + *Partition* + *Split* menunjukkan kode DC (*Disease Cluster*)

A. Struktur Kode iDRG

a. *Major Diagnostic Category (MDC)*

MDC merupakan pengkategorian diagnosis yang dilakukan berdasarkan sistem organ atau etiologi penyakit yang umumnya dikaitkan dengan spesialisasi tertentu yang biasanya menjadi penyebab utama perawatan. MDC merupakan 2 digit pertama dalam susunan kode iDRG dan berjumlah sebanyak 28 MDC yang dideskripsikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Daftar *Major Diagnostic Categories* (MDC)

Kode	Deskripsi
10	Pre MDC*
11	Diseases and Disorders of the Nervous System
12	Diseases and Disorders of the Eye
13	Diseases and Disorders of the Ear, Mouth and Throat
14	Diseases and Disorders of the Respiratory System
15	Diseases and Disorders of the Circulatory System
16	Diseases and Disorders of the Digestive System
17	Diseases and Disorders of the Hepatobiliary System and Pancreas
18	Diseases and Disorders of the Musculoskeletal System and Connective Tissue
19	Diseases and Disorders of the Skin, Subcutaneous Tissue and Breast
20	Endocrine, Nutritional and Metabolic Diseases and Disorders
21	Diseases and Disorders of the the Kidney and Urinary Tract
22	Diseases and Disorders of the Male Reproductive System
23	Diseases and Disorders of the Female Reproductive System
24	Pregnancy, Childbirth and Puerperium
25	Newborns and Other Neonates with Conditions Originating in the Perinatal Period
26	Diseases and Disorders of the Blood and Blood Forming Organs and Immunological Disorders
27	Myeloproliferative Diseases and Disorders
28	Infectious and Parasitic Diseases
29	Mental Diseases and Disorders
30	Factors Influencing Health Status and Other Contacts with Health Services
31	Multiple Significant Trauma
32	Burns
33	Injuries, Poisonings and Toxic Effects of Drugs
34	Neoplasms
35	Rehabilitation

Kode	Deskripsi
36	Ungroupable or Unrelated
90	Diagnostic Procedures

**Pre-MDC adalah kasus-kasus yang memiliki tingkat spesialisasi tinggi dan memerlukan biaya besar*

b. *Disease Cluster (DC)*

DC merupakan 5 digit pertama dalam kode iDRG yang terdiri atas 2 digit pertama (MDC), digit ke-3 dan ke-4 (*treatment partition*), dan digit ke-5 (*split*). MDC dan *treatment partition* sendiri telah membentuk kode DC dasar/*Base DC*. DC merupakan pengelompokan kluster penyakit yang berdasarkan diagnosis atau pengobatan atau prosedur yang diterima, usia, jenis kelamin, cara pulang, lama hari perawatan, dan lain-lain. *Split* merupakan kode 1 – 9 yang menggambarkan perbedaan diagnosis/prosedur, usia, jenis kelamin, cara pulang, lama hari perawatan, dll. Sedangkan *treatment partition* merupakan suatu pembagian perawatan dengan mengkategorikannya menjadi sub kelompok berdasarkan jenis perawatan yang diterima seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Deskripsi Jenis *Treatment Partition*

Kode	Deskripsi
01 – 40	<i>Surgical</i>
41 – 60	<i>Non Surgical</i>
61 – 99	<i>Medical</i>

c. *Patient Type Designation (PTD)*

PTD merupakan digit ke-6 dalam kode iDRG yang mengacu pada pengelompokan kasus berdasarkan jenis layanan yang diterima oleh pasien di Rumah Sakit, yaitu rawat inap atau rawat jalan.

Tabel 3. Deskripsi Jenis Layanan yang diterima (PTD)

Kode	Deskripsi
1	Rawat Inap
2	Rawat Jalan

d. Complexity Level (CL)

CL merupakan digit terakhir pada kode iDRG yang merepresentasikan jenis kasus berdasarkan ada tidaknya *complexity* dan *comorbidity* (CC) yang dipengaruhi oleh diagnosis sekunder dan dihitung menggunakan indeks *Patient Clinical Complexity Level* (PCCL). CC dapat merujuk tingkatan komplikasi atau kompleksitas kasus atau komorbiditas penyakit lainnya yang muncul bersamaan dengan diagnosis utama sehingga meningkatkan sumber daya dalam melakukan penatalaksanaan (tabel 4). Oleh karena itu, CL menggambarkan kemiripan penggunaan sumber daya dalam melayani pasien melalui analisis CART (*Classification and Regression Trees*) untuk melihat perbedaan biaya yang signifikan antara masing-masing CC.

Tabel 4. Deskripsi Pengelompokan *Complexity Level* (CL)

Kode	Deskripsi
0	No CC
1	Mild CC
2	Moderate CC
3	Severe CC
4	Catastrophic CC
9	Merge CC (without CL)

Dengan demikian, penentuan kode iDRG yang tepat sangat bergantung pada pengodean diagnosis atau pengobatan dan/atau prosedur yang dilakukan oleh pengode (*coder*), berdasarkan dokumentasi medis yang lengkap dan akurat yang telah disusun oleh dokter di dalam rekam medis pasien.

CHAPTER II KETENTUAN UMUM KODING iDRG

2.1 Ketentuan Umum Pengkodean (Coding) iDRG

Koding adalah kegiatan pemberian kode untuk diagnosis utama dan sekunder sesuai dengan ICD-10 Versi Tahun 2010 yang diterbitkan oleh WHO dan pemberian kode tindakan atau prosedur berdasarkan ICD-9-CM Versi Tahun 2010 dengan *Indonesian Modification* (IM). Dalam pedoman ini, kedua ICD tersebut akan disingkat menjadi ICD-10-IM dan ICD-9-IM untuk penulisan selanjutnya. Koding merupakan elemen penting dalam sistem pembiayaan prospektif. Dalam sistem ini, aspek koding menjadi salah satu penentu besaran biaya yang dibayarkan kepada FKRTL. Sistem pengkodean yang digunakan dalam bidang kesehatan untuk mengklasifikasikan dan mencatat data terkait penyakit atau kematian adalah koding morbiditas atau koding mortalitas. Dalam aturan dan pedoman koding yang digunakan dalam iDRG ini mengacu pada aturan koding morbiditas.

Koding morbiditas pada iDRG adalah proses pemberian kode diagnosis penyakit berdasarkan diagnosis yang sudah ditetapkan dokter. Semua penyakit yang terdiagnosis wajib dikodekan oleh pengkode (*coder*) sesuai dengan bukti penegakkan dan tatalaksana tanpa melihat status keluar pasien hidup atau meninggal. Koding mortalitas tidak digunakan dalam sistem ini, karena koding mortalitas digunakan untuk menentukan penyebab kematian (*cause of death*) sedangkan dalam sistem pembiayaan kesehatan digunakan aturan koding morbiditas.

. Di samping itu, sumber data untuk pengkodean iDRG berasal dari data diagnosis dan tindakan/prosedur yang tercantum pada rekam medis dan terangkum dalam *resume* medis. Ketepatan koding diagnosis dan tindakan/prosedur sangat berpengaruh terhadap hasil pengelompokkan (*grouper*) dalam aplikasi iDRG.

2.1.1 Diagnosis Utama

Diagnosis utama adalah diagnosis akhir atau final yang ditetapkan oleh dokter pada akhir episode perawatan dengan kriteria sebagai alasan utama pasien memerlukan pelayanan kesehatan, pemeriksaan lanjutan, tindakan medis dan yang paling banyak menggunakan sumber daya. Sehingga, jika terdapat lebih dari satu diagnosis, maka diagnosis yang menggunakan sumber daya paling banyak akan dipilih sebagai diagnosis utama. Jika tidak terdapat diagnosis yang dapat ditegakkan pada akhir episode perawatan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan standar pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku, maka gejala utama, hasil pemeriksaan

penunjang yang tidak normal, atau masalah lainnya ditetapkan menjadi diagnosis utama.

2.1.1.1 Elemen-elemen penting diagnosis utama

a. Penentuan Diagnosis Utama

Dokter harus menetapkan satu diagnosis tunggal sebagai diagnosis utama, meskipun pasien memiliki beberapa diagnosis selama masa perawatan. Berikut ini adalah elemen penting dalam penentuan diagnosis utama:

1) Ditetapkan Setelah Perawatan Selesai

Diagnosis utama ditentukan setelah perawatan berakhir, berdasarkan diagnosis akhir yang dicatat dengan jelas, lengkap dan detail dalam rekam medis pasien. Diagnosis utama bisa berbeda dari diagnosis awal (saat pasien baru masuk rumah sakit).

2) Kondisi yang Menjadi Sebab Utama Pasien Dirawat

Diagnosis utama harus merujuk pada kondisi atau keluhan yang sudah dialami pasien sebelum masuk rumah sakit dan menjadi indikasi pasien memerlukan pelayanan kesehatan, bukan penyakit yang muncul selama perawatan.

Contoh: Jika pasien terkena infeksi di rumah sakit, infeksi tersebut tidak boleh dijadikan diagnosis utama.

3) Prioritas Penyakit yang Dirawat

Jika pasien memiliki beberapa penyakit sejak sebelum rawat inap, maka dipilih penyakit yang menjadi fokus utama perawatan.

Jika perawatan ditujukan untuk beberapa penyakit, maka:

- a) Utamakan untuk memilih penyakit paling parah atau mengancam jiwa.
- b) Penyakit dengan tingkat keparahan sama, utamakan memilih penyakit yang membutuhkan sumber daya terbesar, misalnya penyakit yang memerlukan tindakan operasi atau perawatan di *Intensive Care Unit* (ICU).

4) Jika diagnosis belum dapat ditegakkan sampai akhir episode perawatan

Jika diagnosis belum dapat ditegakkan sampai akhir episode perawatan misalnya pasien pulih/ meninggal/ dirujuk tanpa kejelasan, maka yang dicatat adalah:

- Gejala utama, contoh: “nyeri perut tanpa penyebab jelas”
- Tanda klinis, contoh: “demam tinggi berkepanjangan”
- Sindrom yang menggambarkan kondisi pasien, contoh: “gagal nafas akut”

Tabel 5. Contoh Kasus Penetapan Diagnosis Utama

Contoh 1	Pasien menderita penyakit diabetes mellitus tipe 2, hipertensi, dan hiperkolesterolemia, telah menjalani perawatan rutin dan berkelanjutan. Kali ini, pasien datang dengan gejala nyeri kepala yang berat. Dokter menemukan tekanan darah 200/140 mmHg. Pasien dirawat di rumah sakit dan dokter menegakkan diagnosis <i>Diabetes Melitus tipe 2</i> .	
	Penulisan Diagnosis yang salah	Penulisan Diagnosis yang benar
Diagnostik Primer	HT + DM + hiperkolesterolemia	<i>Diabetes mellitus type 2</i>
Diagnostik Sekunder	-	<i>Malignant Hypertension</i> <i>Hypercholesterolemia</i>
Contoh 2	Pasien mengalami nyeri perut mendadak. Dokter IGD mendiagnosis <i>acute abdomen</i> dan memerintahkan untuk rawat inap. Dokter yang merawat kemudian mendiagnosis <i>peritonitis</i> . Dokter menemukan <i>Perforated chronic duodenal ulcer</i> selama operasi dan melakukan tindakan jahitan sederhana dengan cangkuk omentum (<i>simple suture with omental graft</i>).	
	Penulisan Diagnosis yang salah	Penulisan Diagnosis yang benar
Diagnostik Primer	Sakit perut akut	<i>Perforated chronic duodenal ulcer</i>
Diagnostik Sekunder	Peritonitis	
Contoh 3	Pasien datang dengan gejala demam, batuk, dan sesak napas. Dokter mendiagnosis pneumonia streptokokus pada lobus atas paru kanan dan memerintahkan untuk rawat inap di rumah sakit. Tiga hari kemudian, pasien mengalami demam tinggi, menggigil, dan tekanan darah rendah. Dokter mendiagnosis sepsis sebagai komplikasi dan memindahkannya ke ruang ICU. Setelah 7 hari di ICU, pasien dipindahkan kembali ke bangsal dan diperbolehkan pulang 2 hari kemudian.	
	Penulisan Diagnosis yang salah	Penulisan Diagnosis yang benar
Diagnostik Primer	Septikemia	Pneumonia streptokokus lobus atas kanan
Diagnostik Sekunder	Pneumonia streptokokus lobus atas kanan	Septikemia
Diagnosis Lain	-	-
Contoh 4	Pasien ditabrak mobil saat menyeberang jalan kemudian mengalami penurunan kesadaran. Pemeriksaan menunjukkan tekanan darah rendah, limpa pecah (<i>ruptured spleen</i>) sehingga dilakukan splenektomi. CT scan kepala menunjukkan kontusio serebri frontal kiri, diobati	
	Penulisan Diagnosis yang salah	Penulisan Diagnosis yang benar

	dengan obat pengurang pembengkakan otak. X-ray panggul mengungkap fraktur rami, ditangani dengan fiksator eksternal. Pasien dirawat selama 30 hari sebelum pulang.	
	Penulisan Diagnosis yang salah	Penulisan Diagnosis yang benar
Diagnostik Primer	Kecelakaan mobil dengan limpa pecah, memar serebral, dan patah tulang panggul	<i>Rupture Spleen</i>
Diagnostik Sekunder	-	Kontusio serebral frontal kiri Fraktur rami pubis
Penyebab Eksternal	-	Pejalan kaki terluka dalam tabrakan dengan mobil dalam kecelakaan lalu lintas
Contoh 5		
	Seorang pasien wanita dengan rasa sakit di perut kanan bawah datang ke IGD. Dokter tidak yakin apakah itu radang usus buntu. Jadi, pasien dirawat inap di rumah sakit selama 1 malam. Rasa sakitnya berangsur-angsur berkurang sampai rasa sakit menghilang keesokan harinya. Dokter memperbolehkan pasien pulang tanpa dapat mendiagnosis penyebab atau penyakit sakit perut.	
	Penulisan Diagnosis yang salah	Penulisan Diagnosis yang benar
Diagnostik Primer	R/O usus buntu	Nyeri perut kanan bawah

b. Penentuan Kode Diagnosis Utama

Saat menentukan kode diagnosis utama, cari kode yang sesuai dengan diagnosis utama yang telah ditulis oleh dokter pada *Resume Medis* (ringkasan pulang) menggunakan ICD-10-IM. Jika diagnosis utama yang telah ditulis oleh dokter tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misalnya mencantumkan lebih dari satu diagnosis utama atau mencantumkan diagnosis sekunder di kolom diagnosis utama, maka pengode harus berkonsultasi langsung dengan dokter untuk memperbaiki pencatatan.

Jika diagnosis utama tidak disampaikan secara detail atau tidak mencerminkan karakteristik pasien, pengode wajib mempertimbangkan data spesifik pasien seperti jenis kelamin, usia, status kehamilan, persalinan, atau pasca persalinan untuk memperjelas kode. Contoh: Jika diagnosis utama adalah “hipertensi” pada ibu hamil, gunakan kode O10.- *Pre-existing hypertension complicating pregnancy, childbirth and the puerperium*.

Beberapa diagnosis memerlukan dua kode sesuai sistem klasifikasi ganda (*dual classification* atau *dagger-asterisk system*).

Contoh: Jika diagnosis utama adalah *cryptococcal meningitis*:

- 1) Kode dengan tanda † (*dagger*): B45.1† (*Cerebral cryptococcosis*) sebagai diagnosis utama.
- 2) Kode dengan tanda * (*asterisk*): G02.1* (*Meningitis in mycoses*) sebagai diagnosis tambahan.

Pengode atau petugas koding tidak memiliki kewenangan untuk mengubah diagnosis yang telah ditetapkan oleh dokter dalam kondisi apapun. Apabila diagnosis yang tertulis tidak jelas atau belum dapat ditentukan secara spesifik, maka dapat menggunakan kode gejala utama, misalnya untuk “*Other and unspecified abdominal pain*” dapat menggunakan kode R10.4 atau kode yang tidak spesifik lainnya apabila jenis penyakit belum dapat dirinci lebih lanjut, misalnya kode E14.9 untuk “*Unspecified diabetes mellitus*”.

Untuk jenis pasien tertentu seperti ibu hamil/paska persalinan, bayi baru lahir, pasien HIV/AIDS atau kanker, maka metode pengodean diagnosis utama mungkin dapat dilakukan secara berbeda. Dalam hal ini, pengode harus mengikuti aturan khusus yang tercantum [pada bab terpisah dalam buku ICD-10 versi tahun 2010](#), misalnya bab kebidanan, neonatologi, penyakit menular, atau kanker.

Tabel 6. Contoh Kasus Penentuan Kode Diagnosis Utama

Contoh 6	Dokter mencatat diagnosis utama sebagai <i>laceration wound</i> (luka robek) tanpa menyebutkan lokasi yang spesifik. Jika pengode tidak mencari informasi dari hasil pemeriksaan fisik yang mencatat bahwa pasien memiliki luka robek di punggung bagian bawah, hal ini dapat menghasilkan kode diagnosis dengan kualitas rendah. Pengode wajib meminta dokter untuk meninjau ulang diagnosis tersebut agar lebih detail dengan mencantumkan lokasi/regio luka tersebut
Diagnosis	Luka laserasi
Kode yang salah	T14.1 <i>Open wound of unspecified body region</i>
Kode yang benar	S31.0 <i>Open wound of lower back and pelvis</i>
Contoh 7	Pasien perempuan hamil 30 minggu datang untuk perawatan karena mengalami <i>thrombosed internal haemorrhoids</i> (wasir dalam yang menggumpal). Dokter mencatat nama penyakit tersebut sebagai diagnosis utama, tetapi tidak memperhatikan bahwa kondisi pasien sedang hamil, yang membuat hal tersebut tidak sesuai dengan struktur kode ICD-10. Jika pengode tidak memeriksa informasi bahwa pasien sedang hamil, mungkin akan memberikan kode diagnosis utama yang kurang tepat. Dokter mencatat nama penyakit tersebut sebagai diagnosis utama, yang tidak sesuai dengan struktur kode ICD-10. Jika pengode tidak memeriksa informasi bahwa pasien sedang hamil, mungkin akan memberikan kode diagnosis utama yang salah.
Diagnosis	Wasir internal trombosis

Kode yang salah	I84.0	<i>Internal thrombosed haemorrhoids</i>
Kode yang benar	O22.4	<i>Haemorrhoids in pregnancy</i>

2.1.2 Diagnosis Sekunder

Diagnosis Sekunder merupakan diagnosis yang menyertai diagnosis utama pada saat pasien masuk atau yang terjadi selama episode perawatan. Diagnosis ini berfungsi untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi pasien secara menyeluruh. Jika suatu kode diagnosis tidak menjelaskan secara lengkap kondisi atau penyebab (agen), lokasi, atau tingkat keparahan tertentu, maka dapat ditambahkan kode sekunder untuk melengkapi dan mengidentifikasi kondisi atau agen tersebut dengan lebih rinci. Diagnosis sekunder terdiri dari ko-morbiditas dan/atau komplikasi.

2.1.2.1 Diagnosis Komorbid (*Pre-Admission Comorbidity*)

Komorbiditas, atau *pre-admission comorbidity*, adalah kondisi atau penyakit yang telah ada sebelum pasien menjalani perawatan di rumah sakit, yang menyertai dan/atau yang muncul bersamaan dengan diagnosis utama.

Kriteria Penetapan Komorbiditas

Suatu diagnosis dapat diklasifikasikan sebagai komorbiditas apabila memenuhi seluruh kriteria berikut:

a. Kondisi telah ada sebelum pasien dirawat di rumah sakit

Diagnosis komorbiditas hanya berlaku untuk kondisi atau penyakit yang secara klinis sudah dialami oleh pasien sebelum tanggal masuk rawat inap (*pre-admission*). Penyakit atau gangguan yang timbul selama perawatan tidak dapat diklasifikasikan sebagai komorbiditas.

b. Memiliki tingkat keparahan yang bermakna secara klinis

Komorbiditas harus memberikan dampak terhadap perjalanan penyakit atau perawatan pasien. Dampak tersebut dapat berupa:

- 1) Peningkatan risiko komplikasi, kematian, atau kecacatan;
- 2) Perlunya pemeriksaan penunjang tambahan, seperti pemeriksaan laboratorium atau radiologi; dan/atau
- 3) Kebutuhan intervensi atau penanganan khusus, seperti konsultasi spesialis, tindakan pembedahan, atau penggunaan obat-obatan tertentu.

c. Jumlah diagnosis komorbiditas yang diperbolehkan

Dokter boleh mencantumkan lebih dari satu komorbiditas tanpa batasan jumlah, selama setiap diagnosis yang dicantumkan harus memenuhi kriteria di atas serta berdasar pada evaluasi klinis yang akurat.

Contoh komorbiditas :

- Penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gagal ginjal kronis, penyakit jantung iskemik.
- Penyakit autoimun seperti *systemic lupus erythematosus* .

Catatan:

Jika pasien memiliki luka atau kondisi di beberapa area tubuh dengan tingkat keparahan yang lebih rendah daripada kondisi utama, hal ini juga dianggap sebagai komorbiditas.

Komorbiditas yang dicatat dokter di *resume* medis (ringkasan pulang) harus **ditulis dengan** jelas dalam rekam medis. Pengode tidak **berwenang** menambahkan diagnosis komorbiditas secara sepihak berdasarkan hasil laboratorium, urine, atau pemeriksaan khusus tanpa persetujuan dokter. Jika ada keraguan tentang kemungkinan komorbiditas yang tidak disebutkan dokter, maka perlu dikonfirmasi dengan memperlihatkan rekam medis kepada dokter untuk dapat ditinjau ulang sebelum mencantumkan kode diagnosis komorbiditas.

2.1.2.2 Komplikasi (*Post-Admission Comorbidity*)

Komplikasi (*Complication* atau *Post-Admission Comorbidity*) adalah penyakit yang timbul dalam masa perawatan dan memerlukan pelayanan tambahan serta mendapatkan tata laksana sewaktu episode pelayanan. **Komplikasi dapat disebabkan oleh kondisi yang ada, atau muncul akibat dari pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien**

Kriteria penting dalam diagnosis komplikasi adalah sbb:

- a. Muncul **atau teridentifikasi** saat pasien dirawat di rumah sakit.
- b. Tidak terkait langsung dengan diagnosis utama dan memiliki tingkat keparahan yang cukup untuk:
 - Meningkatkan risiko komplikasi, kematian, atau kecacatan.

- Memerlukan pelayanan/pemeriksaan tambahan, obat, atau tindakan medis khusus.
- Membutuhkan penanganan dari dokter spesialis lain.
- c. Bisa terjadi di sistem tubuh yang berbeda dan tidak harus terkait dengan diagnosis utama.
- d. Dokter boleh mencantumkan lebih dari satu komplikasi tanpa batasan jumlah.

Contoh Diagnosis Komplikasi :

- Trombosis (penggumpalan darah) mendadak.
- Serangan jantung mendadak.
- Alergi obat.
- Efek samping dari pengobatan atau operasi.

Tabel 7. Contoh Kasus Penentuan Diagnosis Komplikasi

Contoh 8	Pasien dengan <i>deep vein thrombosis</i> (DVT) mengalami komplikasi berupa emboli paru (<i>pulmonary embolism</i>) akibat bekuan darah di kaki yang terlepas dan mengalir ke paru-paru.
Diagnosis primer	Trombosis vena dalam
Komplikasi	Emboli paru
Contoh 9	Pasien dalam contoh 8 (dengan diagnosis utama <i>deep vein thrombosis</i>) mengalami diare akut 3 hari setelah dirawat di rumah sakit. Dokter mendiagnosis <i>acute gastroenteritis</i> sebagai komplikasi, meskipun kondisi ini tidak terkait dengan diagnosis utama.
Diagnosis primer	Trombosis vena dalam
Komplikasi	Gastroenteritis akut

Dalam contoh 8 dan 9, komplikasi yang muncul menyebabkan pasien mengalami kesulitan lebih besar karena pasien harus dirawat di rumah sakit lebih lama, menggunakan obat tambahan, dan menimbulkan biaya perawatan yang lebih tinggi. Kondisi ini memenuhi kriteria definisi komplikasi.

Kode diagnosis komplikasi harus **berdasarkan** diagnosis yang dicantumkan dokter sebagai komplikasi dalam *resume* medis (ringkasan pulang). Diagnosis tersebut harus dituliskan secara jelas dalam rekam medis oleh dokter yang merawat atau tim medis yang menangani sebagai bukti sah untuk pemberian kode diagnosis komplikasi.

Pengode tidak diperbolehkan menggunakan hasil pemeriksaan

laboratorium, urin, atau tes khusus lainnya yang tidak dituliskan dokter sebagai diagnosis komplikasi di dalam rekam medis. Jika ada keraguan tentang kemungkinan adanya diagnosis komplikasi yang tidak disimpulkan dokter, maka perlu mengkonfirmasi diagnosis tersebut kepada dokter agar dapat ditinjau dan dilengkapi dalam rekam medis.

2.1.3 Sumber Daya

Penatalaksanaan yang diberikan untuk diagnosis utama atau diagnosis sekunder sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya pelayanan kesehatan yang digunakan selama proses perawatan. Sumber daya ini mencakup satu atau lebih bentuk dukungan klinis dan nonklinis, yang diperlukan untuk mencapai manfaat pelayanan yang optimal.

Sumber daya dalam konteks penatalaksanaan meliputi hal berikut ini, namun tidak terbatas pada:

- a. Konsultasi medis (termasuk konsultasi antar spesialis);
- b. Pemeriksaan fisik dan penunjang, seperti pemeriksaan laboratorium, radiologi, atau diagnostik lainnya;
- c. Tenaga kesehatan, termasuk dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya;
- d. Tindakan medis, baik invasif maupun non-invasif;
- e. Bahan medis habis pakai (BMHP) yang digunakan dalam perawatan;
- f. Obat-obatan;
- g. Alat kesehatan, termasuk penggunaan alat bantu atau terapi penunjang lainnya;
- h. Bentuk dukungan lainnya yang memiliki kontribusi signifikan terhadap hasil tata laksana pasien.

Pemanfaatan sumber daya tersebut wajib terdokumentasi secara lengkap dalam rekam medis pasien dan akan menjadi dasar dalam pengkodean diagnosis dan prosedur.

2.1.4 Penyebab Luar (*External Cause*)

Penyebab luar cedera atau keracunan (*external cause of injury and poisoning*) adalah informasi yang diperoleh dari riwayat pasien atau pihak yang menyaksikan kejadian. Informasi ini menjelaskan bagaimana cedera/keracunan terjadi, lokasi

kejadian, aktivitas yang sedang dilakukan, dan jenis kejadian (apakah kecelakaan, disengaja, atau tujuan yang tidak diketahui).

a. Unsur penting dalam menentukan penyebab eksternal

1) Deskripsi mekanisme cedera/keracunan

Harus dijelaskan secara spesifik, seperti:

- Pasien terjepit di boncengan belakang sepeda motor saat perjalanan ke tempat kerja, lalu motor tergelincir.
- Digigit anjing liar saat bermain di taman.
- Keracunan timbal selama bekerja di pabrik baterai.

2) Jenis kejadian

Dokter yang merawat wajib menyatakan klasifikasi kejadian sebagai salah satu dari kategori berikut:

- Kecelakaan tidak disengaja, seperti jatuh, tergelincir, atau tertabrak;
- Tindakan kekerasan, seperti pemukulan, penusukan, atau penganiayaan;
- Upaya bunuh diri, seperti menelan racun atau melukai diri secara sengaja;
- Tujuan tidak diketahui, apabila informasi yang tersedia tidak cukup untuk mengidentifikasi motif kejadian.

Catatan:

Jika dokter tidak mencantumkan penyebab eksternal, pengode harus mencari informasi tambahan dari rekam medis, seperti aktivitas pasien saat kejadian (misal: bekerja, olahraga), lokasi kejadian (misal: rumah, jalan raya), posisi pasien di kendaraan (misal: pengemudi, penumpang).

Contoh: Jika pasien jatuh dari tangga tetapi tidak dijelaskan penyebabnya, pengode (*coder*) wajib meminta klarifikasi ke dokter.

b. Penyebab eksternal untuk cedera kronis

Jika cedera disebabkan oleh kejadian lama, misalnya patah tulang akibat kecelakaan 1 tahun lalu, maka perlu menggunakan kode Y85–Y89 ([kejadian eksternal di masa lampau](#)).

Tabel 8. Contoh Kasus Diagnosis Penyebab Eksternal untuk Cedera Kronis

Contoh 1-1	Pasien mengalami kecelakaan tunggal saat mengendarai sepeda motor di pinggir jalan akibat terjatuh setelah melewati jalan berlubang. Insiden ini terjadi tanpa adanya tabrakan dengan pihak lain. Saat terjatuh, pasien menggunakan lengan untuk menahan tubuh dan motornya. Pemeriksaan fisik tidak menunjukkan adanya luka pada tubuh pasien. Namun, hasil pemeriksaan radiologi mengungkapkan fraktur (patah tulang) pada bagian tengah tulang humerus (lengan atas) kiri.	
Diagnosis yang salah	Diagnosis Primer	Kecelakaan sepeda motor
	Penyebab Eksternal	-
Diagnosis yang salah	Diagnosis Primer	Fraktur tertutup bagian tengah tulang humerus kiri
	Penyebab Eksternal	-
Diagnosis yang benar	Diagnosis Primer	Fraktur tertutup bagian tengah tulang humerus kiri
	Penyebab Eksternal	Penumpang sepeda motor terluka dalam kecelakaan lalu lintas non-tabrakan selama aktivitas rekreasi

2.2 Aturan Koding Morbiditas ICD-10 Versi Tahun 2010:

Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam menetapkan diagnosis utama sesuai dengan pedoman penulisan diagnosis utama yang terdapat pada 2.1.1 yang dilakukan oleh dokter, maka pengode melakukan klarifikasi kepada dokter. Dalam hal pengode tidak berhasil melakukan klarifikasi kepada Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP), maka pengode menggunakan rule MB1 sampai MB5 untuk memilih kembali diagnosis utama (reseleksi), yaitu:

2.2.1 Rule MB1

Rule MB1 merupakan kondisi minor tercatat sebagai diagnosis utama, sedangkan kondisi yang lebih berarti dicatat sebagai diagnosis sekunder. Ketika kondisi minor atau yang telah berlangsung lama atau masalah insidental tercatat sebagai diagnosis utama, sedangkan kondisi yang lebih berarti, relevan dengan pengobatan dan/atau prosedur yang diberikan dan/atau spesialisasi perawatan tercatat sebagai diagnosis sekunder, maka reseleksi kondisi yang berarti tersebut sebagai diagnosis utama.

a. contoh 1:

Diagnosis Utama : Sinusitis akut

Diagnosis Sekunder : Karsinoma endoserviks
Hipertensi

Prosedur : Histerektomi total

Spesialisasi : Ginekologi

Pasien di rumah sakit selama tiga minggu, diberikan kode C53.0 (*Malignant Neoplasm, Endocervix*) sebagai diagnosis utama, sinusitis akut dan hipertensi sebagai diagnosis sekunder.

b. contoh 2:

Diagnosis Utama : Arthritis rheumatoid
Diagnosis Sekunder : Diabetes mellitus
Hernia femoralis terpuntir
Arteriosklerosis generalisata
Prosedur : *Herniorrhaphy*
Spesialisasi : Bedah umum

Pasien di rumah sakit selama tiga minggu., diberikan kode K41.3 (*Unilateral Or Unspecified Femoral Hernia, With Obstruction, Without Gangrene*) sebagai diagnosis utama, arthritis rheumatoid, diabetes mellitus, dan arteriosklerosis generalisata sebagai diagnosis sekunder.

2.2.2 Rule MB2

Rule MB2 merupakan beberapa kondisi yang dicatat sebagai diagnosis utama. Jika beberapa kondisi yang tidak bisa dikode bersamaan tercatat sebagai diagnosis utama, dan menunjukkan bahwa satu di antaranya adalah diagnosis utama pada asuhan pasien berdasarkan alasan utama pasien mendapatkan pelayanan kesehatan selama perawatan, pilih kondisi tersebut. Jika tidak, pilih kondisi yang sesuai dengan spesialisasi yang menangani.

a. contoh 1:

Diagnosis Utama : Katarak Meningitis stafilokokus
Penyakit jantung iskemik
Diagnosis Sekunder : -
Spesialisasi : Neurologi

Pasien di rumah sakit selama lima minggu, diberikan kode G00.3 (*Staphylococcal Meningitis*) sebagai diagnosis utama, katarak dan penyakit jantung iskemik sebagai diagnosis sekunder.

b. contoh 2:

Diagnosis Utama : Bronkitis obstruktif kronis
Hipertrofi prostat
Psoriasis vulgaris

Diagnosis Sekunder : -

Spesialisasi : Kulit dan Kelamin

Pasien diberikan kode L40.0 (*Psoriasis vulgaris*) sebagai diagnosis utama, bronkitis obstruktif kronis dan hipertrofi prostat sebagai diagnosis sekunder.

c. contoh 3:

Diagnosis Utama : Gastritis kronis
Keganasan sekunder di nodus limfa axilla
Karsinoma mammae

Diagnosis Sekunder : -

Prosedur : Mastektomi

Pasien diberikan kode C50.9 (*Malignant Neoplasm, Breast, Unspecified*) sebagai diagnosis utama, gastritis kronis dan keganasan sekunder di nodus limfa axilla sebagai diagnosis sekunder.

2.2.3 Rule MB3

Rule MB3 yaitu kondisi yang dicatat sebagai diagnosis utama, merupakan gejala dari kondisi yang telah didiagnosis dan diobati. Jika suatu gejala atau tanda (pada umumnya diklasifikasikan pada Bab XVIII), atau suatu masalah yang bisa diklasifikasikan pada Bab XXI, dicatat sebagai diagnosis utama, dan merupakan tanda, gejala atau masalah dari kondisi yang telah didiagnosis sebagai diagnosis sekunder dan telah dirawat, maka pilihlah kondisi yang didiagnosis tersebut sebagai diagnosis utama.

a. contoh 1:

Diagnosis Utama : Hematuria

Diagnosis Sekunder : Varises vena tungkai
Papillomata dinding belakang kandung kemih

Prosedur : Eksisi diatermi papillomata

Spesialis : Urologi

Pasien diberikan kode D41.4 (*Neoplasm Of Uncertain Or Unknown Behaviour Of Bladder*) sebagai diagnosis utama, hematuria dan varises vena tungkai sebagai diagnosis sekunder.

b. contoh 2:

Diagnosis Utama : Koma
Diagnosis Sekunder : Penyakit jantung iskemik
atherosclerosis
Diabetes mellitus, insulin dependent
Spesialis : Endokrinologi
Perawatan : Penentuan dosis insulin yang tepat

Pasien diberikan kode E10.0 (*Insulin-Dependent Diabetes Mellitus With Coma*) sebagai diagnosis utama karena status koma tersebut disebabkan oleh diabetes mellitus, sehingga digunakan kode kombinasi. Penyakit jantung iskemik dan atherosclerosis sebagai diagnosis sekunder.

c. contoh 3:

Diagnosis Utama : Kejang demam
Diagnosis Sekunder : Anemia

Pasien diberikan kode R56.0 (*Febrile Convulsions*) sebagai diagnosis utama. Anemia dikode sebagai diagnosis sekunder. Rule MB3 tidak berlaku karena diagnosis utama bukan gejala yang mewakili diagnosis sekunder.

2.2.4 Rule MB4

Rule MB4 merupakan kespesifikan. Jika suatu diagnosis utama menggambarkan kondisi yang bersifat umum, sementara diagnosis lainnya menjelaskan kondisi yang lebih spesifik/rinci mengenai anatomi atau penyebab yang dicatat pada resume medis, maka dipilih diagnosis yang lebih spesifik/rinci sebagai diagnosis utama.

a. contoh 1:

Diagnosis Utama : *Cerebrovascular accident*
Diagnosis Sekunder : *Diabetes mellitus*, Hipertensi, Perdarahan otak

Pasien diberikan kode I61.9 (*Intracerebral Haemorrhage, Unspecified*) sebagai diagnosis utama, diabetes mellitus dan hipertensi sebagai diagnosis sekunder, dan *cerebrovascular accident* tidak dikoding.

b. contoh 2:

Diagnosis Utama : Penyakit jantung kongenital

Diagnosis Sekunder : Defek septum ventrikel

Pasien diberikan kode Q21.0 (*Ventricular septal defect*) sebagai diagnosis utama dan penyakit jantung kongenital tidak dikoding.

2.2.5 Rule MB5

Rule MB5 merupakan diagnosis alternatif, yaitu:

Apabila terdapat gejala atau tanda yang ditulis sebagai diagnosis utama yang kemungkinan saling berkaitan, maka gejala tersebut sebagai diagnosis utama.

contoh:

Diagnosis Utama : Sakit kepala mungkin karena stress atau tegangan otot atau sinusitis akut

Diagnosis Sekunder : -

Pasien diberikan kode R51 (*Headache*) sebagai diagnosis utama jika terdapat dua atau lebih diagnosis tertulis sebagai diagnosis utama, maka dipilih diagnosis yang paling pertama ditulis oleh DPJP sebagai diagnosis utama.

contoh:

Diagnosis Utama : Kolesistitis akut atau pankreatitis akut

Diagnosis Sekunder : -

Pasien diberikan kode K81.0 (*Acute Cholecystitis*) sebagai diagnosis utama.

2.2.6 Aturan Koding Spesifik

2.2.6.1 Pengodean kondisi dugaan/suspek, gejala, penemuan abnormal, dan situasi tanpa penyakit

Jika pasien sedang menjalani episode perawatan, koder harus hati-hati dalam mengklasifikasikan diagnosis utama pada Bab XVIII (Kode R) dan

copyright@ Pusat pembiayaan kesehatan Kemenkes RI.

Dilarang mengcopy atau memperjualbelikan isi dan dokumen ini dalam bentuk apapun

XXI (Kode Z). Jika hingga akhir episode perawatan belum ada diagnosis spesifik yang bisa ditegakkan, atau tidak ada penyakit / cedera yang bisa dikode, maka kode dalam Bab XVIII dan XXI dapat digunakan sebagai kode diagnosis utama (lihat juga *rules* MB3 dan MB5).

Kode gejala dan tanda dalam ICD-10-IM merujuk pada kode yang digunakan untuk mencatat keluhan atau tanda klinis pasien. Secara umum, pengode tidak perlu memberikan kode gejala atau tanda jika penyebabnya sudah jelas dari diagnosis utama dan/atau sekunder atau komorbiditas atau komplikasi yang telah ditetapkan.

Prinsip Pemberian Kode Gejala dan Tanda:

- 1) Prinsip Umum, jika gejala atau tanda berasal dari diagnosis yang sudah dikodekan, kode gejala/tanda tersebut tidak perlu dicantumkan. Contoh: Jika pasien demam karena *Pneumonia, unspecified* (J18.9), maka kode "*Fever, unspecified*" (R50.9) tidak perlu ditambahkan.
- 2) Gejala atau tanda tetap perlu dikodekan jika hanya muncul pada sebagian kasus penyakit tertentu (kriteria khusus) dan menunjukkan tingkat keparahan atau karakteristik klinis yang mempengaruhi penanganan pasien. Contoh: "Nyeri dada" pada serangan jantung dengan diagnosis *Acute myocardial infarction, unspecified* (I21.9), maka kode Nyeri Dada tetap perlu dikodekan jika menjadi indikator utama keparahan.

Kapan Kode Gejala/Tanda Diberikan?

- 1) Jika dokter tidak mengetahui penyebab gejala/tanda. Contoh: Pasien datang dengan "nyeri kepala" tanpa diagnosis pasti, maka diberikan kode R51 (Nyeri kepala).
- 2) Jika diagnosis pasti belum dapat ditegakkan sampai akhir perawatan. Contoh: Pasien dirawat karena "sesak napas" tetapi pulang sebelum diagnosis pasti ditegakkan, maka diberikan kode R06.0 (*Dyspnea*).
- 3) Jika pasien dirujuk ke fasilitas kesehatan lain sebelum diagnosis pasti ditegakkan. Contoh: Pasien dengan "perdarahan saluran cerna" dirujuk tanpa hasil endoskopi, maka diberikan kode K92.2 (*Gastrointestinal haemorrhage, unspecified*).

- 4) Jika pemeriksaan khusus belum dilakukan untuk memastikan diagnosis. Contoh: Pasien "sakit perut" menunggu hasil USG, maka diberikan kode R10.4 (*Other and unspecified abdominal pain*).

Kategori Z03.– (*Medical observation and evaluation for suspected diseases and conditions*) digunakan untuk diagnosis suspek setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan sesuai dengan standar pelayanan dan diagnosis tidak ditegakkan. Diagnosis suspek dapat diartikan sebagai:

- 1) diagnosis awal yang dibuat sebelum ditegakkan diagnosis pasti ; dan/atau
- 2) diagnosis yang ditegakkan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan/atau pemeriksaan penunjang.

Contoh diagnosis suspek antara lain:

- 1) contoh 1:

Ditemukan massa/benjolan di payudara kiri berdasarkan hasil pemeriksaan klinis yang dominan maka diagnosis utama adalah suspek neoplasma di payudara kiri sehingga diberikan kode Z03.1 (*Observation For Suspected Malignant Neoplasm*).

Untuk kasus neoplasma dengan hasil pemeriksaan patologi anatomi (PA) dinyatakan sebagai neoplasm of *uncertain or unknown behaviour* maka menggunakan kode diagnosis D37-D48 tergantung lokasinya.

- 2) contoh 2:

Diagnosis Utama	: Neoplasma faring
Diagnosis Sekunder	: -
Tindakan	: Pemeriksaan PA dengan hasil jenis tumor tidak diketahui

Diberikan kode D37.0 (*Neoplasm of Uncertain or Unknown Behaviour of Lip, Oral Cavity and Pharynx*) sebagai diagnosis utama dan kode 90.34 (*Microscopic examination of specimen from ear, nose, throat, and larynx, parasitology*) sebagai tindakan.

- 3) contoh 3:

Diagnosis Utama	: Epistaxis berat
-----------------	-------------------

Diagnosis Sekunder : -

Pasien menjalani rawat inap selama satu hari tanpa laporan prosedur atau pemeriksaan.

Diberikan kode R04.0 (*Epistaxis*). Hal ini dapat diterima karena pasien jelas dirawat hanya untuk kondisi darurat.

2.2.6.2 Pengodean kondisi multipel

Prinsip pemberian kode untuk penyakit dengan lokasi/bentuk *multiple* (lebih dari satu) adalah sebagai berikut.

a. Jika penyakit memiliki tingkat keparahan berbeda

Jika penyakit memiliki tingkat keparahan yang berbeda di beberapa lokasi atau manifestasi, maka tidak perlu memberikan kode untuk semua lokasi atau manifestasi tersebut. Cukup gunakan kode untuk kondisi yang paling parah atau menjadi fokus utama penanganan.

b. Jika penyakit memiliki tingkat keparahan sama

Apabila suatu penyakit menunjukkan tingkat keparahan yang seragam pada beberapa lokasi atau variasi, maka gunakan kode gabungan untuk mewakili semua lokasi atau variasi tersebut sebagai diagnosis utama. Selanjutnya, tambahkan kode spesifik untuk masing-masing lokasi atau variasi sebagai diagnosis tambahan. Contohnya, pada pasien dengan luka lecet di beberapa area dengan tingkat keparahan yang sama, kode gabungan digunakan sebagai diagnosis utama, sementara detail lokasi luka dicantumkan sebagai diagnosis sekunder.

c. Jika tidak ada detail yang jelas

Jika informasi detail mengenai lokasi atau bentuk penyakit tidak tersedia, penggunaan kode umum (misalnya, "cedera *multiple*") mungkin diperlukan. Namun, pengode tidak disarankan langsung memilih opsi ini apabila informasi tambahan masih dapat diperoleh dari rekam medis. Contohnya, jika dokter hanya mencatat diagnosis umum seperti "*multiple abrasion*" tanpa menyebutkan lokasi luka secara spesifik, tetapi catatan perawat di ruang gawat darurat

mencantumkan lokasi luka dengan jelas, maka pengode harus berkoordinasi dengan dokter untuk meninjau ulang diagnosis dan meminta detail lokasi luka sebelum mengkode setiap luka secara terpisah.

Selain itu, penggunaan kode ganda (*multiple coding*) diterapkan ketika terdapat diagnosis untuk kondisi multipel, seperti cedera multipel, sekuele (gejala sisa) multipel dari penyakit atau cedera sebelumnya, atau kondisi multipel yang muncul pada penyakit *Human Immunodeficiency Virus* (HIV). **Kondisi tersebut meliputi:**

- a. jika salah satu kondisi lebih berat **secara klinis** dan lebih banyak menggunakan sumber daya dibandingkan dengan yang lain, maka **kondisi tersebut** dicatat sebagai diagnosis utama, sementara kondisi lain sebagai diagnosis sekunder.
- b. jika tidak ada satu kondisi yang lebih dominan, maka diagnosis seperti fraktur multipel, cedera kepala multiple, atau penyakit HIV yang menyebabkan infeksi multipel **ditetapkan sebagai** diagnosis utama, sedangkan kondisi spesifiknya dicatat sebagai diagnosis sekunder.

Contoh kondisi *multiple* antara lain:

a. contoh 1 :

Diagnosis Utama : HIV *disease resulting in multiple infections*

Diagnosis Sekunder : HIV *disease resulting in candidiasis*
HIV *disease resulting in other viral infections*

Diberikan kode B20.7 (HIV *disease resulting in multiple infections*) sebagai diagnosis utama, B20.4 (HIV *disease resulting in candidiasis*) dan B20.3 (HIV *disease resulting in other viral infections*) sebagai diagnosis sekunder.

b. contoh 2 :

Diagnosis Utama : *Multiple open fracture of femur*

Diagnosis Sekunder : *Open fracture of shaft of femur*
Open fracture of lower end of femur

Diberikan kode S72.71 (*multiple open fracture of femur*) sebagai diagnosis utama, S72.31 (*open fracture of shaft of femur*) dan S72.41 (*open fracture of lower end of femur*) sebagai diagnosis sekunder.

c. contoh 3 :

Diagnosis Utama : *Multiple closed fracture upper limbs*

Diagnosis Sekunder : *closed fracture shaft humerus*
closed fracture radius-ulna

Tindakan : ORIF *humerus* ORIF *radius-ulna*

Diberikan kode T02.40 (*Multiple closed fracture upper limbs*) sebagai diagnosis utama, S42.30 (*closed fracture shaft humerus*) dan S52.30 (*closed fracture radius-ulna*) sebagai diagnosis sekunder. Kode 79.31 (*Open reduction of fracture with internal fixation, humerus*) dan 79.02 (*Closed reduction of fracture without internal fixation, radius and ulna*) sebagai tindakan.

2.2.6.3 Pengodean kategori kombinasi

Kode kombinasi/gabungan adalah kode tunggal dalam ICD-10 yang mencakup lebih dari satu penyakit atau kondisi medis dalam satu deskripsi kode. Kode ini dirancang untuk menggambarkan beberapa kondisi yang terjadi bersamaan secara jelas dan spesifik. Jika pengode (*coder*) dapat menggunakan satu kode gabungan untuk mencakup semua penyakit yang diderita pasien, maka kode tersebut harus diprioritaskan.

Prinsip pemberian kode gabungan

- a. Kode tunggal untuk lebih dari satu kondisi (*multiple condition*)

Kode gabungan harus mencakup seluruh penyakit yang relevan dengan pasien dalam satu kode tanpa perlu kode tambahan.

- b. Konsistensi saat penguraian kode

Jika kode gabungan diuraikan, seluruh penyakit yang termasuk dalam kode tersebut harus dapat diidentifikasi kembali secara lengkap.

- c. Bukan untuk kode ambigu atau multi-lokasi

Kode gabungan tidak boleh digunakan untuk:

- 1) Kondisi yang tidak terkait secara klinis.
- 2) Penyakit yang muncul di lokasi tubuh berbeda (misal: fraktur di tangan dan kaki).
- 3) Diagnosis yang tidak spesifik (misal: "infeksi saluran pernapasan" tanpa detail).

Berikut adalah beberapa contoh pengodean kategori kombinasi

contoh 1:

Diagnosis Utama : Gagal ginjal
 Diagnosis Sekunder : Penyakit ginjal hipertensi
 Diberikan kode I12.0 (*Hypertensive Renal Disease With Renal Failure*) sebagai diagnosis utama.

contoh 2

Diagnosis Utama : Glaukoma karena peradangan mata
 Diagnosis Sekunder : Penyakit ginjal hipertensi
 Diberikan H40.4 (*Glaucoma Secondary to Eye Inflammation*) sebagai diagnosis utama.

contoh 3

Diagnosis Utama : Obstruksi usus
 Diagnosis Sekunder : Hernia inguinalis kiri
 Diberikan kode K40.3 (*Unilateral or Unspecified Inguinal Hernia, With Obstruction, Without Gangrene*) sebagai diagnosis utama.

contoh 4:

Diagnosis Utama : Katarak diabetes tergantung insulin
 Diagnosis Sekunder : Hipertensi
 Spesialisasi : Oftalmologi
 Diberikan kode E10.3† (*Insulin-Dependent Diabetes Mellitus with Ophthalmic Complications*) sebagai diagnosis utama dan H28.0* (*Diabetic Cataract (E10-E14) with Common Fourth Character 3*)

serta I10 (*Essential (Primary) Hypertension*) sebagai diagnosis sekunder.

2.2.6.4 Pengodean sekuele kondisi tertentu.

Kode ICD-10-IM diberikan untuk sekuele (“*sequelae of...*”), yaitu B90-B94, E64.-, E68, G09, I69.-, O97, T90-T98, dan Y85-Y89. Kode sekuele digunakan untuk menunjukkan kondisi yang merupakan sisa atau dampak dari suatu penyakit yang telah terjadi sebelumnya.

Aturan koding untuk sekuele yaitu:

- a. jika terdapat kondisi yang lebih spesifik daripada sekuele, sebagai penyebab masalah yang saat ini sedang diperiksa atau diobati, maka kondisi tersebut ditetapkan sebagai diagnosis utama dan kode “*sequelae of...*” ditambahkan sebagai diagnosis sekunder.

1) contoh 1:

Diagnosis Utama : Dysphasia akibat infark otak lama

Diagnosis Sekunder : -

Diberikan kode R47.0 (*Dysphasia and Aphasia*) sebagai diagnosis utama dan I69.3 (*Sequelae of Cerebral Infarction*) sebagai diagnosis sekunder.

2) contoh 2:

Diagnosis Utama : Osteoarthritis sendi panggul
akibat fraktur lama panggul
karena kecelakaan kendaraan
bermotor 10 tahun yang lalu

Diagnosis Sekunder : -

Diberikan kode M16.5 (*Other post-traumatic coxarthrosis*) sebagai diagnosis utama dan T93.1 (*Sequelae of Fracture of Femur*) sebagai diagnosis sekunder.

3) contoh 3:

Diagnosis Utama : Epilepsi akibat abses lama otak

Diagnosis Sekunder : Neurologi

Diberikan kode G40.9 (*Epilepsy, Unspecified*) sebagai diagnosis utama dan G09 (*Sequelae of inflammatory diseases of central nervous system*) sebagai diagnosis sekunder.

- b. jika tidak ada kondisi yang lebih spesifik daripada sekuele, maka sekuele menjadi diagnosis utama.

contoh:

Diagnosis Utama : Efek lanjut poliomyelitis

Diagnosis Sekunder : -

Diberikan kode B91 (*Sequelae of poliomyelitis*) sebagai diagnosis utama karena informasi lain tidak tersedia.

2.2.6.5 Pengodean kondisi-kondisi akut dan kronis.

Pengodean kondisi-kondisi akut dan kronis diatur sebagai berikut:

Jika diagnosis utama dicatat sebagai kondisi akut (atau subakut) dan kronis, dan ICD-10 menyediakan kategori atau subkategori yang terpisah untuk masing-masing kondisi tetapi tidak menyediakan satu kode gabungan untuk keduanya, maka kondisi akut harus digunakan sebagai diagnosis utama.

contoh:

Diagnosis Utama : PPOK dengan eksaserbasi akut

Diagnosis Sekunder : -

Diberikan kode J44.1 (*Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation*) sebagai diagnosis utama karena disini terdapat kode gabungan akut dan kronis.

jika ICD-10 tidak menyediakan kategori atau subkategori yang terpisah untuk masing-masing kondisi, maka kondisi akut ditetapkan sebagai diagnosis utama, dan kondisi kronis sebagai diagnosis sekunder.

contoh:

Diagnosis Utama : Gagal ginjal akut dan kronik

Diagnosis Sekunder : -

Tindakan : -

Diberikan kode N17.9 (*Acute Renal Failure, Unspecified*) sebagai diagnosis utama dan gagal ginjal kronik sebagai diagnosis sekunder.

jika kondisi akut dan kronis terjadi pada organ/sistem tubuh yang berbeda, maka diagnosis utama **ditetapkan pada** kondisi yang menghabiskan sumber daya paling banyak.

contoh:

Diagnosis Utama : Gastritis Akut

Diagnosis Sekunder : CKD Stage 5

Tindakan : Hemodialisa

Diberikan kode N18.5 (*Chronic Kidney Disease, Stage 5*) sebagai diagnosis utama dan K29.1 (*Other Acute Gastritis*) sebagai diagnosis sekunder dan Hemodialisa sebagai Tindakan.

2.2.6.6 Pengodean kondisi pasca-prosedur dan komplikasinya.

Terdapat tiga jenis kode komplikasi, yaitu:

- a. kelompok kategori komplikasi pada Bab XIX (T80-T88) yang berhubungan dengan operasi dan prosedur lain, contohnya infeksi luka operasi, komplikasi mekanis benda-benda implantasi, syok, dan lainnya.

contoh:

Diagnosis Utama : Perdarahan berlebihan setelah pencabutan gigi

Diagnosis Sekunder : -

Spesialis : Gigi

Diberikan kode T81.0 (*Haemorrhage and Haematoma Complicating a Procedures NEC*) sebagai diagnosis utama.

- b. Menggunakan kondisi yang dinyatakan *post-procedural* atau *post-operative*

contoh:

Diagnosis Utama : Hipotiroidisme sejak tiroidektomi 1 tahun yang lalu

Diagnosis Sekunder : -

Spesialis : Penyakit dalam

Diberikan kode E89.0 (*Postprocedural Hypothyroidism*) sebagai diagnosis utama.

- c. Menggunakan kode sesuai kondisi yang ada, disertai tambahan kode Y83-Y84 untuk menjelaskan keadaan *post-procedural*

contoh:

Diagnosis Utama : Psikosis pasca-bedah setelah operasi plastik

Diagnosis Sekunder : -

Spesialis : Psikiatri

Diberikan kode F09 (*Unspecified Organic or Symptomatic Mental Disorder*) sebagai diagnosis utama dan Y83.8 (*Other Surgical Procedures*) sebagai diagnosis sekunder yang merupakan penyebab dari reaksi abnormal pasien untuk mengindikasikan hubungan pasca bedah.

2.2.6.7 Pengodean untuk penyakit Human Immunodeficiency Virus (HIV) (B20-B24).

- a. Koding iDRG menggunakan kode 4 karakter untuk subkategori pada B20-B23 yang berfungsi untuk mengidentifikasi kondisi yang lebih spesifik.

contoh 1:

Diagnosis Utama : Penyakit HIV dan sarkoma Kaposi

Diagnosis Sekunder : -

Diberikan kode B21.0 (*HIV Disease Resulting in Kaposi's Sarcoma*) sebagai diagnosis utama.

contoh 2:

Diagnosis Utama : Penyakit HIV dan kandidiasis

Diagnosis Sekunder : -

Diberikan kode B20.4 (*HIV Disease Resulting in Candidiasis*) sebagai diagnosis utama.

- b. jika diagnosis utama yang dicatat adalah penyakit HIV memiliki lebih dari satu penyakit penyerta yang terkait, maka gunakan subkategori -.7 dari kode B20-B22.. Pengode dapat menggunakan kode B22.7 bila kondisi pasien mencakup dua atau lebih kategori yang termasuk dalam B20-B22 dan tidak dapat diklasifikasikan secara spesifik dalam salah satu kode saja.. Kode tambahan dari dalam blok B20-B24 digunakan sebagai diagnosis sekunder.

contoh 1:

Diagnosis Utama : Toxoplasmosis dan cryptococcosis pada pasien HIV

Diagnosis Sekunder : -

Diberikan kode B20.7 (*HIV Disease Resulting in Multiple Infections*) sebagai diagnosis utama, B20.8 (*HIV Disease Resulting in Other Infectious and Parasitic Disease*) dan B20.5 (*HIV Disease Resulting in Other Mycoses*) sebagai diagnosis sekunder.

contoh 2:

Diagnosis Utama : Penyakit HIV dengan pneumonia *Pneumocystis carinii*, limfoma Burkitt dan kandidiasis mulut.

Diagnosis Sekunder : -

Diberikan kode B22.7 (*HIV Disease Resulting in Multiple Diseases Classified Elsewhere*) sebagai diagnosis utama. B20.6 (*HIV Disease Resulting in Pneumocystis Carinii Pneumonia*), B21.1 (*HIV Disease Resulting in Burkitt's Lymphoma*), dan B20.4 (*HIV Disease Resulting in Candidiasis*) sebagai diagnosis sekunder.

2.2.6.8 Pengodean Neoplasma.

- a. Kasus neoplasma baik primer atau sekunder (metastasis) yang merupakan fokus perawatan, harus dicatat dan dikode sebagai diagnosis utama.

contoh 1:

Diagnosis Utama : Karsinoma prostat

Diagnosis Sekunder : Bronkitis kronis

Prosedur : Prostatektomi

Diberikan kode C61 (*Malignant Neoplasm of Prostate*) sebagai diagnosis utama dan J42 (*Unspecified Chronic Bronchitis*) sebagai diagnosis sekunder.

- b. Pasien dengan riwayat neoplasma ganas yang tidak mendapatkan tatalaksana menggunakan kode Z85.0 – Z85.9 (*Personal history of malignant neoplasm*).

contoh 1:

Diagnosis Utama : Karsinoma mammae – diangkat dua tahun yang lalu

Diagnosis Sekunder : Karsinoma sekunder paru-paru

Prosedur : Bronkoskopi dengan biopsi

Diberikan kode C78.0 (*Secondary Malignant Neoplasm Of Lung*) sebagai diagnosis utama, Z85.3 (*Personal History Of Malignant Neoplasm Of Breast*) sebagai diagnosis sekunder.

contoh 2:

Diagnosis Utama : *Carcinoma bladder* telah diangkat, dirawat untuk pemeriksaan *follow-up* dengan *cystoscopy*

Diagnosis Sekunder : -

Prosedur : *Cystoscopy*

Diberikan kode Z08.0 (*Follow-Up Examination After Surgery For Malignant Neoplasm*) sebagai diagnosis utama, kode Z85.5

(*Personal History of Malignant Neoplasm of Urinary Tract*) sebagai diagnosis sekunder.

- c. Pasien yang menjalani pemeriksaan neoplasma karena riwayat keluarga dengan neoplasma ganas, menggunakan kode Z80.0 – Z80.9 (*Family history of malignant neoplasm*).

2.2.6.9 Pengodean diabetes mellitus (E10-E14).

Karakter keempat dari kode diabetes mellitus (E10-E14) yaitu sebagai berikut :

Digit 0 sampai digit 5 (.0 sampai .5) dan digit 7 (.7) cukup jelas sesuai dengan aturan ICD-10 Versi Tahun 2010.

contoh 1:

Diagnosis Utama : Gagal ginjal akibat glomerulonefrosis diabetes

Diagnosis Sekunder : -

Prosedur : Cystoscopy

Diberikan kode E14.2† dan N08.3* (*Unspecified Diabetes Mellitus With Renal Complications*).

contoh 2:

Diagnosis Utama : Diabetes Melitus tergantung insulin dengan nefropati, gangren, dan katarak

Diagnosis Sekunder : -

Diberikan kode E10.7 (*Insulin-Dependent Diabetes Mellitus With Multiple Complication*) sebagai diagnosis utama, kode E10.2† dan N08.3* (*Insulin-Dependent Diabetes Mellitus With Renal Complications*), kode E10.5 (*Insulin-Dependent Diabetes Mellitus With Peripheral Circulatory Complications*) serta kode E10.3† dan H28.0* (*Insulin- Dependent Diabetes Mellitus With Ophthalmic Complications*) sebagai diagnosis sekunder.

Digit 6 (.6) digunakan jika diabetes mellitus dengan komplikasi spesifik lainnya selain yang terdapat pada digit 0 sampai digit 5 (.0 sampai .5). Keterangan pada digit 6 (.6) dalam ICD-10 hanya merupakan

sebagian contoh kasus karena tidak terdapat lambang dagger (†) setelah digit keempat.

contoh 1:

Diagnosis Utama : Dermatitis diabetikum

Diagnosis Sekunder : -

Diberikan kode E14.6+ (*Unspecified Diabetes Mellitus With Other Specified Complications*) sebagai diagnosis utama dan L99.8* (*Other Specified Disorders Of Skin And Subcutaneous Tissue in Disease Classified Elsewhere*) sebagai diagnosis sekunder.

contoh 2:

Diagnosis Utama : Lancereaux's diabetes

Diagnosis Sekunder : -

Diberikan kode E14.6 (*Unspecified Diabetes Mellitus with Other Specified Complications*) sebagai diagnosis utama.

Digit 8 (-.8) digunakan jika diabetes mellitus dengan komplikasi yang tidak dijelaskan atau tidak spesifik dituliskan jenis komplikasinya.

Digit 9 (-.9) digunakan jika diabetes mellitus tanpa komplikasi.

contoh:

Diagnosis Utama : Diabetes mellitus tipe II

Diagnosis Sekunder : -

Diberikan kode dengan E11.9 (*Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus without Complications*) sebagai diagnosis utama.

2.2.6.10 Pengodean Persalinan (O80-O84).

- a. Kode-kode O80-O84 (*Delivery*) digunakan sebagai diagnosis sekunder untuk menunjukkan metode persalinan.
- b. Jika tidak terdapat komplikasi atau penyulit persalinan lainnya maka kode O80-O84 (*Delivery*) digunakan sebagai diagnosis utama.
- c. Kode Z37.0 – Z37.9 (*Outcome of delivery*) digunakan sebagai diagnosis sekunder.

contoh 1:

Diagnosis Utama : Persalinan

Diagnosis Sekunder : -

Prosedur : Persalinan dengan forseps rendah

Diberikan kode O81.0 (*Low Forceps Delivery*) sebagai diagnosis utama karena tidak ada informasi lain tersedia dan kode Z37.- (*Outcome of delivery*) sebagai diagnosis sekunder.

contoh 2:

Diagnosis Utama : Persalinan

Diagnosis Sekunder : Kegagalan percobaan persalinan

Prosedur : *Sectio Caesarean*

Diberikan kode O66.4 (*Failed Trial of Labour, Unspecified*) sebagai diagnosis utama. O82.9 (*Delivery by Caesarean Section, Unspecified*) dan kode Z37.- (*Outcome of Delivery*) sebagai diagnosis sekunder.

contoh 3:

Diagnosis Utama : Persalinan anak kembar

Diagnosis Sekunder : -

Prosedur : Persalinan spontan

Diberikan kode O30.0 (*Twin Pregnancy*) sebagai diagnosis utama. O84.0 (*Multiple Delivery, All Spontaneous*) dan kode Z37.- (*Outcome of delivery*) dikode sebagai diagnosis sekunder.

contoh 4

Diagnosis Utama : Hamil cukup bulan, melahirkan janin mati 2800gr

Diagnosis Sekunder : -

Prosedur : Kelahiran spontan

Diberikan kode O36.4 (*Maternal Care For Intrauterine Death*) karena penyebab spesifik kematian janin tidak bisa ditentukan,

sebagai diagnosis utama. Kode O80.- (*Single spontaneous delivery*) dan Z37.1 (*Single Stillbirth*) sebagai diagnosis sekunder.

contoh 5:

Diagnosis Utama : Ketuban pecah dini
Diagnosis Sekunder : Persalinan SC
Anemia
Bayi lahir hidup tunggal

Spesialis : Obgyn

Diberikan kode O42.9 (*Premature Rupture of Membranes, Unspecified*) sebagai diagnosis utama, O99.0 (*Anaemia complicating pregnancy, childbirth and the puerperium*), D64.9 (*Anaemia, Unspecified*), O82.- (*Single Delivery by Caesarean Section*) serta Z37.0 (*Single Live Birth*) sebagai diagnosis.

2.3 Pengodean Prosedur / Tindakan

Pengodean tindakan atau prosedur dilakukan untuk setiap tindakan medis yang telah dilakukan oleh dokter, baik di ruang operasi maupun di luar ruang operasi, yang memiliki keterkaitan langsung dengan diagnosis pasien. Proses pengodean ini menggunakan ketentuan pengodean prosedur yang berlaku berdasarkan ICD 9 CM 2010 dengan Indonesian Modification (IM). Kepatuhan terhadap standar ini sangat penting untuk memastikan akurasi data klinis, validitas klaim, serta kesesuaian pengelompokan kasus dalam sistem pembiayaan kesehatan.

2.3.1 Aturan dalam pengodean Tindakan / Prosedur

2.3.1.1 Kata “*See, See also*” (lihat, lihat juga);

Jika ada pernyataan “*see, see also*” di belakang pernyataan tindakan/prosedur, maka harus melihat juga pernyataan tindakan yang dimaksud.

contoh 1:

Atherectomy

coronary Atherectomy

- *Cerebrovascular –see Angioplasty*
- *Coronary –see Angioplasty coronary 36.09*

Diberikan kode 36.09 (*Angioplasty coronary*)

contoh 2:

Catheterization –see also Insertion,

- *Catheter arteriovenous* 39.93
- *Artery* 38.91

Maka harus dilihat juga *Insertion*.

2.3.1.2 Kata “omit code” (tidak dikoding);

Apabila terdapat keterangan “omit code” pada indeks alfabet, artinya prosedur tersebut termasuk dalam kode prosedur lain yang terkait dan tidak perlu dikodekan secara terpisah. Pemberian kode (*omit code*) untuk prosedur pendekatan operasi tidak diperlukan.

Prosedur pendekatan operasi (*Operative-approach procedure*) adalah tahap awal dalam operasi, terutama untuk operasi organ dalam, yang dimulai dengan membuka akses ke dalam tubuh. Prosedur ini harus dilakukan sebelum tindakan operasi utama untuk pengobatan. Contoh istilah yang menunjukkan pendekatan operasi adalah:

- *Craniotomy* : Membuka tengkorak dengan cara melubangi tulang kepala
- *Craniectomy* : Membuka tengkorak dengan mengangkat sebagian tulang kepala
- *Sternotomy* : Membuka rongga dada melalui tulang sternum (tengah)
- *Thoracotomy* : Membuka rongga dada dari sisi lateral
- *Laparotomy* : Membuka rongga perut
- *Laminectomy* : Membuka rongga tulang belakang dengan mengangkat lamina
- *Arthrotomy* : Membuka sendi

Prosedur pendekatan operasi (*Operative-approach procedure*) dapat diberikan pada salah satu kondisi khusus dibawah ini:

- a. Jika pendekatan operasi dilakukan sebagai satu-satunya tindakan (tanpa dilanjutkan dengan operasi pengobatan atau diagnosis lebih lanjut).
- b. Dalam kasus ini, kode pendekatan operasi dianggap sebagai kode utama/prosedur tunggal.

Contoh aturan *omit code*:

- Jika seorang pasien hanya menjalani *craniotomy* untuk mengakses tumor otak, tetapi tidak dilanjutkan dengan reseksi tumor, maka *craniotomy* dikodekan sebagai prosedur utama.
- Jika *craniotomy* diikuti dengan reseksi tumor, maka hanya reseksi tumor yang dikodekan, dan *craniotomy* diabaikan.

contoh 1:

Craniotomy 01.24
as operative approach – omit code
fetal 73.8
for decompression of fracture 02.02
reopening of site 01.23

contoh 2:

Laparotomy NEC 54.19
as operative approach --omit code
exploratory (pelvic) 54.11

contoh 3:

Laminectomy (decompression) (for exploration) 03.09
as operative approach --omit code

2.3.1.3 Kata “*code also*” (dikoding juga);

Jika ada pernyataan “*code also*” dibawah pernyataan tindakan atau prosedur yang telah dilakukan maka harus dikoding jika tindakan tersebut dilakukan.

contoh:

42.69 Antesternal anastomosis of esophagus dengan gastrostomy

Code also any synchronous :

esophagectomy (42.40 – 42.42)

gastrostomy (43.1)

Diberikan kode 42.69 (*antesternal anastomosis of esophagus*) dan 43.19 (*other gastrostomy*).

2.3.1.4. Kata “exclude” (tidak termasuk)

Jika ada pernyataan “*exclude*” di bawah pernyataan tindakan/prosedur maka harus dikoding yang lain sesuai dengan petunjuk “*exclude*” jika tindakan dalam kategori *exclude* tersebut yang dilakukan.

contoh:

Simple excision of lymphatic structure (40.2)

Exclude : biopsy of lymphatic structure (40.11)

2.3.1.5 Kata “includes” (termasuk).

Jika ada pernyataan “*includes*” di bawah pernyataan tindakan/prosedur maka pernyataan tindakan tersebut termasuk bagian atau contoh tindakan tersebut.

contoh:

35.2 *Replacement of heart valve*

Includes: Excision of heart valve with replacement

2.3.2 Kode Tindakan / Prosedur Operasi

Proses kodefikasi tindakan atau prosedur medis berperan penting dalam sistem iDRG karena kodefikasi yang akurat dan konsisten dapat memastikan tindakan yang dilakukan tercatat dengan benar. Hal ini berdampak langsung pada pengelompokan kasus dan tarif pembiayaan layanan kesehatan.

Setiap tindakan atau prosedur harus dimasukkan secara benar dan selaras dengan diagnosis utama pasien agar pengelompokan iDRG yang diperoleh sesuai. Algoritma pengelompokan iDRG mengacu pada hubungan klinis antara diagnosis dan prosedur yang dilakukan. Kesalahan atau ketidaksesuaian pengodean dapat

menyebabkan pengelompokan yang tidak tepat, memengaruhi validitas data klinis, akurasi klaim, serta tarif pembiayaan.

Kode Tindakan atau Prosedur adalah kode yang mewakili tindakan atau prosedur paling penting dalam perawatan pasien. Umumnya, ini adalah tindakan atau prosedur yang bertujuan untuk mengobati penyakit utama. Namun, dalam beberapa kasus, tindakan atau prosedur yang dilakukan bertujuan mengatasi komplikasi atau penyakit penyerta. Misalnya, pasien yang dirawat karena penyakit non bedah, tetapi mengalami komplikasi yang memerlukan prosedur medis. Dalam kasus ini, kode tindakan/prosedur utama adalah kode tindakan/prosedur untuk mengatasi komplikasi tersebut.

Pengode perlu menentukan urutan tindakan atau prosedur berdasarkan relevansi klinisnya dalam melakukan kodefikasi tindakan. Penentuan ini mencakup identifikasi tindakan atau prosedur utama serta tindakan atau prosedur sekunder. Dalam pencatatan ke dalam sistem iDRG, tindakan atau prosedur utama harus dicantumkan terlebih dahulu, yaitu pada urutan pertama. Selanjutnya, tindakan atau prosedur lainnya yang bersifat pendukung atau tambahan dapat diinput pada urutan berikutnya.

Tahapan Memilih Kode Operasi Utama:

- a. Prioritaskan operasi yang mengobati penyakit utama sebagai kode utama. Jika ada beberapa operasi untuk penyakit utama, pilih prosedur yang paling signifikan (misalnya, operasi yang mengatasi lesi/organ utama penyebab penyakit).
- b. Jika tidak ada operasi untuk penyakit utama, pilih operasi yang mengobati komplikasi sebagai kode utama.
- c. Jika ada beberapa operasi untuk komplikasi, pilih prosedur yang paling signifikan (misalnya, operasi yang mengatasi lesi/organ utama penyebab komplikasi).
- d. Jika tidak ada operasi untuk komplikasi, pilih operasi yang mengobati penyakit penyerta sebagai kode utama.
- e. Jika ada beberapa operasi untuk penyakit penyerta, pilih prosedur yang paling signifikan (misalnya, operasi yang mengatasi lesi/organ utama penyebab penyakit penyerta).

Catatan:

- Kode operasi utama harus ditentukan setelah semua kode operasi lainnya terdaftar.
- Kode operasi utama mencerminkan prioritas klinis, bukan urutan waktu pelaksanaan operasi.

Contoh:

- Pasien dengan kanker usus (penyakit utama) menjalani reseksi usus (operasi utama) dan pemasangan stoma (operasi tambahan). Kode prosedur utama adalah reseksi usus.
- Pasien dengan abses hati (penyakit utama) disertai dengan diabetes (komorbid) dan menjalani drainase abses. Kode prosedur utama adalah drainase abses.

2.4 Pendokumentasian Klinis

Pencatatan diagnosis utama dan diagnosis tambahan secara spesifik dan detail sangat penting pada pelayanan kesehatan. Tenaga medis bertanggung jawab untuk mencatat kondisi utama pasien beserta kondisi lain yang relevan pada setiap episode perawatan. Pencatatan harus dilakukan secara sistematis dan sesuai standar agar rekam medis menjadi sumber informasi akurat, sehingga tidak hanya untuk pengelolaan pasien tetapi juga sebagai data statistik kesehatan masyarakat.

Proses klaim pembiayaan rumah sakit yang menggunakan sistem iDRG tercakup dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia. Sistem ini mengelompokkan kasus berdasarkan diagnosis utama, diagnosis tambahan, prosedur medis, tingkat keparahan penyakit, usia pasien, dan faktor lainnya. Kelengkapan serta ketepatan pencatatan diagnosis sangat memengaruhi kelompok DRG yang menentukan besaran tarif klaim yang dibayarkan oleh BPJS kepada rumah sakit.

Jika diagnosis dicatat secara umum atau kurang spesifik, rumah sakit berisiko mendapatkan tarif klaim lebih rendah karena kasus akan masuk ke kelompok DRG dengan tingkat kompleksitas lebih rendah. Sebaliknya, pencatatan diagnosis yang lengkap dan detail memungkinkan pengelompokan kasus ke kategori paling tepat sehingga biaya pelayanan kesehatan dapat dibayarkan sesuai kompleksitas penanganannya. Rekam medis yang baik tidak hanya bermanfaat bagi manajemen klinis pasien tetapi juga berdampak langsung pada efisiensi dan kelancaran proses pembiayaan layanan kesehatan melalui JKN berbasis DRG.

Berikut hal-hal yang harus diperhatikan dalam pendokumentasian klinis pasien:

2.4.1 Gunakan Istilah Diagnosis Paling Spesifik

Istilah yang biasa dicatat dokter sebagai diagnosis pasien memiliki 4 karakteristik spesifisitas, diurutkan dari yang paling spesifik ke kurang spesifik sebagai berikut:

- a. Diagnosis Akhir (*Final Diagnosis*) merupakan diagnosis yang ditetapkan pada akhir pengobatan, setelah dilakukan evaluasi lengkap dan konfirmasi, misalnya: hasil laboratorium, pencitraan, atau pemeriksaan patologi.
- b. Diagnosis Sementara (*Provisional Diagnosis*) merupakan diagnosis awal yang ditetapkan saat mulai pengobatan, sebelum dilakukan konfirmasi lengkap, misalnya: diagnosis kerja, *suspect* atau dugaan sementara.
- c. Kondisi atau Sindrom merupakan kelompok gejala atau kondisi yang menggambarkan gangguan kesehatan secara umum, misalnya: sindrom nefrotik, sindrom metabolik.
- d. Gejala dan Tanda merupakan manifestasi klinis yang tidak spesifik, misalnya: demam, nyeri perut, batuk.
- e. Jika sampai akhir perawatan masih belum bisa ditegakkan diagnosisnya maka hindari penulisan diagnosis suspek atau dugaan sementara tetapi menuliskan gejala atau tanda atau temuan abnormal dari hasil pemeriksaan fisik atau penunjang.

2.4.2 Hindari Penggunaan Singkatan

Dokter tidak diperbolehkan menggunakan singkatan (*abbreviation*) dalam penulisan *resume medis* (ringkasan pulang) dalam kondisi apa pun. Hal ini berisiko menyebabkan kesalahan kode yang tidak sesuai dengan kondisi pasien.

Singkatan dalam dokumen medis hanya boleh digunakan untuk keperluan internal rumah sakit dan harus dihindari dalam *pendokumentasian catatan medis* yang akan digunakan untuk pengodean iDRG.

2.5 Hal - Hal yang harus dilakukan Pengode dalam memberikan kode diagnosis atau tindakan/prosedur

2.5.1 Prinsip Pengodean Diagnosis

Prinsip pengodean yang penting adalah selalu menggunakan diagnosis akhir (a) sebagai dasar pemberian kode karena diagnosis ini merupakan hasil penilaian

copyright@ Pusat pembiayaan kesehatan Kemenkes RI.

Dilarang mengcopy atau memperjualbelikan isi dan dokumen ini dalam bentuk apapun

medis paling pasti dan definitif setelah evaluasi lengkap pasien. Jika diagnosis akhir sudah ditetapkan, maka gejala (d), kondisi atau sindrom sementara (c), serta diagnosis sementara (b) yang terkait tidak perlu dikodekan untuk menghindari duplikasi dan memastikan data rekam medis hanya mencerminkan kondisi yang jelas dan telah dikonfirmasi. Fokus pengodean harus pada diagnosis yang paling spesifik dan definitif agar informasi kesehatan pasien tercatat dengan tepat, mendukung manajemen klinis yang baik, serta mempermudah proses pembiayaan layanan kesehatan seperti JKN berbasis DRG sesuai tingkat keparahan penyakit sebenarnya.

Contoh Kasus

Pasien datang dengan diagnosis awal abdomen akut dan menjalani operasi. Catatan operasi menunjukkan adanya ulkus kronis di dinding anterior bagian pertama duodenum dengan perforasi berukuran 3 mm. Dalam ringkasan pulang (*resume medis*), dokter menyimpulkan bahwa kondisi pasien adalah perforasi ulkus duodenum kronis pada bagian pertama duodenum. Diagnosis akhir ini mencerminkan temuan spesifik dari pemeriksaan operasi, menggantikan diagnosis awal yang lebih umum (abdomen akut). Perforasi ulkus kronis ini menjadi fokus utama pengobatan dan kode diagnosis sesuai ICD-10 (K26.9) digunakan untuk dokumentasi medis.

diagnosis primer : Peritonitis dari perforasi tukak lambung

diagnosis sekunder : Tukak lambung

Contoh di atas, ringkasan untuk kasus diatas dapat ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 9. Contoh prinsip pengodean diagnosis

Diagnosis Akhir (a)	Ulkus kronis di dinding anterior 1 bagian dari duodenum dengan perforasi
Diagnosis Sementara (b)	Perforasi tukak lambung
Keadaan (c)	Peritonitis
Tanda & Gejala (d)	Nyeri perut akut

Pada kasus tersebut, pengode hanya menggunakan kode diagnosis akhir, yaitu K26.5 (*Chronic duodenal ulcer with perforation*) tanpa perlu memberikan kode tambahan untuk kondisi seperti *peptic ulcer perforation*, peritonitis, atau nyeri perut akut.

Maka Prinsip Pengodean adalah sebagai berikut :

copyright@ Pusat pembiayaan kesehatan Kemenkes RI.

Dilarang mengcopy atau memperjualbelikan isi dan dokumen ini dalam bentuk apapun

- Selalu gunakan Diagnosis Akhir (**a**) sebagai dasar pemberian kode penyakit.
- Jika Diagnosis Akhir (**a**) telah ditetapkan, jangan mengkodekan gejala (**d**), kondisi/sindrom (**c**), atau Diagnosis Sementara (**b**) yang terkait.
- Kode hanya berfokus pada diagnosis yang paling spesifik dan definitif.

2.5.2 Penentuan Kode Berdasarkan Dokumentasi

Setiap kode yang diberikan harus didukung oleh bukti tertulis, misalnya catatan medis, hasil laboratorium, laporan operasi, atau gambar radiologi, yang membuktikan **penegakan** diagnosis atau prosedur.

Contoh:

Catatan dokter pada *resume* medis (ringkasan pulang) adalah diagnosis utama Radang paru-paru sedangkan diagnosis sekunder adalah Diabetes mellitus, dalam laporan pemeriksaan *X-Ray*, ahli radiologi melaporkan bahwa pneumonia lobar ditemukan di lobus atas kiri dalam kultur dahak ditemukan *Klebsiella Pneumoniae*. Pasien terinfeksi HIV dan tidak memiliki gejala HIV. Mengenai tata cara pengodean HIV dapat dilihat pada aturan pengodean dasar dan MDC 28.

Dalam kasus ini pengode memberikan kode sebagai berikut namun kurang tepat:

diagnosis primer : J15.0 *Pneumonia due to Klebsiella pneumoniae*

diagnosis sekunder : E10.9 *Insulin-dependent diabetes mellitus, without complication*

Z21 *Asymptomatic human immunodeficiency virus [HIV] infection status*

Semua kode dalam contoh di atas dianggap tidak tepat karena dinilai berlebihan (*over-coding*) dengan alasan berikut:

- Hasil kultur sputum tidak dapat dijadikan dasar pemberian kode, pengode harus konfirmasi kepada dokter mengenai kepastian diagnosis pneumonia dan dokter perlu melengkapinya dalam rekam medis mengenai diagnosis klebsiella pneumonia.
- Dalam kasus ini, kode J18.1 (*Lobar pneumonia*) seharusnya didasarkan pada laporan X-ray oleh dokter radiologi, bukan hasil kultur sputum.
- Meskipun kultur sputum menemukan *Klebsiella pneumoniae*, hal ini hanya menunjukkan penyebab infeksi, bukan diagnosis klinis pneumonia itu sendiri.
- Bila secara klinis dan pemeriksaan penunjang sudah ditegaskan oleh dokter dan terdokumentasi dalam rekam medis maka kode **J15.0 dapat digunakan**.

- e. Pemberian insulin dalam catatan perawatan tidak dapat digunakan untuk mendiagnosis diabetes tipe 1
- f. Mengasumsikan diabetes tipe 1 hanya dari penggunaan insulin adalah spekulasi yang tidak valid.
- g. Catatan perawatan (misalnya: pemberian obat) tidak memenuhi syarat sebagai bukti untuk diagnosis, kecuali jika disertai konfirmasi klinis, misalnya: hasil tes gula darah atau diagnosis dokter.
- h. Pastikan pengode melakukan konfirmasi kepada dokter untuk memastikan tipe diabetes yang diderita pasien dan lengkapi rekam medis dan resume medis.

2.5.3 Bukti Pendukung yang sah saat menentukan kode diagnosis:

Data dalam rekam medis yang dapat digunakan untuk mendukung kode adalah:

a. **Diagnosis Dokter yang Tervalidasi**

Diagnosis yang tercantum dalam dokumen rekam medis, seperti *resume medis (ringkasan pulang)*, catatan operasi, atau laporan klinis yang telah dianalisis untuk memastikan akurasi pengodean.

b. **Laporan Pemeriksaan Radiologi atau Penunjang Khusus lainnya**

Hasil pemeriksaan radiologi (X-ray, USG, CT scan) atau pemeriksaan khusus yang dianalisis oleh dokter spesialis. Contoh: Laporan X-ray yang menyebutkan lobar pneumonia oleh dokter radiologi.

c. **Laporan Patologi Anatomi**

Hasil pemeriksaan jaringan atau cairan tubuh (darah, urine, feses, sputum) yang dianalisis oleh dokter patologi.

d. **Hasil Laboratorium yang Diinterpretasi**

Hasil laboratorium abnormal yang diinterpretasi oleh dokter sebagai diagnosis penyakit.

2.5.4 Bukti pendukung yang Tidak Sah untuk menentukan kode diagnosis:

a. **Spekulasi dari Resep atau Catatan Perawatan**

Menebak diagnosis hanya dari resep obat (misalnya: insulin) atau permintaan pemeriksaan tanpa konfirmasi klinis.

b. **Simbol atau Kode Internal Rumah Sakit**

Kode khusus (misalnya: "UP" untuk asymptomatic HIV infection) yang hanya berlaku di satu institusi dan tidak sesuai standar ICD-10.

2.6 IM Pada ICD-10 dan ICD 9 CM

Indonesian Modification merupakan kode baru yang dibuat di dalam ICD-10 dan ICD 9 CM. Kode tersebut dibuat karena pengode tidak dapat menemukan kode diagnosis dan/atau tindakan/prosedur yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh dokter pada sistem aslinya. Para dokter melalui organisasi profesi mengirimkan usulan terkait tindakan-tindakan yang belum ada didalam ICD untuk dilakukan telaah apakah perlu dibuatkan kode baru atau hanya ditambahkan *include* di dalam ICD.

Indonesian Modification merupakan penyesuaian kode yang dikembangkan dalam sistem ICD-10 dan ICD-9-CM, yang dibuat sebagai respons terhadap kebutuhan pengodean di lapangan. Dalam proses penyusunannya, organisasi profesi kedokteran mengajukan usulan terkait tindakan-tindakan medis yang belum tercantum dalam sistem klasifikasi ICD. Usulan tersebut selanjutnya ditelaah untuk menentukan penanganan yang tepat, yaitu dengan menetapkan kode baru atau menambahkan keterangan *include* pada kode yang telah ada dalam ICD.

Sebagai contoh di dalam ICD 9 CM, penggantian katup jantung tidak dibedakan antara satu katup jantung atau lebih dari satu yang diganti. Padahal, jika dilakukan penggantian katup lebih dari satu memiliki nominal dan penggunaan sumber daya yang lebih besar pula, maka dari itu dibuatlah kode baru berupa *Indonesia Modification*.

Contoh lainnya, prosedur bedah urologi yang bertujuan untuk memperluas leher kandung kemih (*bladder neck*) yang menyempit atau terhambat, umumnya disebabkan oleh striktur atau stenosis. Prosedur ini dilakukan dengan menggunakan alat bedah (sistoskopi) yang dimasukkan melalui uretra. Sayatan dibuat pada *bladder neck* menggunakan kauter atau serat laser. Tujuannya adalah untuk meningkatkan aliran urin dan mempermudah buang air kecil. Prosedur tersebut belum terklasifikasi dalam ICD-9-CM 2010, sehingga dibuatlah penambahan kode 57.13.

Contoh Kode (IM) dan Prosedur Include

- 57.1 Cystotomy and cystostomy
Excludes: cystotomy and cystostomy as operative approach -- omit
- 57.11 Percutaneous aspiration of bladder
- 57.12 Lysis of intraluminal adhesions with incision into bladder
Excludes: transurethral lysis of intraluminal adhesions (57.41)
- 57.13 Endoscopic bladder neck incision (IM)
Includes : Endoscopic bladder neck resection
- 57.17 Percutaneous cystostomy
Closed cystostomy
Percutaneous suprapubic cystostomy
Other suprapubic cystostomy
Cystostomy Closure
- Penambahan kode
- Include prosedur

Gambar 1. Contoh kode (IM) dan Prosedur Include

Dari gambar di atas, tulisan yang berwarna merah merupakan kode baru sedangkan yang berwarna biru merupakan *include* yang ditambahkan dan yang berwarna hijau adalah *notes* atau catatan mengenai kode tersebut.

CHAPTER III KETENTUAN & PERHATIAN KHUSUS KODING iDRG

Pengode (*coder*) harus memperhatikan dokumentasi klinis yang tercantum dalam rekam medis dan menentukan kode diagnosis serta prosedur/tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam ICD-10 IM dan ICD 9 CM-IM. Selain itu, pengode juga wajib mengikuti ketentuan khusus terkait tata cara pengode yang disesuaikan dengan kekhususan kasus pada setiap MDC dalam sistem iDRG.

Berikut ini adalah perhatian khusus yang harus diperhatikan oleh pengode:

3.1 MDC 11 Sistem Syaraf

Beberapa kondisi yang termasuk dalam bab ini dapat disebabkan oleh efek obat atau faktor eksternal lainnya. Kode dari Bab XX dapat digunakan sebagai kode tambahan (diagnosa sekunder) sesuai kebutuhan.

PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 11

- Kasus Pasien yang mendapatkan terapi *Thrombolytic Agent Injection/Infusion* inputkan kode 99.10 *Injection or infusion of thrombolytic agent* dalam tindakan iDRG, terutama pada kasus *Ischemic Stroke with Thrombolytic*.
- Kondisi *myopathy* (kelemahan otot) yang menyertai diagnosis *periodic paralysis* tidak dikode secara terpisah, melainkan digabung menjadi satu dengan kode G72.3 (*Periodic Paralysis*).
- Jika pasien *epilepsy* dirawat akibat luka yang terjadi saat serangan, maka diagnosis *injury* menjadi diagnosis utama dan dapat menambahkan kode sebab luar yang relevan dengan kode *epilepsy*-nya.
- Untuk tindakan di MDC 11 yang berkaitan dengan kelenjar pituitari dan/atau pineal, maka menggunakan kode 07.19 (*Other diagnostic procedures on adrenal glands, pituitary gland, pineal gland, and thymus*).
- Pada kode tindakan *adhesiolysis spinal cord* dan *nerve root* dengan teknik injeksi steroid dan analgetik, jika disesuaikan dengan ICD-9-CM tahun 2010, maka *adhesiolysis* (*Lysis Adhesion*) dengan tindakan tumpul, menggunakan jari-jemari, manual mekanik, dan tanpa instrumen merupakan *omit code* (tidak dikoding).

- Contoh: pada kasus operasi pasien, DPJP melakukan tindakan *adhesiolysis spinal cord* dan *nerve root* dengan teknik injeksi *triamcinolone* 80 mg (steroid). Tindakan tersebut adalah *adhesiolysis* tanpa instrumen (bedah) dan secara mekanik menggunakan agen steroid sehingga tidak dikoding, namun yang dikoding adalah tindakan injeksi *triamcinolone* 80 mg (steroid) tersebut. Sesuai dengan ICD-9-CM, kode tindakan injeksi *triamcinolone* 80 mg (steroid) pada *spinal root* menggunakan kode 03.92 (*Injection of other agent into spinal canal*).

PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 11

3.1.1 Meningitis (G00-G03)

Meningitis non infeksi akibat obat atau metastasis kanker harus **dikodekan sesuai dengan** etiologi spesifik.

Jika dokter mendiagnosis "*bacterial meningitis*" tetapi tidak diketahui jenis bakterinya, maka dapat menggunakan kode G00.9 (*Bacterial meningitis, unspecified*). Namun, jika hasil pemeriksaan mengidentifikasi adanya jenis bakteri spesifik, misalnya *pneumococcal*, maka dapat menggunakan kode G00.1 (*Pneumococcal meningitis*). Jika tidak dilakukan pemeriksaan kultur, maka dapat menggunakan kode G03.9 (*Meningitis, unspecified*).

3.1.2 Encephalitis And Myelitis (G04-G05)

Pada kasus *myelitis viral* (misalnya *cytomegalovirus*), dapat menggunakan kode G05.1* (*Encephalitis, myelitis, and encephalomyelitis in viral diseases classified elsewhere*) sebagai diagnosis tambahan dan kode virusnya sebagai diagnosis utama.

Pada kasus *myelitis transverse viral*, jika dokter mendiagnosis "*viral transverse myelitis*" tanpa menyebutkan jenis virusnya, maka dapat menggunakan kode G04.3 (*Viral transverse myelitis, unspecified*) ^(IM). Namun, jika virus penyebab diketahui, maka dapat menggunakan kode B00.4† (*Herpesviral encephalitis*) + G05.1* (*Encephalitis, myelitis, and encephalomyelitis in viral diseases classified elsewhere*).

Pada kasus *myelitis transverse acute non-viral*, jika **dokter mendiagnosis** "*acute transverse myelitis*" tanpa penyebab infeksi virus,

maka dapat menggunakan kode G37.3 (*Acute transverse myelitis in demyelinating disease of the central nervous system*). Jika terkait penyakit *demyelination* misalnya, *multiple sclerosis*, maka dapat menggunakan kode G35 (*Multiple sclerosis*). Jika penyebab tidak diketahui, maka dapat menggunakan kode yang sesuai dengan diagnosis klinis utama.

3.1.3 Intracranial And Intrapinal Abscess And Granuloma (G06-G07)

- Jika ditemukan *abscess* atau *granuloma* di otak, baik yang berlokasi di *epidural*, *extradural*, maupun *subdural*, maka dapat menggunakan kode G06.0 (*Intracranial abscess and granuloma*).
- Jika abses atau *granuloma* ditemukan di sumsum tulang belakang, baik yang berlokasi di *epidural*, *extradural*, maupun *subdural*, maka dapat menggunakan kode G06.1 (*Intrapinal abscess and granuloma*).
- Jika penyebab infeksi diketahui, maka kode etiologi harus digunakan sebagai diagnosis utama, dan dapat menambahkan kode abses atau granuloma. Sebagai contoh, jika abses otak disebabkan oleh *amoeba*, maka dapat menggunakan kode A06.6† (*Amoebic brain abscess*) sebagai diagnosis utama, kemudian dapat diikuti oleh kode G07* (*Intracranial and intrapinal abscess and granuloma in diseases classified elsewhere*) sebagai penanda kondisi komplementer.

3.1.4 Sequelae of inflammatory diseases of central nervous system (G09)

Kode G09 digunakan untuk mencatat kondisi sisa yang disebabkan oleh penyakit pada sistem saraf pusat yang diklasifikasikan di G00-G08, selama kode asalnya tidak bertanda *asterisk* (*). Kode ini mencakup kondisi sisa yang secara eksplisit dinyatakan sebagai ‘sekuel’, ‘late effect’, atau kondisi yang masih ada satu tahun atau lebih setelah penyakit awal.

Kode G09 tidak digunakan sebagai kode utama jika kondisi sisa (*residual*) sudah dicatat secara spesifik. Dalam pengodean untuk kondisi sisa, kode G09 dapat digunakan sebagai kode tambahan yang bersifat opsional. Perlu diperhatikan bahwa kondisi sisa dari kategori G01*, G02*, G05*, dan G07* tidak boleh dikodekan ke G09, melainkan harus dikodekan ke kategori yang memang disediakan untuk sekuel dari kondisi dasar tersebut, misalnya B90–B94.

Contoh 1

Kondisi utama : Tuli akibat *meningitis tuberculosis*

Spesialisasi : Klinik bicara dan pendengaran

Kode yang digunakan sebagai “kondisi utama” adalah gangguan pendengaran, tidak spesifik (H91.9). Kode B90.0 (Sekuel *tuberculosis* sistem saraf pusat) dapat digunakan sebagai kode tambahan.

Contoh 2

Kondisi utama : *Epilepsy* akibat *abscess* otak lama

Spesialisasi : *Neurology*

Kode yang digunakan sebagai “kondisi utama” adalah epilepsi, tidak spesifik (G40.9). Kode G09 (Sekuel penyakit inflamasi sistem saraf pusat) dapat digunakan sebagai kode tambahan.

Contoh 3

Kondisi utama : Retardasi mental ringan setelah ensefalitis pasca imunisasi

Spesialisasi : Psikiatri

Kode yang digunakan sebagai “kondisi utama” adalah retardasi mental ringan (F70.9). Kode G09 (Sekuel penyakit inflamasi sistem saraf pusat) dapat digunakan sebagai kode tambahan.

3.1.5 *Parkinsonism* (G20-G22)

Jika *parkinsonism* disebabkan oleh penggunaan obat tertentu (misalnya, *neuroleptic* atau *metoclopramide*), maka dapat menggunakan kode G21.1 (*Other drug-induced secondary parkinsonism*) sebagai kode utama dan dapat menambahkan kode eksternal untuk jenis obat yang menjadi *penyebabnya*, misalnya T43.4 (*Butyrophenone and thioxanthene neuroleptics*) untuk obat *neuroleptic*.

Jika *dokter* mendiagnosis "*malignant neuroleptic syndrome*", maka dapat menggunakan kode G21.0 (*Malignant neuroleptic syndrome*) sebagai kode utama, dan dapat menambahkan kode obat yang menyebabkan kondisi tersebut.

Jika **dokter mendiagnosis** "*progressive supranuclear palsy*", maka dapat **menggunakan** kode G23.1 (*Progressive supranuclear ophthalmoplegia [Steele-Richardson-Olszewski]*).

Jika **dokter mendiagnosis** "*multiple system atrophy*", "*shy-drager syndrome*", atau "*neurogenic orthostatic hypotension*", maka dapat **menggunakan** kode G90.3 (*Multi-system degeneration*) sebagai kode utama. Jika terdapat komplikasi tambahan, seperti *hypotension orthostatic*, maka dapat menambahkan kode spesifik untuk kondisi tersebut. Misalnya sebagai berikut.

Contoh 1

Diagnosis : *Parkinsonism akibat haloperidol*
Kode : G21.1 (*Other drug-induced secondary parkinsonism*)
T43.4 (*Butyrophenone and thioxanthene neuroleptics*)

Contoh 2

Diagnosis : *Sindrom neuroleptic malignant akibat Fluphenazine*
Kode : G21.0 (*Malignant neuroleptic syndrome*)
T43.4 (*Butyrophenone and thioxanthene neuroleptics*)

Contoh 3

Diagnosis : (*Neurogenic orthostatic hypotension [Shy-Drager]*)
Kode : G90.3 (*Multi-system degeneration*)
I95.2 (*Hypotension due to drugs*)

3.1.6 Dystonia (G24)

Jika *dystonia* disebabkan oleh penggunaan obat tertentu, maka dapat **menggunakan** kode G24.0 (*Drug-induced dystonia*) sebagai kode utama dan dapat menambahkan kode penyebab eksternal sesuai jenis obat yang menjadi penyebabnya. Contohnya, **penggunaan obat Neuroleptic** golongan *Phenothiazine menggunakan* kode X41.- (*Accidental*) atau X61.- (*Intentional Self-harm*) atau Y11.- (*Undetermined Intent*) atau Y49.3 (*Adverse effect in Therapeutic use*) yang disesuaikan dengan kondisi sebab eksternal pasien dalam tabel obat di volume 3 ICD 10 tahun 2010.

Jika **dokter mendiagnosis** "*spasmodic torticollis*" atau "*cervical dystonia*", maka dapat **menggunakan** kode G24.3 (*Spasmodic torticollis*).

3.1.7 *Alzheimer's Disease (G30)*

Penetapan kode dalam klasifikasi penyakit *Alzheimers* didasarkan pada usia seseorang saat gejala pertama kali muncul, yang memungkinkan pengelompokan kasus secara lebih spesifik sesuai dengan karakteristik *onsetnya*. Kode G30.0 (*Alzheimer disease with early onset*) digunakan jika gejala muncul sebelum usia 65 tahun, yang dikenal sebagai *early-onset Alzheimer*. Sementara itu, kode G30.1 (*Alzheimer disease with late onset*) digunakan untuk kasus-kasus di mana gejala mulai muncul setelah usia 65 tahun, yang menunjukkan *onset* yang sedikit lebih lambat namun tetap termasuk dalam kelompok risiko tinggi. Kode G30.9 diterapkan jika informasi mengenai usia *onset* tidak diketahui secara pasti atau tidak dapat ditentukan karena keterbatasan data.

3.1.8 *Epilepsy, Seizures, and Convulsion (G40-G41, R56.8)*

Jika diagnosis menyebutkan adanya kejang yang diprovokasi (*reactive seizures*), seperti kejang yang disebabkan oleh demam, alkohol, atau obat-obatan, maka dapat menggunakan kode G40.5 (*Special epileptic syndromes*). Dalam hal ini, penting untuk menambahkan kode penyebab eksternal jika penyebab diketahui. Misalnya, jika kejang diprovokasi oleh demam, maka ditambahkan kode R56.0 (*Febrile convulsions*) untuk kejang demam; jika disebabkan oleh alkohol, maka digunakan kode T51.0 (*Ethanol*); dan jika disebabkan oleh obat-obatan tertentu, maka kode yang digunakan harus sesuai dengan jenis obat tersebut, seperti T42.3 (*Barbiturates*) untuk *benzodiazepin*. Jika diagnosis menunjukkan adanya status *epilepticus*, yaitu kejang berkepanjangan yang memerlukan penanganan segera, maka kode yang digunakan adalah G41 (*Status epilepticus*).

Jika pasien *epilepsy* dirawat akibat luka yang terjadi saat serangan, maka diagnosis *injury* menjadi diagnosis utama dan tambahkan kode penyebab eksternal yang relevan dengan kode *epilepsy*-nya.

Tabel 10. Contoh kasus untuk epilepsi, *seizures*, dan konvulsi

Contoh 1-8	Seorang laki-laki sedang menaiki tangga di rumah, kemudian terjadi serangan <i>epilepsy</i> /kejang yang menyebabkan pasien terjatuh dari tangga. Terdapat luka terbuka di dahi.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode

Diagnosis Primer	Luka terbuka di dahi	S01.8 <i>Open wound of other parts of head</i>
Diagnostik Sekunder	Jatuh dari tangga di rumah <i>Epilepsy</i>	W10.09 <i>Fall on and from stairs and steps, Home, During unspecified activity</i> G40.9 <i>Epilepsy, unspecified</i>

3.1.9 *Migraine and Headache (G43-G44)*

Penetapan kode untuk kondisi sakit kepala didasarkan pada penyebab yang diketahui atau detail spesifik diagnosis yang diberikan oleh tenaga medis. Jika penyebab sakit kepala dapat diidentifikasi, maka kode yang digunakan harus sesuai dengan penyebab penyakit tersebut. Sebagai contoh, jika sakit kepala disebabkan oleh perdarahan otak, maka dapat menggunakan kode I60.- (*Subarachnoid haemorrhage*), sedangkan jika disebabkan oleh infeksi sinus, maka dapat menggunakan kode H01.- (*Other inflammation of eyelid*). Namun, jika diagnosis hanya mencantumkan "sakit kepala" tanpa penyebabnya, maka dapat menggunakan kode R51.0 (*Headache, unspecified*) ^(IM) untuk menggambarkan sakit kepala yang tidak spesifik.

3.1.10 *Transient Ischaemic Attack (TIA) (G45)*

Kode G45.- dapat diberikan sesuai jenis sindrom yang diidentifikasi oleh dokter. Kode ini digunakan untuk pasien yang memiliki gangguan sementara pada aliran darah otak (*Transient Ischemic Attack/TIA*) atau sindrom terkait. Kode ini mencakup berbagai kondisi yang disebabkan oleh *ischaemic* sementara atau *insufficiency vascular* otak, dengan sub-kategori yang lebih spesifik tergantung pada manifestasi klinis pasien.

3.1.11 *Sleep Apnea Obstructive and Snoring (G47.3, R06.5)*

Pengodean untuk kondisi gangguan pernapasan saat tidur, seperti mendengkur atau *sleep apnea*, berdasarkan diagnosis spesifik yang diberikan oleh dokter. Jika dokter mendiagnosis mendengkur atau *primary snoring*, maka kode yang sesuai adalah R06.5 (*Mouth breathing*), yang menggambarkan pola pernapasan melalui mulut sebagai bagian dari gejala utama.

Untuk kasus *obstructive sleep apnea*, pengodean lebih rinci bergantung pada detail diagnosis. Jika dokter tidak menentukan penyebab

spesifik dari *sleep apnea*, maka dapat menggunakan kode G47.3 (*Sleep apnea*) sebagai kode diagnosis utama. Namun, jika dokter menentukan penyebab spesifik (misalnya, *hypertrophy tonsil* dengan *hypertrophy adenoid*, *rhinitis chronic*, *deviation septum* hidung, atau *hypertrophy* konka hidung), maka kode penyebab tersebut menjadi kode diagnosis utama dan G47.3 (*Sleep apnea*) dapat ditambahkan sebagai kode diagnosis tambahan untuk memberikan gambaran lengkap tentang kondisi pasien.

Prosedur medis, seperti *uvulopalatopharyngoplasty* (UPPP), yang merupakan operasi untuk memperbaiki uvula, langit-langit lunak, dan faring guna mengobati mendengkur dan *sleep apnea*. Dalam sistem ICD-9-CM, diperlukan tiga kode untuk mencatat prosedur ini secara lengkap:

1. 27.79 (*Other operations on uvula*), untuk mencatat intervensi pada uvula.
2. 27.69 (*Other plastic repair of palate*), untuk mencatat perbaikan plastik pada langit-langit lunak.
3. 29.4 (*Plastic operation on pharynx*), untuk mencatat operasi plastik pada faring

Tabel 11. Contoh kasus *sleep apnea obstructive and snoring*

Contoh 1-12	Seorang pasien anak yang mengalami keluhan mendengkur. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter mendiagnosis bahwa anak tersebut mengalami <i>sleep apnea</i> , yang kemudian dipastikan melalui hasil <i>polysomnography</i> . Penyebab utama dari kondisi ini adalah pembesaran amandel disertai adenoid dan dilakukan <i>adenoidectomy</i> serta <i>tonsillectomy</i>	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	<i>Hypertrophy</i> amandel dan kelenjar gondok	J35.3 <i>Hypertrophy of tonsils with hypertrophy of adenoids</i>
Diagnosis Sekunder	<i>Sleep apnea</i>	G47.3 <i>Sleep apnea</i>
Operasi	<i>Tonsillectomy</i> dengan <i>adenoidectomy</i>	28.3 <i>Tonsillectomy with adenoidectomy</i>

3.1.12 Cranial Nerve Disorders (G50-G53)

Kode yang digunakan harus sesuai dengan jenis kelainan dan lokasi saraf kranial yang terkena. Jika dokter mendiagnosis adanya kelainan pada *trigeminal nerve*, maka dapat menggunakan kode dalam kelompok G50.- (*Disorders of trigeminal nerve*). Apabila diagnosis menunjukkan adanya gangguan pada *facial nerve*, maka dapat menggunakan kode dalam

kelompok G51.- (*Facial nerve disorders*). Untuk kelainan yang melibatkan saraf kranial lainnya selain *trigeminal* dan *facial nerve*, maka dapat menggunakan kode dalam kelompok G52.- (*Disorders of other cranial nerves*).

Pada situasi di mana dokter mendiagnosis bahwa pasien mengalami kelainan pada beberapa saraf kranial secara bersamaan, seperti pada kasus *Tolosa-Hunt syndrome* tanpa penyebab spesifik yang disebutkan, maka dapat menggunakan kode G52.7 (*Disorders of multiple cranial nerves*). Namun, jika dokter dapat menentukan penyebab utama dari kelainan tersebut, maka kode penyakit yang menjadi penyebab utama tersebut harus digunakan sebagai diagnosis utama, sedangkan kode kelainan saraf kranial yang terdeteksi digunakan sebagai diagnosis tambahan untuk memberikan gambaran lebih lengkap tentang kondisi pasien.

Tabel 12. Contoh kasus *cranial nerve disorders*

Contoh 1-13	Pasien dengan kanker pada atap nasofaring dengan kelumpuhan pada beberapa saraf otak (<i>multiple cranial nerve palsies</i>).	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Carcinoma pada atap nasofaring	C11.0† <i>Superior wall of nasopharynx</i>
Diagnosis Sekunder	Beberapa kelumpuhan saraf kranial	G53.3* <i>Nerve root and plexus compressions in other dorsopathies</i>
Contoh 2-13	Pasien yang mengalami trombosis sinus kavernosus dengan kelumpuhan pada beberapa saraf otak (<i>multiple cranial nerve palsies</i>).	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Thrombosis sinus cavernosus	I67.6 <i>Nonpyogenic thrombosis of intracranial venous system</i>
Diagnosis Sekunder	Beberapa kelumpuhan saraf kranial	G53.8* <i>Other cranial nerve disorders in other diseases classified elsewhere</i>

3.1.13 Polyneuropathy (G61-G63)

Jika dokter mendiagnosis penyakit lain yang menjadi penyebab *polyneuropathy*, maka kode dari penyakit tersebut harus digunakan sebagai kode diagnosis utama, sedangkan kode dalam kelompok G63.- (*Polyneuropathy in diseases classified elsewhere*) digunakan sebagai kode diagnosis tambahan untuk menunjukkan adanya *polyneuropathy*.

Dalam kasus *polyneuropathy* karena keracunan obat atau bahan racun, kode penyebab eksternal yang relevan dengan jenis obat atau racun tersebut juga harus ditambahkan untuk memberikan informasi lebih

spesifik tentang penyebabnya. Selain itu, jika dokter mendiagnosis *Guillain-Barré syndrome*, maka dapat menggunakan kode G61.0 *Guillain-Barré syndrome*, sedangkan untuk *Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy* (CIDP), dapat menggunakan kode G61.8 *Other inflammatory polyneuropathies*.

Contoh 1: Pada pasien dengan kanker paru-paru yang disertai polineuropati, diagnosis utamanya menggunakan kode C34.9 (*Bronchus or lung, unspecified*) sedangkan diagnosis sekunder untuk polineuropati menggunakan kode G63.1* (*Polyneuropathy in neoplastic disease*).

Contoh 2: Pada pasien dengan penyakit DM *unspecified* yang disertai *polyneuropathy*, diagnosis utamanya menggunakan kode E14.4† (*DM unspecified with neurological complications*) sedangkan diagnosis sekundernya menggunakan kode G63.2* (*Diabetic polyneuropathy*).

3.1.14 Myopathy (G70-G73)

Jika dijumpai kondisi kelemahan otot (*Myopathy*), diagnosis *periodic paralysis* tidak dikode secara terpisah melainkan digabung menjadi satu dengan kode G72.3 (*Periodic Paralysis*). Pada *periodic paralysis*, kondisi kelemahan otot/*myopathy* menjadi kondisi penyerta.

Dalam kasus di mana *myopathy* disebabkan oleh infeksi, gangguan kelenjar endokrin, atau penyakit autoimun, kode dari penyakit penyebab utama harus digunakan sebagai kode diagnosis utama, sedangkan kode dalam kelompok G73.4 – G73.7 digunakan sebagai kode diagnosis tambahan untuk menunjukkan adanya keterkaitan dengan *myopathy*.

Tabel 13. Contoh kasus *myopathy*

Contoh 1-15	Dokter mendiagnosis pasien dengan miopati yang disebabkan oleh SLE.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Lupus eritematosus sistemik	M32.1† <i>Systemic lupus erythematosus with organ or system involvement</i>
Diagnostik Sekunder	Miopati	G73.7* <i>Myopathy in other diseases classified elsewhere</i>

3.1.15 Sindrom Paralitik (G81–G83)

Kode-kode ini tidak digunakan sebagai diagnosis utama jika penyebab yang mendasarinya telah dicatat sebagai diagnosis utama,

kecuali jika episode perawatan memang difokuskan pada kelumpuhan itu sendiri. Kategori ini hanya digunakan sebagai diagnosis utama apabila kode dalam kategori ini dicatat tanpa spesifikasi lebih lanjut, atau disebut sebagai kondisi lama/telah berlangsung lama tanpa menyebutkan rincian penyebabnya. Selain itu, kategori ini juga digunakan sebagai diagnosis sekunder untuk mengidentifikasi jenis kelumpuhan berdasarkan penyebabnya.

Contoh 1 :

Kondisi utama : *Stroke* dengan *hemiplegia*

Kondisi lain : —

Spesialisasi : *Neurology*

Kode yang digunakan sebagai “kondisi utama” adalah *stroke*, tidak spesifik apakah perdarahan atau infark (I64). Kode G81.9 (*Hemiplegia, unspecified*) dapat digunakan sebagai kode tambahan.

Contoh 2:

Kondisi utama : *Cerebral infarction* tiga tahun lalu

Kondisi lain : Kelumpuhan kaki kiri, Pasien menjalani terapi fisik

Konfirmasikan kembali kepada dokter untuk memastikan kondisi utama dalam episode perawatan, dan sesuaikan pendokumentasian di *resume medis*. Kode yang lebih tepat digunakan sebagai “kondisi utama” adalah *monoplegia* tungkai bawah G83.1 (*Monoplegia of lower limb*). Kode I69.3 (*Sequelae of cerebral infarction*) dapat digunakan sebagai kode tambahan.

Berdasarkan contoh di atas, kode dalam kategori G81-G83 ditetapkan sebagai diagnosis sekunder apabila penyebab suatu kondisi dalam kategori tersebut diketahui dan sedang ditangani pada perawatan saat ini, dan penyebab kondisi tersebut ditetapkan sebagai diagnosis utama. Namun, apabila penyebab kondisi tersebut telah tidak ada lagi dan kode dalam kategori G81-G83 merupakan *sequelae* dari penyebab dan telah menjadi fokus utama perawatan, maka kode dari kategori tersebut dapat ditetapkan sebagai diagnosis utama.

Kode dalam kelompok G81.- (*Hemiplegia*) digunakan sebagai kode diagnosis utama hanya jika dokter mendiagnosis pasien mengalami kelumpuhan separuh tubuh (*hemiplegia*), baik bersifat permanen maupun

sementara tanpa detail tambahan seperti durasi atau penyebab spesifik. Kode ini juga dapat digunakan sebagai kode diagnosis tambahan untuk mengidentifikasi jenis kelumpuhan separuh tubuh, terlepas dari penyebabnya.

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa kode I67.1 dan I67.4 – I67.9 tidak digunakan untuk kondisi sisa (*sequelae*), yang mengacu pada kondisi yang timbul akibat penyakit sebelumnya, baik efek jangka panjang maupun hasil yang muncul setelah satu tahun atau lebih. Oleh karena itu, jika dokter menentukan bahwa *Hemiplegia* adalah hasil dari *sequelae stroke*, maka kode I69.- (*Sequelae of cerebrovascular disease*) harus ditetapkan pada kondisi sekunder dari *Hemiplegia*, karena dengan demikian akan sesuai dengan kaidah pengodean morbiditas, yang menunjukkan bahwa *hemiplegia* adalah masalah saat ini dan merupakan satu-satunya kondisi yang mendasari kunjungan medis dan kausa adalah kondisi yang sudah tidak terdapat lagi namun memberikan efek sisa (*Late effect*).

Tabel 14. Contoh kasus sindrom paralitik

Contoh 1-16	Pasien adalah seorang pria berusia 56 tahun. Dokter mendiagnosis bahwa anggota tubuh sebelah kanan pasien mengalami kelemahan dan kelumpuhan. Kondisi ini disebabkan oleh pecahnya <i>artery cerebral</i> yang terjadi empat bulan lalu. Saat ini, pasien sedang menjalani program rehabilitasi intensif untuk membantu pemulihan fungsi tubuhnya.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Kelumpuhan <i>hemiplegia</i> kanan	G81.0 <i>Flaccid hemiplegia</i>
Diagnosis Sekunder	Gejala sisa perdarahan intraserebral	I69.1 <i>Sequelae of intracerebral haemorrhage</i>
Prosedur	Program rehabilitasi intensif	93.89 <i>Rehabilitation, not elsewhere classified</i>
Contoh 2-16	Pasien adalah seorang pria berusia 67 tahun. Dokter mendiagnosis adanya kelemahan dan kekakuan pada tungkai kiri pasien, yang merupakan akibat dari <i>stroke</i> yang dialami satu tahun lalu. Saat ini, pasien telah diterima untuk menjalani Program Rehabilitasi Intensif.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnostik Primer	Hemiplegia kejang kiri	G81.1 <i>Spastic hemiplegia</i>
Diagnostik Sekunder	Gejala sisa infark serebral	I69.3 <i>Sequelae of cerebral infarction</i>
Prosedur	Program rehabilitasi intensif	93.89 <i>Rehabilitation, not elsewhere classified</i>

3.1.16 Hydrocephalus (G91, G94, Q03)

Semua jenis *hydrocephalus* menggunakan kode dalam kelompok G91.- (*Hydrocephalus*) sesuai dengan diagnosis yang diberikan oleh dokter. Namun, jika dokter mendiagnosis *hydrocephalus congenital*, maka

kode dalam kelompok Q03.- (*Congenital Hydrocephalus*) harus digunakan sesuai dengan spesifikasi diagnosis.

Dalam kasus di mana dokter menegakkan diagnosis bahwa *hydrocephalus* disebabkan oleh infeksi atau kanker, kode untuk penyakit utama (penyebab) harus digunakan sebagai diagnosis utama. Selain itu, kode berikut dapat ditambahkan sebagai diagnosis tambahan:

- G94.0* untuk *hydrocephalus* yang terjadi pada penyakit infeksi dan parasit yang diklasifikasikan di tempat lain
- G94.1* untuk *hydrocephalus in neoplastic disease*.

Dengan demikian, pengodean ini memastikan bahwa penyebab utama *hydrocephalus* telah diidentifikasi secara jelas, sementara kode tambahan memberikan informasi spesifik tentang kondisi *hydrocephalus* yang terkait.

3.1.17 Cerebrovascular Accident (CVA) (I60-I64)

Istilah seperti "*cerebrovascular accident*" atau "*stroke*" dianggap tidak spesifik, sehingga sebaiknya tidak menggunakan kode I64 (*Stroke, not specified as haemorrhage or infarction*), kecuali apabila diagnosis spesifik memang tidak dapat ditentukan. Sebisanya mungkin untuk menggunakan kode yang lebih spesifik sesuai dengan jenis stroke yang didiagnosis, dengan memilih dari kode-kode berikut:

- I60.- (*Subarachnoid haemorrhage*).
- I61.- (*Intracerebral haemorrhage*).
- I62.- (*Other nontraumatic intracranial haemorrhage*)
- I63.- (*Cerebral infarction*)

Ketika dokter mendiagnosis perdarahan *intracerebral*, kode harus diberikan secara rinci dalam grup I61.-. Untuk kondisi perdarahan otak yang disebabkan oleh trauma eksternal, gunakan kode S06.- (*traumatic intracranial haemorrhage*).

Ketika dokter mendiagnosis infark serebral, kode harus diberikan secara rinci dalam grup I63.- (*Cerebral infarction*) untuk menentukan apakah kondisi tersebut disebabkan oleh emboli atau trombosis, serta untuk menentukan lokasi pembuluh darah, apakah di *artery cerebral* atau *precerebral*.

Selain itu, kode tambahan dari grup G46.* (*Vascular syndrome of brain in cerebrovascular disease*) harus diberikan sebagai diagnosis tambahan untuk menentukan pembuluh darah mana yang terkena kelainan tersebut.

3.1.18 *Other Cerebrovascular Disease (I65-I68)*

- Jika dokter mendiagnosis *Occlusion* atau *stenosis* pada *artery precerebral* atau *cerebral* yang tidak menyebabkan *cerebral infarction*, gunakan kode sebagai berikut: I65.- (*Occlusion and stenosis of precerebral arteries, not resulting in cerebral infarction*) untuk kasus pada *artery precerebral*, dan I66.- (*Occlusion and stenosis of cerebral arteries, not resulting in cerebral infarction*) untuk kasus pada *artery cerebral*.
- Jika dokter mendiagnosis *cavernous sinus thrombosis*, maka gunakan kode I67.6 (*Nonpyogenic thrombosis of intracranial venous system*).
- Jika dokter mendiagnosis *cerebral arteritis* pada pasien dengan *systemic lupus erythematosus* (SLE), gunakan kode M32.1† (*Systemic lupus erythematosus with organ or system involvement*) sebagai kode utama, dan I68.2* (*Cerebral arteritis in other diseases classified elsewhere*) sebagai kode tambahan.

3.1.19 *Sequelae of Cerebrovascular Diseases (I69.-)*

Kode ini tidak digunakan sebagai kondisi utama jika sifat dari kondisi sisa (*residual*) sudah dicatat secara spesifik. Saat mengkode kondisi sisa tersebut, kode I69.- (*Sequelae of Cerebrovascular Diseases*) dapat digunakan sebagai kode tambahan.

Jika dokter mendiagnosis *old cerebrovascular accident* disertai dengan kelainan neurologis residu yang masih tersisa, gunakan kode untuk kelainan neurologis residu tersebut sebagai kode utama, kemudian tambahkan kode dari grup I69.- (*Sequelae of cerebrovascular accident*) sebagai kode tambahan. Namun, jika dokter menentukan bahwa tidak ada kelainan neurologis residu yang tersisa (pasien telah pulih sepenuhnya), gunakan kode Z86.7 (*Personal history of diseases of the circulatory system*).

DRAFT V1

3.2 MDC 12 MATA & ADNEXA

PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 12

Pengodean tindakan pengangkatan benda asing pada kornea/ *removal foreign superficial cornea* ditentukan berdasarkan metode yang digunakan selama tindakan. Jika pengangkatan dilakukan tanpa insisi, maka digunakan kode 98.21 (*removal of superficial foreign body from eye without incision*). Apabila prosedur dilakukan dengan bantuan magnet, maka digunakan kode 11.0 (*magnetic removal of embedded foreign body from cornea*).

Pengodean metode pemeriksaan *funduscopy* ditentukan berdasarkan alat yang digunakan. Jika dilakukan dengan menggunakan alat *Ophthalmoscope*, menggunakan kode 16.21 (*Ophthalmoscopy*). Sedangkan jika menggunakan alat *fundus phorography*, menggunakan kode 95.11 (*Fundus Photography*).

Gunakan Kode Lateralisasi Untuk kasus mata dengan kode tambahan lateralisasi mata HL00 *Right eye (IM)* dan HL01 *Left eye (IM)*.

Pasien Kontrol Post Op Mata tanpa tindakan perawatan luka menggunakan kode Z48.8 sebagai kode diagnosa utama diikuti diagnosa lain dan tindakan yang relevan dengan episode perawatan pasien. misalnya Pasien kontrol post vitrectomy konsultasi dengan dokter spesialis mata dan tindakan slit lamp maka kodenya adalah Z48.0 dan 89.07, 95.07 sebagai kode tindakannya.

PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 12

3.2.1 *Conjunctivitis (H10.-)*

Jika dokter mencatat bahwa *conjunctivitis* disertai cairan yang bersifat *mucopurulent* atau *purulent*, maka gunakan kode H10.0 (*Mucopurulent conjunctivitis*) jika dokter menentukan penyebab spesifik dari *conjunctivitis*, pengodean diagnosis utama dan tambahan harus disesuaikan. Misalnya jika *viral conjunctivitis* yang tidak dirinci lebih lanjut, kode utama adalah B30.9† (*Viral conjunctivitis, unspecified*) dengan kode tambahan H13.1* (*Conjunctivitis in infectious and parasitic diseases classified elsewhere*). Sementara itu, jika dokter mendiagnosis *viral conjunctivitis* disertai rinciannya, berikan kode sesuai sesuai dengan rinciannya, misalnya sebagai berikut.

- Pada *adenoviral conjunctivitis*, gunakan kode utama B30.1† (*Viral conjunctivitis due to adenovirus*) dengan kode tambahan H13.1* (*Conjunctivitis in infectious and parasitic diseases classified elsewhere*).
- Pada *haemorrhagic conjunctivitis (enteroviral)*, menggunakan kode utama B30.3† (*Acute epidemic haemorrhagic conjunctivitis [enteroviral]*) dengan tambahan kode yang sama.
- Jika terdapat radang kornea (keratitis), kode utama menjadi B30.0† (*Epidemic keratoconjunctivitis*) dengan kode tambahan H19.2* (*Keratitis and keratoconjunctivitis in other infectious and parasitic diseases classified elsewhere*).

Pada kasus *allergic conjunctivitis*, kode H10.1 (*Acute atopic conjunctivitis*) digunakan untuk semua jenis konjungtivitis alergi seperti *Giant papillary conjunctivitis* (GPC), *Vernal keratoconjunctivitis* (VKC), *Delayed tear clearance* (DTC), *Atopic conjunctivitis*, dan *Atopic keratoconjunctivitis* (AKC).

Jika dokter menyebutkan penyebabnya, berikan kode sesuai dengan jenis patogen penyebabnya. Misalnya *herpes simplex blepharoconjunctivitis* menggunakan kode utama B00.5† (*Herpesviral ocular disease*) dengan kode tambahan H03.1* (*Involvement of eyelid in other infectious diseases classified elsewhere*) dan H13.1* (*Conjunctivitis in infectious and parasitic diseases classified elsewhere*).

3.2.2 ***Pinguecula and Pterygium (H11.0–H11.1)***

Kode H11.0 (*Pterygium*) mencakup semua jenis *pterygium*, termasuk *pterygium unilateral* (hanya satu mata) atau *bilateral* (kedua mata), serta *pterygium* yang disertai gangguan penglihatan maupun yang tidak menyebabkan dampak signifikan pada fungsi visual.

Kode H11.1 (*Conjunctival degenerations and deposits*) digunakan jika dokter mendiagnosis adanya *pinguecula* atau *pingueculitis*. Kode ini mencakup semua kasus *pinguecula* tanpa memandang lokasi spesifiknya di mata (nasal atau temporal) atau tingkat keparahannya, baik dalam kondisi ringan maupun yang menimbulkan gejala seperti iritasi atau kemerahan.

Contoh 1-12	Dokter mendiagnosis pasien dengan <i>pterygium</i> , kemudian melakukan tindakan pengobatan berupa eksisi (pengangkatan) jaringan pterygium yang disertai dengan iradiasi beta.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	<i>Pterygium</i>	H11.0 <i>Pterygium</i>
Prosedur	Eksisi <i>pterygium</i> Iradiasi beta	11.39 <i>Other excision of pterygium</i> 92.21 <i>Superficial radiation</i>

Contoh 2-12	Dokter mendiagnosis pasien dengan <i>pterygium</i> , kemudian melakukan tindakan pengobatan berupa injeksi di subkonjungtiva.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	<i>Pterygium</i>	H11.0 <i>Pterygium</i>
Prosedur	Injeksi di subkonjungtiva	10.91 <i>Subconjunctival injection</i>

Tindakan Pterygium Secara umum operasi pterygium dapat dilakukan secara rawat jalan kecuali bila didapatkan indikasi untuk dilakukan secara rawat inap.

Indikasi rawat inap pada tindakan operasi pterygium adalah bila didapatkan setidaknya **salah satu kondisi di bawah ini**:

Terdapat salah satu kondisi/penyakit pada pasien, sehingga membutuhkan anestesi umum (GA), antara lain:

1. Pasien Pediatri usia = 18 tahun, atau
2. Pasien Dewasa yang menderita setidaknya salah satu kondisi yang dapat menghalangi kerja sama dan kemampuan pasien untuk berbaring selama operasi, yaitu: dementia, tremor kepala, tuli, gangguan/kelainan tulang belakang, klaustrofobia, atau gangguan kejiwaan (termasuk gangguan kecemasan), atau
3. Terdapat penyakit sistemik / kondisi yang telah diderita pasien sebelumnya yang berdasarkan hasil konsultasi dengan dokter spesialis

copyright@ Pusat pembiayaan kesehatan Kemenkes RI.

Dilarang mengcopy atau memperjualbelikan isi dan dokumen ini dalam bentuk apapun

lain sesuai kompetensinya membutuhkan observasi ketat sebelum operasi, saat operasi, dan pasca operasi (wajib dicantumkan dalam rekam medis), atau

4. Terdapat komplikasi operasi yang membutuhkan tindakan/operasi tambahan dan/atau observasi ketat pasca operasi.

3.2.3 *Corneal Scar (H17)*

Jika dokter mendiagnosis *corneal scar*, gunakan kode dari kategori H17.- (*Corneal scars and opacities*) berdasarkan karakteristik dan lokasi bekas luka / jaringan parutnya.

- Jika dokter menyebutkan bahwa bekas luka berada di pusat kornea, gunakan kode H17.1 (*Other central corneal opacity*).
- Jika dokter menyebutkan bahwa bekas luka berada di area lain dari kornea, gunakan kode H17.8 (*Other corneal scars and opacities*).

3.2.4 *Contact Lens Intolerance*

Pada kasus *contact lens intolerance*, penentuan kode utama harus didasarkan pada kelainan mata yang ditemukan selama pemeriksaan. Berikut adalah panduan pengodean:

- *Papillary conjunctivitis* (misalnya *giant papillary conjunctivitis*), gunakan kode H10.1 (*Acute atopic conjunctivitis*).
- *Corneal abrasion* atau *corneal erosion*, gunakan kode H18.8 (*Other specified disorders of cornea*).
- Edema kornea atau *staining* pada posisi 3 dan 9 o'clock, gunakan kode H18.2 (*Other corneal oedema*).

Selain itu, tambahkan kode penyebab eksternal Y77.2 (*Ophthalmic devices associated with adverse incidents*) untuk menunjukkan bahwa masalah tersebut terkait dengan penggunaan alat *ophthalmology* (seperti lensa kontak).

3.2.5 *Ice Syndrome (H18.2, H21.2)*

Tidak ada kode spesifik untuk *ICE Syndrome* dalam ICD-10. Oleh karena itu, pengodean harus didasarkan pada karakteristik lesi atau

manifestasi yang ditemukan oleh dokter. Berikut adalah panduan pengodean:

1. Jika dokter mendiagnosis *Chandler's Syndrome*, gunakan kode H18.2 (*Other corneal oedema*).
2. Jika dokter mendiagnosis *Cogan-Reese Syndrome*, gunakan kode H21.2 (*Degeneration of iris and ciliary body*).

3.2.6 Uveitis (H20-H22, H30, H32)

Untuk kasus di mana dokter mendiagnosis peradangan di ruang anterior bola mata (*anterior uveitis, iritis, siklitis, atau iridocyclitis*):

1. Jika dokter menyebutkan penyebab peradangan di ruang anterior bola mata, gunakan kode berikut:
 - a. Jika dokter mendiagnosis penyebabnya karena lensa mata, misalnya *phacolytic uveitis* (akibat lensa mata katarak) atau *phacoanaphylactic uveitis* (akibat pecahnya lensa atau sisa lensa setelah operasi), gunakan kode H20.2 (*Lens-induced iridocyclitis*).
 - b. Jika dokter mendiagnosis penyebabnya karena infeksi, gunakan kode H22.0 (*Iridocyclitis in infectious and parasitic diseases classified elsewhere*), dengan tambahan kode penyakit infeksi penyebabnya.
 - c. Jika disebabkan oleh infeksi cacar air, gunakan kode B01.8† (*Varicella with other complications*), dengan kode tambahan H22.0*
2. Jika dokter mendiagnosis bahwa kondisi ini disebabkan oleh atau terkait dengan penyakit sistemik, gunakan kode H22.1* (*Iridocyclitis in other diseases classified elsewhere*) sebagai diagnosis tambahan dan gunakan diagnosis utama sesuai penyakit yang mendasarinya.
 - a. Jika terkait dengan *rheumatoid arthritis*, gunakan kode M05.3† (*Rheumatoid arthritis with involvement of other organs and systems*), dengan kode tambahan H22.1*
 - b. Jika terkait dengan *psoriasis*, gunakan kode L40.-† (*Psoriasis*), dengan kode tambahan H22.1*

- c. Jika terkait dengan *juvenile rheumatoid arthritis*, gunakan kode M08.0† (*Juvenile rheumatoid arthritis*), dengan kode tambahan H22.1*
 - d. Jika terkait dengan penyakit Reiter, gunakan kode M02.3† (*Reiter's disease*), dengan kode tambahan H22.1*
 - e. Jika terkait dengan penyakit Behçet, gunakan kode M35.2† (*Behçet's disease*), dengan kode tambahan H22.1*
3. Jika dokter mendiagnosis bahwa kondisi ini tidak disebabkan oleh lensa mata, bukan akibat infeksi, dan tidak terkait dengan penyakit sistemik lainnya, misalnya diagnosis *Fuchs heterochromic iridocyclitis*, gunakan kode: H20.8 (*Other iridocyclitis*).
 4. Jika dokter mendiagnosis *anterior uveitis* yang terjadi bersamaan dengan *Vogt-Koyanagi-Harada disease*, yang merupakan penyakit sistemik, atau bersamaan dengan *sympathetic ophthalmia*, gunakan kode H20.8 (*Other iridocyclitis*), karena kedua kondisi tersebut tidak memiliki kode spesifik.

Jika dokter mendiagnosis adanya peradangan di bagian posterior bola mata (*cyclitis* dan/atau *intermediate uveitis*, *pars planitis*, *posterior uveitis*, atau *vitritis*) akan tetapi tidak ada kode khusus untuk *intermediate uveitis*, maka gunakan kode sebagai berikut:

1. Jika dokter tidak menyebutkan penyebab peradangan, gunakan kode H30.2 (*Posterior cyclitis*) karena penyebab umum kondisi ini seringkali mirip dengan penyebab *posterior uveitis*.
2. Jika dokter mendiagnosis bahwa peradangan disebabkan oleh infeksi, gunakan kode H32.0* (*Chorioretinal inflammation in infectious and parasitic diseases classified elsewhere*) dan gunakan kode penyakit infeksi penyebabnya.
3. Jika dokter mendiagnosis bahwa peradangan disebabkan oleh kondisi non-infeksi, gunakan kode H32.8* (*Other chorioretinal disorders in diseases classified elsewhere*) dan gunakan kode penyakit penyebabnya.

Kasus di mana dokter mendiagnosis adanya peradangan di bagian posterior bola mata (*posterior uveitis*, *choroiditis*, *chorioretinitis*, *retinitis*,

atau *retinal vasculitis*) dan jika dokter tidak menyebutkan penyebab peradangan, gunakan kode berdasarkan pola distribusi peradangan yang ditemukan:

1. Jika dokter menyebutkan bahwa peradangan terjadi hanya pada satu titik, atau tersebar dalam bercak tetapi tidak lebih dari 1 kuadran, gunakan kode H30.0 (*Focal chorioretinal inflammation*).
2. Jika dokter menyebutkan bahwa peradangan tersebar dalam banyak bercak, melibatkan lebih dari 1 kuadran, atau sangat parah hingga mencakup seluruh retina termasuk diagnosis sindrom *white dots syndrome* (WDS) seperti: *Multiple Evanescent White Dots Syndrome* (MEWDS), *Acute Posterior Multifocal Placoid Pigment Epitheliopathy* (APMPPE), *Multifocal Choroiditis With Panuveitis* (MCP), *Birdshot Chorioretinopathy* (BSCR), *Serpiginous Choroidopathy* (SC), *Punctate Inner Choroidopathy* (PIC), *Acute Zonal Occult Outer Retinopathy* (AZOOR), dan *Acute Retinal Pigment Epithelitis* (ARPE), gunakan kode H30.1 (*Disseminated chorioretinal inflammation*).

Jika dokter mendiagnosis adanya peradangan di bagian posterior bola mata dan menyebutkan penyebab peradangan, gunakan kode berdasarkan penyebabnya sebagai berikut:

1. Jika dokter mendiagnosis bahwa peradangan disebabkan oleh infeksi, gunakan kode H32.0* (*Chorioretinal inflammation in infectious and parasitic diseases classified elsewhere*), dengan tambahan kode penyakit infeksi penyebabnya, misalnya:
 - Jika disebabkan oleh *cytomegalovirus* (CMV), gunakan kode B25.8† (*Other cytomegaloviral diseases*), dengan tambahan kode H32.0*
 - Jika disebabkan oleh *cytomegalovirus* (CMV) pada kasus HIV/AIDS, gunakan kode B20.2† (*HIV disease resulting in cytomegaloviral disease*), dengan tambahan kode H32.0*
 - Jika disebabkan oleh virus herpes, gunakan kode B00.5† (*Herpesviral ocular disease*), dengan tambahan kode H32.0*

- Jika disebabkan oleh toksoplasma, gunakan kode B58.0† Toxoplasma oculopathy, dengan tambahan kode H32.0*
 - Jika disebabkan oleh cacing toxocara, gunakan kode B83.0† (*Visceral larva migrans*), dengan tambahan kode H32.0*
2. Jika dokter mendiagnosis bahwa kondisi ini disebabkan oleh atau terkait dengan penyakit sistemik, gunakan kode H32.8* (*Other chorioretinal disorders in diseases classified elsewhere*) dengan tambahan kode penyakit penyebabnya, misalnya:
- Jika terkait dengan sarkoidosis, gunakan kode D86.8† (*Sarkoidosis of other and combined sites*), dengan tambahan kode H32.8*
 - Jika terkait dengan penyakit Behçet, gunakan kode M35.2† (*Behçet's disease*), dengan tambahan kode H32.8*
 - Jika terkait dengan lupus eritematosus sistemik, gunakan kode M32.1† (*Systemic lupus erythematosus with organ or system involvement*), dengan tambahan kode H32.8*

Kasus di mana dokter mendiagnosis *panuveitis* atau *endophthalmitis*:

1. Jika diagnosis menyebutkan bahwa kondisi ini disebabkan oleh infeksi dan jenis infeksi spesifik telah dinyatakan, gunakan kode H45.1* (*Endophthalmitis in diseases classified elsewhere*), dengan tambahan kode penyakit infeksi penyebabnya, misalnya:
 - a. Jika *endophthalmitis* disebabkan oleh infeksi cacing pita (*cysticercosis*), gunakan kode B69.1† (*Cysticercosis of eye*), dengan tambahan kode H45.1*
 - b. Jika *endophthalmitis* disebabkan oleh infeksi jamur *Candida*, gunakan kode B37.8† (*Candidiasis of other sites*), dengan tambahan kode H45.1*
2. Jika dokter mendiagnosis bahwa kondisi ini disebabkan oleh atau terkait dengan penyakit sistemik, yang sering kali dokter sebut sebagai *panuveitis* alih-alih *non-infectious endophthalmitis*, gunakan kode H45.1* (*Endophthalmitis in diseases classified elsewhere*), dengan tambahan kode penyakit penyebabnya, misalnya:

- a. Jika terkait dengan sarkoidosis, gunakan kode D86.8† (*Sarkoidosis of other and combined sites*), dengan tambahan kode H45.1*
 - b. Jika terkait dengan penyakit Behçet, gunakan kode M35.2† (*Behçet's disease*), dengan tambahan kode H45.1*
 - c. Jika terkait dengan lupus eritematosus sistemik, gunakan kode M32.1† (*Systemic lupus erythematosus with organ or system involvement*), dengan tambahan kode H45.1*
 - d. Jika disebabkan oleh atau terkait dengan *Wegener's granulomatosis*, gunakan kode M31.3† (*Wegener's granulomatosis*), dengan tambahan kode H45.1*
 - e. Jika disebabkan oleh atau terkait dengan polyangiitis nodosa (PAN), gunakan kode M30.0† (*Polyarteritis nodosa*), dengan tambahan kode H45.1*
 - f. Jika disebabkan oleh atau terkait dengan *Churg-Strauss syndrome*, gunakan kode M30.1† (*Polyarteritis with lung involvement [Churg-Strauss]*), dengan tambahan kode H45.1*
3. Jika dokter mendiagnosis bahwa kondisi ini tidak disebabkan oleh infeksi, tidak terkait dengan penyakit sistemik, atau penyebabnya tidak dapat ditentukan, gunakan kode H44.1 (*Other endophthalmitis*).

Dalam kasus di mana dokter mendiagnosis *Masquerade syndrome* dan menyebutkan jenis kanker sebagai penyebabnya, gunakan kode untuk jenis kanker tersebut sebagai diagnosis utama, misalnya: C69.2 (*Malignant neoplasm of retina*), atau C83.3 (*Diffuse large B-cell lymphoma*), sebagai kode diagnosis utama. Kode untuk jenis uveitis digunakan sebagai diagnosis tambahan. Namun, jika penyebabnya tidak disebutkan, gunakan kode untuk jenis uveitis sebagai diagnosis utama.

3.2.8 Retinal Procedures

Jika dilakukan beberapa prosedur operasi, berikan kode untuk prosedur operasi sesuai dengan ringkasan yang disebutkan oleh dokter dalam *resume medis* (ringkasan pulang).

Catatan Operasi Dokter pada <i>Resume Medis</i>	Kode Bedah
<i>Vitrectomy</i> dengan antibiotik intravitreal	14.74 <i>Other mechanical vitrectomy</i>
	14.79 <i>Other operations on vitreous</i>
<i>Pars plana vitrectomy</i> (PPV) dengan prosedur gesper skleral endolaser dengan tamponade minyak silikon	14.74 <i>Other mechanical vitrectomy</i>
	14.49 <i>Other scleral buckling</i>
	14.54 <i>Repair of retinal detachment with laser photocoagulation</i>
	14.75 <i>Injection of vitreous substitute</i>

3.2.9 Cataract (H25-H26)

Kode untuk operasi pengobatan katarak diberikan berdasarkan jenis operasi yang dicatat oleh dokter. Berikut ringkasannya:

Catatan Operasi Dokter pada <i>Resume Medis</i>	Kode Bedah
Ekstraksi katarak intrakapsular (ICCE)	13.19 <i>Other intracapsular extraction of lens</i>
Ekstraksi katarak ekstrakapsular (ECCE)	13.2 <i>Extracapsular extraction of lens by linear extraction technique</i>
Aspirasi lensa atau Irigasi katarak traumatis	13.3 <i>Extracapsular extraction of lens by simple aspiration (and irrigation) technique</i>
Fakoemulsifikasi (PE)	13.41 <i>Phacoemulsification and aspiration of cataract</i>
Lensektomi Pars plana (PPL)	13.42 <i>Mechanical phacofragmentation and aspiration of cataract by posterior route</i>
Lensektomi anterior	13.43 <i>Mechanical phacofragmentation and other aspiration of cataract</i>
Manual fakoemulsifikasi atau Ekstraksi katarak sayatan kecil	13.59 <i>Other extracapsular extraction of lens</i>

Pengode (*coder*) & Verifikator Perlu memperhatikan dokumentasi medis mengenai teknik operasi katarak dan pemasangan IOL Sekunder yang direkomendasikan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (PERDAMI).

Secara umum operasi katarak dapat dilakukan secara rawat jalan kecuali bila didapatkan indikasi untuk dilakukan secara rawat inap. Indikasi rawat inap pada copyright@ Pusat pembiayaan kesehatan Kemenkes RI.
Dilarang mengcopy atau memperjualbelikan isi dan dokumen ini dalam bentuk apapun

tindakan operasi katarak adalah bila didapatkan setidaknya salah satu kondisi di bawah ini:

1. Terdapat salah satu kondisi/penyakit pada pasien, sehingga membutuhkan anestesi umum (GA), antara lain:
2. Pasien Pediatri usia = 18 tahun, atau
3. Pasien Dewasa yang menderita setidaknya salah satu kondisi yang dapat menghalangi kerja sama dan kemampuan pasien untuk berbaring selama operasi, yaitu: dementia, tremor kepala, tuli, gangguan/kelainan tulang belakang, klaustrofobia, atau gangguan kejiwaan (termasuk gangguan kecemasan).
4. Terdapat penyakit sistemik / kondisi yang telah diderita pasien sebelumnya yang berdasarkan hasil konsultasi dengan dokter spesialis lain sesuai kompetensinya membutuhkan observasi ketat sebelum operasi, saat operasi, dan pasca operasi (wajib dicantumkan dalam rekam medis), atau
5. Terdapat komplikasi operasi yang membutuhkan tindakan/operasi tambahan dan/atau observasi ketat pasca operasi.

Batasan visus yang dapat dilakukan operasi katarak adalah $< 6/18$ (sesuai PNPK Katarak pada Dewasa).

Terdapat rekomendasi dari Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (PERDAMI) mengenai tindakan IOL tidak dapat dipasang sekaligus bersamaan dengan operasi katarak bila didapatkan setidaknya salah satu kondisi dan/atau komplikasi operasi di bawah ini:

1. Zonular tidak adekuat, atau
2. Capsular bag tidak adekuat, atau
3. Tanda-tanda peningkatan tekanan intraokular pada saat operasi, atau
4. Pasien Pediatri usia = 2 tahun.

Tindakan pemasangan IOL sekunder dilakukan pada setidaknya salah satu kondisi di bawah ini:

1. Afakia, atau
2. Dislokasi IOL, atau
3. Kekeruhan IOL, atau
4. Refractive Surprise, atau
5. Kerusakan Kornea akibat pemasangan Angle Supported AC-IOL.

Tindakan pemasangan IOL sekunder dapat dilakukan bila kondisi mata telah siap, yang ditandai dengan sudah tidak adanya proses infeksi dan/atau inflamasi pada mata tersebut.

Posterior Capsule Opacification (PCO) adalah Kekeruhan Kapsul Posterior yang merupakan komplikasi yang paling umum terjadi setelah operasi katarak dengan Teknik ECCE, SICS, dan Fakoemulsifikasi. PCO secara umum hanya terjadi satu kali kecuali pada keadaan tertentu.

Hingga saat ini belum ada ketentuan kapan waktu yang ideal untuk menangani PCO dengan laser Nd YAG. Tingkat keberhasilan kapsulotomi posterior dengan laser Nd YAG melebihi 95%. Frekuensi kapsulotomi menggunakan laser Nd YAG bervariasi antara 3% - 53% dalam kurun waktu paling cepat 2 bulan setelah operasi katarak.

Peningkatan risiko terjadinya PCO dapat terjadi bila sedikitnya terdapat salah satu di bawah ini:

1. usia pasien yang lebih muda, atau
2. terdapat riwayat peradangan intraokular, atau
3. terdapat sindrom pseudoexfoliation, atau
4. terdapat riwayat operasi yang menggunakan tamponade silicon oil, atau
5. semakin lama waktu setelah operasi.

Indikasi untuk kapsulotomi menggunakan *laser Nd YAG* meliputi sedikitnya terdapat salah satu hal berikut:

1. visus menurun yang dipastikan diakibatkan oleh PCO setelah masa evaluasi pasca operasi tuntas (> 1 bulan), atau
2. PCO menghalangi dokter untuk melihat kondisi fundus okular yang diperlukan untuk diagnosis dan terapi kelainan segmen posterior, atau
3. Diplopia monokuler yang disebabkan oleh gangguan pada kapsul posterior, atau
4. Perubahan posisi optik IOL akibat adanya kontraksi kapsulotomi anterior (fimosis kapsul), atau
5. *Capsular Block Syndrome*.

3.2.10 Aphakia (H27.0)

Jika dokter menyebutkan bahwa *aphakia* disebabkan oleh operasi pengangkatan lensa mata, tambahkan kode: H59.8 (*Other postprocedural disorders of eye and adnexa*) sebagai diagnosis tambahan. Jika dokter menyebutkan bahwa *aphakia* disebabkan oleh cedera, gunakan kode: T90.4 (*Sequelae of injury of eye and orbit*) sebagai diagnosis tambahan.

Contoh 3-12	Pasien datang untuk menjalani prosedur pemasangan lensa mata buatan. Sebelumnya, pasien telah menjalani operasi katarak dengan pengangkatan lensa mata pada kunjungan sebelumnya.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Aphakia pasca operasi	H27.0 <i>Aphakia</i>
Diagnosis Sekunder	-	H59.8 <i>Other postprocedural disorders of eye and adnexa</i>
Prosedur	Penyisipan lensa intraokular	13.72 <i>Secondary insertion of intraocular lens prosthesis</i>

3.2.11 Refractive Error (H52)

Kode dalam kelompok H52.- (*Disorders of refraction and accommodation*) diberikan sesuai diagnosis dokter. Untuk pasien dengan miopia (rabun jauh) yang dirawat dengan prosedur operasi *insertion of phakic intraocular lens*, kode prosedur yang digunakan adalah 13.70 (*Insertion of pseudophakos, not otherwise specified*).

3.2.12 Visual Impairment (H54.-)

Kode H54.- (*Visual impairment including blindness (binocular or monocular)*) ini tidak digunakan sebagai kode utama untuk “kondisi utama” jika penyebab gangguan penglihatan sudah dicatat, kecuali jika perawatan difokuskan terutama pada kebutaan itu sendiri. Saat mengkode penyebabnya, kode H54.- dapat digunakan sebagai kode tambahan opsional.

Dalam kasus operasi katarak pada kedua mata, gunakan tingkat ketajaman penglihatan jarak jauh yang diukur tanpa koreksi atau dengan alat bantu penglihatan yang digunakan (*presenting distance visual acuity*) dari mata dengan penglihatan lebih baik untuk menentukan kode sebagai

copyright@ Pusat pembiayaan kesehatan Kemenkes RI.

Dilarang mengcopy atau memperjualbelikan isi dan dokumen ini dalam bentuk apapun

berikut: Jika tidak dapat menghitung jari pada jarak 3 meter atau 10 kaki hingga tidak dapat melihat cahaya (kurang dari 3/60 atau 20/400 hingga *no light perception*), gunakan kode H54.0 (*Blindness, binocular*).

Jika tidak dapat membaca baris 6/60 atau 20/200 pada jarak 6 meter atau 20 kaki, tetapi masih dapat menghitung jari pada jarak 3 meter atau 10 kaki (kurang dari 6/60 atau 20/200 hingga 3/60 atau 20/400), gunakan kode H54.1 (*Severe visual impairment, binocular*).

Jika tidak dapat membaca baris 6/18 atau 20/70 pada jarak 6 meter atau 20 kaki, tetapi masih dapat membaca baris 6/60 atau 20/200 (kurang dari 6/18 atau 20/70 hingga 6/60 atau 20/200), gunakan kode H54.2 (*Moderate visual impairment, binocular*).

Jika dapat membaca baris 6/18 atau 20/70 pada jarak 6 meter atau 20 kaki, gunakan kode H54.3 (*Mild or no visual impairment, binocular*).

Contoh 4-12	Dokter mendiagnosis pasien dengan <i>senile hypermature cataract</i> pada mata kanan dan <i>senile combined cataract</i> pada mata kiri. Hasil pemeriksaan tajam penglihatan (<i>visual acuity/VA</i>) menunjukkan: • Mata kanan : hanya mampu mendeteksi gerakan tangan (<i>hand movement</i>) dan tidak membaik meskipun menggunakan lubang jarum (<i>pinhole not improve</i>). • Mata kiri : visus sebesar 1/60 atau 20/1200, dan juga tidak membaik dengan penggunaan lubang jarum (<i>pinhole not improve</i>). Tindakan operasi direncanakan hanya pada mata kanan untuk saat ini.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	<i>Senile hypermature cataract</i>	H25.2 <i>Senile cataract, morgagnian type</i> HL 01 <i>Left eye (IM)</i>
Diagnosis Sekunder	Kebutaan	H54.4 <i>Blindness, monocular</i> HL 00 <i>Right eye (IM)</i>

Contoh 5-12	Dokter mendiagnosis bahwa pasien mengalami <i>senile hypermature cataract</i> pada mata kanan dan <i>senile combined cataract</i> pada mata kiri. Hasil pemeriksaan tajam penglihatan (<i>visual acuity/VA</i>) menunjukkan: • Mata kanan : kemampuan melihat hanya terbatas pada persepsi gerakan tangan (<i>hand movement</i>) dan tidak membaik meskipun menggunakan lubang jarum (<i>pinhole not improve</i>). • Mata kiri : visus sebesar 1/60 atau 20/1200 , serta tidak menunjukkan perbaikan dengan penggunaan lubang jarum (<i>pinhole not improve</i>).
--------------------	--

	Tindakan operasi direncanakan untuk kedua mata guna menangani kondisi tersebut.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	<i>Senile hypermature cataract</i>	H25.2 <i>Senile cataract, morgagnian type</i> HL 01 <i>Left eye (IM)</i>
Diagnosis Sekunder	<i>Senile combined cataract</i> Kebutaan	H25.8 <i>Other senile cataract</i> H54.0 <i>Blindness, binocular</i> HL 00 <i>Right eye (IM)</i>

Contoh 6-12	Dokter mendiagnosis bahwa pasien mengalami katarak gabungan senil pada mata kanan dan katarak nuklear senil pada mata kiri. Hasil pemeriksaan tajam penglihatan (<i>visual acuity/VA</i>) menunjukkan: • Mata kanan : visus sebesar 5/60 atau 15/200 , yang meningkat menjadi 6/36 atau 20/100 dengan penggunaan lubang jarum (<i>pinhole</i>). • Mata kiri : visus sebesar 6/36 atau 20/100 , yang membaik menjadi 6/18 atau 20/70 dengan penggunaan lubang jarum (<i>pinhole</i>). Tindakan operasi direncanakan hanya pada mata kanan untuk saat ini guna menangani kondisi tersebut.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	<i>Senile combined cataract</i>	H25.8 <i>Other senile cataract</i>
Diagnosis Sekunder	Gangguan penglihatan parah, monocular	H54.5 <i>Severe visual impairment, monocular</i> HL 00 <i>Right eye (IM)</i> HL 01 <i>Left eye (IM)</i>

3.2.13 Operasi Trabekulotomi

Indikasi rawat inap pada tindakan operasi trabekulektomi adalah bila didapatkan setidaknya salah satu kondisi di bawah ini:

1. Terdapat salah satu kondisi/penyakit pada pasien, sehingga membutuhkan anestesi umum (GA), antara lain:
2. Pasien Pediatri usia = 18 tahun, atau
3. Pasien Dewasa yang menderita setidaknya salah satu kondisi yang dapat menghalangi kerja sama dan kemampuan pasien untuk berbaring selama operasi, yaitu: dementia, tremor kepala, tuli, gangguan/kelainan tulang

belakang, klaustrofobia, atau gangguan kejiwaan (termasuk gangguan kecemasan).

4. Terdapat penyakit sistemik / kondisi yang telah diderita pasien sebelumnya yang berdasarkan hasil konsultasi dengan dokter spesialis lain sesuai kompetensinya membutuhkan observasi ketat sebelum operasi, saat operasi, dan pasca operasi (wajib dicantumkan dalam rekam medis), atau
5. Terdapat komplikasi operasi (misalnya perdarahan intraokular, glaukoma maligna, dll.) yang membutuhkan tindakan/operasi tambahan dan/atau observasi ketat pasca operasi, atau
6. Penderita dengan rasa nyeri pasca operasi kategori VAS >4.

3.2.14 Pemeriksaan Tekanan Intra Okuli (TIO)

Pemeriksaan TIO adalah pemeriksaan yang bertujuan menentukan tekanan intra okuli, sebagai salah satu faktor risiko terpenting terjadinya glaukoma.

Indikasi pemeriksaan TIO pada penderita glaukoma adalah bila didapatkan setidaknya salah satu kondisi di bawah ini:

1. Penderita yang memiliki risiko glaukoma, atau
2. Penderita yang memiliki riwayat gejala dan tanda glaukoma, atau
3. Penderita glaukoma yang kontrol.

Pemeriksaan TIO juga harus dilakukan pada setidaknya salah satu kondisi di bawah ini:

1. Penderita yang baru pertama kali melakukan kunjungan pemeriksaan, atau
2. Penderita yang akan dilakukan pemeriksaan dan/atau tindakan pada segmen posterior. atau
3. Penderita yang akan dilakukan tindakan operasi mata, atau
4. Penderita lain sesuai indikasi medis.

3.3 MDC 13 TELINGA, MULUT, TENGGOROKAN

PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 13

- Hilang pendengaran yang terdokumentasi sebagai berat atau sangat berat tanpa diketahui penyebabnya harus selalu dikodekan menggunakan kode dari kategori H90.- (*Conductive and sensorineural hearing loss*) atau H91.- (*Other hearing loss*) tergantung pada jenis hilang pendengaran yang

didokumentasikan. Ketika penyebab hilang pendengaran berat atau sangat berat telah diketahui, kedua kondisi harus dikodekan, [penempatan kode](#) bergantung pada kondisi utama yang diobati atau diselidiki selama episode tersebut.

Contoh 1-13	Dokter mendiagnosis pasien dengan otosklerosis pada telinga kanan. Berdasarkan hasil tes pendengaran, diketahui bahwa telinga kanan mengalami gangguan pendengaran tipe konduktif, sementara pendengaran pada telinga kiri berada dalam kondisi normal. Selama operasi, ditemukan adanya plak sklerotik di area jendela oval, yang kemudian ditangani dengan melakukan prosedur stapedektomi.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Otosklerosis	H80.0 (<i>Otosclerosis involving oval window, nonobliterative</i>)
Diagnosis Sekunder	Gangguan pendengaran konduktif telinga kanan	H90.4 (<i>Sensorineural hearing loss, unilateral with unrestricted hearing on the contralateral side</i>)
Operasi	Stapedektomi	19.11 (<i>Stapedectomy with incus replacement</i>)

Contoh 2-13	Pasien datang dengan <i>tinnitus</i> dan pusing. Tes darah menunjukkan VDRL positif dan TPHA positif, dan dokter mendiagnosis otosifilis. Hasil pemeriksaan pendengaran menunjukkan bahwa telinga kanan mengalami gangguan pendengaran sensorineural.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Otosifilis	A52.1† (<i>Symptomatic neurosyphilis</i>)
Diagnosis Sekunder	Gangguan pendengaran konduktif telinga kanan	H94.0* (<i>Acoustic neuritis in infectious and parasitic diseases classified elsewhere</i>) H90.4 (<i>Sensorineural hearing loss, unilateral with unrestricted hearing on the contralateral side</i>)

Contoh 3-13	Pasien datang dengan <i>tinnitus</i> akut selama 1 minggu. Pemeriksaan fisik dan pemeriksaan telinga menunjukkan bahwa itu normal, tetapi pemeriksaan pendengaran menunjukkan gangguan pendengaran sensorineural 40 dB pada semua frekuensi.	
	Diagnosis	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Gangguan pendengaran sensorineural mendadak	H91.2 (<i>Sudden idiopathic hearing loss</i>)
Diagnosis Sekunder	-	-
Operasi	Injeksi steroid intratimpani	20.94 (<i>Injection of tympanum</i>)

- **Kasus tindakan ekstirpasi jaringan granulasi**

Pasien didiagnosis OMSK (*Otitis Media Suppuratif Kronis*) pada membran timpani dan dokter melakukan tindakan pengangkatan jaringan granulasi. Dalam proses pengkodean tindakan, perlu diperhatikan detail lokasi dan tujuan prosedur medis yang dilakukan:

- Jika tindakan yang dilakukan adalah eksisi (pengangkatan) pada telinga luar sebagai tindakan terapeutik, maka gunakan kode 18.29 (*Excision or destruction of other lesion of external ear*).
- Jika tindakan yang dilakukan hanya berupa biopsi jaringan telinga luar, maka gunakan kode 18.12 (*Biopsy of external ear*).
- Jika tindakan eksisi diikuti dengan biopsi (dengan hasil pemeriksaan patologi anatomi), maka gunakan kedua kode tersebut, yaitu kode eksisi dan kode biopsi.
- Dalam MDC 13 terdapat DRG khusus untuk tindakan *Rhinosinusitis & Nasal Polyp*, sehingga koder harus memperhatikan dokumentasi medis dan bukti tata laksana tindakan *Rhinosinusitis & Nasal Polyp*.
 - Apabila terdapat tindakan pada group *Rhinosinusitis & Nasal Polyp*, maka masuk ke *Rhinosinusitis & Nasal Polyp Proc.* Akan tetapi apabila pengodean group *Rhinosinusitis & Nasal Polyp* disertai lebih dari tiga tindakan pada group *Rhinosinusitis & Nasal Polyp Complex*, maka akan masuk ke dalam kelompok *Rhinosinusitis & Nasal Polyp Complex Proc.*

P13AG *Rhinosinusitis & Nasal Polyp Proc.*

21.31	<i>Local excision or destruction of intranasal lesion</i>
22.20	<i>Uncinectomy (IM)</i>
22.200	<i>Uncinectomy sinistra (IM)</i>
22.201	<i>Uncinectomy dextra (IM)</i>
22.41	<i>Frontal sinusotomy</i>
22.410	<i>Frontal sinusotomy sinistra (IM)</i>
22.411	<i>Frontal sinusotomy dextra (IM)</i>
22.42	<i>Frontal sinusectomy</i>
22.420	<i>Frontal sinusectomy sinistra (IM)</i>
22.421	<i>Frontal sinusectomy dextra (IM)</i>
22.50	<i>Sinusotomy, not otherwise specified</i>
22.51	<i>Ethmoidotomy</i>
22.510	<i>Ethmoidotomy sinistra (IM)</i>
22.511	<i>Ethmoidotomy dextra (IM)</i>
22.52	<i>Sphenoidotomy</i>
22.520	<i>Sphenoidotomy sinistra (IM)</i>
22.521	<i>Sphenoidotomy dextra (IM)</i>
22.53	<i>Incision of multiple nasal sinuses</i>
22.60	<i>Sinusectomy, not otherwise specified</i>
22.63	<i>Ethmoidectomy</i>
22.630	<i>Ethmoidectomy sinistra (IM)</i>
22.631	<i>Ethmoidectomy dextra (IM)</i>
22.64	<i>Sphenoidectomy</i>
22.640	<i>Sphenoidectomy sinistra (IM)</i>
22.641	<i>Sphenoidectomy dextra (IM)</i>
22.9	<i>Other operations on nasal sinuses</i>
96.21	<i>Dilation of frontonasal duct</i>

AX 13PCX Procedures for Rhinosinusitis and Nasal Polyp

21.31	<i>Local excision or destruction of intranasal lesion</i>
21.32	<i>Local excision or destruction of other lesion of nose</i>
22.20	<i>Uncinectomy (IM)</i>
22.200	<i>Uncinectomy sinistra (IM)</i>
22.201	<i>Uncinectomy dextra (IM)</i>

22.41	<i>Frontal sinusotomy</i>
22.410	<i>Frontal sinusotomy sinistra (IM)</i>
22.411	<i>Frontal sinusotomy dextra (IM)</i>
22.42	<i>Frontal sinusectomy</i>
22.420	<i>Frontal sinusectomy sinistra (IM)</i>
22.421	<i>Frontal sinusectomy dextra (IM)</i>
22.50	<i>Sinusotomy, not otherwise specified</i>
22.51	<i>Ethmoidotomy</i>
22.510	<i>Ethmoidotomy sinistra (IM)</i>
22.511	<i>Ethmoidotomy dextra (IM)</i>
22.52	<i>Sphenoidotomy</i>
22.520	<i>Sphenoidotomy sinistra (IM)</i>
22.521	<i>Sphenoidotomy dextra (IM)</i>
22.53	<i>Incision of multiple nasal sinuses</i>
22.60	<i>Sinusectomy, not otherwise specified</i>
22.63	<i>Ethmoidectomy</i>
22.630	<i>Ethmoidectomy sinistra (IM)</i>
22.631	<i>Ethmoidectomy dextra (IM)</i>
22.64	<i>Sphenoidectomy</i>
22.640	<i>Sphenoidectomy sinistra (IM)</i>
22.641	<i>Sphenoidectomy dextra (IM)</i>
22.9	<i>Other operations on nasal sinuses</i>
96.21	<i>Dilation of frontonasal duct</i>

- Pemberian kode 23.70 *Root canal, not otherwise specified* dan 23.71 *Root canal therapy with irrigation* dalam sistem pengkodean prosedur dilakukan hanya satu kali pada awal perawatan untuk gigi yang sama, dan berlaku hingga seluruh rangkaian terapi pada gigi tersebut selesai. Pengulangan pengkodean tidak diperlukan untuk setiap kunjungan selama terapi berlangsung pada gigi yang sama. Namun, apabila perawatan dilakukan pada gigi yang berbeda, maka masing-masing perawatan dapat dikodekan sekali pada awal terapi gigi tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk mencerminkan praktik klinis yang efisien dan mencegah duplikasi tarif dalam sistem pembayaran.

PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 13

3.3.1 Otitis Externa (H60.-)

Jika dokter mendiagnosis *malignant otitis externa* atau *necrotizing otitis externa* gunakan kode H60.2 (*Malignant otitis externa*). Jika kondisi ini ditemukan bersamaan dengan diabetes, gunakan kode diabetes sebagai diagnosis tambahan.

Contoh 1-13	Pasien dengan sakit telinga, demam tinggi, dan saluran telinga yang membengkak. Pasien memiliki riwayat diabetes tipe 2 dan tidak minum obat dengan rutin. Dokter mendiagnosis otitis eksterna ganas.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Otitis eksterna ganas	H60.2 <i>Malignant otitis externa</i>
Diagnosis Sekunder	Diabetes mellitus tipe 2	E11.9 <i>Non-insulin-dependent diabetes mellitus without complications</i>

3.3.3 Cholesteatoma (H71)

- Jika dokter mendiagnosis *congenital cholesteatoma*, gunakan kode Q17.8 (*Other congenital malformation of the ear*).
- Jika dokter mendiagnosis *primary acquired cholesteatoma*, kode yang sesuai adalah H71 (*Cholesteatoma of middle ear*).
- Jika dokter mendiagnosis *secondary acquired cholesteatoma* atau *chronic otitis media with cholesteatoma*, gunakan kode H71 (*Cholesteatoma of middle ear*) sebagai diagnosis utama, dan kode untuk chronic otitis media sebagai diagnosis tambahan, misalnya H66.3 (*Other chronic suppurative otitis media*).
- Dalam kasus cholesteatoma yang ditemukan setelah operasi mastoidectomy, dan pasien harus secara rutin membersihkan telinga, kode yang sesuai adalah H95.0 (*Recurrent cholesteatoma of postmastoidectomy cavity*).

Contoh 4-13	Pasien dengan gangguan pendengaran (tuli) di telinga kiri, kemudian dokter mendeteksi puing-puing keratin dan epitel skuamosa di telinga tengah otitis media kronis dengan kolesteatoma. Lalu, pasien mengalami <i>tinnitus</i> di telinga kirinya. Melalui audiogram, dokter menemukan bahwa itu gangguan pendengaran konduktif sisi kiri yang merupakan komplikasi dari <i>cholesteatoma</i> .	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Kolesteatoma	H71 <i>Cholesteatoma of middle ear</i>
Diagnosis Sekunder	Otitis media kronis	H66.3 <i>Other chronic suppurative otitis media</i>
Komplikasi	Gangguan pendengaran konduktif, telinga kiri	H90.1 <i>Conductive hearing loss, unilateral with unrestricted hearing on the contralateral side</i>

3.3.4 Perforation Of Tympanic Membrane (H72.-)

Pengodean kasus perforasi gendang telinga :

- 1) *Acute otitis media* dengan perforasi gendang telinga => H66.0 (*Acute suppurative otitis media*) sebagai DU, H72.- (*Perforation of tympanic membrane*) sebagai DS
- 2) *Chronic otitis media* dengan perforasi gendang telinga => H66.3 *Other chronic suppurative otitis media* sebagai DU, H72.- (*Perforation of tympanic membrane*) sebagai DS.
- 3) *Traumatic tympanic membrane perforation* => S09.2 (*Traumatic rupture of ear drum*), ditambahkan dengan dengan kode penyebab eksternal sebagai diagnosis sekunder.

Contoh 3-13	Pasien bertengkar dengan suaminya di rumah. pasien mengungkapkan "Saya ditampar oleh suami saya". Pasien mengeluh sakit telinga dan berdenging (<i>Tinnitus</i>), dokter mendeteksi gendang telinga berlubang dan berdarah di saluran telinga. Kemudian dokter mendiagnosis perforasi traumatis membran timpani.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis primer	Perforasi traumatis membran timpani	S09.2 <i>Traumatic rupture of ear drum</i>

Diagnosis sekunder	-	-
Penyebab eksternal	Saya ditampar oleh suami saya di rumah.	Y04.09 <i>Assault by bodily force in home during unspecified activity</i>

3.3.5 Vertigo (H81, R42)

- 1) *Meniere's disease* atau *endolymphatic hydrops*
 - Jika gejala klinis lengkap, gunakan kode H81.0 (*Meniere's disease*)
 - Jika gejala klinis tidak lengkap, konsultasikan dengan dokter untuk mempertimbangkan diagnosis menjadi *peripheral vertigo* dengan penyebab tidak diketahui, dan gunakan kode H81.3 (*Other peripheral vertigo*)
- 2) Pada kasus *peripheral vertigo* dengan penyebab yang jelas dan spesifik, gunakan kode penyakit penyebabnya sebagai diagnosis utama, tanpa perlu menggunakan kode H81.3 *Other peripheral vertigo* sebagai diagnosis tambahan

Contoh 4-13	Pasien mengalami vertigo perifer yang telah berlangsung cukup lama dengan gangguan pendengaran sensorineural tipe fluktuatif. Pemeriksaan laboratorium menunjukkan hasil dengan titer tinggi pada tes VDRL (<i>Venereal Disease Research Laboratory</i>) serta hasil positif pada TPHA (<i>Treponema Pallidum Hemagglutination Assay</i>).	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Otosifilis	A52.1† <i>Symptomatic neurosyphilis</i>
Diagnosis Sekunder	Vertigo perifer	H94.0* <i>Acoustic neuritis in infectious and parasitic diseases classified elsewhere</i> H81.3 <i>Other peripheral vertigo</i>

3.3.6 Hearing Loss (H90-H91)

Kode H90-H91 tidak digunakan sebagai kode utama untuk “Diagnosis utama” jika penyebab gangguan pendengaran sudah dicatat, kecuali jika penanganan difokuskan terutama pada gangguan pendengaran itu sendiri. Saat mengkode penyebabnya, kode H90.- atau H91.- dapat digunakan sebagai diagnosis sekunder.

Gunakan kode penyebab utama yang menyebabkan penurunan atau kehilangan pendengaran sebagai diagnosis utama, dan gunakan kode dalam kelompok H90.- (*Conductive and sensorineural hearing loss*) sebagai diagnosis tambahan.

Contoh 5-13	Pasien didiagnosis oleh dokter dengan otosklerosis pada telinga kanan. Berdasarkan hasil pemeriksaan pendengaran, diketahui bahwa telinga kanan mengalami gangguan pendengaran tipe konduktif, sementara pendengaran pada telinga kiri berada dalam kondisi normal. Pada saat dilakukan operasi, ditemukan adanya plak sklerotik di area jendela oval, yang kemudian ditangani melalui prosedur stapedektomi untuk memperbaiki fungsi pendengaran pasien.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Otosklerosis	H80.0 <i>Otosclerosis involving oval window, nonobliterative</i>
Diagnosis Sekunder	Gangguan pendengaran konduktif telinga kanan	H90.4 <i>Sensorineural hearing loss, unilateral with unrestricted hearing on the contralateral side</i>
Operasi	Stapedektomi	19.11 <i>Stapedectomy with incus replacement</i>

Contoh 6-13	Pasien datang dengan keluhan <i>tinnitus</i> dan rasa pusing. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan bahwa tes VDRL (<i>Venereal Disease Research Laboratory</i>) dan TPHA (<i>Treponema Pallidum Hemagglutination Assay</i>) positif, yang mengindikasikan adanya infeksi sifilis.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Otosifilis	A52.1† <i>Symptomatic neurosyphilis</i>
Diagnosis Sekunder	Gangguan pendengaran konduktif telinga kanan	H94.0* <i>Acoustic neuritis in infectious and parasitic diseases classified elsewhere</i>
		H90.4 <i>Sensorineural hearing loss, unilateral with unrestricted hearing on the contralateral side</i>

Contoh 7-13	Pasien datang dengan keluhan <i>tinnitus</i> yang bersifat akut dan telah berlangsung selama satu minggu. Pemeriksaan fisik umum serta pemeriksaan kondisi telinga luar dan tengah menunjukkan hasil yang normal, tanpa adanya kelainan yang terdeteksi secara klinis. Namun, pemeriksaan fungsi pendengaran mengungkapkan adanya gangguan pendengaran sensorineural dengan penurunan ambang pendengaran sebesar 40 dB pada semua frekuensi yang diuji.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis primer	Gangguan pendengaran sensorineural mendadak	H91.2 (<i>Sudden idiopathic hearing loss</i>)
Diagnosis sekunder	-	-
Operasi	Injeksi steroid intratimpani	20.94 (<i>Injection of tympanum</i>)

3.3.7 Rhinitis (J00, J30, J31.0)

Kode J31.0 (*Chronic rhinitis*) digunakan jika dokter mendiagnosis *chronic rhinitis*, *NARES (Non-Allergic Rhinitis with Eosinophilia Syndrome)*, *rhinitis medicamentosa*, *drug-induced rhinitis*, *hormone-induced rhinitis*, *atrophic rhinitis*, atau *irritative rhinitis*

3.3.8 Sinusitis (J01, J32)

Pengodean kasus sinusitis :

- 1) Jika dokter mendiagnosis *acute sinusitis* atau *acute rhinosinusitis*, gunakan kode dari grup : J01.- (*Acute sinusitis*). Kode ini juga mencakup *subacute sinusitis*.
- 2) Jika dokter mendiagnosis *chronic sinusitis* atau *chronic rhinosinusitis*, gunakan kode dari grup: J32.- (*Chronic sinusitis*). Pemeriksaan *CT scan* sinus paranasal merupakan baku emas dalam penegakan diagnosa rinosinusitis kronik. Rinosinusitis kronik ditegakkan bila pada *CT scan* didapatkan: perubahan mukosa yang berkaitan dengan kompleks ostiomeatal dan/atau sinus paranasal, yang melibatkan lebih dari 2 dinding sinus dan melibatkan area ostium sinus. (KMK No HK.01.07/MENKES 1257/2022 tentang PNPK Tatalaksana Sinusitis Kronik) Jika lokasi sinus yang terkena ditentukan melalui radiografi atau CT scan, gunakan kode yang lebih spesifik.

- 3) Jika dilakukan pemeriksaan kultur bakteri dan ditemukan agen infeksi, tambahkan kode penyebab atau agen infeksi sebagai kode tambahan.
- 4) Jika dokter mendiagnosis *allergic fungal sinusitis* (AFS) dengan hasil pemeriksaan patologi atau kultur positif untuk jamur *Aspergillus*, gunakan dua kode berikut: B44.8 (*Other forms of aspergillosis*) sebagai kode utama dan J32.- (*Chronic sinusitis*) sebagai kode tambahan.
- 5) Jika dokter mendiagnosis *invasive Fungal Sinusitis* dari infeksi jamur *Aspergillus*, gunakan dua kode berikut: B44.8 (*Other forms of aspergillosis*) sebagai kode utama dan J32.- (*Chronic sinusitis*) sebagai kode tambahan.
- 6) Jika disebabkan oleh *Mucor* (*mucormycosis*), gunakan dua kode berikut: B46.1 (*Rhinocerebral mucormycosis*) sebagai kode utama dan J32.- (*Chronic sinusitis*) sebagai kode tambahan.
- 7) Jika pasien memiliki penyakit lain seperti diabetes atau gangguan imun, maka diagnosis tambahan penyakit terkait juga perlu dicantumkan
- 8) Prosedur Bedah untuk Sinusitis:
 - a) *Endoscopic Sinus Surgery* (ESS): Operasi dengan menggunakan endoskop kaku untuk mengangkat lesi pada sinus. Kode operasi harus didasarkan pada detail prosedur yang dilakukan.
 - b) *Microscopic Sinus Surgery* (MSS): Operasi dengan menggunakan mikroskop bedah untuk mengangkat lesi pada sinus. Kode operasi harus didasarkan pada detail prosedur yang dilakukan.
 - c) *Caldwell-Luc Operation* (CWL): Prosedur bedah untuk mengobati sinusitis maksilaris kronis melalui pendekatan canine fossa di bawah gusi. gunakan kode tindakan 22.61 (*Excision of lesion of maxillary sinus with Caldwell-Luc approach*).

Contoh 8-13	Pasien dengan AIDS mengalami gejala sinusitis kronis yang disertai infeksi pada kelopak mata. Selain itu, pasien juga mengalami abses orbital. Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut, dokter mendiagnosis kondisi ini sebagai sinusitis jamur invasif. Hasil biopsi menunjukkan adanya
--------------------	---

	keberadaan jamur jenis mucorales, yang menjadi penyebab utama infeksi tersebut.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Sinusitis jamur invasif karena mucorales	B20.5 (<i>HIV disease resulting in other mycoses</i>)
Diagnosis Sekunder	Penyakit HIV Abses orbital	B46.1 (<i>Rhinocerebral mucormycosis</i>) J32.4 (<i>Chronic pansinusitis</i>) H05.0 (<i>Acute inflammation of orbit</i>)

3.3.9 Tonsillectomy

Tonsillectomy merupakan prosedur pengangkatan tonsil untuk mengobati chronic hypertrophic tonsillitis (CHT). Kode Prosedur: 28.2 (*Tonsillectomy without adenoidectomy*).

Adenoidectomy merupakan prosedur pengangkatan adenoid untuk mengobati adenoid hypertrophy. Kode Prosedur: 28.6 (*Adenoidectomy without tonsillectomy*).

Jika dilakukan pengangkatan kedua tonsil dan adenoid secara bersamaan (*Tonsillectomy dengan Adenoidectomy*), Kode Prosedur: 28.3 (*Tonsillectomy with adenoidectomy*).

Contoh 9-13	Pasien mengalami demam dan sakit tenggorokan selama 3 hari. Dokter mendiagnosis tonsilitis akut, dan hasil kultur menemukan <i>Haemophilus influenzae</i> .	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Tonsilitis akut akibat <i>Haemophilus influenzae</i>	J03.8 (<i>Acute tonsillitis due to other specified organisms</i>)
Diagnosis Sekunder	-	B96.3 (<i>Haemophilus influenzae [H. influenzae] as the cause of diseases classified to other chapters</i>)

3.3.10 Hoarseness

Gunakan kode spesifik sesuai penyebab *Hoarseness* yang didiagnosis oleh dokter, sebagai berikut:

- 1) *Laryngeal Web* / Anomali Laring Kongenital, gunakan kode Q31.0 (*Web of larynx*).
- 2) *Acute Laryngitis*, gunakan kode J04.0 (*Acute laryngitis*).
- 3) *Chronic Laryngitis*, gunakan kode J37.0 (*Chronic laryngitis*).
- 4) Polip Vokal, gunakan kode J38.1 (*Polyp of vocal cord and larynx*).
- 5) Nodul Vokal, gunakan kode J38.2 (*Nodules of vocal cords*).
- 6) Kista Vokal atau Gangguan Lain Pita Suara, gunakan kode J38.3 (*Other diseases of vocal cords*).
- 7) Kelumpuhan Pita Suara Tanpa Penyebab yang Diketahui (Idiopatik), gunakan kode J38.0 (*Paralysis of vocal cords and larynx*).
- 8) Jika diketahui penyebab, gunakan kode untuk penyebab tersebut.
Contohnya: Jika disebabkan oleh komplikasi tindakan operasi tiroid, gunakan kode T81.2 (*Accidental puncture and laceration during a procedure, not elsewhere classified*).
- 9) *Spastic Dysphonia*, gunakan kode J38.3 (*Other diseases of vocal cords*).
- 10) Jika tidak terdapat penyebab yang ditetapkan atau jika dokter hanya mencatat "*hoarseness*" tanpa menyebutkan penyebabnya, gunakan kode R49.0 (*Dysphonia*).

Contoh 10-13	Pasien dengan nodul tiroid telah menjalani operasi lobektomi. Setelah operasi, pasien mengalami suara serak, dan pemeriksaan menunjukkan bahwa pita suara mengalami kelumpuhan (paralisis).	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Nodul tiroid	E04.1 <i>Nontoxic single thyroid nodule</i>
Diagnosis Sekunder	Kelumpuhan pita suara	J38.0 (<i>Paralysis of vocal cords and larynx</i>)
Diagnosis Lain	-	-
Operasi	Lobektomi	06.2 (<i>Unilateral thyroid lobectomy</i>)

3.4 MDC 14 SISTEM PERNAFASAN

PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 14

Pada pasien tuberkulosis, baik yang melibatkan sistem pernapasan maupun sistem lainnya, gunakan kode A15–A19 apabila pasien masih menunjukkan sensitivitas terhadap obat.

Jika terdapat resistensi terhadap Obat Anti-Tuberkulosis (OAT), kode primer tetap menggunakan A15–A19, dan ditambahkan:

- a. Kode **U88** untuk mencatat adanya resistensi obat, serta
- b. Kode tambahan **IM** yang menjelaskan jenis resistensi obat tertentu.

Namun demikian, kode A15–A19 tidak boleh digunakan apabila pasien dirawat karena mengalami efek samping akibat penggunaan OAT.

Dalam kasus tersebut, gunakan:

- a. Kode diagnosis yang sesuai untuk menggambarkan efek samping OAT (baik yang bersifat sistemik maupun yang tidak ditentukan), dan
- b. Kode dari **Bab 20** (Chapter XX) untuk mencatat penyebab luar terkait penggunaan OAT.

AX 14BX TB Episode of Care

- U84.31 Tuberculosis with multidrug resistance (IM)
- U84.32 Tuberculosis with pre extreme drug resistance (IM)
- U84.33 Tuberculosis with extreme drug resistance (IM)
- U84.34 Tuberculosis with poly drug resistance (IM)
- U84.35 Tuberculosis with mono drug resistance (IM)

AX 14CX Drug Types

- U82.20 Respiratory diseases with resistance of betalactamase (ESBL) resistance (IM)
- U82.80 Respiratory diseases with resistance of betalactam antibiotics (IM)
- U83.3 Respiratory diseases with resistance to other antibiotics (IM)
- U84.10 Respiratory diseases with resistance to antifungal drugs (IM)
- U84.20 Respiratory diseases with resistance to antiviral drugs (IM)
- U85.0 Respiratory diseases with resistance to antineoplastic drugs (IM)

PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 14

3.4.1 Influenza (J09-J11)

Jika dokter mendiagnosis influenza dengan hasil tes positif untuk *avian influenza virus*, gunakan kode J09 (*Influenza due to identified avian influenza virus*).

Jika dokter mendiagnosis influenza dengan hasil tes positif untuk jenis virus influenza lainnya (misalnya A, B, C, atau H1N1), gunakan kode dari grup: J10.- (*Influenza due to other identified influenza virus*).

Jika tidak dilakukan tes atau tes tidak mendeteksi virus influenza, gunakan kode dari grup: J11.- (*Influenza, virus not identified*).

Penambahan Kode untuk komplikasi: Jika ada komplikasi seperti pneumonia atau kondisi lainnya, tambahkan kode spesifik untuk komplikasi tersebut sesuai dengan diagnosis dokter.

3.4.2 Pneumonia (J12-J18, J69)

Pneumonia diklasifikasikan dalam MDC 14 dengan kategori spesifik J12-J18 dan J69. Kode J12-J17 digunakan untuk pneumonia yang disebabkan oleh agen spesifik, seperti virus, bakteri, atau organisme lainnya. Sementara itu, kode J69 digunakan untuk kondisi pneumonia yang disebabkan oleh aspirasi benda padat atau cair (*aspiration pneumonia*).

Penetapan kode untuk pneumonia harus mempertimbangkan beberapa aspek agar kode yang diberikan sesuai dengan dokumentasi klinis dan benar-benar merepresentasikan kondisi pasien secara akurat. Berikut beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengkodean pneumonia:

1. Pengkodean dalam kategori J12-J17

a. Viral Pneumoniae (J12)

Jika pneumonia disebabkan oleh Virus, namun kode dalam kategori J12 tidak menggambarkan secara spesifik jenis virus, maka gunakan kode tambahan dari kategori **B97 Viral agents as the cause of diseases classified to other chapters** untuk mengidentifikasi secara spesifik agen infeksi.

Contoh:

- Pneumonia due to adenovirus
Kode: J12.0 Adenoviral pneumonia
- Pneumonia due to enterovirus
Kode Utama : J12.8 Other viral pneumonia dan kode
Kode Sekunder : B97.1 Enterovirus as the cause of diseases
classified elsewhere

b. Bacterial Pneumonia (J13, J14 & J15)

Apabila kode dalam kategori **J13–J15 (Pneumonia bakteri)** tidak sepenuhnya menggambarkan jenis bakteri penyebab secara spesifik, maka kode tambahan dari kategori B95–B96 harus digunakan sebagai kode sekunder untuk mengidentifikasi agen infeksius penyebab pneumonia.

Contoh:

- Pneumonia akibat staphylococcus
Kode Utama : J15.2 Pneumonia due to staphylococcus
- Pneumonia akibat staphylococcus aureus
Kode Utama : J15.2 Pneumonia due to staphylococcus
Kode Sekunder : B95.6 *Staphylococcus aureus* as the cause of diseases classified to other chapters
- Pneumonia akibat bakteri Gram-Negatif berdasarkan pengecatan gram
Kode Utama : J15.6 Pneumonia due to other aerobic Gram-negative bacteria

c. Pneumonia akibat benda padat dan cair

Apabila pneumonia disebabkan oleh benda padat dan/atau cairan, gunakan kode J69 *Pneumonitis due to solids and liquids*. Jika penyebab spesifik teridentifikasi, maka kode tambahan dari Chapter XX (Faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehatan dan kontak dengan layanan kesehatan) harus digunakan sebagai kode sekunder untuk melengkapi informasi penyebab, misalnya sebagai berikut.

- Jika tidak diketahui penyebab aspirasi, atau jika aspirasi disebabkan oleh makanan, susu, atau muntahan, gunakan J69.0 *Pneumonitis due to food and vomit*.

- Jika dokter menyatakan bahwa penyebab pneumonia adalah menghirup berbagai jenis minyak, gunakan J69.1 *Pneumonitis due to oils and essences*.
- Jika dokter menyatakan penyebab infeksi adalah aspirasi zat lain, seperti darah atau bahan lainnya, gunakan J69.8 *Pneumonitis due to other solids and liquids*.

Pada kasus pneumonia berdasarkan penyebab (J12-J18), Gunakan kode dari grup J12-J18 sesuai jenis pneumonia yang didiagnosis oleh dokter, contohnya sebagai berikut.

- Pneumonia akibat *Acinetobacter baumannii* atau *Serratia marcescens* menggunakan kode J15.6 *Pneumonia due to other aerobic Gram-negative bacteria*.
- Cytomegaloviral pneumonia, menggunakan kode B25.0† (*Cytomegaloviral pneumonitis*) sebagai kode utama dan J17.1* (*Pneumonia in viral diseases classified elsewhere*) sebagai kode tambahan.
- *Aspergillus pneumonia*, menggunakan kode B44.0† *Invasive pulmonary aspergillosis* atau B44.1† (*Other pulmonary aspergillosis*) sebagai kode utama dan J17.2* *Pneumonia in mycoses* sebagai kode tambahan.

Jika dokter mendiagnosis pneumonia sebagai *hospital-acquired pneumonia* (HAP) atau *ventilator-associated pneumonia* (VAP), maka harus ditambahkan kode penyebab eksternal untuk kondisi nosokomialnya, yaitu Y95 *Nosocomial condition*. Kode ini digunakan untuk menunjukkan bahwa infeksi pneumonia diperoleh selama perawatan di fasilitas kesehatan.

Jika dokter mendiagnosis bahwa patogen penyebab pneumonia resisten terhadap antibiotik tertentu, gunakan kode tambahan dari grup U80.-, U81.-, atau U88 untuk mencatat jenis resistensi bakteri yang teridentifikasi, sesuai dengan hasil pemeriksaan sensitivitas bakteri. Contohnya:

- U80.0 *Penicillin resistant agent*.
- U80.1 *Methicillin resistant agent*.

- U80.8 *Agent resistant to other penicillin-related antibiotic.*
- U81.0 *Vancomycin resistant agent.*
- U81.8 *Agent resistant to other vancomycin-related antibiotic.*
- U88 *Agent resistant to multiple antibiotics.*

3.4.3 Bronchitis (J20, J40-J42)

Jika dokter mendiagnosis acute bronchitis, gunakan kode dari grup J20.- (*Acute bronchitis*). Jika penyebab spesifik diketahui (misalnya virus atau bakteri), gunakan kode spesifik sesuai patogen. Pemilihan kode harus didasarkan pada jenis bronchitis (akut atau kronis), usia pasien, serta keterangan spesifik dari dokter yang menangani. Jika penyebab tidak diketahui atau tidak dicatat, gunakan kode J20.9 (*Acute bronchitis, unspecified*).

Jika dokter mendiagnosis *chronic bronchitis*, gunakan kode berikut: J41.0 (*Simple chronic bronchitis*) jika dokter mencatat jenis "simple", J41.1 (*Mucopurulent chronic bronchitis*) jika dokter mencatat jenis "mucopurulent", atau J42 (*Unspecified chronic bronchitis*) jika jenis chronic bronchitis tidak ditentukan.

Jika dokter hanya mencatat diagnosis bronchitis tanpa menyebutkan apakah akut atau kronis: Untuk pasien usia kurang dari 15 tahun, gunakan kode J20.- *Acute bronchitis*. Untuk pasien usia 15 tahun atau lebih, gunakan kode J40 *Bronchitis, not specified as acute or chronic*.

3.4.4 Stenosis Laryngotracheal (J38.6, J39.8, J95.5)

Pada kasus *Stenosis of larynx* (J38.6) kode J38.6 tetap digunakan terlepas apakah dokter mendiagnosis sebagai *subglottic*, *glottic*, atau *supraglottic stenosis*, atau *posterior commissure synechiae stenosis*. Jika dokter mendiagnosis *subglottic* stenosis yang disebabkan oleh prosedur medis, seperti pemasangan endotracheal tube, gunakan kode J95.5 (*Postprocedural subglottic stenosis*). Jika dokter mendiagnosis *subglottic* stenosis sebagai kondisi bawaan sejak lahir, gunakan kode: Q31.1 (*Congenital subglottic stenosis*).

Jika dokter mendiagnosis laryngotracheal stenosis, yaitu penyempitan yang melibatkan baik laring maupun trakea, dengan

penyempitan laring lebih parah, gunakan J38.6 *Stenosis of larynx* sebagai kode utama dan J39.8 (*Other specified diseases of upper respiratory tract*) sebagai kode tambahan.

3.4.5 Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) (J44.-)

Jika dokter mendiagnosis COPD dengan infeksi sekunder saluran pernafasan bawah (kecuali influenza), termasuk didalamnya pneumonia, maka gunakan kode J44.0 (*Chronic obstructive pulmonary disease with acute lower respiratory infection*) sebagai kode utama. Misalnya jika diagnosis mencakup COPD dengan *acute bronchitis*, gunakan kode J44.0 (*Chronic obstructive pulmonary disease with acute lower respiratory infection*).

Jika dokter mendiagnosis COPD dengan *acute exacerbation*, gunakan kode J44.1 (*Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified*).

Jika dokter mendiagnosis COPD dengan Eksaserbasi Akut dan Acute Bronchitis, gunakan kode gabungan J44.1 (*Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified*). dan J20 (*Acute bronchitis*).

Jika COPD dengan Eksaserbasi Akut dan Pneumonia, gunakan J44.1 (*Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified*) sebagai kode utama. Sedangkan pneumonia dikoding terpisah menggunakan kode J18.9 (*Pneumonia, unspecified*) jika tidak diketahui jenis agen penginfeksi. Akan tetapi, gunakan kode pneumonia yang lebih spesifik, jika agen penginfeksi diketahui.

Jika dokter hanya mencatat COPD tanpa spesifikasi tambahan, gunakan kode J44.9 (*Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified*).

Jika emfisema merupakan bagian dari COPD, gunakan kode J44.- (*Other chronic obstructive pulmonary disease*), sesuai kondisi. Jika emfisema didiagnosis secara terpisah tanpa detail tambahan, gunakan kode J43.9 (*Emphysema, unspecified*).

3.4.6 Asthma (J45-J46)

Jika dokter mendiagnosis *asthmatic bronchitis* atau hanya mencatat asma tanpa rincian tambahan, gunakan kode: J45.9 (*Asthma, unspecified*). Jika diagnosis adalah *chronic asthmatic bronchitis*, gunakan kode: J44.8 (*Other specified chronic obstructive pulmonary disease*).

Kode J46 (Status asthmaticus) hanya boleh diberikan apabila dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) secara jelas mendokumentasikan diagnosis sebagai "**acute severe asthma**" atau "**status asthmaticus**" dalam rekam medis pasien. Apabila hanya ditemukan istilah "**acute asthma**" tanpa disertai penjelasan lebih lanjut mengenai derajat keparahan (misalnya tidak disebutkan "severe"), maka klarifikasi harus dilakukan kepada DPJP guna memastikan bahwa diagnosis yang dikodekan benar dan sesuai kondisi klinis pasien.

3.4.7 Bronchiectasis (J47)

Jika dokter mendiagnosis *bronchiectasis* atau *infected bronchiectasis*, gunakan kode J47 (*Bronchiectasis*). Jika dokter mencatat adanya *massive haemoptysis* (batuk darah masif), tambahkan kode R04.2 (*Haemoptysis*) untuk menunjukkan tingkat keparahan penyakit.

3.4.8 Lung Diseases Due To External Agents (J60-J66)

- Jika diagnosis Silicosis disebabkan oleh debu talc, gunakan kode J62.0 *Pneumonconiosis due to talc dust*. Jika disebabkan oleh Namun, jika disebabkan oleh debu silika lainnya, gunakan kode J62.8 (*Pneumonconiosis due to other dust containing silica*).
- Pneumokoniosis dengan Tuberkulosis: J65 (*Pneumoconiosis associated with tuberculosis*) sebagai kode utama. Tambahkan kode untuk pneumokoniosis (J60-J64) dan tuberkulosis (A15-A16) sebagai kode tambahan.

3.4.9 Hypersensitivity Pneumonitis Due To Organic Dust (J67.-)

Gunakan kode dari grup J67.- (*Hypersensitivity pneumonitis due to organic dust*) sesuai diagnosis dokter. Jika dokter menyimpulkan bahwa penyakit yang ditemukan merupakan kondisi yang berhubungan dengan

pekerjaan, tambahkan kode penyebab eksternal Y96 (*Work-related condition*). Jika dokter menyimpulkan kondisi penyakit berhubungan dengan pencemaran lingkungan, tambahkan kode penyebab eksternal Y97 (*Environmental-pollution-related condition*).

3.4.10 Respiratory Conditions Due To External Agents (J68.-, J70.-)

- Kondisi Akibat Inhalasi Bahan Kimia, Gas, Asap, dan Uap, gunakan kode dari grup J68.- (*Respiratory conditions due to inhalation of chemicals, gases, fumes and vapours*).
- Kondisi Akibat Radiasi atau Obat-Obatan: Gunakan kode dari grup J70.- (*Respiratory conditions due to other external agents*).
- Tambahkan kode penyebab eksternal sesuai dengan agen spesifik yang dicatat oleh dokter.

3.4.11 Adult Respiratory Distress Syndrome (ARDS) (J80)

Jika dokter mendiagnosis *adult respiratory distress syndrome*, gunakan kode: J80 (*Adult respiratory distress syndrome*). Kode J80 sudah mencakup gejala gagal napas (*respiratory failure*) sebagai bagian dari kondisi penyakit tersebut, sehingga tidak diperlukan penambahan kode tersendiri untuk menggambarkan gagal napas secara terpisah.

3.4.12 Abscess Of Lung (J85)

Jika dokter mencatat bahwa pasien memiliki abses paru disertai pneumonia, dan pneumonia tersebut tidak disebabkan oleh organisme spesifik yang termasuk dalam kode J09–J16, maka gunakan kode J85.1 (*Abscess of lung with pneumonia*).

Namun, jika pneumonia disebabkan oleh organisme tertentu yang sudah diklasifikasikan dalam kode J09 sampai J16 (misalnya pneumonia akibat virus influenza, bakteri spesifik, atau organisme lain yang telah ditentukan), maka gunakan kode pneumonia spesifik dari J09–J16.

Apabila dokter mencatat bahwa pasien memiliki abses paru tanpa disertai pneumonia, atau tidak ada informasi yang menyebutkan adanya pneumonia, maka gunakan kode J85.2 (*Abscess of lung without pneumonia*).

3.4.13 *Pleural Effusion (J90-J91)*

Jika dokter tidak mencatat penyebab spesifik dari efusi pleura, gunakan kode J90 (*Pleural effusion, not elsewhere classified*). Jika dokter mencatat penyebab spesifik dari efusi pleura, gunakan kode penyebab utama sebagai kode diagnosis utama, dan tambahkan kode: J91* (*Pleural effusion in conditions classified elsewhere*) sebagai kode diagnosis tambahan. Pengecualian untuk Penyebab Tertentu:

1. Jika efusi pleura akibat keganasan atau efusi pleura sebagai manifestasi sekunder dari proses keganasan lain, maka gunakan kode J91* *Pleural effusion in conditions classified elsewhere* sebagai diagnosis sekunder. Meskipun hasil sitologi menunjukkan adanya sel ganas, kode yang digunakan tetap J91*.
2. Kode C78.2 (*Secondary malignant neoplasm of pleura*) digunakan jika ada keterlibatan metastatik langsung pada jaringan pleura, bukan pada cairan pleura itu sendiri. Dengan demikian, C78.2 tidak digunakan hanya berdasarkan temuan sel ganas dalam cairan pleura, melainkan bila terdapat bukti keterlibatan anatomis pleura oleh proses metastasis. Jika diketahui lokasi kanker primernya, kode kanker primernya sebagai diagnosis utama dan C78.2 sebagai diagnosis sekunder. Jika diketahui ada manifestasi di fungsi pleura, tetapi tidak diketahui dari mana kanker berasal, maka kode C78.2 bisa menjadi diagnosis utama. Sedangkan jika efusi pleura tidak terbukti menunjukkan keganasan, maka menggunakan kode J90 *Pleural effusion, not elsewhere classified*.
3. Efusi pleura akibat tuberkulosis: gunakan kode A15.6 (*Tuberculous pleurisy, confirmed bacteriologically and histologically*) jika dikonfirmasi secara bakteriologis dan histologis, gunakan A16.5 (*Tuberculous pleurisy, without mention of bacteriological or histological confirmation*) jika tidak disebutkan konfirmasi bakteriologis atau histologis.
4. Efusi pleura akibat influenza: gunakan kode J11.1 (*Influenza with other respiratory manifestations, virus not identified*) jika virus tidak teridentifikasi secara spesifik.

3.4.14 *Pneumothorax* (J93.-)

Pada kasus *Traumatic Pneumothorax*, jika *pneumothorax* disebabkan oleh trauma (cedera), gunakan kode S27.0 (*Traumatic pneumothorax*). Tambahkan kode eksternal untuk mencatat penyebab spesifik dari trauma.

Pada kasus *Iatrogenic Pneumothorax* akibat Prosedur Medis, jika *pneumothorax* disebabkan oleh prosedur medis (misalnya akibat tusukan jarum atau luka selama prosedur), gunakan kode T81.2 (*Accidental puncture and laceration during a procedure, not elsewhere classified*). Tambahkan kode eksternal untuk mencatat detail prosedur yang menyebabkan kondisi ini.

3.4.15 *Chylothorax* (J94.0, J95.6)

Jika dokter mendiagnosis *chylothorax* tanpa mencatat penyebab spesifik, gunakan kode: J94.0 (*Chylous effusion*).

Jika dokter mencatat bahwa *chylothorax* disebabkan oleh prosedur medis (misalnya trauma iatrogenik), gunakan kode: J95.6 (*Postprocedural chylothoraxTM*).

Jika *chylothorax* disebabkan oleh kanker di mediastinum, gunakan kode untuk jenis kanker sebagai kode diagnosis utama. Tambahkan kode J94.0 (*Chylous effusion*) sebagai kode diagnosis tambahan.

3.4.16 *Haemothorax* (J94.2)

Jika dokter mendiagnosis *haemothorax* tanpa mencatat penyebab spesifik, gunakan kode J94.2 (*Haemothorax*). Jika *haemothorax* disebabkan oleh trauma (cedera), gunakan kode: S27.1 (*Traumatic haemothorax*), atau S27.2 (*Traumatic haemopneumothorax*) jika disertai *pneumothorax*. Tambahkan kode eksternal untuk mencatat penyebab trauma.

Jika *haemothorax* disebabkan oleh prosedur medis (misalnya trauma iatrogenik), gunakan kode: T81.0 (*Haemorrhage and hematoma complicating a procedure, not elsewhere classified*). Tambahkan kode eksternal untuk mencatat detail prosedur yang menyebabkan kondisi ini.

3.4.17 *Granuloma Laryngeal Due To Intubation (J95.8)*

Apabila dokter menetapkan diagnosis granuloma laring akibat intubasi, maka kode yang harus digunakan adalah J95.8, yaitu *Other postprocedural respiratory disorders* (gangguan pernapasan lainnya yang terjadi setelah prosedur).

3.4.18 *Respiratory Failure (J96.-)*

Berikan kode dalam kelompok J96.- (*Respiratory failure, not elsewhere classified*), sesuai diagnosis dokter. Pastikan untuk mencatat apakah gagal napas bersifat akut, kronis, atau kombinasi keduanya (akut di atas kronis), karena karakteristik ini akan memengaruhi pemilihan subkategori kode yang tepat..

3.4.19 *Emphysema Subcutan (J98.2)*

Jika dokter mendiagnosis emfisema subkutan atau emfisema mediastinum tanpa menyebutkan penyebab spesifik, gunakan kode J98.2, yaitu *Interstitial emphysema*.

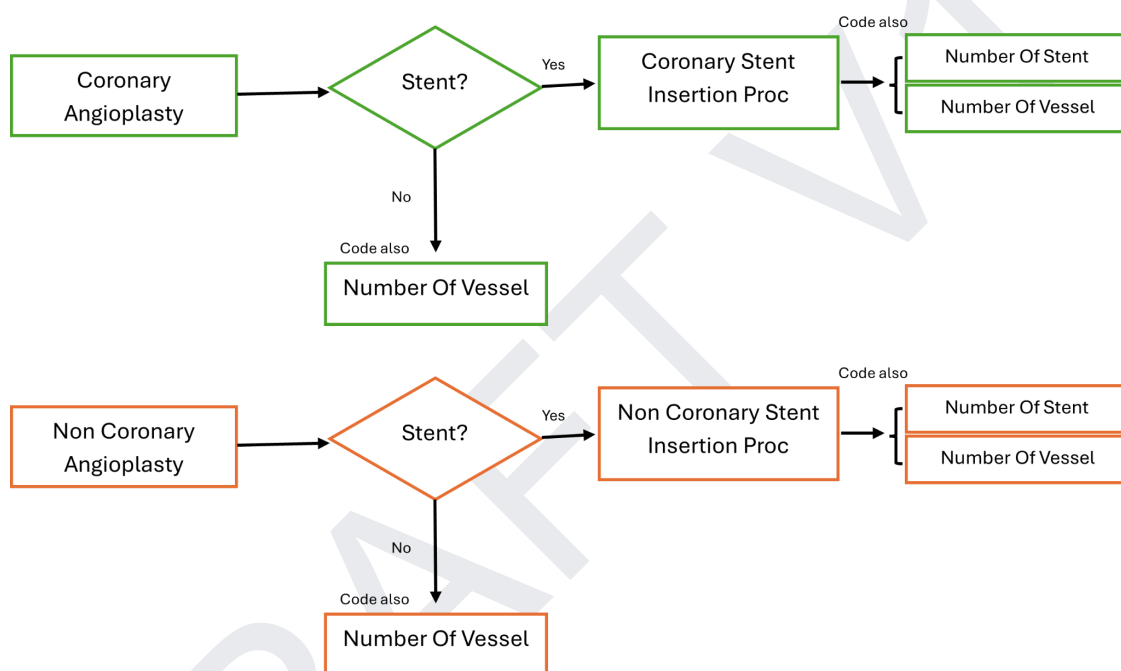
Jika dokter menyatakan bahwa emfisema subkutan disebabkan oleh trauma, gunakan kode T79.7, yaitu *Traumatic subcutaneous emphysema*, dan tambahkan kode penyebab luar sesuai trauma yang dimaksud (apabila tersedia).

Jika dokter menyatakan bahwa emfisema subkutan disebabkan oleh prosedur medis, gunakan kode T81.2, yaitu *Accidental puncture and laceration during a procedure, not elsewhere classified*, dan tambahkan **kode penyebab luar iatrogenik** (suatu kondisi atau efek yang terjadi akibat tindakan medis, prosedur, pengobatan, atau perawatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan) yang relevan (apabila tersedia).

3.5 MDC 15 JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH

PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 15

Pedoman koding dalam iDRG terkait jantung dan pembuluh darah yang memiliki prosedur yang kompleks dalam penanganannya seperti pada kasus pemasangan stent pada pembuluh darah dimana ada sumbatan kemudian dilakukan pelebaran untuk melancarkan peredaran darah. Pada INA-Grouper Tindakan PCI harus dikode dengan ‘code also’ yang ada di dalam ICD-9 CM



Gambar 3.5.1 Alur Koding Stent Coronary & Non Coronary

- Perhatikan tabel ini terkait logic iDRG karena adanya kode dalam tabel ini akan menentukan Disease Cluster (DC) dalam iDRG

Tabel 3.15 Kode ICD dan DC khusus yang berhubungan pada MDC 15

No	Tindakan	Kode ICD	DC terkait
1	Catheterization	Bila ada salah satu kode ICD dibawah ini : 37.21 Right heart cardiac catheterization 37.22 Left heart cardiac catheterization 37.23 Combined right and left heart cardiac catheterization 37.26 Catheter based invasive electrophysiologic testing 88.52 Angiocardiography of right heart structures 88.53 Angiocardiography of left heart structures 88.54 Combined right and left heart angiocardiography 88.55 Coronary arteriography using a single catheter 88.56 Coronary arteriography using two catheters 88.57 Other and unspecified coronary arteriography 88.58 Negative-contrast cardiac roentgenography	Acute MI w Cath Multiple Valve Procedures w Cath Coronary Bypass w Cath Cardiac Angiography
2	Percutaneous	00.66 Percutaneous transluminal coronary angioplasty [PTCA] or coronary atherectomy	Acute MI w PTCA w (+Stent)

copyright@ Pusat pembiayaan kesehatan Kemenkes RI.

Dilarang mengcopy atau memperjualbelikan isi dan dokumen ini dalam bentuk apapun

	Transluminal Cardiovascular Angiography (PTCA)	36.09 Other removal of coronary artery obstruction	Acute MI w PTCA Coronary Bypass w PTCA PTCA (+Stent) PTCA
3	Coronary Stent	Coronary Stent Categories 36.06 Insertion of non-drug-eluting coronary artery stent(s) 36.07 Insertion of drug-eluting coronary artery stent(s) 36.050 Insertion Of Drug eluting or coated Balloon of Coronary (IM) Number of Stents 00.45 Insertion of one vascular stent 00.46 Insertion of two vascular stents 00.47 Insertion of three vascular stents 00.48 Insertion of four or more vascular stents 00.450 Insertion of one vascular drug eluting or coated baloon (IM) 00.460 Insertion of two vascular drug eluting or coated baloon (IM) 00.470 Insertion of three vascular drug eluting or coated baloon (IM) 00.480 Insertion of four or more drug eluting or coated baloon (IM) Number of Vessels 00.40 Procedure on single vessel 00.41 Procedure on two vessels 00.42 Procedure on three vessels 00.43 Procedure on four or more vessels 00.44 Procedure on vessel bifurcation	Acute MI w PTCA w (+Stent) PTCA (+Stent)
No	Tindakan	Kode ICD	DC terkait
4	Non Coronary Stent	Insertion of Non-Coronary Stents 00.55 Insertion of drug-eluting stent(s) of other peripheral vessel(s) 00.63 Percutaneous insertion of carotid artery stent(s) 00.64 Percutaneous insertion of other precerebral (extracranial) artery stent(s) 00.65 Percutaneous insertion of intracranial vascular stent(s) 39.90 Insertion of non-drug-eluting peripheral (non-coronary) vessel stent(s) 36.051 Insertion Of Drug eluting or coated Balloon of Non Coronary (IM) Number of Stents 00.45 Insertion of one vascular stent 00.46 Insertion of two vascular stents 00.47 Insertion of three vascular stents 00.48 Insertion of four or more vascular stents 00.450 Insertion of one vascular drug eluting or coated baloon (IM) 00.460 Insertion of two vascular drug eluting or coated baloon (IM) 00.470 Insertion of three vascular drug eluting or coated baloon (IM) 00.480 Insertion of four or more drug eluting or coated baloon (IM) Number Of Vessel 00.45 Insertion of one vascular stent 00.46 Insertion of two vascular stents 00.47 Insertion of three vascular stents 00.48 Insertion of four or more vascular stents	PTA (+Stent)
5	Percutaneous Transluminal Angiography (PTA)	3950 & 0040 (angio/ath oth non-coro ves + procedure-one vessel) 3950 & 0041 (angio/ath oth non-coro ves + procedure-two vessels) 3950 & 0042 (angio/ath oth non-coro ves + procedure-three vessels) 3950 & 0043 (angio/ath oth non-coro ves + procedure-four+ vessels) 3950 & 0044 (angio/ath oth non-coro ves + proc-vessel bifurcation) 0061 & 0040 (perc angio precereb vess + procedure-one vessel) 0061 & 0041 (perc angio precereb vess + procedure-two vessels) 0061 & 0042 (perc angio precereb vess + procedure-three vessels) 0061 & 0043 (perc angio precereb vess + procedure-four+ vessels) 0061 & 0044 (perc angio precereb vess + proc-vessel bifurcation) 0062 & 0040 (perc angio intracran ves + procedure-one vessel) 0062 & 0041 (perc angio intracran ves + procedure-two vessels) 0062 & 0042 (perc angio intracran ves + procedure-three vessels) 0062 & 0043 (perc angio intracran ves + procedure-four+ vessels) 0062 & 0044 (perc angio intracran ves + proc-vessel bifurcation)	PTA
6	Thrombolytic Agent Injection/Infusion	99.10 Injection or infusion of thrombolytic agent 99.20 Injection or infusion of platelet inhibitor	Acute MI w Thrombolytic Injection

Contoh :

- Pasien usia 56 tahun datang dengan keluhan nyeri dada hebat dan sesak nafas selama 2 jam sebelum dibawa ke IGD, setelah diperiksa oleh dokter dilakukan
- copyright@ Pusat pembiayaan kesehatan Kemenkes RI.
Dilarang mengcopy atau memperjualbelikan isi dan dokumen ini dalam bentuk apapun

pemeriksaan, EKG didapatkan elevasi segmen ST anterior, didiagnosis *STEMI anterior* yang akan dilakukan PCI segera. Pasien segera dipindahkan ke ruang kateterisasi jantung untuk melakukan PCI emergensi, Dalam ruang kateterisasi, dokter jantung melakukan angiografi koroner yang mengungkapkan sumbatan total pada arteri koroner anterior, Balon angioplasty ditempatkan di dalam arteri koroner untuk melebarkan sumbatan, dan stent ditempatkan untuk menjaga pembuluh darah tetap terbuka.

Diagnosis Utama : MCI Anterior

Diagnosis Sekunder : -

Tindakan : PCI

Diberikan kode I21.0 (*Acute transmural myocardial infarction of anterior wall*) sebagai diagnosis utama, kode 00.66 (*Percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA) of coronary artery(s); single vessel*) untuk PTCA nya, 36.07 (*Insertion of non-drug-eluting coronary artery stent(s)*), 00.40 (*Procedure on single vessel*) code also untuk pemasangan di satu vessel, 00.45 (*Insertion of one vascular stent*) code also untuk pemasangan di satu stent, 00.49 (*SuperSaturated oxygen therapy*) dan 99.10 (*Injection or infusion of thrombolytic agent*) untuk tindakannya.

Note: PTCA wajib dikode juga untuk tindakan 36.06-36.07, 00.40-00.43, 00.45-00.49. Jika tidak lengkap akan terjadi eror. Demikian pula untuk *non-coronary vessel(s)*. Perhatikan *code also* nya.

- Pasien usia 52 tahun datang dengan keluhan nyeri hebat dan mati rasa pada kaki kanan kemudian dibawa ke IGD, pasien memiliki riwayat diabetes dan hipertensi tidak terkontrol. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan penunjang ditemukan bahwa pasien mengalami penyempitan yang signifikan pada arteri femoralis kanan, yang merupakan pembuluh darah besar yang memasok darah ke kaki kanan. Setelah melakukan konsultasi dengan tim kardiologi dan intervensionalis vaskular, diputuskan untuk melakukan tindakan PTA pada arteri femoralis kanan pasien. Prosedur PTA dilakukan dengan memasukkan kateter ke dalam arteri femoralis dan meluncurkannya

ke lokasi penyempitan. Kemudian, balon pada ujung kateter diperluas untuk melebarkan pembuluh darah yang menyempit dan mengembalikan aliran darah normal ke kaki kanan pasien.

Diagnosis Utama : PAD

Diagnosis Sekunder : HT dan DM

Tindakan : PTA

Diberikan kode I77.9 (*Disorder of arteries and arterioles, unspecified*) sebagai diagnosis utama, I10 (*Essential (primary) hypertension*) dan E11.9 (*Non-insulin-dependent diabetes mellitus*) sebagai diagnosis sekundernya, kode 39.50 (*Angioplasty or atherectomy of other non-coronary vessel(s)*), 00.55 (*Insertion of drug-eluting peripheral vessel stent(s)*), 39.90 (*Insertion of non-drug-eluting peripheral vessel (non-coronary) stent(s)*), 00.40 (*Procedure on single vessel*) code also untuk pemasangan di satu vessel, 00.44 (*Procedure on vessel bifurcation*), 00.45 (*Insertion of one vascular stent*) code also untuk pemasangan di satu stent, 00.49 (*SuperSaturated oxygen therapy*) dan 99.10 (*Injection or infusion of thrombolytic agent*) untuk rangkaian kode tindakannya.

Note : perhatikan *code also* nya (jumlah vessel dan jumlah stent) karena wajib di kode dan diinput kedalam sistem agar tidak terjadi eror. Jika tidak dipasang stent, maka masukkan jumlah vessels nya saja.

- Penggunaan 35.29^{IM} diperuntukkan dalam kasus operasi *valve repair* lebih dari satu dalam satu kali operasi. 00.66 minimal harus dengan 00.40 . 00.61 berpasangan dengan 00.63 dan 00.64 . 00.62 berpasangan dengan 00.65 . 39.50 berpasangan 39.90 dan 00.55/00.60 .
- Gunakan 36.05 *Insertion Of Drug eluting or coated Balloon* ^(IM) untuk tindakan DCB.
- Apabila pasien didiagnosis dengan penyakit ginjal hipertensi, ataupun penyakit jantung dan ginjal hipertensi, di mana penyakit ginjal termasuk dalam kategori N18.- Penyakit ginjal kronis, maka kode N18.- wajib dikode untuk mengidentifikasi tahap perkembangan penyakit ginjal kronis tersebut. Kode N18.- ini dapat digunakan bersamaan dengan kategori I12.- atau I13.-

sesuai dengan kondisi pasien. Penentuan Urutan mana yang dijadikan diagnosa Utama dan sekunder mengacu pada chapter 2 mengenai definisi dan kriteria diagnosa utama & sekunder.

PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 15

3.5.1 *Heart Valve Disease (I05-I09, I34-I39)*

Pada saat mencari kode pada ICD-10 Volume 3, pengode harus memperhatikan catatan yang terdapat di samping atau di bawah *leadterm*, seperti tanda indentasi, istilah “*see*”, “*see also*”, “*with*”, dan istilah lainnya. Jika terdapat kode 3-karakter dengan *point dash* (-), maka terdapat karakter ke-4 pada volume 1 yang perlu ditambahkan. Perhatikan *includes* dan *excludes* pada blok kategori 3 karakter pada ICD-10 Volume 1. Jika berkaitan dengan kelainan kongenital, maka gunakan kode Q23.-

3.5.2 *Primary and Secondary Hypertension (I10 dan I15)*

3.5.2.1 *Primary Hypertension*

Essential (Primary) Hypertension. Jika dokter mendiagnosis hipertensi sebagai essential atau primary hypertension (tidak diketahui penyebabnya), gunakan kode I10 (*Essential (primary) hypertension*).

- Contoh penggunaan kode untuk kasus *Essential hypertension* dengan *Acute renal failure* adalah sebagai berikut:

Pasien didiagnosis hipertensi dengan gagal ginjal akut. Sesuai dengan instruksi *includes* pada volume I sub bab *hypertensive renal disease* (I12) yang menyatakan bahwa hanya kondisi pada kode N00–N07, N18.-, N19 or N26 *due to hypertension* yang bisa masuk ke dalam sub bab I12. Pada kasus ini pasien menderita gagal ginjal akut atau *acute renal failure, unspecified* (N17.9), kode ini tidak masuk ke dalam *includes* pada sub bab I12, sehingga penggunaan kode tidak bisa digabung dengan *essential (primary) hypertension* (I10) menjadi I12 dan tetap dikode masing masing, yaitu I10 dan N17.9.

- Kode I12.- mengacu pada penyakit hipertensi dengan komplikasi penyakit ginjal (renal disease) yang secara etiologis disebabkan oleh kondisi hipertensi. Dalam proses pengkodean, sangat penting untuk

memastikan bahwa dokumentasi pada rekam medis mencerminkan secara jelas dan rinci adanya hubungan kausal antara hipertensi dan penyakit ginjal tersebut. Apabila tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa penyakit ginjal disebabkan oleh hipertensi, maka kedua kondisi dikodekan secara terpisah sesuai dengan pedoman klasifikasi ICD-10.

3.5.2.2 *Secondary hypertension (I15.-)*

Kode ini tidak digunakan sebagai kode utama jika penyebab hipertensi sudah dicatat, kecuali jika perawatan difokuskan terutama pada hipertensi itu sendiri. Saat mengkode penyebabnya, kode I15.- dapat digunakan sebagai kode tambahan.

Jika dokter mendiagnosis hipertensi disebabkan oleh *renal artery stenosis* atau sebagai *renovascular hypertension*, dan pasien sedang dirawat untuk hipertensi, maka gunakan kode I15.0 (*Renovascular hypertension*). Kode ini harus diikuti dengan kode penyebab *renal artery stenosis*, misalnya I70.1 (*Atherosclerosis of renal artery*).

Jika dokter mendiagnosis hipertensi disebabkan oleh penyakit ginjal, dan pasien sedang dirawat untuk hipertensi, gunakan kode I15.1 (*Hypertension secondary to other renal disorders*), diikuti dengan kode spesifik untuk penyakit ginjal yang menjadi penyebab.

Untuk kasus hipertensi disebabkan oleh gangguan kelenjar endokrin, dan pasien sedang dirawat untuk hipertensi, gunakan kode I15.2 (*Hypertension secondary to endocrine disorders*). Sama seperti sebelumnya, tambahkan kode spesifik untuk gangguan endokrin yang menjadi penyebab, misalnya E26.0 (*Primary hyperaldosteronism*).

Apabila dokter mendiagnosis hipertensi sebagai *secondary hypertension* namun penyebab pastinya belum ditetapkan, misalnya pada pasien yang masih dalam proses evaluasi lanjutan seperti *hypertension in the young*, *resistant hypertension*, atau *suspected secondary hypertension* (contohnya kecurigaan terhadap pheochromocytoma), maka gunakan kode I15.9 (*Secondary hypertension, unspecified*). Namun, jika tidak ada pemeriksaan

tambahan dilakukan, gunakan kode I10 (*Essential (primary) hypertension*).

3.5.3 *Hypertensive Heart and Renal Disease (I11-I13)*

Kode dalam kelompok I11.- *Hypertensive heart disease* atau I12.- (*Hypertensive renal disease*) digunakan hanya jika dokter secara eksplisit mendiagnosis bahwa pasien mengalami *hypertensive heart disease* atau *hypertensive renal disease*. Pemilihan kode tergantung pada ada atau tidaknya *heart failure* atau *renal failure*. Contohnya:

1. Jika dokter mendiagnosis *hypertensive heart disease with heart failure*, gunakan kode: I11.0 (*Hypertensive heart disease with (congestive) heart failure*). Jika dokter mendiagnosis *hypertensive heart disease without heart failure*, gunakan kode: I11.9 (*Hypertensive heart disease without (congestive) heart failure*).
2. Jika dokter mendiagnosis *hypertensive renal disease with renal failure*, gunakan kode: I12.0 (*Hypertensive renal disease with renal failure*). perhatikan keterangan *Use additional code, if desired, to identify underlying disease & Use additional code, if desired, to identify presence of hypertension* di bawah kategori kode N18.-.
3. Jika dokter mendiagnosis *hypertensive renal disease without renal failure*, gunakan kode: I12.9 (*Hypertensive renal disease without renal failure*). Berikut merupakan beberapa contoh kasus lain terkait *Hypertension* dengan CKD :
 - a. Jika dokter mendiagnosis *Hypertension* dengan CKD Stage 1, maka gunakan kode N18.1 (*Chronic kidney disease, stage 1*) dan I12.9 (*Hypertensive renal disease without renal failure*).
 - b. Jika dokter mendiagnosis *Hypertension* dengan CKD Stage 2 dan *Renal Failure*, maka gunakan kode N18.2 (*Chronic kidney disease, stage 2*) dan I12.0 (*Hypertensive renal disease with renal failure*).
 - c. Jika dokter mendiagnosis *Hypertension* dengan CKD Stage 2 dan *Acute Renal Failure*, maka gunakan kode N17.9 (*Acute renal failure, unspecified*), N18.2 (*Chronic kidney disease, stage 2*) dan I12.0 (*Hypertensive renal disease with renal failure*).

- d. Jika dokter mendiagnosis *Hypertension* dengan CKD *Stage 4*, maka gunakan kode N18.4 (*Chronic kidney disease, stage 4*) dan I12.0 (*Hypertensive renal disease with renal failure*).
 - e. Jika dokter mendiagnosis *Hypertension* dengan CKD *Stage 4* dan *Acute Renal Failure* (akut on kronik). Berdasarkan kaidah coding, jika kondisi akut dan kronik terjadi bersamaan, maka gunakan kondisi akut sebagai diagnosis utama, sehingga pada contoh kasus di atas, kode diagnosis utama adalah N17.9 (*Acute renal failure, unspecified*), dan kode diagnosis sekunder adalah N18.4 (*Chronic kidney disease, stage 4*) dan I12.0 (*Hypertensive renal disease with renal failure*).
4. Contoh lain:

Contoh 1:

DU : Hipertensi dengan gagal ginjal yang disertai gagal jantung

DS : edema paru

Contoh : Hipertensi dengan gagal ginjal yang disertai dengan gagal jantung dengan diagnosis sekunder edema paru, maka menggunakan kode gabungan I13.2 (*Hypertensive heart and renal disease with both (congestive) heart failure and renal failure*) dan edema paru tidak perlu dikoding terpisah.

Contoh 2:

DU : Hipertensi dengan gagal ginjal tanpa disertai gagal jantung

DS : edema paru

Contoh : Hipertensi dengan gagal ginjal yang tidak disertai gagal jantung dengan diagnosis sekunder, maka masing masing dikode terpisah, yakni I12.0 (*Hypertensive renal disease with renal failure*) dan J81 (*Pulmonary oedema*)

3.5.4 *Acute Myocardial Infarction (I21-I22)*

Penggunaan kode untuk STEMI dan NSTEMI juga harus memperhatikan durasi terjadinya infark. Dalam pengkodean *Acute Myocardial Infarction* (AMI), penting untuk membedakan antara infark pertama kali (*de novo* MI) dan infark yang terjadi dalam 28 hari setelah infark sebelumnya (*subsequent* MI) guna memastikan ketepatan

penggunaan kode dalam kategori I21.- dan I22.- dan Infark miokard akut pertama kali (*first-time AMI*) harus dikodekan dengan kategori I21.-, yang mencakup *ST-elevated myocardial infarction* (STEMI) dan *non-ST-elevated myocardial infarction* (NSTEMI) sesuai dengan lokasi kerusakan miokard. Jika dokter mendiagnosis *acute myocardial infarction* atau *acute ST-elevated myocardial infarction* (STEMI), gunakan kode I21.0 – I21.2 sesuai dengan lokasi infarksi. Jika dokter mendiagnosis *acute non-ST-elevated myocardial infarction* (NSTEMI) atau *acute subendocardial myocardial infarction*, gunakan kode I21.4 (*Acute subendocardial myocardial infarction*).

Jika dokter mendiagnosis *recurrent myocardial infarction* dalam kurun waktu 28 hari setelah infark sebelumnya, maka infark tersebut dikategorikan sebagai *subsequent myocardial infarction* (MI berulang) dan harus dikodekan dalam gunakan kode dalam kelompok I22.- (*Subsequent myocardial infarction*) sesuai dengan lokasi infarksi. Penggunaan kode Z03.4 (*Observation for suspected myocardial infarction*) diberikan jika pasien pada saat datang ke rumah sakit memiliki gejala / tanda *myocardial infarction* tetapi saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut tidak dapat ditegakkan diagnosis *myocardial infarction*, sehingga tidak membutuhkan pengobatan atau penanganan medis lanjutan. namun jika pasien datang dengan keluhan (tanda atau gejala) dan hasil pemeriksaan belum dapat mengonfirmasi diagnosis pasti atau definitif, maka keluhan atau gejala tersebut harus ditetapkan sebagai diagnosis utama, dan kode dari Chapter XVIII (R00–R99: *Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified*) harus digunakan.

3.5.5 Complications Following Acute Myocardial Infarction (I23.-)

Komplikasi yang muncul setelah infark miokard akut (I23.-) harus dikodekan secara spesifik sesuai dengan jenis komplikasi yang terjadi. Apabila disebutkan bahwa atrial septal defek tersebut merupakan komplikasi setelah infarksi miokard akut, gunakan kode I23.1 (*Atrial septal defect as current complication following acute myocardial infarction*).

Jika disebutkan bahwa trombosis di atrium atau ventrikel merupakan komplikasi setelah infarksi miokard akut, gunakan kode I23.6 (*Thrombosis of atrium, auricular appendage and ventricle as current complication following acute myocardial infarction*).

Jika dokter mendiagnosis komplikasi tertentu setelah infarksi miokard akut, gunakan kode dalam kelompok I23.- (*Certain current complications following acute myocardial infarction*), sesuai dengan jenis komplikasi yang terjadi:

1. Untuk *haemopericardium*, gunakan kode I23.0 (*Haemopericardium as current complication following acute myocardial infarction*).
2. Untuk *atrial septal defect*, gunakan kode I23.1 (*Atrial septal defect as current complication following acute myocardial infarction*).

Kode I23.- hanya digunakan untuk komplikasi yang terjadi segera setelah infarksi miokard akut dan masih berkaitan langsung dengan episode tersebut. Jika komplikasi terjadi lebih dari 4 minggu setelah infarksi miokard akut, maka pengodean akan berbeda dan tidak termasuk dalam kelompok ini. Penggunaan kode yang tepat sangat penting untuk mendukung dokumentasi medis yang akurat dan perencanaan pengobatan yang optimal bagi pasien.

3.5.6 Chronic Ischaemic Heart Disease (I25.-)

- *Atherosclerotic Cardiovascular Disease*, gunakan kode I25.0 (*Atherosclerotic cardiovascular disease, so described*).
- *Atherosclerotic Heart Disease* atau *Stable Angina*, gunakan kode I25.1 (*Atherosclerotic heart disease*). Tidak ada kode spesifik untuk jumlah pembuluh darah yang terlibat (*single vessel disease, double vessels disease, atau triple vessels disease*). Semua kondisi tersebut menggunakan kode yang sama, yaitu I25.1.
- Infark Miokard Lama (*Old Myocardial Infarction*), gunakan kode sesuai dengan riwayat medis pasien.
- Aneurisma Jantung, gunakan kode spesifik untuk aneurisma jantung jika ditemukan.

- Status Pasca Operasi atau Prosedur Intervensi: Untuk pasien dengan status *post CABG* atau status *post stent placement*, pengodean tetap menggunakan I25.1, dengan catatan tambahan tentang prosedur yang telah dilakukan.
- Nyeri Dada Non-Kardiak, gunakan kode yang sesuai untuk nyeri dada non-kardiak jika tidak ada penyakit jantung yang terdeteksi.
- *Atherosclerotic Heart Disease, Status Post Coronary Bypass Graft*, pengodean terdiri dari dua kode, yaitu I25.1 (*Atherosclerotic heart disease*) dan Z95.1 (*Presence of aortocoronary bypass graft*).
- *Atherosclerotic Heart Disease, Status Post Stent Placement*, pengodean terdiri dari dua kode, yaitu I25.1 (*Atherosclerotic heart disease*) dan Z95.5 (*Presence of coronary angioplasty implant and graft*).
- *Noncardiac Chest Pain*, gunakan kode R07.4 (*Chest pain, unspecified*) karena penyebab nyeri dada belum dapat ditentukan.

3.5.7 **Pulmonary Heart Disease (I27.-)**

Dalam situasi di mana *primary pulmonary hypertension* disertai dengan *heart failure, unspecified*, kedua kondisi tersebut tetap harus dikodekan secara terpisah menggunakan I27.0 untuk hipertensi pulmonal dan I50.9 untuk gagal jantung. Hal tersebut dilakukan karena dalam ICD-10 versi tahun 2010 tidak terdapat instruksi *include* atau *exclude* yang mengindikasikan bahwa keduanya dapat digabung dalam satu kode kombinasi.

3.5.8 **Pericarditis (I30-I32)**

Efusi Perikardial Non-Inflamasi (*Pericardial Effusion*): Jika dokter mendiagnosis adanya cairan perikardial (*pericardial fluid*) atau efusi perikardial (*pericardial effusion*) yang tidak disebabkan oleh peradangan, atau jika diagnosis menyebutkan *chylopericardium*, gunakan kode: I31.3 (*Pericardial effusion (non-inflammatory)*).

Jika dokter menentukan bahwa efusi perikardial tersebut disebabkan oleh penyebaran kanker (metastasis) ke perikardium, gunakan dua kode: C78.1 (*Secondary malignant neoplasm of the pericardium*) sebagai kode

utama, I31.3 (*Pericardial effusion (non-inflammatory)*) sebagai kode tambahan.

3.5.9 Infective Endocarditis (I33, I39)

Jika dokter dapat menentukan katup jantung yang terinfeksi, gunakan kode dari grup I39.- untuk katup tersebut sebagai kode tambahan. Contohnya: Jika terjadi pada katup mitral, gunakan kode I39.0* (*Mitral valve endocarditis*) sebagai kode tambahan. Jika dokter mendiagnosis *syphilitic endocarditis*, gunakan dua kode berikut: A52.0† (*Cardiovascular syphilis*) sebagai kode utama, I39.8* (*Endocarditis, valve unspecified, in diseases classified elsewhere*) sebagai kode tambahan.

Jika terjadi pada katup aorta, gunakan kode I39.1* (*Aortic valve disorders in diseases classified elsewhere*) sebagai kode tambahan.

Jika dokter mendiagnosis bahwa pasien memiliki *systemic lupus erythematosus* (SLE) dengan *Libman-Sacks endocarditis* pada katup aorta, gunakan dua kode berikut: M32.1† (*Systemic lupus erythematosus with organ or system involvement*) sebagai kode utama, I39.1* (*Aortic valve disorders in diseases classified elsewhere*) sebagai kode tambahan.

1. Endocarditis dengan penyebab tidak diketahui

Jika dokter hanya mendiagnosis secara umum sebagai endocarditis tanpa informasi lebih lanjut mengenai penyebab (infeksi atau tidak) maupun lokasi katup jantung yang terkena, gunakan kode: I38 (*Endocarditis, valve unspecified*).

2. Endocarditis dengan penyebab diketahui

- a. Jika dokter mendiagnosis *infective endocarditis*, baik dengan rincian tambahan sebagai acute atau subacute, gunakan kode: I33.0 (*Acute and subacute infective endocarditis*). Untuk menentukan agen penyebab infeksi, tambahkan kode dari B95 - B97 sebagai kode tambahan.
- b. Jika dokter mendiagnosis *candidal endocarditis*, gunakan dua kode berikut: B37.6† (*Candidal endocarditis*) sebagai kode utama, dan I39.8* (*Endocarditis, valve unspecified, in diseases classified elsewhere*) sebagai kode tambahan.

- c. Jika dokter mendiagnosis bahwa pasien memiliki systemic lupus erythematosus (SLE) dengan *Libman-Sacks endocarditis* pada katup aorta, gunakan dua kode berikut: M32.1† (*Systemic lupus erythematosus with organ or system involvement*) sebagai kode utama, dan I39.1* (*Aortic valve disorders in diseases classified elsewhere*) sebagai kode tambahan.
3. Lokasi Endocarditis pada katup spesifik
- a. Jika dokter dapat menentukan katup jantung mana yang terkena, gunakan kode dari grup I39.- sebagai kode tambahan.
 Contohnya: Jika dokter mendiagnosis syphilitic endocarditis dan terjadi pada katup mitral, gunakan dua kode berikut: A52.0† (*Cardiovascular syphilis*) sebagai kode utama, dan I39.8* (*Endocarditis, valve unspecified, in diseases classified elsewhere*) sebagai kode tambahan.
 - b. Jika dokter dapat menentukan katup jantung mana yang terkena, gunakan kode dari grup I39.- untuk katup tersebut sebagai kode tambahan.
 Contohnya: Jika terjadi pada katup aorta, gunakan kode I39.1* (*Aortic valve disorders in diseases classified elsewhere*) sebagai kode tambahan.

3.5.10 Myocarditis (I40-I41)

1. Myocarditis Infeksius

- a. Jika dokter mendiagnosis *septic myocarditis* atau *infective myocarditis*, gunakan kode: I40.0 (*Infective myocarditis*) sebagai kode utama, serta tambahkan kode dari B95 - B97 sebagai kode tambahan untuk menentukan agen penyebab infeksi.
- b. Jika dokter mendiagnosis *diphtherial myocarditis*, gunakan dua kode berikut: A36.8† (*Other diphtheria*) sebagai kode utama, dan I41.0* (*Myocarditis in bacterial diseases classified elsewhere*) sebagai kode tambahan.
- c. Jika dokter mendiagnosis influenza yang dapat dikonfirmasi dan disertai *myocarditis*, dengan penyebab selain virus tipe A atau B, gunakan dua kode J10.8† (*Influenza with other manifestations*,

other influenza virus identified) sebagai kode utama, dan I41.1* (*Myocarditis in viral diseases classified elsewhere*) sebagai kode tambahan.

- d. Jika diagnosis *influenza* ditegakkan berdasarkan gejala tanpa konfirmasi laboratorium dan disertai *myocarditis*, gunakan dua kode berikut: J11.8† (*Influenza with other manifestations, virus not identified*) sebagai kode utama, I41.1* (*Myocarditis in viral diseases classified elsewhere*) sebagai kode tambahan.

2. Myocarditis Non-Infeksius

- a. Jika dokter mendiagnosis *rheumatoid myocarditis*, gunakan dua kode berikut: M05.3† (*Rheumatoid arthritis with involvement of other organs and systems*) sebagai kode utama I41.8* *Myocarditis in other diseases classified elsewhere* sebagai kode tambahan.
- b. Jika dokter mendiagnosis *myocarditis* yang disebabkan oleh obat atau radiasi, gunakan dua kode berikut: I40.8 (*Other acute myocarditis*) sebagai kode utama, Tambahkan kode eksternal sesuai jenis obat atau paparan radiasi sebagai kode tambahan.

3.5.11 Cardiomyopathy (I42-I43)

- 1) Jika diagnosis dokter merupakan *cardiac amyloidosis* (amiloidosis jantung), gunakan kode dari grup E85.- sesuai jenis amiloidosis yang teridentifikasi. Jika jenis amiloidosis tidak ditentukan, gunakan dua kode berikut: E85.9† (*Amyloidosis, unspecified*) sebagai kode utama, I43.1* (*Cardiomyopathy in metabolic diseases*) sebagai kode tambahan.
- 2) Jika penyakit yang menyebabkan *cardiomyopathy* tidak disebutkan, gunakan kode dagger M10.0† (*Gouty tophi of heart*) atau E05.9† (*Thyrotoxic heart disease*) (disesuaikan dengan kasusnya) sebagai kode utama, sedangkan I43.8* (*Cardiomyopathy in other diseases classified elsewhere*) sebagai kode tambahan.

3.5.12 Heart Block (I44-I45)

- Jika dokter mendiagnosis *third degree atrioventricular block (complete AV block)*, gunakan kode I44.2 (*Atrioventricular block, complete*).

- Jika dokter mendiagnosis *left fascicular block* tanpa merujuk secara spesifik ke *anterior* atau *posterior*, gunakan kode I44.6 (*Other and unspecified fascicular block*).
- Jika dokter mendiagnosis *junctional bradycardia* atau *sinoatrial block*, gunakan kode: I45.5 (*Other specified heart block*).
- Jika diagnosis hanya menyebutkan *heart block* secara umum tanpa rincian lebih lanjut, gunakan kode: I45.9 (*Conduction disorder, unspecified*).

3.5.13 Cardiac Arrest (I46)

Jika Penyebab *Cardiac Arrest* diketahui, maka diagnosis *Cardiac Arrest* dikode sebagai kode sekunder dan penyebab *cardiac arrest* dikode sebagai kode primer. Misalnya: Jika diagnosis adalah *Cardiac Arrest* dengan resusitasi berhasil, gunakan kode I46.0 (*Cardiac arrest with successful resuscitation*) Kode I46.0 ini tidak boleh digunakan sebagai kode utama jika penyebab *Cardiac Arrest* diketahui. Namun, apabila penyebab *Cardiac Arrest* tidak terdokumentasi secara spesifik maka dapat dikodekan sebagai kode primer.

Jika diagnosis adalah *Sudden Cardiac Death*, gunakan kode I46.1 (*Sudden cardiac death, so described*). Perlu diperhatikan bahwa kode ini memiliki *excludes*, kode I46.1 tidak boleh digunakan untuk kematian mendadak yang disebabkan oleh gangguan konduksi jantung (I44–I45) atau infark miokard (I21–I22). Jika *cardiac arrest* dilakukan resusitasi namun tidak berhasil dan tidak disebut sebagai *sudden cardiac death*, maka kode yang digunakan adalah I46.9 (*Cardiac arrest, unspecified*).

Prinsip pengodean I46.-, kondisi cardiac arrest wajib tetap dikode untuk mencerminkan kondisi morbiditas secara menyeluruh, meskipun pasien dinyatakan meninggal pada saat pulang.

3.5.14 Ventricular Fibrillation and Flutter (I49.0)

Untuk kode diagnosis fibrilasi atau flutter ventrikel, pilih kode dari grup I49.0 berdasarkan kondisi yang disebutkan dokter, dengan ketentuan berikut:

- Jika fibrilasi dan flutter ventrikel disertai penyakit jantung struktural, gunakan kode I49.00 (*Ventricular fibrillation and flutter with structural heart diseases*) ^(IM).
- Jika fibrilasi dan flutter ventrikel tanpa penyakit jantung struktural (idiopatik), misalnya pada kasus sindrom Brugada, gunakan kode I49.01 (*Ventricular fibrillation and flutter without structural heart diseases (idiopathic) [Brugada's syndrome]*) ^(IM).
- Jika fibrilasi dan flutter ventrikel tidak ditentukan apakah disertai penyakit jantung struktural atau tidak, gunakan kode I49.09 (*Ventricular fibrillation and flutter, unspecified*) ^(IM).

3.5.15 Heart Failure (I50.-)

- Jika dokter mendiagnosis *Right Ventricular Failure* yang disebabkan oleh *Left Ventricular Failure*, *Biventricular Failure*, atau *Right Ventricular Failure* itu sendiri, gunakan kode I50.0 (*Congestive heart failure*).
- *Pulmonary oedema* dengan disertai *heart failure* atau *heart disease* yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kode lain yang lebih spesifik, gunakan kode I50.1 (*Left ventricular failure*).
- Apabila diagnosis hanya menyebutkan *Heart Failure* tanpa rincian lebih spesifik, gunakan kode I50.9 (*Heart failure, unspecified*).
- *Acute Non-Cardiogenic Pulmonary Oedema*, gunakan kode J81 (*Pulmonary oedema*). Kode J81 dapat digunakan apabila Edema Paru terjadi tanpa disertai *Heart Failure* I50.- atau *Heart Disease* I51.9. Jika Edema Paru disebabkan oleh faktor lain, seperti cedera paru, sepsis, aspirasi, trauma, atau ARDS, dapat dikategorikan sebagai edema paru non-kardiogenik dengan kode J81.

3.5.16 Peripheral Vascular Disease (I70, I73)

Kasus atherosclerosis pada arteri ekstremitas, gunakan kode dari grup I70.- (*Atherosclerosis*). Sedangkan untuk penyakit vaskular perifer lainnya, gunakan kode dari grup I73.- (*Other peripheral vascular diseases*). Jika dokter menentukan bahwa penyakit vaskular perifer disebabkan oleh diabetes melitus tipe 2, gunakan dua kode, yaitu E11.5†

(*Type 2 diabetes mellitus with peripheral circulatory complications*) sebagai kode utama dan I79.2* (*Peripheral angiopathy in diseases classified elsewhere*) sebagai kode tambahan.

Peripheral Vascular Disease (PVD) merupakan suatu manifestasi klinis dari aterosklerosis atau ateroma pada pembuluh darah perifer. Oleh karena itu, ketika PVD terjadi pada pasien dengan diabetes melitus tipe 2 dan terbukti disebabkan oleh aterosklerosis, maka kode yang paling tepat adalah E11.5† sebagai kode utama, dan I70.- sebagai kode sekunder untuk menggambarkan penyebab spesifik dari PVD tersebut. Jika PVD tidak dijelaskan sebagai akibat dari aterosklerosis, namun tetap merupakan komplikasi diabetes, maka kode sekunder yang sesuai adalah I79.2 (*Peripheral angiopathy in diseases classified elsewhere*). Penting untuk dicatat bahwa kode I79.2 tidak boleh digunakan apabila sudah terdapat penyebab yang lebih spesifik, seperti aterosklerosis (I70.-). Selain itu, kode I73.9 (*Peripheral vascular diseases, unspecified*) hanya boleh digunakan apabila tidak terdapat informasi lebih lanjut mengenai penyebab PVD dalam rekam medis.

3.5.17 Arterial Embolism and Thrombosis (I74.-)

Sistem klasifikasi medis mengharuskan penggunaan kode dari grup I74.-, yang secara spesifik merujuk pada *arterial embolism and thrombosis*. Penggunaan kode ini harus disesuaikan lebih lanjut berdasarkan lokasi oklusi arteri yang terkena sesuai dengan diagnosis dokter. Hal ini memungkinkan identifikasi yang lebih akurat dan rinci mengenai area tubuh yang mengalami gangguan sirkulasi darah akibat emboli atau trombosis, serta membantu dalam menentukan pendekatan penanganan medis yang tepat sesuai dengan kebutuhan pasien.

3.5.18 Phlebitis and Thrombophlebitis (I80.-)

Jika dokter mendiagnosis *deep vein thrombosis* pada kaki, gunakan kode I80.2 (*Phlebitis and thrombophlebitis of other deep vessels of lower extremities*) untuk phlebitis dan thrombophlebitis pada pembuluh darah ekstremitas bawah. Untuk phlebitis akibat infus atau transfusi, jika kondisi ini terjadi sebagai komplikasi yang dapat diprediksi dari prosedur medis

tanpa adanya kesalahan dalam pelaksanaannya, kode penyebab luar yang digunakan adalah Y84.8 (*Other medical procedures*) untuk prosedur medis lain sebagai penyebab reaksi abnormal pasien atau komplikasi kemudian, tanpa menyebutkan kesalahan dalam prosedur. Namun, jika kondisi tersebut disebabkan oleh kegagalan dalam menjaga sterilitas selama prosedur infus atau transfusi, maka kode Y62.1 (*During infusion or transfusion*) untuk kegagalan menjaga prosedur steril selama infus atau transfusi) dapat digunakan.

3.5.19 Oesophageal Varices (I85.-, I98.2 - I98.3)

- Jika dokter mendiagnosis varises esofagus pada pasien dengan sirosis hati, gunakan kode K74.6 (*Other and unspecified cirrhosis of liver*) sebagai kode utama, serta tambahkan kode tambahan berdasarkan kondisi perdarahan:
 - Jika tidak ada perdarahan, gunakan kode I98.2* (*Oesophageal varices without bleeding in diseases classified elsewhere*).
 - Jika ada perdarahan, gunakan kode I98.3* (*Oesophageal varices with bleeding in diseases classified elsewhere*).
- Jika dokter mendiagnosis varises esofagus tanpa menetapkan penyebabnya, gunakan kode berikut:
 - Jika ada perdarahan, gunakan kode I85.0 (*Oesophageal varices with bleeding*).
 - Jika tidak ada perdarahan, gunakan kode I85.9 (*Oesophageal varices without bleeding*).

3.5.20 Gastric Varices (I86.4)

- Jika dokter mendiagnosis *gastric varices* dengan perdarahan pada pasien dengan sirosis hati, gunakan kode berikut: I86.4 (*Gastric varices*) sebagai kode utama, serta tambahkan kode tambahan untuk gejala perdarahan: K92.0 (*Haematemesis*) (muntah darah) dan K92.1 (*Melaena*) (buang air besar berwarna hitam akibat darah terdegradasi). Tambahkan juga kode K74.6 (*Other and unspecified cirrhosis of liver*) sebagai diagnosis tambahan untuk sirosis hati yang tidak dijelaskan lebih lanjut atau jenis sirosis hati lainnya.

- Jika dokter mendiagnosis *gastric varices* tanpa perdarahan pada pasien dengan sirosis hati, gunakan kode berikut: K74.6 (*Other and unspecified cirrhosis of liver*) sebagai kode utama, serta tambahkan I86.4 (*Gastric varices*) sebagai kode tambahan.
- Contoh:
 - Pasien dirawat karena sirosis hati dan juga mengalami *Gastric Ulcer* dalam perawatannya, maka kode K74.6 (*Other and unspecified cirrhosis of liver*) dapat digunakan sebagai kode utama, serta tambahkan kode I86.4 (*Gastric varices*) sebagai kode tambahan untuk mencerminkan adanya varises gaster.
 - Pasien dirawat karena *Gastric Varices* yang merupakan konsekuensi dari sirosis hati, maka kode I86.4 (*Gastric varices*) digunakan sebagai kode utama karena ini alasan utama perawatan. Kode K74.6 (*Other and unspecified cirrhosis of liver*) digunakan sebagai kode tambahan untuk menunjukkan etiologi yang mendasarinya.

3.5.21 *Circulatory Disease Procedures*

- *Percutaneous Balloon Valvuloplasty* : Prosedur ini dilakukan pada pasien dengan mitral stenosis, gunakan kode 35.96 (*Percutaneous valvuloplasty*).
- Prosedur untuk diagnosis dan pengobatan penyakit jantung koroner diurutkan berdasarkan langkah-langkah berikut:
 - *Coronary Arteriography* : 88.55 (*Coronary arteriography using a single catheter*) dan 88.56 (*Coronary arteriography using two catheters*).
 - *Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty* (PTCA), gunakan kode 00.66 (*Percutaneous transluminal coronary angioplasty [PTCA]*).
 - Kode berdasarkan jumlah pembuluh darah yang ditangani : 00.40 (*Procedure on single vessel*), 00.41 (*Procedure on two vessels*), 00.42 (*Procedure on three vessels*), 00.43 (*Procedure on four or more vessels*).

- Kode berdasarkan jenis stent kode prosedur: 36.06 (*Insertion of non-drug-eluting coronary artery stent(s)*), 36.07 (*Insertion of drug-eluting coronary artery stent(s)*)
- Kode berdasarkan jumlah stent yang dipasang: 00.45 (*Insertion of one vascular stent*), 00.46 (*Insertion of two vascular stents*), 00.47 (*Insertion of three vascular stents*), 00.48 (*Insertion of four or more vascular stents*)
- *Fractional Flow Reserve (FFR)* : Prosedur ini dilakukan untuk mengukur tekanan intravaskular pada arteri koroner guna mengevaluasi aliran darah, gunakan 00.59 (*Intravascular pressure measurement of coronary arteries*).
- Pemasangan Monitoring Catheter, kode prosedur berbeda tergantung pada tujuan pemantauan:
 - a. Pemantauan Tekanan Arteri Sistemik, gunakan kode 89.61 (*Systemic arterial pressure monitoring*).
 - b. Pemantauan Tekanan Vena Sentral (CVP), gunakan kode 89.62 (*Central venous pressure monitoring*).
 - c. Pemantauan Tekanan Arteri Pulmonalis (PA Wedge), gunakan kode 89.64 (*Pulmonary artery wedge monitoring*).
- Berikut merupakan contoh kode dan tindakan yang dilakukan pada kasus *Cardiac Arrest*:
 - a. Jika *cardioversion* dilakukan, gunakan kode 99.62 (*Other electric counter-shock of heart*)
 - b. Pijat jantung tertutup (*Closed Chest Cardiac Massage*), jika *cardioversion* tidak dilakukan, gunakan kode 99.63 (*Closed chest cardiac massage*).
 - c. Kode umum untuk resusitasi jantung dan paru (CPR), hindari penggunaan kode umum 99.60 (*Cardiopulmonary resuscitation, not elsewhere specified*), kecuali jika detail tindakan lainnya tidak dicatat.
- *Radiofrequency Ablation* untuk mengobati aritmia jantung, dilakukan untuk mengobati kondisi seperti *supraventricular tachycardia* atau fibrilasi atrium. Kode prosedur sebagai berikut:

- a. *Invasive Electrophysiologic Testing* (EPS), gunakan kode 37.26 (*Catheter based invasive electrophysiologic testing [EPS]*)
 - b. *Cardiac Mapping*, gunakan kode 37.27 (*Cardiac mapping*)
 - c. Pengangkatan atau Destruksi Lesi Jantung, gunakan kode 37.34 (*Excision or destruction of other lesion of heart, other approach*).
- Tindakan *repair AV Shunt* : tindakan perbaikan (revisi) av shunt yang sebelumnya telah dipasang untuk dialysis. Teknik pembedahan bervariasi, tergantung tipe anastomosis yang dibutuhkan untuk mengembalikan fungsi shunt.
Contoh: Tindakan *repair AV Shunt* pada pasien hemodialisis, gunakan kode 39.42 (*Revision of arteriovenous shunt for renal dialysis Conversion of renal dialysis*)
 - Tindakan pemasangan AV Shunt dengan tujuan renal dialysis
Contoh: pemasangan AV Shunt dengan tujuan dialisis, gunakan kode 39.27 (*Arteriovenostomy for renal dialysis*). Tindakan *arteriovenostomy* merupakan pembuatan lubang untuk menggabungkan arteri dan vena untuk membuat fistula guna mengakses aliran darah untuk dialisis. *Code also any renal dialysis* (39.95)
 - Tindakan *Endovascular Radiofrequency Ablation* pada kasus *venous insufficiency* (CVI)
Contoh: Dokter melakukan tindakan endovaskular radiofrequency ablation pada vena pasien yang didiagnosis *venous insufficiency* (CVI). Tindakan tersebut menggunakan kode 39.79 (*Other endovascular procedures on other vessels*) dan dibuktikan dengan hasil USG Doppler
 - Tindakan vena seksi menggunakan kode 38.94 (*Venous cutdown*)

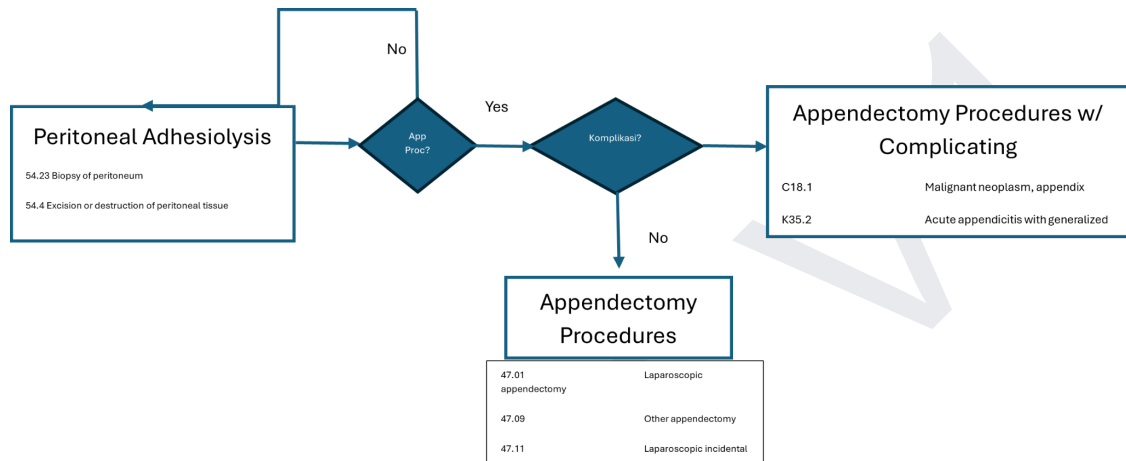
3.6 MDC 16 SALURAN PENCERNAAN

PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 16

- Kasus konstipasi pada ileus maupun obstruksi saluran cerna seharusnya tidak dikode tersendiri karena konstipasi merupakan bagian dari ileus obstruksi tersebut.
 - Contoh: Pada pasien dengan konstipasi yang disebabkan oleh hernia umbilical dengan obstruksi, cukup diberikan kode K42.0 (*Umbilical hernia with obstruction, without gangrene*).
- Tidak ada kode kombinasi baik *include* / *exclude* secara langsung untuk K29.7 (*Gastritis, unspecified*) dengan K92.0 (*Haematemesis*) menjadi K29.0 (*Acute haemorrhagic gastritis*). Kode K29.0 (*Acute haemorrhagic gastritis*) digunakan jika sudah tegak dan terkonfirmasi sumber perdarahan berasal dari gaster.
- *Appendicitis* jika disertai dengan perforasi dan/atau peritonitis, abses peritoneal ataupun sebaliknya diberikan kode gabungan pada K35.-.
- Kasus K83.1 (*Obstruction of bile duct* pada *cholelithiasis*) tidak diberikan kode sendiri karena *obstruction of bile duct* merupakan bagian dari *cholelithiasis* sehingga cukup dikode K80.-.
- *Cholelithiasis* yang disertai dengan *cholangitis* tidak dikode terpisah, melainkan menggunakan kode gabungan K80.3 (*Calculus of bile duct with cholangitis*).
- Tindakan x-ray dental menggunakan kode 87.11 (*Full-mouth x-ray of teeth*) atau 87.12 (*Other dental x-ray*).
- Tindakan enukleasi kista radikuler gigi menggunakan 24.4 (*Excission of dental lesion of jaw*).
- Tindakan ekstirpasi yang dilakukan pada daerah gingiva/gum/gusi, maka menggunakan kode 24.31 (*Excision of lesion or tissue of gum*).
- Tindakan *laparotomy* dan *adhesiolysis*.
 - *Laparotomy* jika sebagai *operative approach* bersifat “omit code” atau tidak perlu dikoding karena merupakan bagian dari kode prosedur lain.
 - *Adhesiolysis* perlu dilakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada DPJP apakah menggunakan instrumen tajam (*surgical*), karena pada ICD9CM teknik *adhesiolysis* yang menggunakan teknik tumpul,

digital, manual, mekanik, atau tanpa instrumen bersifat “omit code” atau tidak perlu dikoding.

- Peritoneal Adhesiolysis Proc dimana bila bersamaan dengan tindakan appendectomy maka kan masuk dalam kategori Appendectomy Procedures atau Appendectomy Procedures w Complicating PDx seperti diagram dibawah ini:



PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 16

Untuk kode pada rentang K00–K08 dan kode S02.5, harap gunakan kode tambahan yang menunjukkan sisi lateral gigi. Kode tambahan ini diperlukan untuk memberikan informasi lebih spesifik mengenai lokasi tindakan atau kondisi pada sisi lateral gigi yang bersangkutan.

Berikut ini adalah kode tambahan kode laterasi gigi

For Permanent Teeth / Adult Teeth :

KG11	Upper Right Central Incisor (IM)	KG31	Lower left central incisor (IM)
KG12	Upper right lateral incisor (IM)	KG32	Lower left lateral incisor (IM)
KG13	Upper right canine (IM)	KG33	Lower left canine (IM)
KG14	Upper right first premolar (IM)	KG34	Lower left first premolar (IM)
KG15	Upper right second premolar (IM)	KG35	Lower left second premolar (IM)
KG16	Upper right first molar (IM)	KG36	Lower left first molar (IM)
KG17	Upper right second molar (IM)	KG37	Lower left second molar (IM)
KG18	Upper right third molar (IM)	KG38	Lower left third molar (IM)
KG21	Upper left central incisor (IM)	KG41	Lower right central incisor (IM)
KG22	Upper left lateral incisor (IM)	KG42	Lower right lateral incisor (IM)
KG23	Upper left canine (IM)	KG43	Lower right canine (IM)
KG24	Upper left first premolar (IM)	KG44	Lower right first premolar (IM)
KG25	Upper left second premolar (IM)	KG45	Lower right second premolar (IM)
KG26	Upper left first molar (IM)	KG46	Lower right first molar (IM)
KG27	Upper left second molar (IM)	KG47	Lower right second molar (IM)
KG28	Upper left third molar (IM)	KG48	Lower right third molar (IM)

copyright@ Pusat pembiayaan kesehatan Kemenkes RI.

Dilarang mengcopy atau memperjualbelikan isi dan dokumen ini dalam bentuk apapun

For Deciduous Teeth / Primary Teeth :

KG51	Upper Right Central Incisor ^(IM)	KG71	Lower Left Central Incisor ^(IM)
KG52	Upper Right Lateral Incisor ^(IM)	KG72	Lower Left Lateral Incisor ^(IM)
KG53	Upper Right Canine ^(IM)	KG73	Lower Left Canine ^(IM)
KG54	Upper Right First Molar ^(IM)	KG74	Lower Left First Molar ^(IM)
KG55	Upper Right Second Molar ^(IM)	KG75	Lower Left Second Molar ^(IM)
KG61	Upper Left Central Incisor ^(IM)	KG81	Lower Right Central Incisor ^(IM)
KG62	Upper Left Lateral Incisor ^(IM)	KG82	Lower Right Lateral Incisor ^(IM)
KG63	Upper Left Canine ^(IM)	KG83	Lower Right Canine ^(IM)
KG64	Upper Left First Molar ^(IM)	KG84	Lower Right First Molar ^(IM)
KG65	Upper Left Second Molar ^(IM)	KG85	Lower Right Second Molar ^(IM)

3.6.1 Embedded and Impacted Teeth (K01.-)

Embedded teeth merupakan gigi yang gagal tumbuh ke rongga mulut tanpa adanya hambatan dari gigi lain, sedangkan *impacted teeth* merupakan gigi yang gagal tumbuh ke rongga mulut karena terhalang oleh gigi lain.

Jika dokter gigi mendiagnosis pasien mengalami gigi terpendam, gunakan kode K01.0 (*Embedded teeth*). Jika dokter gigi mendiagnosis pasien dengan gigi tertanam, diagnosis harus disertai dengan informasi yang jelas mengenai gigi bagian mana yang terpengaruh. Misalnya: Jika gigi yang tertanam adalah geraham bawah (*mandibular molar*), seperti gigi geraham ketiga (nomor 38 atau 48), gunakan kode K01.17 (*Impacted teeth, mandibular molar ^{IM}*).

3.6.2 Dental Caries (K02.-)

- *Dental caries* tanpa spesifikasi lebih lanjut, gunakan kode K02.9 (*Dental caries, unspecified*).
- Jenis karies lain yang tidak sesuai dengan klasifikasi utama dalam ICD-10 (misalnya, *early childhood caries* atau *secondary caries*), gunakan kode K02.8 (*Other dental caries*)

Kata yang sama dengan diagnosis dokter gigi	ICD-10
Karies enamel, karies gigi yang baru muncul, karies awal	K02.0 <i>Caries limited to enamel</i>
Karies dentinum	K02.1 <i>Caries of dentine</i>

Karies sementum, karies akar, karies permukaan akar	K02.2 <i>Caries of cementum</i>
---	---------------------------------

3.6.3 Diseases Of Pulp And Periapical Tissues (K04.-)

- Jika dokter gigi mendiagnosis *irreversible pulpitis*, yang merupakan istilah yang tidak tercantum dalam ICD-10-IM, pemberi kode harus menentukan apakah diagnosis tersebut menunjukkan kondisi akut atau kronis. Disarankan untuk meminta klarifikasi dari dokter gigi guna memastikan ketepatan pengkodean.
- Pada saat dokter gigi mencatat diagnosis *caries exposed pulp*, pemberi kode harus mengonfirmasi kepada dokter gigi mengenai kondisi jaringan pulpa atau jaringan periapikal (jaringan di sekitar ujung akar gigi). Jika konfirmasi tidak dapat dilakukan, maka gunakan kode K02.8 (*Other dental caries*).
- Pemberi kode juga harus sangat berhati-hati untuk tidak menyamakan istilah *periodontitis* dengan *apical periodontitis*, karena keduanya merujuk pada kondisi yang berbeda dan termasuk dalam kategori yang berbeda pula :
 - *Apical periodontitis* merupakan penyakit yang berkaitan dengan jaringan di sekitar ujung akar gigi, dan termasuk dalam kategori K04.-.
 - *Periodontitis* adalah gangguan pada jaringan pendukung gigi (termasuk gusi), dan termasuk dalam kategori K05.-.

3.6.4 Cellulitis And Abscess Of Mouth (K12.2)

- Jika dokter mendiagnosis infeksi yang berasal dari gigi dan menyebar ke wajah, dan diagnosis mencakup kondisi seperti cellulitis pada dasar mulut, abses submandibular, atau infeksi di area berikut:
 - *Vestibule of maxilla*
 - *Vestibule of mandible*
 - *Subperiosteal space of mandible*
 - *Mentalis space*
 - *Submental space*
 - *Sublingual space*
 - *Submandibular space*
 - *Ludwig's angina, Buccal space*
 - *Messeteric space*

- *Deep and superficial temporal space*
- *Infratemporal space*
- *Palatal subperiosteal area*
- *Infraorbital space*
- *Canine space*
- *Periorbital space*
- *Base of upper lip*
- *Pterygomandibular atau pterygomaxillary space*

Maka kode yang digunakan adalah K12.2 (*Cellulitis and abscess of mouth*).

- Jika dokter mendiagnosis infeksi di leher, dan diagnosis mencakup *retropharyngeal space abscess*, *buccopharyngeal space abscess*, atau *parapharyngeal space abscess*, maka kode yang digunakan adalah J39.0 (*Retropharyngeal and parapharyngeal abscess*).
- Jika dokter mendiagnosis infeksi yang berasal dari kulit permukaan di area wajah atau leher:
 - Untuk infeksi di wajah, maka gunakan kode L02.0 (*Cutaneous abscess, furuncle and carbuncle of face*).
 - Untuk infeksi di leher, maka gunakan kode L02.1 (*Cutaneous abscess, furuncle and carbuncle of neck*).

3.6.5 Oesophagitis And Oesophageal Ulcer (K20, K22.1)

- *Herpes simplex oesophagitis*, gunakan kode utama B00.8† (*Other forms of herpesviral infection*) dan tambahkan kode sekunder K23.8* (*Disorders of oesophagus in other diseases classified elsewhere*).
- *Candidal oesophagitis* atau *candidal oesophageal ulcer*, gunakan kode utama B37.8† (*Candidiasis of other sites*), dan tambahkan kode sekunder K23.8* (*Disorders of oesophagus in other diseases classified elsewhere*).
- *Streptococcal oesophagitis*, gunakan kode utama K20 (*Oesophagitis*), serta tambahkan kode sekunder sesuai dengan spesies *streptococcus* yang menjadi penyebabnya dengan menggunakan kode dari rentang B95.0 – B95.5 (tergantung spesies *streptococcus*).
- *Drug-induced oesophagitis* atau *drug-induced oesophageal ulcer*, maka gunakan kode utama K20 (*Oesophagitis*) pada kasus peradangan dan K22.1 (*Ulcer of oesophagus*) jika terdapat ulkus, serta tambahkan kode penyebab eksternal berdasarkan jenis obat yang menyebabkan efek

samping. **Misalnya**, jika disebabkan oleh *tetracycline*, maka tambahkan kode penyebab eksternal Y40.4 (*Tetracyclines causing adverse effects in therapeutic use*).

- *Radiation oesophagitis*, gunakan kode utama K20 (*Oesophagitis*) pada kasus peradangan dan K22.1 (*Ulcer of oesophagus*) jika terdapat ulkus, serta tambahkan kode penyebab eksternal Y84.2 (*Radiological procedure and radiotherapy as the cause of abnormal reaction of the patient*).

3.6.6 Oesophageal Obstruction (K22.2)

Jika dokter mendiagnosis obstruksi esofagus akibat benda asing, **maka gunakan** kode utama T18.1 (*Foreign body in oesophagus*), tambahkan kode sekunder K22.2 (*Oesophageal obstruction*), serta kode penyebab eksternal W44.- (*Foreign body entering into or through eye or natural orifice*).

Jika dokter mendiagnosis obstruksi esofagus akibat kanker esofagus, **maka gunakan** kode utama C15.- (*Malignant neoplasm of oesophagus*), serta tambahkan kode sekunder K22.2 (*Oesophageal obstruction*) jika prosedur medis, seperti operasi, diperlukan untuk mengatasi obstruksi tersebut.

Obstruksi esofagus akibat penelanan zat korosif (misalnya, asam) sebagai upaya bunuh diri beberapa minggu sebelumnya, **maka gunakan** kode utama K22.2 (*Oesophageal obstruction*), tambahkan kode sekunder T97 (*Sequelae of toxic effects of substances chiefly nonmedicinal as to source*), serta kode penyebab eksternal Y87.0 (*Sequelae of intentional self-harm*).

3.6.7 Perforation Of Oesophagus (K22.3)

- *Rupture* atau perforasi esofagus akibat penelanan bahan korosif (misalnya, asam kuat) sebagai upaya bunuh diri, **maka gunakan** kode utama T54.2 (*Toxic effect of corrosive acids and acid-like substances*). Tambahkan kode sekunder K22.3 (*Perforation of oesophagus*) jika perforasi terjadi sejak awal perawatan. Jika perforasi terjadi setelah perawatan, kode ini digunakan sebagai kode komplikasi. Tambahkan kode penyebab eksternal X69.- (*Intentional self-poisoning by and exposure to other and unspecified chemical and noxious substances*).
- *Rupture* esofagus akibat prosedur medis (misalnya, *oesophagoscopy*), **maka gunakan** kode utama T81.2 (*Accidental puncture and laceration*

during a procedure, not elsewhere classified), serta tambahan kode penyebab eksternal Y60.4 (*Unintentional cut, puncture, perforation or haemorrhage during endoscopic examination*).

- *Spontaneous rupture esofagus (Boerhaave syndrome)*, maka gunakan kode utama K22.3 (*Perforation of oesophagus*) tanpa kode tambahan.
- Perforasi esofagus akibat kanker esofagus, maka gunakan kode utama C15.- (*Malignant neoplasm of oesophagus*), serta tambahkan kode tambahan (sekunder) K22.3 (*Perforation of oesophagus*).
- Perforasi esofagus akibat ulkus esofagus, maka gunakan kode utama K22.3 (*Perforation of oesophagus*), serta tambahkan kode tambahan (sekunder) K22.1 (*Ulcer of oesophagus*).

3.6.8 Dyskinesia Of Oesophagus (K22.4)

- *Dyskinesia of oesophagus, diffuse oesophageal spasm*, gangguan motorik hipertensif pada *oesophagus*, atau *nutcracker oesophagus*, maka gunakan kode K22.4 (*Dyskinesia of oesophagus*).

3.6.9 Diverticulum Of Oesophagus (K22.5)

- Divertikulum pada *oesophagus*, tanpa memandang jenisnya (*Zenker's, mid-oesophageal, epiphrenic*, atau *diffuse intramural*), maka gunakan kode K22.5 (*Diverticulum of oesophagus*).

3.6.10 Gastro-Oesophageal Laceration-Haemorrhage Syndrome (K22.6)

- *Gastro-oesophageal laceration - haemorrhage syndrome* atau *Mallory-Weiss syndrome*, maka gunakan kode K22.6 (*Gastro-oesophageal laceration-haemorrhage syndrome*).

3.6.11 Tuberculous Oesophagitis (K23.0*)

- *Tuberculous oesophagitis*, maka gunakan kode A18.8† (*Tuberculosis of other specified organs*) sebagai kode diagnosis utama untuk menunjukkan bahwa tuberkulosis merupakan penyebab utama kondisi ini, serta tambahkan kode K23.0* (*Tuberculous oesophagitis*) sebagai kode diagnosis tambahan untuk menunjukkan lokasi spesifik infeksi tuberkulosis, yaitu pada *oesophagus*.

3.6.12 Ulcer And Dyspepsia (K25-K28, K30)

- *Dyspepsia* dengan penyebab spesifik, tambahkan kode lain untuk mencatat penyebab tersebut sebagai berikut:
 - *Dyspepsia* yang disebabkan oleh obat-obatan tertentu, seperti NSAIDs, kortikosteroid, atau obat lainnya, maka gunakan kode K30 (*Dyspepsia*) dan tambahkan kode eksternal yang sesuai untuk mencatat jenis obat yang menyebabkan kondisi tersebut. Kode eksternal ini harus disesuaikan dengan jenis obat yang digunakan, sesuai dengan klasifikasi ICD mengenai efek samping obat.
 - *Dyspepsia* disebabkan oleh infeksi *Helicobacter pylori*, maka gunakan kode tambahan B98.0 (*Helicobacter pylori as the cause of diseases classified elsewhere*) sebagai kode tambahan (*supplementary code*) bersama dengan kode utama K30 (*Dyspepsia*).
 - *Dyspepsia* bukan disebabkan oleh ulkus (*non-ulcer dyspepsia*), tetap gunakan kode K30 dan tidak diperlukan kode tambahan kecuali ada informasi tambahan tentang penyebab spesifik (seperti obat atau infeksi).

3.6.13 Gastritis And Duodenitis (K29.-)

Diagnosis gastritis ditegakkan setelah konfirmasi hasil pemeriksaan penunjang endoskopi.

- *Acute haemorrhagic gastritis* atau *acute gastritis* dengan perdarahan, maka gunakan kode K29.0 (*Acute haemorrhagic gastritis*). Kode K29.0 digunakan jika sudah ada konfirmasi medis bahwa sumber perdarahan berasal dari gastritis yang terdiagnosis.
- *Viral gastritis*, ikuti pedoman diagnosis dan pengodean pada bab 1 ICD-10 (penyakit menular).
- *Gastritis* atau *duodenitis* disebabkan oleh infeksi *Helicobacter pylori*, maka tambahkan kode B98.0 (*Helicobacter pylori as the cause of diseases classified elsewhere*).
- *Portal hypertensive gastropathy*, maka gunakan kode K29.6 (*Other gastritis*), serta tambahkan kode penyebab utama, seperti K74.6 (*Other and unspecified cirrhosis of liver*) atau K76.6 (*Portal hypertension*).

- Jika tidak ada informasi spesifik tentang jenis *chronic gastritis (superficial* atau *atrophic)*, maka gunakan kode K29.5 (*Chronic gastritis, unspecified*).

3.6.14 Other Diseases Of Stomach And Duodenum (K31.-)

- *Pyloric stenosis* atau *gastric outlet obstruction* pada orang dewasa, maka gunakan kode K31.1 (*Adult hypertrophic pyloric stenosis*). Jika kondisi ini bersifat kongenital (bawaan lahir), maka gunakan kode Q40.0 (*Congenital hypertrophic pyloric stenosis*).
- *Hourglass stricture and stenosis* pada orang dewasa, maka gunakan kode K31.2 (*Hourglass stricture and stenosis of stomach*). Jika kondisi ini bersifat kongenital, maka gunakan kode Q40.2 (*Other specified congenital malformations of stomach*).
- *Pylorospasm* tanpa kaitan dengan kondisi psikiatrik, maka gunakan kode K31.3 (*Pylorospasm, not elsewhere classified*). Jika kondisi ini bersifat kongenital, maka gunakan kode Q40.2 (*Other specified congenital malformations of stomach*). Namun, jika dokter mencatat bahwa kondisi ini terkait dengan gangguan psikosomatik, maka kode yang digunakan adalah F45.31 (*Somatoform autonomic dysfunction, upper gastrointestinal tract*)^(IM).

3.6.15 Appendicitis (K35-K37)

- Apendisitis akut, dan terdapat kondisi peritonitis, perforasi, atau abses peritoneal yang disertai apendisitis, atau kondisi sebaliknya, cukup menggunakan kode gabungan K35.- (*Acute appendicitis*).

Contoh: Pada kasus Appendicitis Akut dengan Generalized Peritonitis, jika diagnosisnya adalah apendisitis akut yang disertai dengan peritonitis umum akibat ruptur atau perforasi appendix, gunakan kode K35.2 (*Acute appendicitis with generalized peritonitis*). Sedangkan jika diagnosisnya adalah apendisitis akut dengan peritonitis umum disertai perforasi non-traumatik usus (K63.1), maka cukup menggunakan kode K35.2 (*Acute appendicitis with generalized peritonitis*).

- Appendicitis akut disertai peritonitis lokal (dengan atau tanpa ruptur/perforasi) atau abses dalam rongga peritoneum, maka gunakan kode K35.3 (*Acute appendicitis with localized peritonitis*).

- Appendicitis akut tetapi tidak disebutkan adanya peritonitis umum atau lokal, maka gunakan kode K35.8 (*Acute appendicitis, unspecified*).

Catatan Penting: Kode K35.0, K35.1, dan K35.9 telah dihapus dari ICD-10 revisi terbaru dan tidak lagi digunakan.

3.6.16 Hernia (K40-K46)

Dalam pengodean diagnosis hernia, pemberi kode harus mencatat secara rinci, apakah terdapat obstruksi atau gangrene. Perlu dicatat bahwa hernia yang disertai dengan obstruksi atau gangrene, baik satu atau keduanya, diklasifikasikan dalam kategori hernia dengan gangrene.

Pada kasus kode kombinasi diagnosis primer hernia dengan diagnosis sekunder obstruksi, sudah terdapat kode untuk hernia yang disertai obstruksi pada subbab Hernia (K40-K46). Oleh karena itu, obstruksi tidak dapat digunakan sebagai diagnosis sekunder.

3.6.17 Noninfective Enteritis And Colitis (K50-K52)

Kolitis yang disebabkan oleh obat-obatan, kode yang digunakan adalah K52.2, yang mencakup gastroenteritis dan kolitis alergi serta dietetik. Kolitis alergi dan dietetik lainnya dikodekan dengan K52.3. Sementara untuk kolitis yang tidak infeksius dan tidak dapat ditentukan, termasuk eosinophilic gastroenteritis, digunakan kode K52.8.

3.6.18 Allergic And Dietetic Gastroenteritis And Colitis Due To Cow's Milk Protein (K52.20)

- Alergi protein susu sapi yang menyebabkan diare, maka gunakan kode K52.20 (*Allergic and dietary gastroenteritis and colitis due to cow's milk protein*)^(IM).
- Alergi dermatitis akibat susu sapi, maka gunakan kode L27.2 (*Dermatitis due to ingested food*).
- Alergi rinitis akibat protein susu sapi, maka gunakan kode J30.3 (*Other allergic rhinitis*).

Oleh karena itu, jika dokter hanya menegakkan diagnosis sebagai alergi protein susu sapi secara umum, pengode harus berkonsultasi dengan dokter untuk memastikan bentuk spesifik dari alergi tersebut.

3.6.19 Vascular Disorders Of Intestine (K55.-)

- *Acute mesenteric ischaemia* atau *acute intestinal infarction*, maka gunakan kode K55.0 (*Acute vascular disorders of intestine*).
- *Chronic intestinal ischaemia* atau *mesenteric atherosclerosis*, maka gunakan kode K55.1 (*Chronic vascular disorder of intestine*).
- *Vascular ectasia of small intestine* atau *intestinal vasculitis*, maka gunakan kode K55.8 (*Other vascular disorders of intestine*).

3.6.20 Paralytic Ileus And Intestinal Obstruction Without Hernia (K56.-)

- Jika obstruksi usus disebabkan oleh kanker, divertikulitis, atau enteritis regional, gunakan kode K56.6 (*Other and unspecified intestinal obstruction*).
- Jika dokter mendiagnosis bahwa obstruksi usus disebabkan oleh hernia, gunakan kode dari kelompok K40 – K46 untuk menunjukkan adanya obstruksi pada usus.

3.6.21 Diverticular Disease Of Intestine (K57.-)

Jika dokter mendiagnosis adanya penyakit divertikular usus besar dengan perdarahan saluran cerna bagian bawah, maka gunakan kode K57.3 (*Diverticular disease of large intestine without perforation and abscess*) sebagai kode utama. Sementara itu, jika pasien mengalami BAB berdarah atau perdarahan rektum (misalnya darah tampak jelas merah terang / darah segar), tambahkan kode K62.5 (*Haemorrhage of anus and rectum* sebagai kode tambahan. Namun, jika darah dalam feses tampak berwarna hitam atau kecoklatan (melena, menunjukkan perdarahan lebih tinggi di saluran cerna), maka gunakan kode K92.2 (*Gastrointestinal haemorrhage, unspecified*) sebagai kode tambahan.

Jika dokter mendiagnosis adanya penyakit divertikular usus besar dengan fistula, maka gunakan kode K57.2 (*Diverticular disease of large intestine with perforation and abscess*) sebagai kode utama, serta tambahkan kode K63.2 (*Fistula of intestine*) sebagai kode tambahan.

3.6.22 Other Functional Intestinal Disorders (K59.-)

- *Megacolon*, maka gunakan kode K59.3 (*Megacolon, not elsewhere classified*), serta tambahkan kode untuk penyakit penyebab yang

mendasarinya, seperti *ulcerative colitis*, *regional ileitis*, atau *shigellosis*. Jika *megacolon* disebabkan oleh obat-obatan, gunakan kode eksternal yang sesuai dengan jenis obat yang menjadi penyebabnya.

- *Anal spasm*, maka gunakan kode K59.4 (*Anal spasm*), serta tambahkan kode untuk penyakit penyebab seperti *anal fissure* atau *external haemorrhoids*.

3.6.23 Diseases Of Anus And Rectum (K60-K62)

Kode K60 – K62 digunakan berdasarkan diagnosis dokter. Jika dokter mendiagnosis *Lower gastrointestinal bleeding*, maka gunakan kode K62.5 (*Haemorrhage of anus and rectum*). Jika dokter mendiagnosis proktitis radiasi, gunakan kode K62.7 (*Radiation proctitis*) sebagai diagnosis utama.

3.6.24 Other Diseases Of Intestine (K63.-)

- Abses usus, maka gunakan kode K63.0 (*Abscess of intestine*).

Pengecualian:

- Abses terjadi di anus atau rektum, maka gunakan kode dalam rentang K61.- (*Abscess of anal and rectal regions*).
- Abses terjadi di apendiks, gunakan kode K35.3 (*Acute appendicitis with localized peritonitis*).

- Perforasi usus (nontraumatik), maka gunakan kode K63.1 (*Perforation of intestine (nontraumatic)*).

Pengecualian:

- Perforasi terjadi di apendiks, maka gunakan kode yang sesuai dalam rentang K35.- (*Acute appendicitis*).
- Perforasi terjadi di duodenum, maka gunakan kode yang sesuai dalam rentang K26.- (*Duodenal ulcer*).

- Polip kolon, maka gunakan kode K63.5 (*Polyp of colon*). Jika hasil patologi telah diperoleh, gunakan kode sesuai hasil patologi. **Contoh:** jika hasil patologi menunjukkan adenoma, gunakan kode D12.2 – D12.6 (*Benign neoplasm of colon*) bersama dengan kode ICD-O M8140/0 (*Adenoma NOS*).

3.6.25 Peritonitis (K65, K67)

- *Spontaneous bacterial peritonitis*, maka gunakan kode K65.00 (*Primary peritonitis^{IM}*), tambahkan kode untuk penyakit dasar seperti sirosis hati atau sindrom nefrotik.
- *Secondary peritonitis*, maka gunakan kode K65.01 (*Secondary bacterial peritonitis^{IM}*). Jika disebabkan oleh perforasi usus, gunakan kode sesuai lokasi dan jenis perforasi, misalnya:
 - K62.1 (*Rectal polyp*)
 - K25.1 (*Acute gastric ulcer with perforation*)
 - K57.2 (*Diverticular disease of large intestine with perforation and abscess*).
- *Tuberculous peritonitis*, maka gunakan kode A18.3† (*Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands*) sebagai kode utama, serta tambahkan kode K67.3* (*Tuberculous peritonitis*) sebagai kode tambahan.

3.6.26 Hemoperitoneum (K66.1)

- *Hemoperitoneum* tanpa menyebutkan penyebabnya, maka gunakan kode K66.1 (*Haemoperitoneum*).
- *Hemoperitoneum* yang disebabkan oleh ruptur hepatoma, maka gunakan kode C22.0 (*Liver cell carcinoma*) sebagai kode utama, serta tambahkan kode K66.1 (*Haemoperitoneum*) sebagai kode tambahan.
- *Hemoperitoneum* yang disebabkan oleh ruptur kehamilan tuba, maka gunakan kode O00.1 (*Tubal pregnancy*) sebagai kode utama, serta tambahkan kode K66.1 (*Haemoperitoneum*) sebagai kode tambahan.

3.6.27 Intestinal Malabsorption (K90.-)

- *Steatorrhea pankreas* maka gunakan kode K90.3 (*Pancreatic Steatorrhea*), digabungkan dengan kode untuk pankreatitis kronis, yaitu: K86.0 (*Alcohol-induced chronic pancreatitis*) atau K86.1 (*Other chronic pancreatitis*).

3.6.28 Postprocedural Disorders Of Digestive System (K91.-)

- *Short bowel syndrome* maka gunakan kode K91.20 (*Post surgical malabsorption, post massive bowel resection*).

- *Postsurgical blind loop syndrome* maka gunakan kode K91.28 (*Other postsurgical malabsorption*).

3.6.29 Gastrointestinal Haemorrhage (K92.0-K92.2)

- *Lower gastrointestinal bleeding* maka gunakan kode K62.5 (*Hemorrhage of anus and rectum*).
- *Upper gastrointestinal bleeding*, konsultasikan dengan dokter apakah pasien mengalami *haematemesis* atau *melaena*.

3.6.30 Gastrointestinal Procedures

- Pemberian prosedur EGD dan kontrol perdarahan secara endoskopik maka gunakan kode spesifik 44.43 (*Endoscopic control of gastric or duodenal bleeding*). Tidak perlu menambahkan kode untuk prosedur EGD itu sendiri, seperti 45.13 (*Other endoscopy of small intestine*) karena kode akses atau rute tindakan tidak dikodekan secara terpisah.
- Ketika melakukan ERCP lalu mengangkat batu dari saluran empedu maka gunakan kode spesifik 51.88 (*Endoscopic removal of stone(s) from biliary tract*) tanpa memberikan kode 51.10 (*Endoscopic retrograde cholangiopancreatography*) [ERCP].

Ringkasan kode prosedur yang dilakukan oleh dokter dapat dilihat pada tabel berikut:

Prosedur Catatan Dokter	ICD-9-CM 2010
<i>Colonoscopy</i>	45.23 <i>Colonoscopy</i>
<i>Colonoscopy with biopsy of colon</i>	45.25 <i>Closed [endoscopic] biopsy of large intestine</i>
<i>Colonoscopy with polypectomy</i>	45.42 <i>Endoscopic polypectomy of large intestine</i>
<i>Colonoscopy with control of bleeding</i>	45.43 <i>Endoscopic destruction of other lesion or tissue of large intestine</i>
<i>Colonoscopy through colonostomy</i>	45.22 <i>Endoscopy of large intestine through artificial stroma</i>

<i>Colonoscopy during abdominal surgery</i>	45.21 <i>Transabdominal endoscopy of large intestine</i>
<i>EGD</i>	45.13 <i>Other endoscopy of small intestine</i>
<i>EGD with biopsy of oesophagus</i>	45.16 <i>Oesophagogastroduodenoscopy [EGD] with closed biopsy</i>
<i>EGD with biopsy of stomach</i>	
<i>EGD with biopsy of duodenum</i>	
<i>EGD through gastrostomy</i>	45.12 <i>Endoscopy of small intestine through artificial stroma</i>
<i>EGD during abdominal surgery</i>	45.11 <i>Transabdominal endoscopy of small intestine</i>

3.7 MDC 17 HEPATOBILIER DAN PANKREAS

PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 17

- a. Penetapan kode dalam kategori K70.- *Alcoholic liver disease*, K85.2 *Alcohol-induced acute pancreatitis*, atau K86.0 *Alcohol-induced chronic pancreatitis* harus dinyatakan secara jelas bahwa hepatitis atau pankreatitis tersebut disebabkan oleh konsumsi alkohol. Jika seorang pasien memiliki penyakit hati atau pankreatitis yang tidak diketahui penyebabnya dan pasien tersebut memiliki riwayat konsumsi alkohol, diagnosis tidak boleh diasumsikan sebagai akibat konsumsi alkohol tanpa adanya konfirmasi dari dokter yang menangani dan/atau tanpa dokumentasi medis yang menyatakan keterkaitan tersebut.
- b. Penyakit hati akibat alkohol atau pankreatitis akibat alkohol yang disebabkan karena penggunaan alkohol berlebihan atau ketergantungan alkohol saat ini harus menggunakan kode-kode berikut:
 - K70.- (*Alcoholic liver disease*).
 - K85.2 (*Alcohol-induced acute pancreatitis*).
 - K86.0 (*Alcohol-induced chronic pancreatitis*).
 - F10.- (*Mental and behavioural disorders due to use of alcohol*).

Catatan:

Penugasan karakter keempat tergantung pada apakah konsultan yang bertanggung jawab telah menyatakan bahwa penyakit hati akibat alkohol disebabkan oleh penggunaan berbahaya alkohol (F10.1) atau ketergantungan (F10.2).

- c. Penyakit hati akibat alkohol atau pankreatitis akibat alkohol karena penyalahgunaan alkohol sebelumnya harus menggunakan kode-kode berikut dan urutan:
- K70.- (*Alcoholic liver disease*).
 - K85.2 (*Alcohol-induced acute pancreatitis*).
 - K86.0 (*Alcohol-induced chronic pancreatitis*).
 - Z86.4 (*Personal history of psychoactive substance abuse*).
- d. Apabila tidak ada informasi mengenai penggunaan atau penyalahgunaan alkohol saat ini atau masa lalu dan hanya menyebutkan jenis penyakit hati akibat alkohol atau pankreatitis akibat alkohol maka kode yang sesuai kategori berikut:
- K70.- (*Alcoholic liver disease*).
 - K85.2 (*Alcohol-induced acute pancreatitis*).
 - K86.0 (*Alcohol-induced chronic pancreatitis*).
- e. Dalam MDC 17 terdapat kelompok DRG khusus untuk tindakan *Cholecystectomy* yang disertai dengan tindakan CDE. Oleh karena itu, *coder* perlu mencermati dokumentasi medis dan riwayat tatalaksana pemberian transfusi.
- f. Apabila ada tindakan pada grup P17AE, maka dimasukkan ke dalam kelompok DRG *Cholecystectomy Proc.* Akan tetapi, apabila pengodean group P17AE disertai dengan tambahan dari grup 17PCX, maka akan masuk ke dalam kelompok DRG *Cholecystectomy Proc. w CDE Proc.* Berikut adalah prosedur yang terdapat di dalam grup P17AE dan AX 17PCX:

P17AE Cholecystectomy Proc.

51.21 Other partial cholecystectomy

51.22 Cholecystectomy

AX 17PCX CDE Procedures

- 51.10 Endoscopic retrograde cholangiopancreatography [ERCP]
- 51.11 Endoscopic retrograde cholangiography [ERC]
- 51.14 Other closed [endoscopic] biopsy of biliary duct or sphincter of Oddi
- 51.15 Pressure measurement of sphincter of Oddi
- 51.64 Endoscopic excision or destruction of lesion of biliary ducts or sphincter of Oddi
- 51.84 Endoscopic dilation of ampulla and biliary duct
- 51.85 Endoscopic sphincterotomy and papillotomy
- 51.86 Endoscopic insertion of nasobiliary drainage tube
- 51.87 Endoscopic insertion of stent (tube) into bile duct
- 51.88 Endoscopic removal of stone(s) from biliary tract
- 51.96 Percutaneous extraction of common duct stones
- 51.98 Other percutaneous procedures on biliary tract

PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 17

3.7.1 Alcoholic Liver Disease (K70.-)

- *Alcoholic hepatic encephalopathy* atau *alcoholic hepatic failure* maka digunakan kode K70.4 (*Alcoholic hepatic failure*).

3.7.2 Toxic Liver Disease (K71.-)

- *Toxic liver disease with hepatic coma* maka digunakan kode K71.1 (*Toxic liver disease with hepatic necrosis*).
- *Toxic liver disease with chronic hepatitis* maka digunakan kode K71.3 (*Toxic liver disease with chronic persistent hepatitis*), K71.4 (*Toxic liver disease with chronic lobular hepatitis*) atau K71.5 (*Toxic liver disease with chronic active hepatitis*) tergantung pada hasil pemeriksaan histopatologi untuk menentukan tipe hepatitis kronis dan/atau berdasarkan dokumentasi medis yang lengkap, termasuk riwayat perjalanan penyakit secara kronis serta riwayat tatalaksana pemberian transfusi apabila dilakukan.

3.7.3 Hepatic Failure And Encephalopathy (K72.-)

Jika dokter mendiagnosis gagal hati, maka perlu memilih kode dalam kelompok K72.- yaitu *Hepatic failure, not elsewhere classified* sesuai dengan penentuan dokter, misalnya apakah kondisi tersebut bersifat akut, kronis, atau tidak dispesifikasi, kecuali dalam kasus di mana dokter mendiagnosis:

- Koma hepatik akibat obat maka dapat digunakan kode K71.1 (*Toxic liver disease with hepatic necrosis*), termasuk kode penyebab eksternal dari obat yang menjadi penyebab.

3.7.4 Cirrhosis of Liver (K74.3-K74.6)

- Untuk Sirosis akibat hepatitis B kronis menggunakan kode B18.19 (*Chronic viral hepatitis B, unspecified delta-agent status*) sebagai kode diagnosis utama dan tambahkan kode K74.6 (*Other and unspecified cirrhosis of liver*) sebagai kode diagnosis tambahan.
- Untuk Sirosis akibat hepatitis C kronis maka menggunakan kode B18.2 (*Chronic viral hepatitis C*) sebagai kode diagnosis utama dan tambahkan kode K74.6 (*Other and unspecified cirrhosis of liver*) sebagai kode diagnosis tambahan.
- Untuk *Primary biliary cirrhosis* maka menggunakan kode K74.3 (*Primary biliary cirrhosis*). Namun, jika diagnosis merupakan *secondary biliary cirrhosis* dengan penyebab obstruksi saluran empedu gunakan kode utama sesuai dengan penyebab obstruksi tersebut. Misalnya, kode K80.5 (*Calculus of bile duct without cholangitis or cholecystitis*) untuk diagnosis batu di saluran empedu tanpa radang. Kemudian, dapat ditambahkan kode sekunder K74.4 (*Secondary biliary cirrhosis*) sebagai kode tambahan.
- Untuk *Cardiac cirrhosis* maka menggunakan kode K76.1 (*Chronic passive congestion of liver*). Namun, jika sirosis disebabkan oleh *Wilson's disease* maka dapat menggunakan kode utama E83.0 (*Disorder of copper metabolism*) dan tambahkan kode sekunder K74.6 (*Other and unspecified cirrhosis of liver*) sebagai kode tambahan.

3.7.5 Abscess Of Liver (K75.0)

- Untuk *Phlebitis of portal vein with liver abscess* maka menggunakan kode K75.0 (*Abscess of liver*) sebagai kode utama. Kode K75.1 (*Phlebitis of portal vein*) dapat dimasukkan sebagai kode tambahan. Namun, jika dokter mendiagnosis *Phlebitis of portal vein without liver abscess*, maka dapat menggunakan kode K75.1 (*Phlebitis of portal vein*) saja.
- Untuk *Suppurative liver abscess* akibat infeksi *E. coli* maka menggunakan kode K75.0 (*Abscess of liver*) sebagai kode utama. Kode B96.2 (*Escherichia coli [E. coli] as the cause of disease classified to other chapters*) dapat digunakan sebagai kode tambahan.
- Untuk *Liver abscess* akibat komplikasi batu di saluran empedu dengan *cholangitis* maka menggunakan kode K80.3 (*Calculus of bile duct with cholangitis*) sebagai kode utama. Kode K75.0 (*Abscess of liver*) dapat digunakan sebagai kode tambahan.
- Untuk *Candidal liver abscess* maka menggunakan kode B37.8 (*Candidiasis of other sites*) sebagai kode utama. Kode K75.0 (*Abscess of liver*) dapat digunakan sebagai kode tambahan.

3.7.6 Peliosis Hepatis (K76.4)

- Untuk *Peliosis hepatis* dengan penyebab infeksi *Bartonella*, maka kode utama yang digunakan adalah A44.8 (*Other forms of bartonellosis*) lalu diikuti dengan kode K76.4 (*Peliosis hepatis*) sebagai kode tambahan.
- Untuk *Peliosis hepatis* yang ditemukan pada pasien dengan HIV/AIDS maka menggunakan kode B20.1 (*HIV disease resulting in other bacterial infections*) sebagai kode utama. Kode A44.8 untuk infeksi *Bartonella* dan K76.4 untuk *peliosis hepatis* dapat digunakan sebagai kode tambahan.

3.7.7 Liver Disorders In Diseases Classified Elsewhere (K77.-*)

- Untuk *Scrub typhus with hepatitis* maka menggunakan kode A75.3† (*Typhus fever due to Rickettsia tsutsugamushi*) sebagai kode utama.

Kode K77.0* (*Liver disorders in infectious and parasitic diseases classified elsewhere*) dapat digunakan sebagai kode tambahan.

- Untuk *Sarcoidosis with hepatic involvement* maka menggunakan kode D86.8† (*Sarcoidosis of other and combined sites*) sebagai kode utama. Kode K77.8* (*Liver disorders in other diseases classified elsewhere*) dapat digunakan sebagai kode tambahan.

3.7.8 Cholelithiasis And Diseases Of Biliary Tract (K80-K83)

- Untuk Sindrom Mirizzi maka menggunakan kode K80.5 (*Calculus of bile duct without cholangitis or cholecystitis*) sebagai kode utama. Kode K82.0 (*Obstruction of gallbladder*) dapat digunakan sebagai kode tambahan.
- Untuk Stenosis papiler maka menggunakan kode K83.6 (*Stenosis of sphincter of Oddi*).

3.7.9 Pancreatitis (K85, K86.0, K86.1, K87)

Kode dalam grup K85.- *Acute pancreatitis* digunakan jika dokter mendiagnosis pankreatitis atau pankreatitis akut, dengan memilih kode sesuai penyebab yang ditentukan oleh dokter, sebagai contoh:

- Untuk Pankreatitis akibat obat atau pankreatitis akut akibat obat, maka menggunakan kode K85.3 (*Drug-induced acute pancreatitis*) dan dapat memberikan kode eksternal sesuai jenis obat penyebabnya. Misalnya jika disebabkan oleh *azathioprine* maka menggunakan kode eksternal Y43.4 (*Immunosuppressive agents*).
- Untuk Pankreatitis akut yang disebabkan oleh kondisi hipertrigliseridemia, maka menggunakan kode K85.8 (*Other acute pancreatitis*) sebagai kode utama dan kode E78.3 (*Hyperchylomicronaemia*) sebagai kode tambahan.
- Untuk Pankreatitis atau pankreatitis akut yang disebabkan oleh kondisi hiperkalsemia, maka menggunakan kode K85.8 (*Other acute pancreatitis*) sebagai kode utama dan kode E83.5 (*Disorders of calcium metabolism*) sebagai kode tambahan.

Berikut merupakan contoh lain untuk pengkodean penyakit pankreatitis:

- Untuk Pankreatitis kronis yang disebabkan oleh kondisi hiperkalsemia maka menggunakan kode K86.1 (*Other chronic pancreatitis*) sebagai kode utama dan kode E83.5 (*Disorders of calcium metabolism*) sebagai kode tambahan.
- Untuk Pankreatitis akut yang terjadi setelah ERCP maka menggunakan kode T88.8 (*Other complications of surgical and medical care, not elsewhere classified*) sebagai kode utama, kode K85.8 (*Other acute pancreatitis*) sebagai kode tambahan dan kode Y84.2 (*Radiological procedure and radiotherapy*) sebagai kode eksternal.
- Untuk Pankreatitis sitomegaloviral maka menggunakan kode B25.5† (*Cytomegaloviral pancreatitis*) sebagai kode utama dan kode K87.1* (*Disorders of pancreas in diseases classified elsewhere*) sebagai kode tambahan.

Ringkasan kode prosedur yang dilakukan oleh dokter dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel X. Ringkasan kode ICD-9-CM-2010 untuk prosedur Hepatobilier dan Pankreas

Prosedur Catatan Dokter	ICD-9-CM 2010
<i>ERC</i>	51.11 <i>Endoscopic retrograde cholangiography [ERC]</i>
<i>ERCP</i>	51.10 <i>Endoscopic retrograde cholangiopancreatography [ERCP]</i>
<i>ERCP with removal of biliary stone</i>	51.88 <i>Endoscopic removal of stone(s) from biliary tract</i>
<i>ERCP with insertion of stent</i>	51.87 <i>Endoscopic insertion of stent (tube) into bile duct</i>
<i>Liver biopsy, percutaneous</i>	50.11 <i>Closed (percutaneous) [needle] biopsy of liver</i>
<i>Liver biopsy, laparoscopic</i>	50.14 <i>Laparoscopic liver biopsy</i>
<i>Liver biopsy, open</i>	50.12 <i>Open biopsy of liver</i>
<i>Liver tumour; radiofrequency ablation</i>	50.24 <i>Percutaneous ablation of liver lesion or tissue</i>
<i>Liver tumour; ethanol injection</i>	50.94 <i>Other injection of therapeutic substance into liver</i>
<i>Oesophageal varices ligation or sclerosing therapy</i>	42.33 <i>Endoscopic excision or destruction of lesion or tissue of oesophagus</i>
<i>Oesophageal dilatation</i>	42.92 <i>Dilation of oesophagus</i>

<i>Oesophageal manometry</i>	89.32 <i>Oesophageal manometry</i>
<i>Oesophageal pH monitoring</i>	89.39 <i>Other nonoperative measurements and examinations</i>
<i>Proctosigmoidoscopy</i>	45.24 <i>Flexible sigmoidoscopy</i>
<i>Proctosigmoidoscopy with rectal biopsy</i>	48.24 <i>Closed [endoscopic] biopsy of rectum</i>
<i>PTBD</i>	51.98 <i>Other percutaneous procedures on biliary tract</i>
<i>Stop bleeding of stomach (endoscopic)</i>	44.43 <i>Endoscopic control of gastric or duodenal bleeding</i>
<i>Stop bleeding of duodenum (endoscopic)</i>	
<i>TACE (transhepatic oily chemoembolization)</i>	99.250 <i>Transarterial Chemoembolization (IM)</i> 88.47 <i>Arteriography of other intra-abdominal arteries</i>

3.8 MDC 18 MUSKULOSKELETAL DAN JARINGAN IKAT

PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 18

- Dalam sistem klasifikasi diagnosis penyakit, khususnya dalam sistem muskukokeletal, karakter kelima pada kode diagnosis digunakan untuk memberikan informasi yang lebih rinci terkait jenis dan lokasi keterlibatan jaringan muskulokeletal. Catatan di tingkat bab, kategori, atau kode menunjukkan kode mana yang dapat lebih diperinci dengan penambahan karakter kelima dan lokasi daftar kode karakter kelima dalam klasifikasi. Berikut adalah yang harus diterapkan saat menetapkan karakter kelima dalam system muskuloskeletal:
 - Karakter kelima harus digunakan jika data tersebut ada dalam catatan medis dan jika melakukannya menambahkan informasi yang lebih spesifik tentang lokasi.
 - Dalam kasus di mana kode empat karakter sudah spesifik terhadap lokasi dan penambahan karakter kelima tidak akan menambahkan informasi yang lebih spesifik tentang lokasi, karakter kelima tidak diperlukan.
- Berikut adalah contoh kode yang tidak pernah memerlukan penambahan karakter kelima karena spesifik terhadap lokasi. Penambahan karakter kelima tidak akan menambahkan informasi yang lebih spesifik tentang lokasi:
 - *Idiopathic gout in left knee*, gunakan kode M10.06 (*Idiopathic gout, lower leg*)
 - *Pseudosarcomatous fibromatosis*. No further information is given, gunakan kode M72.4 (*Pseudosarcomatous fibromatosis*)
 - *Thoracogenic scoliosis*, gunakan kode M41.3 (*Thoracogenic scoliosis*)
 - *Cervicalgia of cervicothoracic spine*, gunakan kode M54.23 (*Cervicalgia, cervicothoracic region*).
- Cedera lama atau berulang pada sistem muskuloskeletal dan jaringan ikat harus diberikan kode dari bab penyakit sistem muskuloskeletal dan jaringan ikat. Sedangkan cedera saat ini (baru terjadi) pada sistem muskuloskeletal dan jaringan ikat harus dikodekan ke bab cedera, keracunan dan beberapa konsekuensi lain dari penyebab eksternal, kecuali jika Indeks Alfabetis atau Daftar Tabular menunjukkan kode lain yang lebih tepat.

Contoh:

- *Recurrent dislocation of the elbow joint*, gunakan kode M24.42 (*Recurrent dislocation and subluxation of joint, upper arm*).
- *Stress fracture of lumbar vertebra*, gunakan kode M48.46 (*Fatigue fracture of vertebra, lumbar region*).
- Istilah seperti 'primer', 'sekunder', dan 'post-traumatik' digunakan untuk menjelaskan jenis-jenis khusus arthrosis pada kode M15-M19. Dalam klasifikasi ICD-10, istilah ini penting dan harus disebutkan dalam diagnosis dokter agar kode yang tepat bisa diberikan. Jika istilah tersebut tidak disebutkan, maka kode dengan angka .9 (tidak spesifik) dari kategori yang sesuai akan digunakan
 - Kategori M15.- (*Poliarthrosis*) harus digunakan untuk arthrosis/osteoarthritis dengan penyebutan lebih dari satu situs. Seperti yang ditunjukkan pada catatan eksklusif di kategori M15-M19, *osteoarthritis* tulang belakang dikecualikan dari rentang kode ini (M47.- *Spondilosis*).
 - Kategori M15.- tidak boleh digunakan untuk mengkodekan keterlibatan bilateral dari satu sendi tunggal; ini harus dikodekan ke kategori M16–M19.
 - Kategori M19.- (*Arthrosis*) lain harus digunakan untuk mengkodekan osteoarthritis di situs lain selain pinggul (M16.- Koksartrosis [arthrosis pinggul]), lutut (M17.- Gonartrosis [arthrosis lutut]), sendi carpometacarpal pertama (M18.- Arthrosis sendi carpometacarpal pertama), atau tulang belakang (M47.- Spondilosis).

Contoh: *Osteoarthritis (OA) left hip* diberi kode M16.9 (*Coxarthrosis, unspecified*). *Secondary osteoarthritis (OA) right knee due to osteochondritis dissecans* diberikan kode M17.5 (*Other secondary gonarthrosis*) dan M93.2 (*Osteochondritis dissecans*).

- Dalam MDC 18 terdapat DRG khusus untuk pemberian *complex procedures* untuk tindakan *arthroscopy*, sehingga koder harus memperhatikan dokumentasi medis, termasuk adanya tindakan pembedahan dan/atau bukti riwayat tata laksana pemberian transfusi, untuk memastikan pemilihan kode dan DRG yang tepat.
 - Apabila ada tindakan yang termasuk dalam *Arthroscopy Proc*, maka masuk ke dalam kelompok DRG *Arthroscopy Proc*. Akan tetapi apabila pengodean group *Arthroscopy Proc* disertai dengan tambahan dari grup *Complex*

Procedures for Arthroscopy, maka akan masuk ke dalam kelompok DRG *Arthroscopy w/ Complex Proc.*

Arthroscopy Proc.

- 80.20 Arthroscopy, unspecified site
- 80.21 Arthroscopy, shoulder
- 80.22 Arthroscopy, elbow
- 80.23 Arthroscopy, wrist
- 80.24 Arthroscopy, hand and finger
- 80.25 Arthroscopy, hip
- 80.26 Arthroscopy, knee
- 80.27 Arthroscopy, ankle
- 80.28 Arthroscopy, foot and toe
- 80.29 Arthroscopy, other specified sites

Complex Procedures for Arthroscopy

- 81.42 Five-in-one repair of knee
- 81.43 Triad knee repair
- 81.44 Patellar stabilization
- 81.45 Other repair of the cruciate ligaments
- 81.46 Other repair of the collateral ligaments
- 81.47 Other repair of knee
- 81.83 Other repair of shoulder
- 83.63 Rotator cuff repair

PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 18

3.8.1 Pyogenic Arthritis (M00-M01)

Untuk diagnosis artritis piogenik atau septik, kode M00 digunakan dengan spesifikasi jenis bakteri penyebab, seperti:

- M00.0 (*Staphylococcal arthritis and polyarthritis*) atau M00.8 (*Arthritis and polyarthritis due to other specified bacterial agents*) jika disebabkan oleh bakteri lain yang telah diidentifikasi melalui hasil kultur atau pemeriksaan mikrobiologi.

- Jika penyebab infeksi tidak dapat diidentifikasi (misal: hasil kultur negatif atau pemeriksaan terbatas), maka gunakan kode M00.9 (*Pyogenic arthritis, unspecified*) sebagai klasifikasi sementara.
- Jika artritis terkait dengan infeksi sistemik seperti tuberkulosis (A18.0), virus (misal: B33.0), atau jamur (B35-B49), maka kode utama diambil dari Bab 1 (Kode A/B) sesuai etiologi, dan disertai kode tambahan M01.- untuk menunjukkan manifestasi artikular (contoh: A18.0† M01.1* untuk *Tuberculous arthritis*). Dokumentasi medis harus mencantumkan hubungan sebab-akibat antara infeksi sistemik dan artritis, serta hasil pemeriksaan penunjang (misal: PCR, MRI, atau biopsi sinovium) untuk memastikan akurasi pengodean.

3.8.2 Reactive Arthropathies (M02-M03)

Arthropati reaktif, maka gunakan kode M02 (*Reactive Arthropathies*) sebagai klasifikasi medis yang sesuai, dengan catatan bahwa kondisi ini muncul sebagai respon inflamasi sendi akibat infeksi atau proses imunologis di lokasi tubuh lain (misal: saluran cerna, genitourinaria, atau saluran napas).

3.8.3 Rheumatoid Arthritis (M05-M06)

- Kode M05 digunakan untuk *Arthritis rematoid seropositif* yang disertai komplikasi sistemik atau organ, seperti M05.0 (*Felty's syndrome*), yang didukung dengan hasil tes antibodi (misal: RF atau anti-CCP positif) dan bukti klinis keterlibatan organ lain.
- Kode M06.0 (*Seronegative rheumatoid arthritis*) diterapkan di mana hasil tes antibodi negatif tetapi manifestasi klinis (nyeri sendi, kekuatan) memenuhi kriteria diagnosis artritis rematoid.
- Kode M06.9 (*Rheumatoid arthritis, unspecified*) digunakan sebagai klasifikasi jika diagnosis tidak memuat detail serologis (tes antibodi tidak dilakukan) atau tidak memenuhi kriteria untuk kode M05 atau M06.0.

3.8.4 Psoriatic And Enteropathic Arthropathies (M07)

- Kode M07.0* (*Distal interphalangeal psoriatic arthropathy*) digunakan untuk *arthritis psoriasis* tipe interfalang distal, yaitu peradangan sendi yang terkait dengan psoriasis dan secara khusus mengenai sendi-sendi interfalang (ujung jari tangan/kaki). Kode ini memerlukan dokumentasi

yang menunjukkan hubungan kausal antara psoriasis (kode L40.-) dan manifestasi artikular.

- Kode M07.5* (*Arthropathy in ulcerative colitis*) diterapkan untuk suatu kondisi ekstraintestinal yang muncul sebagai komplikasi inflamasi kronis pada penyakit usus. Kode ini harus digunakan bersamaan dengan kode utama kolitis ulseratif (K51.-).

3.8.5 Juvenile Arthritis (M08-M09)

- *Juvenile rheumatoid arthritis*, baik dengan maupun tanpa deteksi faktor reumatoid, gunakan kode M08.0 (*Juvenile rheumatoid arthritis*).
- *Juvenile ankylosing spondylitis*, suatu inflamasi kronis yang mengenai tulang belakang dan sendi sakroiliaka, gunakan kode M08.1 (*Juvenile ankylosing spondylitis*).
- *Juvenile arthritis with systemic onset (Still's disease)*, yang ditandai dengan demam, ruam, dan hepatosplenomegali disertai gejala artikular, gunakan kode M08.2 (*Juvenile arthritis with systemic onset*).
- Arthritis juvenil tidak jelas atau tidak spesifik, gunakan kode M08.9 (*Juvenile arthritis, unspecified*) untuk menjadi pilihan sementara.
- Arthritis juvenil terkait psoriasis, gunakan L40.5† (*Arthropathic psoriasis*) sebagai kode utama dan M09.0* (*Juvenile arthritis in psoriasis*) sebagai kode tambahan untuk menunjukkan manifestasi artikular.
- Penyakit Crohn, gunakan kode K50.† (*Crohn's disease of small intestine*) disertai M09.1* (*Juvenile arthritis in Crohn's disease*) [*regional enteritis*].

Kode dalam kelompok M08. dan M09. harus memiliki 5 digit, dengan digit kelima menunjukkan lokasi sendi yang terlibat (misal: M08.01 untuk artritis reumatoid juvenil pada sendi lutut). Simbol † menandakan kode utama (penyakit primer), sedangkan * menunjukkan kode tambahan (komplikasi atau manifestasi sekunder). Dokumentasi medis harus mencantumkan hubungan sebab-akibat antara kondisi primer (psoriasis, penyakit Crohn) dan artritis juvenil, serta spesifikasi lokasi pengiriman untuk digit kelima.

3.8.6 Gout And Crystal Arthropathies (M10-M11)

- *Idiopathic gout* , yaitu kondisi pembentukan asam urat tanpa penyebab yang jelas, gunakan kode M10.0 (*Idiopathic gout*)

- *Lead-induced gout*, gunakan kode M10.1 (*Lead-induced gout*)
- *Drug-induced gout* (misal: diuretik), gunakan kode M10.2 (*Drug-induced gout*) dengan catatan bahwa kode eksternal tambahan (misal: T36-T50) harus disertakan untuk menyebutkan obat penyebab
- *Gout due to impairment of renal function*, seperti gagal ginjal kronis, gunakan kode M10.3 (*Gout due to impairment of renal function*)
- Kondisi pseudogout, gunakan M11.8 (*Other specified crystal arthropathies*), sedangkan M11.2 (*Other chondrocalcinosis*) diterapkan jika kondrokalkinosis (endapan kalsium pirofosfat) secara eksplisit disebutkan dalam diagnosis. Kode E79.0 (*Hyperuricaemia without signs of inflammatory arthritis and tophaceous disease*).

Kode dalam kelompok M10. (*Gout*) dan M11. (*Other crystal arthropathies*) harus dituliskan secara lengkap hingga 5 digit, dengan digit kelima menunjukkan lokasi sendi yang terlibat (misal: M10.01 untuk gout idiopatik pada sendi metatarsal). Jika diagnosis melibatkan penyebab eksternal (misal: obat atau paparan timbal), kode tambahan dari Bab 19 (Kode T , Z) harus digabungkan. E79.0 tidak memerlukan digit tambahan karena hanya mencerminkan kondisi metabolik tanpa manifestasi artikular.

3.8.7 Polyarthritis And Monoarthritis (M13.0 - M13.1)

- Kode M13.0 (*Polyarthritis, unspecified*), yaitu peradangan yang mengenai beberapa sendi (≥ 4 sendi) tanpa penyebab yang jelas setelah evaluasi klinis awal.
- Kode M13.1 (*Monoarthritis, not elsewhere classified*), yaitu radang yang terbatas pada satu sendi (misal: lutut atau pergelangan tangan kaki) dengan etiologi yang belum teridentifikasi.
- Kode M13.0 dan M13.1 bersifat sementara dan hanya digunakan jika:
 - Penyebab pasti (misal: infeksi, autoimun, metabolik) belum terdeteksi melalui pemeriksaan awal dan dokter belum dapat menegakkan diagnosis spesifik (misal: artritis reumatoid, gout, atau spondilitis ankilosa).
 - Jika penyebab ditemukan, kode ini harus diganti dengan kode yang lebih spesifik, contoh:

- a. Poliartritis akibat rheumatoid arthritis, gunakan kode M05-M06
- b. Monoartritis akibat infeksi, gunakan kode M00 (arthritis septik)
- c. Radang sendi terkait psoriasis, gunakan kode M07.0 atau M09.0
- Digit ke-4 dan ke-5 pada kode M13.0/M13.1 harus diisi sesuai lokasi pengiriman yang terlibat (lihat daftar di Bab 13).

3.8.8 Coxarthrosis [Arthrosis Of Hip] (M16)

Jika dokter mendiagnosis osteoarthritis pinggul tetapi tidak mencantumkan detail seperti jumlah sisi (unilateral/bilateral) atau penyebab pasti, kode M16.9 (*Coxarthrosis, unspecified*) dapat digunakan sebagai klasifikasi sementara. Namun, pembuat kode wajib melakukan upaya untuk mengidentifikasi informasi tambahan dari rekam medis atau meminta dokter meninjau diagnosis untuk mendapatkan kode yang lebih spesifik. Berikut detail pengodean berdasarkan kriteria klinis:

1. Osteoarthritis Pinggul Primer (Tanpa Penyebab Jelas)

Jika diagnosis menyebutkan osteoarthritis pinggul pada lansia tanpa penyebab yang jelas atau osteoarthritis primer bilateral, gunakan M16.0 (*Primary coxarthrosis, bilateral*). Jika hanya satu sisi (unilateral), gunakan M16.1 (*Other primary coxarthrosis*).

2. Osteoarthritis Pinggul Sekunder Akibat Displasia

Untuk kondisi seperti displasia sendi pinggul (misal: soket tidak tumbuh sempurna atau riwayat terkilir sejak kanak-kanak):

- Bilateral → M16.2 (*Coxarthrosis resulting from dysplasia, bilateral*).
- Unilateral → M16.3 (*Other dysplastic coxarthrosis*).

3. Osteoarthritis Pinggul Sekunder Pasca-Trauma

Jika disebabkan oleh cedera tulang pinggul/panggul di masa lalu :

- Bilateral → M16.4 (*Post-traumatic coxarthrosis, bilateral*).
- Unilateral → M16.5 (*Other post-traumatic coxarthrosis*).

4. Osteoarthritis Pinggul Sekunder Akibat Penyebab Lain

Untuk kondisi seperti nekrosis iskemik tulang pinggul, atrofi, penggunaan steroid jangka panjang, atau komplikasi penyakit radang (arthritis reumatoid, gout):

- Bilateral → M16.6 (*Other secondary coxarthrosis, bilateral*).
- Unilateral → M16.7 (*Other secondary coxarthrosis*).

Catatan: Jika penyebab mendasar (misal: artritis reumatoid/gout) diketahui, kode M16.6/M16.7 harus digabungkan dengan kode primer penyakit tersebut (misal: M05.- untuk artritis reumatoid atau M10.- untuk gout).

Prinsip Umum: Digit ke-4 dan ke-5 pada kode M16.- menunjukkan lokasi anatomi (misal: "0" untuk bilateral, "1" untuk unilateral di sisi kanan, "2" untuk kiri). Jika dokter tidak menyebutkan detail, M16.9 tetap bisa digunakan, tetapi dokumentasi harus diperjelas untuk menghindari kesalahan klasifikasi.

Contoh 1-18	Pasien adalah seorang pria berusia 50 tahun. Dokter mendiagnosis pasien dengan nekrosis avaskular pada pinggul serta osteoartritis pinggul satu sisi, yang disebabkan oleh penggunaan steroid. Dalam kode konsultasi, dokter meminta untuk mengubah diagnosis utama menjadi osteoartritis sekunder satu sisi pada pinggul. Diagnosis terkait sendi yang diberikan adalah osteonekrosis, dengan identifikasi penyebab eksternal yang berasal dari penggunaan steroid.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Osteoartritis sekunder unilateral pinggul	M16.7 <i>Other secondary coxarthrosis</i>
Diagnosis Sekunder	Osteonekrosis	M87.15 <i>Osteonecrosis due to drugs</i>
Penyebab Eksternal	Penggunaan steroid	Y42.0 <i>Glucocorticoids and synthetic analogues</i>

- Pemberian kode 81.51 (*Total hip replacement*) dan 81.52 (*Partial hip replacement*) umumnya mudah karena prosedur ini sering dilakukan. Namun, kode 84.57 (*Removal of joint spacer*) dan kode jenis *bearing surface* juga harus diberikan jika informasinya tersedia. Permasalahan biasanya muncul pada pemberian kode untuk operasi revisi penggantian sendi panggul. Untuk operasi revisi, sebaiknya menggunakan kode 00.70–00.73 (*Revision of hip replacement*) yang lebih spesifik, bukan hanya 81.53. Selain itu, sekarang ada juga tindakan baru berupa *hip resurfacing*.

- *Revision of total hip replacement* adalah operasi perbaikan salah satu bagian dari sendi pinggul buatan pada pasien yang sebelumnya telah menjalani operasi penggantian sendi pinggul. Setelah digunakan selama bertahun-tahun, mungkin terjadi pelonggaran yang memerlukan perbaikan. Pengode harus mencari informasi dalam catatan operasi tentang komponen mana yang diperbaiki. Tidak disarankan memberikan kode 81.53 (*Revision of hip replacement, not otherwise specified*) karena catatan operasi seharusnya memiliki informasi yang spesifik dan jelas.
- Jika dokter melakukan operasi penggantian kedua bagian sendi pinggul buatan, baik komponen asetabular maupun femoral, gunakan kode 00.70 (*Revision of hip replacement, both acetabular and femoral components*).
- Jika dokter melakukan operasi penggantian khusus bagian *acetabular shell*, mungkin dilakukan bersamaan dengan penggantian cup atau liner atau bersamaan dengan penggantian bagian femoral head, gunakan kode 00.71 (*Revision of hip replacement, acetabular component*).
- Jika dokter melakukan operasi penggantian khusus bagian femoral stem, mungkin dilakukan bersamaan dengan penggantian femoral head atau acetabular liner, gunakan kode 00.72 (*Revision of hip replacement, femoral component*).
- Jika dokter melakukan operasi penggantian khusus acetabular liner dan/atau femoral head, gunakan kode 00.73 (*Revision of hip replacement, acetabular liner and/or femoral head only*).
- Pemberi kode harus memberikan kode tambahan untuk menentukan jenis permukaan bantalan (*bearing surface*) yang diganti oleh dokter, berdasarkan informasi dari stiker yang terlampir dalam rekam medis, sebagai berikut:
 - Berikan kode 00.74 (*Hip replacement bearing surface, metal on polyethylene*) ketika menggunakan jenis bantalan umum, yaitu *femoral head* terbuat dari logam dan bagian liner asetabular terbuat dari plastik sintetis kepadatan tinggi khusus berwarna putih atau hijau muda (*polyethylene*).
 - Berikan kode 00.75 (*Hip replacement bearing surface, metal on metal*) ketika menggunakan jenis bantalan khusus untuk mengurangi gesekan,

yang dirancang dengan *femoral head* dari logam yang bersentuhan dengan liner asetabular yang juga terbuat dari logam.

- Berikan kode 00.76 (*Hip replacement bearing surface, ceramic on ceramic*) ketika menggunakan jenis bantalan khusus untuk mengurangi gesekan, yang dirancang dengan *femoral head* dari keramik yang bersentuhan dengan liner asetabular yang juga terbuat dari keramik
- Berikan kode 00.77 (*Hip replacement bearing surface, ceramic on polyethylene*) ketika menggunakan bantalan yang dirancang dengan *femoral head* dari keramik yang bersentuhan dengan liner asetabular yang terbuat dari *polyethylene*

Dalam kasus di mana dokter menggunakan jenis bantalan yang dirancang dengan *femoral head* dari keramik yang bersentuhan dengan liner asetabular yang terbuat dari logam, belum ada kode yang tersedia. Kode tambahan untuk menentukan jenis permukaan bantalan seperti disebutkan di atas hanya tersedia dalam sistem ICD 9 CM saja, tidak ditemukan dalam ICD-10 CM karena bukan merupakan operasi atau prosedur.

- Kode operasi hip resurfacing dalam ICD-9-IM terdiri dari: 00.85 (*Resurfacing hip, acetabulum and femoral head*) yaitu penggantian permukaan sendi pada kedua sisi, 00.86 (*Resurfacing hip, femoral head*) yaitu penggantian permukaan sendi pada sisi *femoral head*, 00.87 (*Resurfacing hip, acetabulum*) yaitu penggantian permukaan sendi pada sisi acetabulum.

Contoh 2-18	Pasien pria dengan penggantian pinggul total (total hip replacement) mengalami pengenduran hanya pada bagian soket pinggul. Pasien kemudian menjalani operasi revisi penggantian pinggul, meliputi penggantian komponen asetabular (soket) dan kepala femoralis. Informasi pada stiker yang terdapat dalam catatan operasi (operative note) menyebutkan bahwa liner terbuat dari polietilen dan kepala femoralis terbuat dari kobalt-krom.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Operasi	Revisi penggantian pinggul, komponen asetabular	00.71 <i>Revision of hip replacement, acetabular component</i> 00.74 <i>Hip replacement bearing surface, metal on polyethylene</i>

Contoh 3-18	Pasien pria memiliki kondisi pengenduran pada pinggul buatan (protesis pinggul), di mana bagian kepala femoralis yang terbuat dari logam mengalami gesekan ringan hingga menyebabkan liner (pelapis soket) terlepas. Namun, karena usia pasien yang sudah lanjut, dokter memutuskan untuk hanya melakukan operasi penggantian liner saja. Informasi pada stiker yang terdapat dalam catatan operasi (operative note) menyebutkan bahwa liner tersebut terbuat dari polietilen.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Operasi	Revisi penggantian pinggul, hanya liner acetabular	00.73 <i>Revision of hip replacement, acetabular liner and/or femoral head only</i> 00.74 <i>Hip replacement bearing surface, metal on polyethylene</i>

3.8.9 Gonarthrosis [Arthritis Of Knee] (M17)

Dalam kasus di mana dokter mendiagnosis osteoarthritis lutut tetapi tidak mencatat jumlah sisi yang terkena dan penyebab penyakit, pengode harus berusaha menghindari pemberian kode M17.9 (*Gonarthrosis, unspecified*). Sebaiknya mencari informasi dalam catatan rekam medis dan meminta dokter

untuk meninjau kembali diagnosis secara detail untuk mendapatkan kode yang lengkap sebagai berikut:

- *Osteoarthritis* lutut primer pada kedua lutut, berikan kode M17.0 (*Primary gonarthrosis, bilateral*), dan jika hanya pada satu sisi, berikan kode M17.1 (*Other primary gonarthrosis*)
- *Osteoarthritis* lutut pasca trauma pada kedua lutut, berikan kode M17.2 (*Post traumatic gonarthrosis, bilateral*), dan jika hanya pada satu sisi, berikan kode M17.3 (*Other post traumatic gonarthrosis*).
- *Osteoarthritis* lutut sekunder pada kedua lutut, berikan kode M17.4 (*Other secondary gonarthrosis, bilateral*), dan jika hanya pada satu sisi, berikan kode M17.5 (*Other secondary gonarthrosis*). Dalam kasus ini, gunakan kode penyakit yang menjadi penyebabnya sebagai kode diagnosis tambahan, misalnya jika didiagnosis *osteoarthritis* lutut akibat *rheumatoid arthritis*, gunakan kode M05. atau M06. sebagai kode diagnosis tambahan.

Kode ICD-9-IM untuk prosedur penggantian sendi lutut hanya memiliki satu kode yaitu 81.54 (*Total knee replacement*) yang juga mencakup berbagai jenis *partial knee replacement*

Contoh 4-18	Pasien telah menjalani operasi total knee arthroplasty (penggantian sendi lutut total) satu tahun lalu, namun bagian permukaan belakang patela (tempurung lutut) tidak diganti saat itu. Setelah operasi, pasien mengalami nyeri pada area lutut, dan pemeriksaan menunjukkan adanya kerusakan kartilago di bagian belakang patela. Dokter mendiagnosis bahwa pasien mengalami osteoarthritis patellofemoral sehingga dilakukan prosedur operasi patellar resurfacing untuk mengatasi kondisi tersebut.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis primer	Artritis patellofemoral	M22.8 <i>Other disorders of patella</i>
Diagnosis sekunder	-	-
Operasi	Pelapisan ulang patelar	78.46 <i>Other repair or plastic operations on bone, patella</i>

Revisi penggantian lutut mengacu pada prosedur pembedahan pada pasien yang sebelumnya telah menjalani operasi penggantian sendi lutut

buatan. Setelah digunakan untuk jangka waktu tertentu, implan lutut mungkin mengalami pelonggaran atau infeksi sehingga memerlukan pembedahan untuk memperbaiki sebagian komponen, atau prosedur koreksi setelah pendekatan operasi dua tahap (*two stage*). Ini juga mencakup operasi untuk memperbaiki prosedur fusi sendi untuk mengatasi masalah dari operasi implan sebelumnya yang gagal. Namun, tidak termasuk prosedur yang terkait dengan tendon dan jaringan seperti artroskopi lutut (*arthroscopy*) dan operasi *lateral release*. Oleh karena itu, ketika dokter mencatat bahwa dilakukan "*revision of total knee replacement*", pemberi kode harus mencari informasi dari catatan operasi tentang komponen mana yang diperbaiki untuk memberikan kode yang rinci, yaitu:

- Berikan kode 00.80 (*Revision of knee replacement, total (all components)*) untuk operasi perbaikan mengganti seluruh perangkat lutut buatan yang terdiri dari 3 bagian: material buatan yang menutupi bagian distal femur, bagian atas tibia, dan patela.
- Berikan kode 00.81 (*Revision of knee replacement, tibial component*) untuk operasi penggantian khusus komponen yang mendukung bagian atas tulang tibia, yang mungkin termasuk penggantian tibial baseplate logam bersama dengan tibial insert (liner) yang terbuat dari polietilen.
- Berikan kode 00.82 (*Revision of knee replacement, femoral component*) untuk operasi penggantian logam yang menutupi bagian distal femur, yang mungkin juga dilakukan bersamaan dengan penggantian tibial insert.
- Berikan kode 00.83 (*Revision of knee replacement, patellar component*) untuk operasi penggantian material buatan pada bagian patella
- Berikan kode 00.84 (*Revision of knee replacement, tibial insert (liner)*) untuk operasi penggantian material buatan yang mendukung sendi di atas logam yang menutupi tulang tibia, metode ini sering digunakan dalam pengobatan infeksi pada lutut buatan.

Untuk kasus di mana dokter mengganti komponen pada kedua sisi tetapi tidak mengganti komponen permukaan patela, belum ada kode ICD-9-IM yang sesuai. Disarankan untuk menggunakan kode 81.55 *Revision of knee replacement NOS*. Kode tambahan untuk prosedur revision of knee replacement adalah 84.57 *Removal of (cement) spacer* yang mengacu pada

pengangkatan semen yang digunakan dalam pengobatan infeksi lutut buatan sebelum memasang perangkat baru.

Contoh 5-18	Pasien telah menjalani operasi total knee arthroplasty (penggantian sendi lutut total). Selanjutnya, terjadi pengenduran hanya pada komponen femur. Oleh karena itu, pasien menjalani operasi revisi penggantian lutut dengan mengganti hanya bagian komponen femur serta tibial insert.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Operasi	Revisi penggantian lutut, tulang paha dan sisipan tibialis	00.82 <i>Revision of knee replacement, femoral component</i>

Catatan: Dalam contoh ini, kode 00.84 tidak diperlukan karena sudah termasuk dalam kode 00.82.

Contoh 6-18	Pasien sebelumnya telah menjalani operasi penggantian sendi lutut buatan dan mengalami infeksi. Dokter melakukan tindakan koreksi pertama dengan membersihkan luka serta mengganti tibial insert, namun infeksi masih tidak dapat dikendalikan. Oleh karena itu, dilakukan operasi kedua untuk melepas seluruh komponen alat prostesis dan dipasang <i>cement spacer</i> sebagai pengganti sementara. Setelah 3 bulan, pasien kembali menjalani operasi ketiga, di mana cement spacer dilepas dan dipasang satu set alat penggantian sendi lutut total (total knee replacement) yang baru secara keseluruhan.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Operasi Primer	Revisi penggantian lutut, total	00.80 <i>Revision of knee replacement, total (all components)</i>
Operasi Sekunder	Penghapusan spacer semen	84.57 <i>Removal of (cement) spacer</i>

3.8.10 Acquired Clawhand, Clubhand, Clawfoot, And Clubfoot (M21.5, Q66.0)

Jika dokter mendiagnosis secara singkat sebagai kaki pengkor, pemberi kode sebaiknya berkonsultasi dengan dokter untuk meninjau diagnosis apakah pasien memiliki kaki pengkor bawaan atau terjadi setelah lahir.

- Jika kongenital kaki pengkor (*clubfoot* bawaan), pemberi kode sebaiknya berkonsultasi dengan dokter untuk meninjau diagnosis dengan lebih rinci tentang jenis kaki pengkor bawaan.

- Jika kaki pengkor jinjit bengkok ke dalam, berikan kode Q66.0 (*Talipes equinovarus*).
- Jika kaki pengkor tumit bengkok ke dalam, berikan kode Q66.1 (*Talipes calcaneovarus*).
- Jika *Acquired Clubfoot* (kaki pengkor didapat), berikan kode M21.57 (*Acquired Clawfoot dan Clubfoot*).
- Dalam kasus di mana dokter menegaskan bahwa tidak dapat mendiagnosis jenis kaki pengkor atau hanya dapat mendiagnosis sebagai kaki pengkor bawaan, maka perlu diberikan kode Q66.8 (*Other congenital deformities of feet*).

3.8.11 Disorders Of Patella (M22)

- Jika dokter mendiagnosis sindrom nyeri lutut anterior, pemberi kode harus berkonsultasi dengan dokter untuk mengubah diagnosis menjadi sindrom nyeri patellofemoral atau sindrom nyeri patellofemoral, dan memberi kode M22.2 (*Patellofemoral disorders*), yang merupakan kode untuk sekelompok gejala. Oleh karena itu, setelah dokter memberikan perawatan untuk jangka waktu tertentu, diagnosis dapat diubah menjadi lebih jelas.
- *Malalignment of patella* atau *derangement of patella*, berikan kode M22.3 (*Other derangements of patella*).
- *Chondromalacia of patella*, berikan kode M22.4 (*Chondromalacia patellae*).
- Displasia patela atau patela agensis, yang merupakan kelainan pada patela itu sendiri, seperti malformasi atau ukuran yang lebih kecil dari normal, berikan kode M22.8 (*Other disorders of patella*).
- Osteoarthritis patellofemoral, belum ada kode khusus, gunakan kode M22.8 (*Other disorders of patella*) untuk sementara.

Contoh 7-18	Pasien wanita, usia 50 tahun, datang dengan keluhan nyeri di sekitar area lutut, terutama saat menekuk atau menggerakkan lutut untuk berdiri atau duduk. Dokter menemukan adanya suara seperti gesekan kertas pasir (crepitus) di lutut saat bergerak. Awalnya dokter mendiagnosis kondisi ini sebagai anterior knee pain syndrome. Namun, setelah mendapatkan saran dari dokter konsultan, diagnosis diubah menjadi patellofemoral syndrome.
------------------------	---

	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Sindrom patellofemoral	M22.2 <i>Patellofemoral disorders</i>
Diagnosis Sekunder	-	-

Contoh 8-18	Pasien wanita tersebut sebelumnya telah menjalani perawatan terus-menerus selama 6 bulan. Meskipun nyeri telah berkurang, keluhan nyeri masih belum sepenuhnya hilang. Hasil pemeriksaan radiologi menunjukkan adanya osteofit (pertumbuhan tulang abnormal) di tepi lutut. Berdasarkan temuan ini, dokter mendiagnosis pasien dengan osteoarthritis patellofemoral.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Osteoarthritis patellofemoral	M22.8 <i>Other disorders of patella</i>
Diagnosis Sekunder	-	-

3.8.12 Chronic Instability Of Knee (M23.5)

Jika dokter mendiagnosis ACL atau PCL robekan tetapi merupakan cedera kronis, tetapi tidak menyebabkan insufisiensi atau instabilitas, maka harus dikodekan sesuai dengan Chapter XIII *Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue*, seperti M24.2 (*Disorder of ligament*). Jika ada bukti klinis insufisiensi atau instabilitas yang dinyatakan oleh dokter, kode yang digunakan seperti M23.51 (*Chronic instability of knee, anterior cruciate ligament*) atau M23.52 (*Chronic instability of knee, posterior cruciate ligament*).

Gunakan kode dari kelompok Y70 – Y82 untuk mendokumentasikan kejadian yang melibatkan peralatan medis, dengan digit keempat pada kode utama secara spesifik menunjukkan jenis perangkat yang terlibat. Jenis perangkat ini mencakup berbagai kategori, seperti alat untuk diagnosis dan pemantauan (misalnya, monitor jantung atau alat pencitraan), peralatan untuk terapi dan rehabilitasi (seperti alat fisioterapi atau ventilator), serta instrumen bedah (contohnya, pisau bedah atau alat penjepit). Penting untuk memastikan bahwa jenis perangkat yang digunakan dicatat dengan sangat rinci, termasuk

fungsi dan konteks penggunaannya, agar pengodean dapat merepresentasikan situasi secara tepat dan tidak menimbulkan ambiguitas.

Penggunaan kode ini memiliki implikasi penting dalam analisis insiden medis yang melibatkan peralatan tertentu. Setiap kejadian, baik berupa kerusakan alat, kesalahan pengoperasian, atau komplikasi selama penggunaan, harus didokumentasikan secara kritis dan detail guna mendukung evaluasi menyeluruh. Data yang dihasilkan dari pengodean ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola kegagalan atau risiko yang terkait dengan perangkat medis tertentu, sehingga memungkinkan dilakukannya tindakan korektif seperti pelatihan ulang tenaga medis, pembaruan protokol penggunaan, atau peningkatan kualitas perangkat. Dengan pendekatan yang teliti dan kritis, dokumentasi ini menjadi alat penting untuk meningkatkan keselamatan pasien dan memastikan standar pelayanan medis yang lebih tinggi di masa depan. Kode ICD-9-IM untuk operasi rekonstruksi ACL/PCL terdiri dari:

1. Kode untuk operasi perbaikan ligamen, yaitu:
 - 81.43 (*Triad knee*), perbaikan berarti melakukan 3 jenis operasi dalam satu waktu, terdiri dari menisektomi medial, perbaikan ligamen silang anterior, dan penjahitan ligamen kolateral medial. Dokter mungkin mencatat operasi ini sebagai prosedur O'Donoghue.
 - 81.45 (*Other repair of the cruciate ligaments*), berarti rekonstruksi ligamen ACL atau PCL.
 - 83.41 (*Excision of tendon for graft*), berarti pengambilan tendon dari tempat lain untuk membuat ligamen lutut baru
 - 83.43 (*Excision of muscle or fascia for graft*), berarti pengambilan sebagian otot atau fascia untuk membuat ligamen lutut baru.
2. Kode prosedur yang dilakukan bersamaan dengan perbaikan ACL/PCL, yaitu:
 - 80.26 (*Arthroscopy of knee*), berarti penggunaan artroskopi untuk melihat ke dalam sendi lutut.
 - 80.36 (*Biopsy of joint structure of knee*), berarti pengambilan jaringan sendi lutut untuk diperiksa.
 - 80.46 (*Division of joint capsule, ligament, or cartilage of knee*), berarti pemotongan kapsul sendi, ligamen, atau tulang rawan di lutut.

- 80.6 (*Excision of semilunar cartilage of knee*), berarti mengangkat meniskus lutut.
 - 80.76 (*Synovectomy of knee*), berarti menghubungkan jaringan sinovial untuk memudahkan operasi.
 - 80.86 (*Other local excision or destruction of lesion of joint of knee*), berarti mengangkat sebagian sisa ligamen, tulang rawan yang terlepas, atau osteofit yang tidak berfungsi.
3. Untuk semua jenis operasi lutut yang dilakukan melalui artroskopi, berikan kode 80.26 (*Arthroscopy of knee*).

Dalam ICD-10 CM, kode operasi perbaikan ligamen silang telah dipisahkan dengan jelas antara operasi melalui artroskopi dan operasi terbuka, sehingga tidak perlu memberikan kode tambahan untuk artroskopi lutut.

Contoh 9-18	Pasien berusia 30 tahun didiagnosis dengan ACL insufficiency (kelemahan ligamen anterior cruciatum) pada lutut kanan. Dokter memutuskan untuk melakukan operasi rekonstruksi ACL secara artroskopik menggunakan graft semitendinosus. Selama operasi, ditemukan bahwa meniskus medial (bantalan sendi di bagian dalam lutut) juga mengalami robekan, sehingga meniskus tersebut dipotong dan diangkat.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Insufisiensi ACL lutut kanan	M23.51 <i>Chronic instability of knee, anterior cruciate ligamen or Anterior horn of medial meniscus</i>
Diagnosis Sekunder	Robekan lutut kanan meniskus	M23.21 <i>Derangement of meniscus due to old tear or injury Anterior cruciate ligament or Anterior horn of medial meniscus</i>
Operasi	(1) Rekonstruksi ACL artroskopi dengan cangkok semitendinosa (2) Eksisi meniskus	81.45 <i>Other repair of the cruciate ligaments</i> 80.26 <i>Arthroscopy of knee</i> 80.6 <i>Excision of semilunar cartilage of knee</i> 83.43 <i>Excision of muscle or fascia for graft</i>

3.8.13 Haemarthrosis (M25.0)

Apabila dokter mendiagnosis seorang pasien dengan hemofilia disertai hemarthrosis (pendarahan pada sendi), kode diagnosis utama yang harus diberikan adalah D66 (*Hereditary factor VIII deficiency*), yang menunjukkan

factor VIII deficiency bawaan sebagai penyebab hemofilia. Selain itu, untuk mendokumentasikan kondisi hemarthrosis, kode diagnosis tambahan yang digunakan adalah M25.0 (*Haemarthrosis*).

3.8.14 Polyarteritis Nodosa And Vasculopathies (M30-M31)

Untuk memberikan kode yang tepat dari grup M30. (*Polyarteritis nodosa and related conditions*) atau M31. (*Other necrotizing vasculopathies*), pemberi kode harus merujuk pada diagnosis spesifik yang diberikan oleh dokter.

3.8.15 Systemic Lupus Erythematosus (M32)

- Lupus eritematosus sistemik yang diinduksi oleh obat (*drug-related systemic lupus erythematosus*), maka gunakan kode M32.0 (*Drug-induced systemic lupus erythematosus*) sebagai kode utama. Selain itu, kode tersebut harus dipadukan dengan kode penyebab eksternal untuk mengidentifikasi jenis obat yang menjadi penyebab kondisi tersebut.
- SLE dengan keterlibatan organ (SLE dengan keterlibatan organ), maka gunakan kode M32.1† (*Systemic lupus erythematosus with organ or system involvement*), yang merupakan kode dagger (kode utama). Kode ini harus diikuti oleh kode tambahan yang spesifik untuk menunjukkan organ atau sistem tubuh yang terkena dampaknya, seperti:
 - N08.5 *Glomerular disorders in systemic connective tissue disorders*
 - J99.1 *Respiratory disorders in other diffuse connective tissue disorders*
 - D59.1 *Other autoimmune haemolytic anaemia*
- SLE tanpa memberikan detail lebih lanjut, maka kode yang digunakan adalah M32.9 (*Systemic lupus erythematosus, unspecified*), yang menggambarkan SLE secara umum tanpa spesifikasi organ atau sistem yang terlibat.
- *Lupus erythematosus* atau *discoid lupus erythematosus*, jangan gunakan kode dari kelompok M32.-. Sebaliknya, gunakan kode L93.0 (*Discoid lupus erythematosus*), yang dikhususkan untuk bentuk lupus yang terbatas pada kulit (tanpa melibatkan sistemik).

3.8.16 Systemic Sclerosis (M34)

- *Progressive systemic sclerosis*, gunakan kode M34.0 (*Progressive systemic sclerosis*).
- Sindrom CR(E)ST (kondisi yang merupakan subset dari sklerosis sistemik dan melibatkan kalsinosis, fenomena Raynaud, gangguan esofagus, sklerodaktili, dan telangiectasia), gunakan kode M34.1 (*CR(E)ST syndrome*).

3.8.17 Scoliosis (M41)

Skoliosis maupun *kyphoscoliosis* (kondisi tulang belakang yang melengkung dan bengkok) menggunakan kode dari kelompok M41. (*Scoliosis*). Jika dokter mendiagnosis salah satu kondisi ini, pemberi kode harus memeriksa informasi dalam rekam medis terkait usia pasien dan lokasi kelainan pada tulang belakang untuk menentukan karakter ke-4 dan ke-5 secara tepat. Berikut merupakan contoh kasus Skoliosis dan pengodeannya:

1. Skoliosis Kongenital

- Skoliosis kongenital disebabkan oleh faktor postur tubuh (skoliosis postural) atau penyebabnya tidak diketahui, gunakan kode Q67.5 (*Congenital deformity of spine*).
- Skoliosis kongenital disebabkan oleh malformasi tulang bawaan seperti hemivertebra fusion, gunakan kode Q76.3 (*Congenital scoliosis due to congenital bony malformation*).

2. Skoliosis Idiopatik

Untuk skoliosis idiopatik, pemberi kode harus memeriksa usia pasien dan berkonsultasi dengan dokter untuk diagnosis yang lebih spesifik:

- Pasien berusia 6 bulan hingga 3 tahun, gunakan kode M41.0 (*Infantile idiopathic scoliosis*) setelah memastikan diagnosis sebagai Skoliosis Idiopatik Infantil.
- Pasien berusia 3–10 tahun, gunakan kode M41.1 (*Juvenile idiopathic scoliosis*) setelah memastikan diagnosis sebagai Skoliosis Idiopatik Remaja.
- Pasien berusia 10–25 tahun, gunakan kode M41.1 (*Juvenile idiopathic scoliosis*) setelah memastikan diagnosis sebagai Skoliosis Idiopatik Remaja.

- Pasien berusia lebih dari 25 tahun, gunakan kode M41.2 (*Other idiopathic scoliosis*) setelah memastikan diagnosis sebagai Skoliosis Idiopatik Dewasa.
3. Skoliosis Torakogenik
Skoliosis torakogenik, gunakan kode M41.3 (*Thoracogenic scoliosis*) sebagai kode utama. Jika ada penyebab penyakit yang masih relevan, tambahkan kode penyakit tersebut sebagai kode diagnosis tambahan.
 4. Skoliosis Neuromuskular
Jika kelainan tulang belakang disebabkan oleh gangguan sistem saraf dan otot yang menyeluruh, seperti *cerebral palsy*, *Friedreich's ataxia*, atau *poliomyelitis*, gunakan kode M41.4 (*Neuromuscular scoliosis*).
 5. Skoliosis Sekunder
Jika tulang belakang bengkok disebabkan oleh kelainan sistem lain selain sistem saraf dan otot, seperti perbedaan panjang kaki, dislokasi tulang belakang, herniasi diskus yang menyebabkan sciatica, atau tumor osteoid osteoma pada tulang belakang, gunakan kode M41.5 (*Other Secondary Scoliosis*).
 6. Skoliosis Degeneratif
Jika tulang belakang bengkok disebabkan oleh degenerasi tulang belakang, gunakan kode M41.8 (*Other forms of scoliosis*).
 7. Skoliosis Tidak Ditentukan
Pemberi kode harus menghindari penggunaan kode M41.9 (*Scoliosis, unspecified*). Jika ada ketidakjelasan dalam pemberian kode, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter ortopedi.
 8. Lokasi Kelainan Tulang Belakang
Kode dalam kelompok M41. Skoliosis harus selalu terdiri dari 5 karakter, di mana karakter ke-5 menunjukkan lokasi tulang belakang yang bengkok. Daftar kode karakter ke-5 dapat ditemukan dalam buku kode ICD-10 sebelum kode M40.
 9. Skoliosis Pascaprocedural

Jika tulang belakang bengkok disebabkan oleh operasi sebelumnya pada tulang belakang, gunakan kode M96.8 (*Other postprocedural musculoskeletal disorders*).

10. Skoliosis Pascaradiasi

Jika tulang belakang bengkok akibat paparan radiasi, gunakan kode M96.5 (*Postradiation scoliosis*).

Contoh 10-18	Pasien adalah seorang bayi perempuan berusia 8 bulan. Ibunya menyadari bahwa tulang belakang bagian tengah tampak melengkung tidak normal ketika bayi sedang duduk. Hasil pemeriksaan radiologi menunjukkan bahwa tulang belakang bagian tengah melengkung secara abnormal pada bidang kiri-kanan, namun tidak ditemukan kelainan pada struktur vertebra itu sendiri. Perkembangan otak anak normal dan tidak pernah mengalami cedera kepala. Awalnya dokter mendiagnosis kondisi ini sebagai <i>scoliosis of thoracic spines</i> (skoliosis tulang belakang toraks). Namun, setelah mendapat masukan dari dokter konsultan, diagnosis diubah menjadi <i>infantile scoliosis of thoracic spines</i> .	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Skoliosis infantil pada duri toraks	M41.40 <i>Infantile idiopathic scoliosis, Thoracic region</i>
Diagnosis Sekunder		

Contoh 11-18	Pasien wanita berusia 18 tahun ditemukan memiliki kelainan bentuk tulang belakang bagian tengah (toraks). Hasil pemeriksaan radiologi menunjukkan bahwa tulang belakang bagian toraks dan pinggang melengkung tidak normal pada bidang kiri-kanan. Tidak ditemukan adanya kelainan struktur pada vertebra, dan pasien tidak memiliki riwayat penyakit saraf atau otak maupun kelemahan otot. Pasien juga tidak pernah mengalami cedera kepala. Awalnya dokter mendiagnosis kondisi ini sebagai <i>scoliosis of thoracolumbar spines</i> (skoliosis tulang belakang torakolumbal). Namun, setelah mendapat masukan dari dokter konsultan, diagnosis diubah menjadi <i>adolescent scoliosis of thoracolumbar spines</i> .	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Skoliosis remaja pada tulang belakang torakolumbal	M41.15 <i>Juvenile idiopathic scoliosis, Thoracolumbar region</i>
Diagnosis Sekunder		

Contoh 12-18	Seorang pasien wanita berusia 26 tahun datang dengan nyeri punggung dan diketahui memiliki kelainan pada tulang belakang lumbar. Ada riwayat bahwa ketika saya berusia 20 tahun, saya didiagnosis menderita patah tulang belakang. Pinggang sedikit melengkung Hasil sinar X menunjukkan adanya kelengkungan tulang belakang lumbar kiri dan kanan. Tidak ditemukan kelainan pada tulang belakang. Tidak pernah memiliki penyakit otak atau kelemahan otot. Dokter mendiagnosis skoliosis pada tulang belakang lumbar. Koder meminta dokter untuk berkonsultasi. Diagnosis diubah menjadi skoliosis tulang belakang lumbar dewasa.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Skoliosis dewasa pada tulang lumbal	M41.26 <i>Other idiopathic scoliosis, Lumbar region</i>
Diagnosis Sekunder		

Contoh 13-18	Pasien wanita berusia 45 tahun mengeluhkan nyeri punggung dan ditemukan adanya kelainan bentuk tulang belakang bagian tengah (toraks). Pasien memiliki riwayat cedera akibat jatuh dari ketinggian saat berusia 38 tahun, yang menyebabkan patah tulang rusuk dan tulang belakang bagian tengah, namun tanpa disertai pergeseran tulang. Hasil pemeriksaan radiologi menunjukkan bahwa tulang belakang bagian tengah melengkung tidak normal pada bidang kiri-kanan. Tidak ditemukan adanya kelainan struktur pada vertebra, dan pasien tidak memiliki riwayat penyakit saraf, otak, maupun kelemahan otot. Dokter mendiagnosis kondisi ini sebagai <i>scoliosis of thoracic spines</i> .	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Skoliosis toraks	M41.34 <i>Thoracogenic scoliosis, Thoracic region</i>
Diagnosis Sekunder	Riwayat patah tulang rusuk dan toraks	T91.1 <i>Sequelae of fracture of spine</i>
Penyebab Eksternal		Y86 <i>Sequelae of other accidents</i>

Contoh 14-18	Pasien wanita berusia 14 tahun ditemukan memiliki kelainan bentuk tulang belakang bagian pinggang. Hasil pemeriksaan radiologi menunjukkan bahwa tulang belakang bagian pinggang melengkung tidak normal pada bidang kiri-kanan. Tidak ditemukan adanya kelainan struktur pada vertebra, namun terdapat perbedaan panjang kaki, di mana kaki kiri lebih pendek dan lebih kecil dibandingkan kaki kanan, serta otot gluteal di sisi kiri juga lebih kecil. Dokter mendiagnosis kondisi ini sebagai scoliosis of lumbar spines, sequelae of poliomyelitis.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Skoliosis lumbal	M41.46 <i>Neuromuscular scoliosis, Lumbar region</i>
Diagnosis Sekunder	Gejala sisa poliomyelitis	B91 <i>Sequelae of poliomyelitis</i>

Contoh 15-18	Pasien wanita berusia 21 tahun ditemukan memiliki kelainan bentuk tulang belakang bagian pinggang. Hasil pemeriksaan radiologi menunjukkan bahwa tulang belakang bagian pinggang melengkung tidak normal pada bidang kiri-kanan. Tidak ditemukan adanya kelainan struktur pada vertebra, namun terdapat perbedaan panjang kaki, di mana kaki kiri lebih pendek dibandingkan kaki kanan akibat cedera yang dialami saat masih kecil. Otot gluteal di sisi kiri dalam kondisi normal. Dokter mendiagnosis kondisi ini sebagai scoliosis of lumbar spines, LLD (<i>limb length discrepancy</i>).	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Skoliosis lumbal	M41.56 <i>Other secondary scoliosis, Lumbar region</i>
Diagnosis Sekunder	Perbedaan panjang tungkai	M21.76 <i>Unequal limb length (acquired), lower leg</i>

Contoh 16-18	Pasien pria berusia 71 tahun ditemukan memiliki kelainan bentuk tulang belakang bagian pinggang. Hasil pemeriksaan radiologi menunjukkan bahwa tulang belakang bagian pinggang melengkung tidak normal pada bidang kiri-kanan. Ditemukan adanya kelainan struktur pada vertebra, dengan kondisi vertebra yang mengalami pengapuran (osteofit) serta ruang antarvertebra yang menyempit. Dokter mendiagnosis kondisi ini sebagai <i>degenerative scoliosis of lumbar spines</i> .	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode

Diagnosis Primer	Skoliosis degeneratif duri lumbal	M41.86 <i>Other forms of scoliosis, Lumbar region</i>
Diagnosis Sekunder	Spondylosis daerah lumbal	M47.86 <i>Other spondylosis, Lumbar region</i>

3.8.18 Spondylolisthesis (M43.1, Q76.2)

- Jika pasien berusia 40 tahun ke atas didiagnosis *spondylolisthesis*, gunakan kode M43.1 (*Spondylolisthesis*) dengan menambahkan karakter kelima sesuai level tulang belakang yang mengalami patologi. Daftar karakter kelima untuk kode ini dapat ditemukan dalam buku ICD-10 sebelum kode M40.-.
- Jika pasien berusia 40 tahun ke atas dan didiagnosis *spondyloptosis* yang tidak disebabkan oleh kecelakaan, tetap gunakan kode M43.1 (*Spondylolisthesis*) dengan karakter kelima yang sesuai berdasarkan level tulang belakang yang terkena.
- Jika pasien berusia kurang dari 40 tahun dan didiagnosis *spondylolisthesis*, pemberi kode harus berkonsultasi dengan dokter untuk menentukan penyebab kondisi tersebut:
 - Jika kondisinya bawaan (*congenital*), gunakan kode Q76.20 (*Congenital spondylolisthesis*).
 - Jika *isthmic spondylolisthesis*, gunakan kode Q76.20 (*Congenital spondylolisthesis*), karena kondisi ini juga dianggap bawaan.

Untuk kasus *spondylolysis*:

 - Jika *spondylolysis* atau *acquired spondylolysis*, gunakan kode M43.0 (*Spondylolysis*).
 - Jika diagnosis jelas menyebutkan *congenital spondylolysis*, gunakan kode Q76.21 (*Congenital spondylolysis*).
- *Traumatic spondylolisthesis* pada level lumbar atau sakral, dan ada riwayat trauma yang terkait dengan kejadian tersebut, kondisi ini harus dikodekan sebagai cedera, gunakan kode S33.1 (*Dislocation of lumbar vertebra*), serta tambahkan kode penyebab eksternal yang relevan untuk mendokumentasikan penyebab cedera tersebut.

Contoh 17-18	Pasien perempuan, usia 20 tahun, atlet senam, datang dengan keluhan nyeri punggung bawah kronis yang hari ini memberat setelah mengikuti kompetisi. Tidak ada gejala kesemutan atau nyeri menjalar ke kedua kaki. Hasil radiologi menunjukkan pergeseran (spondylolisthesis) vertebra lumbal level 4 ke arah depan sekitar 25% dibandingkan vertebra level 5.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Spondylolisthesis kongenital	Q76.20 <i>Congenital spondylolisthesis</i>
Diagnosis Sekunder		

Contoh 18-18	Pasien laki-laki, usia 51 tahun, pekerja konstruksi, datang dengan keluhan nyeri punggung kronis yang hari ini bertambah berat setelah bekerja. Gejala disertai kesemutan dan nyeri menjalar ke kedua kaki, serta pengecilan (atrofi) pada kedua kaki. Riwayat jatuh dari scaffolding 15 tahun sebelumnya.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Spondylolisthesis lumbal kelas 2	M43.16 <i>Spondylolisthesis, lumbal region</i>
Diagnosis Sekunder		

3.8.19 Spondylosis (M47)

- Sindrom kompresi arteri tulang belakang dan tulang belakang anterior, gunakan kode M47.0† (*Anterior spinal and vertebral artery compression syndromes*) dengan digit kelima yang sesuai berdasarkan lokasi tulang belakang yang mengalami patologi, serta gabungkan dengan kode G99.2* (*Myelopathy in diseases classified elsewhere*).
- *Spondylosis with myelopathy*, gunakan kode M47.1† (*Other spondylosis with myelopathy*) dengan digit kelima berdasarkan lokasi tulang belakang yang terkena, serta kombinasikan dengan kode G99.2* (*Myelopathy in diseases classified elsewhere*). Misalnya, jika diagnosisnya adalah *cervical spondylotic myelopathy* (CSM), maka berikan kode M47.12† bersama dengan G99.2*.

- *Spondylosis with radiculopathy* atau *OA spine with radiculopathy*, gunakan kode M47.2 (*Other spondylosis with radiculopathy*) dengan digit kelima yang sesuai berdasarkan lokasi tulang belakang yang mengalami patologi.
- *Spondylosis* atau *OA spine* tanpa spesifikasi lebih dan tidak ditemukan bukti adanya penekanan pada lanjut sumsum tulang belakang atau akar saraf, gunakan kode M47.8 (*Other spondylosis*) dengan digit kelima berdasarkan lokasi patologi.

Penting untuk diingat bahwa kode M47.9 *Spondylosis, unspecified* tidak boleh digunakan, karena dokter seharusnya dapat dengan mudah menentukan adanya penekanan serta lokasi patologi. Jika dokter tidak mencantumkan detail yang cukup, pemberi kode harus berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan informasi lebih rinci sebelum memberikan kode.

Contoh 19-18	Pasien laki-laki, usia 60 tahun, datang dengan keluhan kesulitan berjalan (ataksia), mudah jatuh, sulit mengambil benda, dan kadang-kadang mengalami nyeri menjalar ke lengan kiri serta mati rasa di punggung tangan kiri. Hasil radiografi menunjukkan penyempitan ruang anterior antara tulang leher bagian ke5 dan ke6. Dokter mendiagnosis kondisi ini sebagai cervical 56 spondylotic myelopathy.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Myelopati spondylotic serviks 56	M47.12† <i>Other spondylosis with myelopathy, Cervical region</i>
Diagnosis Sekunder		G99.2* <i>Myelopathy in diseases classified elsewhere</i>

Contoh 20-18	Pasien laki-laki, usia 45 tahun, datang dengan keluhan nyeri menjalar ke lengan kiri hampir sepanjang waktu dan mati rasa di area punggung tangan kiri. Tidak ditemukan gejala kesulitan berjalan (ataksia) atau refleks abnormal. Hasil radiografi menunjukkan penyempitan ruang anterior antara tulang leher bagian ke4, ke5, dan ke6. Dokter mendiagnosis kondisi ini sebagai cervical 456 spondylotic radiculopathy.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Radikulopati spondylotik serviks 456	M47.22 <i>Other spondylosis with radiculopathy, Cervical region</i>

Diagnosis Sekunder		
--------------------	--	--

3.8.20 Intervertebral Disc Disorders (M50-M51)

Dalam pemberian kode untuk gangguan disc, tidak boleh ada riwayat cedera akut.

- Jika dokter mencatat adanya cedera akut dan mendiagnosis *herniated nucleus pulposus* (HNP) , terjadi tanpa adanya trauma akut, maka kode dari kategori M50-M51 dapat digunakan.
- Jika terdapat cedera akut yang secara langsung menyebabkan HNP, maka kondisi tersebut harus dikodekan sebagai cedera akut dalam Bab XIX (*Injury, Poisoning, and Certain Other Consequences of External Causes*).
- Jika terdapat cedera akut tetapi cedera tersebut tidak secara langsung menyebabkan HNP, maka kode dari kategori M50-M51 tetap dapat digunakan.
 - *Cervical disc disorder with myelopathy*, kode utama yang digunakan adalah M50.0† (*Cervical disc disorder with myelopathy*), dengan kode tambahan G99.2* (*Myelopathy in diseases classified elsewhere*).
 - *Cervical disc disorder with radiculopathy* merupakan kondisi umum yang sering memerlukan rawat inap atau operasi, tetapi sering terjadi ketidakkonsistenan dalam pencatatan diagnosis di rekam medis. Dokter kerap hanya mencantumkan diagnosis "HNP" (*herniated nucleus pulposus*) tanpa menyebut lokasi spesifik atau menyatakan adanya radiculopathy. Oleh karena itu, pengode perlu memeriksa rekam medis untuk memastikan apakah ada informasi tentang lokasi patologi (misalnya, C5/6) dan bukti penekanan saraf seperti gejala kesemutan atau kelemahan otot. Jika ditemukan data pendukung, pengode harus berkonsultasi dengan dokter untuk mengubah diagnosis menjadi *cervical disc disorder with radiculopathy* dengan kode M50.1 (*Cervical disc disorder with radiculopathy*).
 - Jika dokter mendiagnosis *disc displacement* berdasarkan pemeriksaan myelogram, CT myelogram, atau MRI , tetapi hanya mencatat "HNP" disertai lokasi disc yang bergeser (misal: HNP C5/6), pengode harus

berkonsultasi dengan dokter untuk mengubah diagnosis menjadi cervical disc displacement C5/6 dengan kode M50.2 (*Other cervical disc displacement*).

- Jika diagnosis adalah *cervical disc degeneration*, gunakan kode M50.3 (*Other cervical disc degeneration*). Hindari menggunakan kode M50.8 (*Other cervical disc disorder*) karena kode lain yang lebih spesifik sudah tersedia.
- Jika diagnosis awal hanya "HNP" dan setelah konsultasi dengan dokter hanya diperoleh diagnosis *cervical disc disorder* tanpa spesifikasi jenis gangguan, gunakan kode M50.9 (*Cervical disc disorder, unspecified*)
- Berikan kode diagnosis untuk pasien dengan gangguan discus intervertebralis lumbal (*lumbar disc disorder*) berdasarkan tipe penekanan pada sistem saraf sebagai berikut:
 - *Lumbar and other intervertebral disc disorders with myelopathy*, berikan kode M51.0†
 - Gangguan discus intervertebralis lumbal dan lainnya dengan myelopathy merupakan diagnosis utama, dan berikan kode G99.2* (*Myelopathy in diseases classified elsewhere*) sebagai diagnosis tambahan.
 - *Lumbar disc disorder with radiculopathy*. Ini mengacu pada kondisi discus intervertebralis lumbal yang menekan akar saraf, yang menjadi indikasi umum untuk operasi disketomi. Namun, sering ditemukan ketidakakuratan dalam pencatatan diagnosis di rekam medis. Dokter biasanya hanya mencatat "HNP" tanpa menyebutkan lokasi tertentu atau tanpa menunjukkan adanya radiculopathy. Pengode harus memeriksa informasi yang dicatat dalam rekam medis apakah terdapat spesifikasi lokasi patologi atau data pendukung yang menunjukkan adanya penekanan akar saraf, seperti catatan bahwa pasien mengalami kesemutan atau kelemahan otot, atau hasil positif dari SLRT (*straight leg raising test*). Jika informasi ini ditemukan, pengode harus berkonsultasi dengan dokter untuk mempertimbangkan perubahan diagnosis menjadi lumbar disc disorder with radiculopathy sehingga

dapat diberikan kode M51.1† (*Lumbar and other intervertebral disc disorders with radiculopathy*) sebagai diagnosis utama, dan kode G55.1* (*Nerve root and plexus compressions in intervertebral disc disorders*) sebagai diagnosis tambahan.

- Dokter mendiagnosis disc displacement berdasarkan pemeriksaan menggunakan myelogram atau CT myelogram atau MRI, namun sering kali mencatat diagnosis hanya sebagai HNP dan menyebutkan posisi disc yang bergeser, seperti HNP L4/5. Dalam kasus ini, pemberi kode harus berkonsultasi dengan dokter untuk meminta mencatat diagnosis sebagai lumbar disc displacement L4/5 dan memberikan kode M51.2 (*Other specified intervertebral disc displacement*).
- Degenerasi disc lumbal atau torakal, gunakan kode M51.3 (*Other specified intervertebral disc degeneration*), dan jika dokter mendiagnosis bahwa kondisi tersebut ditemukan bersamaan dengan *spondylosis*, tambahkan kode dari kelompok M47. (*Spondylosis*) sebagai diagnosis tambahan.
- *Schmorl's nodes* pada tulang belakang torakal atau lumbal, gunakan kode M51.4 (*Schmorl's nodes*).
- Jika dokter mendiagnosis *lumbar disc disorder with cauda equina syndrome*, pahami bahwa ini mengacu pada *lumbar disc displacement* yang disertai dengan *cauda equina syndrome*, maka gunakan kode M51.2 (*Other specified intervertebral disc displacement*) sebagai diagnosis utama, dan berikan kode G83.4 (*Cauda equina syndrome*) sebagai diagnosis tambahan.
- Tidak disarankan untuk menggunakan kode M51.8 *Other specified intervertebral disc disorders* karena sudah terdapat kode-kode di atas yang lebih sesuai.
- Kode M51.9 (*Intervertebral disc disorder, unspecified*) hanya digunakan dalam kasus di mana dokter mencatat diagnosis sebagai HNP dan tidak dapat menemukan informasi mengenai posisi serta jenis patologi tersebut.

Contoh 21-18	Pasien pria usia 55 tahun, telah menderita sakit punggung kronis selama 2 tahun. Hari ini saya sangat kesakitan, dan saya kesakitan hampir sepanjang waktu. Radikulopati L5 terdeteksi, tidak ada gaya berjalan terhuyung-huyung, tidak ada refleks abnormal, radiografi menunjukkan bahwa ruang anterior antara vertebra L4/5 lebih sempit dari biasanya, dan tulang belakang lumbal pada tingkat L4L5 memiliki pertumbuhan tulang. Dokter mendiagnosis radikulopati cakram lumbal L4/5 dan lumbal Spondylosis.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Radikulopati cakram lumbal L4/5	M51.1† <i>Lumbar and other intervertebral disc disorders with radiculopathy</i>
Diagnosis Sekunder	Spondylosis lumbal	G55.1* <i>Nerve root and plexus compressions in intervertebral disc disorders</i> M47.26 <i>Other spondylosis with radiculopathy, lumbar region</i>

3.8.21 Spine Fusion And Instrumentation

Dalam prakteknya, prosedur operasi ini sering kali tidak tercatat secara lengkap atau sesuai standar dalam resume medis (ringkasan pulang). , tetapi lebih sering menggunakan istilah singkat atau singkatan yang tidak universal, seperti "PDS L2S1 with PLF", tanpa menyertakan detail informasi tambahan yang diperlukan untuk pengodean. Pengode harus aktif mencari informasi tambahan dan berkonsultasi dengan dokter untuk meminta pencatatan operasi yang lebih detail agar dapat memberikan kode yang akurat dan lengkap.

Kode prosedur utama terdapat dalam kelompok 81.0 (*Spinal fusion*). Pengode harus mengetahui bagian tulang belakang yang dioperasi (misalnya: *atlasaxis, cervical, thoracic, lumbar, atau sacral*) serta pendekatan yang digunakan (*anterior* atau *posterior*) untuk memilih kode 4 digit yang sesuai. Untuk pengodean kelompok 81.0 (*Spinal fusion*) dalam ICD 9 IM, 4 kode tambahan wajib ditambahkan jika prosedur berikut dilakukan dalam satu kali operasi:

- Kode 84.51 (*Insertion of interbody spinal fusion device*), merujuk pada pemasangan alat di antara *body* tulang belakang. Dokter biasanya menyebutkan pemasangan alat pada tingkat discus tertentu untuk

menyangga bagian anterior tulang belakang dan memfasilitasi fusi. Alat ini meliputi: *Cage* (logam berulir atau polimer dengan ruang untuk bone graft). *Spacer* (alat biodegradable yang dapat diisi bone graft). *Threaded bone dowels* (allograft yang dibentuk menjadi silinder). Kode ini hanya berlaku untuk alat pabrik. Jika dokter menggunakan tulang iliac pasien yang dimodifikasi menjadi batang pengganti, kode 84.51 tidak dapat digunakan.

- Kode 84.52 (*Insertion of recombinant bone morphogenetic protein*), merujuk pada penggunaan zat penunjang fusi tulang berupa *recombinant bone morphogenetic protein* (BMP).
- Kode 81.62–81.64 (*Total number of vertebrae fused*), menunjukkan jumlah level tulang belakang yang menjalani fusi, sesuai catatan dokter.
- Kode 77.70–77.79 (*Excision of bone for graft*), merujuk pada pengambilan tulang dari bagian tubuh lain untuk cangkok dalam prosedur fusi spinal. Jika tidak dilakukan atau digunakan tulang sintetis, kode ini tidak diberikan.

Jika dokter tidak mencantumkan 4 informasi tambahan yang diperlukan untuk pengodean dalam *resume medis (ringkasan pulang)*, pengode harus mencari data dari *operative note* atau dokumen ruang operasi, lalu meminta dokter untuk melengkapi catatan secara detail agar semua kode dapat ditetapkan. Jika informasi tetap tidak ditemukan, pengode wajib berkonsultasi dengan dokter.

Pembedahan pemasangan logam penyangga tulang belakang yang dilakukan bersamaan dengan *spinal fusion* dianggap sebagai prosedur sekunder. Pengodean untuk prosedur ini boleh dicantumkan atau tidak, tergantung kebijakan internal.

Pengode harus membedakan dengan jelas antara:

- Operasi pertama kali (menggunakan kode 81.0 *Spinal fusion*)
- Operasi ulangan di area yang pernah dioperasi sebelumnya (menggunakan kode 81.3 *Refusion of spine*). Jika dokter tidak mencatat di *resume medis (ringkasan pulang)* bahwa ini adalah operasi keberapa, pengode harus menelusuri informasi dari catatan penerimaan pasien (*admission note*).

Contoh 22-18	Seorang pasien perempuan berusia 45 tahun dengan skoliosis remaja menjalani operasi koreksi, fiksasi sekrup pedikular, dan fusi posterior. Jumlah vertebra yang akan difusi tidak ditentukan. Namun, catatan operasi menunjukkan bahwa operasi dilakukan pada level T2-L1. Catatan operasi menunjukkan bahwa cangkok tulang dari ilium kanan digunakan. Pembuat kode meminta dokter untuk meninjau ringkasan tersebut secara lebih rinci.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Operasi Primer	Fiksasi sekrup pedikular dan fusi posterior	81.05 <i>Dorsal and dorsolumbar fusion, posterior technique</i>
Operasi Sekunder	-	77.79 <i>Excision of bone for graft, other</i> 81.64 <i>Fusion or refusion of 9 or more vertebrae</i>

Contoh 23-18	Pasien perempuan, usia 70 tahun, didiagnosis oleh dokter mengalami spinal stenosis dan telah menjalani operasi pertama dengan metode posterior decompression and fusion and fixation with pedicular screw di tingkat L3-S1. Setelah operasi, gejala pasien sembuh sepenuhnya.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Operasi Primer	Dekompresi posterior	03.09 <i>Other exploration and decompression of spinal canal</i>
Operasi Sekunder	Fusi dan fiksasi dengan sekrup pedikular L3-S1	81.08 <i>Lumbar and lumbosacral fusion, posterior technique</i> 81.63 <i>Fusion or refusion of 4- 8 vertebrae</i>

Contoh 24-18	Pasien yang sama, 3 tahun kemudian, mengalami mati rasa serupa lagi. Pasien didiagnosis dengan degenerasi diskus L1-2, L2-3 dan menjalani operasi kedua dengan pelepasan fiksasi sebelumnya, fusi posterior, dan revisi fiksasi dengan sekrup pedikular T10-L3. Catatan operasional mencatat bahwa pengganti tulang telah ditambahkan hidroksiapatit, tidak ada cangkok tulang, tidak ada alat fusi tulang belakang interbody.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Operasi Primer	Fusi posterior dan revisi fiksasi dengan sekrup pedikular T10-L3	81.05 <i>Dorsal and dorsolumbar fusion, posterior technique</i>
Operasi Sekunder	Penghapusan fiksasi sebelumnya	81.63 <i>Fusion or refusion of 4- 8 vertebrae</i> 78.69 <i>Removal of implanted devices from bone, other</i>

Contoh 25-18	Pasien laki-laki, usia 40 tahun, didiagnosis dengan cervical spondylotic myelopathy C5-6, C6-7. Dalam catatan operasi disebutkan telah dilakukan operasi C5-6, C6-7 disektomi dengan cangkok tulang iliac strut di C5-6, C6-7 disc dan fiksasi internal menggunakan pelat anterior yang mengunci. Pemberi kode harus menafsirkan bahwa ini adalah operasi fusi servikal 2 tingkat melalui pendekatan anterior, dengan pengambilan cangkok dari ilium, fiksasi tulang menggunakan pelat anterior, tanpa penggunaan bahan BMP, dan tanpa pemasangan alat interbody spinal fusion.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Operasi Primer	Fusi serviks anterior	81.02 <i>Other cervical fusion, anterior technique</i>
Operasi Sekunder	Cangkok tulang dari ilium	77.79 <i>Excision of bone for graft, other</i> 81.62 <i>Fusion or refusion of 2-3 vertebrae</i>

3.8.22 Spontaneous Fracture (M48.4, M48.5, M80, M84.3, M84.4)

Fraktur spontan umumnya terjadi akibat penyakit tulang. Pemberi kode harus merujuk pada catatan medis untuk menemukan penyebab yang mendasari:

- Fraktur terjadi pada pasien dengan osteoporosis, gunakan kode M80.- (*Osteoporosis with pathological fracture*). Digit ke-5 dari kode M80 menunjukkan lokasi fraktur (lihat daftar di awal Bab 13 ICD-10-CM).

- Fraktur disebabkan oleh penyakit lain (misalnya *Paget's disease*), gunakan kode M84.4 (*Pathological fracture, not elsewhere classified*) sebagai diagnosis utama, dengan digit ke-5 sesuai lokasi fraktur. Tambahkan kode penyakit yang mendasari (misalnya M88.8 *Paget's disease of other bones*).
- Fraktur tulang belakang tidak diketahui penyebabnya (hanya dicatat sebagai *collapsed fracture of spine*), gunakan kode M48.5 (*Collapsed vertebra, not elsewhere classified*).
- Jika diagnosis jelas sebagai *stress fracture* atau *fatigue fracture*
 - Tulang belakang, gunakan kode M48.4 (*Fatigue fracture of vertebra*).
 - Tulang lain, gunakan kode M84.3 (*Stress fracture, not elsewhere classified*).
- Jika episode perawatan untuk malunion, maka dikode M84.0- (*Malunion of fracture*) dan kode diagnosis fraktur tidak dikode

3.8.23 Fracture In Neoplastic Disease (M49.5, M90.7)

Jika dokter mendiagnosis fraktur akibat metastasis kanker ke tulang:

- Kode utama: C79.5† (*Secondary malignant neoplasm of bone and bone marrow*).
- Kode tambahan untuk fraktur: Jika tulang belakang patah, gunakan kode M49.5* (*Collapse of vertebra in diseases classified elsewhere*), jika tulang lain patah, gunakan kode M90.7* (*Fracture of bone in neoplastic disease*).

3.8.24 Rhabdomyolysis (M62.8)

Jika dokter mendiagnosis *rhabdomyolysis*, kode utama yang digunakan adalah M62.8 (*Other specified disorders of muscle*). Selain itu, pengode harus menambahkan kode untuk kondisi terkait, seperti gagal ginjal akut, jika ditemukan dalam dokumentasi medis. Jika penyebab eksternal (misalnya obat atau faktor lain) diketahui sebagai pemicu *rhabdomyolysis*, pengode juga harus mencantumkan kode penyebab eksternal sesuai dengan informasi yang terdokumentasi dalam rekam medis. Hal ini memastikan bahwa semua aspek diagnosis dan penyebabnya direkam secara komprehensif.

3.8.25 Radial Styloid Tenosynovitis [De Quervain] (M65.4)

Jika dokter mendiagnosis *De Quervain's tenosynovitis*, pengodean yang tepat adalah menggunakan kode M65.4 (*Radial styloid tenosynovitis [de*

Quervain]). Kode ini secara spesifik menggambarkan peradangan pada tendon di area radial styloid, yang merupakan ciri khas dari kondisi tenosinovitis *De Quervain*. Kondisi ini biasanya ditandai dengan nyeri dan pembengkakan di sekitar pergelangan tangan bagian ibu jari, terutama saat melakukan gerakan yang melibatkan ekstensi atau abduksi ibu jari.

3.8.26 Necrotizing Fasciitis (M72.6)

Jika dokter mendiagnosis *necrotizing fasciitis*, kode yang harus digunakan adalah M72.6 (*Necrotizing fasciitis*). Tidak perlu menambahkan kode tambahan untuk radang kulit (misalnya selulitis atau erisipelas) karena kondisi ini sudah mencakup cakupan diagnosis yang lebih spesifik. Namun, jika patogen penyebab (seperti bakteri atau jamur) telah diidentifikasi dalam dokumentasi medis, pengode harus mencantumkan kode penyebab eksternal atau kode infeksi yang relevan sesuai dengan pedoman ICD-10. Hal ini memastikan bahwa sumber infeksi dan kondisi utama tercatat secara akurat.

3.8.27 Fibromyalgia (M79.7)

Jika dokter mendiagnosis *fibromyalgia*, kode diagnosis yang digunakan adalah M79.7 (*Fibromyalgia*). Kode ini mencerminkan kondisi nyeri kronis yang menyebar pada otot dan jaringan lunak, sesuai dengan kriteria diagnosis yang telah ditetapkan. Tidak diperlukan kode tambahan kecuali ada komorbiditas atau kondisi terkait lainnya yang terdokumentasi dalam rekam medis. Pastikan diagnosis fibromyalgia telah dikonfirmasi oleh dokter berdasarkan gejala klinis dan pemeriksaan yang relevan.

3.8.28 Myofascial Pain Syndrome (M79.8)

Ketika dokter mendiagnosis sindrom nyeri myofascial, kode yang digunakan adalah M79.8 (*Other specified soft tissue disorders*). Kode ini mencakup kondisi nyeri kronis yang berhubungan dengan otot dan fascia, sering kali disertai dengan adanya *trigger points* (titik nyeri yang sensitif). Pastikan diagnosis telah dikonfirmasi oleh dokter melalui evaluasi klinis dan dokumentasi yang relevan.

3.8.29 Osteoporosis (M80-M82)

- Kode diagnosis osteoporosis dalam ICD-10 CM:
 - M80.- (*Osteoporosis with pathological fracture*), digunakan jika terjadi fraktur patologis (tanpa sebab eksternal) atau fraktur tulang belakang berbentuk baji akibat osteoporosis. Kode utama sesuai lokasi fraktur, dengan M80.- sebagai kode tambahan. Digit ke-5 kode M80 menunjukkan lokasi osteoporosis (lihat daftar di awal Bab 13 ICD-10 CM).
 - M81.- (*Osteoporosis without pathological fracture*), digunakan jika tidak ada fraktur patologis. Digit ke-5 kode M81 menunjukkan lokasi osteoporosis.
 - M82.- (*Osteoporosis in diseases classified elsewhere*). Kode ini digunakan jika osteoporosis terkait penyakit lain (misalnya *multiple myeloma* atau gangguan endokrin). Digit ke-5 kode M82 merujuk ke lokasi osteoporosis.
- Jika dokter mendiagnosis osteopaenia, yang merupakan diagnosis dari radiograf, kodenya didasarkan pada lokasi di mana ia terdeteksi, yaitu:
 - R93.6 (*Abnormal findings on diagnostic imaging of limbs*)
 - R93.7 (*Abnormal findings on diagnostic imaging of other parts of musculoskeletal system*)

3.8.30 Nonunion Of Fracture [Pseudarthrosis] (M84.1, M96.0)

- Nonunion terjadi pada fraktur yang tidak ditangani atau setelah perawatan tertutup (misalnya *closed reduction*), gunakan kode M84.1 (*Nonunion of fracture [pseudarthrosis]*). Tambahkan digit ke-5 kode M84.1 untuk menunjukkan lokasi fraktur (lihat daftar di awal Bab 13 ICD-10 CM).
- Nonunion terjadi setelah operasi (fusi, artrodesis, atau implan ortopedi), gunakan kode M96.0 (*Pseudarthrosis after fusion or arthrodesis*).

3.8.31 Periprosthetic Fracture (M96.6)

Jika fraktur terjadi setelah pemasangan prostesis atau implan ortopedi, gunakan kode M96.6 (*Fracture of bone following insertion of orthopaedic*

implant, joint prosthesis, or bone plate). Fraktur yang terjadi di sekitar implan prostetik (misalnya sendi buatan).

DRAFT V1

3.9 MDC 19 KULIT DAN SUBKUTAN

PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 19

- Kasus *decubitus ulcer* L89 yang disebabkan oleh DM Type II diberikan kode E11.5 (*Non-insulin-dependent diabetes mellitus, With peripheral circulatory complications*).
- Ulkus dekubitus yang tidak disebabkan oleh diabetes mellitus maka menggunakan kode L89.
- Pada kasus pasien dengan abses L02.4 (*Cutaneous abscess, furuncle and carbuncle of limb*):
 - Jika dilakukan insisi pada abses tersebut, gunakan kode 86.04 (*Other incision with drainage of skin and subcutaneous tissue*).
 - Jika eksisi dilakukan untuk mengambil jaringan, gunakan kode 86.3 (*Other local excision or destruction of lesion or tissue of skin and subcutaneous tissue*).
 - Jika dilakukan eksisi dan biopsi, gunakan kode 86.11 (*Biopsy of skin and subcutaneous tissue*).
 - Untuk kasus *debridemen* (membuang jaringan nekrotik), gunakan kode 86.22 (*Excisional debridement of wound, infection or burn*).
- Pada kasus pasien dengan ulkus thorax dextra, L98.4 (*Chronic ulcer of skin, not elsewhere classified*), jika pasien dilakukan debridement maka dapat diberikan kode sesuai tindakan debridement yang diberikan.
- Berikut ini adalah tindakan yang biasanya berhubungan dengan MDC 19 Kulit & Subkutan :
 1. Tindakan 86.22 (*Excisional debridement of wound, infection, or burn*) dapat dikoding jika pada laporan operasi terdapat eksisi dan *debridement* pada luka atau luka bakar.
 2. Tindakan 86.28 (*Nonexcisional debridement of wound, infection, or burn*) merupakan tindakan pembersihan jaringan mati dan luka untuk infeksi atau luka bakar.
 3. Tindakan *rehecting superficial* pada luka operasi yang belum sembuh, namun tidak membuka kembali abdomen, dikode menggunakan 86.59 (*Closure of skin and subcutaneous tissue of other sites*).
 4. Tindakan eksisi lesi dengan *flap graft*.

- a. Jika eksisi lesi radikal (*wide*) dengan *flap closure*, maka dikode 86.49 *Radical excision of skin lesion*)
- b. Jika eksisi lesi radikal dengan *graft* (mengambil jaringan dari organ/regio lain) maka dikode 86.4 ditambah dengan kode *graft* disesuaikan dengan lokasi/anatomi
- c. Jika eksisi dengan tujuan pengambilan *graft*, maka dikode *graft* saja disesuaikan dengan lokasi/anatomi

PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 19

3.9.1 Impetigo (L01.-)

- Impetigo yang terjadi pada kulit normal atau hanya menyebutkan impetigo tanpa keterangan lebih lanjut, maka gunakan kode L01.0 (*Impetigo*) . Kode ini digunakan tanpa memperhatikan lokasi tubuh dan/atau jenis bakteri penyebabnya..
- Impetigo yang merupakan komplikasi dari penyakit kulit lainnya, maka gunakan kode L01.1 (*Impetiginization of other dermatoses*)

3.9.2 Cutaneous Abscess, Furuncle, and Carbuncle (L02.-)

- *Abscess, cutaneous abscess, furuncle*, bisul, atau *carbuncle* di area wajah maka gunakan kode L02.0 (*Cutaneous abscess, furuncle and carbuncle of face*), kecuali telinga, mata, dan hidung.
- *Abscess, cutaneous abscess, furuncle*, bisul, atau *carbuncle* di area tubuh bagian tengah, termasuk dada, punggung, perut, daerah inguinal, lipatan paha, dan pusar maka gunakan kode L02.2 (*Cutaneous abscess, furuncle and carbuncle of trunk*). Pengecualian untuk lokasi tertentu di batang tubuh:
 - *Abscess* terjadi di payudara maka gunakan kode N61 (*Inflammatory disorders of breast*).
 - *Abscess* terjadi di organ genital pria maka gunakan kode N48.2 (*Other inflammatory disorders of penis*) atau kode dalam grup N49.- (*Inflammatory disorders of male genital organs, not elsewhere classified*).
 - *Abscess* terjadi di organ genital wanita maka gunakan kode N76.4 (*Abscess of vulva*).

- *Abscess* terjadi di area panggul bagian belakang dan pangkal paha maka gunakan kode L02.3 (*Cutaneous abscess, furuncle and carbuncle of buttock*).
- *Abscess, cutaneous abscess, furuncle*, bisul, atau *carbuncle* di area lengan atau kaki termasuk ketiak, pinggul, dan bahu maka gunakan kode L02.4 (*Cutaneous abscess, furuncle and carbuncle of limb*).
- *Abscess, cutaneous abscess, furuncle*, bisul, atau *carbuncle* di area kepala atau kulit kepala (bukan area wajah) maka gunakan kode L02.8 (*Cutaneous abscess, furuncle and carbuncle of other sites*).

3.9.3 Cellulitis (L03.-)

- Selulitis pada batang tubuh, termasuk dada, punggung, perut, selangkangan, lipatan paha, dan pusar, menggunakan kode L03.3 (*Cellulitis of trunk*). Namun, ada pengecualian untuk lokasi tertentu di batang tubuh:
 - Selulitis terjadi di organ genital pria maka menggunakan kode N48.2 (*Other inflammatory disorders of penis*) atau kode dalam grup N49.- (*Inflammatory disorders of male genital organs, not elsewhere classified*).
 - Selulitis terjadi di organ genital wanita maka menggunakan kode N76.4 (*Abscess of vulva*).
 - Selulitis terjadi di pusar bayi baru lahir maka menggunakan kode P38 (*Omphalitis of newborn with or without mild haemorrhage*).
- Pada kasus diagnosis limfangitis akut yang merupakan peradangan akut pada pembuluh limfatik. Hal ini dianggap setara dengan selulitis maka menggunakan kode yang sama sesuai dengan lokasi terjadinya limfangitis.

3.9.8 Pemphigoid (L12.-)

- *Pemphigoid* maka menggunakan kode dalam grup L12.- (*Pemphigoid*) sesuai dengan jenis *pemphigoid* yang disebutkan oleh dokter.
- *Pemphigoid gestationis* maka menggunakan kode O26.4 (*Herpes gestationis*).

3.9.9 Atopic Dermatitis (L20.-)

- *Classical atopic dermatitis* maka menggunakan kode L20.0 (*Besnier's prurigo*).
- *Flexural atopic dermatitis* atau *infantile atopic dermatitis* maka menggunakan kode L20.8 (*Other atopic dermatitis*).
- *Atopic dermatitis* tanpa menyebutkan jenis spesifik (*unspecified*) maka menggunakan kode L20.9 (*Atopic dermatitis, unspecified*).

3.9.12 Irritant Contact Dermatitis (L24.-)

- Dermatitis kontak iritan akibat reaksi alergi (*allergic reaction*) yang disebabkan oleh obat maka menggunakan kode T88.7 (*Unspecified adverse effect of drugs or medicaments*) serta menambahkan kode penyebab eksternal sesuai jenis obat yang disebutkan dokter.
- *Paederus dermatitis* maka menggunakan kode L24.81 (*Paederus dermatitis*)^(IM).

3.9.13 Dermatitis due to Substances Taken Internally (L27.-)

- Ruam kulit akibat konsumsi obat, baik disebutkan sebagai *generalized skin eruption* atau hanya sebagai *skin eruption* saja maka menggunakan kode L27.0 (*Generalized skin eruption due to drugs and medicaments*) serta menambahkan kode penyebab eksternal sesuai jenis obat yang disebutkan.
- *Localized skin eruption* akibat konsumsi obat maka menggunakan kode L27.19 (*Localized skin eruption due to drugs and medicaments, unspecified*)^(IM) serta menambahkan kode penyebab eksternal sesuai jenis obat yang disebutkan.
- *Fixed drug eruption* maka menggunakan kode L27.10 (*Fixed drug eruption (IM)*) serta menambahkan kode penyebab eksternal sesuai jenis obat yang disebutkan.
- Dermatitis akibat makanan yang dimakan, gunakan kode L27.2 (*Dermatitis due to ingested food*). Terdapat *excludes* pada sub-bab ini untuk kasus dermatitis akibat makanan yang kontak langsung dengan kulit, maka menggunakan kode L23.6, L24.6, atau L25.4 (sesuai dengan diagnosis yang diberikan oleh dokter).

3.9.14 Psoriasis (L40.-)

Menggunakan kode dalam grup L40.- *Psoriasis*, sesuai diagnosis dokter.

- *Arthropathic psoriasis* menggunakan kode L40.5† (*Arthropathic psoriasis*) sebagai kode utama dan tambahkan salah satu dari kode berikut sebagai kode tambahan sesuai jenis artritis yang disebutkan oleh dokter, yaitu M07.0* (*Distal interphalangeal psoriatic arthropathy*), M07.1* (*Arthritis mutilans*), M07.2* (*Psoriatic spondylitis*), atau M09.0* (*Juvenile arthritis psoriasis*).
- *Arthropathic psoriasis* tanpa spesifikasi jenis artritis maka menggunakan kode L40.5† (*Arthropathic psoriasis*) sebagai kode utama dan tambahkan kode M07.3* (*Other psoriatic arthropathies*) sebagai kode tambahan.

Catatan: Untuk pengodean dalam grup M07.- dan M09.-, pastikan tidak melupakan kode utama L40.5† untuk menunjukkan lokasi penyakit yang relevan.

3.9.15 Lichen Planus (L43.-)

Gunakan kode dalam grup L43.- *Lichen Planus*, sesuai jenis kondisi yang didiagnosis oleh dokter.

- *Lichenoid drug reaction* atau *drug-induced lichen planus* maka menggunakan kode L43.2 (*Lichenoid drug reaction*) serta menambahkan kode penyebab eksternal sesuai jenis obat yang disebutkan oleh dokter.
- *Lichen planus aktinik*, *lichen planus tropikus*, atau *actinic lichen planus* maka menggunakan kode L43.3 (*Subacute (active) lichen planus*).
- *Lichen planus* jenis popular, atrofik, erosif, plak, atau retikular maka menggunakan kode L43.8 (*Other lichen planus*).

3.9.16 Urticaria (L50.-)

Gunakan kode dalam grup L50.- *Urticaria*, sesuai jenis kondisi yang didiagnosis oleh dokter.

- *Allergic urticaria* atau *contact urticaria* maka menambahkan kode penyebab eksternal sesuai zat atau kondisi yang disebutkan oleh dokter.

3.9.17 Erythema Multiforme (L51.-)

Gunakan kode dalam grup L51.- *Erythema Multiforme*, sesuai jenis kondisi yang didiagnosis oleh dokter.

- *Overlapping Stevens-Johnson syndrome* dan *toxic epidermal necrolysis* maka menggunakan kode L51.8 (*Other erythema multiforme*).
- Kelainan mata pada pasien *Stevens-Johnson syndrome* dianggap sebagai manifestasi penyakit maka menggunakan kode utama L51.1† (*Bullous erythema multiforme*) serta menambahkan kode untuk kelainan mata sebagai kode tambahan.

Contoh 1-19	Dokter mata mendiagnosis bahwa pasien dengan sindrom Stevens-Johnson mengalami kondisi <i>dry eye</i> (mata kering) yang terdeteksi selama pemeriksaan.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	<i>Dry eye</i>	L51.1† <i>Bullous erythema multiforme</i>
Diagnosis Sekunder	<i>Stevens-Johnson syndrome</i>	H19.3* <i>Keratitis and keratoconjunctivitis in other diseases classified elsewhere</i>

Contoh 2-19	Dokter mata mendiagnosis bahwa pada pasien dengan sindrom Stevens-Johnson terdeteksi adanya defisiensi sel punca limbal.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	<i>Limbal stem cell deficiency</i>	L51.1† <i>Bullous erythema multiforme</i>
Diagnosis Sekunder	<i>Stevens-Johnson syndrome</i>	H18.8* <i>Other specified disorders of cornea</i>

3.9.18 Erythema Nodosum (L52)

Gunakan kode dalam grup L52 Erythema Nodosum, sesuai jenis kondisi yang didiagnosis oleh dokter.

- Eritema nodosum tanpa menyebutkan penyebabnya maka menggunakan kode L52 (*Erythema nodosum*).
- Eritema nodosum dengan disebutkan penyebab spesifiknya maka menggunakan kode penyebab tersebut sebagai kode utama dan menambahkan kode L52 (*Erythema nodosum*) sebagai kode tambahan.

Catatan: Pastikan untuk memeriksa diagnosis dokter dengan cermat untuk menentukan apakah penyebab sudah disebutkan agar pengodean tepat.

3.9.19 Other Erythematous Conditions (L53-L54)

Gunakan kode dalam grup L53-L54 *Other Erythematous Conditions*, sesuai jenis kondisi yang didiagnosis oleh dokter.

- *Granuloma annulare, erythema migrans*, atau *necrotic migratory erythema* tanpa menyebutkan penyebab maka menggunakan kode L53.3 (*Other chronic figurate erythema*).
- *Granuloma annulare, erythema migrans*, atau *necrotic migratory erythema* dengan menyebutkan penyebab maka menggunakan kode penyebab sebagai kode utama dan menambahkan kode L54.8* (*Erythema in other diseases classified elsewhere*) sebagai kode tambahan.

3.9.24 Alopecia (L63-L66)

Gunakan kode dalam grup L63-L66, sesuai jenis *alopecia* yang didiagnosis oleh dokter.

- *Scarring alopecia* maka gunakan kode L66.- (*Cicatricial alopecia*).
- *Alopecia* disebabkan oleh obat-obatan maka tambahkan kode penyebab eksternal sesuai jenis obat yang disebutkan oleh dokter.

3.9.26 Hypertrichosis (L68.-)

- *Hirsutism* dan tidak menyebutkan penyebab maka gunakan kode L68.0 (*Hirsutism*).
- *Hirsutism* disebabkan oleh obat-obatan maka tambahkan kode eksternal sesuai jenis obat penyebab.
- *Hirsutism* disebabkan oleh sindrom adrenogenital atau PCOS maka gunakan kode penyakit tersebut sebagai kode utama (tanpa perlu memberikan kode L68.0).
- *Hirsutism* disebabkan oleh tumor indung telur atau kelenjar adrenal maka gunakan kode tumor sebagai kode utama, dan tambahkan L68.0 (*Hirsutism*) sebagai kode tambahan.
- *Congenital hypertrichosis lanuginosa* maka gunakan kode Q84.2 (*Other congenital malformations of hair*).

- *Acquired hypertrichosis lanuginosa* maka gunakan kode L68.1 (*Acquired hypertrichosis lanuginosa*). Jika disebabkan oleh kanker maka gunakan kode kanker sebagai kode utama dan tambahkan kode L68.1 (*Acquired hypertrichosis lanuginosa*) sebagai kode tambahan.

3.9.28 Vitiligo and Other Disorders of Pigmentation (L80-L81)

Kode dalam kelompok L80 (*Vitiligo*) atau L81.- (*Other disorders of pigmentation*) digunakan secara selektif, sesuai diagnosis dokter berdasarkan pemeriksaan menyeluruh. Pemeriksaan ini mencakup:

- Observasi gejala klinis
- Riwayat kesehatan pasien
- Pemeriksaan penunjang seperti dermatoskopi atau biopsi kulit.

Pemilihan kode tidak hanya berfungsi untuk klasifikasi administratif, tetapi juga menjadi dasar perencanaan terapi, pemantauan progresi penyakit, dan koordinasi layanan antar tenaga medis termasuk dalam pelaporan data epidemiologi.

3.9.29 Epidermal Thickening (L82-L86)

Kode dalam kelompok L82–L86 (meliputi kondisi seperti keratosis, ulkus kulit, dan gangguan kornea) digunakan secara spesifik sesuai diagnosis klinis yang ditegakkan dokter. Diagnosis ini didasarkan pada:

- Pemeriksaan fisik menyeluruh
- Analisis gejala
- Pemeriksaan penunjang seperti biopsi atau tes laboratorium.

Pemilihan kode tidak hanya memastikan akurasi dokumentasi medis tetapi juga berperan dalam perencanaan terapi yang tepat, pemantauan progresi atau perbaikan selama pengobatan, serta koordinasi layanan kesehatan termasuk keputusan rujukan ke spesialis apabila diperlukan.

3.9.30 Transepidermal Elimination Disorders (L87)

Kode dalam kelompok L82–L86 (meliputi keratosis, ulkus kulit, dan gangguan kornea) digunakan secara spesifik berdasarkan diagnosis klinis yang ditetapkan oleh dokter. Penetapan diagnosis didukung oleh pemeriksaan mendetail, seperti:

- Observasi lesi kulit
- Analisis riwayat penyakit
- Dermatoskopi
- Biopsi jaringan
- Tes laboratorium.

Pemilihan kode ini tidak hanya memastikan keakuratan dokumentasi medis tetapi juga menjadi acuan dalam perencanaan terapi (misalnya terapi topikal, bedah eksisi, atau manajemen luka), pemantauan perkembangan kondisi, serta koordinasi antar tenaga kesehatan seperti perawat, ahli patologi, dan spesialis bedah plastik dalam kasus kompleks.

3.9.31 Pyoderma Gangrenosum (L88)

kode L88 (*Pyoderma Gangrenosum*) harus digunakan sebagai klasifikasi medis yang akurat apabila diagnosis *pyoderma gangrenosum* telah ditetapkan melalui pemeriksaan klinis yang komprehensif termasuk:

- Evaluasi lesi kulit
- Analisis riwayat penyakit,
- Pemeriksaan histopatologis
- Tes laboratorium maka

Kode ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana terapi intensif (seperti penggunaan imunosupresan, terapi biologi, atau perawatan luka spesifik) termasuk progresivitas penyakit serta mengkoordinasikan bidang multidisiplin antara dokter spesialis dermatologi, ahli bedah, dan tenaga kesehatan lain yang berguna untuk memastikan kesinambungan perawatan dan optimalisasi hasil klinis pasien.

3.9.32 Decubitus Ulcer and Pressure Area (L89)

- Kode dalam kelompok L89 (*Decubitus ulcer and pressure area*) digunakan sesuai dengan tahap keparahan yang ditetapkan oleh tim medis. Tingkat keparahan tersebut ditentukan berdasarkan evaluasi klinis komprehensif, termasuk penilaian lokasi ulkus, kedalaman luka (misalnya: tahap I hingga IV), durasi, dan faktor risiko seperti imobilitas atau malnutrisi, serta pemeriksaan penunjang seperti skala Braden atau pencitraan radiologi untuk menentukan prognosis.

- Pengecualian diberlakukan untuk ulkus dekubitus yang terjadi di serviks uteri, kondisi tersebut harus diklasifikasikan menggunakan kode N86 (*Erosion and Ectropion of Cervix Uteri*) karena perbedaan karakteristik anatomis dan patologis yang memerlukan pendekatan diagnosis dan penanganan khusus oleh dokter spesialis kebidanan dan ginekologi.
- Ulkus dekubitus (L89) yang terkait dengan diabetes melitus tipe 2 diklasifikasikan menggunakan kode E11.5 (*Non-insulin-dependent diabetes mellitus, with peripheral circulatory complications*).
- Ulkus dekubitus yang tidak disebabkan oleh diabetes melitus tetap menggunakan kode L89 (*Decubitus ulcer and pressure area*) sesuai dengan tingkat keparahan dan lokasi lesi.
- Terdapat catatan (*notes*) pada ICD-10 Tahun 2010 bahwa jika ulkus dekubitus terjadi pada lebih dari 1 tempat (*multiple sites*) dengan tahap (*stage*) yang berbeda maka hanya ditetapkan 1 kode dengan tahap tertinggi.

3.9.33 Atrophic Disorders of Skin (L90)

Kode dalam kelompok L90 (*Atrophic disorders of skin*) digunakan berdasarkan diagnosis klinis yang ditegakkan melalui evaluasi komprehensif. Evaluasi ini mencakup:

- karakteristik lesi seperti penipisan epidermis, perubahan tekstur, atau kehilangan elastisitas
- Pemeriksaan tambahan seperti dermoskopi, biopsi, atau analisis histopatologis untuk membedakan kondisi atrofik dari gangguan kulit lain.

Pemilihan kode mempertimbangkan penyebab (misalnya penuaan, inflamasi kronis, atau faktor genetik), lokasi lesi, dan tingkat keparahan. Kode ini menjadi dasar dalam perencanaan terapi spesifik (seperti terapi regenerasi kulit, manajemen inflamasi, atau intervensi bedah) serta memastikan dokumentasi medis yang akurat untuk pemantauan jangka panjang dan koordinasi layanan kesehatan.

3.9.34 Hypertrophic Scar (L91.0)

- Diagnosis parut hipertrofik atau keloid dapat menggunakan kode L91.0 (*Hypertrophic scar*) atau keloid setelah dilakukan evaluasi klinis

menyeluruh untuk memastikan karakteristik jaringan parut yang menebal dan melebihi batas luka asli atau disertai gejala seperti nyeri/kekakuan.

- *Acne keloid* (keloid yang terkait dengan peradangan jerawat kronis) maka kode yang tepat adalah L73.0 (*Acne keloid*).
- Istilah umum seperti 'parut' tanpa spesifikasi jenis atau alasannya maka kode L90.5 (*Atrophic scar*) diberlakukan sebagai klasifikasi sementara dengan catatan bahwa kode ini dapat direvisi jika informasi lebih detail tersedia melalui pemeriksaan lanjutan seperti biopsi atau dermoskopi.

3.9.35 Granulomatous Disorders (L92)

- Kode dalam kelompok L92 (*Granulomatous disorders of skin and subcutaneous tissue*) digunakan sesuai diagnosis spesifik yang ditetapkan oleh dokter, setelah melalui evaluasi klinis termasuk pemeriksaan histopatologis untuk mengidentifikasi karakteristik granuloma maka menggunakan L92.0 (*Granuloma annulare*), L92.1 (*Necrobiosis lipoidica, not elsewhere classified*), atau L92.8 (*Other granulomatous disorders of skin and subcutaneous tissue*)
- *Necrobiosis lipoidica diabetorum* (suatu kondisi yang berkaitan erat dengan diabetes mellitus) maka menggunakan kode utama E10-E14 (Diabetes mellitus) sesuai jenis diabetes yang mendasarinya disertai kode tambahan L92.8 (*Other granulomatous disorders of skin and subcutaneous tissue*) untuk menunjukkan manifestasi kulit granulomatosa. Pemilihan kode ini harus didukung oleh dokumentasi medis yang mencantumkan hubungan sebab-akibat antara diabetes dan lesi kulit, serta hasil pemeriksaan seperti biopsi atau tes metabolik untuk memastikan akurasi klasifikasi.

3.9.36 Lupus Erythematosus (L93)

Kode dalam kelompok L93 (*Lupus erythematosus*) diberikan sesuai diagnosis klinis yang ditetapkan oleh dokter melalui evaluasi komprehensif, termasuk

- Pemeriksaan gejala khas seperti lesi kulit berbentuk kupu-kupu (pada lupus sistemik) atau plak diskoid (pada lupus kutan)
- Pemeriksaan laboratorium (misal: tes ANA, anti-dsDNA)

- Biopsi kulit untuk konfirmasi histopatologis.

Pemilihan subkode L93.0 (*Discoid lupus erythematosus*) atau L93.1 (*Subacute cutaneous lupus erythematosus*) didasarkan pada:

- Karakteristik klinis
- Luasnya keterlibatan organ
- Didukung oleh dokumentasi medis yang mencantumkan hasil pemeriksaan fisik, tes serologis, dan rencana terapi (seperti penggunaan kortikosteroid, imunosupresan, atau fotoproteksi) untuk memastikan peringkat klasifikasi dan layanan kesehatan antar spesialis (misal: dokter kulit, reumatologi, atau imunologi).

3.9.37 Localized Connective Tissue Disorders (L94)

Kode dalam kelompok L94 (*Other localized connective tissue disorders*) digunakan sesuai diagnosis spesifik yang ditetapkan oleh dokter seperti L94.0 (*Localized scleroderma [morphea]*) atau L94.2 (*Calcinosis cutis*), setelah melalui evaluasi klinis menyeluruh termasuk pemeriksaan fisik, biopsi, atau tes imunologis. Namun, terdapat pengecualian dalam penggunaan kode ini, yaitu:

- Jika diagnosis kalkinosis kutis atau sklerodaktili terkait dengan sindrom CR(E)ST (kombinasi kalsinosis, fenomena Raynaud, gangguan esofagus, sklerodaktili, dan telangiectasia), maka kode yang digunakan adalah M34.1 (*CR(E)ST Syndrome*) sebagai prioritas utama, karena kondisi ini bersifat sistemik yang memerlukan penanganan multidisiplin.
- Jika diagnosis papul Gottron atau poikiloderma vaskular atrofik terkait dengan dermatomyositis, kode yang tepat adalah M33.1 (*Other dermatomyositis*), dengan catatan bahwa manifestasi kulit tersebut menjadi bagian dari penyakit sistemik yang melibatkan otot dan jaringan ikat.

Dokumentasi medis harus mencantumkan hubungan sebab-akibat antara gejala kulit, kondisi sistemik, dan hasil pemeriksaan (seperti: MRI, elektromiografi, atau tes autoantibodi) untuk memastikan akurasi pengodean dan koordinasi layanan antara dokter spesialis kulit, reumatologi, dan neurologi.

3.9.38 Vasculitis Limited to Skin (L95)

Kode dalam kelompok L95 (*Vasculitis limited to skin, not elsewhere classified*) ditentukan berdasarkan diagnosis klinis yang ditegakkan oleh dokter, setelah dilakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan bahwa peradangan pembuluh darah hanya terlokalisir di kulit (tanpa keterlibatan organ internal) dan didukung oleh pemeriksaan penunjang seperti:

- Biopsi kulit,
- Tes laboratorium (misal: analisis komplemen atau antibodi)
- Klasifikasi medis (seperti kriteria *Chapel Hill* atau *American College of Rheumatology*).

3.9.39 Ulcer of Lower Limb (L97)

- Ulkus Dekubitus (Ulkus Tekanan)

Kode L89 digunakan untuk ulkus dekubitus dengan mempertimbangkan tingkat keparahan (misal: tahap I-IV). Penentuan tahap didasarkan pada kriteria klinis seperti lokasi luka (misal: sakrum, tumit), kedalaman (dangkal hingga melibatkan jaringan tulang), dan durasi ulkus. Dokumentasi harus mencantumkan parameter ini untuk memastikan keakuratan kode.

- Gangren pada Diabetes Melitus

Jika gangren terjadi sebagai komplikasi aterosklerosis pada pasien diabetes, kode utama yang digunakan adalah E10-E14 (diabetes mellitus) dengan subkode .5 (komplikasi sirkulasi perifer). **Misalnya:** E11.5 (*Non-insulin-dependent diabetes mellitus with gangrene*). Dokter wajib mencantumkan hubungan sebab-akibat antara diabetes dan gangren dalam laporan medis untuk memperkuat kode ini.

- Gangren Non-Diabetes

Untuk gangren yang tidak terkait diabetes, kode I74.3 (*Embolism and thrombosis of arteries of lower extremities*) digunakan jika penyebabnya adalah oklusi vaskular akut, seperti emboli atau trombosis arteri. Kode ini mencerminkan patologi vaskular non-metabolik.

- Gangren Tanpa Penyebab Jelas

Jika diagnosis hanya menyebut "gangren" informasi tanpa etiologi, kode R02 *Gangrene, not elsewhere classified* dapat digunakan sebagai

klasifikasi sementara. Kode ini berlaku hingga penyebab pasti teridentifikasi melalui pemeriksaan lanjutan (misal: angiografi atau biopsi).

- Ulkus Varises (Ulkus Vena)

Ulkus yang terkait dengan insufisiensi vena dikodekan sebagai I83.0 (*Varicose veins of lower extremities with ulcer*) atau I83.2 (*Varicose veins of lower extremities with both ulcer and inflammation*). Pemilihan subkode didasarkan pada adanya tanda peradangan seperti eritema, edema, atau eksudat.

- Ulkus Kaki Non Spesifik

Jika ulkus kaki tidak dapat dikaitkan dengan diabetes, vena, atau arteri (misal: etiologi traumatis atau nekrosis idiopatik), gunakan kode L97 (*Ulcer of lower limb, not elsewhere classified*). Kode ini menunjukkan ketidakjelasan penyebab dan memerlukan evaluasi lebih lanjut.

- Ulkus Kronis Non Spesifik

Untuk ulkus kronis yang tidak memenuhi kriteria kode lain (misal: ulkus karena dermatitis kronis atau autoimun), kode L98.4 (*Chronic ulcer of skin, not elsewhere classified*) menjadi pilihan. Kode ini digunakan setelah upaya mengidentifikasi penyebab spesifik tidak menghasilkan hasil.

3.9.40 Disorders of Skin and Subcutaneous Tissue (L98)

Kode dalam kelompok L98 (*Other disorders of skin and subcutaneous tissue, not elsewhere classified*) diberikan sesuai diagnosis klinis yang ditetapkan oleh dokter setelah dilakukan evaluasi menyeluruh, termasuk:

- identifikasi karakteristik lesi
- Riwayat penyakit
- pemeriksaan seperti biopsi, tes laboratorium, atau pencitraan

Kode ini mencakup kondisi seperti L98.4 (*Chronic ulcer of skin, not elsewhere classified*), L98.0 (*Pyogenic granuloma*) atau L98.1 (*Factitial dermatitis*) yang tidak masuk ke dalam kategori kode spesifik lainnya. Pemilihan kode L98 harus didukung oleh dokumentasi medis yang detail untuk memastikan akurasi klasifikasi terutama jika kondisi tersebut memerlukan pendekatan terapi khusus atau pemantauan jangka panjang.

3.10 MDC 20 ENDOKRIN, NUTRISI DAN METABOLIK

Beberapa kondisi yang termasuk dalam bab ini dapat disebabkan oleh obat atau faktor eksternal lainnya. Kode dari Bab XX dapat digunakan sebagai kode tambahan.

PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 20

Penetapan diagnosis utama dan sekunder harus mengikuti prinsip morbiditas sebagaimana dijelaskan dalam *Chapter 2*. Pada kasus diabetes mellitus dengan komplikasi ganda, coder wajib memasukkan komplikasi utama yang menjadi alasan utama pasien dirawat sebagai diagnosis sekunder setelah kode E10–E14 dengan karakter keempat “.7”, contohnya E11.7. Pastikan keberadaan atau ketiadaan penyakit terkait komplikasi diabetes mellitus tercantum secara jelas dalam dokumen medis pasien.

Pada pasien dengan diagnosis diabetes mellitus tipe 2 disertai penyakit jantung iskemik, kode E11.6 diberikan apabila penyakit jantung iskemik secara definitif disebabkan oleh diabetes mellitus. Untuk menggambarkan secara lebih rinci terkait kondisi kondisi jantung iskemik yang dialami pasien, tambahkan kode I20–I25 sebagai diagnosis sekunder.

Apabila penyakit diabetes mellitus tidak berhubungan dengan penyakit jantung iskemik, penentuan diagnosis utama dan sekunder harus mengikuti prinsip morbiditas sebagaimana dijelaskan dalam *Chapter 2*. Dalam situasi di mana dokter menetapkan diabetes mellitus sebagai diagnosis utama dan penyakit jantung iskemik sebagai diagnosis sekunder, maka gunakan kode E11.9 (diabetes mellitus tipe II tanpa komplikasi) sebagai diagnosis utama dan kode I20–I25 sebagai diagnosis sekunder untuk penyakit jantung iskemik.

Dokumentasikan dengan benar mengenai kasus diabetes melitus, dalam iDRG terdapat 2 group tersendiri mengenai diabetes melitus yaitu, *Diabetes without Complicated PDx* & *Diabetes with Complicated PDx*, ketepatan dokumentasi klinis dan kode diagnosis akan berpengaruh kepada pengelompokan grouper iDRG.

PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 20

3.10.1 Hypothyroidism (E03.-)

- *Hypothyroidism* sekunder atau tersier yang disebabkan oleh hipopituitarisme, maka gunakan kode E23.0 (*Hypopituitarism*).
- *Subclinical hypothyroidism* dengan penyebab tidak ditentukan, maka gunakan kode R94.6 (*Abnormal results of thyroid function studies*)

3.10.2 Thyrotoxicosis [Hyperthyroidism] (E05.-)

- Tirotoksikosis *Graves' disease*, gunakan kode E05.0 (*Thyrotoxicosis with diffuse goitre*).
- Struma ovarii, gunakan kode E05.3 (*Thyrotoxicosis from ectopic thyroid tissue*), diikuti dengan kode D27 (*Benign neoplasm of ovary*). Jika jenis ganas, gunakan kode C56 (*Malignant neoplasm of ovary*) sebagai kode utama diikuti dengan kode E05.3 (*Thyrotoxicosis from ectopic thyroid tissue*).
- *Drug-induced thyrotoxicosis*, gunakan kode E05.4 (*Thyrotoxicosis factitia*).
- Tirotoksikosis akibat tumor hipofisis, gunakan kode E05.8 (*Other thyrotoxicosis*) diikuti dengan kode D44.3 (*Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of pituitary gland*).
- Oftalmopati Graves, gunakan kode E05.0† (*Thyrotoxicosis with diffuse goitre*) diikuti dengan kode H06.2* (*Dysthyroid exophthalmos*).
- Paralisis periodik hipokalemik tirotoksik, gunakan kode dalam grup E05.- (*Thyrotoxicosis*) diikuti dengan kode E87.6 (*Hypokalemia*).
- *Subclinical hyperthyroidism*, gunakan kode dalam grup E05.- (*Thyrotoxicosis*) sesuai karakteristik tiroid, jika tidak disebutkan, gunakan kode R94.6 (*Abnormal result of thyroid function studies*).
- Jika pasien telah dinyatakan sembuh dari hipertiroidisme, maka kode yang digunakan adalah dari kelompok Z09.- (*Follow-up examination after treatment for conditions other than malignant neoplasms*).
 - Jika pasien mencapai keadaan eutiroid (*euthyroidism*) setelah menjalani operasi tiroid (*thyroidectomy*), gunakan kode Z09.0 (*Follow-up examination after surgery for other conditions*)

- Jika pasien mencapai eutiroid setelah mendapatkan terapi yodium radioaktif, gunakan kode Z09.1 (*Follow-up examination after radiotherapy for other conditions*)
- Jika pasien dengan penyakit Graves yang berada dalam remisi setelah pengobatan medis jangka panjang, kode yang tepat digunakan adalah Z09.2 (*Follow-up examination after chemotherapy for other conditions*)

3.10.3 Thyroiditis (E06.-)

- Tiroiditis transien tanpa nyeri atau *sporadic thyroiditis*, gunakan kode E06.6 (*Transient painless thyroiditis, sporadic*) ^(IM).

3.10.3.1 Procedural Codes for Thyroid Disorders

- Prosedur *fine needle aspiration biopsy* pada kelenjar tiroid, gunakan kode prosedur 06.11 (*Closed [percutaneous] [needle] biopsy of thyroid gland*). Jika prosedur biopsi tersebut dilakukan dengan panduan ultrasound (ultrasonografi) / *ultrasound-guided biopsy*, maka selain menggunakan kode 06.11 untuk biopsi, juga harus ditambahkan kode 88.71 (*Diagnostic ultrasound of head and neck*).
- Untuk pengobatan hipertiroidisme dengan pemberian *radioactive iodine* dalam bentuk kapsul atau larutan, gunakan kode prosedur 92.28 (*Injection or instillation of radioisotopes*).
- Untuk prosedur *thyroid scan* atau *radioactive iodine uptake* pada nodul tiroid atau hipertiroidisme, gunakan kode prosedur 92.01 (*Thyroid scan and radioisotope function studies*) jika menggunakan MIBI.
- Untuk prosedur drainase abses di area tiroid, jika menggunakan jarum aspirasi, gunakan kode prosedur 06.01 (*Aspiration of thyroid field*).
- Jika dilakukan insisi untuk drainase, gunakan kode prosedur 06.09 (*Other incision of thyroid field*).

3.10.4 Diabetes Mellitus (E10-E14)

Dalam pengkodean “kondisi utama”, pemilihan subkategori yang tepat dari daftar yang berlaku untuk semua kategori ini harus didasarkan pada “kondisi utama” sebagaimana dicatat oleh tenaga kesehatan. Subkategori dengan kode .7 hanya digunakan sebagai kode “kondisi utama” jika terdapat beberapa komplikasi diabetes yang dicatat sebagai “kondisi utama” tanpa

memprioritaskan salah satu komplikasi tertentu. Kode untuk komplikasi individual yang tercantum dapat ditambahkan sebagai kode tambahan opsional.

Contoh 1:

Kondisi utama : Gagal ginjal akibat glomerulonefritis diabetik

Kode yang digunakan adalah diabetes mellitus tidak spesifik dengan komplikasi ginjal (E14.2† dan N08.3*).

Contoh 2:

Kondisi utama : Diabetes melitus tipe insulin dengan nefropati, gangren, dan katarak

Kondisi lain : —

Kode yang digunakan adalah diabetes melitus tipe insulin dengan komplikasi ganda (E10.7).

Kode tambahan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi komplikasi spesifik adalah:

- E10.2† dan N08.3* (diabetes melitus tipe insulin dengan nefropati)
- E10.5 (diabetes melitus tipe insulin dengan komplikasi sirkulasi perifer)
- E10.3† dan H28.0* (diabetes melitus tipe insulin dengan katarak)

3.10.4.1 Perhatian khusus dalam pengodean kasus diabetes adalah sebagai berikut :

1. Diabetes tipe 1 atau *insulin-dependent diabetes mellitus*, gunakan kode dalam grup E10.- (*Type 1 diabetes mellitus*).
2. Diabetes tipe 2 atau *non-insulin-dependent diabetes mellitus*, gunakan kode dalam grup E11.- (*Type 2 diabetes mellitus*).
3. Diabetes mellitus dengan malnutrisi, gunakan kode E12 (*Malnutrition-related diabetes mellitus*), disertai dengan subkategori (digit keempat) sesuai dengan jenis komplikasinya. Kode E46 (*Unspecified protein-energy malnutrition*) tidak perlu dikode terpisah.
4. *Steroid-induced diabetes mellitus*, gunakan kode dalam grup E13.- (*Other specified diabetes mellitus*), disertai dengan kode eksternal Y42.0 (*Glucocorticoids and synthetic analogues*).
5. *Pancreatic diabetes mellitus*, gunakan kode dalam grup E13.- (*Other specified diabetes mellitus*), disertai dengan kode penyakit pankreas

- yang relevan, seperti K86.0 (*Alcohol-induced chronic pancreatitis*), K86.1 (*Other chronic pancreatitis*), dan sebagainya.
6. Diabetes akibat gangguan endokrin lain, seperti sindrom Cushing atau akromegali, gunakan kode dalam grup E13.- (*Other specified diabetes mellitus*), disertai dengan kode gangguan endokrin yang relevan, seperti E22.0 (*Acromegaly and pituitary gigantism*), E24.8 (*Other Cushing's syndrome*), dan sebagainya.
 7. Diabetes mellitus tanpa merinci jenisnya, gunakan kode dalam grup E14.- (*Unspecified diabetes mellitus*).

3.10.4.2 Pemberian Kode untuk Komplikasi Diabetes:

1. Komplikasi Akut:

- *Hyperosmolar nonketotic coma*, gunakan kode diabetes dengan subkategori .0 *With coma*.
- *Hypoglycemia pada diabetic coma*, gunakan kode E10 – E14 dengan subkategori .0 *With coma*
- *Hypoglycemic coma* akibat obat antidiabetik, gunakan kode diabetes dengan subkategori .0 *With coma*, serta tambahkan kode eksternal Y42.3 (*Insulin and oral hypoglycaemic (antidiabetic) drug*).
- *Drug-induced hypoglycemia* tanpa koma, gunakan kode E16.0 (*Drug-induced hypoglycaemia without coma*) sebagai diagnosis utama, diikuti dengan kode diabetes sebagai diagnosis tambahan, serta tambahkan kode eksternal Y42.3 (*Insulin and oral hypoglycaemic (antidiabetic) drug*).
- *Diabetic ketoacidosis*, gunakan kode diabetes dengan subkategori .1 *With ketoacidosis*.

2. Komplikasi Kronis:

- *Diabetic nephropathy*, gunakan kode diabetes dengan subkategori .2 *With renal complications*, diikuti dengan kode N08.3* (*Glomerular disorders in diabetes mellitus*).
- *Diabetic cataract*, gunakan kode diabetes dengan subkategori .3 *With ophthalmic complications*, diikuti dengan kode H28.0* (*Diabetic cataract*).

- Jenis katarak lain, seperti katarak senil, gunakan kode dalam grup H25.- (*Senile cataract*) sebagai diagnosis utama, diikuti dengan kode diabetes dengan subkategori .9 *Without complications*. Jika katarak disebabkan oleh obat, gunakan kode H26.3 (*Drug-induced cataract*), diikuti dengan kode diabetes dengan subkategori .9 *Without complications*, serta tambahkan kode eksternal sesuai jenis obat penyebab.
- *Diabetic neuropathy*, serta gunakan kode diabetes dengan subkategori .4 *With neurological complications*, diikuti dengan salah satu kode berikut sesuai jenis neuropati yang dirinci:
 - G59.0* (*Diabetic mononeuropathy*)
 - G63.2* (*Diabetic polyneuropathy*)
 - G73.0* (*Diabetic amyotrophy*)
 - G99.0* (*Diabetic autonomic neuropathy*)
 - Jika jenis tidak dirinci, gunakan kode G63.2* (*Diabetic polyneuropathy*).
- *Diabetic diarrhea* atau *diabetic gastropathy*, gunakan kode diabetes dengan subkategori .4 *With neurological complications*, diikuti dengan kode G99.0* (*Diabetic autonomic polyneuropathy*).
- Diabetes dengan gangguan pembuluh darah tepi, ulkus ada kulit, atau *diabetic gangrene* atau *diabetic ulcer*, gunakan kode diabetes dengan subkategori .5 *With peripheral circulatory complications*. Gangguan pembuluh darah tepi, ulkus ada kulit, atau *diabetic gangrene* atau *diabetic ulcer* tidak dikode sebagai diagnosis sekunder.
- *Peripheral vascular disease* akibat diabetes, gunakan kode diabetes dengan subkategori .5 *With peripheral circulatory complications*, diikuti dengan kode I79.2 (*Peripheral angiopathy in diseases classified elsewhere*).
- *Diabetic arthropathy*, gunakan kode diabetes dengan subkategori .6 *With other specified complications*, diikuti dengan kode M14.2 (*Diabetic arthropathy*).

- *Diabetic neuropathic arthropathy*, gunakan kode diabetes dengan subkategori .6 *With other specified complications*, diikuti dengan kode M14.6 (*Neuropathic arthropathy*).

3.10.4.3 Penyakit Lain pada Pasien Diabetes

- *Diabetic foot*, pengode harus mencari informasi lebih lanjut tentang adanya *peripheral vascular disease* dan/atau *neuropathy*, serta berkonsultasi dengan dokter untuk klarifikasi diagnosis.
- *Cellulitis* atau abses pada pasien diabetes, gunakan kode L03.0 (*Cellulitis of finger and toe*), L03.1 (*Cellulitis of other parts of limb*), atau L02.4 (*Cutaneous abscess, furuncle, and carbuncle of limb*) sebagai diagnosis utama atau tambahan, tergantung pada diagnosis dokter.
- Jika infeksi pada kaki pasien diabetes tidak disertai *peripheral vascular disease* atau *neuropathy*, gunakan kode *cellulitis* sebagai diagnosis utama, serta kode diabetes dengan subkategori .9 *Without complications* sebagai diagnosis tambahan.
- Diabetes dengan *chronic osteomyelitis*, gunakan kode M86.4 (*Chronic osteomyelitis with draining sinus*) atau M86.6 (*Other chronic osteomyelitis*) sebagai diagnosis utama, serta kode diabetes dengan subkategori .9 *Without complications* sebagai diagnosis tambahan.
- Diabetes dengan penyakit jantung koroner (PJK) tidak dianggap sebagai komplikasi diabetes karena dapat disebabkan oleh faktor risiko lain. Gunakan kode dalam grup I20.- (*Angina pectoris*) atau I25.- (*Chronic ischaemic heart disease*) sebagai diagnosis utama, serta kode diabetes dengan atau tanpa komplikasi sebagai diagnosis tambahan. Tidak boleh menggunakan subkategori .6 *With other specified complications* pada diabetes untuk pasien dengan PJK.
- Diabetes dengan *stroke* tidak dianggap sebagai komplikasi diabetes karena dapat disebabkan oleh faktor risiko lain. Gunakan kode *stroke* sebagai diagnosis utama, serta kode diabetes dengan atau tanpa komplikasi sebagai diagnosis tambahan. Tidak boleh menggunakan subkategori .6 *With other specified complications* pada diabetes untuk pasien dengan *stroke*.

3.10.4.4 Hipoglikemia pada Diabetes:

Jika dokter mendiagnosis hipoglikemia akibat obat antidiabetik, serta terdapat perubahan kesadaran mulai dari bingung hingga koma, gunakan kode diabetes dengan subkategori .0 *With coma*, serta tambahkan kode eksternal Y42.3 (*Insulin and oral hypoglycaemic (antidiabetic) drug*).

Contoh 1-20	Pasien dengan diabetes tipe 2 datang dengan keluhan tidak sadarkan diri. Dokter mendiagnosis sebagai koma hipoglikemik dan menyatakan bahwa kondisi ini disebabkan oleh obat pengobatan diabetes	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	<i>Hypoglycemic coma</i>	E11.0 <i>Non-insulin-dependent diabetes mellitus, with coma</i>
Diagnosis Sekunder	<i>Non-insulin-dependent diabetes mellitus</i>	-
Penyebab Eksternal	<i>Antidiabetic drugs</i>	Y42.3 <i>Insulin and oral hypoglycaemic [antidiabetic] drugs</i>

Contoh 2-20	Pasien dengan diabetes tipe 1 datang dengan komplikasi berupa retinopati diabetik	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	<i>Diabetic retinopathy</i>	E10.3† <i>Insulin-dependent diabetes mellitus, with ophthalmic complications</i>
Diagnosis Sekunder	<i>Insulin-dependent diabetes mellitus</i>	H36.0* <i>Diabetic retinopathy</i>

Contoh 3-20	Pasien dengan diabetes tipe 1 datang dengan komplikasi berupa polineuropati diabetik	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode

Diagnosis Primer	<i>Diabetic polyneurpathy</i>	E10.4† <i>Insulin-dependent diabetes mellitus, with neurological complications</i>
Diagnosis Sekunder	<i>Insulin-dependent diabetes mellitus</i>	G63.2* <i>Diabetic polyneuropathy</i>

Contoh 4-20	Pasien dengan diabetes tipe 2 datang dengan beberapa komplikasi, meliputi penyakit ginjal, retinopati (penyakit retina), dan penyakit vaskular perifer.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	<i>Diabetic nephropathy</i>	E11.7† <i>Non-insulin-dependent diabetes mellitus, with multiple complications</i>
Diagnosis Sekunder	<i>Diabetic retinopathy</i>	N08.3 <i>Glomerular disorders in diabetes mellitus</i> H36.0* <i>Diabetic retinopathy</i>
	<i>Peripheral vascular disease diabetes mellitus type 2</i>	I79.2 <i>Peripheral angiopathy in diseases classified elsewhere</i>

3.10.5 Hypoglycaemic (E15-E16)

- Hipoglikemia disebabkan oleh insulinoma dengan diagnosis berdasarkan pencitraan, gunakan kode D37.7 (*Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of pancreas*) sebagai diagnosis tambahan.
- Hipoglikemia disebabkan oleh insulinoma dengan konfirmasi patologi, gunakan kode D13.7 (*Benign neoplasm of endocrine pancreas*) atau C25.- (*Malignant neoplasm of pancreas*) sebagai diagnosis tambahan.
- Hipoglikemia disebabkan oleh kondisi spesifik lain, seperti insufisiensi adrenal, syok septik, atau gagal hati, baik dengan atau tanpa koma, gunakan kode untuk kondisi tersebut saja. Hipoglikemia dianggap sebagai salah satu gejala dari kondisi tersebut.

3.10.6 Disorder of Pancreatic Internal Secretion (E16.3-E16.9)

- *Glucagonoma*, gunakan kode E16.3 (*Increased secretion of glucagon*), serta tambahkan kode tumor penyebabnya.
- *Gastrinoma* atau *Zollinger-Ellison syndrome*, gunakan kode E16.4 (*Abnormal secretion of gastrin*), serta tambahkan kode tumor penyebabnya.
- *VIPoma*, *somatostatinoma*, atau tumor penghasil GHRH, gunakan kode E16.8 (*Other specified disorders of pancreatic internal secretion*), serta tambahkan kode tumor penyebabnya.

3.10.7 Hyperparathyroidism (E21.0-E21.3, E83.5)

- *Hiperkalsemia maligna*, gunakan kode penyakit kanker sebagai diagnosis utama, serta tambahkan kode E83.5 (*Disorders of calcium metabolism*) sebagai diagnosis tambahan.
- *Hiperkalsemia* akibat penyebab lain seperti imobilisasi, dehidrasi, insufisiensi adrenal, atau tuberkulosis, gunakan kode penyakit atau kondisi penyebab tersebut sebagai diagnosis utama, serta tambahkan kode E83.5 (*Disorders of calcium metabolism*) sebagai diagnosis tambahan.

3.10.8 Hyperfunction of Pituitary Gland (E22, E24.0)

- *Akromegali*, gunakan kode E22.0 (*Acromegaly and pituitary gigantism*) sebagai diagnosis utama, serta tambahkan kode untuk tumor kelenjar pituitari sebagai diagnosis tambahan.
- *Prolaktinoma*, gunakan kode D35.2 (*Benign neoplasm of pituitary gland*) sebagai diagnosis utama, serta tambahkan kode E22.1 (*Hyperprolactinaemia*) sebagai diagnosis tambahan.
- *Hiperprolaktinemia* akibat obat, gunakan kode E22.1 (*Hyperprolactinaemia*), serta tambahkan kode eksternal sesuai jenis obat penyebab.

3.10.9 Cushing' Syndrome (E24.-)

- *Adrenal Cushing's syndrome*, gunakan kode E24.8 (*Other Cushing's syndrome*), serta tambahkan kode untuk tumor kelenjar adrenal.
- *Pituitary Cushing's syndrome*, gunakan kode E24.0 (*Pituitary-dependent Cushing's disease*), serta tambahkan kode untuk tumor kelenjar pituitari.

- *Ectopic ACTH syndrome*, gunakan kode E24.3 (*Ectopic ACTH syndrome*), serta tambahkan kode untuk tumor organ lain yang memproduksi ACTH.
- *Drug-induced Cushing's syndrome*, gunakan kode E24.2 (*Drug-induced Cushing's syndrome*), serta tambahkan kode eksternal Y42.0 (*Glucocorticoids and synthetic analogues causing adverse effects in therapeutic use*).

3.10.10 Hyperaldosteronism (E26.-)

- Hiperaldosteronisme primer dan disebabkan oleh tumor kelenjar adrenal, gunakan kode E26.0 (*Primary hyperaldosteronism*), serta tambahkan kode untuk tumor kelenjar adrenal. Jika disebabkan oleh hiperplasia adrenal atau penyebab tidak disebutkan, hanya gunakan kode E26.0 (*Primary hyperaldosteronism*)
- Hiperaldosteronisme sekunder tanpa menyebutkan penyebab, gunakan kode E26.1 (*Secondary hyperaldosteronism*). Jika penyebab disebutkan, gunakan kode untuk penyebab tersebut. Misalnya, jika disebabkan oleh stenosis arteri renal, gunakan kode I15.0 (*Renovascular hypertension*)

3.10.11 Primary Adrenocortical Insufficiency (E27.1)

- Insufisiensi adrenal primer dan menyebutkan bahwa disebabkan oleh tuberkulosis, gunakan kode A18.7† (*Tuberculosis of adrenal glands*), diikuti dengan kode E35.1* (*Disorders of adrenal glands in diseases classified elsewhere*). Jika disebabkan oleh infeksi meningokokus, gunakan kode A39.1† (*Waterhouse-Friderichsen syndrome*), diikuti dengan kode E35.1*.

3.10.12 Adrenomedullary Hyperfunction (E27.5)

- Hiperfungsi medula adrenal, gunakan kode E27.5 (*Adrenal medullary hyperfunction*) sebagai diagnosis utama.
- Hiperfungsi medula adrenal yang disebabkan oleh hal lain:
 - Hiperfungsi medula adrenal yang disebabkan oleh feokromositoma jinak pada kelenjar adrenal, gunakan kode E27.5 (*Adrenal medullary hyperfunction*) sebagai diagnosis utama dan tambahkan kode D35.0 (*Benign neoplasm of adrenal gland*) sebagai diagnosis tambahan.

- Hiperfungsi medula adrenal yang disebabkan oleh feokromositoma ganas, gunakan kode C74.1 (*Malignant neoplasm of medulla of adrenal gland*) sebagai diagnosis utama, serta tambahkan kode E27.5 (*Adrenomedullary hyperfunction*) sebagai diagnosis tambahan.

3.10.13 Androgen Excess (E28.1)

- Kelebihan androgen akibat obat, gunakan kode E28.1 (*Androgen excess*) sebagai diagnosis utama, serta tambahkan kode eksternal Y42.7 (*Androgens and anabolic congeners*) sebagai penyebab eksternal.
- Kelebihan androgen akibat kanker ovarium atau kelenjar adrenal, gunakan kode kanker tersebut sebagai diagnosis utama, serta tambahkan kode E28.1 (*Androgen excess*) sebagai diagnosis tambahan.
- Kelebihan androgen akibat sindrom polikistik ovarium (PCOS) atau hiperplasia adrenal kongenital, gunakan kode E28.2 (*Polycystic ovarian syndrome*) atau E25.0 (*Congenital adrenogenital disorders associated with enzyme deficiency*) tanpa perlu menambahkan kode E28.1 (*Androgen excess*), karena gejala ini merupakan bagian dari penyakit tersebut.

3.10.14 Testicular Hypofunction (E29.1)

- Hipogonadisme pasca-pengangkatan testis, gunakan kode E89.5 (*Postprocedural testicular hypofunction*).
- *Isolated hypogonadotropic hypogonadism*, hipogonadisme sekunder atau tersier, atau sindrom Kallmann, gunakan kode E23.0 (*Hypopituitarism*)

3.10.15 Disorders of Puberty (E30.-)

- Tumor yang memproduksi hormon seks, gunakan kode E30.1 (*Precocious puberty*), serta tambahkan kode untuk tumor tersebut.
- Pubertas prekoks akibat hiperplasia adrenal kongenital, gunakan kode E25.0 (*Congenital adrenal disorders associated with enzyme deficiency*), tanpa perlu menambahkan kode E30.1

3.10.16 Carcinoid Syndrome (E34.)

Kode ini tidak digunakan sebagai kode utama untuk “kondisi utama” jika tumor karsinoid sudah dicatat, kecuali jika perawatan difokuskan terutama pada sindrom endokrin itu sendiri. Saat mengkode tumor, kode

E34.0 dapat digunakan sebagai kode tambahan untuk menunjukkan aktivitas fungsional tumor.

3.10.17 Sequelae of Malnutrition and Other Nutritional Deficiencies (E64.-) & Sequelae of Hyperalimentation (E68)

Kode-kode ini tidak digunakan sebagai kode utama untuk “kondisi utama” jika sifat dari kondisi *sequelae* sisa (residual) sudah dicatat secara spesifik. Saat mengkode kondisi sisa tersebut, kode E64.- atau E68 dapat digunakan sebagai kode tambahan opsional.

3.10.18 Disorders of Lipoprotein Metabolism (E78.-)

Gunakan kode dalam grup E78.- (*Disorders of lipoprotein metabolism and other lipidaemias*) sesuai jenis kelainan lipid yang didiagnosis oleh dokter:

- Dislipidemia tanpa merincikan jenis lipid yang meningkat, gunakan kode E78.5 (*Hyperlipidaemia, unspecified*).
- HDL rendah, gunakan kode E78.6 (*Lipoprotein deficiency*).
- Kelainan lipoprotein lainnya yang tidak termasuk dalam kategori sebelumnya, gunakan kode E78.8 (*Other disorders of lipoprotein metabolism*)
- Dislipidemia tanpa rincian lebih lanjut, gunakan kode E78.9 (*Disorders of lipoprotein metabolism, unspecified*).

3.10.19 Hyperuricemia (E79.0)

- Hiperurisemia disertai artritis gout, gunakan kode dalam grup M10.- (*Gout*), tanpa perlu menambahkan kode untuk hiperurisemia

3.10.20 Disorders of Calcium Metabolism (E83.5)

- Hiperkalsemia atau hipokalsemia tanpa menyebutkan penyebabnya, gunakan kode E83.5 (*Disorders of calcium metabolism*).
- Jika dokter menyebutkan penyebabnya, gunakan kode penyakit tersebut tanpa perlu menambahkan kode E83.5 (*Disorders of calcium metabolism*).
- Hiperkalsemia maligna, gunakan kode keganasan sebagai diagnosis utama, serta tambahkan kode E83.5 (*Disorders of calcium metabolism*) sebagai diagnosis tambahan.

3.10.21 Amyloidosis (E85.-)

- Amiloidosis sekunder akibat penyakit inflamasi kronis, gunakan kode E85.3 (*Secondary systemic amyloidosis*) sebagai diagnosis utama, serta tambahkan kode untuk penyakit inflamasi tersebut sebagai diagnosis tambahan.

3.10.22 Volume Depletion and Fluid Overload (E86, E87.7)

- Kekurangan volume/dehidrasi/hipovolemia tanpa menyebutkan penyebabnya, gunakan kode E86 (*Volume depletion*). Jika penyebabnya disebutkan, gunakan kode penyebab tersebut tanpa perlu menambahkan kode E86.
- Kekurangan volume akibat obat diuretik, gunakan kode E86 (*Volume depletion*) sebagai diagnosis utama, serta tambahkan kode eksternal untuk obat penyebab.
- Kelebihan cairan tanpa menyebutkan penyebabnya, gunakan kode E87.7 (*Fluid overload*). Jika penyebabnya disebutkan (misalnya gagal ginjal), gunakan kode penyebab tersebut sebagai diagnosis utama, serta tambahkan kode E87.7 (*Fluid overload*) sebagai diagnosis tambahan.

3.10.23 Hypernatremia and Hyponatremia (E87.0-E87.1)

- Hipernatremia atau hiponatremia tanpa menyebutkan penyebabnya, gunakan kode E87.0 (*Hyperosmolality and hypernatremia*) atau E87.1 (*Hypo-osmolality and hyponatremia*). Jika penyebabnya disebutkan, gunakan kode penyebab tersebut tanpa perlu menambahkan kode E87.0 atau E87.1

3.10.24 Acidosis (E87.2)

- Jika penyebabnya tidak disebutkan, gunakan kode E87.2 (*Acidosis*). Namun, jika terdapat penyebab asidosis, gunakan kode penyebab tersebut tanpa perlu menambahkan kode E87.2.

3.10.25 Alkalosis (E87.3)

- Jika penyebabnya tidak disebutkan, gunakan kode E87.3 (*Alkalosis*). Namun, jika terdapat penyebab alkalosis, gunakan kode penyebab tersebut tanpa perlu menambahkan kode E87.3.

3.10.26 Hyperkalemia and Hypokalemia (E87.5-E87.6)

- Jika tidak disebutkan penyebabnya, gunakan kode E87.5 (*Hyperkalemia*) atau E87.6 (*Hypokalemia*). Namun, jika terdapat penyebab hiperkalemia/hipokalemia, gunakan kode penyebab penyakit tersebut tanpa perlu menambahkan kode E87.5 atau E87.6.
- Hipokalemia disebabkan oleh obat diuretik, gunakan kode E87.6 (*Hypokalemia*) sebagai diagnosis utama, serta tambahkan kode eksternal untuk jenis obat penyebab.
- Hipokalemia disebabkan oleh amfoterisin B yang digunakan untuk mengobati infeksi jamur, serta menyebabkan kerusakan tubulo-interstitial pada ginjal, gunakan kode N14.1 (*Nephropathy induced by other drugs, medicaments and biological substances*), serta tambahkan kode eksternal Y40.7 (*Antifungal antibiotics, systemically used*).

3.10.27 Lipodystrophy (E88.1)

- Lipodistrofi akibat obat, gunakan kode E88.1 (*Lipodystrophy, not elsewhere classified*) sebagai diagnosis utama, serta tambahkan kode eksternal untuk jenis obat penyebab.
- Lipodistrofi terjadi pada pasien diabetes, gunakan kode dalam grup E13.- (*Other specified diabetes mellitus*) sebagai diagnosis utama, serta tambahkan kode E88.1 (*Lipodystrophy, not elsewhere classified*) sebagai diagnosis tambahan.

3.11 MDC 21 DISEASE AND DISORDERS OF THE KIDNEY AND URINARY TRACT

PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 21

- Dalam kasus pasien dengan batu (*calculus*) pada saluran kemih yang disertai infeksi, tidak diperbolehkan menggunakan kode diagnosis secara terpisah. Gunakan kode gabungan yang ada pada N20–N23 (*Urolithiasis*), sesuai dengan kriteria eksklusi yang tercantum pada subbab N30–N39.
- Pengodean Tindakan Terkait CAPD
 - Untuk pemasangan *shunt* pada pasien rawat inap dalam rangka terapi *Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis* (CAPD), gunakan kode 54.94 (*Creation of peritoneovascular shunt*).
 - Untuk training penggunaan alat CAPD (sebelum alat dipasang secara permanen) pada pasien rawat jalan, gunakan kode 54.98 (*Peritoneal dialysis*).
 - Untuk kunjungan kontrol atau pengambilan cairan CAPD, tidak perlu menggunakan kode 54.98.
- Pemasangan Akses Hemodialisis
 - Untuk pemasangan *Catheter Double Lumen* (CDL), gunakan kode 38.95 (*Venous catheterization for renal dialysis*).
 - Untuk pembuatan akses Cimino, gunakan kode 39.27 (*Arteriovenostomy for renal dialysis*).
- Kode 55.520 (IM) (*Living donor*) dan 55.521 (IM) (*Cadaver donor*) digunakan untuk pemberi donor ginjal disertai dengan Z52.4 (*Kidney donor*).
- Gout yang menyebabkan nefropati harus dikodekan sebagai berikut, M10.0† (*Idiopathic gout*) (karakter ke-5 untuk menentukan lokasi) dan N16.8* (*Renal tubulo-interstitial disorders in other diseases classified elsewhere*).
- Berikut adalah pedoman yang harus diterapkan saat menetapkan kode dari kategori N18.- Penyakit ginjal kronis:
 - Ketika penyakit ginjal kronis (CKD) dan penyebabnya yang mendasari didokumentasikan, kedua kondisi harus dikodekan.
 - Penentuan tahap CKD harus mengacu pada dokumentasi tahap yang tercatat oleh dokter dalam rekam medis. Pengode (*coder*) tidak diperkenankan menggunakan nilai laju filtrasi glomerulus (GFR) secara langsung (seperti 45

mL/menit) atau deskripsi seperti "penurunan GFR ringan" untuk menentukan tahap CKD pasien.

- Jika selama episode perawatan terjadi perubahan tahap CKD, maka kode yang digunakan adalah tahap tertinggi yang tercatat dalam periode tersebut (contoh: dari tahap 1 menjadi tahap 2, maka kodekan sebagai tahap 2).
- Ketika memberikan kode untuk kondisi yang termasuk dalam kategori N18.- yaitu Penyakit Ginjal Kronis yang disebabkan oleh hipertensi, maka harus juga diberikan kode dari kategori I12.- yaitu Penyakit Ginjal Hipertensi (atau I13.- jika pasien juga mengalami penyakit jantung akibat hipertensi). Penentuan diagnosis utama tergantung pada kondisi apa yang menjadi fokus utama perawatan atau pemeriksaan medis.
- Saat mengkodekan kondisi apapun yang dapat diklasifikasikan ke kategori N18.- Penyakit ginjal kronis pada pasien dengan hipertensi yang tidak disebabkan oleh hipertensi, sebuah kode dari kategori I12.- tidak boleh ditetapkan dan hipertensi harus dikodekan secara terpisah.
- Dalam MDC 21 terdapat DRG khusus untuk tindakan *Extracorporeal shockwave lithotripsy* (ESWL), sehingga koder harus memperhatikan dokumentasi medis dan bukti tata laksana tindakan ESWL.
 - Ketika terdapat tindakan yang masuk ke dalam MDC 21 dan disertai dengan tindakan ESWL dengan kode 98.51, maka akan masuk ke dalam DRG dengan deskripsi *w/ESWL*, misalkan:
 - *Ureteroscopy Proc. w/ ESWL*
 - *Cystourethroscopy Proc. w/ ESWL*
 - *Urinary Stone/Obstruction w/ ESWL*

PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 21

3.11.1 Glomerular diseases (N00-N08)

- Penggunaan subdivisi karakter keempat dari .0 sampai .8 pada kode N00-N08 yang menunjukkan perubahan morfologis dari kategori kode N00-N07, hanya diperbolehkan apabila perubahan tersebut teridentifikasi berdasarkan Biopsi atau Autopsi.

- Jika pasien mempunyai penyakit ginjal atau gagal ginjal (baik akut, kronis, maupun yang tidak ditentukan), kondisi tersebut harus dikodekan sebagai diagnosis sekunder..
- Jika penyebab dari kondisi yang diklasifikasikan pada kode N00-N08 disebabkan oleh faktor luar, maka tambahkan kode dari Bab XX sebagai kode diagnosis sekunder.
- Kode I12 (*Hypertensive renal disease*) merupakan pengecualian dari kode N00-N08 dan hanya digunakan ketika kondisi tersebut berkaitan dengan hipertensi.

3.11.2 Obstructive And Reflux Uropathy (N13.-)

Dalam kasus *Other obstructive and reflux uropathy* yang disertai infeksi saluran kemih (ISK), maka tidak dapat menggunakan kode gabungan N13.6 (*Pyonephrosis*). Hal ini merujuk pada ketentuan ICD-10 Volume 1 yang menyatakan bahwa N13.6 hanya dapat digunakan jika infeksi terjadi bersamaan dengan obstruksi yang dikodekan dalam rentang N13.0–N13.5. Oleh karena itu gunakan kode terpisah, yaitu N13.8 (*Other obstructive and reflux uropathy*) dan N39.0 (*Urinary tract infection, site not specified*). Tambahkan kode dari rentang B95–B98 untuk mengidentifikasi agen infeksius penyebab ISK (jika tersedia).

3.11.3 Renal Tubulo-Interstitial Disorders (N14-N16)

Pada penyakit atau gangguan yang disebabkan oleh penggunaan obat-obatan (seperti analgesik atau obat lain) atau terpapar logam berat (seperti emas atau timbal) yang dapat menimbulkan kerusakan, khususnya pada ginjal maka dalam pengodeannya adalah sbb:

- Jika penyebabnya adalah obat penghilang rasa sakit (misalnya aspirin, fenasetin, asetaminofen, NSAID), gunakan kode N14.0 (*Analgesic nephropathy*).
- Jika penyebabnya adalah obat/bahan biologis lain (misalnya amfoterisin B, litium, siklosporin, zat kontras), gunakan kode N14.1 (*Nephropathy induced by other drugs, medicaments, and biological substances*).

- Jika obat/bahan biologis tidak spesifik, maka gunakan kode N14.2 (*Nephropathy induced by unspecified drug, medicament, and biological substance*).
- Jika penyebabnya adalah logam berat (misalnya emas, timbal), maka gunakan kode N14.3 (*Nephropathy induced by heavy metals*). Tambahkan kode penyebab eksternal sesuai jenis obat/logam berat yang disebutkan.

Jika penyakit ginjal tubulo-interstitial disebabkan oleh penyakit lain (misalnya diabetes, lupus), gunakan kode penyakit primer sebagai diagnosis utama dan tambahkan kode N16.- (*Renal tubulo-interstitial disorders in diseases classified elsewhere*) sebagai diagnosis sekunder.

Contoh 1-21	Dokter mendiagnosis nefropati tubulo-interstisial dari Multiple myeloma.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	<i>Multiple myeloma</i>	C90.0† <i>Multiple myeloma</i>
Diagnosis Sekunder	<i>Nephropathy tubulo-interstitial</i>	N16.1* <i>Renal tubulo-interstitial disorders in neoplastic diseases</i>

3.11.4 Acute Renal Failure (N17.-)

Konfirmasi kepada Dokter untuk stage *Acute Renal Failure* (N17.-) dan penambahan pendokumentasian di rekam medis supaya koder bisa mengkode lebih spesifik. Kode N17.- digunakan untuk gagal ginjal akut, kecuali jika terdapat kondisi berikut:

- *Extrarenal uraemia* (R39.2).
- *Congenital renal failure* (P96.0) pada bayi baru lahir..
- *Drug- and heavy-metal-induced tubulo-interstitial and tubular conditions* (N14.-).
- *Haemolytic-uraemic syndrome* (D59.3).
- *Hepatorenal syndrome* (K76.7).
- *Renal failure complicating abortion and puerperium* (O00-O07, O08.4, O90.4).
- *Postprocedural renal failure* (N99.0).

3.11.5 Chronic Kidney Disease (N18.-)

- Jika *Chronic kidney Disease* disertai hipertensi, maka gunakan tambahan kode *Hypertension* untuk menggambarkan kondisi pasien secara utuh.

Contoh 1: Lupus nefritis, gunakan kode M32.1† (*Systemic lupus erythematosus with organ involvement*) + N08.5* (*Glomerular disorders in systemic connective tissue disorders*).

Jenis dialisis	Cuci darah pertama	Cuci darah berikutnya
Hemodialisis	38.95 <i>Venous catheterization for renal dialysis</i> 39.95 Hemodialysis	39.95 <i>Hemodialysis</i>
Dialisis peritoneal	54.93 <i>Creation of cutaneoperitoneal fistula</i> 54.98 <i>Peritoneal dialysis</i>	54.98 <i>Peritoneal dialysis</i>

- Pasien yang menjalani transplantasi ginjal untuk mengobati gagal ginjal kronis berikan kode prosedur 55.69 (*Other kidney transplantation*) bersama dengan kode yang menunjukkan jenis donor tempat ginjal diterima, termasuk:
 - Menerima ginjal dari kerabat yang masih hidup, kode 00.91 (*Transplant from live related donor*).
 - Menerima ginjal dari orang orang asing yang masih hidup, kode 00.92 (*Transplant from live non-related donor*)
 - Menerima ginjal dari orang yang sudah meninggal, kode 00.93 (*Transplant from cadaver*)

3.11.6 Urolithiasis N20-N23

Berikan kode dari kelompok N20.- (*Calculus of kidney and ureter*) dan N21.- (*Calculus of lower urinary tract*) sesuai dengan lokasi batu seperti yang didiagnosis oleh dokter:

- Batu saluran kemih dengan disertai ISK, maka gunakan kode gabungan pada sub bab *Urolithiasis* (N20-N23) sesuai dengan kriteria *excludes* yang dijelaskan pada sub bab N30-N39 (Hal ini sesuai pada BA tahun 2023), antara lain:
 - a. *Prostatocystitis* (N41.3)
 - b. *Cord bladder NOS* (G95.8)
 - c. *Due to spinal cord lesion* (G95.8)
 - d. *Neurogenic bladder due to cauda equina syndrome* (G83.4)
 - e. *Urinary incontinence NOS* (R32)
 - f. *Urinary incontinence specified* (N39.3-N39.4)
 - g. *Calculus in bladder* (N21.0)
 - h. *Cystocele* (N81.1)
 - i. *Hernia or prolapse of bladder, female* (N81.1)
 - j. *Reiter's disease* (M02.3)
 - k. *Urethritis in diseases with a predominantly sexual mode of transmission* (A50-A64)
 - l. *Urethrotigonitis* (N30.3)
 - m. *Postprocedural urethral stricture* (N99.1)
 - n. *Fistula urethroscrotal* (N50.8)
 - o. *Fistula urethrovaginal* (N82.1)
 - p. *Haematuria NOS* (R31)
 - q. *Haematuria recurrent and persistent* (N02.-)
 - r. *Haematuria with specified morphological lesion* (N02.-)
 - s. *proteinuria NOS* (R80)
- Kalkulus urin dari kondisi Hiperparatiroidisme primer, gunakan kode E21.0† (*Primary hyperparathyroidism*) sebagai kode diagnosis utama, dan N22.8* (*Calculus of urinary tract in other diseases classified elsewhere*) sebagai kode diagnosis sekunder.
- Kolik ginjal atau kolik ureter, gunakan kode N23 (*Unspecified renal colic*).
- *Colic renal* disertai *ureterolithiasis* dengan *hydroureter* dan *hydronephrosis*, maka gunakan kode N13.2 (*Hydronephrosis with renal*

and ureteral calculous obstruction). *Colic renal* tidak perlu dikode terpisah karena merupakan gejala dari *hydronephrosis*. (BA 2023)

3.11.7 Contracted And Small Kidney (N26-N27)

- Contracted kidney, atrofi ginjal, atau sklerosis ginjal, gunakan kode N26 (*Unspecified contracted kidney*).
- *Small kidney* tanpa diketahui penyebabnya dan hanya pada satu sisi, gunakan kode N27.0 (*Small kidney, unilateral*).
- *Small kidneys* atau *contracted kidneys* pada kedua sisi, gunakan kode di kelompok N27.1 (*Small kidney, bilateral*).

3.11.8 Cyst Of Kidney (N28.1, Q61)

- Kista yang terinfeksi pada pasien polikistik ginjal N15.1 (*Renal and perinephric abscess*) sebagai kode diagnosis utama dan kode Q61.2 (*Polycystic kidney, autosomal dominan*) sebagai kode diagnosis terkait.

3.11.9 Neuromuscular Dysfunction Of Bladder (N31.-)

- Kandung kemih neurogenik diabetik, gunakan kode diabetes E10 – E14 dengan kode primer keempat yaitu .4 seperti E10.4† (*Insulin-dependent diabetes mellitus, with neurological complications*) sebagai kode diagnosis utama dan memberikan kode G99.0* (*Autonomic neuropathy in endocrine and metabolic diseases*) sebagai kode diagnosis terkait.
- Kandung kemih neurogenik akibat penyakit sumsum tulang belakang akibat obat atau radiasi, gunakan kode G95.8 (*Other specified diseases of spinal cord*) bersama dengan kode penyebab. Secara eksternal sesuai indikasi dokter, pada kasus dimana dokter menyatakan bahwa hal tersebut disebabkan oleh kanker menyebar ke sumsum tulang belakang, gunakan kode C79.4 (*Secondary malignant neoplasm of other and unspecified parts of nervous system*). Sedangkan pada kasus dimana dokter mendiagnosis bahwa itu adalah akibat dari cedera tulang belakang, gunakan kode T91.3 (*Sequelae of injury of spinal cord*) dengan kode penyebab cedera eksternalnya.

Contoh 2-21	Seorang pasien wanita lanjut usia memiliki gejala inkontinensia urin, tetapi saat batuk atau bersin, tidak ada urin. Pasien mengaku bisa buang air kecil
------------------------	--

	sepenuhnya. Dokter mendiagnosis kandung kemih yang terlalu aktif dengan melakukan studi urodinamik dan menemukan kontraksi yang tidak terhambat.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Kandung kemih yang terlalu aktif	N31.0 <i>Uninhibited neuropathic bladder, not elsewhere classified</i>
Diagnosis Sekunder		

3.11.10 Bladder-Neck Obstruction (N32.0)

Jika dokter mendiagnosis obstruksi leher kandung kemih atau stenosis leher kandung kemih (penyempitan leher kandung kemih), gunakan kode N32.0 (*Bladder-neck obstruction*). Penggunaan kode N32.0 memastikan bahwa diagnosis terklasifikasi sesuai standar internasional (ICD-10), yang penting untuk pelaporan data kesehatan yang akurat dan konsisten dan memperhatikan petunjuk *exclude* pada N32 yaitu *calculus in bladder* (N21.0), *cystocele* (N81.1), *hernia or prolapse of bladder, female* (N81.1). Pastikan dokumentasi medis mencakup informasi lengkap tentang penyebab, metode diagnosis, dan tindakan yang dilakukan untuk memvalidasi penggunaan kode ini.

3.12 MDC 22 SISTEM REPRODUKSI PRIA

Perhatian Khusus Terkait Penginputan iDRG MDC 22

Dalam proses pengkodean tindakan medis di MDC ini, terdapat kode Indonesian Modification (IM) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mendokumentasikan tindakan khusus dengan lebih akurat. Beberapa kode Indonesian Modification yang digunakan antara lain:

- 60.50 *Laparoscopic radical prostatectomy* (IM)
- 64.970 *Revision artificial erection device* (IM)
- 17.25 *Laparoscopic repair inguinal hernia* (IM)
- 63.10 *Microligation for varicocele* (IM)
- 63.11 *Laparoscopic varicocele ligation* (IM)
- 86.060 *Insertion prostatic stent/coil with ultrasound control* (IM)
- 86.061 *Insertion prostatic stent/coil with visual* (IM)
- 60.22 *Transurethral needle ablation prostate* (IM)
- 60.23 *Cryoablation of prostate* (IM)
- 60.24 *Transurethral electric vaporization prostate* (IM)
- 60.25 *High intensity focused ultrasound prostate* (IM)
- 51.120 *Laparoscopic biopsy gonad* (IM)
- 60.290 *Transurethral resection of ejaculatory duct (TURED)* (IM)
- 62.31 *Laparoscopic orchiectomy* (IM)
- 62.50 *Laparoscopic orchidopexy* (IM)
- 62.52 *Laparoscopic orchidopexy fowler stephen* (IM)
- 99.960 *Microsurgical testicular sperm extraction (micro-TESE)* (IM)

Detail lengkap mengenai kode Indonesian Modification dapat dilihat dalam daftar yang telah diterbitkan oleh Kemenkes RI. Penggunaan kode IM wajib dilakukan sesuai dengan tindakan yang terdokumentasi dalam rekam medis pasien untuk memastikan akurasi dan validitas data.

Pemanfaatan kode IM ini sangat penting dalam pengembangan sistem DRG (Diagnosis Related Group) kedepannya, untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data pembiayaan kesehatan nasional.

Selain itu, terdapat DRG khusus untuk tindakan pada MDC 22 yang dilakukan dengan teknik laparoskopi, khususnya untuk tindakan prostatektomi, yaitu "*Radical Prostatectomy Proc. w Laparoscopy*". Untuk tindakan radikal prostatektomi yang dilakukan dengan teknik laparoskopi, diwajibkan menggunakan kode tindakan 60.50 *Laparoscopic radical prostatectomy* (IM).

3.12.1 Hyperplasia of Prostate (N40)

- Obstruksi uretra disebabkan oleh *benign prostatic hypertrophy/hyperplasia* (BPH), tidak boleh dikodekan tambahan karena dianggap sebagai gejala dari BPH dan oleh karena termasuk (*include*) dalam kode N40. (*Hyperplasia of prostate*).

3.13 MDC 23 SISTEM REPRODUKSI WANITA

PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 23

- Perhatikan kriteria *include* dan *exclude* yang berkaitan dengan MDC 23. Untuk kasus eksisi kista dan *adhesiolisis* pada kista vagina N89.8:
 - Tindakan prosedur eksisi pada vagina untuk pengangkatan kista tanpa pengambilan sampel jaringan untuk pemeriksaan histopatologi maka gunakan kode 70.33.
 - Tindakan prosedur pengambilan jaringan untuk *biopsy* maka gunakan kode 70.24.
 - Tindakan prosedur pengangkatan kista secara keseluruhan dan *biopsy* maka gunakan kode 70.33 dan 70.24.
- Dalam proses pengkodean tindakan medis pada MDC ini, sangat penting untuk mencatat secara jelas dan rinci dalam rekam medis mengenai jenis teknik tindakan yang digunakan, apakah dilakukan dengan teknik laparoskopi atau non-laparoskopi. Hal ini dikarenakan sistem iDRG MDC membedakan pengelompokan (grouping) pasien berdasarkan teknik tindakan tersebut. sebagai contoh tindakan 68.61 *Laparoscopic radical abdominal hysterectomy* & 68.71 *Laparoscopic radical vaginal hysterectomy* [LRVH] merupakan prosedur khusus untuk DC *Laparoscopic Radical Hysterectomy Proc.*

PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 23

3.13.1 Inflammatory Disease Of Female Pelvic Organs (N70-N74)

Kode diagnosis untuk peradangan dan infeksi pada organ daerah panggul wanita dirangkum dalam tabel di bawah ini.

Diagnosis	Kode
Abses Tuba falopi	N70.2 <i>Abses tubo-ovarium</i> ^(IM)
Abses Ovarium	N70.2 <i>Abses tubo-ovarium</i> ^(IM)
Abses Tubo-ovarium	N70.2 <i>Abses tubo-ovarium</i> ^(IM)
Radang Rahim, <i>unspecified</i>	N71.9 <i>Inflammatory disease of uterus, unspecified</i>
Radang Rahim Akut	N71.0 <i>Acute inflammatory disease of uterus</i>
Radang Rahim Kronis	N71.1 <i>Chronic inflammatory disease of uterus</i>

- Hasil identifikasi yang menunjukkan penyebab peradangan dan penyebab infeksi memiliki kode tertentu, maka gunakan kode penyebab infeksi yaitu kode *Dagger* (Sangkur) pada Bab 1 ICD-10 bersama dengan kode *Asterisk* (tanda bintang) pada kelompok N74.-
- Hasil identifikasi yang menunjukkan penyebab infeksi tidak memiliki kode tertentu, maka gunakan kode dari kelompok B95 – B97 sebagai *additional code* (kode tambahan) untuk mengidentifikasi penyebab infeksi.

Diagnosis	Kode
Adnexitis	N70.9 <i>Salpingitis and oophoritis, unspecified</i>
Adnexitis akut	N70.0 <i>Acute salpingitis and oophoritis</i>
Adnexitis kronis	N70.1 <i>Chronic salpingitis and oophoritis</i>
Cervicitis	N72 <i>Inflammatory disease of cervix uteri</i>
Endocervicitis	N72 <i>Inflammatory disease of cervix uteri</i>
Endometritis	N71.9 <i>Inflammatory disease of uterus, unspecified</i>
Endometritis akut	N71.0 <i>Acute inflammatory disease of uterus</i>
Endometritis kronis, Pyometra	N71.1 <i>Chronic inflammatory disease of uterus</i>
Eksoservikis	N72 <i>Inflammatory disease of cervix uteri</i>
Metritis	N71.9 <i>Inflammatory disease of uterus, unspecified</i>
Metritis akut	N71.0 <i>Acute inflammatory disease of uterus</i>
Metritis kronis	N71.1 <i>Chronic inflammatory disease of uterus</i>
Oophoritis	N70.9 <i>Salpingitis and oophoritis, unspecified</i>
Oophoritis akut	N70.0 <i>Acute salpingitis and oophoritis</i>
Oophoritis kronis	N70.1 <i>Chronic salpingitis and oophoritis</i>
Parametritis	N73.2 <i>Unspecified parametritis and pelvic cellulitis</i>
Parametritis akut	N73.0 <i>Acute parametritis and pelvic cellulitis</i>
Parametritis kronis	N73.1 <i>Chronic parametritis and pelvic cellulitis</i>
Peritonitis panggul	N73.5 <i>Female pelvic peritonitis, unspecified</i>
Peritonitis panggul akut	N73.3 <i>Female acute pelvic peritonitis</i>
Peritonitis panggul kronis	N73.4 <i>Female chronic pelvic peritonitis</i>
Salpingitis	N70.9 <i>Salpingitis and oophoritis, unspecified</i>
Salpingitis akut	N70.0 <i>Acute salpingitis and oophoritis</i>
Salpingitis kronis	N70.1 <i>Chronic salpingitis and oophoritis</i>
Salpingo-oophoritis	N70.9 <i>Salpingitis and oophoritis, unspecified</i>

Diagnosis	Kode	
Salpingo-oophoritis akut	N70.0	<i>Acute salpingitis and oophoritis</i>
Salpingo-oophoritis kronis	N70.1	<i>Chronic salpingitis and oophoritis</i>

Contoh 1-23	Pasien perempuan datang dengan keluhan nyeri pada bagian bawah perut yang dirasakan di kedua sisi, disertai keputihan yang berwarna seperti nanah. Pada pemeriksaan fisik oleh dokter, ditemukan adanya nyeri tekan di area adneksa (indung telur dan tuba falopi) di kedua sisi. Pemeriksaan apusan serviks menunjukkan keberadaan diplokokus Gram negatif intraseluler yang merupakan ciri khas infeksi gonore. Berdasarkan temuan ini, pasien didiagnosis dengan adenitis gonokokus akut.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	<i>Acute gonococcal adnexitis</i>	A54.2† <i>Gonococcal pelviperitonitis and other gonococcal genitourinary infections</i>
Diagnosis Sekunder	-	N74.3* <i>Female gonococcal pelvic inflammatory disease</i>

Contoh 2-23	Pasien perempuan mengalami nyeri pada bagian bawah perut yang dirasakan di kedua sisi, disertai keputihan yang berwarna seperti nanah. Pada pemeriksaan fisik oleh dokter, ditemukan adanya nyeri tekan di area adneksa (indung telur dan tuba falopi) di kedua sisi. Hasil kultur sekret serviks menunjukkan pertumbuhan bakteri E. coli. Berdasarkan temuan ini, pasien didiagnosis dengan Penyakit Radang Panggul Akut (<i>Acute Pelvic Inflammatory Disease/PID</i>) yang disebabkan oleh infeksi bakteri E. coli.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	<i>Acute Pelvic Inflammatory Disease (PID) due to E. coli</i>	N73.9 Penyakit radang panggul akut, tidak ditentukan
Diagnosis Sekunder	-	B96.2 <i>Escherichia</i> sebagai penyebab penyakit yang diklasifikasikan ke bab lain

- PID terjadi setelah keguguran, kehamilan ektopik, atau kehamilan ovum, maka gunakan Kode O08.0 (*Genital tract and pelvic infection following abortion and ectopic and molar pregnancy*)

3.13.2 Female Pelvic Peritoneal Adhesions (N73.6)

- Kode Umum (Tidak Spesifik Lokasi/Gender), maka gunakan kode K66.0 (*Peritoneal adhesions*) apabila diagnosis menunjukkan adanya perlekatan/penggumpalan pada peritoneum tanpa menyebut lokasi anatomi secara spesifik (misalnya: panggul atau abdomen) atau apabila kondisi tersebut terjadi pada pasien laki-laki.
- Kode Khusus untuk Perempuan (Panggul), maka gunakan kode N73.6 (*Female pelvic peritoneal adhesion*) apabila secara eksplisit menunjukkan bahwa adhesi terjadi di rongga panggul perempuan.
- Adhesi Pasca-Prosedur Medis, maka gunakan kode N99.4 (*Postprocedural pelvic peritoneal adhesions*) jika adhesi muncul setelah operasi atau prosedur di rongga panggul (seperti: histerektomi, operasi kista ovarium). Dokumentasi medis harus mengonfirmasi hubungan kausal antara prosedur dan terjadinya adhesi.
- Adhesi dengan Komplikasi Obstruksi Usus, maka gunakan kode K56.5 (*Intestinal adhesions with obstruction*) jika adhesi menyebabkan penyumbatan usus (seperti: ileus obstruktif).
- Pengode harus memeriksa apakah operasi termasuk dalam laparoskopi atau laparotomi (perut terbuka), hal tersebut dapat mempengaruhi pemilihan kode prosedur serta tingkat keparahan komplikasi.

3.13.3 Disease Of Bartholin's Gland (N75)

- Kode Utama :
 - N75.0 → *Cyst of Bartholin's gland* (kista tanpa tanda infeksi).
 - N75.1 → *Abscess of Bartholin's gland* (kista disertai infeksi/abses).
- Jika Pasien Hamil/Melahirkan :
 - Kode dari Bab 15 (kode O) ICD-10 digunakan sebagai diagnosis utama (misalnya: O23.4 untuk infeksi genital pada kehamilan) dengan menambahkan N75.0/N75.1 menjadi diagnosis tambahan ("*use additional code for spesifik...*").

Ringkasan kode diagnosis dan prosedur untuk kista dan abses kelenjar Bartholin pada tabel berikut.

Diagnosis	Kode
Kista Bartholin	N75.0 <i>Cyst of Bartholin's gland</i>
Selama kehamilan, persalinan dan nifas	O99.8 <i>Other specified diseases and conditions complicating pregnancy, childbirth and the puerperium</i> N75.0 <i>Cyst of Bartholin's gland</i>
Abses Bartholin	N75.1 <i>Abscess of Bartholin's gland</i>
Selama kehamilan	O23.5 <i>Infections of the genital tract in pregnancy</i> N75.1 <i>Abscess of Bartholin's gland</i>
Selama nifas	O86.3 <i>Other genitourinary tract infections following delivery</i> N75.1 <i>Abscess of Bartholin's gland</i>
Prosedur	Kode
Aspirasi Sayatan (dan drainase) Marsupialisasi Eksisi	71.21 <i>Percutaneous aspiration of Bartholin's gland</i> 71.22 <i>Incision of Bartholin's gland</i> 71.23 <i>Marsupialization of Bartholin's gland</i> 71.24 <i>Excision or other destruction of Bartholin's gland</i> 71.29 <i>Other operations on Bartholin's gland</i>

Contoh 3-23	Pasien hamil usia 28 minggu datang ke poliklinik kebidanan dengan keluhan terdapat benjolan di bibir vagina akibat penyumbatan kelenjar Bartholin. Pasien merasa sedikit tidak nyaman saat berjalan, namun tidak mengeluhkan nyeri hebat. Tidak ada demam maupun keputihan.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Komplikasi kehamilan	O99.8 <i>Other specified diseases and conditions complicating pregnancy, childbirth and the puerperium</i>
Diagnosis Sekunder	Kista Bartholin	N75.0 <i>Cyst of Bartholin's gland</i>

Prosedur	-	-
-----------------	---	---

Contoh 4-23	Pasien perempuan tidak hamil dan tidak dalam masa nifas, terdapat benjolan di bibir vagina akibat penyumbatan kelenjar Bartholin. Tidak ada tanda infeksi (seperti kemerahan, nyeri hebat, atau demam).	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Kista Bartholin	N75.0 <i>Cyst of Bartholin's gland</i>
Diagnosis Sekunder	-	-
Prosedur	Aspirasi kista Bartholin	71.21 <i>Percutaneous aspiration of Bartholin's gland</i>

Contoh 5-23	Pasien perempuan, hamil 3 bulan, didiagnosis dengan abses Bartholin dan menjalani operasi marsupialisasi.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Abses Bartholin	O23.5 <i>Infections of the genital tract in pregnancy</i>
Diagnosis Sekunder	-	N75.1 <i>Abscess of Bartholin's gland</i>
Prosedur	Marsupialisasi abses Bartholin	71.23 <i>Marsupialization of Bartholin's gland</i>

Contoh 6-23	Pasien perempuan, 4 minggu postpartum (nifas), didiagnosis dengan abses Bartholin dan menjalani operasi marsupialisasi.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Abses Bartholin	O86.3 <i>Other genitourinary tract infections following delivery</i>
Diagnosis Sekunder	-	N75.1 <i>Abscess of Bartholin's gland</i>
Prosedur	Marsupialisasi abses Bartholin	71.23 <i>Marsupialization of Bartholin's gland</i>

3.13.4 Other Inflammation Of Vagina And Vulva (N76-N77)

- Gunakan kode tambahan (B95-B98) untuk mengidentifikasi agen infeksi yang terjadi pada kasus peradangan jika menggunakan kode N76.-.
- Vaginitis atau vulvovaginitis, maka gunakan kode N76.0 (*Acute vaginitis*) jika kondisi tersebut bersifat akut atau tidak spesifik.
- Vaginitis atau vulvovaginitis sebagai bentuk subakut atau kronis, maka gunakan kode N76.1 (*Subacute and chronic vaginitis*).
- Vulvitis akut atau tidak spesifik, maka gunakan kode N76.2 (*Acute vulvitis*).
- Vulvitis subakut atau kronis, maka gunakan kode N76.3 (*Subacute and chronic vulvitis*).
- Abses atau furunkel pada vulva (kecuali abses kelenjar Bartholin), gunakan kode N76.4 (*Abscess of vulva*).
- Ulkus pada vagina atau vulva, maka kode ditentukan berdasarkan penyebab yang diidentifikasi dokter, seperti infeksi herpes, penyakit menular seksual lain, atau trauma. Ketika penyebab tidak dapat ditentukan, gunakan N76.5 (*Ulceration of vagina* atau N76.6 *Ulceration of vulva*).
- Kasus infeksi jamur Candida di vulva dan/atau vagina, maka gunakan kode B37.3† (*Candidiasis of vulva and vagina*) sebagai kode utama, dengan kode tambahan N77.1 (*Vaginitis, vulvitis, and vulvovaginitis in infectious diseases*).
- Ulkus pada vulva disebabkan oleh infeksi herpes, maka gunakan kode A60.0† (*Herpesviral infection of genitalia*) sebagai kode utama dengan

copyright@ Pusat pembiayaan kesehatan Kemenkes RI.

Dilarang mengcopy atau memperjualbelikan isi dan dokumen ini dalam bentuk apapun

kode tambahan N77.0 (*Ulceration of vulva in infectious diseases*). Untuk ulkus pada vagina atau kombinasi vagina-vulva akibat herpes, kode utama tetap A60.0†, dengan kode tambahan N77.1 .

- Jika diagnosis menyatakan bacterial vaginosis (BV), maka gunakan kode N76.8 (*Other specified inflammation of vagina and vulva*).

3.13.5 Endometriosis (N80.-)

- Kode N80.- digunakan sesuai lokasi endometriosis yang diidentifikasi dokter, antara lain :
 - N80.1 (*Endometriosis of ovary*), digunakan untuk endometrioma atau "kista coklat" di ovarium.
 - N80.3 (*Endometriosis of pelvic peritoneum*), digunakan khusus untuk endometriosis di peritoneum panggul.
 - N80.7 (*Pelvic endometriosis*), digunakan jika endometriosis melibatkan beberapa lokasi di panggul. Kode ini dijadikan diagnosis utama, dengan kode tambahan N80.0–N80.6 untuk spesifikasi lokasi.
- Adenomyoma (tumor jinak rahim) berbeda dengan adenomyosis atau leiomyoma. Kode ICD-10 untuk adenomyoma tergantung pada lokasi, di antaranya:
 - D26.0 (*Other benign neoplasms of cervix uteri*)
 - D26.1 (*Other benign neoplasms of corpus uteri*)
 - D26.7 (*Other benign neoplasms of other parts of uterus*).
 - Jika lokasi tidak spesifik, maka gunakan D26.9 (*Other benign neoplasms of uterus, unspecified*).

3.13.6 Prolapsus Genital (N81)

- *Cystorectocele* (gabungan kistocele dan rektokel), maka gunakan kode N81.7 (*Cystorectocele*) ^(IM) sebagai kode utama. Tidak perlu menambahkan kode N81.1 (*cystocele*) atau N81.6 (*rectocele*) secara terpisah.
- Prolapsus uterovaginal (turunnya rahim dan dinding vagina) yang disertai *cystocele*, *rectocele*, atau *cystorectocele*, kode yang digunakan adalah:
 - N81.2 (*Incomplete uterovaginal prolapse*) untuk keparahan ringan-sedang (Stage 1–2).

- N81.3 (*Complete uterovaginal prolapse*) untuk keparahan berat (Stage 3).
- N81.4 (*Uterovaginal prolapse, unspecified*) jika tingkat keparahan tidak disebutkan.

Kode N81.1, N81.6, atau N81.7 ^(IM) tidak perlu ditambahkan karena istilah "*prolapsus uterovaginal*" sudah mencakup turunnya rahim dan dinding vagina.

- Relaksi perineum atau outlet vagina, gunakan kode N81.8 (*Other female genital prolapse*).
- Prolapsus yang terjadi sebagai komplikasi kehamilan atau persalinan, gunakan kode O34.5 (*Maternal care for other abnormalities of gravid uterus*) sebagai kode utama, dengan kode tambahan dari kelompok N81 sesuai kondisi spesifik.
- Prolapsus vaginal vault pasca-histerektomi (pengangkatan rahim), maka gunakan kode N99.3 (*Prolapsus vaginal vault after hysterectomy*).
- Perawatan bedah tradisional untuk prolaps uterus adalah histerektomi vagina total (TVH). Operasi ini sering kali melibatkan perbaikan satu atau kedua sisi dinding vagina. Kode terkait meliputi:

Operasi	ICD-9-CM 2010
<i>Other and unspecified vaginal hysterectomy</i>	68.59
<i>Repair of cystocele and rectocele</i>	70.50
<i>Repair of cystocele</i>	70.51
<i>Repair of rectocele</i>	70.52

3.13.7 Torsion Of Ovary, Ovarian Pedicle And Fallopian Tube (N83.5)

- Jika diagnosis menyebutkan torsi pada kista atau tumor ovarium non-kanker, gunakan kode N83.5 *Torsion of ovary, ovarian pedicle, and fallopian tube* sebagai kode utama. Kode tambahan diberikan untuk

menyatakan jenis kista atau tumor non-kanker berdasarkan hasil patologi, seperti:

- N80.1 (*Endometriosis of ovary*)
 - N83.0–N83.2 (*Follicular cyst of ovary/Other and unspecified ovarian cysts*)
 - D27 (*Benign neoplasm of ovary*).
 - Jika jenis tumor ovarium belum diketahui sifatnya (menunggu hasil patologi), maka gunakan D39.1 (Neoplasma ovarium dengan perilaku tidak pasti).
 - Jika diagnosis menyatakan torsi pada kanker ovarium (harus disertai hasil patologi), maka gunakan kode C56 (*Malignant neoplasm of ovary*) sebagai kode utama, dengan kode tambahan N83.5 (*Torsion of ovary, ovarian pedicle, and fallopian tube*) untuk menunjukkan komplikasi torsinya.
 - Jika terjadi hasil biopsi pemberi kode harus menyediakan kode tersebut.
- Morfologi tumor juga :

Contoh 7-23	Pasien perempuan dengan nyeri perut hebat secara tiba-tiba, didiagnosis mengalami torsi tumor ovarium kiri. Dilakukan operasi pengangkatan ovarium dan tuba fallopii kiri (<i>left salpingo-oophorectomy</i>). Hasil pemeriksaan patologi menunjukkan tumor tersebut merupakan kista adenoma serosa jinak (<i>benign serous cystadenoma</i>) pada ovarium.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Cystadenoma serosa jinak bengkok ovarium kiri	N83.5 <i>Torsion of ovary, ovarian pedicle and fallopian tube</i>
Diagnosis Sekunder	-	D27 <i>Benign neoplasm of ovary</i>
Prosedur	Salpingo-ooforektomi kiri	65.49 <i>Salpingo-ooforektomi unilateral lainnya</i>

Contoh 8-23	Pasien perempuan dengan nyeri perut hebat secara tiba-tiba, didiagnosis mengalami torsi tumor ovarium kiri. Dilakukan operasi pengangkatan ovarium dan tuba fallopii kiri (<i>left salpingo-oophorectomy</i>). Hasil pemeriksaan patologi
--------------------	---

	menunjukkan tumor tersebut merupakan kista adenokarsinoma serosa papiler (<i>papillary serous cystadenocarcinoma</i>) pada ovarium.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Cystadenocarcinoma serosa papiler bengkok ovarium kiri	C56 <i>Malignant neoplasm of ovary</i>
Diagnosis Sekunder	-	N83.5 <i>Torsion of ovary, ovarian pedicle and fallopian tube</i>
Prosedur	Salpingo-ooforektomi kiri	65.49 <i>Other unilateral salpingo-oophorectomy</i>

3.13.8 Cyst Of Ovary (N83.0-N83.2)

- Kista folikular atau kista korpus luteum, gunakan kode N83.0 (*Follicular cyst of ovary*) dan N83.1 (*Corpus luteum cyst*).
- Kista ovarium jenis lain (misalnya: kista sederhana) atau jenis kista tidak spesifik, maka gunakan kode N83.2 (*Other and unspecified ovarian cysts*).
- *Polycystic ovary* (PCO), *polycystic ovarian syndrome* (PCOS), atau *Sindrom Stein-Leventhal*, maka gunakan kode E28.2 (*Polycystic ovarian syndrome*).
- Kista endometriosis (endometrioma) atau tumor ovarium spesifik (misal: kista dermoid, serous cystadenoma), kode harus disesuaikan dengan bukti pendukung (misal: hasil patologi anatomi). apabila tidak ada bukti yang jelas, pengode wajib melakukan konsultasi kepada dokter untuk konfirmasi diagnosis karena harus mencantumkan hasil PA.

3.13.9 Hyperplasia Endometrial (N85.0-N85.1)

- Hiperplasia endometrium jenis sederhana (simple), kompleks (complex), atau tidak spesifik, maka menggunakan kode N85.0 (*Endometrial glandular hyperplasia*)
- Hiperplasia atipikal (dengan atau tanpa spesifikasi jenis), maka menggunakan kode N85.1 (*Endometrial adenomatous hyperplasia*)

3.13.10 Dysplasia Of Cervix Uteri (N87,-)

Kode dalam kelompok N87.- (*Dysplasia of cervix uteri*) digunakan sesuai diagnosis dokter. Sistem klasifikasi displasia tradisional dan *Cervical intraepithelial neoplasia* (CIN) dapat disetarakan sebagai berikut:

Kode	Deskripsi
N87.0	<i>Mild cervical dysplasia</i>
	CIN grade I
N87.1	<i>Moderate cervical dysplasia</i>
	CIN grade II
N87.2	<i>Severe cervical dysplasia, not elsewhere classified</i>
D06.-	CIN grade III

Kode

N87.2 memiliki pengecualian yang ditetapkan sebagai berikut:

N87.2 (*Severe cervical dysplasia, not elsewhere classified*)

Severe cervical dysplasia NOS

Excludes: *Cervical intraepithelial neoplasia* [CIN], grade III, with or without mention of severe dysplasia (D06.-).

Hal ini berarti:

- *Severe cervical dysplasia*, gunakan kode N87.2.
- Jika diagnosis menyebutkan CIN III, gunakan kode D06.- (*Carcinoma in situ of cervix*), terlepas dari apakah displasia berat disebutkan atau tidak.

Alasan: CIN III merupakan istilah yang lebih luas, mencakup baik *cervical dysplasia* berat maupun *Carcinoma in situ of cervix*. Prinsip ini juga berlaku untuk pemberian kode pada *dysplasia* vagina (N89.0–N89.2) dan kondisi pra kanker vagina lainnya (N90.0–N90.2).

3.13.11 Leucorrhoea (N89.8)

- Penyebab keputihan yang diketahui (misal: infeksi), maka kode disesuaikan penyebabnya.
- *Leucorrhea* tanpa penyebab yang jelas, maka kode yang digunakan adalah N89.8 (*Other specified noninflammatory disorders of vagina*).

3.13.12 Postcoital And Contact Bleeding

- Perdarahan *postcoital* yang tidak disebabkan oleh pemerkosaan (*rape*) dan tidak ditemukan adanya luka, maka gunakan kode N93.01 (*Postcoital bleeding*) ^(IM) sebagai diagnosis utama. Tidak perlu mencantumkan kode penyebab eksternal.
- Perdarahan *postcoital* yang tidak disebabkan oleh luka, maka gunakan kode diagnosis sesuai jenis luka tersebut sebagai diagnosis utama. Jangan gunakan kode N93.01 ^(IM), namun tetap cantumkan kode penyebab eksternal dari cedera.
- Perdarahan kontak (*contact bleeding*), maka gunakan kode N93.00 (*Contact bleeding*) ^(IM) sebagai diagnosis karena kondisi ini tidak dianggap sebagai cedera, sehingga tidak perlu diberikan kode penyebab eksternal.

Contoh 9-23	Pasien perempuan mengalami perdarahan setelah berhubungan seksual. Dokter menemukan perdarahan telah berhenti dan tidak ada luka yang ditemukan, diagnosisnya adalah perdarahan postcoital.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Perdarahan pasca seks	N93.01 <i>Postcoital bleeding</i>
Diagnosis Sekunder	-	-
Penyebab Eksternal		-

Contoh 10-23	Pasien perempuan mengalami perdarahan setelah berhubungan seksual di rumah. Pemeriksaan dalam oleh dokter menemukan perdarahan berasal dari luka pada dinding vagina, dengan diagnosis laserasi mukosa vagina. Penanganan dilakukan dengan menjahit luka pada dinding vagina, tanpa komplikasi.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Laserasi mukosa vagina	S31.4 <i>Open wound of vagina and vulva</i>
Diagnosis Sekunder	-	-
Penyebab Eksternal	Seks di rumah	X58.08 <i>Exposure to other specified factors</i>
Prosedur	Jahitan	70.71 <i>Suture of laceration of vagina</i>

Contoh 11-23	Pasien datang untuk pemeriksaan dalam tahunan. Dokter menemukan adanya perdarahan di permukaan serviks saat menggunakan alat pemeriksaan, dengan diagnosis perdarahan kontak serviks.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Pendarahan kontak serviks	N93.00 <i>Postcoital and contact bleeding</i>
Diagnosis Sekunder	-	-
Penyebab Eksternal		

Contoh 12-23	Pasien perempuan mengalami perdarahan setelah mengalami pemerkosaan di taman umum pada saat jalan santai. Pemeriksaan dalam oleh dokter menemukan perdarahan berasal dari luka di bibir vagina, dengan diagnosis robekan vagina. Penanganan dilakukan dengan menjahit luka di bibir vagina, tanpa komplikasi.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Robekan vagina	S31.4 <i>Open wound of vagina and vulva</i>
Diagnosis Sekunder	-	-
Penyebab Eksternal	Diperkosa di sebuah taman pada saat jalan santai.	Y05.81 <i>Sexual assault by bodily force</i>
Prosedur	Jahitan	71.71 <i>Suture of laceration of vulva or perineum</i>

Contoh 13-23	Pasien datang untuk pemeriksaan dalam tahunan. Dokter menemukan adanya perdarahan di permukaan serviks saat menggunakan alat pemeriksaan, dengan diagnosis perdarahan kontak serviks.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Pendarahan kontak serviks	N93.00 <i>Postcoital and contact bleeding</i>
Diagnosis Sekunder	-	-
Penyebab Eksternal		

3.13.13 Vaginal Bleeding (N93.8-N93.9)

- *Vaginal bleeding* tanpa menyebutkan penyebab atau lokasi perdarahan, maka gunakan kode N93.9 (*Abnormal uterine and vaginal bleeding, unspecified*).

copyright@ Pusat pembiayaan kesehatan Kemenkes RI.

Dilarang mengcopy atau memperjualbelikan isi dan dokumen ini dalam bentuk apapun

- *Abnormal Uterine Bleeding* [AUB], maka gunakan kode N93.9 (*Abnormal uterine and vaginal bleeding, unspecified*).
- Perdarahan yang disebabkan oleh luka (misalnya, luka pada dinding vagina yang terdeteksi saat pemeriksaan dalam), maka gunakan kode sesuai jenis luka, seperti S31.4 (*Open wound of vagina and vulva*) sebagai diagnosis utama dan cantumkan kode penyebab eksternal untuk menjelaskan asal-usul luka.
- *Dysfunctional uterine bleeding* (DUB), maka gunakan kode N93.8 (*Other specified abnormal uterine and vaginal bleeding*)

3.13.14 Menopause (N95)

- *Menopause* atau gejala terkait *menopause* namun tidak menyebutkan jenis menopause (alami atau artifisial), maka gunakan kode N95.1 (*Menopausal and female climacteric states*).
- *Menopause artificial*, maka gunakan kode N95.3 (*States associated with artificial menopause*).
- *Menopause* yang terjadi secara alami atau tidak disebutkan jenisnya, maka gunakan kode N95.0 (*Postmenopausal bleeding*).
- Vaginitis atrofik postmenopausal (radang vagina akibat penipisan jaringan), maka gunakan kode N95.2 (*Postmenopausal atrophic vaginitis*).

3.13.15 Habitual Aborter (N96)

- Pemeriksaan atau penanganan untuk mencari penyebab aborsi habitual pada pasien yang tidak dalam kondisi hamil dan tidak dalam kondisi keguguran, maka gunakan kode N96 (*Habitual aborter*).
- Riwayat aborsi habitual dalam kondisi hamil, maka gunakan kode O26.2 (*Pregnancy care of habitual aborter*).
- Riwayat aborsi habitual dalam kondisi keguguran, maka gunakan kode dalam kelompok O03–O06 (sama seperti kasus keguguran umum).

3.13.16 Female Infertility (N97.-)

Kode dalam kelompok N97.- hanya berlaku untuk pasien wanita. Pilih kode sesuai penyebab infertilitas yang diidentifikasi sebagai berikut:

- Infertilitas dengan penyebab yang tidak diketahui, maka gunakan N97.9 (*Female infertility, unspecified*).

- Infertilitas tidak disebabkan oleh terjadinya ovulasi dan tidak termasuk kelainan ovarium lain, maka gunakan kode N97.0 (*Female infertility associated with anovulation*).
- Infertilitas yang terjadi akibat kelainan tuba fallopi (seperti: penyumbatan atau penyempitan), maka gunakan kode N97.1 (*Female infertility of tubal origin*).
- Infertilitas yang disebabkan oleh kelainan uterus (seperti: mioma atau kelainan bawaan uterus), maka gunakan kode N97.2 (*Female infertility of uterine origin*).
- Infertilitas terkait masalah pria (seperti: oligospermia), maka gunakan kode N97.4 (*Female infertility associated with male factors*) tanpa perlu kode tambahan untuk kondisi pria.
- Infertilitas yang terjadi akibat adhesi peritoneal atau endometriosis, maka gunakan kode N97.5 (*Female infertility associated with peritoneal factors*) dan tambahkan kode kondisi penyebab sebagai diagnosis sekunder.
- Multi-penyebab, maka cantumkan semua kode dan minta dokter menentukan penyebab utama sebagai diagnosis primer.

Kode N97.- tidak digunakan untuk wanita hamil yang datang melahirkan karena infertilitas dianggap telah berakhir sejak kehamilan terjadi.

3.14 MDC 24 KEHAMILAN, PERSALINAN DAN NIFAS

PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 24

- Pada kasus persalinan yang memiliki penyulit, maka yang dijadikan diagnosis utama adalah penyulit persalinannya, sedangkan kode O80-O84 (*Delivery*) digunakan sebagai diagnosis sekunder untuk menunjukkan metode persalinan. Jika tidak terdapat komplikasi atau penyulit persalinan lainnya, maka kode O80-O84 (*Delivery*) dapat digunakan sebagai diagnosis utama. Untuk kode dari kategori Z37.- merupakan hasil persalinan (*outcome delivery*) yang harus ditetapkan pada episode persalinan ibu, untuk mengidentifikasi hasil akhir persalinan, seperti kelahiran hidup tunggal, kelahiran mati atau kelahiran kembar. Kode Z37.- dapat ditempatkan sebagai diagnosis sekunder namun tidak boleh sebagai diagnosis utama.
- Untuk kasus abortus yang dilakukan kuretase, kode 69.02 (*Dilation and curettage following delivery or abortion*) digunakan untuk terminasi kehamilan akibat abortus, sedangkan kode 69.09 (*Other dilation and curettage*) digunakan untuk kuretase selain abortus. Kode dalam kategori Z37.- hasil persalinan (*outcome delivery*) tidak boleh digunakan pada pasien yang telah menjalani pengguguran kehamilan atau mengalami keguguran yang mengakibatkan kelahiran janin mati saat berada di rumah sakit. Kode O95–O99 digunakan jika ada kondisi penyakit atau kelainan yang menyertai kehamilan atau persalinan.
- Prosedur induksi persalinan dengan menggunakan obat-obatan menggunakan kode 73.4 (*Medical induction of labor*). Jika induksi persalinan dengan alat dilatasi servikal menggunakan kode 73.1 (*Other surgical induction of labour*), sedangkan akselerasi persalinan pada saat pasien sudah dalam kondisi persalinan menggunakan kode 73.99 (*Other operations assisting delivery, other*).
- Persalinan normal pada pasien dengan Riwayat SC sebelumnya, menggunakan kode O75.7 (*Vaginal delivery following previous cesarean section*). Sedangkan shock pasca bersalin menggunakan kode O75.1 (*Shock during or following labour and delivery*).
- Prosedur episiotomy menggunakan kode 73.6 (*Episiotomy*). Tindakan *episiorrhaphy* tidak dikoding terpisah apabila dilakukan setelah episiotomi pada episode perawatan yang sama. Tindakan *repair* pada rutin *episiotomy* saat persalinan normal menggunakan kode 73.6. Jika didapatkan robekan perineum

spontan ataupun robekan perineum tambahan diluar *episiotomy*, maka kode O70.- (*Perineal laceration during delivery*) harus ditambahkan, serta kode 75.69 (*Repair of other current obstetric laceration*) juga ditambahkan jika dilakukan *repair perineum*.

- Jika dilakukan tindakan lain bersamaan dengan tindakan SC, dapat ditambahkan kode di bawah ini:
 - Kode 66.39 (*Other bilateral destruction or occlusion of fallopian tubes*) untuk sterilisasi tuba
 - Kode 69.99 (*Other operations on cervix and uterus*) untuk B-Lynch atau tindakan jahitan kompresi uterus lainnya
 - Kode 68.39 (*Other and unspecified subtotal abdominal hysterectomy, NOS*) untuk subtotal histerektomi
 - Kode 68.4 (*Total abdominal hysterectomy*) untuk total histerektomi
 - Kode 68.29 (*Other excision or destruction of lesion of uterus*) untuk eksisi uterus pada kasus reseksi uterus pada plasenta akreta.
- Jika didapatkan upaya untuk melakukan devaskularisasi pada uterus untuk menurunkan jumlah perdarahan, dapat juga dikode 38.86 untuk ligasi arteri iliaka / uterina / neovaskularisasi uterovesika dan kode 38.84 untuk kompresi aorta.
- Jika terdapat *multiple delivery* dengan 2 kombinasi cara bersalin yang berbeda, gunakan kode O84.8 untuk melengkapi kaidah koding persalinan.
- Kriteria kondisi yang menggunakan kode O80:
 - Kode O80 *Single spontaneous delivery* hanya digunakan ketika persalinan sepenuhnya normal dengan satu kelahiran hidup, tidak ada komplikasi pasca persalinan, dan komplikasi antepartum selama kehamilan harus sudah teratasi sebelum waktu persalinan. Berikut merupakan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi agar kode O80 dapat digunakan dengan benar:
 - a. Persalinan sepenuhnya normal (memerlukan bantuan minimal atau tidak sama sekali, dengan atau tanpa episiotomi)
 - b. Tidak terdapat manipulasi janin (misalnya: rotasi) atau instrumentasi (forsep)
 - c. Terjadi persalinan spontan, melalui kepala dan vagina

- d. Presentasi saat persalinan hanya bisa berupa *cephalic* (kepala) atau oksipital. Istilah seperti “*right occipito-anterior* (ROA)”, “*left occipito-anterior* (LOA)”, “*right occipito-posterior* (ROP)”, “*left occipito-posterior* (LOP)”, dan “*vertex*” menggambarkan presentasi oksipital. Presentasi lainnya seperti bokong, wajah, atau alis (dahi), tidak memperbolehkan penggunaan kode O80.
- e. Setiap komplikasi antepartum yang dialami selama kehamilan harus sudah diatasi sebelum waktu persalinan
- f. Tidak terdapat kelainan yang mungkin terjadi pada persalinan atau melahirkan
- g. Tidak ada komplikasi pasca persalinan yang mungkin terjadi
- h. Tidak boleh dilakukan prosedur selain prosedur berikut ini : episiotomi tanpa forsep, *episiorrhaphy*, *amniotomy* (pecahnya selaput ketuban secara buatan), persalinan dengan bantuan manual tanpa forsep, pemberian analgesik dan/atau anestesi, pemantauan janin, induksi persalinan (jika tidak ada indikasi medis), dan sterilisasi. Jika prosedur lain dilakukan, kode O80 tidak dapat ditetapkan.
- i. *Outcome of delivery* harus berupa kelahiran hidup tunggal (Z37.0 *Single live birth*). Jika terjadi kelahiran ganda atau kelahiran mati, kode O80 tidak dapat ditetapkan.

PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 24

3.14.1 Ectopic Pregnancy (O00)

- Kode dalam kelompok O08.- (*Complications following abortion and ectopic and molar pregnancy*) digunakan sebagai diagnosis sekunder jika pasien mengalami komplikasi seperti perdarahan berat yang memerlukan transfusi darah (O08.1) atau syok (O08.3).
 - Jika komplikasi ini menjadi fokus perawatan pada episode kunjungan saat ini, baik terjadi selama episode rawat jalan maupun rawat inap, kode O08.- menjadi diagnosis utama.
 - Jika kondisi pada kategori O08.- muncul atau terjadi pada asuhan yang sama untuk kehamilan ektopik dan abortusnya (O00-O07), baik

pada asuhan rawat inap atau rawat jalan, maka kode primernya adalah kondisi kehamilan ektopik dan abortusnya (O00-O07) dan diikuti kode sekunder O08.- yang sesuai. Hal tersebut dikarenakan kode O08.- bukan merupakan kondisi yang menjadi dasar pertemuan atau yang paling bertanggung jawab terhadap asuhan pasien (prinsip diagnosis utama).

- Jika kondisi pada kategori O08.- muncul atau terjadi pada episode berikutnya diluar asuhan untuk abortusnya, misal dirawat kembali pasca 3 hari *curettage* dengan *Delayed Excessive haemorrhage* (O08.1), maka kode O08.1 harus dipilih sebagai satu-satunya sebagai kode primer dan kode dari O00-O07 tidak boleh diberikan kembali.
- Kode O00.0 (*Abdominal pregnancy*) hanya digunakan jika dokter memastikan janin telah meninggal, namun jika janin masih hidup, gunakan kode O36.7 (*Maternal care for viable fetus in abdominal pregnancy*).
- Kehamilan tuba diobati dengan obat (misalnya metotreksat), maka gunakan kode Z51.2 (Kemoterapi lainnya) sebagai diagnosis sekunder untuk mencatat penggunaan obat, tanpa perlu kode prosedur tambahan.
- Untuk prosedur salpingektomi (pengangkatan tuba fallopi), baik total atau parsial, yang dilakukan melalui laparotomi atau laparoskopi, gunakan kode 66.62 (*Salpingectomy with removal of tubal pregnancy*) dalam ICD-9-CM.
 - Jika salpingektomi disertai pengangkatan ovarium sepihak, maka untuk laparotomi gunakan kode 66.62 + 65.39 (*Other oophorectomy unilateral*), dan untuk laparoskopi gunakan kode 66.62 + 65.31 (*Oophorectomy unilateral laparoscopy*). Dalam ICD-10-IM, kode prosedur bedah untuk kehamilan tuba mengikuti aturan umum yang sama dengan prosedur lainnya.

Contoh 1-24	Seorang pasien wanita berusia 25 tahun tidak mendapat menstruasi. Pemeriksaan ultrasonografi menemukan adanya massa di tuba falopi kiri. Dokter mendiagnosis kehamilan tuba kiri yang tidak pecah dan mengobatinya dengan metotreksat.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Kehamilan tuba kiri yang tidak pecah	O00.1 <i>Tubal pregnancy</i>
Diagnosis Sekunder		Z51.2 <i>Other chemotherapy</i>
Prosedur	-	-

Contoh 2-24	Pasien perempuan berusia 25 tahun, mengalami amenore (tidak menstruasi), nyeri perut, pucat, dan tekanan darah rendah. Dokter mendiagnosis kehamilan ektopik disertai syok dan melakukan operasi darurat. Pada pembedahan, ditemukan kehamilan tuba kiri yang ruptur dengan perdarahan di rongga perut sebanyak 1.500 mililiter. Pasien mendapat transfusi 3 unit Packed Red Cells (PRC) dan menjalani reseksi segmental tuba falopi kiri.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Kehamilan tuba kiri pecah	O00.1 <i>Tubal pregnancy</i>
Diagnosis Sekunder	Pendarahan intraperitoneal	O08.1 <i>Delayed or excessive haemorrhage following abortion and ectopic and molar pregnancy</i>
	Syok	O08.3 <i>Shock following abortion and ectopic and molar pregnancy</i>
Operasi	Reseksi segmental tuba falopi kiri	66.62 <i>Salpingectomy with removal of tubal pregnancy</i>
Prosedur	RRC 3 unit	99.04 <i>Transfusion of packed cells</i>

3.14.2 Abortion (O03-O08)

Kode diagnosis abortus dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan penyebab:

- O03 (*Spontaneous abortion*), digunakan jika dokter mendiagnosis abortus yang terjadi secara alami (tanpa intervensi).
- O04 (*Medical abortion*), digunakan jika abortus dilakukan atas indikasi medis ([legal](#) atau [terapeutik](#)).
- O05 (*Other abortion*), digunakan jika abortus dilakukan tanpa indikasi medis (misal: ilegal).
- O06 (*Unspecified abortion*), digunakan jika dokter tidak menyebutkan jenis abortus secara spesifik.

Kode dalam kelompok O03–O06 harus menggunakan 4 digit. Digit keempat menunjukkan kelengkapan abortus (lengkap/tidak lengkap) serta adanya komplikasi (misal: perdarahan, infeksi, atau syok). Apabila tidak disebutkan secara spesifik dalam rekam medis apakah abortus bersifat lengkap atau tidak, maka kode empat digit tetap harus digunakan, *subcategory* abortus lengkap (*complete*) dapat dipilih sebagai *default*.

Perhatikan saat menggunakan kode *Complications following abortion and ectopic and molar pregnancy* (O08.-). Kode ini tidak digunakan sebagai kode utama untuk “kondisi utama”, kecuali jika episode perawatan baru difokuskan sepenuhnya untuk pengobatan komplikasi, misalnya komplikasi saat ini dari aborsi sebelumnya. Kode ini dapat digunakan sebagai kode tambahan opsional bersama kategori O00–O02 untuk mengidentifikasi komplikasi yang menyertai, dan bersama kategori O03–O07 untuk memberikan rincian lebih lengkap mengenai komplikasi tersebut. Perlu diperhatikan bahwa istilah-istilah yang tercantum pada sub kategori O08 harus dijadikan acuan saat menentukan subdivisi karakter keempat dari kategori O03–O07.

Contoh 1:

Kondisi utama : Kehamilan tuba yang pecah disertai syok

Spesialisasi : Ginekologi

Kode yang digunakan sebagai “kondisi utama” adalah kehamilan tuba yang pecah (O00.1).

Kode O08.3 (Syok setelah aborsi serta kehamilan ektopik dan mola) dapat digunakan sebagai kode tambahan opsional.

Contoh 2:

Kondisi utama : Aborsi tidak lengkap dengan perforasi rahim

Spesialisasi : Ginekologi

Kode yang digunakan sebagai “kondisi utama” adalah aborsi tidak lengkap dengan komplikasi lain dan tidak spesifik (O06.3).

Kode O08.6 (Kerusakan pada organ dan jaringan panggul setelah aborsi serta kehamilan ektopik dan mola) dapat ditambahkan sebagai kode tambahan opsional.

Contoh 3:

Kondisi utama : Koagulasi intravaskular diseminata (DIC) setelah aborsi yang dilakukan dua hari lalu di fasilitas lain

Spesialisasi : Ginekologi

Kode yang digunakan adalah O08.1 (Perdarahan tertunda atau berlebihan setelah aborsi serta kehamilan ektopik dan mola).

Tidak diperlukan kode lain karena aborsi tersebut dilakukan pada episode perawatan sebelumnya

Kode abortus harus mencerminkan diagnosis akhir, yang mungkin berbeda dari diagnosis awal. Jika diagnosis akhir tidak jelas atau tidak lengkap (misalnya, tidak menyebutkan jenis abortus), mintalah dokter untuk merevisi diagnosis agar kode yang diberikan lebih spesifik.

Contoh 3-24	Pasien hamil 8 minggu, dokter mendiagnosis kematian janin (fetal demise) dan pasien dirawat untuk menjalani kuretase uterus	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Kematian janin	O02.1 <i>Missed abortion</i>

Diagnosis Sekunder	-	-
Prosedur	Kuret	69.02 <i>Dilation and curettage following delivery or abortion</i>

Contoh 4-24	Pasien hamil 8 minggu, dokter mendiagnosis kehamilan mola lengkap dan pasien dirawat untuk menjalani kuretase uterus dengan alat vakum	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Kehamilan mola lengkap	O01.0 <i>Classical hydatidiform mole</i>
Diagnosis Sekunder	-	-
Prosedur	Kuret hisap	69.59 <i>Other aspiration curettage of uterus</i>

Contoh 5-24	Pasien hamil 8 minggu mengalami perdarahan ringan. Dokter mendiagnosis abortus mengancam (<i>threatened abortion</i>) dan pasien dirawat untuk istirahat hingga perdarahan berhenti	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Aborsi yang terancam	O20.0 <i>Threatened abortion</i>
Diagnosis Sekunder	-	-
Prosedur	-	-

Contoh 6-24	Pasien hamil 8 minggu mengalami perdarahan ringan. Dokter mendiagnosis awal sebagai abortus mengancam (<i>threatened abortion</i>) dan pasien dirawat untuk istirahat. Dua hari kemudian, pasien mengalami abortus spontan yang tidak lengkap, sehingga dilakukan kuretase uterus. Diagnosis akhir adalah abortus spontan tidak lengkap.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode

Diagnosis Primer	Aborsi spontan tidak lengkap	O03.4 <i>Spontaneous abortion</i>
Diagnosis Sekunder	-	-
Prosedur	Kuret	69.02 <i>Dilation and curettage following delivery or abortion</i>

Contoh 7-24	Pasien hamil 8 minggu mengalami abortus spontan tidak lengkap di rumah. Dokter mendiagnosis kondisi tersebut sebagai abortus spontan tidak lengkap dan pasien dirawat untuk menjalani kuretase uterus guna membersihkan sisa produk konsepsi di dalam rahim.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Aborsi spontan tidak lengkap	O03.4 <i>Spontaneous abortion</i>
Diagnosis Sekunder	-	-
Prosedur	Kuret	69.02 <i>Dilation and curettage following delivery or abortion</i>

Contoh 8-24	Pasien hamil 8 minggu mengalami abortus tidak lengkap di rumah. Dokter mendiagnosis sebagai abortus tidak lengkap dan pasien dirawat untuk menjalani kuretase uterus guna membersihkan sisa jaringan konsepsi di dalam rahim.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Aborsi tidak lengkap	O06.4 <i>Unspecified abortion</i>
Diagnosis Sekunder	-	-
Prosedur	Kuret	69.02 <i>Dilation and curettage following delivery or abortion</i>

Jika pasien dirawat dengan diagnosis awal abortus tak terhindarkan (*inevitable abortion*) dan janin kemudian keluar secara spontan tanpa intervensi medis, kode diagnosis ditentukan berdasarkan hasil akhir, yaitu jika abortus lengkap (O03.5 - O03.9) atau abortus tidak lengkap (O03.0 -

O03.4). Namun, jika pada saat perawatan dokter segera melakukan tindakan kuretase uterus tanpa menunggu hasil konsepsi keluar secara spontan, maka diagnosis akhir yang tepat adalah abortus tertunda (*missed abortion*), yaitu kondisi dimana janin telah meninggal di dalam rahim namun belum dikeluarkan oleh tubuh secara alami. Kode diagnosis yang digunakan dalam kasus ini adalah O02.1.

Contoh 9-24	Pasien hamil 8 minggu mengalami perdarahan. Dokter mendiagnosis awal sebagai abortus tak terhindarkan (<i>inevitable abortion</i>). Selanjutnya, pasien mengalami abortus spontan lengkap tanpa memerlukan tindakan kuretase uterus.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Aborsi lengkap spontan	O03.9 <i>Spontaneous abortion, complete or unspecified, without complication</i>
Diagnosis Sekunder	-	-
Prosedur	-	-

Contoh 10-24	Pasien hamil 8 minggu mengalami perdarahan hebat. Dokter mendiagnosis awal sebagai abortus tak terhindarkan (<i>inevitable abortion</i>) dan pasien dirawat untuk menjalani kuretase uterus.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Aborsi yang terlewatkan	O02.1 <i>Missed abortion</i>
Diagnosis Sekunder	-	-
Prosedur	Kuret	69.02 <i>Dilation and curettage following delivery or abortion</i>

- Jika pasien dirawat saat tidak hamil, maka gunakan kode N96 (*Habitual aborter*) (misalnya, pasien dengan riwayat keguguran berulang yang dirawat untuk evaluasi penyebab atau pemantauan sebelum kehamilan berikutnya).

- Jika pasien dirawat selama kehamilan dengan riwayat keguguran berulang, maka gunakan kode O26.2 (*Pregnancy care of habitual aborter*) (misalnya, pasien dengan riwayat abortus habitual yang dirawat untuk pemantauan kehamilan tanpa komplikasi)
- Jika terjadi abortus sebelum atau selama perawatan, maka gunakan kode sesuai jenis abortus (misal: O03.- *Spontaneous abortion*) dan tidak perlu kode O26.2 lagi dikarenakan fokus perawatan dilakukan pada abortus yang terjadi saat ini

Contoh 11-24	Pasien pada kehamilan ke-4, usia 10 minggu, mengalami perdarahan ringan dengan riwayat 3 kali abortus spontan berturut-turut pada trimester pertama. Dokter mendiagnosis awal sebagai abortus habitualis disertai abortus mengancam dan pasien dirawat untuk istirahat total. Tiga hari kemudian, pasien mengalami abortus spontan lengkap tanpa memerlukan kuretase uterus	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Aborsi lengkap spontan	O03.9 <i>Spontaneous abortion</i>
Diagnosis Sekunder	-	-
Prosedur	-	-

Secara umum, kode pada kelompok O08.- (Komplikasi Pasca-Abortus, Kehamilan Ektopik, dan Kehamilan Mola) digunakan sebagai diagnosis sekunder atau kode penyakit penyerta untuk mengidentifikasi jenis komplikasi yang terjadi akibat abortus, kehamilan ektopik, atau kehamilan mola. Kode utama tetap harus merujuk ke kelompok O00–O07 (misalnya, O03.- *Spontaneous abortion*, O00.- *Ectopic pregnancy*, atau O01.- *Hydatidiform mole*).

Contoh 12-24	Pasien menjalani tindakan aborsi 2 hari sebelumnya dan datang dengan keluhan nyeri perut hebat. Dokter mendiagnosis perforasi uterus (robekan pada dinding rahim) dan pasien dirawat untuk menjalani histerektomi (pengangkatan rahim)	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode

Diagnosis Primer	Perforasi rahim	O08.6 <i>Damage to pelvic organs and tissues following abortion and ectopic and molar pregnancy</i>
Diagnosis Sekunder	-	-
Operasi	Histerektomi perut total	68.49 <i>Other and unspecified total abdominal hysterectomy</i>

3.14.3 Termination of Pregnancy (O04.- O05)

Jika dokter menyatakan abortus terapeutik/medisinalis (*Medical abortion*), gunakan kode O04.- sebagai diagnosis utama. Kode alasan terminasi (misal: kelainan janin atau masalah kesehatan ibu) dalam kelompok O35.- (*Maternal care for known or suspected fetal abnormality and damage*) atau O36.- (*Maternal care for other known or suspected fetal problems*) digunakan sebagai diagnosis sekunder untuk masalah janin serta koding O lainnya untuk problem spesifik pada Ibu.

Jika terminasi kehamilan menghasilkan bayi hidup (*live birth*), meskipun bayi meninggal kemudian, kondisi ini tidak dianggap sebagai abortus, tetapi sebagai persalinan preterm. Kode diagnosis mengikuti aturan persalinan preterm dengan indikasi medis. Selain itu, terminasi kehamilan setelah 20 minggu dengan indikasi medis juga tidak dikategorikan sebagai abortus, tetapi sebagai persalinan. Kode diagnosis utama adalah alasan terminasi, disertai kode O80-O84 (*Delivery*) dan Z37.- (*Outcome of delivery*).

Contoh 13-24	Dokter melakukan terminasi kehamilan pada usia 19 minggu karena janin didiagnosis dengan sindrom Down . Bayi tunggal lahir dengan berat 400 gram dalam keadaan hidup, tetapi meninggal dalam 2 jam kemudian. Plasenta lahir lengkap tanpa komplikasi. Diagnosis akhir dokter adalah <i>abortus terapeutikus</i> akibat <i>sindrom Down</i> pada janin	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Aborsi terapeutik karena janin Down sindrom	O35.1 <i>Maternal care for (suspected) chromosomal abnormality in fetus</i>
Diagnosis Sekunder	-	O60.3 <i>Preterm delivery without spontaneous labour</i>

		Z37.0 <i>Single live birth</i>
--	--	--------------------------------

Contoh 14-24	Pasien mengalami perdarahan hebat hingga memerlukan transfusi darah pada usia kehamilan 32 minggu, belum mengalami kontraksi persalinan. Dokter mendiagnosis plasenta previa dan melakukan operasi caesar darurat dengan insisi transversal rendah . Bayi tunggal lahir dengan berat 1.800 gram dalam keadaan hidup. Diagnosis akhir dokter adalah plasenta previa dan persalinan prematur .	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Plasenta previa	O44.1 <i>Placenta praevia with haemorrhage</i>
Diagnosis Sekunder	Persalinan preterm	Ø60.3 <i>Preterm delivery without spontaneous labour</i> O82.1 <i>Delivery by emergency caesarean section</i> Z37.0 <i>Single live birth</i>
Operasi	Operasi caesar melintang rendah darurat	74.1 <i>Low cervical cesarean section</i>

3.14.4 Gangguan Hipertensi (O10-O16)

- O14.- (*Gestational [pregnancy-induced] hypertension with significant proteinuria*). Kode O14.0 (*Moderate pre-eclampsia*). Kode ini digunakan untuk menggantikan diagnosis pre-eklampsia ringan (atau preeklampsia tanpa tanda pemberatan) yang ditandai dengan adanya hipertensi ≥ 20 minggu dengan proteinuri minimal +1. Dikarenakan perkembangan terbaru preeklampsia, kode O14.1 digunakan sesuai definisi severe preeklampsia (atau preeklampsia dengan tanda pemberatan) seperti adanya hipertensi berat disertai proteinuria minimal +1 atau hipertensi dengan gangguan target organ lainnya (meskipun tanpa proteinuria) termasuk kondisi impending eklampsia. Penetapan kode diagnosis harus disesuaikan dengan derajat keparahan klinis dan kriteria diagnosis terkini, bukan berdasarkan istilah “ringan” atau “berat” dalam dokumentasi medis lama.

- O10.9 digunakan untuk (*Unspecified pre-existing hypertension complicating pregnancy, childbirth and the puerperium*). Kode ini digunakan jika dokter hanya menyebut "hipertensi kronis" tanpa spesifikasi jenisnya.
- O11 (*Pre-existing hypertensive disorder with superimposed proteinuria*), digunakan untuk kondisi hipertensi kronis atau hipertensi jenis apapun yang telah ada sebelum kehamilan, yang kemudian diperburuk atau diperberat dengan adanya proteinuria selama kehamilan saat ini. Kondisi ini sering kali berkembang menjadi pre-eklampsia yang tumpang tindih (*superimposed preeclampsia*). Kode O11 dapat digunakan tanpa memandang usia kehamilan, artinya dapat diterapkan baik pada trimester awal maupun lanjut, selama memenuhi kriteria tersebut.. Pada kondisi *superimposed preeclampsia* dimana didapatkan tanda pemberatan, maka kode O14.1 (*severe preeclampsia*) dapat ditambahkan
- O12.- (*Gestational [pregnancy-induced] oedema and proteinuria without hypertension*), digunakan untuk edema atau proteinuria gestasional tanpa hipertensi.
- O13 digunakan untuk (*Gestational [pregnancy-induced] hypertension without significant proteinuria*), ditujukan pada kondisi hipertensi gestasional yaitu adanya hipertensi tanpa didapatkan proteinuria signifikan.
- Jika dokter mendiagnosis eklampsia (pre-eklampsia disertai kejang), mintalah spesifikasi waktu kejang:
 - O15.0 (*Eclampsia in pregnancy*) (saat hamil)
 - O15.1 (*Eclampsia in labour*) (saat persalinan)
 - O15.2 (*Eclampsia in the puerperium*) (pasca persalinan)
 - O15.9 (*Eclampsia, unspecified as to time period*)

3.14.5 Excessive Vomiting in Pregnancy (O21,-)

Jika dokter mendiagnosis *hyperemesis gravidarum*, pengode harus memeriksa catatan medis untuk menilai tingkat keparahan. Muntah ringan yang tidak memenuhi kriteria tersebut tidak boleh dikodekan dalam kategori ini, meskipun berhubungan langsung dengan kehamilan. Selain itu, usia kehamilan dan ada tidaknya gangguan elektrolit harus diperhatikan, karena

faktor-faktor ini mempengaruhi pemilihan subkategori yang tepat. Jika ada tanda deplesi karbohidrat seperti bukti tubuh kurus (penurunan berat badan), dehidrasi (dehidrasi), atau ke elektrolit (ketidakseimbangan elektrolit), gunakan kode O21.1 (*Hyperemesis gravidarum with metabolic disturbance*) sebagai diagnosis utama. Gangguan metabolik yang terjadi dapat dikoding terpisah jika dilakukan penatalaksanaan spesifik terhadap gangguan tersebut. Jika pasien yang dirawat karena muntah berlebihan atau berat yang dimulai sebelum akhir minggu ke-22 kehamilan, tanpa adanya gangguan metabolik, gunakan kode O21.0 (*Mild hyperemesis gravidarum*). Untuk diagnosis muntah berlebihan atau berat dimulai setelah usia kehamilan 22 minggu lengkap, baik dengan atau tanpa gangguan metabolik, gunakan kode O21.2 (*Late vomiting of pregnancy*).

3.14.6 Infections of Genitourinary Tract in Pregnancy (O23, O41.1, O85, O86, O98)

Jika infeksi yang didiagnosis memiliki kode spesifik berawalan "O", seperti:

- O23.- (*Infections of genitourinary tract in pregnancy*)
- O41.1 (*Infection of amniotic sac and membranes*)
- O85 (*Puerperal sepsis*)
- O86.- (*Other puerperal infections*),

maka gunakan kode tersebut. Jika informasi kurang lengkap, tambahkan kode standar penyakit terkait. Jika patogen penyebab diidentifikasi, gunakan kode B95-B97 untuk spesifikasi patogen.

Untuk infeksi atau penyakit parasit yang muncul/memperburuk kondisi selama kehamilan, persalinan, atau masa nifas, dan memerlukan penanganan obstetri, serta tidak memiliki kode "O" spesifik, gunakan O98.- (*Maternal infectious and parasitic disease complicating pregnancy, childbirth, and the puerperium*) sebagai diagnosis utama, disertai kode standar penyakit tersebut. Pengecualian berlaku untuk:

- Z21, R75 (*Asymptomatic human immunodeficiency virus [HIV] infection status*),
- A34 (*Obstetrical tetanus*),
- O85-O86 (*Other puerperal infections*),

- O35-O36 (*Maternal care for other known or suspected fetal problems*), yang tidak menggunakan kode O98.- (*Maternal infectious and parasitic diseases classifiable elsewhere but complicating pregnancy, childbirth and the puerperium*)

Pada setiap akun subkode dalam grup O98.- (*Maternal infectious and parasitic diseases classifiable elsewhere but complicating pregnancy, childbirth and the puerperium*) disebutkan dengan jelas, bahwa setiap kode dalam kelompok ini digunakan untuk penyakit menular yang kode normalnya, seperti O98.0 (*Tuberculosis complicating pregnancy, childbirth and the puerperium*). Kondisi pada A15-A19 (*Respiratory tuberculosis, not confirmed bacteriologically or histologically*). Ini berarti bahwa kode O98.0 harus digunakan sebagai kode diagnosis utama. Bila penyakit menular dengan kode A15-A19 terjadi pada masa kehamilan, persalinan atau masa nifas.

Contoh 15-24	Pasien Hamil 20 Minggu dengan Demam, Nyeri Punggung, dan Diagnosis <i>Acute Pyelonephritis</i> dari <i>E. coli</i>	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Pielonefritis akut dari <i>E. coli</i>	O23.0 <i>Infections of kidney in pregnancy</i>
Diagnosis Sekunder	Kehamilan 20 minggu	N10 <i>Acute tubulo-interstitial nephritis</i> B96.2 <i>Escherichia coli [E. coli] as the cause of diseases classified to other chapters</i>

Contoh 16-24	Pasien Hamil 16 Minggu dengan Diagnosis Pulmonary Tuberculosis dan Dirawat Inap	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Tuberkulosis paru	O98.0 <i>Tuberculosis complicating pregnancy, childbirth and the puerperium</i>
Diagnosis Sekunder	Kehamilan 16 minggu	A16.2 <i>Tuberculosis of lung, without mention of bacteriological or histological confirmation</i>

Contoh 17-24	Pasien Hamil 18 Minggu dengan Diagnosis <i>Abses Bartholin Akibat Gonore</i> dan Penanganan <i>Marsupialization</i>	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Abses Bartholin gonokokus	O98.2 <i>Gonorrhoea complicating pregnancy, childbirth and the puerperium</i>
Diagnosis Sekunder		A54.1 <i>Gonococcal infection of lower genitourinary tract with periurethral and accessory gland abscess</i>
Prosedur	Marsupilasi	71.23 <i>Marsupialization of Bartholin's gland (cyst)</i>

Contoh 18-24	Pasien dengan infeksi HIV asimtomatik, kehamilan cukup bulan, melahirkan secara spontan dengan presentasi belakang kepala, dan mendapatkan bayi tunggal yang hidup	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Persalinan simpul spontan	O80.0 <i>Spontaneous vertex delivery</i>
Diagnosis Sekunder	Infeksi HIV tanpa gejala	Z21 <i>Asymptomatic human immunodeficiency virus [HIV] infection status</i> Z37.0 <i>Single live birth</i>
Prosedur	Persalinan normal	73.59 <i>Other manually assisted delivery</i>

Contoh 19-24	Pasien AIDS, hamil 20 minggu, dokter mendiagnosisnya dengan tuberkulosis paru, dirawat di rumah sakit	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Tuberkulosis paru	O98.7 <i>Human immunodeficiency [HIV] disease complicating pregnancy, childbirth and the puerperium</i>
Diagnosis Sekunder	Penyakit HIV	B20.0 <i>HIV disease resulting in mycobacterial infection</i>

	Kehamilan 20 minggu	A16.2 <i>Tuberculosis of lung, without mention of bacteriological or histological confirmation</i>
--	---------------------	--

Contoh 20-24	Pasien sedang hamil 28 minggu dan dokter mendiagnosis diare menular dan memasukkannya untuk dirawat.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Diare menular	O98.8 <i>Other maternal infectious and parasitic diseases complicating pregnancy, childbirth and the puerperium</i>
Diagnosis Sekunder	Kehamilan 28 minggu	A09.0 <i>Other and unspecified gastroenteritis and colitis of infectious origin</i>

3.14.7 Diabetes Mellitus in Pregnancy (O24)

Jika pasien telah menderita diabetes sebelum kehamilan, maka pengkodean disesuaikan dengan jenis diabetesnya, yakni gunakan kode O24.0 untuk diabetes tipe 1 (insulin-dependent) dan O24.1 untuk diabetes tipe 2 (non-insulin-dependent). Apabila jenis diabetes yang disebutkan tidak spesifik, gunakan kode O24.3 (*pre-existing diabetes mellitus, unspecified*). Dalam kasus di mana pasien memiliki diabetes tipe 2 sebelum hamil dan tidak menggunakan insulin, tetapi kemudian memerlukan insulin selama kehamilan, tetap gunakan kode O24.1, karena jenis diabetesnya tidak berubah. Sementara itu, jika diabetes baru terdiagnosis selama masa kehamilan (gestational diabetes), gunakan kode O24.4 (*diabetes mellitus arising in pregnancy*).

O24.9 (*diabetes mellitus in pregnancy, unspecified*) hanya digunakan jika dokter tidak menyebutkan apakah diabetes sudah ada sebelum hamil atau tidak serta tidak memungkinkan untuk verifikasi ulang. Kode O24.2 (*pre-existing malnutrition-related diabetes*) tidak relevan dalam praktik saat ini. Jika hasil 50 g GCT positif, gunakan O28.8 (*abnormal findings on antenatal screening*).

3.14.8 Maternal Care for Known or Suspected Malpresentation of Fetus (O32,-)

Gunakan kode O32.- (*Maternal care for known or suspected malpresentation of fetus*) jika malpresentasi menjadi alasan rawat inap atau keputusan operasi sesar sebelum onset persalinan. Jika malpresentasi menyebabkan *obstructed labour* (persalinan tersumbat) setelah persalinan dimulai, gunakan kode O64.- (*Obstructed labour due to malpresentation*). Jika dokter tidak mencantumkan adanya *obstructed labour*, tetap gunakan O32.- sebagai diagnosis utama.

Contoh 21-24	Pasien hamil 39 minggu, belum mengalami nyeri persalinan. Dokter menemukan presentasi bokong janin (malpresentasi) dan memutuskan untuk melakukan operasi sesar elektif transversal rendah (<i>elective low transverse cesarean section</i>). Bayi lahir hidup dengan berat 3.400 gram, dalam keadaan sehat dan tidak ada komplikasi.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Presentasi sungsang	O32.1 <i>Maternal care for breech presentation</i>
Diagnosis Sekunder	Kehamilan 39 minggu	O82.0 <i>Delivery by elective caesarean section</i>
		Z37.0 <i>Single live birth</i>
Operasi	Operasi caesar melintang rendah elektif	74.1 <i>Low cervical cesarean section</i>

Contoh 22-24	Pasien hamil 39 minggu, datang dengan nyeri persalinan dari rumah. Dokter menemukan presentasi bokong janin (malpresentasi) dan terindikasi obstruksi persalinan maka dokter memutuskan untuk melakukan operasi sesar darurat transversal rendah (<i>emergency low transverse cesarean section</i>). Bayi lahir hidup dengan berat 3.400 gram, dalam keadaan sehat dan tidak ada komplikasi	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Presentasi sungsang	O64.1 <i>Obstructed labour due to breech presentation</i>
Diagnosis Sekunder	Kehamilan 39 minggu	O82.1 <i>Delivery by emergency caesarean section</i>
		Z37.0 <i>Single live birth</i>

Operasi	Operasi caesar melintang rendah elektif	74.1 <i>Low cervical cesarean section</i>
----------------	---	---

3.14.9 Maternal Care For Known Or Suspected Disproportion (O33.-, O64-O66)

Gunakan kode O33.- (*Maternal care for known or suspected disproportion*) jika ketidaksesuaian menjadi alasan utama intervensi medis, seperti operasi sesar. Jika CPD menjadi indikasi operasi sesar setelah persalinan dimulai, tetapi tidak menyebabkan *obstructed labour* kemacetan/distosia, tetap gunakan O33.- sebagai diagnosis utama.

Jika terjadi *obstructed labour*, gunakan kode dalam kelompok O64.- (*Obstructed labour due to malposition and malpresentation of fetus*), O65.- (*Obstructed labour due to maternal pelvic abnormality*), atau O66.- (*Other obstructed labour*) sesuai penyebab yang dicantumkan dokter.

O33.9 (*Maternal care for disproportion, unspecified*) mencakup kasus CPD/FPD yang tidak spesifik. Jika dokter hanya mencantumkan "CPD", gunakan O33.9 (bukan kode O64-O66).

Contoh 23-24	Pasien hamil cukup bulan, dokter mendiagnosis panggul sempit dan menjadwalkan untuk operasi sesar transversal rendah (<i>low transverse cesarean section</i>). Bayi tunggal lahir hidup.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Panggul sempit	O33.1 <i>Maternal care for disproportion due to generally contracted pelvis</i>
Diagnosis Sekunder	-	O82.0 <i>Delivery by elective cesarean section</i>
		Z37.0 <i>Single live birth</i>
Operasi	Operasi caesar melintang rendah elektif	74.1 <i>Low cervical cesarean section</i>

Contoh 24-24	Pasien hamil cukup bulan, mengalami nyeri persalinan selama 12 jam dan belum masuk inpartu. Dokter mendiagnosis <i>cephalopelvic disproportion</i> (ketidaksesuaian antara kepala janin dan panggul ibu) dan melakukan operasi sesar darurat transversal rendah (<i>low transverse cesarean section</i>). Bayi tunggal lahir hidup.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Disproporsi cephalopelvic	O33.9 <i>Maternal care for disproportion, unspecified</i>
Diagnosis Sekunder	-	O82.1 <i>Delivery by emergency caesarean section</i>
		Z37.0 <i>Single live birth</i>
Operasi	Operasi caesar melintang rendah darurat	74.1 <i>Low cervical cesarean section</i>

Contoh 25-24	Pasien hamil cukup bulan, mengalami nyeri persalinan selama 12 jam. Dokter mendiagnosis <i>obstructed labor due to cephalopelvic disproportion</i> (persalinan tersumbat akibat ketidaksesuaian antara kepala janin dan panggul ibu) dan melakukan operasi sesar darurat transversal rendah (<i>low transverse cesarean section</i>). Bayi tunggal lahir hidup.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Persalinan terhambat karena disproporsi cephalopelvic	O65.4 <i>Obstructed labour due to fetopelvic disproportion, unspecified</i>
Diagnosis Sekunder	Kehamilan cukup bulan	O82.1 <i>Delivery by emergency caesarean section</i>
Operasi	Operasi caesar melintang rendah darurat	74.1 <i>Low cervical cesarean section</i>

Contoh 26-24	Pasien hamil cukup bulan, pembukaan serviks mencapai 7 cm tetapi tidak mengalami pembukaan lebih lanjut selama lebih dari 2 jam. Dokter mendiagnosis <i>secondary arrest of dilatation</i> (penghentian sekunder pembukaan serviks) dan melakukan operasi sesar darurat transversal rendah (<i>low transverse caesarean section</i>). Bayi tunggal lahir hidup.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Penangkapan sekunder dilatasi	O66.9 <i>Obstructed labour, unspecified</i>
Diagnosis Sekunder	Kehamilan cukup bulan	O82.1 <i>Delivery by emergency caesarean section</i>
		Z37.0 <i>Single live birth</i>
Operasi	Operasi caesar melintang rendah darurat	74.1 <i>Low cervical cesarean section</i>

3.14.10 Maternal Care for Tumour of Corpus Uteri (O34.1)

Jika dokter mendiagnosis bahwa wanita hamil memiliki mioma uteri, gunakan kode O34.1 (*Maternal care for tumour of corpus uteri*) sebagai diagnosis utama. Selain itu, tambahkan kode D25.- (*Leiomyoma of uterus*) sebagai diagnosis tambahan. Jika mioma uteri menyebabkan persalinan tersumbat, gunakan kode O65.5 (*Obstructed labour due to abnormality of maternal pelvic organs*).

Contoh 27-24	Pasien hamil 30 minggu, mengeluh nyeri perut. Dokter menemukan adanya mioma intramural berukuran 5 cm di daerah fundus uteri dan mendiagnosis sebagai degenerated myoma uteri (mioma uteri yang mengalami degenerasi). Pasien diberikan pengobatan simptomatik dan dipulangkan tanpa persalinan.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Mioma intramural yang merosot	O34.1 <i>Maternal care for tumour of corpus uteri</i>
Diagnosis Sekunder	Kehamilan 30 minggu	D25.1 <i>Intramural leiomyoma of uterus</i>
Operasi	-	-

Contoh 28-24	Pasien hamil cukup bulan, mengalami nyeri persalinan. Dokter menemukan mioma intramural berukuran besar di bagian bawah rahim yang menyebabkan janin tidak dapat turun ke jalan lahir. Diagnosis ditegakkan sebagai obstructed labour due to large intramural myoma (persalinan tersumbat akibat mioma intramural besar). Dilakukan operasi sesar darurat (emergency caesarean section), dan bayi tunggal lahir hidup.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Persalinan terhambat karena mioma intramural yang besar	O65.5 <i>Obstructed labour due to abnormality of maternal pelvic organs</i>
Diagnosis Sekunder	Kehamilan cukup bulan	D25.1 <i>Intramural leiomyoma of uterus</i>
		O82.1 <i>Delivery by emergency caesarean section</i>
		Z37.0 <i>Single live birth</i>
Operasi	Operasi caesar melintang rendah darurat	74.1 <i>Low cervical cesarean section</i>

3.14.11 Maternal Care for Other Abnormalities of Cervix (O34.4)

Jika dokter mendiagnosis bahwa wanita hamil atau dalam masa nifas mengalami kanker serviks, gunakan kode O34.4 (*Maternal care for other abnormalities of cervix*) sebagai diagnosis utama. Selain itu, tambahkan kode dari kelompok C53.- (*Malignant neoplasm of cervix uteri*) sebagai diagnosis tambahan.

Contoh 29-24	Pasien sedang hamil 16 minggu dan didiagnosis dengan karsinoma sel skuamosa serviks stadium IB1. Histerektomi abdomen radikal dengan janin dalam kandungan dan limfadenektomi panggul dilakukan.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Karsinoma sel skuamosa serviks stadium IB1	O34.4 <i>Maternal care for other abnormalities of cervix</i>
Diagnosis Sekunder	Kehamilan 16 minggu	C53.1 <i>Exocervix</i>

Operasi	Histerektomi perut radikal dengan limfadenektomi panggul	68.69 <i>Other and unspecified radical abdominal hysterectomy</i> 40.3 <i>Regional lymph node excision</i>
ICD-O	Karsinoma sel skuamosa	M8070/3 <i>Squamous cell carcinoma NOS</i>

Contoh 30-24	Pasien didiagnosis dengan karsinoma sel skuamosa serviks stadium IB1 pada usia kehamilan 32 minggu. Dokter bedah melakukan histerektomi caesar radikal elektif dengan limfadenektomi panggul. Pada usia kehamilan 34 minggu, satu janin hidup lahir.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Karsinoma sel skuamosa serviks stadium IB1	O34.4 <i>Maternal care for other abnormalities of cervix</i>
Diagnosis Sekunder	Persalinan prematur	C53.1 <i>Exocervix</i>
		O82.2 <i>Delivery by caesarean hysterectomy</i>
		O60.3 <i>Preterm delivery without spontaneous labour</i>
		Z37.0 <i>Single live birth</i>
Operasi	Histerektomi caesarean radikal dengan limfadenektomi panggul	74.4 <i>Cesarean section of other specified type</i>
		68.69 <i>Other and unspecified radical abdominal hysterectomy</i>
		40.3 <i>Regional lymph node excision</i>
ICD-O	Karsinoma sel skuamosa	M8070/3 <i>Squamous cell carcinoma NOS</i>

3.14.12 Premature Rupture of Membranes (O42.)-

Kode dalam grup O42 (*Premature rupture of membranes*) dibagi menjadi sub-kategori 4 digit berdasarkan durasi waktu antara ketuban pecah hingga mulainya kontraksi persalinan.

copyright@ Pusat pembiayaan kesehatan Kemenkes RI.

Dilarang mengcopy atau memperjualbelikan isi dan dokumen ini dalam bentuk apapun

Kode dalam kelompok O42 dibagi berdasarkan waktu antara pecahnya ketuban hingga onset persalinan:

- O42.0 (*Premature rupture of membranes, onset of labour within 24 hours*): Jika waktu antara pecahnya ketuban hingga onset persalinan ≤ 24 jam.
- O42.1 (*Premature rupture of membranes, onset of labour after 24 hours*): Jika waktu antara pecahnya ketuban hingga onset persalinan >24 jam.
- O42.9 (*Premature rupture of membranes, unspecified*): Jika durasi tidak disebutkan. Hal penting yang harus diperhatikan oleh pengode adalah diagnosis dokter sering kali menghitung waktu dari ketuban pecah hingga bayi lahir karena ada hubungannya dengan risiko infeksi pada ketuban. Durasi ini biasanya lebih lama daripada waktu yang dihitung hingga mulainya kontraksi. Oleh karena itu, pemberian kode dalam grup ini harus memeriksa waktu ketuban pecah dan waktu mulai kontraksi persalinan.
- Kode O42.2 (*Premature rupture of membranes, labour delayed by therapy*) digunakan dalam kasus ketika dokter mendiagnosis bahwa ketuban pecah sebelum kontraksi dimulai, dan dokter memberikan perawatan sehingga pasien dapat pulang tanpa melahirkan. Kondisi ini biasanya ditemukan pada kehamilan yang belum cukup bulan. Dalam kasus di mana ada kecurigaan ketuban pecah namun setelah diperiksa ternyata tidak pecah, dan dokter memulangkan pasien tanpa proses persalinan, kode diagnosis utama yang digunakan adalah Z36.8 (*Other antenatal screening*).

3.14.13 False Labour (O47,-)

- Jika dokter menyimpulkan diagnosis sebagai *labour pain*, pengode harus mencari tahu diagnosis akhirnya dan meminta dokter untuk mengubah diagnosis agar didapatkan kode yang sesuai. Istilah *labour pain* hanya digunakan sebagai diagnosis awal, sehingga tidak memiliki kode.
- Jika pasien masuk rumah sakit dan dokter mendiagnosis *false labour*, pengode harus meminta dokter untuk menentukan usia kehamilan pasien saat dirawat, apakah sudah mencapai 37 minggu atau belum, untuk memilih kode yang tepat dalam kelompok O47.- (*False labour*).

- Jika pasien dengan kondisi hamil cukup bulan dan mengalami rasa sakit persalinan secara alami, namun dokter kemudian mendiagnosis bahwa terdapat penyulit yang mengharuskan pasien tersebut dirujuk ke rumah sakit lain karena rumah sakit tersebut tidak memiliki sumber daya yang memadai, maka gunakan kode penyulit persalinan sebagai diagnosis utama dan Z75.3 sebagai kode diagnosis sekunder.

Contoh 31-24	Pasien hamil cukup bulan, mengalami rasa sakit persalinan. Dokter mendiagnosis awal sebagai <i>labour pain</i> , melahirkan secara spontan dengan presentasi kepala tanpa episiotomi, mendapatkan bayi tunggal hidup.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Persalinan spontan kepala	O80.0 <i>Spontaneous vertex delivery</i>
Diagnosis Sekunder	Kehamilan cukup bulan	Z37.0 <i>Single live birth</i>
Prosedur	Persalinan normal tanpa episiotomi	73.59 <i>Other manually assisted delivery</i>

Contoh 32-24	Pasien hamil cukup bulan, mengalami rasa sakit persalinan secara alami. Dokter mendiagnosis awal sebagai <i>labour pain</i> dan menerima pasien untuk proses persalinan. Selanjutnya, dokter mendiagnosis adanya cephalopelvic disproportion (ketidaksesuaian antara ukuran kepala bayi dan panggul ibu). Namun, karena rumah sakit tidak dapat melakukan operasi caesar, pasien dirujuk untuk menjalani operasi caesar di rumah sakit lain.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Disproporsi cephalopelvic	O33.9 <i>Maternal care for disproportion, unspecified</i>
Diagnosis Sekunder	-	Z75.3 <i>Unavailability and inaccessibility of health-care facilities</i>
Prosedur	-	-

3.14.14 Preterm Labour and Delivery (O60.-)

- Kode O60.0 (*Preterm labour and delivery*) digunakan ketika dokter mendiagnosis bahwa pasien mulai merasakan kontraksi persalinan sebelum usia kehamilan mencapai 37 minggu penuh dan dipulangkan sebelum melahirkan.
- Kode O60.1 (*Preterm labour with preterm delivery*) digunakan ketika dokter mendiagnosis bahwa pasien mulai merasakan kontraksi persalinan dan melahirkan sebelum usia kehamilan mencapai 37 minggu penuh.
- Kode O60.2 (*Preterm spontaneous labour with term delivery*) digunakan ketika dokter mendiagnosis bahwa pasien mulai merasakan kontraksi persalinan secara alami sebelum usia kehamilan mencapai 37 minggu penuh, tetapi melahirkan setelah usia kehamilan mencapai 37 minggu penuh.
- Kode O60.3 (*Preterm delivery without spontaneous labour*) digunakan ketika dokter mendiagnosis bahwa pasien melahirkan sebelum usia kehamilan mencapai 37 minggu penuh tanpa mengalami kontraksi persalinan secara alami, mungkin karena diinduksi untuk persalinan atau menjalani operasi caesar sebelum mulai merasakan sakit persalinan.

Contoh 34-24	Pasien hamil 32 minggu mengalami rasa kontraksi persalinan. Dokter mendiagnosis <i>preterm labour</i> (persalinan prematur) dan memberikan obat untuk menekan kontraksi rahim hingga rasa sakit persalinan hilang. Pasien kemudian dipulangkan ke rumah tanpa melahirkan.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Persalinan prematur	O60.0 <i>Preterm spontaneous labour without delivery</i>
Diagnosis Sekunder	-	-
Prosedur	-	-

Contoh 35-24	Pasien hamil 32 minggu mengalami rasa sakit persalinan. Dokter mendiagnosis preterm labour (persalinan prematur) dan memberikan obat untuk menekan kontraksi rahim, namun tidak berhasil. Dua hari kemudian, pasien melahirkan secara spontan dengan presentasi kepala dengan episiotomi, bayi tunggal hidup.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Persalinan spontan kepala	O60.1 <i>Preterm labour with preterm delivery</i>
Diagnosis Sekunder	Persalinan prematur	O80.0 <i>Spontaneous vertex delivery</i>
		Z37.0 <i>Single live birth</i>
Prosedur	Persalinan normal dengan episiotomi	73.59 <i>Other manually assisted delivery</i>

Contoh 36-24	Pasien mulai merasakan sakit persalinan pada usia kehamilan 36 minggu lebih, dan melahirkan secara spontan dengan presentasi kepala dengan episiotomi saat usia kehamilan mencapai 37 minggu. Bayi yang dilahirkan adalah bayi tunggal hidup.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Persalinan spontan kepala	O60.2 <i>Preterm spontaneous labour with term delivery</i>
Diagnosis Sekunder	-	O80.0 <i>Spontaneous vertex delivery</i>
		Z37.0 <i>Single live birth</i>
Prosedur	Persalinan normal dengan episiotomi	73.59 <i>Other manually assisted delivery</i>

Contoh 37-24	Pasien mulai merasakan sakit persalinan pada usia kehamilan 36 minggu lebih, dan melahirkan saat usia kehamilan mencapai 37 minggu dengan bantuan <i>low forceps</i> serta dilakukan episiotomi. Dokter mencatat indikasi sebagai <i>maternal exhaustion</i> (kelelahan pada ibu), mendapatkan bayi tunggal hidup.
-------------------------	--

	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Kelelahan pada ibu	O75.8 Komplikasi persalinan dan persalinan tertentu lainnya
Diagnosis Sekunder	-	O60.2 <i>Preterm spontaneous labour with term delivery</i>
		O81.0 <i>low forceps delivery</i>
		Z37.0 <i>Single live birth</i>
Prosedur	Ekstraksi forseps rendah dengan episiotomi	72.1 <i>Low forceps operation with episiotomy</i>

Contoh 38-24	Pasien hamil 35 minggu, dokter mendiagnosis <i>oligohydramnios</i> (cairan ketuban kurang) dan menjadwalkan operasi caesar dengan teknik low transverse caesarean section, mendapatkan bayi tunggal hidup	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Oligohidramnios	O41.0 <i>Oligohydramnios</i>
Diagnosis Sekunder	Persalinan prematur	O60.3 <i>Preterm delivery without spontaneous labour</i>
		O82.0 <i>Delivery by elective caesarean section</i>
		Z37.0 <i>Single live birth</i>
Operasi	Operasi caesar melintang rendah elektif	74.1 <i>Low cervical cesarean section</i>

3.14.15 Intrapartum Haemorrhage and Postpartum Haemorrhage (O67,-, O72.-)

- *Intrapartum haemorrhage* tanpa menyebutkan penyebabnya, kode yang digunakan adalah dalam kelompok O67.- (*Labour and delivery complicated by intrapartum haemorrhage, not elsewhere classified*). Namun, jika penyebabnya jelas, seperti plasenta previa atau solusio

plasenta, kode untuk penyebab tersebut digunakan sebagai diagnosis utama, sedangkan kode O67.- digunakan sebagai diagnosis tambahan atau komplikasi.

- *Postpartum haemorrhage*, pengode harus meminta dokter untuk mencatat diagnosis secara lebih rinci, termasuk penyebabnya, untuk memilih kode yang sesuai dalam kelompok O72.- (*Postpartum haemorrhage*).
 - Kode O72.0 (*Third-stage haemorrhage*) digunakan ketika dokter mendiagnosis perdarahan pada tahap pengeluaran plasenta yang sering disebabkan oleh retensi plasenta (*retained placenta*). Jika dokter mendiagnosis bahwa perdarahan disebabkan oleh plasenta yang melekat terlalu dalam, seperti *placenta accreta*, *placenta increta*, atau *placenta percreta*, maka kode O72.0 digunakan bersama dengan kode O43.2 (*Morbidly adherent placenta*).
 - Kode O72.1 (*Other immediate postpartum haemorrhage*) digunakan ketika dokter mendiagnosis perdarahan postpartum yang terjadi dalam 24 jam pertama setelah persalinan, yang sering kali disebabkan oleh atonia uteri (rahim tidak berkontraksi dengan baik), serta dalam kasus di mana dokter tidak menyebutkan penyebab perdarahan postpartum.
 - Kode O72.2 (*Delayed and secondary postpartum haemorrhage*) digunakan ketika dokter mendiagnosis perdarahan yang terjadi lebih dari 24 jam hingga 12 minggu setelah persalinan yang sering diakibatkan sisa-sisa plasenta atau membran ketuban yang tertinggal di dalam rongga rahim setelah persalinan, termasuk kasus late postpartum haemorrhage.
 - Dalam pengkodean perdarahan postpartum, pengode harus fokus pada waktu terjadinya perdarahan, bukan pada penyebabnya, yaitu O72.1 untuk perdarahan dalam 24 jam pertama dan O72.2 untuk perdarahan yang terjadi setelah 24 jam. Penyebab perdarahan dapat dikodekan terpisah jika tercatat, namun tidak menjadi dasar dalam pemilihan antara kedua subkategori ini.
 - Kode O72.3 (*Postpartum coagulation defect*) digunakan ketika dokter mendiagnosis bahwa perdarahan disebabkan oleh gangguan pembekuan darah.

3.14.16 Fetal Distress (O68.-)

- Kode dalam kelompok O68.- (*Labour and delivery complicated by fetal stress [distress]*) digunakan sesuai dengan bukti yang mendukung diagnosis *fetal distress* yang ditentukan oleh dokter. Kode ini hanya diterapkan jika ibu mengalami komplikasi persalinan akibat distress janin.
- Jika distress janin terdeteksi atau dicurigai tetapi tidak menyebabkan komplikasi selama persalinan, maka kode O68 tidak boleh diberikan. Sebagai gantinya, gunakan kode O36.3 (*Maternal care for signs of fetal hypoxia*) yang lebih tepat untuk mencerminkan manajemen ibu terkait tanda-tanda hipoksia janin.
- Jika tidak ada informasi tambahan yang spesifik mengenai komplikasi yang ditimbulkan oleh *fetal distress*, gunakan kode O68.9 (*Labour and delivery complicated by fetal stress, unspecified*). Dalam pengkodean, penting untuk memperhatikan apakah distress janin menyebabkan komplikasi dalam persalinan, karena ini akan menjadi dasar dalam pemilihan kode yang sesuai dari kategori ini.
- Jika dokter mendiagnosis *non-reassuring fetal status*, gunakan kode O68.8 (*Labour and delivery complicated by other evidence of fetal stress*).

3.14.17 Perineal and Vaginal Laceration during Delivery (O70.-, O71.4)

- Kode dalam kelompok O70.- (*Perineal laceration during delivery*) hanya digunakan jika dokter mendiagnosis bahwa robekan perineum terjadi selama persalinan, baik tanpa episiotomi atau sebagai tambahan dari episiotomi yang telah dilakukan. Jika dokter tidak menyebutkan derajat robekan, pengode harus selalu meminta klarifikasi kepada dokter, karena tidak boleh memberikan kode O70.- tanpa diagnosis yang jelas dari dokter.
- Jika dokter mendiagnosis bahwa pasien memiliki robekan pada dinding vagina yang tidak berhubungan dengan episiotomi atau tidak ada robekan perineum, gunakan kode O71.4 (*Obstetric high vaginal laceration alone*).

3.14.18 Delivery (O80-O84)

- Untuk memilih kode diagnosis utama bagi pasien yang melahirkan, pertimbangkan urutan prioritas berikut:

- Urutan Pertama: Jika persalinan dilakukan dengan tindakan obstetrik, seperti operasi caesar, penggunaan forseps, penggunaan alat vakum, atau bantuan persalinan sungsang, gunakan kode indikasi untuk tindakan obstetrik tersebut sebagai kode diagnosis utama.
- Urutan Kedua: Jika persalinan normal tetapi ada penyakit penyerta atau komplikasi selama perawatan, gunakan kode untuk diagnosis penyerta atau komplikasi yang paling parah menurut dokter, yang terdapat dalam kategori huruf "O" sebagai kode diagnosis utama.
- Urutan Ketiga: Jika persalinan normal tanpa penyakit penyerta atau komplikasi, gunakan kode metode persalinan (O80 - O84) sebagai kode diagnosis utama.
- Dengan demikian, kode metode persalinan (O80 - O84) hanya dapat digunakan sebagai kode diagnosis utama jika tidak ada kode diagnosis lain yang dimulai dengan huruf "O" pada episode perawatan ini. Artinya, hanya berlaku untuk kasus persalinan normal tanpa penyakit penyerta atau komplikasi.
- Gunakan kode hasil persalinan dalam kelompok Z37.- (*Outcome of delivery*) sebagai kode diagnosis sekunder untuk semua pasien yang melahirkan. Kode dalam kelompok ini tidak boleh digunakan sebagai kode diagnosis utama dalam situasi apa pun. Bahkan jika dokter tidak mencatat hasil persalinan dalam resume medis (ringkasan pulang), adalah tanggung jawab pengode untuk mencari informasi hasil persalinan dari bagian lain rekam medis, seperti catatan persalinan atau ringkasan persalinan.
- Dalam persalinan pervaginam, jika dokter tidak mencatat apakah episiotomi dilakukan atau tidak, adanya robekan perineum atau tidak, pengode harus mencari informasi mengenai episiotomi dari rekam medis atau bertanya kepada dokter untuk memastikan keakuratan kode. Jika tidak ditemukan informasi mengenai episiotomi, diasumsikan bahwa episiotomi tidak dilakukan.
- Pada kehamilan kembar, setiap bayi dapat dilahirkan dengan metode yang sama atau berbeda. Kode metode persalinan untuk kelahiran kembar terdapat dalam kelompok O84.- (*Multiple delivery*).

Contoh 40-24	Pasien hamil cukup bulan melahirkan secara spontan dengan presentasi kepala dengan episiotomy, mendapatkan bayi tunggal hidup. Dokter mencatat bahwa ketuban pecah 20 jam sebelum mulai merasakan sakit persalinan.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Pengiriman simpul spontan	O42.0 <i>Premature rupture of membranes, onset of labour within 24 hours</i>
Diagnosis Sekunder	Pecahnya membran dini (PROM) 20 jam	O80.0 <i>Spontaneous vertex delivery</i>
		Z37.0 <i>Single live birth</i>
Prosedur	Persalinan normal dengan episiotomi	73.59 <i>Other manually assisted delivery</i>

Contoh 41-24	Pasien dengan diabetes gestasional hamil cukup bulan melahirkan secara spontan dengan presentasi kepala dengan episiotomi, mendapatkan bayi tunggal hidup.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Persalinan spontan kepala	O24.4 <i>Diabetes mellitus arising in pregnancy</i>
Diagnosis Sekunder	Diabetes gestasional	O80.0 <i>Spontaneous vertex delivery</i>
		Z37.0 <i>Single live birth</i>
Prosedur	Persalinan normal dengan episiotomi	73.59 <i>Other manually assisted delivery</i>

Contoh 42-24	Pasien hamil cukup bulan dengan bekas luka SC dijadwalkan menjalani operasi SC dengan teknik <i>low transverse caesarean section</i> , bayi tunggal hidup	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Bekas luka SC	O34.2 <i>Maternal care due to uterine scar from previous surgery</i>
Diagnosis Sekunder		O82.0 <i>Delivery by elective caesarean section</i>
		Z37.0 <i>Single live birth</i>
Operasi	Operasi caesar melintang rendah elektif	74.1 <i>Low cervical cesarean section</i>

Contoh 43-24	Pasien hamil cukup bulan melahirkan secara spontan dengan presentasi kepala dengan episiotomi, mendapatkan bayi tunggal hidup. Namun, pasien mengalami perdarahan postpartum sebanyak 600 mililiter akibat atonia uteri (rahim tidak berkontraksi dengan baik).	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Persalinan spontan kepala	O72.1 <i>Other immediate postpartum haemorrhage</i>
Diagnosis Sekunder		O80.0 <i>Spontaneous vertex delivery</i>
		Z37.0 <i>Single live birth</i>
Komplikasi	Pendarahan pasca persalinan	-
Operasi	Persalinan normal dengan episiotomi	73.59 <i>Other manually assisted delivery</i>

Pada contoh 43-24, dokter menyimpulkan persalinan verteks spontan sebagai diagnosis utama dan menyimpulkan perdarahan pascapersalinan. Hal ini dikarenakan perdarahan merupakan penyakit penyerta karena pendarahan

terjadi di kemudian hari, tetapi pembuat kode memberikan kode O72.1 (*Other immediate postpartum haemorrhage*) sebagai kode diagnosis utama, karena kode O80.0 (*Spontaneous vertex delivery*) akan menjadi kode diagnosis utama hanya jika dirawat inap dan saat itu belum ada kode diagnosis lain yang diawali dengan huruf “O”, sehingga kode diagnosis terkait adalah kode O80.0. Dalam contoh ini, dokter menyimpulkan dengan benar dan pembuat kode juga membuat kode dengan benar.

3.14.19 Caesarean section (O82.-)

- Jika dokter mencatat indikasi untuk seksio sesarea sebagai *previous caesarean section* atau *previous uterine scar*, baik dalam kasus seksio sesarea elektif maupun darurat, gunakan kode O34.2 (*Maternal care due to uterine scar from previous surgery*) sebagai kode diagnosis utama, dan gunakan kode untuk seksio sesarea O82.0 (*Delivery by elective caesarean section*) atau O82.1 (*Delivery by emergency caesarean section*) sebagai kode diagnosis sekunder.
- Jika dokter mendiagnosis *elective caesarean section* tanpa menyebutkan diagnosis sekunder atau komplikasi lain, gunakan kode O82.0 (*Delivery by elective caesarean section*) sebagai kode diagnosis utama.

Contoh 44-24	Pasien hamil cukup bulan mengalami perdarahan tanpa rasa sakit persalinan. Dokter melakukan pemeriksaan ultrasonografi dan menemukan <i>placenta previa</i> (plasenta menutupi jalan lahir). Pasien kemudian menjalani operasi caesar darurat dengan teknik <i>low transverse caesarean section</i> , bayi tunggal hidup.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Perdarahan antepartum	O44.1 <i>Placenta praevia with haemorrhage</i>
Diagnosis Sekunder	Plasenta previa	O82.1 <i>Delivery by emergency caesarean section</i>
		Z37.0 <i>Single live birth</i>
Operasi	Operasi caesar melintang rendah darurat	74.1 <i>Low cervical cesarean section</i>

Contoh 45-24	Pasien hamil cukup bulan dengan riwayat operasi miomektomi yang melibatkan rongga rahim. Dokter merencanakan persalinan melalui operasi caesar elektif dengan teknik <i>low transverse caesarean section</i> , bayi tunggal hidup.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Miomektomi sebelumnya	O34.2 <i>Maternal care due to uterine scar from previous surgery</i>
Diagnosis Sekunder	-	O82.0 <i>Delivery by elective caesarean section</i>
		Z37.0 <i>Single live birth</i>
Operasi	Operasi caesar melintang rendah darurat	74.1 <i>Low cervical cesarean section</i>

Contoh 46-24	Pasien hamil cukup bulan dengan bekas luka SC. Dokter merencanakan persalinan melalui operasi caesar elektif, tetapi pasien mulai merasakan sakit persalinan sebelum hari yang ditentukan. Akibatnya, dokter melakukan operasi caesar darurat dengan teknik <i>low transverse caesarean section</i> , bayi tunggal hidup.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Bekas luka SC	O34.2 <i>Maternal care due to uterine scar from previous surgery</i>
Diagnosis Sekunder	-	O82.1 <i>Delivery by emergency caesarean section</i>
		Z37.0 <i>Single live birth</i>
Operasi	Operasi caesar melintang rendah darurat	74.1 <i>Low cervical cesarean section</i>

Contoh 47-24	Pasien hamil cukup bulan meminta untuk melahirkan melalui operasi caesar atas permintaan sendiri. Dokter merencanakan persalinan melalui operasi
-------------------------	--

	caesar elektif dengan teknik <i>low transverse caesarean section</i> , bayi tunggal hidup.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Operasi caesar elektif	O82.0 <i>Delivery by elective caesarean section</i>
Diagnosis Sekunder	-	Z37.0 <i>Single live birth</i>
Operasi	Operasi caesar melintang rendah elektif	74.1 <i>Low cervical cesarean section</i>

- Pada pasien yang melahirkan normal setelah pernah menjalani operasi caesar pada kehamilan sebelumnya, gunakan kode O75.7 (*Vaginal delivery following previous caesarean section*) sebagai kode diagnosis utama, dan gunakan kode metode persalinan sebagai kode diagnosis sekunder tanpa perlu memberikan kode O34.2 (*Maternal care due to uterine scar from previous surgery*). Namun, jika persalinan pervaginam dilakukan dengan bantuan prosedur obstetrik, seperti penggunaan forseps atau alat vakum, setelah pernah menjalani operasi caesar, gunakan kode indikasi untuk prosedur obstetrik yang telah ditentukan oleh dokter sebagai kode diagnosis utama, dengan kode metode persalinan dan kode O75.7 sebagai kode diagnosis sekunder, serta tidak perlu memberikan kode O34.2.
- Persalinan pervaginam setelah operasi pada rahim tidak memiliki kode khusus, tetap gunakan kode seperti persalinan pervaginam normal, dan tetap perlu memberikan kode O34.2.

Contoh 48-24	Pasien hamil cukup bulan dengan riwayat operasi caesar pada kehamilan sebelumnya. Pada kehamilan ini, pasien melahirkan secara spontan dengan presentasi kepala dengan episiotomi, bayi tunggal hidup.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Persalinan spontan kepala	O75.7 <i>Vaginal delivery following previous caesarean section</i>

Diagnosis Sekunder	Operasi caesar sebelumnya	O80.0 <i>Spontaneous vertex delivery</i>
		Z37.0 <i>Single live birth</i>
Prosedur	Persalinan normal dengan episiotomi	73.59 <i>Other manually assisted delivery</i>

Contoh 49-24	Pasien hamil cukup bulan dengan riwayat operasi miomektomi (pengangkatan mioma). Pada kehamilan ini, pasien melahirkan secara spontan dengan presentasi kepala dengan episiotomi, bayi tunggal hidup.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Persalinan spontan kepala	O80.0 <i>Spontaneous vertex delivery</i>
Diagnosis Sekunder	Miomektomi sebelumnya	Z37.0 <i>Single live birth</i>
		O34.2 <i>Maternal care due to uterine scar from previous surgery</i>
Prosedur	Persalinan normal dengan episiotomi	73.59 <i>Other manually assisted delivery</i>

Contoh 50-24	Pasien hamil cukup bulan dengan riwayat operasi caesar pada kehamilan sebelumnya. Pada kehamilan ini, pasien melahirkan dengan bantuan <i>low forceps</i> dan episiotomi. Dokter mencatat indikasi sebagai <i>fetal distress</i> , bayi tunggal hidup.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Gangguan janin	O68.9 <i>Labour and delivery complicated by fetal stress, unspecified</i>
Diagnosis Sekunder	Operasi caesar sebelumnya	O75.7 <i>Vaginal delivery following previous caesarean section</i>
		O81.0 <i>Low forceps delivery</i>
		Z37.0 <i>Single live birth</i>

Prosedur	Ekstraksi forsep rendah dengan episiotomi	72.1 <i>Low forceps operation with episiotomy</i>
-----------------	---	---

- Berikan kode operasi caesar seperti yang dicatat oleh dokter, termasuk:

Catatan Operasi Dokter	Kode Operasi
Operasi caesar melintang rendah	74.1 <i>Low cervical cesarean section</i>
Operasi caesar segmen bawah	
Operasi caesar klasik	74.0 <i>Classical cesarean section</i>
Operasi caesar	74.99 <i>Other cesarean section of unspecified type</i>

3.14.20 Maternal Diseases Classifiable Elsewhere but Complicating Pregnancy, Childbirth and The Puerperium (O98.-,O99.-)

Subkategori yang disediakan dalam bab ini harus digunakan sebagai kode “kondisi utama” dibandingkan dengan kategori dari bab lain, apabila kondisi yang diklasifikasikan oleh tenaga kesehatan dinyatakan sebagai komplikasi kehamilan, diperburuk oleh kehamilan, atau menjadi alasan utama perawatan obstetri. Kode-kode relevan dari bab lain dapat digunakan sebagai kode tambahan opsional untuk memberikan spesifikasi lebih lanjut mengenai kondisi tersebut.

Contoh 1:

Kondisi utama : Toksoplasmosis

Kondisi lain : Kehamilan belum melahirkan

Spesialisasi : Klinik antenatal risiko tinggi

Kode yang digunakan sebagai kondisi utama adalah O98.6 (*Protozoal diseases complicating pregnancy, childbirth and the puerperium*).

Kode tambahan opsional B58.9 (*Toxoplasmosis, unspecified*) dapat digunakan untuk mengidentifikasi organisme penyebab secara spesifik.

Kode O99.- (*Other maternal diseases classifiable elsewhere but complicating pregnancy, childbirth and the puerperium*) digunakan untuk

pasien yang mengalami kondisi atau penyakit yang memperumit kehamilan, memperburuk keadaan ibu selama masa kehamilan, atau menjadi alasan utama dilakukannya perawatan obstetrik, dan tidak memiliki kode spesifik dalam Bab 15 (kode berawalan "O"). Penggunaan kode ini harus berdasarkan dokumentasi klinis dari dokter yang menyatakan bahwa kondisi tersebut memang berdampak pada kehamilan atau proses persalinan.

Namun, jika kondisi medis yang dialami pasien tidak menyulitkan kehamilan, tidak memperburuk kondisi ibu, dan bukan alasan utama perawatan obstetri, maka kode dari Bab lain sesuai penyakit yang diderita harus digunakan sebagai diagnosis utama. Dalam situasi seperti ini, status kehamilan dapat tetap dicatat dengan menambahkan kode Z33.- (*Pregnant state, incidental* atau *Pregnant state, NOS*) sebagai kode sekunder.

Sementara itu, untuk kondisi cedera akibat faktor luar yang bukan trauma obstetrik, pengkodean tidak termasuk dalam Bab XV (kode "O"), melainkan harus menggunakan kode dari Bab XIX (S00–T98) yang sesuai. Jika pasien dalam keadaan hamil, tambahkan juga kode Z33.- untuk menunjukkan bahwa kehamilan bersifat insidental terhadap cedera tersebut.

Jika dokter mendiagnosis bahwa wanita hamil atau setelah melahirkan mengalami anemia, gunakan kode O99.0 (*Anaemia complicating pregnancy, childbirth and the puerperium*) sebagai kode diagnosis utama. **Anemia pada saat kehamilan atau persalinan harus menggunakan dua kode, yaitu O99.0 dan kelompok D50-D64 yang dikoding sebagai diagnosis sekunder.** Jika dokter menyebutkan penyebab anemia, gunakan kode untuk penyebab tersebut dalam kelompok D50-D64 sebagai kode diagnosis sekunder.

Jika dokter mendiagnosis bahwa wanita hamil atau setelah melahirkan memiliki gangguan darah yang biasanya menggunakan kode D50-D64, gunakan kode O99.0 (*Anaemia complicating pregnancy, childbirth and the puerperium*) sebagai kode diagnosis utama, dan gunakan kode standar untuk gangguan darah tersebut sebagai kode diagnosis sekunder, meskipun kadar hemoglobin saat itu tidak kurang dari 11 gram/desiliter.

Contoh 51-24	Pasien hamil 12 minggu didiagnosis dengan anemia defisiensi besi (iron deficiency anaemia).
-------------------------	---

	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Anemia defisiensi besi	O99.0 <i>Anaemia complicating pregnancy, childbirth and the puerperium</i>
Diagnosis Sekunder	Kehamilan 12 minggu	D50.9 <i>Iron deficiency anaemia, unspecified</i>

Contoh 52-15	Pasien hamil 10 minggu didiagnosis dengan penyakit hemoglobin H (hemoglobin H disease).	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Penyakit Hemoglobin H	O99.0 <i>Anaemia complicating pregnancy, childbirth and the puerperium</i>
Diagnosis Sekunder	Kehamilan 10 minggu	D56.0 <i>Alpha thalassaemia</i>

Pasien yang dirawat di rumah sakit karena gejala umum yang terjadi selama kehamilan tanpa penyebab spesifik, seperti nyeri perut atau nyeri punggung, gunakan kode O99.8 (*Other specified diseases and conditions complicating pregnancy, childbirth and the puerperium*) sebagai kode diagnosis utama, dan gunakan kode untuk gejala tersebut sebagai kode diagnosis sekunder. Kode ini juga dapat digunakan untuk kondisi – kondisi spesifik pada kehamilan yang meningkatkan risiko pada kehamilan, persalinan dan nifas, sebagai contoh: usia Ibu ≥ 35 tahun, risiko preeklampsia (+), riwayat penggunaan vakum / forsepa atau tranfusi pada kehamilannya sebelumnya, usia kehamilan lewat waktu ≥ 41 minggu.

Cedera atau keracunan tidak dianggap sebagai komplikasi kehamilan. Gunakan kode untuk cedera atau keracunan tersebut sebagai kode diagnosis utama, gunakan kode Z33 (*Pregnant state, incidental*) sebagai kode diagnosis sekunder, serta tambahkan kode untuk penyebab eksternal dari cedera atau keracunan tersebut.

Contoh 53-24	Pasien hamil 30 minggu mengalami gejala nyeri perut dan perut kembung. Dokter mendiagnosis bahwa penyebabnya adalah gas pain (nyeri akibat gas).
---------------------	--

	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Nyeri gas	O99.8 <i>Other specified diseases and conditions complicating pregnancy, childbirth and the puerperium</i>
Diagnosis Sekunder	Kehamilan 30 minggu	R14 <i>Flatulence and related conditions</i>

Contoh 54-15	Pasien hamil 34 minggu mengalami cedera di rumah karena tangannya terjepit pintu. Dokter mendiagnosis bahwa pasien mengalami <i>fracture of first metacarpal bone</i> (patah tulang metakarpal pertama).	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Fraktur tulang metakarpal pertama	S62.20 <i>Closed fracture of first metacarpal bone</i>
Diagnosis Sekunder	Kehamilan 34 minggu	Z33 <i>Pregnant state, incidental</i>
Penyebab Eksternal	Terjepit oleh pintu di rumah.	W23.09 <i>Caught, crushed, jammed or pinched in or between objects</i>

3.14.21 Penjelasan Kombinasi Kode yang Tidak Dapat Diterima pada MDC 24

Pada pengodean untuk MDC 24, terdapat beberapa kombinasi kode yang tidak sesuai dengan kaidah atau tidak dapat diterima sebagai sebagai koding diagnosis. Hal ini dikarenakan karakteristik diagnosis, prosedur atau intervensi yang harus spesifik terhadap kelompok ini. Kode-kode yang tidak dapat diterima tersebut umumnya sebagai berikut:

- **Kombinasi Diagnosis Obstetri yang Tidak Dapat Diterima 0**

Persalinan harus selalu dikodekan *outcomenya* kelompok kode Z37.- sesuai dengan kelahiran bayi. jika tidak dikode, maka akan terjadi eror.

- **Kombinasi Diagnosis Obstetri yang Tidak Dapat Diterima 1**

Diagnosis berikut (*Delivery & Outcome*) tidak dapat digunakan sebagai diagnosis primer karena berkaitan langsung dengan proses persalinan atau hasil persalinan yang harus dikodekan sebagai bagian dari

copyright@ Pusat pembiayaan kesehatan Kemenkes RI.

Dilarang mengcopy atau memperjualbelikan isi dan dokumen ini dalam bentuk apapun

sekunder atau tambahan, bukan sebagai penyebab utama rawat inap atau perawatan medis. Menggunakan salah satu dari kode ini sebagai diagnosis utama akan mengakibatkan error dalam pengajuan klaim sebagai group 3652119 Unacceptable obs. diag. comb. 1. Sebagai contoh, apabila ada pasien dengan persalinan normal tanpa komplikasi lalu di dalam resume medis tertulis diagnosa O80 dan Z37.0 maka akan tertolak oleh sistem karena kode tersebut tidak mewakili kondisi klinis yang menyebabkan rawat inap.

Delivery & Outcome

O80.0 <i>Spontaneous vertex delivery</i>	O83.0 <i>Breech extraction</i>
O80.1 <i>Spontaneous breech delivery</i>	O83.1 <i>Other assisted breech delivery</i>
O80.8 <i>Other single spontaneous delivery</i>	O83.2 <i>Other manipulation-assisted delivery</i>
O80.9 <i>Single spontaneous delivery, unspecified</i>	O83.3 <i>Delivery of viable fetus in abdominal pregnancy</i>
O81.0 <i>Low forceps delivery</i>	O83.4 <i>Destructive operation for delivery</i>
O81.1 <i>Mid-cavity forceps delivery</i>	O83.8 <i>Other specified assisted single delivery</i>
O81.2 <i>Mid-cavity forceps with rotation</i>	
O81.3 <i>Other and unspecified forceps delivery</i>	O83.9 <i>Assisted single delivery, unspecified</i>
O81.4 <i>Vacuum extractor delivery</i>	O84.0 <i>Multiple delivery, all spontaneous</i>
O81.5 <i>Delivery by combination of forceps and vacuum extractor</i>	O84.1 <i>Multiple delivery, all by forceps and vacuum extractor</i>
O82.0 <i>Delivery by elective cesarean section</i>	O84.2 <i>Multiple delivery, all by cesarean section</i>
O82.1 <i>Delivery by emergency cesarean section</i>	O84.8 <i>Other multiple delivery</i>
O82.2 <i>Delivery by cesarean hysterectomy</i>	O84.9 <i>Multiple delivery, unspecified</i>
O82.8 <i>Other single delivery by cesarean section</i>	Z37.0 <i>Single live birth</i>
O82.9 <i>Delivery by cesarean section, unspecified</i>	Z37.1 <i>Single stillbirth</i>
	Z37.2 <i>Twins, both liveborn</i>
	Z37.3 <i>Twins, one liveborn and one stillborn</i>
	Z37.4 <i>Twins, both stillborn</i>

Z37.5 *Other multiple births, all liveborn*

Z37.6 *Other multiple births, some liveborn*

Z37.7 *Other multiple births, all stillborn*

Z37.9 *Outcome of delivery, unspecified*

- **Kombinasi Diagnosis Obstetri yang Tidak Dapat Diterima 2**

Diagnosis berikut *Delivery by Caesarean Section* selain tidak dapat dikodekan sebagai diagnosis primer dan harus dikodekan sebagai diagnosis sekunder namun jika tidak dimasukkan kedalam sistem tetapi terdapat tindakan *Caesarean Section* akan mengakibatkan error dalam pengajuan klaim sebagai group 3652219 Unacceptable obs. diag. comb. 2.

Delivery by Caesarean Section	Caesarean Section
O82.0 <i>Delivery by elective caesarean section</i>	74.0 <i>Classical cesarean section</i>
O82.1 <i>Delivery by emergency caesarean section</i>	74.1 <i>Low cervical cesarean section</i>
O82.2 <i>Delivery by caesarean hysterectomy</i>	74.2 <i>Extraperitoneal cesarean section</i>
O82.8 <i>Other single delivery by caesarean section</i>	74.3 <i>Removal of extratubal ectopic pregnancy</i>
O82.9 <i>Delivery by caesarean section, unspecified</i>	74.4 <i>Cesarean section of other specified type</i>
O84.2 <i>Multiple delivery, all by caesarean section</i>	74.91 <i>Hysterotomy to terminate pregnancy</i>
	74.99 <i>Other cesarean section of unspecified type</i>

- **Kombinasi Diagnosis Obstetri yang Tidak Dapat Diterima 3**

Kebalikan dari Kombinasi Diagnosis Obstetri yang Tidak Dapat Diterima 2, jika terdapat kode diagnosis *Delivery by Caesarean Section* tetapi tidak ada kode tindakan *Caesarean Section* akan mengakibatkan error dalam pengajuan klaim sebagai group 3652319 Unacceptable obs. diag. comb. 3

- **Kombinasi Diagnosis Obstetri yang Tidak Dapat Diterima 4**

Jika terdapat *multiple delivery* dengan kombinasi cara bersalin tetapi kode O84.8 *Other multiple delivery* tidak di kodekan, akan mengakibatkan error dalam pengajuan klaim sebagai group 3652419 Unacceptable obs. diag. comb. 4.

Delivery by Caesarean Section	O80.1 <i>Spontaneous breech delivery</i>
O82.0 <i>Delivery by elective caesarean section</i>	O80.8 <i>Other single spontaneous delivery</i>
O82.1 <i>Delivery by emergency caesarean section</i>	O80.9 <i>Single spontaneous delivery, unspecified</i>
O82.2 <i>Delivery by caesarean hysterectomy</i>	O81.0 <i>Low forceps delivery</i>
O82.8 <i>Other single delivery by caesarean section</i>	O81.1 <i>Mid-cavity forceps delivery</i>
O82.9 <i>Delivery by caesarean section, unspecified</i>	O81.2 <i>Mid-cavity forceps with rotation</i>
O84.2 <i>Multiple delivery, all by caesarean section</i>	O81.3 <i>Other and unspecified forceps delivery</i>
	O81.4 <i>Vacuum extractor delivery</i>
	O81.5 <i>Delivery by combination of forceps and vacuum extractor</i>
Other Multiple Delivery	O83.0 <i>Breech extraction</i>
O84.8 <i>Other multiple delivery</i>	O83.1 <i>Other assisted breech delivery</i>
Vaginal Delivery	O83.2 <i>Other manipulation-assisted delivery</i>
O80.0 <i>Spontaneous vertex delivery</i>	O84.0 <i>Multiple delivery, all spontaneous</i>
	O84.1 <i>Multiple delivery, all by forceps and vacuum extracto</i>

- **Kombinasi Diagnosis Obstetri yang Tidak Dapat Diterima 5**

Jika terdapat kombinasi diagnosis *Postpartum/Post Abortion Condition* dan *Delivery & Outcome* akan mengakibatkan error dalam pengajuan klaim sebagai group 3652519 Unacceptable obs. diag. comb. 5

Delivery & Outcome

O80.0 <i>Spontaneous vertex delivery</i>	O83.3 <i>Delivery of viable fetus in abdominal pregnancy</i>
O80.1 <i>Spontaneous breech delivery</i>	O83.4 <i>Destructive operation for delivery</i>
O80.8 <i>Other single spontaneous delivery</i>	O83.8 <i>Other specified assisted single delivery</i>
O80.9 <i>Single spontaneous delivery, unspecified</i>	O83.9 <i>Assisted single delivery, unspecified</i>
O81.0 <i>Low forceps delivery</i>	O84.0 <i>Multiple delivery, all spontaneous</i>
O81.1 <i>Mid-cavity forceps delivery</i>	O84.1 <i>Multiple delivery, all by forceps and vacuum extractor</i>
O81.2 <i>Mid-cavity forceps with rotation</i>	O84.2 <i>Multiple delivery, all by cesarean section</i>
O81.3 <i>Other and unspecified forceps delivery</i>	O84.8 <i>Other multiple delivery</i>
O81.4 <i>Vacuum extractor delivery</i>	O84.9 <i>Multiple delivery, unspecified</i>
O81.5 <i>Delivery by combination of forceps and vacuum extractor</i>	Z37.0 <i>Single live birth</i>
O82.0 <i>Delivery by elective cesarean section</i>	Z37.1 <i>Single stillbirth</i>
O82.1 <i>Delivery by emergency cesarean section</i>	Z37.2 <i>Twins, both liveborn</i>
O82.2 <i>Delivery by cesarean hysterectomy</i>	Z37.3 <i>Twins, one liveborn and one stillborn</i>
O82.8 <i>Other single delivery by cesarean section</i>	Z37.4 <i>Twins, both stillborn</i>
O82.9 <i>Delivery by cesarean section, unspecified</i>	Z37.5 <i>Other multiple births, all liveborn</i>
O83.0 <i>Breech extraction</i>	Z37.6 <i>Other multiple births, some liveborn</i>
O83.1 <i>Other assisted breech delivery</i>	Z37.7 <i>Other multiple births, all stillborn</i>
O83.2 <i>Other manipulation-assisted delivery</i>	Z37.9 <i>Outcome of delivery, unspecified</i>

Postpartum/Post Abortion Condition

O08.0 *Genital tract and pelvic infection following abortion and ectopic and molar pregnancy*

O08.1 *Delayed or excessive haemorrhage following abortion and ectopic and molar pregnancy*

O08.2 *Embolism following abortion and ectopic and molar pregnancy*

O08.3 *Shock following abortion and ectopic and molar pregnancy*

O08.4 *Renal failure following abortion and ectopic and molar pregnancy*

O08.5 *Metabolic disorders following abortion and ectopic and molar pregnancy*

O08.6 *Damage to pelvic organs and tissues following abortion and ectopic and molar pregnancy*

O08.7 *Other venous complications following abortion and ectopic and molar pregnancy*

O08.8 *Other complications following abortion and ectopic and molar pregnancy*

O08.9 *Complication following abortion and ectopic and molar pregnancy, unspecified*

Z39.0 *Care and examination immediately after delivery*

Z39.1 *Care and examination of lactating mother*

Caesarean Section

74.0 *Classical cesarean section*

74.1 *Low cervical cesarean section*

74.2 *Extraperitoneal cesarean section*

74.3 *Removal of extratubal ectopic pregnancy*

74.4 *Cesarean section of other specified type*

74.91 *Hysterotomy to terminate pregnancy*

74.99 *Other cesarean section of unspecified type*

• Kombinasi Diagnosis Obstetri yang Tidak Dapat Diterima 6

Jika terdapat kombinasi diagnosis *Antenatal Condition* dan *Delivery & Outcome* akan mengakibatkan error dalam pengajuan klaim sebagai group 3652619 Unacceptable obs. diag. comb. 6.

Antenatal Condition

O28.0 *Abnormal haematological finding on antenatal screening of mother*

O28.1 *Abnormal biochemical finding on antenatal screening of mother*

O28.2 *Abnormal cytological finding on antenatal screening of mother*

O28.3 *Abnormal ultrasonic finding on antenatal screening of mother*

copyright@ Pusat pembiayaan kesehatan Kemenkes RI.

Dilarang mengcopy atau memperjualbelikan isi dan dokumen ini dalam bentuk apapun

O28.4 <i>Abnormal radiological find on antenatal screening of mother</i>	Z36.2 <i>Other antenatal screening based on amniocentesis</i>
O28.5 <i>Abnormal chromosomal and genetic finding antenatal screening of mother</i>	Z36.3 <i>Antenatal screening malformation using ultrasound and other physical methods</i>
O28.8 <i>Other abnormal findings on antenatal screening of mother</i>	Z36.4 <i>Antenatal screening fetal growth retardation using ultrasound oth physical methods</i>
O28.9 <i>Abnormal finding on antenatal screening of mother, unspecified</i>	Z36.5 <i>Antenatal screening for isoimmunization</i>
O60.0 <i>Preterm labour without delivery</i>	Z36.8 <i>Other antenatal screening</i>
Z36.0 <i>Antenatal screening for chromosomal anomalies</i>	Z36.9 <i>Antenatal screening, unspecified</i>
Z36.1 <i>Antenatal screening for raised alphafetoprotein level</i>	

- **Kombinasi Diagnosis Obstetri yang Tidak Dapat Diterima 7**

Jika terdapat kombinasi diagnosis *Threatened abortion* dan *Delivery & Outcome* akan mengakibatkan error dalam pengajuan klaim sebagai group 3652719 Unacceptable obs. diag. comb. 7.

Threatened abortion

O20.0 *Threatened abortion*

O20.8 *Other haemorrhage in early pregnancy*

O20.9 *Haemorrhage in early pregnancy, unspecified*

- **Kombinasi Diagnosis Obstetri yang Tidak Dapat Diterima 8**

Jika terdapat kombinasi diagnosis *Uncomplicated Abortion* dan *Delivery & Outcome* akan mengakibatkan error dalam pengajuan klaim sebagai group 3652819 Unacceptable obs. diag. comb. 8

Uncomplicated Abortion

O02.0 <i>Blighted ovum and nonhydatidiform mole</i>	O02.9 <i>Abnormal product of conception, unspecified</i>
O02.8 <i>Other specified abnormal products of conception</i>	O03.1 <i>Spontaneous abortion, incomplete abortion complicated by delayed or excessive haemorrhage</i>

- O03.3 *Spontaneous abortion, incomplete, with other and unspecified complications*
- O03.4 *Spontaneous abortion, incomplete, without complication*
- O03.6 *Spontaneous abortion, complete or unspecified, complicated by delayed or excessive haemorrhage*
- O03.8 *Spontaneous abortion, complete or unspecified, with other and unspecified complications*
- O03.9 *Spontaneous abortion, complete or unspecified, without complication*
- O04.1 *Medical abortion, incomplete, complicated by delayed or excessive haemorrhage*
- O04.3 *Medical abortion, incomplete, with other and unspecified complications*
- O04.4 *Medical abortion, incomplete, without complication*
- O04.6 *Medical abortion, complete or unspecified, complicated by delayed or excessive haemorrhage*
- O04.8 *Medical abortion, complete or unspecified, with other and unspecified complications*
- O04.9 *Medical abortion, complete or unspecified, without complication*
- O05.1 *Other abortion, incomplete, complicated by delayed or excessive haemorrhage*
- O05.3 *Other abortion, incomplete, with other and unspecified complications*
- O05.4 *Other abortion, incomplete, without complication*
- O05.6 *Other abortion, complete or unspecified, complicated by delayed or excessive haemorrhage*
- O05.8 *Other abortion, complete or unspecified, with other and unspecified complications*
- O05.9 *Other abortion, complete or unspecified, without complication*
- O06.1 *Unspecified abortion, incomplete, complicated by delayed or excessive haemorrhage*
- O06.3 *Unspecified abortion, incomplete, with other and unspecified complications*
- O06.4 *Unspecified abortion, incomplete, without complication*
- O06.6 *Unspecified abortion, complete or unspecified, complicated by delayed or excessive haemorrhage*
- O06.8 *Unspecified abortion, complete or unspecified, with other and unspecified complications*

O06.9 *Unspecified abortion, complete or unspecified, without complication*

O07.1 *Failed medical abortion complicated by delayed or excessive haemorrhage*

O07.3 *Failed medical abortion, with other and unspecified complications*

O07.4 *Failed medical abortion, without complication*

O07.6 *Other and unspecified failed attempted abortion, complicated by delayed or excessive haemorrhage*

O07.8 *Other and unspecified failed attempted abortion, with other and unspecified complications*

O07.9 *Other and unspecified failed attempted abortion, without complication*

- **Kombinasi Diagnosis Obstetri yang Tidak Dapat Diterima 9**

Jika terdapat kombinasi diagnosis *Complicated Abortion* dan *Delivery & Outcome* akan mengakibatkan error dalam pengajuan klaim sebagai group 3652919 Unacceptable obs. diag. comb. 9.

Complicated Abortion

O02.1 *Missed abortion*

O03.0 *Spontaneous abortion, incomplete abortion complicated by genital tract and pelvic infection*

O03.2 *Spontaneous abortion, incomplete, complicated by embolism*

O03.5 *Spontaneous abortion, complete or unspecified, complicated by genital tract and pelvic infection*

O03.7 *Spontaneous abortion, complete or unspecified, complicated by embolism*

O04.0 *Medical abortion, incomplete, complicated by genital tract and pelvic infection*

O04.2 *Medical abortion, incomplete, complicated by embolism*

O04.5 *Medical abortion, complete or unspecified, complicated by genital tract and pelvic infection*

O04.7 *Medical abortion, complete or unspecified, complicated by embolism*

O05.0 *Other abortion, incomplete, complicated by genital tract and pelvic infection*

O05.2 *Other abortion, incomplete, complicated by embolism*

O05.5 *Other abortion, complete or unspecified, complicated by genital tract and pelvic infection*

O05.7 *Other abortion, complete or unspecified, complicated by embolism*

O06.0 <i>Unspecified abortion, incomplete, complicated by genital tract and pelvic infection</i>	O07.0 <i>Failed medical abortion, complicated by genital tract and pelvic infection</i>
O06.2 <i>Unspecified abortion, incomplete, complicated by embolism</i>	O07.2 <i>Failed medical abortion, complicated by embolism</i>
O06.5 <i>Unspecified abortion, complete or unspecified, complicated by genital tract and pelvic infection</i>	O07.5 <i>Other and unspecified failed attempted abortion, complicated by genital tract and pelvic infection</i>
O06.7 <i>Unspecified abortion, complete or unspecified, complicated by embolism</i>	O07.7 <i>Other and unspecified failed attempted abortion, complicated by embolism</i>

- **Kombinasi Diagnosis Obstetri yang Tidak Dapat Diterima 10**

Jika terdapat kombinasi diagnosis *Molar Pregnancy* dan *Delivery & Outcome* akan mengakibatkan error dalam pengajuan klaim sebagai group 3653019 Unacceptable obs. diag. comb. 10.

Molar Pregnancy

- O01.0 *Classical hydatidiform mole*
- O01.1 *Incomplete and partial hydatidiform mole*
- O01.9 *Hydatidiform mole, unspecified*

- **Kombinasi Diagnosis Obstetri yang Tidak Dapat Diterima 11**

Jika terdapat kombinasi diagnosis *False Labour* dan *Delivery & Outcome* akan mengakibatkan error dalam pengajuan klaim sebagai group 3653119 Unacceptable obs. diag. comb. 11.

False Labour

- O47.0 *False labour before 37 completed weeks of gestation*
- O47.1 *False labour at or after 37 completed weeks of gestation*
- O47.9 *False labour, unspecified*

- **Kombinasi Diagnosis Obstetri yang Tidak Dapat Diterima 12**

Jika terdapat kombinasi diagnosis *Delivery by Caesarean Section* tetapi tidak ada kode pada kelompok *Delivery & Outcome* akan

mengakibatkan error dalam pengajuan klaim sebagai group 3653219
Unacceptable obs. diag. comb. 12 .

Caesarean Section

74.0	<i>Classical cesarean section</i>
74.1	<i>Low cervical cesarean section</i>
74.2	<i>Extraperitoneal cesarean section</i>
74.3	<i>Removal of extra tubal ectopic pregnancy</i>
74.4	<i>Cesarean section of other specified type</i>
74.91	<i>Hysterotomy to terminate pregnancy</i>
74.99	<i>Other cesarean section of unspecified type</i>

Delivery & Outcome

O80.0	<i>Spontaneous vertex delivery</i>	O82.1	<i>Delivery by emergency cesarean section</i>
O80.1	<i>Spontaneous breech delivery</i>	O82.2	<i>Delivery by cesarean hysterectomy</i>
O80.8	<i>Other single spontaneous delivery</i>	O82.8	<i>Other single delivery by cesarean section</i>
O80.9	<i>Single spontaneous delivery, unspecified</i>	O82.9	<i>Delivery by cesarean section, unspecified</i>
O81.0	<i>Low forceps delivery</i>	O83.0	<i>Breech extraction</i>
O81.1	<i>Mid-cavity forceps delivery</i>	O83.1	<i>Other assisted breech delivery</i>
O81.2	<i>Mid-cavity forceps with rotation</i>	O83.2	<i>Other manipulation-assisted delivery</i>
O81.3	<i>Other and unspecified forceps delivery</i>	O83.3	<i>Delivery of viable fetus in abdominal pregnancy</i>
O81.4	<i>Vacuum extractor delivery</i>	O83.4	<i>Destructive operation for delivery</i>
O81.5	<i>Delivery by combination of forceps and vacuum extractor</i>	O83.8	<i>Other specified assisted single delivery</i>
O82.0	<i>Delivery by elective cesarean section</i>		

O83.9	<i>Assisted single delivery, unspecified</i>	Z37.1	<i>Single stillbirth</i>
O84.0	<i>Multiple delivery, all spontaneous</i>	Z37.2	<i>Twins, both liveborn</i>
O84.1	<i>Multiple delivery, all by forceps and vacuum extractor</i>	Z37.3	<i>Twins, one liveborn and one stillborn</i>
O84.2	<i>Multiple delivery, all by cesarean section</i>	Z37.4	<i>Twins, both stillborn</i>
O84.8	<i>Other multiple delivery</i>	Z37.5	<i>Other multiple births, all liveborn</i>
O84.9	<i>Multiple delivery, unspecified</i>	Z37.6	<i>Other multiple births, some liveborn</i>
Z37.0	<i>Single live birth</i>	Z37.7	<i>Other multiple births, all stillborn</i>
		Z37.9	<i>Outcome of delivery, unspecified</i>

3.15 MDC 25 PERINATOLOGI

PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 25

Dalam pengodean MDC 25, selain kode diagnosis dan prosedur yang digunakan, berat badan bayi juga memiliki pengaruh pada hasil *grouper*. Contohnya, jika berat badan bayi yang dimasukkan adalah 2500 gram, maka bayi tersebut akan masuk ke dalam kelompok *grouper* dengan kategori berat badan > 2499.

Bayi baru lahir/neonatus yang tidak sehat selama episode kelahiran sampai dengan usia 28 hari pada umumnya menggunakan kode P, tetapi tidak menutup kemungkinan menggunakan kode lain, dan menggunakan kode Z38.- *Bayi lahir hidup menurut tempat kelahiran* sebagai kode diagnosis tambahan.

Untuk Bayi lahir normal hanya diberikan kode Z38.- saja dan diklaim satu episode dengan ibunya.

Tabel X. Contoh kasus penginputan iDRG MDC 25

Contoh 1-25	Bayi tunggal lahir hidup dari persalinan SC, mengalami asfiksia berat dengan nilai apgar 2.	
	Diagnosis Dokter	Pengode Memberi Kode
Diagnosis Primer	Asfiksia berat	P21.0 <i>Severe birth asphyxia</i>
Diagnosis sekunder	-	P03.4 <i>Fetus and newborn affected by cesarean delivery</i>
		Z38.0 <i>Singleton, born in hospital</i>
Tindakan	Ventilator 80 jam	96.71 <i>Continuous invasive mechanical ventilation for less than 96 consecutive hours</i>

PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 25

3.15.2 Neonatus (Bayi baru lahir)

- Untuk Bayi Baru Lahir dengan penyakit atau gejala abnormal, maka menggunakan kode untuk penyakit atau gejala abnormal tersebut sebagai kode diagnosis utama, kemudian dapat menggunakan kode dalam kelompok Z38.- (*Liveborn infants according to place of birth*) sebagai kode diagnosis tambahan.

- Untuk Bayi Baru Lahir tanpa penyakit atau kelainan yang dilahirkan di rumah sakit dan dirawat tanpa ditemukan penyakit atau kelainan, maka gunakan kode dalam kelompok Z38.- (*Liveborn infants according to place of birth*) sebagai kode diagnosis utama.

Detail lebih lanjut tentang pemberian kode Z38.- dapat melihat penjelasannya di MDC 30.

Tabel X. Contoh pemberian kode iDRG MDC 25 Neonatus

Contoh 2-25	Bayi tunggal lahir cukup bulan di rumah sakit dengan berat lahir 2.200 gram dari ibu yang terinfeksi malaria. Dokter mendiagnosis hypoglikemia.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Hipoglikemia	P70.4 <i>Other neonatal hypoglycaemia</i>
Diagnosis Sekunder	Efek buruk dari penggunaan <i>dietil stilbestrol</i> ibu	Z38.0 <i>Singleton, born in hospital</i>
Contoh 3-25	Bayi tunggal lahir cukup bulan di rumah sakit dengan berat lahir 3.000 gram dari ibu yang terinfeksi malaria. Dokter mendiagnosis <i>respiratory distress newborn</i> dan pneumotoraks.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Sindrom gangguan pernapasan	P22.0 <i>Respiratory distress syndrome of newborn</i>
Diagnosis Sekunder	-	P25.1 <i>Pneumothorax originating in the perinatal period</i>
Komplikasi	<i>Pneumotoraks</i>	Z38.0 <i>Singleton, born in hospital</i>

3.15.3 Fetus and Newborn Affected by Maternal Factors and by Complications of Pregnancy, Labour and Delivery (P00-P04)

Kode dalam kelompok P00 - P04 digunakan untuk bayi baru lahir yang terkena dampak dari kondisi penyakit ibu. Kode penyakit dalam kelompok ini tidak digunakan sebagai kode diagnosis utama, tetapi digunakan sebagai kode diagnosis tambahan.

Ketika ibu mengalami komplikasi selama kehamilan, seperti penyakit infeksi tetapi bayi yang dilahirkan normal maka gunakan kode dalam kelompok Z38.- (*Liveborn infants according to place of birth*) bersama dengan kode dalam kelompok Z20.- (*Contact with and exposure to communicable diseases*).

Tabel X. Contoh pemberian kode iDRG MDC 25 Fetus and Newborn affected by Maternal Factors and Complications of pregnancy, lab labour and delivery

Contoh 4-25	Bayi tunggal lahir cukup bulan di rumah sakit dengan berat lahir 2.200 gram, panjang badan 50 cm, dan tidak ada gejala abnormal dari seorang ibu yang terkena penyakit malaria. Dokter mendiagnosis sebagai <i>term low birth weight</i>	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	<i>Term low birth weight</i>	P05.1 <i>Small for gestational age</i>
Diagnosis Sekunder	Malaria ibu	P00.2 <i>Fetus and newborn affected by maternal infectious and parasitic diseases</i>
		Z38.0 <i>Singleton, born in hospital</i>
Contoh 5-25	Bayi tunggal lahir cukup bulan di rumah sakit dengan berat lahir 1.900 gram, panjang badan 40 cm, dan tidak ada gejala abnormal dari seorang ibu yang terkena penyakit malaria. Dokter mendiagnosis sebagai BBLR dan <i>term SGA (Small for Gestational Age)</i> .	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	BBLR	P07.1 <i>Other low birth weight</i>
Diagnosis Sekunder	<i>SGA (Small for Gestational Age)</i>	Z38.0 <i>Singleton, born in hospital</i>
	Malaria Ibu	Z20.8 <i>Contact with and exposure to other communicable diseases</i>
Contoh 6-25	Bayi tunggal lahir cukup bulan di rumah sakit dari ibu yang terinfeksi virus hepatitis B, berat lahir 3.000 gram, tidak menunjukkan gejala abnormal. Dokter mendiagnosis sebagai <i>term AGA (Appropriate for Gestational Age)</i> dan <i>maternal viral hepatitis B</i>	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Istilah AGA	Z38.0 <i>Singleton, born in hospital</i>
Diagnosis Sekunder	Hepatitis B virus ibu	Z20.5 <i>Contact with and exposure to viral hepatitis</i>

3.15.4 Slow Fetal Growth and Fetal Malnutrition (P05)

- Kode dalam kelompok P05.- (*Slow fetal growth and fetal malnutrition*) dapat digunakan untuk bayi/neonatus, baik yang lahir prematur maupun cukup bulan (aterm).
 - Untuk *Light for gestational age* atau *low birth weight*, maka menggunakan kode P05.0 (*Light for gestational age*).
 - Untuk *Small for gestational age*, maka menggunakan kode P05.1 (*Small for gestational age*).
- Perlu diperhatikan bahwa dokter mungkin menggunakan singkatan SGA sebagai pengganti istilah *Small for Gestational Age*

- Perhatikan bahwa dokter tidak akan menggunakan singkatan LGA sebagai pengganti *Light for Gestational Age*, karena LGA biasanya digunakan untuk *Large for Gestational Age*, yang memiliki arti berlawanan.
- Koder mungkin menemukan bahwa dokter menggunakan singkatan AGA (*Average for Gestational Age*) yang menunjukkan bahwa bayi memiliki berat badan dan panjang badan dalam kisaran normal. Oleh sebab itu, kondisi ini tidak perlu dikode.
- Bayi baru lahir yang tidak didiagnosis oleh dokter sebagai *light for gestational age* atau *small for gestational age*, tetapi dokter mencatat adanya tanda-tanda malnutrisi janin, seperti kulit kering dan mengelupas, sedikit jaringan subkutan, dan sebagainya maka dapat menggunakan kode P05.2 (*Fetal malnutrition without mention of light or small for gestational age*).
- Bayi baru lahir yang didiagnosis dengan pertumbuhan janin yang tidak optimal atau lambat dapat dicatat sebagai *intrauterine fetal growth restriction* atau *intrauterine fetal growth retardation* (IUGR), maka menggunakan kode P05.9 (*Slow fetal growth, unspecified*).

Tabel X. Contoh kasus iDRG MDC 25 Slow Fetal Growth and Fetal Malnutrition

Contoh 7-25	Bayi tunggal lahir cukup bulan di rumah sakit dengan berat lahir 2.200 gram, panjang badan 50 cm, tidak ada gejala abnormal. Dokter mendiagnosis sebagai <i>term low birth weight</i> (bayi cukup bulan dengan berat lahir rendah).	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Berat badan lahir rendah	P05.0 <i>Light for gestational age</i>
Diagnosis Sekunder	-	Z38.0 <i>Singleton, born in hospital</i>
Contoh 8-25	Bayi tunggal lahir cukup bulan di rumah sakit dengan berat lahir 1.900 gram, panjang badan 40 cm, tidak ada gejala abnormal. Dokter mendiagnosis sebagai <i>term SGA</i> (<i>Small for Gestational Age</i>).	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Istilah SGA	P05.1 <i>Small for gestational age</i>
Diagnosis Sekunder	-	Z38.0 <i>Singleton, born in hospital</i>

3.15.5 Disorders Related to Short Gestational Age and Low Birth Weight, Not Elsewhere Classified (P07.-)

- Kode P07.- (*Disorders related to short gestational age and low birth weight, not elsewhere classified*) hanya digunakan untuk bayi yang lahir prematur saja. Apabila dokter mencatat berat lahir dan usia kehamilan bayi, maka berat lahir dianggap sebagai prioritas utama dalam memberikan kode pada kelompok ini yang mencakup:
 - Jika Berat lahir kurang dari 1.000 gram, maka menggunakan kode P07.0 (*Extremely low birth weight*)
 - Jika Berat lahir antara 1.000 – 2.499 gram, maka menggunakan kode P07.1 (*Other low birth weight*).
 - Jika Usia kehamilan kurang dari 28 minggu (196 hari), maka menggunakan kode P07.2 (*Extremely preterm*).
 - Jika Usia kehamilan mulai dari 28 minggu atau lebih tetapi belum mencapai 37 minggu, maka menggunakan P07.3 (*Other preterm infants*).
- Apabila diketahui usia kehamilan dan berat lahir serta telah menggunakan kode P07.0 atau P07.1, maka tidak perlu lagi memberikan kode P07.2 atau P07.3.
- Untuk bayi dengan diagnosis lahir prematur dan memiliki penyakit atau kelainan lain secara bersamaan, maka penentuan diagnosis utama dan sekunder mengacu pada chapter II subchapter 2.1. Misalnya, dokter menetapkan diagnosis BBLR sebagai diagnosis utama, maka dapat menggunakan kode dalam kelompok P07.- sebagai kode diagnosis utama dan kode untuk penyakit atau kelainan yang didiagnosis oleh dokter sebagai kode diagnosis tambahan atau komplikasi.

Tabel X. Contoh kasus iDRG MDC 25 Disorders related to Short Gestational Age and Low Birth Weight, Not Elsewhere Classified

Contoh 9-25	Bayi tunggal lahir di rumah sakit pada usia kehamilan 36 minggu, berat lahir 2.400 gram, tidak ada gejala abnormal. Dokter mendiagnosis sebagai <i>preterm</i> (lahir prematur)	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Prematur	P07.1 <i>Other low birth weight</i>

copyright@ Pusat pembiayaan kesehatan Kemenkes RI.

Dilarang mengcopy atau memperjualbelikan isi dan dokumen ini dalam bentuk apapun

Diagnosis Sekunder	-	Z38.0 <i>Singleton, born in hospital</i>
Contoh 10-25	Bayi tunggal lahir di rumah sakit pada usia kehamilan 36 minggu, berat lahir 2.600 gram, tidak ada gejala abnormal. Dokter mendiagnosis sebagai <i>preterm</i> (lahir prematur)	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Prematur	P07.3 <i>Other preterm infants</i>
Diagnosis Sekunder	-	Z38.0 <i>Singleton, born in hospital</i>
Contoh 11-25	Bayi tunggal lahir di mobil angkutan umum saat ibu dalam perjalanan ke rumah sakit, usia kehamilan tidak diketahui, berat lahir 2.000 gram, tidak ada gejala abnormal. Dokter mendiagnosis sebagai <i>preterm</i> (lahir prematur)	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Prematur	P07.1 <i>Other low birth weight</i>
Diagnosis Sekunder	-	Z38.1 <i>Singleton, born outside hospital</i>
Contoh 12-25	Bayi tunggal lahir di rumah sakit pada usia kehamilan 32 minggu, berat lahir 1.800 gram, dokter mendiagnosis sebagai <i>severe birth asphyxia</i> (asfiksia lahir berat) dan <i>preterm</i> (lahir prematur).	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Asfiksia lahir parah	P07.1 <i>Other low birth weight</i>
Diagnosis Sekunder	-	P21.0 <i>Severe birth asphyxia</i> Z38.0 <i>Singleton, born in hospital</i>
Contoh 13-25	Bayi tunggal lahir di rumah sakit pada usia kehamilan 32 minggu, berat lahir 1.800 gram, kemudian mengalami kesulitan bernapas. Dokter mendiagnosis sebagai <i>hyaline membrane disease</i> (penyakit membran hialin) dan <i>preterm</i> (lahir prematur).	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Penyakit membran hialin	P07.1 <i>Other low birth weight</i>
Diagnosis Sekunder	Prematur	P22.0 <i>Respiratory distress syndrome of newborn</i> Z38.0 <i>Singleton, born in hospital</i>

3.15.6 Birth Injury to Spine (P11.5, P13)

- Untuk Patah tulang pada bayi baru lahir disebabkan oleh cedera lahir, maka menggunakan kode diberikan dalam kelompok P13.- (*Birth injury to skeleton*) sesuai dengan jenis tulang yang patah.

3.15.7 Birth Asphyxia (P21.-)

- Pada diagnosis *Birth asphyxia*, koder harus mencari informasi tambahan dari catatan kelahiran bayi untuk memberikan kode 4 digit yang tepat untuk kondisi *asphyxia* lahir dengan melihat nilai *Apgar score* pada menit pertama setelah lahir, sebagai berikut:

copyright@ Pusat pembiayaan kesehatan Kemenkes RI.

Dilarang mengcopy atau memperjualbelikan isi dan dokumen ini dalam bentuk apapun

- Jika *Apgar score* pada menit pertama adalah 0–3, maka menggunakan kode P21.0 (*Severe birth asphyxia*).
- Jika *Apgar score* pada menit pertama adalah 4–7, maka menggunakan kode P21.1 (*Mild and moderate birth asphyxia*).
- Jika *Apgar score* pada menit pertama yang tidak diketahui, maka menggunakan kode P21.9 (*Birth asphyxia, unspecified*).
- Untuk diagnosis bayi baru lahir yang mengalami *asphyxia* lahir, koder tidak diperbolehkan memberikan kode dalam kelompok P21.- hanya berdasarkan nilai *Apgar score*.
- Jika diagnosis *asphyxia* lahir dan terdapat catatan bahwa ada penyakit atau gangguan lain yang muncul kemudian, seperti gangguan pernapasan, kejang, atau *hypoxic ischaemic encephalopathy*, maka menggunakan kode yang sesuai dalam kelompok P21.- (*Birth asphyxia*) sebagai kode diagnosis utama dan dapat menambahkan kode untuk penyakit atau gangguan sebagai komplikasi tambahan.

Tabel X. Contoh kasus iDRG MDC 25 Birth Asphyxia

Contoh 15-25	Bayi tunggal lahir cukup bulan di rumah sakit dengan <i>Apgar score</i> 1, 3, dan 7 pada menit ke-1, ke-2, dan ke-5 setelah lahir, secara berurutan. Keesokan harinya, bayi mengalami kejang. Dokter mendiagnosis bahwa bayi tersebut mengalami <i>birth asphyxia</i> (asfiksia lahir) dan <i>hypoxic ischaemic encephalopathy</i> [HIE].	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Asfiksia kelahiran	P21.0 <i>Severe birth asphyxia</i>
Diagnosis Sekunder	-	Z38.0 <i>Singleton, born in hospital</i>
Komplikasi	Ensefalopati iskemik hipoksia	P91.0 <i>Neonatal cerebral ischaemia</i>

3.15.9 Congenital Pneumonia (P23.-)

Untuk Pneumonia kongenital, maka menggunakan kode P23.- (*Congenital pneumonia*) sesuai dengan jenis penyebab infeksi seperti contoh berikut:

- Jika *Pneumonia* kongenital yang disebabkan oleh *Chlamydia trachomatis*, maka menggunakan kode P23.1 (*Congenital pneumonia due to Chlamydia*)
- Jika *Pneumonia* disebabkan oleh *Chlamydial pneumoniae*, maka menggunakan kode J16.0 (*Chlamydial pneumonia*). Oleh karena itu,

jika dokter mendiagnosis *Chlamydial pneumonia*, koder harus meminta klarifikasi kepada dokter mengenai jenis spesifiknya. Apabila dokter menyatakan bahwa bayi baru lahir mengalami *nosocomial pneumonia*, *ventilator-associated pneumonia*, atau *community-acquired pneumonia*, maka menggunakan kode yang sesuai dalam kelompok J12 – J18.

3.15.10 Neonatal Aspiration of Meconium (P24.0)

- Untuk Sindrom aspirasi mekonium, maka menggunakan kode P24.0 (*Neonatal aspiration of meconium*).
- Apabila ada tambahan diagnosis *persistent pulmonary hypertension of the newborn*, maka dapat ditambahkan kode P29.3 (*Persistent fetal circulation*).

3.15.11 Haemolytic Diseases of Fetus and Newborn (P55, P58-P59)

- Kode dalam kelompok P55.- (*Haemolytic diseases of fetus and newborn*), P58.- (*Neonatal jaundice due to other excessive haemolysis*), atau P59.- (*Neonatal jaundice from other and unspecified causes*) dapat diberikan sesuai dengan penyebab kuning yang dicatat oleh dokter.
- Berikut adalah panduan pengkodean ICD-10 untuk berbagai jenis *jaundice neonatal* berdasarkan diagnosis yang diberikan oleh dokter:
 - a) Untuk Penyakit Kuning neonatal akibat defisiensi G6PD, maka menggunakan kode P59.8 (*Neonatal jaundice from other specified causes*) sebagai kode utama dan D55.0 (*Anaemia due to glucose-6-phosphate dehydrogenase [G6PD] deficiency*) sebagai kode tambahan.
 - b) Jika bayi baru lahir tidak menunjukkan gejala abnormal tetapi dinyatakan memiliki defisiensi G6PD melalui skrining, maka dapat menggunakan kode D55.0 (*Anaemia due to glucose-6-phosphate dehydrogenase [G6PD] deficiency*) sebagai kode utama, dan kode Z38.- (*Liveborn infants according to place of birth*) sebagai kode tambahan.

3.15.12 Syndrome Of Infant Of Mother With Gestational Diabetes (P70.0-P70.1)

- Untuk Sindrom bayi dari ibu dengan diabetes gestasional, maka menggunakan kode P70.0 (*Syndrome of infant of mother with gestational diabetes*).
- Untuk Sindrom bayi dari ibu diabetes, maka menggunakan kode P70.1 (*Syndrome of infant of a diabetic mother*). Pengode tidak perlu memberikan kode P70.4 (*Other neonatal hypoglycaemia*) karena hipoglikemia adalah gejala dari kondisi tersebut.

3.16 MDC 26 PENYAKIT PADA DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK DARAH

PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 26

- Jika pasien dengan *Thalasemia Mayor*, pada saat kontrol ulang diberikan obat kelasi besi (*Deferiprone*, *Deferoxamine* dan *Deferasirox*) maka perlu diinput sebagai pasien rawat jalan dengan menggunakan kode D56.1 (*Beta thalassaemia*) sebagai diagnosis utama.
- Dalam MDC 26, terdapat DRG khusus untuk pemberian transfusi faktor koagulasi dan transfusi darah sehingga koder harus memperhatikan dokumentasi medis dan bukti tatalaksana pemberian transfusi.
 - Apabila terdapat diagnosis yang masuk ke dalam MDC 26 dan disertai dengan tindakan transfusi darah dengan kode 99.03, 99.04, dan 99.05, maka dapat dimasukkan ke dalam DRG dengan diagnosis *Red Blood Cell Disorders w/ Blood Transfusion* atau *Coagulation Disorders w/ Blood Transfusion* atau *Immunity Disorders w/ Blood Transfusion*.
 - Apabila terdapat diagnosis yang masuk ke dalam kelompok *coagulation disorders* dan disertai dengan tindakan transfusi faktor koagulasi dengan kode 99.06, maka dapat dimasukkan ke dalam DRG *Coagulation Disorders w/ Coagulation Factor Transfusion*.

PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 26

Beberapa kondisi yang termasuk dalam bab ini dapat disebabkan oleh obat-obatan atau faktor eksternal lainnya. Kode dari Bab XX digunakan sebagai kode tambahan untuk mengidentifikasi penyebab eksternal tersebut.

Tabel X. Contoh kasus iDRG MDC 26

Contoh 1-26	Pasien mengalami anemia defisiensi folat yang disebabkan karena trimetoprim	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Anemia defisiensi folat yang disebabkan oleh trimetoprim	D52.1 <i>Drug-induced folate deficiency anaemia</i>
Diagnosis Sekunder	-	-
Penyebab Eksternal	Efek samping obat trimetoprim	Y41.2 <i>Antimalarials and drugs acting on other blood protozoa</i>

3.16.1 Pengambilan dan Transplantasi Sel Induk / Sumsum Tulang

Bagi pasien kanker yang dirawat untuk pengambilan sel induk atau sumsum tulang sebagai bagian dari persiapan transplantasi, maka

menggunakan kode untuk jenis kanker tersebut sebagai kode diagnosis utama. Pengode dilarang menggunakan kode Z52.0 *Blood donor* atau Z52.3 *Bone marrow donor* dalam kasus *autologous donation* (pengambilan dari tubuh sendiri).

3.16.2 Anemia (D50-D64)

- Untuk *Iron deficiency anaemia*, maka menggunakan kode dalam grup D50.- (*Iron deficiency anaemia*) sesuai rincian yang dicantumkan oleh dokter.
- Untuk *Vitamin B12 deficiency anaemia*, maka menggunakan kode dalam grup D51.- (*Vitamin B12 deficiency anaemia*).
- Untuk *Folate deficiency anaemia*, maka menggunakan kode dalam grup D52.- (*Folate deficiency anaemia*).
- Untuk *Megaloblastic anaemia*, maka menggunakan kode D53.1 (*Other megaloblastic anaemias, not elsewhere classified*).
- Untuk *Thalassaemia*, maka koder harus memeriksa rekam medis supaya dapat mengetahui jenis yang disebutkan.
 - Untuk *Alpha thalassaemia*, *haemoglobin H disease*, atau *haemoglobin constant spring*, maka menggunakan kode D56.0 (*Alpha thalassaemia*).
 - Untuk *Beta thalassaemia* atau *beta thalassaemia/haemoglobin E*, maka menggunakan kode D56.1 (*Beta thalassaemia*).
 - Untuk *Alpha thalassaemia trait* atau *beta thalassaemia trait*, maka menggunakan kode D56.3 (*Thalassaemia trait*).
 - Untuk jenis yang tidak disebutkan, maka menggunakan kode D56.9 (*Thalassaemia, unspecified*).
- Untuk *Homozygous haemoglobin E*, *heterozygous haemoglobin E*, atau *haemoglobin E trait*, maka menggunakan kode D58.2 (*Other haemoglobinopathies*).

Setelah memberikan kode jenis anemia yang didiagnosis oleh dokter, maka pengode tidak perlu menggunakan kode D64.9 (*Anaemia, unspecified*) sebagai diagnosis tambahan.

a. Anemia ditemukan bersamaan dengan penyakit lain

- Jika Anemia bersamaan dengan kanker, maka menggunakan kode kanker sebagai diagnosis utama dan dapat menambahkan kode D63.0* (*Anaemia in neoplastic disease*) sebagai diagnosis tambahan.
- Jika Anemia bersamaan dengan penyakit hati atau gangguan endokrin tertentu, maka menggunakan kode penyakit utama sebagai diagnosis utama dan dapat menambahkan kode D63.1* (*Anaemia due to liver and endocrine disorders*) sebagai diagnosis tambahan.
- Jika Anemia bersamaan dengan penyakit kronis, seperti gagal ginjal (stage 3 atau lebih tinggi), maka menggunakan kode gagal ginjal sebagai diagnosis utama dan dapat menambahkan kode D63.8* (*Anaemia in other chronic diseases classified elsewhere*) sebagai diagnosis tambahan.
- Jika Anemia bersamaan dengan infeksi kronis, maka menggunakan kode infeksi sebagai diagnosis utama dan dapat menambahkan kode D63.8* (*Anaemia in other chronic diseases classified elsewhere*) sebagai diagnosis tambahan.

Catatan: Dilarang memberikan kode jenis anemia berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium tanpa catatan diagnosis dari dokter.

3.16.3 Other Aplastic Anaemias (D61.)-

Diagnosis ini dapat menggunakan kode dalam grup D61.- (*Other aplastic anaemias*) sesuai dengan jenis *aplastic anaemias* yang didiagnosis oleh dokter:

- Untuk *Pancytopenia* dengan rincian riwayat medis dan hasil biopsi sumsum tulang, maka menggunakan kode yang lebih spesifik dalam grup D61.- (*Other aplastic anaemias*).
- Untuk *Pancytopenia* dengan penyebab spesifik, maka gunakan kode sesuai penyebab tersebut, seperti D73.1 (*Hypersplenism*) atau C92.0 (*Acute myeloid leukemia*).
- Untuk *Bicytopenia* yang tidak memiliki kode spesifik maka koder harus memeriksa diagnosis dokter apakah menyebutkan *anemia*,

neutropenia, atau *trombositopenia*. Lalu gunakan kode untuk kondisi yang ditemukan, antara lain:

D64.9 (*Anaemia, unspecified*)

D70 (*Agranulocytosis*)

D69.6 (*Thrombocytopenia, unspecified*)

3.16.4 Gangguan Koagulasi (D65-D69)

Aturan pengkodean untuk kondisi hiperkoagulasi (*hypercoagulable state*) dalam ICD-10 mengharuskan diagnosis tersebut dituliskan dengan jelas oleh dokter dan sesuai dengan pedoman ICD-10. Berikut beberapa aturan mengenai kondisi hiperkoagulasi:

- Kode untuk kondisi hiperkoagulasi hanya boleh digunakan jika pasien mendapatkan tatalaksana untuk kondisi hiperkoagulasi.
- Dokumentasi yang kurang jelas perlu dilakukan klarifikasi kepada dokter untuk memastikan apakah kondisi hiperkoagulasi penting selama perawatan.
- Pasien yang mengalami perdarahan akibat penggunaan obat antikoagulan yang diberikan dengan benar, maka hiperkoagulasi dianggap sebagai efek samping dari obat, dan tetap dikoding
- Perdarahan seperti batuk darah, darah dalam urine, muntah darah, atau darah dalam tinja yang terkait dengan obat antikoagulan, maka gunakan kode D68.3 (*Haemorrhagic disorder due to circulating anticoagulants*)
- Dokumentasi hiperkoagulasi yang tidak jelas dan ditemukan hasil pemeriksaan laboratorium seperti waktu protrombin yang memanjang abnormal maka gunakan kode R79.1.
- Gangguan pembekuan darah, purpura, dan kondisi perdarahan lainnya dapat dikode sesuai jenis kelainan yang dialami pasien.
 - a) Diagnosis *Disseminated Intravascular Coagulation* (DIC), maka gunakan kode D65 (*Disseminated intravascular coagulation [defibrination syndrome]*).
 - b) Diagnosis *Coagulation defect*, maka gunakan kode D68.9 (*Coagulation defect, unspecified*).

- Berikan kode untuk gangguan koagulasi sesuai dengan subtype yang didiagnosis oleh dokter.

Tabel X. Contoh kasus iDRG MDC 26 Gangguan Koagulasi

Contoh 2-26	Perempuan berusia 55 tahun dengan kondisi fibrilasi atrium telah menjalani pengobatan dengan obat warfarin selama 1 tahun. Dia datang dengan keluhan pendarahan gusi dan urine berdarah. Pemeriksaan laboratorium menunjukkan hasil PT-INR 4.0. Pasien tidak mengonsumsi obat yang berbeda dari yang diresepkan oleh dokter.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Pendarahan dari <i>warfarin</i>	D68.3 <i>Hemorrhagic disorder due to circulating anticoagulants</i>
Diagnosis Sekunder	<i>Fibrilasi atrium</i>	I48 <i>Fibrilasi atrium</i>
Penyebab Eksternal	<i>Warfarin</i>	Y44.2 <i>Anticoagulants</i>

3.16.5 Non-Thrombocytopenic Purpura (D69.0-D69.2)

- *Nonthrombocytopenic purpura* akibat alergi, maka gunakan kode D69.0 (*Allergic purpura*).
- Disfungsi trombosit, maka gunakan kode D69.1 (*Qualitative platelet defects*).
- Diagnosis dengan penyebab lainnya, maka gunakan kode D69.2 (*Other nonthrombocytopenic purpura*).

3.16.6 Agranulocytosis

- Jika terdapat neutropenia demam, gunakan kode D70 (*Agranulocytosis*) sebagai diagnosis utama jika hanya terjadi penurunan sel darah putih saja, atau gunakan kode D61.1 (*Drug-induced aplastic anaemia*) sebagai diagnosis utama jika terjadi penurunan semua jenis sel darah (*pancitopenia*). Kode ini harus digunakan bersama dengan kode diagnosis tambahan, seperti:
 - Kode R50.9 (*Fever of unknown origin*) jika dokter tidak menentukan lokasi infeksi, atau
 - Kode infeksi spesifik sesuai lokasi yang didiagnosis oleh dokter. Contohnya, jika dokter mendiagnosis infeksi saluran kemih bagian atas, gunakan kode N10 (*Acute tubulointerstitial nephritis*), atau

- Kode dari kelompok A40.- (*Streptococcal sepsis*) atau A41.- (*Other sepsis*) jika dokter mendiagnosis septikemia dan menentukan hasil pembiakan bakteri, atau
- Kode A41.9 (*Sepsis, unspecified*) jika dokter mendiagnosis septikemia tetapi tidak menentukan hasil pembiakan bakteri.
- Jika dokter mendiagnosis bahwa neutropenia demam disebabkan oleh obat kemoterapi, gunakan kode eksternal berdasarkan jenis obat kemoterapi yang menjadi penyebab, seperti:
 - Y43.1 (*Antineoplastic antimetabolites*),
 - Y43.2 (*Antineoplastic natural products*),
 - Y43.3 (*Other antineoplastic drugs*).

3.17 MDC 27 PENYAKIT DAN GANGGUAN PROLIFERATIF

PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 27

Kelompok diagnosis *myeloproliferatif* (MPD) mencakup beberapa kondisi yang dapat berkembang menjadi keganasan, seperti *leukemia mieloid kronis* (LMK) dan *mielofibrosis primer*. LMK adalah salah satu bentuk keganasan darah yang berkembang dari MPD, ditandai oleh proliferasi sel-sel *myeloid* yang abnormal dalam sumsum tulang. Hal ini disebabkan oleh mutasi genetik seperti translokasi kromosom *Philadelphia*, yang menghasilkan protein BCR-ABL yang onkogenik. Pasien dengan LMK dapat mengalami peningkatan jumlah sel darah putih, anemia, dan trombositosis. Selain itu, juga mengalami gejala seperti kelelahan, berat badan turun, dan pembesaran limpa.

Sementara itu, *myelofibrosis primer* adalah kondisi MPD yang ditandai oleh *fibrosis* atau penggantian jaringan normal sumsum tulang oleh jaringan parut. Kondisi ini dapat berkembang menjadi keganasan, terutama ketika mutasi genetik tambahan terjadi, seperti mutasi genetik dalam gen JAK2, MPL, atau CALR. Pasien dengan *mielofibrosis primer* dapat mengalami gejala seperti kelelahan, pembesaran limpa atau hati, dan peningkatan risiko infeksi dan perdarahan. Terkadang, *mielofibrosis primer* juga dapat berkembang menjadi *leukemia mieloid akut* (AML).

Pemahaman akan potensi keganasan MPD penting dalam manajemen dan perawatan pasien. Dokter harus memantau pasien secara ketat untuk deteksi dini perkembangan keganasan dan merencanakan intervensi yang sesuai. Pemantauan dapat melibatkan terapi target yang lebih agresif atau transplantasi sumsum tulang. Tindak lanjut rutin dengan pemeriksaan fisik, tes darah, dan pemantauan genetik diperlukan untuk mengelola risiko dan memaksimalkan hasil pasien.

PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 27

3.17.1 *Malignant Neoplasms Of Lymphoid, Haematopoietic And Related Tissue (C81-C96)*

- *B-cell lymphoma* dengan sub tipe tertentu, maka gunakan kode spesifik. Contohnya: *Diffuse large B-cell lymphoma*, maka gunakan kode C83.3 (*Diffuse large B-cell lymphoma*). Jangan gunakan kode C85.1 (*B-cell lymphoma, unspecified*).

- *Refractory anaemia with excess blasts in transformation*, maka gunakan kode C92.0 (*Acute myeloid leukaemia*) [AML].

DRAFT V1

3.18 MDC 28 PENYAKIT INFEKSI DAN PARASIT

PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 28

- Pada kasus *typhoid* dalam kehamilan yang dirawat oleh dokter spesialis penyakit dalam, jika tidak ada diagnosis lainnya, berikan kode untuk *typhoid* pada kehamilan yaitu O98.8 *Other maternal infectious and parasitic diseases complicating pregnancy, childbirth and the puerperium* sebagai diagnosis utama dan A01.0 *Typhoid fever* sebagai diagnosis sekunder.
- Tidak ada kode gabung antara *typhoid* dengan diare menjadi A02.0 karena instruksi *exclude* pada volume I sub bab *other gastroenteritis and colitis or infectious and unspecified origin* (A09) yang menyatakan “*gastroenteritis and colitis due to bacterial, protozoal, viral and other specified infectious agents*” mengarah pada kode spesifik sesuai dengan organismenya (A00-A08). Sehingga kode A09 seharusnya tidak dikoding lagi apabila sudah ada *typhoid fever* (A01.0) yang tegak secara medis.
- Perlu diperhatikan lagi penggunaan kode A09, A09.0 dan A09.9 digunakan untuk diare yang penyebabnya tidak diketahui. Jika penyebab diare diketahui maka menggunakan kode yang spesifik. Jika disebabkan oleh bakteri, protozoa, virus dan organisme spesifik lainnya berada dalam A00-A08. Contoh GE akibat infeksi *Entamoeba Histolytica* disebut disentri dan dikoding dengan menggunakan kode A06.0 tanpa A09.
- Kasus TB dengan *Pneumonia/Bronchopneumonia* menggunakan kode gabungan A16.2 (*Tuberculosis of lung*), dengan penjelasan kondisi tuberculous pneumonia sudah termasuk (*include*) dalam kode A16.2. Perlu dijadikan perhatian pada sub bab A15-A19 termasuk pada kondisi infeksi yang disebabkan oleh *Mycobacterium Tuberculosis* dan *mycobacterium bovis*:
 - Kode A15.1 (*Tuberculosis of lung, confirmed by culture only*) hanya digunakan pada TB Paru yang sudah ditegakkan melalui kultur.
 - A15.2 (*Tuberculosis of lung, confirmed histologically*) hanya digunakan pada TB Paru yang sudah ditegakkan melalui pemeriksaan histologis.
 - A15.3 (*Tuberculosis of lung, confirmed by unspecified means*) hanya digunakan pada TB Paru yang sudah tegak namun tidak dapat dipastikan secara bakteriologi ataupun histologis.

- Kasus TB dengan malnutrisi terdapat kode kombinasi hanya untuk kasus marasmus yaitu kode E41 (*Nutritional marasmus*).
- Kode *pneumonia* (J18.9) dengan TB Paru (A15.2 atau A16.2) sudah termasuk dalam kode A15.2 atau A16.2 dengan kepastian dari pemeriksaan penunjang. Jika ada sepsis / *Septicaemia, unspecified* (A41.9) dengan Pneumonia (J18.9) tidak ada instruksi *includes/exclude* secara langsung untuk kode gabungan antara keduanya.
- Sepsis dengan shock sepsis sesuai dengan ICD-10 sudah termasuk kedalam A41.9 tanpa perlu menambahkan R57.2 (*Septic shock*).
- Jika pasien mengalami shock kardiogenik bersamaan dengan sepsis, pengode tidak boleh hanya mengkode sepsis saja. Dalam kaidah morbiditas untuk klaim, tidak ada aturan *includes* dan *excludes* yang menggabungkan kode sepsis (A41.9) dengan kode shock kardiogenik (R57.0) menjadi satu kode. Jadi, kedua kode tersebut harus dicatat secara terpisah.
- Begitu juga dengan shock hipovolemik (R57.1) yang terjadi bersamaan dengan sepsis (A41.9), tidak ada aturan yang menggabungkan keduanya menjadi satu kode. Oleh karena itu, kode sepsis dan kode shock hipovolemik juga harus dikodekan secara terpisah
- Jika dokter memberikan diagnosis hanya gas gangrene, dapat dikode R02 *Gangrene, not elsewhere classified*. Jika dokter memberikan diagnosis gas gangrene dikode A48.0 dan gangrene pada diabetes mellitus diberikan kode E10-E14 (sesuai dengan jenis diabetes mellitus) dengan digit terakhir .5
- Jika dokter memberikan diagnosis ancylostomiasis, gunakan kode B76.0 termasuk di dalamnya uncinariasis. Jika dokter memberikan diagnosis askariasis atau infeksi cacing gelang, gunakan kode B77.-. Perhatikan kode dagger asterisk dengan pneumonia dan komplikasi intestinal.
- Sepsis adalah reaksi tubuh terhadap infeksi di mana tubuh menyerang organ dan jaringan sendiri. Kondisi ini sangat berbahaya dan perlu penanganan segera. Sepsis bukanlah infeksi itu sendiri. Aturan dan cara mengenali serta mengobati sepsis terus berubah dari waktu ke waktu. Di berbagai negara, pemahaman dan cara mencatat sepsis juga berbeda-beda. Sepsis sulit didiagnosis karena tidak ada tes laboratorium khusus yang bisa dengan cepat dan pasti memastikan apakah seseorang mengalami sepsis atau tidak,

terutama saat pengobatan harus segera dimulai. Untuk membantu mengenali pasien yang mungkin mengalami sepsis dan membutuhkan penanganan cepat, ada berbagai alat, sistem penilaian, dan pedoman yang digunakan oleh tenaga medis.

- Jika pasien didiagnosis sepsis, maka kode yang secara khusus menunjukkan sepsis harus selalu dicantumkan. Jika kode yang dipakai tidak secara khusus menyebut sepsis (misalnya A54.8 untuk infeksi gonokokal lainnya yang juga bisa menyebabkan sepsis), maka kode sepsis harus ditambahkan sebagai kode sekunder agar kondisi pasien tercatat lengkap.
- Jika dokter menyebut istilah seperti urosepsis, sepsis bilier, sepsis dada, sepsis intraokular, atau sepsis urinari, ini berarti pasien mengalami sepsis sekaligus infeksi di organ tertentu, sehingga dalam kasus ini kedua kondisi tersebut harus dikodekan. Namun, jika pasien hanya mengalami infeksi tanpa sepsis, misalnya infeksi saluran kemih atau infeksi dada tanpa tanda sepsis, maka kode sepsis tidak boleh digunakan.
- Jika sepsis terjadi karena adanya alat medis, implan, atau graft (seperti penggantian pinggul, kateter, stoma trakeostomi, atau kateter hemodialisis), ini berarti pasien memiliki sepsis dan infeksi di lokasi alat tersebut. Maka, kode untuk sepsis dan lokasi infeksi harus dicatat.
- Sepsis tidak selalu menjadi kondisi utama yang diobati, jadi urutan kode sepsis, infeksi, dan kondisi lain bisa disesuaikan sesuai dengan fokus pengobatan pasien.
- Setiap kali dokter mencatat syok septik dalam catatan medis, kode R57.2 Syok septik harus ditambahkan sebagai kode sekunder setelah kode yang menunjukkan sepsis.
- Untuk diagnosis sepsis berat, gunakan kode berikut dengan penempatan yang tepat :
 - Kode A41.- untuk sepsis (termasuk jenis sepsis tertentu yang tercatat dalam catatan medis)
 - Kode R65.1 untuk sindrom respons inflamasi sistemik akibat infeksi yang disertai kegagalan organ.
- Berikut merupakan beberapa contoh kasus sepsis:

- 1) Sepsis urinaria (konsultan yang bertanggung jawab mengkonfirmasi sepsis dan infeksi saluran kemih) karena streptokokus grup A, dengan syok septik dan kegagalan ginjal dan hati.

A40.0 Sepsis due to Streptococcus, group A

N39.0 Urinary tract infection, site not specified

B95.0 Streptococcus, group A, as the cause of diseases classified to other chapters

R57.2 Septic shock

N19.X Unspecified kidney failure

K72.9 Hepatic failure, unspecified

- 2) Sepsis urinaria dan sepsis bilier (konsultan yang bertanggung jawab mengkonfirmasi infeksi saluran kemih dan kolangitis tanpa sepsis)

N39.0 Urinary tract infection, site not specified

K83.0 Cholangitis

- 3) Sepsis setelah keguguran yang terlewat selama episode yang sama

O02.1 Missed abortion

O08.0 Genital tract and pelvic infection following abortion and ectopic and molar pregnancy

A41.9 Sepsis, unspecified

- 4) Pasien dengan infeksi streptokokus pada saluran kemih yang berkembang menjadi sepsis berat karena streptokokus. Cedera ginjal akut, kegagalan hati, dan syok septik.

A40.9 Streptococcal sepsis, unspecified

R65.1 Systemic Inflammatory Response Syndrome of infectious origin with organ failure

N39.0 Urinary tract infection, site not specified

B95.5 Unspecified streptococcus as the cause of diseases classified to other chapters

N17.9 Acute renal failure, unspecified

K72.9 Hepatic failure, unspecified

R57.2 Septic shock

5) *Sepsis stafilocokus* negatif koagulase pasca operasi karena infeksi kateter *hemodialisis stafilocokus negatif koagulase*.

A41.1 *Sepsis due to other specified staphylococcus*

T82.7 *Infection and inflammatory reaction due to other cardiac and vascular devices, implants and grafts*

B95.7 *Other staphylococcus as the cause of diseases classified to other chapters*

Y83.1 *Surgical operation with implant of artificial internal device*

(Operasi bedah dan prosedur bedah lainnya sebagai penyebab reaksi abnormal pasien, atau komplikasi kemudian, tanpa disebutkan ketidakberuntungan pada saat prosedur, operasi bedah dengan pemasangan perangkat internal buatan).

- Untuk kasus *Dengue Shock Syndrome* (DSS) menggunakan kode A91.0 *Dengue Haemorrhagic Fever, with shock* sebagai diagnosis utama, penambahan diagnosis syok disesuaikan dengan penegakan diagnosis dan tatalaksana yang diberikan.
- Berikut ini harus diterapkan saat melakukan pengodean penyakit HIV simptomatik (aktif):
 - Hanya gunakan satu kode dari kategori B20-B24 Penyakit *Human Immunodeficiency Virus* [HIV] jika kode tersebut sudah mewakili diagnosis HIV maupun penyakit yang ditimbulkan oleh HIV (kecuali HIV menyebabkan neoplasma ganas)
 - Jika kode penyakit HIV dari kategori B20-B24 tidak sepenuhnya mengklasifikasikan baik HIV maupun kondisi yang disebabkan oleh HIV, kode yang mengklasifikasikan kondisi juga harus dituliskan setelah kode penyakit HIV.
 - Jika terdapat lebih dari satu kondisi yang disebabkan oleh HIV yang diklasifikasikan ke kategori yang sama di B20-B22, sub-karakter .7 dari kategori yang sesuai harus digunakan, diikuti oleh kode yang mengklasifikasikan kondisi spesifik.
 - Ketika melakukan pengodean penyakit HIV yang menyebabkan neoplasma ganas, kode yang mengklasifikasikan neoplasma ganas harus dituliskan setelah kode yang mengklasifikasikan HIV yang menyebabkan

neoplasma ganas dari kategori B21.- *Human immunodeficiency virus [HIV] disease resulting in malignant neoplasms.*

- Jika seorang pasien memiliki penyakit HIV yang menyebabkan lebih dari satu neoplasma ganas, kode B21.7 HIV yang menyebabkan beberapa neoplasma ganas harus ditugaskan diikuti oleh kode-kode untuk neoplasma ganas yang spesifik.
- Contoh pengkodean kasus HIV:
 - a) *HIV disease resulting in Pneumocystis jirovecii pneumonia*
B20.6 *HIV disease resulting in Pneumocystis jirovecii pneumonia*
 - b) *HIV resulting in candidiasis of the mouth*
B20.4 *HIV disease resulting in candidiasis*
B37.0 *Candidal stomatitis*
 - c) *HIV disease resulting in respiratory tuberculosis and cytomegaloviral disease*
B20.7 *HIV disease resulting in multiple infections*
A16.9 *Respiratory tuberculosis unspecified, without mention of bacteriological or histological confirmation*
B25.9 *Cytomegaloviral disease, unspecified*
 - d) *HIV disease resulting in Kaposi sarcoma of multiple organs*
B21.0 *HIV disease resulting in Kaposi sarcoma*
C46.8 *Kaposi sarcoma of multiple organs*
 - e) *HIV disease resulting in Kaposi sarcoma of the palate and Burkitt lymphoma*
B21.7 *HIV disease resulting in multiple malignant neoplasms*
C46.2 *Kaposi sarcoma of palate*
C83.7 *Burkitt lymphoma*

Berikut merupakan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengkodean infeksi seperti :

- Dokumentasi medis yang mencatat agen/organisme infeksi tanpa menyebutkan lokasi spesifik infeksi, maka kode dari Bab I *Certain infectious and parasitic diseases (A00-B99)* ICD-10 harus diberikan untuk menjelaskan

dokumentasi medis tersebut. Dalam kasus ini, hanya agen penyebab infeksi yang dikodekan, tanpa menentukan lokasi infeksi.

- **Contoh:** Pasien masuk rumah sakit dengan demam dan menggigil. Hasil kultur darah menunjukkan infeksi *Staphylococcus*, maka gunakan kode A49.0 (*Staphylococcal infection, unspecified site*) (Infeksi Staphylococcal tanpa lokasi spesifik).
- Dokumentasi medis yang mencatat lokasi infeksi tanpa menyebutkan agen/organisme penyebabnya, maka kode yang digunakan harus berasal dari bab sistem tubuh terkait (Bab VI–XIV dalam ICD-10) yang sesuai dengan lokasi infeksi tersebut.
 - **Contoh:** Dokter mendiagnosis pasien dengan infeksi pada saluran kemih tanpa menyebutkan agen/organisme penyebab, maka berikan kode N39.0 (*Urinary Tract Infection, Site not specified*) (Lokasi spesifik infeksi tanpa agen penyebab).
- Dokumentasi medis yang mencatat lokasi infeksi dan agen/organisme, maka kode yang digunakan harus mencerminkan lokasi spesifik infeksi beserta agen penyebabnya. Penerapan kode mengikuti ketentuan berikut:
 - 1) Pada indeks alfabetik ICD-10, apabila ada petunjuk untuk menggunakan kombinasi kode *Dagger* (†) dan *Asterisk* (*) yang menggabungkan antara penyebab (agen/organisme) dan lokasi infeksi, maka gunakan kode *Dagger* untuk penyebab penyakit dan kode *Asterisk* untuk lokasi atau manifestasi infeksi sesuai sistem *Dagger & Asterisk*.
 - **Contoh:** Pasien dirawat karena infeksi *Salmonella*, kemudian selama pemulihan mengalami batuk yang memburuk. Dokter mendiagnosis pasien dengan *pneumonia* akibat infeksi *Salmonella*, maka gunakan kode A02.2† (*calized salmonella infections*) sebagai kode utama dan J17.0* (*Pneumonia in bacterial diseases classified elsewhere*) sebagai kode sekunder. **Catatan:** Dalam kaidah morbiditas *asterisk* dapat dipergunakan sebagai primer, jika dia merupakan alasan perawatan.
 - 2) Alfabet Indeks ICD-10 yang mengarahkan ke satu kode, dimana kode tersebut sudah mencakup agen/organisme dan lokasi infeksi, maka

gunakan kode tunggal tersebut tanpa perlu menambahkan kode tambahan dari Bab I (B95-B97).

- **Contoh:** Seorang pria 45 tahun mengalami demam tinggi, sakit kepala berat, muntah, dan leher kaku. Pungsi lumbal menunjukkan leukosit meningkat, protein tinggi, dan glukosa rendah. Hasil kultur CSF mengkonfirmasi infeksi *Streptococcus* tanpa spesifikasi lebih lanjut. Pasien didiagnosa *Meningitis Streptococcus*, maka gunakan kode G00.2 (*Streptococcal meningitis*) tanpa tambahan kode dari chapter I (B95- B97).

3) Agen infeksi yang tidak teridentifikasi secara spesifik atau dokumentasi medis yang hanya mencantumkan kategori umum misalnya *Streptococcus* tanpa sub kelompoknya, maka kode dari B95-B97 dapat digunakan sebagai tambahan untuk menjelaskan jenis patogen.

- **Contoh:** Seorang pria 40 tahun mengalami demam tinggi, sakit kepala berat, dan gangguan kesadaran. Pemeriksaan pungsi lumbal menunjukkan peningkatan leukosit dan protein tinggi dengan hasil kultur CSF menunjukkan infeksi *Streptococcus* tanpa spesifikasi lebih lanjut. Pasien didiagnosis dengan meningitis bakteri akibat *Streptococcus Group D*, Maka gunakan kode G00.2 (*Streptococcal meningitis*) sebagai kode utama dan tambahkan kode B95.2 (*Streptococcus group D and enterococcus as the cause of diseases classified to other chapters*) sebagai kode sekunder untuk mengidentifikasi jenis patogen spesifik dari *streptococcus*.

PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 28

3.18.1 Other Salmonella Infections (A01-A02)

- *Arthritis salmonella*, maka gunakan kode A02.2† (*Localized salmonella infection*) sebagai kode utama dan tambahkan kode M01.3* (*Arthritis in other bacterial diseases classified elsewhere*) sebagai kode tambahan.
- *Osteomyelitis salmonella*, maka gunakan kode A02.2† (*Localized salmonella infection*) sebagai kode utama dan tambahkan kode

M90.2* (*Osteopathy in other infectious diseases classified elsewhere*) sebagai kode tambahan.

- *Meningitis salmonella*, maka gunakan kode A02.2† (*Localized salmonella infection*) sebagai kode utama dan tambahkan kode G01* (*Meningitis in other bacterial diseases classified elsewhere*) sebagai kode tambahan.

3.18.2 ***Enteroinvasive Escherichia Coli Infection (A04.0-A04.4)***

Gunakan kode A04.0 hingga A04.4, yang merupakan klasifikasi diagnosis medis untuk berbagai jenis infeksi *Escherichia coli* (*E. coli*), sesuai dengan hasil pemeriksaan dan diagnosis yang telah ditetapkan oleh dokter berdasarkan gejala serta hasil laboratorium pasien.

3.18.3 ***Enterocolitis Due To Clostridium Difficile (A04.7)***

Diare terkait antibiotik, *pseudomembranous enterocolitis*, atau *enterocolitis* akibat *Clostridium difficile*, maka gunakan kode A04.7 (*Enterocolitis due to Clostridium difficile*) dan tambahkan kode untuk penyebab eksternal sesuai dengan jenis antibiotik yang menjadi penyebab.

3.18.4 ***Other Bacterial Foodborne Intoxication, Not Elsewhere Classified (A05.-)***

Gunakan kode dalam kelompok A05.- (*Other bacterial foodborne intoxication, not elsewhere classified*) untuk keracunan makanan bakterial yang tidak diklasifikasikan di bawah kelompok lain, sesuai dengan jenis bakteri yang diidentifikasi oleh dokter sebagai penyebab. Jika dokter mendiagnosis adanya *food poisoning* atau keracunan makanan tanpa menyebutkan penyebab, maka gunakan kode A05.9 (*Bacterial foodborne intoxication, unspecified*).

3.18.5 ***Amoebiasis (A06.-)***

Berikan kode dalam kelompok A06.- (*Amoebiasis*), sesuai dengan jenis infeksi amoeba yang didiagnosis oleh dokter.

- *Abscess hati amoeba*, maka gunakan kode A06.4 (*Amoebic liver abscess*) sebagai kode utama dan tambahkan kode K77.0* (*Liver*

disorders in infectious and parasitic diseases classified elsewhere)
sebagai kode tambahan

- *Abscess paru-paru amoeba* atau *Abscess paru-paru amoeba* bersamaan dengan *Abscess hati amoeba*, gunakan kode A06.5† (*Amoebic lung abscess*) sebagai kode utama dan tambahkan kode J99.8* (*Respiratory disorders in other diseases classified elsewhere*) sebagai kode tambahan.
- *Abscess otak amoeba*, atau *Abscess otak amoeba* bersamaan dengan *Abscess hati amoeba* atau *Abscess paru-paru amoeba*, gunakan kode A06.6† (*Amoebic brain abscess*) sebagai kode utama dan tambahkan kode G07* (*Intracranial and intraspinal abscess and granuloma in diseases classified elsewhere*) sebagai kode tambahan.

3.18.6 Adenoviral Enteritis (A08.0-A08.4)

- *Rotaviral diarrhoea*, maka gunakan kode A08.0 (*Rotaviral enteritis*).
- *Viral gastroenteritis*, *viral gastritis*, *viral enteritis*, atau *viral diarrhoea*, maka gunakan kode A08.4 (*Viral intestinal infection, unspecified*).

3.18.7 Other Gastroenteritis And Colitis Of Infectious And Unspecified Origin (A09.-)

- *Drug-induced diarrhoea*, maka gunakan kode K52.1 (*Toxic gastroenteritis and colitis*) disertai kode penyebab eksternal sesuai jenis obat yang menjadi penyebab.
- Jika dokter mendiagnosis gastroenteritis toksik akibat kemoterapi, gunakan kode K52.1 (*Toxic gastroenteritis and colitis*) sebagai diagnosis utama dan kode Y43.1 – Y43.3 sebagai kode eksternal.
- *Cow's milk protein-induced diarrhoea*, maka gunakan kode K52.20 (*Allergic and dietetic gastroenteritis and colitis due to cow's milk protein^{IM}*).
- *Food hypersensitivity gastroenteritis*, maka gunakan kode K52.29 (*Allergic and dietetic gastroenteritis, unspecified^{IM}*).
- *Non infectious diarrhoea*, maka gunakan kode K52.9 (*Noninfective gastroenteritis and colitis, unspecified*).

- Dehidrasi atau kondisi terkait lainnya seperti defisiensi volume cairan, hipotensi postural, atau *azotemia prerenal* tidak perlu dikode secara terpisah, kecuali jika dokter secara jelas mendiagnosis adanya *Hypovolaemic shock*, maka gunakan kode R57.1 (*Hypovolaemic shock*).

3.18.8 Tuberculosis (A15-A19)

1) Tuberkulosis paru, maka gunakan kode dalam kelompok A15.- dan A16.- sesuai diagnosis yang disebutkan oleh dokter:

- Diagnosis berdasarkan penemuan basil tahan asam pada dahak melalui pewarnaan atau metode PCR, maka gunakan kode A15.0 (*Tuberculosis of lung, confirmed by sputum microscopy with or without culture*).
- Diagnosis berdasarkan hasil kultur saja, maka gunakan kode A15.1 (*Tuberculosis of lung confirmed by culture only*).
- Diagnosis berdasarkan hasil biopsi jaringan, maka gunakan kode A15.2 (*Tuberculosis of lung, confirmed histologically*).
- Diagnosis berdasarkan gejala klinis, seperti batuk kronis dan gambar radiologi dada yang konsisten dengan tuberkulosis (misalnya, adanya kavitas di bagian atas paru) tetapi pemeriksaan mikrobiologi dan *histopatologi* tidak menemukan basil tuberkulosis, maka gunakan kode A16.0 (*Tuberculosis of lung, bacteriologically and histologically negative*).
- Diagnosis berdasarkan gejala klinis dan gambar radiologi dada tanpa pemeriksaan dahak atau biopsi jaringan, maka gunakan kode A16.1 (*Tuberculosis of lung, bacteriological and histological examination not done*).
- Tidak ada bukti pemeriksaan dahak atau biopsi jaringan dilakukan, maka gunakan kode A16.2 (*Tuberculosis of lung without mention of bacteriological or histological confirmation*).

2) Tuberkulosis kelenjar getah bening, maka gunakan kode sesuai lokasi kelenjar getah bening yang terkena:

- Tuberkulosis kelenjar getah bening intratoraks, maka gunakan kode A15.4 (*Tuberculosis of intrathoracic lymph nodes, confirmed*

bacteriologically and histologically) atau A16.3 (*Tuberculosis of intrathoracic lymph nodes, without mention of bacteriological or histological confirmation*), tergantung konfirmasi diagnosis melalui pemeriksaan laboratorium atau tidak.

- Tuberkulosis kelenjar getah bening abdomen, maka gunakan kode A18.3 (*Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands*).
- Tuberkulosis kelenjar getah bening perifer (misalnya, di leher), maka gunakan kode A18.2 (*Tuberculous peripheral lymphadenopathy*).

3) Tuberkulosis pleura:

- Tuberkulosis pleura dengan spesifikasi diagnosis yang dikonfirmasi melalui biopsi menunjukkan proses *granulomatosa* atau basil tahan asam ditemukan pada jaringan atau cairan pleura atau pemeriksaan PCR positif, maka gunakan kode A15.6 (*Tuberculous pleurisy, confirmed bacteriologically and histologically*).
- Tidak ada pemeriksaan yang dilakukan atau hasilnya negatif, maka gunakan kode A16.5 (*Tuberculous pleurisy, without mention of bacteriological or histological confirmation*).

4) Tuberkulosis pada organ lain:

- Tuberkulosis meningitis, maka gunakan kode A17.0† (*Tuberculous meningitis*) sebagai kode utama dan gunakan kode G01* (*Meningitis in bacterial diseases classified elsewhere*) sebagai kode tambahan.
- Tuberkuloma atau tuberkulosis otak, maka gunakan kode A17.8† (*Other tuberculosis of nervous system*) sebagai kode utama dan tambahkan kode G07* (*Intracranial and intraspinal abscess and granuloma in diseases classified elsewhere*) sebagai kode tambahan.
- Tuberkulosis perikarditis, maka gunakan kode A18.8† (*Tuberculosis of other specified organs*) sebagai kode utama dan tambahkan kode I32.0* (*Pericarditis in bacterial diseases classified elsewhere*) sebagai kode tambahan.

- Tuberkulosis peritonitis, maka gunakan kode A18.3† (*Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands*) sebagai kode utama dan tambahkan kode K67.3* (*Tuberculous peritonitis*) sebagai kode tambahan.
- Tuberkulosis tulang atau sendi, maka gunakan kode A18.0† (*Tuberculosis of bones and joints*) sebagai kode utama dan tambahkan kode tambahan sesuai lokasi tulang atau sendi yang terkena. Misalnya, terjadi pada lokasi tulang belakang, maka gunakan kode M49.0* (*Tuberculosis of spine*).
- Tuberkulosis respirasi primer dengan konfirmasi laboratorium atau histopatologi, maka gunakan kode A15.7 (*Primary respiratory tuberculosis, confirmed bacteriologically and histologically*).
- Tuberkulosis respirasi primer tanpa konfirmasi laboratorium atau histopatologi, maka gunakan kode A16.7 (*Primary respiratory tuberculosis, without mention of bacteriological or histological confirmation*).
- Tuberkulosis milier akut pada satu organ tunggal, maka gunakan kode A19.0 (*Acute miliary tuberculosis of a single site*).
- Tuberkulosis milier akut pada beberapa organ tunggal, maka gunakan kode A19.1 (*Acute miliary tuberculosis of multiple sites*) dan berikan kode tambahan untuk setiap organ yang terkena sesuai tingkat keparahan penyakit.

3.18.9 Infection Due To Other Mycobacteria (A31.-)

Gunakan kode yang termasuk dalam kelompok A31.- (*Infection due to other mycobacteria*) dengan memperhatikan jenis penyakit spesifik yang telah di diagnosis oleh dokter. Diagnosis ini harus didasarkan pada hasil pemeriksaan klinis yang teliti, analisis laboratorium untuk mengidentifikasi spesies mikrobakteria penyebab infeksi. Pilihlah kode yang secara tepat merepresentasikan jenis mikobakteria yang terlibat.

3.18.10 Listeriosis (A32.-)

Jika dokter mendiagnosis *listerial meningitis*, gunakan kode A32.1† (*Listerial meningitis and meningoencephalitis*) sebagai kode utama dan kode G01* (*Meningitis in bacterial diseases classified elsewhere*) sebagai kode tambahan. Jika dokter mendiagnosis *listerial meningoencephalitis*, gunakan kode A32.1† (*Listerial meningitis and meningoencephalitis*) sebagai kode utama dan tambahkan kode G05.0* (*Encephalitis, myelitis and encephalomyelitis in bacterial diseases classified elsewhere*) sebagai kode tambahan.

3.18.11 Diphtheria (A36)

Gunakan kode yang termasuk dalam kelompok A36.- (*Diphtheria*) dengan memperhatikan jenis spesifik difteri yang telah di diagnosis oleh dokter. Diagnosis ini harus didasarkan pada hasil pemeriksaan klinis yang cermat, analisis laboratorium untuk mengkonfirmasi keberadaan *Corynebacterium diphtheriae* sebagai penyebab infeksi, serta evaluasi menyeluruh terhadap gejala dan riwayat medis pasien.

Catatan: Pastikan bahwa kode yang dipilih secara akurat mencerminkan bentuk atau manifestasi difteri yang dialami oleh pasien.

3.18.12 Meningococcal Infection (A39.-)

Jika dokter *Meningococcal meningitis*, gunakan kode A39.0† (*Meningococcal meningitis*) sebagai kode utama, dan tambahkan kode G01* (*Meningitis in bacterial diseases classified elsewhere*) sebagai kode tambahan. Jika dokter mendiagnosis *Waterhouse-Friderichsen syndrome*, gunakan kode A39.1† (*Waterhouse-Friderichsen syndrome*) sebagai kode utama, dan tambahkan kode E35.1* (*Disorders of adrenal glands in diseases classified elsewhere*) sebagai kode tambahan. Pada kasus di mana dokter mendiagnosis infeksi meningokokus pada jantung atau organ lain, gunakan kode A39.5† (*Meningococcal heart disease*) atau A39.8† (*Other meningococcal infections*), disertai kode tambahan sesuai organ yang terinfeksi.

3.18.13 Sepsis (A40-A41)

- Sepsis atau septikemia akibat berbagai jenis bakteri yang bersamaan dengan diagnosis sumber infeksi seperti pneumonia, pielonefritis akut, kolesistitis akut, atau peritonitis bakterial spontan, maka gunakan kode untuk penyakit yang menjadi sumber infeksi tersebut sebagai diagnosis utama.

Contoh 1-28	Pasien mengalami demam tinggi dan menggigil selama 1 hari. Pemeriksaan menunjukkan suhu tubuh 39 °C, frekuensi napas 26 kali per menit, denyut jantung 100 kali per menit, tekanan darah 120/70 mmHg, serta nyeri tekan di sudut <i>kostovertebral</i> kanan. Pemeriksaan urin menunjukkan jumlah leukosit yang sangat tinggi. Kultur bakteri dari urin dan darah positif untuk <i>E.coli</i> .	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Pielonefritis akut	N10 <i>Acute tubulo-interstitial nephritis</i>
Diagnosis sekunder	Sepsis karena <i>E.Coli</i>	A41.5 <i>Sepsis due to other Gram-negative organisms</i> B96.2 <i>Escherichia coli [E. coli] as the cause of diseases classified to other chapters</i>

- Sindrom respons inflamasi sistemik (SIRS) yang berhubungan dengan infeksi non-bakteri pada organ tertentu (misalnya, kultur darah negatif meskipun ada bukti infeksi dari sumber lain), maka gunakan *systemic inflammatory response syndrome of infectious origin* sebagai diagnosis tambahan.
 - Gunakan kode R65.0 (*Systemic inflammatory response syndrome of infectious origin without organ failure*) untuk SIRS infeksius tanpa kegagalan organ, sebagai diagnosis tambahan.
 - Gunakan kode R65.1 (*Systemic inflammatory response syndrome of infectious origin with organ failure*) untuk SIRS infeksius dengan kegagalan organ, sebagai diagnosis tambahan.

Catatan: Jangan menggunakan kode sepsis dalam kasus ini.

- Sepsis sebagai diagnosis awal, kemudian ditemukan sindrom respons inflamasi sistemik (SIRS) yang disebabkan oleh kondisi lain seperti peritonitis, maka gunakan kode infeksi dengan sumber yang diketahui sebagai diagnosis utama dan gunakan kode sepsis sesuai jenis bakteri yang telah diidentifikasi oleh dokter sebagai diagnosis tambahan.
- Pasien yang dirawat karena sepsis dengan kegagalan organ akut harus dikodekan sesuai aturan pada *severe sepsis*. Namun, jika dokumen medis menyatakan kegagalan organ tersebut tidak terkait dengan sepsis, maka kode R65.1 tidak boleh digunakan. Jika hubungan antara sepsis dan kerusakan organ tidak jelas, *coder* harus meminta klarifikasi dari dokter yang menangani pasien.
- Untuk kasus selain infeksi, gunakan kode penyakit yang ditetapkan dokter sebagai penyebab utama. Kode sindrom respons inflamasi sistemik (SIRS) non-infeksi, seperti R65.2 (tanpa kegagalan organ) atau R65.3 (dengan kegagalan organ), diberikan sebagai kode diagnosis tambahan, bukan sebagai diagnosis utama.
- Pasien yang datang dengan gejala sindrom respon inflamasi sistemik (SIRS) tanpa ada pendeteksian sumber infeksi. Saat dilakukan pemeriksaan kultur darah, hasil menunjukkan adanya infeksi. Dokter mencatat diagnosis primer sepsis, maka gunakan kode sepsis menurut infeksi yang dikultur sebagai kode diagnosis utama.
- Kode yang secara spesifik mengklasifikasikan sepsis harus selalu diberikan ketika pasien didiagnosis dengan sepsis dan tercatat dalam rekam medis. Jika kode yang diberikan tidak secara spesifik mengklasifikasikan sepsis (misalnya A54.8 Infeksi gonokokus lainnya, yang mencakup sepsis gonokokus), maka gunakan kode yang mengklasifikasikan sepsis pada posisi sekunder mana saja, untuk menggambarkan kondisi tersebut secara lengkap.
- Diagnosis menggunakan istilah seperti urosepsis, sepsis bilier, sepsis dada, sepsis intraokular, dan sepsis urin, Hal ini berarti bahwa pasien mengalami sepsis dan infeksi lokal pada organ, maka kedua kondisi tersebut harus dikode.

- Seorang pasien hanya mengalami infeksi tanpa disebutkan sepsis dalam dokumentasi klinis rekam medis maka tidak boleh menggunakan kode sepsis. Contohnya infeksi saluran kemih tanpa sepsis atau tidak dengan Urosepsis.
- Sepsis yang diakibatkan oleh alat, implan, atau cangkok (misalnya sepsis akibat total penggantian pinggul, kateter infus, stoma trakeostomi, jalur pembuluh darah, hemodialisis kateter, dll.), hal ini berarti bahwa pasien memiliki sepsis dan infeksi lokal di lokasi perangkat, implan atau cangkok. Dalam kasus ini, baik sepsis maupun lokasi infeksi lokalnya keduanya harus dikode.

Contoh 2-28	Pasien dengan penyakit sirosis hati datang dengan gejala demam dan menggigil, yang telah berlangsung selama 2 hari. Pemeriksaan menunjukkan suhu tubuh 38,5 °C, denyut jantung 110 kali per menit, serta nyeri tekan di daerah perut. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan jumlah leukosit sebanyak 15.000 sel/mm ³ , dengan neutrofil 90% dan limfosit 10%. Pemeriksaan cairan dalam rongga peritoneal menunjukkan leukosit sebanyak 1.500 sel/mm ³ , dengan neutrofil 90%. Kultur bakteri dari cairan dalam rongga peritoneal positif untuk <i>E. coli</i> , sedangkan kultur bakteri dari darah negatif.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Peritonitis bakteri spontan	K65.00 <i>Acute peritonitis</i> ^(IM)
Diagnosis Sekunder	Sirosis Sindrom respons inflamasi sistemik karena <i>E.Coli</i>	K74.6 <i>Other and unspecified cirrhosis of liver</i> R65.0 <i>Systemic Inflammatory Response Syndrome of infectious origin without organ failure</i> B96.2 <i>Escherichia coli [E. coli] as the cause of diseases classified to other chapters</i>

Contoh 3-28	Pasien diabetes tipe 2 datang dengan gejala demam tinggi dan menggigil, yang telah berlangsung selama 3 hari. Pemeriksaan menunjukkan suhu tubuh 40 °C, frekuensi napas 28 kali per menit, denyut jantung 112 kali per menit, dan tekanan darah 100/70 mmHg. Pemeriksaan fisik terhadap berbagai sistem tubuh tidak menemukan kelainan. Pemeriksaan laboratorium menunjukkan jumlah leukosit sebanyak 20.500 sel/mm ³ , dengan neutrofil 90%. Hasil pemeriksaan lainnya normal. Kultur darah menunjukkan adanya <i>Staphylococcus aureus</i> .	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	<i>Staphylococcus aureus</i> <i>sepsis</i>	A41.0 <i>Sepsis a due to Staphylococcus aureus</i>
Diagnosis Sekunder	Diabetes mellitus tipe 2 tanpa komplikasi	E11.9 <i>type II non-insulin-dependent diabetes of the young</i>

Contoh 4-28	Pasien dengan β - <i>Thalasemia</i> yang pernah menjalani transplantasi sumsum tulang datang dengan gejala demam tinggi. Pemeriksaan menunjukkan suhu tubuh 39 °C, denyut jantung 110 kali per menit, dan frekuensi napas 24 kali per menit. Tidak ditemukan sumber infeksi yang jelas. Dokter mendiagnosis awal sebagai sepsis dan memberikan antibiotik intravena. Setelah beberapa waktu, demam berkurang, kondisi pasien membaik, dan dipulangkan ke rumah setelah 2 hari tanpa pemberian obat tambahan.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Demam yang tidak diketahui penyebabnya	R50.9 <i>Fever, unspecified</i>
Diagnosis Sekunder	β - <i>Thalassemia</i> <i>postplenektomi</i>	D56.1 <i>Beta thalassaemia</i> D73.0 <i>Hyposplenism</i>

Contoh 5-28	Pasien tuberkulosis paru yang pemeriksaan dahaknya positif terhadap bakteri telah menerima pengobatan anti tuberkulosis selama 1 bulan. Pasien datang dengan gejala demam dan menggigil selama 2 hari. Pemeriksaan menunjukkan suhu tubuh 39°C, denyut jantung 110 kali per menit, dan frekuensi napas 24 kali per menit. Pemeriksaan fisik tidak menemukan kelainan. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan jumlah leukosit sebanyak 15.000 sel/mm³, dengan neutrofil 85% dan limfosit 15%. Dokter mendiagnosis awal sebagai sepsis dan memberikan antibiotik intravena. Keesokan harinya, hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan adanya hepatitis akut, yang merupakan efek samping dari obat antituberkulosis.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Hepatitis yang menginduksi obat	A41.0 <i>Sepsis due to Staphylococcus aureus</i>
Diagnosis Sekunder	Tuberkulosis paru dikonfirmasi oleh dahak AFB Sindrom respons inflamasi sistemik	A15.0 <i>Tuberculosis of lung, confirmed by sputum microscopy with or without culture</i> R65.2 <i>Systemic Inflammatory Response Syndrome of non-infectious origin without organ failure</i>
Komplikasi	-	-
Penyebab Eksternal	Obat antituberkulosis	Y41.1 <i>Antimycobacterial drugs</i>

3.18.14 Congenital Syphilis (A50.-)

Gunakan kode dalam kelompok A50.- (*Congenital syphilis*), sesuai karakteristik sifilis kongenital. Pada sifilis kongenital lanjut, tambahkan kode organ yang terkena, misalnya:

- *Keratitis interstisial*, maka gunakan kode A50.3† (*Late congenital syphilitic oculopathy*) sebagai diagnosis utama dan tambahkan H19.2* (*Late congenital syphilitic interstitial keratitis*) sebagai diagnosis sekunder.
- *Arthritis*, maka gunakan kode A50.5† (*Other late congenital syphilis, symptomatic*) sebagai diagnosis utama dan tambahkan M03.1* (*Postinfective arthropathy in syphilis*) sebagai diagnosis sekunder.

3.18.15 *Syphilis* (A51-A53)

Tetapkan kode untuk penyakit *syphilis* dengan memperhatikan stadium spesifik yang telah didiagnosis oleh dokter, serta organ atau sistem tubuh yang terlibat dalam infeksi tersebut. Diagnosis ini harus didasarkan pada hasil pemeriksaan klinis yang mendetail, termasuk identifikasi gejala yang sesuai dengan setiap tahap perkembangan penyakit. Selain itu, analisis laboratorium untuk mendeteksi keberadaan *Treponema pallidum* sebagai penyebab infeksi juga diperlukan untuk memastikan diagnosis yang akurat.

3.18.16 *Gonococcal Infection* (A54.-)

Gunakan kode yang termasuk dalam kelompok A54.- (*Gonococcal Infection*) dengan memperhatikan organ atau area tubuh yang telah didiagnosis oleh dokter mengalami infeksi akibat bakteri *Neisseria gonorrhoeae*. Pastikan bahwa pemilihan kode ini didasarkan pada hasil pemeriksaan klinis yang mendalam, termasuk identifikasi lokasi spesifik infeksi. Selain itu, analisis laboratorium untuk mendeteksi keberadaan bakteri penyebab dan evaluasi riwayat medis pasien juga diperlukan guna memastikan diagnosis yang akurat.

3.18.17 *Chlamydia Infection* (A55-A56, A70-A74)

Apabila dokter mendiagnosis infeksi *Chlamydia* pada sistem reproduksi atau saluran kemih, gunakan kode dalam kelompok A56.- (*Other sexually transmitted chlamydial diseases*), sesuai organ yang terinfeksi.

Jika diagnosis mengarah pada *psittacosis* atau *parrot fever*, kode yang diberikan adalah A70 (*Chlamydia psittaci infection*). Diagnosis trachoma dikodekan dalam kelompok A71.- (*Trachoma*) berdasarkan stadium penyakit yang ditentukan dokter. Namun apabila diagnosis dokter hanya *chlamydial conjunctivitis*, gunakan kode A74.0† (*Chlamydial conjunctivitis*) dan H13.1* (*Conjunctivitis in infectious and parasitic diseases classified elsewhere*).

Untuk pneumonia akibat chlamydia atau *Pneumonia Chlamydia*, gunakan kode J16.0 (*Chlamydial pneumonia*). Sedangkan *Peritonitis*

Chlamydia, gunakan kode A74.8† (*Other chlamydial diseases*) dan K67.0* (*Chlamydial peritonitis*).

3.18.18 Anogenital Herpesviral [Herpes Simplex] Infection (A60.-)

- Infeksi herpes simpleks pada genital wanita, gunakan kode A60.0† (*Herpesviral infection of genitalia and urogenital tract*) dan gabungkan dengan kode N77.0* (*Ulceration of vulva in infectious and parasitic diseases classified elsewhere*) atau N77.1* (*Vaginitis, vulvitis and vulvovaginitis in infectious and parasitic diseases classified elsewhere*), sesuai karakteristik lesi.
- Infeksi herpes simpleks pada genital pria, gunakan kode A60.0† (*Herpesviral infection of genitalia and urogenital tract*) dan gabungkan dengan kode yang sesuai dalam kelompok N51.-* (*Disorders of male genital organs in diseases classified elsewhere*).

3.18.19 Anogenital [Venereal] Warts (A63.0)

Jika pasien sedang hamil, melahirkan, atau dalam masa nifas, gunakan kode O98.3 (*Other infections with a predominantly sexual mode of transmission complicating pregnancy, childbirth and the puerperium*) sebagai kode utama, dan kombinasikan dengan kode A63.0 (*Anogenital [venereal] warts*) sebagai kode tambahan.

3.18.20 Viral Meningitis (A87.-)

Jika dokter mendiagnosis *enteroviral meningitis*, *coxsackievirus meningitis*, atau *echovirus meningitis*, gunakan kode A87.0† (*Enteroviral meningitis*) dan gabungkan dengan kode G02.0* (*Meningitis in viral diseases classified elsewhere*).

3.18.21 Dengue Fever [Classical Dengue] (A90-A91)

Pada diagnosis demam berdarah dengue, pengode harus meminta klarifikasi dokter apakah terjadi syok atau tidak, untuk memberikan kode A91.0 (*Dengue haemorrhagic fever with shock^{IM}*) atau A91.1 (*Dengue haemorrhagic fever without shock^{IM}*).

3.18.22 *Measles (B05.-)*

Berikan kode yang termasuk dalam kelompok B05.- (*Campak/Measles*), dengan memperhatikan diagnosis spesifik yang telah ditetapkan oleh dokter berdasarkan hasil pemeriksaan klinis yang mendalam. Perhatikan kode *dagger* dan *asterisk* pada kondisi measles disertai dengan komplikasi. Misalnya jika dokter memberikan diagnosis measles disertai dengan pneumonia, gunakan kode B05.2† *Measles complicated by pneumonia* sebagai diagnosis utama dan J17.1* *Pneumonia in viral diseases classified elsewhere* sebagai diagnosis sekunder.

3.18.23 *Human Immunodeficiency Virus [Hiv] Disease (B20-B24)*

Berikut merupakan aturan penerapan kode untuk berbagai tahap penyakit HIV sesuai diagnosis dokter:

- Pasien dirawat untuk penyakit yang tidak terkait dengan HIV, seperti keracunan makanan, gunakan kode penyakit tersebut sebagai diagnosis utama dan kode penyakit HIV sebagai diagnosis tambahan.
- Kode R75 (*Laboratory evidence of human immunodeficiency virus [HIV]*) dan Z21 (*Asymptomatic human immunodeficiency virus [HIV] infection status*) tidak boleh digunakan sebagai diagnosis utama untuk pasien yang sudah didiagnosis dengan HIV.
- Dokter menyimpulkan bahwa penyakit utama yang dirawat adalah komplikasi dari HIV, gunakan kode dalam kelompok di bawah ini:
 - B20.- (*Human immunodeficiency virus [HIV] disease resulting in infectious and parasitic diseases*),
 - B21.- (*Human immunodeficiency virus [HIV] disease resulting in malignant neoplasms*),
 - B22.- (*Human immunodeficiency virus [HIV] disease resulting in other specified diseases*), atau
 - B23.- (*Human immunodeficiency virus [HIV] disease resulting in other conditions*) (kecuali B23.0) sebagai diagnosis utama.

Ketika komplikasi tersebut tidak memiliki kode spesifik dalam kelompok B20-B23, gunakan kode komplikasi tersebut sebagai diagnosis tambahan. Jika petugas pengode tidak yakin apakah

penyakit yang dicatat dokter sebagai diagnosis utama terkait dengan HIV, konsultasikan dengan dokter.

Catatan : Tidak boleh menggunakan lebih dari satu kode tahap HIV secara bersamaan

Contoh 6-28	Pasien HIV datang dengan gejala Tuberkulosis paru. Dokter memberikan diagnosis tuberkulosis paru disertai HIV.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Tuberculosis paru	B20.0 <i>HIV disease resulting in mycobacterial infection</i>
Diagnosis Sekunder	Penyakit HIV	-

Contoh 6-28	Pasien HIV datang dengan gejala pembesaran kelenjar getah bening secara umum. Diagnosis awal dokter adalah penyakit HIV dengan <i>limfadenopati</i> umum. Setelah dilakukan biopsi kelenjar getah bening, ditemukan bahwa kondisi tersebut adalah <i>limfadenopati tuberkulosis</i> .	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	<i>Limfadenopati tuberkulosis</i>	B20.0 <i>HIV disease resulting in mycobacterial infection</i>
Diagnosis Sekunder	Penyakit HIV	A18.2 <i>Tuberculous peripheral lymphadenopathy</i>

Contoh 7-28	Pasien HIV, dokter menerima pasien di rumah sakit untuk pengobatan <i>herpes zoster disseminata</i>	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	<i>Herpes zoster</i> yang disebarluaskan	B20.3 <i>HIV disease resulting in other viral infections</i>
Diagnosis Sekunder	Penyakit HIV	B02.7 <i>Disseminated zoster</i>

Dokter mendiagnosis bahwa pasien HIV sedang dirawat untuk beberapa komplikasi sekaligus, seperti infeksi dengan banyak jenis

patogen, maka gunakan kode B20.7 (*HIV disease resulting in multiple infections*) sebagai diagnosis utama, dan gunakan kode untuk setiap jenis infeksi sebagai diagnosis tambahan.

Contoh 8-28	Pasien HIV, dokter menerima pasien di rumah sakit untuk pengobatan pneumonia due to staphylococcus.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	<i>Pneumonia due to staphylococcus</i>	B20.7 <i>HIV disease resulting in multiple infections</i>
Diagnosis Sekunder	Penyakit HIV	J15.2 <i>Pneumonia due to staphylococcus</i>

Contoh 8-28	Pasien HIV, dokter menerima pasien di rumah sakit untuk pengobatan keracunan makanan, tanpa menentukan apakah disebabkan oleh toksin dari jenis bakteri tertentu.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Keracunan makanan	A05.9 <i>Bacterial foodborne intoxication, unspecified</i>
Diagnosis Sekunder	Penyakit HIV	B24 <i>Unspecified human immunodeficiency virus [HIV] disease</i>

Contoh 9-28	Pasien HIV, dokter menerima pasien di rumah sakit untuk pengobatan meningitis kriptokokus dan tuberkulosis paru (tes AFB positif)	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Meningitis kriptokokus	B20.7 <i>HIV disease resulting in multiple infections</i>
Diagnosis Sekunder	Penyakit HIV tuberkulosis paru	B45.1† <i>Cerebral cryptococcosis</i> G02.1* <i>Meningitis in mycoses</i> A15.0 <i>Tuberculosis of lung, confirmed by sputum microscopy with or without culture</i>

Contoh 10-28	Pasien HIV dengan jumlah CD4+ rendah, setelah menerima obat antivirus pasien mengalami <i>anemia aplastik</i> , sehingga dokter harus merawatnya di rumah sakit.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	<i>Anemia aplastik</i> yang diinduksi obat	D61.1 <i>Drug-induced aplastic anaemia</i>
Diagnosis Sekunder	Penyakit HIV	B24 <i>Unspecified human immunodeficiency virus [HIV] disease</i>
Komplikasi	-	-
Penyebab Eksternal	Efek samping anti-retrovirus	Y41.5 <i>Antiviral drugs</i>

- Bayi lahir dari ibu yang terinfeksi HIV, apabila tidak ada kelainan maka gunakan kode dalam kelompok Z38.- (*Liveborn fetus according to place of birth*) sebagai diagnosis utama, dan gunakan kode Z20.6 (*Contact with and exposure to human immunodeficiency virus [HIV]*) sebagai diagnosis tambahan.
- Bayi lahir dari ibu yang terinfeksi HIV dengan adanya kelainan maka gunakan kode kelainan tersebut sebagai diagnosis utama, serta gunakan kode P00.2 (*Fetus and newborn affected by maternal infectious and parasitic disease*), Z20.6 (*Contact with and exposure to human immunodeficiency virus [HIV]*), dan kode dalam kelompok Z38.- (*Liveborn fetus according to place of birth*) sebagai diagnosis tambahan.
- Diagnosis sindrom rekonstitusi kekebalan (*immune reconstitution syndrome*), maka gunakan kode D89.3 (*Immune reconstitution syndrome*) sebagai diagnosis utama, dan gunakan kode penyakit HIV sebagai diagnosis tambahan.
- Penanganan efek samping yang disebabkan oleh obat antivirus untuk pengobatan HIV, maka gunakan kode efek samping tersebut sebagai diagnosis utama, gunakan kode penyakit HIV sebagai diagnosis tambahan, dan gunakan kode penyebab eksternal sesuai jenis obat tersebut.
- Wanita hamil, melahirkan, atau dalam masa nifas yang didiagnosis oleh dokter sebagai penyakit HIV, maka gunakan kode O98.7 (*Human*

immunodeficiency virus [HIV] diseases complicating pregnancy, childbirth and the puerperium).

3.18.24 Cytomegaloviral Disease : B25.-

- Infeksi *cytomegalovirus* pada pasien HIV, maka gunakan kode B20.2 (*HIV disease resulting in cytomegaloviral disease*) sebagai diagnosis utama, dan gunakan kode dalam kelompok B25.- sebagai diagnosis tambahan.

Contoh 11-28	Pasien HIV, dokter menerima pasien di rumah sakit untuk pengobatan <i>cytomegaloviral chorioretinitis</i>	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	<i>Korioretinitis sitomegaloviral</i>	B20.2 <i>HIV disease resulting in cytomegaloviral disease</i>
Diagnosis Sekunder	Penyakit HIV	B25.8† <i>Other cytomegaloviral diseases</i> H32.0* <i>Chorioretinal inflammation in infectious and parasitic diseases classified elsewhere</i>

3.18.25 Aspergillosis (B44.-)

Gunakan kode dalam kelompok B44.- (*Aspergillosis*), sesuai diagnosis dokter.

- *Aspergillosis pulmonal* akut, subakut, atau invasif, gunakan kode B44.0 (*Invasive pulmonary aspergillosis*).
- *Aspergillosis pulmonal kronis, aspergilloma, atau aspergillosis bronkopulmoner alergik*, gunakan kode B44.1 (*Other pulmonary aspergillosis*).

3.18.26 Malaria (B50-B54)

Gunakan kode dalam kelompok B50-B53, sesuai jenis *Plasmodium* dan komplikasi yang didiagnosis oleh dokter. Hindari menggunakan kode B54 (*Unspecified malaria*) karena diagnosis spesies dapat dilakukan melalui pemeriksaan apusan darah.

3.18.27 *Toxoplasmosis* (B58.-)

Gunakan kode dalam kelompok B58.- (*Toxoplasmosis*), sesuai organ yang didiagnosis dokter memiliki lesi.

Contoh 12-28	Pasien HIV dirawat di rumah sakit untuk pengobatan <i>Toxoplasma meningoencephalitis</i>	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	<i>Meningoensefalitis toksoplasma</i>	B20.8 <i>HIV disease resulting in other infectious and parasitic diseases</i>
Diagnosis Sekunder	Penyakit HIV	B58.2† <i>Toxoplasma meningoencephalitis</i> G05.0* <i>Encephalitis, myelitis and encephalomyelitis in bacterial diseases classified elsewhere</i>

3.19 MDC 29 PENYAKIT DAN GANGGUAN MENTAL

PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 29

- Kombinasi kode *dagger* dan *asterisk* G30.-† (*Alzheimer's disease*) dan F00* (*Dementia in Alzheimer's disease*) mengklasifikasikan *Demensia Alzheimer*. Istilah penyakit *Alzheimer* dan *demensia Alzheimer* sering digunakan secara bergantian. Namun, mungkin bagi pasien dapat didiagnosis penyakit *Alzheimer* sebelum menunjukkan gejala klinis demensia. Oleh karena itu, ketika penyakit *Alzheimer* didokumentasikan dalam catatan medis tanpa menyebutkan demensia, konsultan yang bertanggung jawab harus dikonsultasikan untuk mengonfirmasi keberadaan demensia sebelum penugasan kombinasi *dagger* dan *asterisk* G30.-† (*Alzheimer's disease*) dan F00* (*Dementia in Alzheimer's disease*).

Contoh: *Dementia in early onset Alzheimer disease*

G30.0† (*Alzheimer disease with early onset*)

F00.0* (*Dementia in Alzheimer disease with early onset*)

- Setiap kali diagnosis terdokumentasi dari 'delirium' atau 'keadaan kebingungan akut' dibuat dalam catatan medis pasien, ini harus dikodekan menggunakan kode ICD-10 yang sesuai. Jika penyebab delirium atau keadaan kebingungan akut diketahui, ini juga harus dikodekan menggunakan kode ICD-10 yang sesuai. Diagnosis terdokumentasi dari 'delirium' bersama dengan ko-morbiditas/diagnosis terdokumentasi dari 'demensia' harus dikodekan menggunakan kode F05.1 (*Delirium superimposed on dementia*).

Contoh: Pasien lanjut usia dengan infeksi saluran kemih dan keadaan kebingungan akut. Infeksi saluran kemih diobati dengan antibiotik.

N39.0 (*Urinary tract infection, site not specified*)

F05.9 (*Delirium, unspecified*)

- Dalam MDC 29 terdapat DRG khusus untuk pemberian tindakan *Electroconvulsive Therapy* (ECT), sehingga koder harus memperhatikan dokumentasi medis dan bukti tata laksana pemberian ECT.
 - Ketika terdapat diagnosis yang masuk ke dalam MDC 29 dan disertai dengan tindakan ECT dengan kode 94.27, 94.270, dan 94.271, maka akan masuk ke dalam DRG dengan deskripsi *w/ECT*, misalkan:

○ *Schizophrenia and Schizoaffective Disorders w/ ECT - Chronic*

- *Schizophrenia and Schizoaffective Disorders w/ ECT - Sub Acute*

PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 29

3.19.1 *Dementia in Alzheimer's Disease (F00-F03)*

Gunakan kode dalam grup F00 – F03 sesuai diagnosis dokter berdasarkan evaluasi klinis dan temuan tambahan.

Contoh 1-29	Tiga bulan lalu, pasien wanita usia 70 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan kehilangan memori, sering lupa, kesalahan dalam berpikir dan perhitungan, serta sulit berkonsentrasi pada masalah sederhana. Pemeriksaan CT scan menunjukkan <i>multiple areas of infarction</i> di korteks serebral kedua belah pihak. Dokter mendiagnosis <i>multi-infarct dementia</i> . Sehari sebelum masuk rumah sakit, pasien mengalami kelemahan pada lengan dan kaki sebelah kiri, <i>facial weakness upper motor neuron</i> , dan <i>aphasia</i>	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	<i>Stroke iskemik (arteri serebral tengah)</i>	I63.3 <i>Infark serebral karena trombosis serebral arteri</i>
Diagnosis Sekunder	<i>Dementia multi-infarct</i>	F01.1 <i>Dementia multi-infarct</i>

Contoh 2-29	Pasien wanita usia 65 tahun telah didiagnosis dengan <i>multi-infarct dementia</i> selama satu tahun. Dua minggu lalu, pasien dibawa ke rumah sakit karena timbul gejala paranoid, yaitu keyakinan bahwa orang lain menyamar sebagai anak perempuannya. Dokter memutuskan untuk merawat inap pasien untuk mengontrol gejala tersebut.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis primer	<i>Dementia multi-infarct</i>	F01.1 <i>Dementia multi-infarct</i>
Diagnosis sekunder	-	-

3.19.2 *Delirium, Not Induced by Alcohol and Other Psychoactive Substances (F05)*

Gunakan kode dalam grup F05.- (*Delirium, not induced by alcohol and other psychoactive substances*), sesuai diagnosis dokter.

Contoh 3-29	Pasien wanita usia 75 tahun dirawat di rumah sakit karena demam dan nyeri punggung. Pemeriksaan fisik menunjukkan suhu tubuh 39°C dengan nyeri tekan di area pinggang kanan. Hasil pemeriksaan urin menunjukkan adanya 10 sel darah putih <i>per high power field</i> . Dokter mendiagnosis <i>acute pyelonephritis</i> dan memberikan pengobatan antibiotik. Pasien memiliki riwayat diagnosis <i>Alzheimer's disease</i> sejak usia 70 tahun, disertai gejala demensia. Setelah dirawat selama dua hari, pasien mengalami kebingungan, insomnia, halusinasi visual, dan tidak responsif terhadap lingkungan sekitarnya. Dokter mendiagnosis <i>delirium</i>	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	<i>Pielonefritis akut</i>	N10 <i>Nefritis tubulointerstitial akut</i>
Diagnosis Sekunder	Penyakit <i>Alzheimer onset</i> terlambat <i>Dementia</i>	G30.1† <i>Alzheimer's disease with late onset</i> F00.1* <i>Dementia in Alzheimer's disease with late onset</i>
Komplikasi	<i>Delirium</i>	F05.1 <i>Delirium superimposed on dementia</i>

3.19.3 *Other Mental Disorders due to Brain Damage and Dysfunction and to Physical Disease (F06.-)*

Gunakan kode dalam grup F06.- (*Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease*), sesuai diagnosis dokter. Tambahkan kode untuk penyakit otak atau penyakit sistemik yang menjadi penyebabnya.

Contoh 4-29	Pasien wanita usia 25 tahun telah didiagnosis menderita <i>systemic lupus erythematosus</i> (SLE) selama dua tahun. Saat ini, pasien datang dengan keluhan halusinasi visual dan suara (<i>auditory hallucinations</i>).	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	<i>Neuropsikiatri lupus eritematosus</i>	M32.1 <i>Systemic lupus erythematosus with organ or system involvement</i>
Diagnosis Sekunder	<i>Hallucinosi organik</i>	F06.0 <i>Organic hallucinosis</i>

3.19.4 *Mental and Behavioural Disorders due to Psychoactive Substance Use* (F10-F19)

Gunakan kode dalam grup F10-F19 (*Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use*), sesuai diagnosis dokter dan jenis zat yang menjadi penyebab.

Contoh 5-29	Pasien pria usia 36 tahun memiliki kebiasaan minum alkohol satu botol sehari selama 10 tahun. Tiga hari lalu, pasien mulai meningkatkan konsumsi alkohol lebih dari biasanya dan mengeluhkan nyeri perut selama satu hari. Dokter mendiagnosis <i>acute alcoholic pancreatitis</i> dan merawat pasien di rumah sakit. Setelah dua hari dirawat, pasien mengalami agitasi, gelisah, dan delirium.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	<i>Pankreatitis alkoholik akut</i>	K85.2 <i>Alcohol-induced acute pancreatitis</i>
Diagnosis Sekunder	<i>Alkoholisme</i>	F10.1 <i>Mental and behavioural disorders due to use of alcohol (Harmful Use)</i>
Komplikasi	<i>Delirium tremens</i>	F10.4 <i>Mental and behavioural disorders due to use of alcohol (Withdrawal state with delirium)</i>

Contoh 6-29	Pasien pria usia 45 tahun memiliki keluhan sesak napas selama dua tahun. Dokter mendiagnosis <i>chronic obstructive pulmonary disease</i> (COPD) dan merawat pasien di rumah sakit karena eksaserbasi akut. Pasien memiliki riwayat merokok satu bungkus per hari selama 10 tahun.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Penyakit paru obstruktif kronis dengan akut eksaserbasi	J44.1 <i>Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified</i>
Diagnosis Sekunder	Penyalahgunaan tembakau	F17.1 <i>Mental and behavioural disorders due to use of tobacco (Harmful Use)</i>

Contoh 7-29	Pasien wanita usia 35 tahun dirawat di rumah sakit karena demam, batuk, dan sesak napas. Pemeriksaan radiologi dada menunjukkan <i>pulmonary infiltration right lower lobe</i> , dan hasil kultur dahak menunjukkan adanya <i>Streptococcus pneumoniae</i> . Dokter mendiagnosis lobar pneumonia. Pasien memiliki riwayat minum alkohol berat hingga satu botol sehari. Selama dirawat di rumah sakit, pasien menunjukkan tanda-tanda gelisah, mudah
--------------------	--

	tersinggung, dan telah mencoba beberapa kali untuk berhenti minum tetapi tidak berhasil. Dokter mendiagnosis <i>alcoholism</i> .	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis primer	<i>Pneumonia lobar karena pneumonia Streptokokus</i>	J13 <i>Pneumoniae due to Streptococcal pneumoniae</i>
Diagnosis sekunder	Alkoholisme	F10.1 <i>Mental and behavioural disorders due to use of alcohol (Harmful Use)</i>

3.19.5 Skizofrenia (F20.-)

Gunakan kode dalam grup F20.- (*Schizophrenia*) sesuai jenis yang didiagnosis oleh dokter. Kode harus selalu lima digit, dengan digit kelima menunjukkan pola perkembangan penyakit.

3.19.6 Somatoform Disorders (F45.-)

Penetapan kode dalam kelompok F45.- (*Somatoform disorders*) dilakukan berdasarkan diagnosis yang ditegakkan oleh dokter. Kode ini digunakan untuk mengklasifikasikan gangguan yang melibatkan keluhan somatik persisten atau berulang, seperti nyeri kronis, gangguan gastrointestinal fungsional, atau kelelahan yang tidak terkait dengan kondisi medis yang jelas, dan harus ditentukan berdasarkan evaluasi menyeluruh serta kesimpulan profesional dari tenaga medis yang berwenang.

3.19.7 Neurasthenia (F48.0)

Penetapan kode dalam kelompok F48.0 (*Neurasthenia*) dilakukan berdasarkan diagnosis yang ditegakkan dokter. Kode ini digunakan untuk mengklasifikasikan kondisi yang sering dikaitkan dengan stres psikologis atau beban emosional yang berkepanjangan, dan diagnosis akhir harus didasarkan pada evaluasi menyeluruh oleh tenaga medis profesional, termasuk pemeriksaan riwayat medis pasien, hasil observasi klinis, serta penghapusan kemungkinan penyebab organik atau gangguan medis lainnya yang serupa.

3.19.8 Sindrom Depersonalisasi-Derealitas (F48.1)

Kode dalam kelompok F48.1 (*Sindrom Depersonalisasi-Derealitas*) dapat diberikan sesuai diagnosis yang diberikan oleh dokter. Kode ini digunakan untuk menggambarkan kondisi yang biasanya muncul sebagai respons terhadap stres psikologis berat, trauma emosional, atau kecemasan yang intens, namun tetap mempertahankan realitas kesadaran individu secara umum. Diagnosis akhir harus didasarkan pada evaluasi mendalam oleh tenaga medis profesional, termasuk analisis riwayat medis, pemeriksaan psikologis, serta penyingkiran kemungkinan penyebab organik lainnya seperti cedera otak, efek samping obat-obatan, atau gangguan *neuropsikiatri* lainnya.

3.19.9 Eating Disorders (F50.-)

Kode dalam kelompok F50.- (*Eating disorders*) dapat diberikan sesuai diagnosis yang diberikan oleh dokter. Kode ini mencakup berbagai kondisi terkait pola makan abnormal dan persepsi terhadap berat badan atau bentuk tubuh yang menyebabkan gangguan fisik maupun psikologis signifikan, seperti anoreksia nervosa, bulimia nervosa, atau gangguan makan tidak terklasifikasi lainnya.

Kode dalam kelompok ini dapat digunakan sebagai kode diagnosis utama, kecuali untuk kondisi tertentu seperti F50.5 (*Vomiting associated with other psychological disturbances*) yaitu muntah yang diakibatkan gangguan psikologis lain, yang hanya dapat digunakan sebagai kode diagnosis tambahan karena muntah tersebut bukan merupakan gangguan makan primer melainkan manifestasi dari gangguan psikologis lain yang mendasarinya. Kode diagnosis utama harus diberikan berdasarkan kondisi yang lebih spesifik, seperti F44.- (*Dissociative [conversion] disorders*) jika gejala muncul sebagai bagian dari disosiasi psikologis, F45.2 (*Hypochondriacal disorder*) jika terkait dengan kekhawatiran berlebihan terhadap kesehatan fisik, atau O21.- (*Excessive vomiting in pregnancy*) jika gejala tersebut terjadi selama masa kehamilan dan terkait dengan perubahan hormonal atau faktor fisiologis lainnya.

3.19.10 *Nonorganic Sleep Disorders (F51.-)*

Kode dalam kelompok F51.- (*Nonorganic sleep disorders*) dapat diberikan sesuai diagnosis yang diberikan oleh dokter. Jika dokter mendiagnosis "insomnia" tanpa rincian tambahan, berikan kode G47.0 (*Disorders of initiating and maintaining sleep [insomnias]*).

- Insomnia yang disebabkan oleh gangguan mental, dan gejala insomnia merupakan gejala utama yang memerlukan penanganan lebih intensif, maka kode diagnosis utama harus mencerminkan gangguan mental yang mendasarinya (misalnya, F32.- untuk depresi, F41.- untuk kecemasan) sebagai kode diagnosis utama, sementara F51.0 (*Nonorganic insomnia*) diberikan sebagai kode diagnosis tambahan untuk menunjukkan bahwa insomnia tersebut merupakan manifestasi utama dari gangguan mental tersebut.
- Insomnia yang disebabkan oleh penyakit fisik, dan gejala insomnia merupakan gejala utama yang memerlukan penanganan lebih intensif, maka kode diagnosis utama harus mencerminkan penyakit fisik yang mendasarinya (misalnya, E11.- untuk diabetes, I10.- untuk hipertensi) sebagai kode diagnosis utama, sedangkan G47.0 (*Disorders of initiating and maintaining sleep [insomnias]*) diberikan sebagai kode diagnosis tambahan untuk menunjukkan bahwa insomnia tersebut merupakan komplikasi atau gejala sekunder dari kondisi medis tersebut.

3.19.11 *Sexual Dysfunction, not caused by Organic Disorder or Disease (F52.-)*

Kode dalam kelompok F52.- (*Sexual dysfunction, not caused by organic disorder or disease*) dapat diberikan sesuai diagnosis yang diberikan oleh dokter. Kode ini digunakan untuk mengklasifikasikan masalah seperti kurangnya hasrat seksual (hipoaktif), kesulitan mencapai orgasme, disfungsi ereksi yang bersifat psikogenik, atau nyeri saat berhubungan seksual (dispareunia) yang tidak dapat dijelaskan oleh penyebab fisik langsung. Diagnosis akhir harus ditentukan berdasarkan evaluasi menyeluruh oleh tenaga medis profesional, termasuk wawancara mendalam dengan pasien, pemeriksaan psikologis, serta penghapusan

kemungkinan penyebab organik melalui pemeriksaan fisik atau tes laboratorium jika diperlukan.

3.19.12 *Mental and Behavioural Disorders Associated with The Puerperium, Not Elsewhere Classified (F53.-)*

Kode dalam kelompok F53.- (*Mental and behavioural disorders associated with the puerperium, not elsewhere classified*) dapat diberikan sesuai diagnosis yang diberikan oleh dokter. Kode ini digunakan untuk menggambarkan gangguan seperti depresi pasca persalinan, kecemasan berlebihan, psikosis pascapersalinan, atau gangguan adaptasi yang berkaitan dengan stres perinatal, yang muncul sebagai respons terhadap perubahan fisik, hormonal, emosional, dan sosial yang signifikan selama periode pasca melahirkan. Diagnosis akhir harus didasarkan pada evaluasi menyeluruh oleh tenaga medis profesional, termasuk wawancara klinis mendalam dengan pasien, observasi perilaku, riwayat medis serta psikososial, dan penyingkiran kemungkinan penyebab organik atau kondisi medis lain yang dapat menimbulkan gejala serupa.

3.19.13 *Abuse of Non-Dependence-Producing Substance (F55.-)*

Kode dalam kelompok F55.- (*Abuse of non-dependence-producing substances*) dapat diberikan sesuai jenis zat yang diidentifikasi oleh dokter. Kode ini digunakan untuk mengklasifikasikan kasus-kasus di mana individu secara sengaja atau tidak sengaja mengonsumsi zat-zat tersebut dalam dosis atau cara yang tidak direkomendasikan oleh tenaga medis profesional, seperti penggunaan obat pencahar secara berlebihan, konsumsi suplemen dalam jumlah berlebih, atau penyalahgunaan obat penghilang rasa sakit tanpa indikasi medis yang jelas. Pemberian kode spesifik dalam kategori F55.- harus mempertimbangkan jenis zat utama yang disalahgunakan, pola penggunaannya, dampaknya terhadap kesehatan fisik dan mental pasien, serta konteks psikososial yang mungkin memengaruhi perilaku tersebut.

3.19.14 *Specific Personality Disorders (F60.0)*

Kode dalam kelompok F60.0 (*Specific personality disorders*) dapat diberikan apabila diagnosis yang diberikan oleh dokter adalah:

copyright@ Pusat pembiayaan kesehatan Kemenkes RI.

Dilarang mengcopy atau memperjualbelikan isi dan dokumen ini dalam bentuk apapun

- *Paranoid personality*,
- *Expansive paranoid personality* (cenderung menunjukkan superioritas diri dan rasa percaya diri yang berlebihan),
- *Fanatic personality* (keterikatan kuat pada keyakinan atau ideologi tertentu hingga menjadi obsesif),
- *Querulant personality* (kecenderungan untuk mengeluh, menyalahkan, atau bersikap litigius), atau
- *Sensitive paranoid personality* (hipersensitivitas terhadap kritik atau penolakan).

Diagnosis akhir harus didasarkan pada evaluasi menyeluruh oleh tenaga medis profesional, termasuk wawancara psikiatrik mendalam, analisis riwayat psikologis dan sosial pasien, serta observasi perilaku dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari.

3.19.15 *Schizoid Personality Disorder (F60.1)*

Kode dalam kelompok F60.1 (*Schizoid personality disorder*) dapat diberikan sesuai diagnosis yang diberikan oleh dokter. Kode ini digunakan untuk pasien yang memiliki gangguan kepribadian yang ditandai dengan pola umum ketidakpedulian terhadap hubungan sosial dan interaksi interpersonal yang minim, serta preferensi kuat untuk aktivitas soliter dan dunia fantasi internal dibandingkan dengan kehidupan sosial eksternal. Diagnosis akhir harus didasarkan pada evaluasi menyeluruh oleh tenaga medis profesional, termasuk wawancara psikiatrik mendalam, analisis riwayat perkembangan individu, observasi perilaku dalam berbagai konteks, serta penilaian apakah pola perilaku ini sudah ada sejak masa dewasa awal dan stabil sepanjang waktu.

3.19.16 *Dissocial Personality Disorder (F60.2)*

Kode dalam kelompok F60.2 (*Dissocial personality disorder*) dapat diberikan apabila diagnosis yang diberikan oleh dokter adalah *Dissocial personality disorder*, *Amoral personality*, *Anti-social personality*, *Asocial personality*, *Psychopathic personality*, *Sociopathic personality*. Kode ini digunakan untuk pasien yang memiliki gangguan kepribadian yang ditandai dengan pola umum pengabaian terhadap

norma-norma sosial, hak orang lain, dan perasaan atau kebutuhan individu lainnya. Individu dengan gangguan ini sering kali menunjukkan perilaku impulsif, agresif, atau manipulatif, cenderung melakukan tindakan melawan hukum tanpa rasa bersalah atau penyesalan (*remorse*), serta memiliki kesulitan dalam mempertahankan hubungan interpersonal yang sehat dan bermakna. Diagnosis akhir harus didasarkan pada evaluasi menyeluruh oleh tenaga medis profesional, termasuk wawancara psikiatrik mendalam, analisis riwayat perilaku antisosial sejak usia dini, pemeriksaan catatan hukum jika ada, serta observasi terhadap pola interaksi sosial dan emosional individu dalam berbagai konteks.

3.19.17 *Emotionally Unstable Personality Disorder (F60.3)*

Kode dalam kelompok F60.30 (*Emotionally unstable personality disorder, Impulsive type*) ^(IM) dapat diberikan sesuai diagnosis yang diberikan oleh dokter. Kode ini digunakan untuk pasien yang memiliki ketidakstabilan emosi yang ditandai dengan impulsivitas tinggi, kesulitan mengendalikan dorongan atau perilaku spontan, serta kecenderungan untuk bertindak tanpa mempertimbangkan konsekuensi, sering kali terlihat dalam bentuk ledakan emosi intens, perilaku berisiko, atau hubungan interpersonal yang tidak stabil.

Kode dalam kelompok F60.31 (*Emotionally unstable personality disorder, Borderline type*) ^(IM), dapat diberikan sesuai diagnosis yang diberikan oleh dokter. Kode ini digunakan untuk pasien yang memiliki gejala yang lebih kompleks, termasuk ketidakstabilan gambaran diri, perasaan kosong yang persisten, ketakutan berlebihan terhadap penolakan atau ditinggalkan, serta kemungkinan adanya perilaku menyakiti diri sendiri atau upaya bunuh diri sebagai respons terhadap stres emosional yang luar biasa. Diagnosis akhir untuk kedua tipe ini harus didasarkan pada evaluasi menyeluruh oleh tenaga medis profesional, termasuk wawancara psikiatrik mendalam, analisis riwayat psikologis dan sosial individu, observasi perilaku jangka panjang, serta penilaian apakah pola perilaku ini sudah ada sejak masa dewasa awal dan stabil sepanjang waktu.

3.19.18 *Histrionic Personality Disorder* (F60.4)

Kode dalam kelompok F60.4 (*Histrionic personality disorder*) dapat diberikan apabila diagnosis yang diberikan oleh dokter adalah *Histrionic personality disorder, Hysterical personality, Psychoinfantile personality*. Kode ini digunakan untuk pasien yang memiliki gangguan kepribadian yang ditandai dengan pola umum emosi yang berlebihan (emosi dramatis, teatrikal, atau provokatif) serta perhatian yang berlebihan terhadap penampilan fisik dan pengakuan dari orang lain sebagai cara untuk mendapatkan validasi diri. Diagnosis akhir harus didasarkan pada evaluasi menyeluruh oleh tenaga medis profesional, termasuk wawancara psikiatrik mendalam, analisis riwayat psikologis dan sosial individu, observasi terhadap pola interaksi sosial dan ekspresi emosional, serta penilaian apakah perilaku ini sudah ada sejak masa dewasa awal dan stabil sepanjang waktu.

3.19.19 *Anankastic Personality Disorder* (F60.5)

Kode dalam kelompok F60.5 (*Anankastic personality disorder*) dapat diberikan apabila diagnosis yang diberikan oleh dokter adalah *Anankastic personality disorder, Compulsive personality, Obsessional personality, Obsessive-compulsive personality*. Kode ini digunakan untuk pasien yang memiliki gangguan kepribadian yang ditandai dengan pola umum perfeksionisme yang kaku, kehati-hatian berlebihan, kebutuhan mendesak untuk kontrol terhadap diri sendiri dan orang lain, serta fokus yang berlebihan pada detail, aturan, atau jadwal hingga mengabaikan tujuan utama aktivitas.

Jika diagnosis adalah *Obsessive-Compulsive Disorder* (OCD), yaitu kondisi yang ditandai dengan adanya obsesi (pikiran intrusif yang berulang) dan kompulsi (perilaku berulang sebagai respons terhadap obsesi), maka gunakan kode F42.-. Diagnosis akhir harus didasarkan pada evaluasi menyeluruh oleh tenaga medis profesional, termasuk wawancara psikiatrik mendalam, analisis riwayat perkembangan individu, observasi perilaku dalam berbagai konteks, serta penilaian apakah pola kepribadian ini sudah ada sejak masa dewasa awal dan stabil sepanjang waktu.

3.19.20 *Anxious [Avoidant] Personality Disorder (Avoidant) (F60.6)*

Kode dalam kelompok F60.6 (*Anxious [Avoidant] Personality Disorder*) dapat diberikan sesuai diagnosis yang diberikan oleh dokter. Kode ini digunakan untuk pasien yang memiliki gangguan kepribadian yang ditandai dengan pola umum penghindaran terhadap aktivitas sosial, pekerjaan, atau situasi lain yang melibatkan interaksi dengan orang lain, karena perasaan tidak memadai, takut akan kritik, penolakan, atau rasa malu. Diagnosis akhir harus didasarkan pada evaluasi menyeluruh oleh tenaga medis profesional, termasuk wawancara psikiatrik mendalam, analisis riwayat perkembangan individu, observasi perilaku dalam berbagai konteks sosial, serta penilaian apakah pola kepribadian ini sudah ada sejak masa dewasa awal dan stabil sepanjang waktu.

3.19.21 *Dependent Personality Disorder (F60.7)*

Kode dalam kelompok F60.7 (*Dependent personality disorder*) dapat diberikan apabila diagnosis yang diberikan oleh dokter adalah *Dependent personality disorder, Asthenic personality, Inadequate personality, Passive personality, Self-defeating personality*. Kode ini digunakan untuk pasien yang memiliki gangguan kepribadian yang ditandai dengan pola umum ketergantungan yang berlebihan dan kebutuhan mendesak untuk diperhatikan atau didukung oleh orang lain dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Diagnosis akhir harus didasarkan pada evaluasi menyeluruh oleh tenaga medis profesional, termasuk wawancara psikiatrik mendalam, analisis riwayat perkembangan individu, observasi perilaku dalam berbagai konteks sosial, serta penilaian apakah pola kepribadian ini sudah ada sejak masa dewasa awal dan stabil sepanjang waktu.

3.19.22 *Other Specific Personality Disorders (F60.8)*

Kode dalam kelompok F60.8 (*Other specific personality disorders*) dapat diberikan apabila diagnosis yang diberikan oleh dokter adalah gangguan kepribadian narsistik. Kode ini digunakan untuk pasien yang memiliki gangguan kepribadian yang tidak termasuk dalam kategori-kategori sebelumnya tetapi memiliki karakteristik unik dan

spesifik, seperti pola umum grandiositas (rasa superioritas atau kehebatan diri), kebutuhan berlebihan akan pujian atau pengakuan, serta kurangnya empati terhadap perasaan atau kebutuhan orang lain. Diagnosis akhir harus didasarkan pada evaluasi menyeluruh oleh tenaga medis profesional, termasuk wawancara psikiatrik mendalam, analisis riwayat perkembangan individu, observasi perilaku dalam berbagai konteks sosial, serta penilaian apakah pola kepribadian ini sudah ada sejak masa dewasa awal dan stabil sepanjang waktu.

3.19.23 *Enduring Personality Changes, Not Attributable to Brain Damage and Disease (F62.-)*

Kode dalam kelompok F62.- (*Enduring personality changes, not attributable to brain damage and disease*) dapat diberikan sesuai diagnosis yang diberikan oleh dokter. Kode ini digunakan untuk pasien yang memiliki perubahan signifikan dan menetap dalam pola kepribadian individu yang tidak dapat dijelaskan oleh kerusakan otak, penyakit neurologis, atau kondisi medis organik lainnya. Perubahan ini dapat melibatkan aspek-aspek seperti sikap, perilaku, emosi, atau cara individu berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, dan biasanya terjadi sebagai akibat dari pengalaman traumatis berat, stress kronis, atau peristiwa kehidupan yang mendalam seperti kehilangan orang terdekat, konflik interpersonal berkepanjangan, atau perubahan drastis dalam kehidupan seseorang. Diagnosis akhir harus didasarkan pada evaluasi menyeluruh oleh tenaga medis profesional, termasuk wawancara psikiatrik mendalam, analisis riwayat psikologis dan sosial individu, observasi perilaku jangka panjang, serta penyingkiran kemungkinan penyebab organik atau gangguan medis lain yang dapat menimbulkan gejala serupa.

3.19.24 *Habit and Impulse Disorders (F63.-)*

Kode dalam kelompok F63.- (*Habit and impulse disorders*) dapat diberikan sesuai diagnosis yang diberikan oleh dokter. Kode ini digunakan untuk pasien yang memiliki pola perilaku berulang yang tidak terkendali atau impulsif, sering kali merugikan diri sendiri atau orang

lain, tanpa didasari oleh gangguan mental utama seperti psikosis atau gangguan suasana hati. Kondisi ini meliputi perilaku seperti perjudian patologis (*compulsive gambling*), kleptomania (dorongan untuk mencuri), piromania (dorongan untuk membakar sesuatu), trichotillomania (kebiasaan mencabut rambut), atau kebiasaan destruktif lainnya yang sulit dikontrol meskipun individu menyadari konsekuensinya. Diagnosis akhir harus didasarkan pada evaluasi menyeluruh oleh tenaga medis profesional, termasuk wawancara psikiatrik mendalam, analisis riwayat perilaku, observasi pola kebiasaan atau dorongan impulsif dalam konteks kehidupan sehari-hari, serta penilaian dampaknya terhadap fungsi sosial, pekerjaan, dan kualitas hidup individu secara keseluruhan.

3.19.25 *Gender Identity Disorders (F64.-)*

Kode dalam kelompok F64.- (*Gender identity disorders*) dapat diberikan sesuai diagnosis yang diberikan oleh dokter. Kode ini digunakan untuk pasien yang mengalami ketidaksesuaian yang signifikan dan menetap antara identitas gender yang mereka rasakan secara internal dan jenis kelamin yang ditetapkan pada mereka saat lahir (*assigned sex at birth*). Ketidaksesuaian ini sering kali menyebabkan penderitaan psikologis yang mendalam, kesulitan dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau aspek kehidupan lainnya, serta dorongan kuat untuk hidup sesuai dengan identitas gender yang mereka identifikasi. Diagnosis akhir harus didasarkan pada evaluasi menyeluruh oleh tenaga medis profesional, termasuk wawancara psikiatrik mendalam, analisis riwayat perkembangan gender sejak usia dini, observasi pola perilaku dan ekspresi gender, serta penilaian dampak ketidaksesuaian ini terhadap kesejahteraan mental, fisik, dan sosial individu.

3.19.26 *Disorders of Sexual Preference (F65.-)*

Kode dalam kelompok F65.- (*Disorders of sexual preference*) dapat diberikan sesuai diagnosis yang diberikan oleh dokter. Kode ini digunakan untuk pasien yang menunjukkan pola preferensi seksual yang menyimpang dari norma-norma sosial dan budaya yang diterima secara

umum, serta dapat menyebabkan penderitaan psikologis atau gangguan dalam fungsi interpersonal, sosial, atau aspek kehidupan lainnya. Diagnosis akhir harus didasarkan pada evaluasi menyeluruh oleh tenaga medis profesional, termasuk wawancara psikiatrik mendalam, analisis riwayat perilaku seksual, observasi dampak perilaku tersebut terhadap kehidupan sehari-hari, serta penilaian apakah preferensi tersebut menyebabkan distress signifikan atau risiko bahaya bagi individu atau orang lain.

3.19.27 Retardasi Mental (F70-F79)

Kode dalam kelompok F70 – F79, dapat diberikan sesuai dengan tingkat keparahan retardasi mental yang didiagnosis. Kode ini digunakan untuk pasien yang mengalami keterbatasan signifikan dalam fungsi intelektual dan perilaku adaptif, yang biasanya terjadi sebelum usia 18 tahun. Tingkat keparahan retardasi mental dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan skor IQ dan kemampuan adaptif seseorang, seperti:

- F70 Retardasi Mental Ringan (IQ 50-69)
- F71 Retardasi Mental Sedang (IQ 35-49)
- F72 Retardasi Mental Berat (IQ 20-34)
- F73 Retardasi Mental Sangat Berat (IQ di bawah 20).

Selain itu, gunakan digit keempat untuk menunjukkan tingkat keparahan keterbatasan perilaku atau cacat fisik yang menyertai, seperti gangguan motorik, komunikasi, atau kondisi medis lainnya yang sering kali berkaitan dengan retardasi mental.

3.19.28 Tic Disorders (F95.-)

Kode dalam kelompok F95.- (*Tic disorders*) dapat diberikan sesuai diagnosis yang diberikan oleh dokter. Kode ini digunakan untuk pasien yang mengalami gerakan atau vokalisasi tidak terkendali dan berulang (tics) yang bersifat involunter namun dapat ditekan sementara dengan upaya sadar. Gangguan ini dapat bervariasi dari yang ringan hingga parah, seperti:

- F95.0 Tic Sementara (tics yang berlangsung kurang dari 12 bulan)

- F95.1 Tic Motorik atau Vokal Kronis (tics motorik atau vokal yang berlangsung lebih dari 12 bulan)
- F95.2 Sindrom Tourette (gabungan tics motorik multipel dan satu atau lebih tics vokal, sering kali melibatkan gerakan kompleks atau ucapan yang tidak pantas).

Diagnosis akhir harus didasarkan pada evaluasi menyeluruh oleh tenaga medis profesional, termasuk wawancara klinis mendalam dengan pasien dan keluarga, observasi langsung terhadap pola tics, analisis riwayat onset gejala (biasanya dimulai pada masa kanak-kanak), serta penilaian dampak tics terhadap fungsi sosial, akademik, pekerjaan, dan kualitas hidup individu secara keseluruhan.

3.19.29 *Enuresis Nonorganik* (F98.0)

Kode dalam kelompok F98.0 (*Enuresis nonorganik*) dapat diberikan sesuai diagnosis yang diberikan oleh dokter. Kode ini digunakan untuk pasien yang mengalami pengeluaran urine secara tidak disengaja (mengompol) pada usia di mana kontrol kandung kemih seharusnya sudah tercapai (biasanya setelah usia 5 tahun), tanpa adanya penyebab organik seperti infeksi saluran kemih, kelainan anatomi, atau kondisi medis lainnya yang dapat menjelaskan gejala tersebut. Diagnosis akhir harus didasarkan pada evaluasi menyeluruh oleh tenaga medis profesional, termasuk wawancara klinis dengan orang tua atau pengasuh, analisis riwayat perkembangan anak, pemeriksaan fisik untuk menyingkirkan kemungkinan penyebab organik, serta observasi pola buang air kecil dan frekuensi kejadian enuresis.

3.19.30 *Enkopresis Nonorganik* (F98.1)

Kode dalam kelompok F98.1 (*Enkopresis nonorganik*) dapat diberikan sesuai diagnosis yang diberikan oleh dokter. Kode ini digunakan untuk pasien yang mengalami pengeluaran tinja secara tidak disengaja atau disengaja pada tempat yang tidak pantas (seperti pakaian atau lantai) tanpa adanya penyebab organik seperti kelainan anatomi, gangguan neurologis, atau kondisi medis lainnya yang dapat menjelaskan gejala tersebut. Diagnosis akhir harus didasarkan pada evaluasi

menyeluruh oleh tenaga medis profesional, termasuk wawancara klinis dengan orang tua atau pengasuh, analisis riwayat perkembangan anak, pemeriksaan fisik untuk menyingkirkan kemungkinan penyebab organik seperti konstipasi kronis atau gangguan gastrointestinal, serta observasi pola buang air besar dan frekuensi kejadian enkopresis.

3.19.31 *Feeding Disorder of Infancy and Childhood (F98.2)*

Kode dalam kelompok F98.2 (*Feeding disorder of infancy and childhood*) dapat diberikan sesuai diagnosis yang diberikan oleh dokter. Kode ini digunakan untuk pasien yang memiliki kondisi di mana seorang bayi atau anak mengalami pola makan yang abnormal atau bermasalah, seperti penolakan makan, pemilih makanan berlebihan (*picky eating*), makan berlebihan, atau perilaku makan yang tidak biasa lainnya, tanpa adanya penyebab organik seperti gangguan pencernaan, alergi makanan, atau kondisi medis lainnya yang dapat menjelaskan gejala tersebut. Diagnosis akhir harus didasarkan pada evaluasi menyeluruh oleh tenaga medis profesional, termasuk wawancara klinis dengan orang tua atau pengasuh, analisis riwayat perkembangan anak, observasi perilaku makan, serta penilaian status gizi dan pertumbuhan anak melalui pemeriksaan fisik dan pengukuran antropometri (misalnya berat badan, tinggi badan, atau indeks massa tubuh).

3.19.32 *Pica of Infancy and Childhood (F98.3)*

Kode dalam kelompok F98.3 (*Pica of infancy and childhood*) dapat diberikan sesuai diagnosis yang diberikan oleh dokter. Kode ini digunakan untuk pasien yang memiliki kondisi di mana seorang bayi atau anak secara persisten dan berulang kali mengonsumsi bahan-bahan non-nutritif (bukan makanan) seperti tanah, pasir, kotoran, cat, rambut, kertas, atau benda lainnya selama periode waktu minimal satu bulan, pada usia di mana perilaku tersebut tidak sesuai dengan perkembangan normal (biasanya setelah usia 2 tahun). Diagnosis akhir harus didasarkan pada evaluasi menyeluruh oleh tenaga medis profesional, termasuk wawancara klinis dengan orang tua atau pengasuh, analisis riwayat perilaku makan anak, pemeriksaan fisik untuk menilai kemungkinan

dampak medis dari konsumsi bahan non-nutritif (seperti keracunan timbal akibat memakan cat), serta penilaian status gizi dan perkembangan anak.

3.19.33 *Stereotyped Movement Disorders* (F98.4)

Kode dalam kelompok F98.4 (*Stereotyped movement disorders*) dapat diberikan sesuai diagnosis yang diberikan oleh dokter. Kode ini digunakan untuk pasien yang memiliki kondisi di mana seorang anak secara berulang melakukan gerakan tubuh stereotipik yang tidak memiliki tujuan jelas, seperti menggoyangkan badan, menepuk tangan, memukul kepala, atau mengayunkan tubuh secara ritmis. Gerakan ini biasanya bersifat involunter dan dapat menyebabkan cedera fisik atau gangguan dalam fungsi sosial, akademik, atau aktivitas sehari-hari jika dilakukan secara persisten dan intens. Diagnosis akhir harus didasarkan pada evaluasi menyeluruh oleh tenaga medis profesional, termasuk wawancara klinis dengan orang tua atau pengasuh, observasi langsung terhadap pola gerakan stereotipik, analisis riwayat perkembangan anak, serta penilaian dampak perilaku tersebut terhadap kesejahteraan fisik, emosional, dan sosial anak.

3.19.34 *Stuttering [Stammering]* (F98.5)

Kode dalam kelompok F98.5 (*Stuttering [stammering]*) dapat diberikan sesuai diagnosis yang diberikan oleh dokter. Kode ini digunakan untuk pasien yang mengalami gangguan kelancaran berbicara yang ditandai dengan pengulangan suku kata, kata, atau frasa secara tidak disengaja, pemanjangan bunyi tertentu, atau hambatan dalam mengeluarkan bunyi (*blocking*) saat berbicara. Diagnosis akhir harus didasarkan pada evaluasi menyeluruh oleh tenaga medis profesional, termasuk wawancara klinis dengan orang tua atau pengasuh, observasi langsung terhadap pola bicara anak, analisis riwayat perkembangan bahasa dan komunikasi, serta penilaian dampak gagap terhadap fungsi sosial, emosional, dan akademik anak.

3.19.35 Cluttering (F98.6)

Kode dalam kelompok F98.6 (*Cluttering*) dapat diberikan sesuai diagnosis yang diberikan oleh dokter. Kode ini digunakan untuk pasien yang memiliki kondisi di mana seorang anak mengalami gangguan kelancaran berbicara yang ditandai dengan pola bicara cepat dan tidak teratur, sering kali sulit dipahami karena kurangnya pengaturan ritme, jeda, atau struktur gramatikal dalam ucapannya. Diagnosis akhir harus didasarkan pada evaluasi menyeluruh oleh tenaga medis profesional, termasuk wawancara klinis dengan orang tua atau pengasuh, observasi langsung terhadap pola bicara anak, analisis riwayat perkembangan bahasa, serta penilaian dampak cluttering terhadap fungsi sosial, akademik, dan emosional anak.

3.20 MDC 30 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN

PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 30

- Penggunaan kode Z masih digunakan untuk melengkapi kondisi utama saat dilakukan *follow up* penyakit dan digunakan untuk terapi pada penyakit seperti kemoterapi, radioterapi, fisioterapi, rehabilitasi medis maupun status persalinan dan bayi baru lahir. Kode-kode Z digunakan sebagai dasar pengajuan klaim, bukan untuk kepentingan statistik penyakit rumah sakit. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemisahan secara tegas antara kode untuk klaim dan kode untuk keperluan statistik rumah sakit.
- Untuk Follow Up hanya ada 3 Sub bab kode yang digunakan yaitu:

Z08.- Follow-up examination after treatment for malignant neoplasms

Z09.- Follow-up examination after treatment for conditions other than malignant neoplasms

Z39.- Postpartum care and examination

- Kode dalam kategori Z00-Z13 digunakan pada orang/pasien yang berkunjung untuk pemeriksaan dan investigasi kesehatan dan hanya boleh dicantumkan sebagai diagnosis utama apabila tidak terdapat diagnosis spesifik, komplikasi, cedera, gejala, atau temuan abnormal lainnya yang dapat menjelaskan alasan kunjungan. Apabila ditemukan diagnosis spesifik atau temuan abnormal sebagai hasil investigasi, maka kode Z00–Z13 tidak boleh digunakan. .
- Bila Pasien kontrol pengobatan dengan diagnosa utama yang sama dengan kunjungan sebelumnya maka Kode Z08-Z09.8 digunakan untuk klaim pasien rawat jalan kunjungan “*follow up*”.
- Kode Z37 digunakan untuk kasus persalinan sebagai *output delivery* pada rekam medis ibu sedangkan Z38 untuk rekam medis bayi.
- Kode Z50 dan Z51 digunakan sebagai penanda untuk kasus Radioterapi, Kemoterapi, dan Rehabilitasi Medis. Kode tersebut dicantumkan sebagai diagnosis primer ataupun sekunder, sesuai konteks klinis dan administratif.

PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 30

3.20.1 *Encounter For General Medical Examination (Z00-Z01)*

Gunakan kode dalam kelompok Z00.- (*General examination and investigation of persons without complaint and reported diagnosis*) dan Z01.- (*Other special examinations and investigations of persons without complaint or reported diagnosis*) untuk mencatat tindakan pemeriksaan medis pada individu yang tidak memiliki keluhan atau gejala, dan setelah dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan penyakit atau kelainan apa pun, sehingga tidak memerlukan pengobatan. Beberapa ketentuannya sebagai berikut:

- Pemeriksaan untuk skrining

Pemeriksaan skrining yang dilakukan untuk mendeteksi penyakit tertentu seperti skrining adanya kanker serviks, maka gunakan kode Z11-Z13, bukan Z00.- atau Z01.-

- Pemeriksaan untuk tujuan administratif

Pemeriksaan yang dilakukan untuk keperluan administratif seperti surat keterangan sehat untuk kerja, maka gunakan kode Z02.-

- Pemeriksaan atas dasar gejala atau keluhan

Pasien memiliki gejala atau keluhan yang membuatnya harus diperiksa, tetapi tidak ditemukan penyakit atau kelainan, maka gunakan kode gejala atau keluhan yang menyebabkan pasien datang untuk diperiksa. Tidak perlu menggunakan kode Z00.- atau Z01.- karena fokusnya adalah pada gejala atau keluhan tersebut.

Contoh: Pasien sakit kepala, setelah dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan kelainan, maka gunakan kode R51 (*Headache*) sebagai diagnosis utama, bukan Z00.- atau Z01.-

- Penyakit/ kelainan ditemukan saat pemeriksaan

Apabila dalam suatu pemeriksaan ditemukan penyakit atau kelainan, maka gunakan kode penyakit atau kelainan tersebut sebagai diagnosis utama dan tidak perlu menambahkan kode Z00.- atau Z01.-.

Contoh: Pasien *medical check-up* lalu ditemukan penyakit hipertensi, maka gunakan kode I10 (*Essential (primary) hypertension*)

- Pemeriksaan Panggul (*Pelvic Examination*)

Pemeriksaan panggul menggunakan metode *conventional Papanicolaou smear* atau *liquid-based preparation* yang merupakan bagian dari pemeriksaan rutin tahunan atau berdasarkan jadwal tertentu, tanpa adanya gejala atau keluhan, dan hasil pemeriksaan tidak menunjukkan adanya penyakit atau kelainan, maka gunakan kode Z01.4 *Gynaecological examination (general)(routine)* sebagai diagnosis utama.

Pengecualian:

- a. Pemeriksaan dilakukan untuk tujuan kontrasepsi (KB) maka gunakan kode dalam grup Z30.- (*Contraceptive management*).
- b. Pemeriksaan dilakukan untuk mendiagnosis kehamilan maka gunakan kode dalam grup Z32.- (*Pregnancy examination and test*).

3.20.2 *Examination And Encounter For Administrative Purposes (Z02)*

Kode diagnosis dalam kelompok Z02.- (*Examination and encounter for administrative purposes*) digunakan untuk individu yang menjalani pemeriksaan hanya untuk tujuan administratif dan tidak ditemukan penyakit atau kelainan selama pemeriksaan berlangsung. Beberapa ketentuannya sebagai berikut:

- Apabila selama pemeriksaan ditemukan penyakit atau kelainan, maka gunakan kode penyakit/kelainan tersebut sebagai diagnosis utama dan tidak perlu menggunakan kode dalam grup Z02.-.
- Kode Z02.7 digunakan secara khusus untuk penerbitan sertifikat medis pada pasien atau keluarga yang meminta dokumen resmi dari dokter, seperti:
 - o Sertifikat kematian
 - o Surat keterangan sehat
 - o Surat keterangan ketidakmampuan atau disabilitas
- Kode Z02.7 tidak digunakan apabila dokter tidak hanya menerbitkan dokumen resmi tetapi juga memberikan layanan pemeriksaan penyakit, gejala, pengobatan pasien sakit, atau layanan pemeriksaan kesehatan lainnya, seperti:
 - Z00 – Z01 (*Encounter for general medical examination*)

- Z02.0 – Z02.6 dan Z02.8 – Z02.9 (*Other examinations for administrative purposes*)
- Z10 (*Routine general health check-up of defined subpopulation*)

Contoh: Pasien datang untuk mendapatkan surat keterangan sehat tanpa ada keluhan atau gangguan yang dialaminya. Pemeriksaan dilakukan dengan hasilnya normal, maka gunakan kode Z02.8 (*Other examinations for administrative purposes*).

3.20.3 *Medical Observation And Evaluation For Suspected Diseases And Conditions (Z03)*

Gunakan kode dari kelompok Z03.- (*Medical observation and evaluation for suspected diseases and conditions*) untuk mencatat proses observasi dan evaluasi medis terhadap dugaan awal adanya suatu patologi atau kelainan medis yang selanjutnya dilakukan serangkaian pemeriksaan klinis, analisis laboratorium, atau prosedur diagnosis lainnya dengan hasil tidak ditemukan bukti adanya penyakit atau kelainan yang sesuai dengan kecurigaan awal. Contoh: Pasien diduga menderita kanker payudara karena ditemukan benjolan, setelah dilakukan pemeriksaan biopsi hasilnya negatif, maka gunakan kode Z03.1 (*Observation for suspected malignant neoplasm*)

3.20.4 *Examination And Observation For Other Reasons (Z04.-)*

Gunakan kode dari kelompok Z04.- (*Examination and observation for other reasons*) sebagai kode tambahan untuk mencatat pemeriksaan dan pengamatan yang dilakukan dengan alasan tertentu, lalu dokter menyimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya kelainan atau kondisi patologis selama pemeriksaan. Apabila dokter mengidentifikasi adanya kelainan atau penyakit selama proses pemeriksaan, maka kode untuk kelainan atau penyakit tersebut yang harus digunakan dan tidak menambahkan kode Z04.- sebagai tambahan.

Contoh: Pasien kecelakaan lalu lintas, lalu dilakukan pemeriksaan lengkap pada pasien, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pasien dalam keadaan normal, maka gunakan kode Z04.1 (*Examination and observation following transport accident*).

3.20.5 *Follow-Up Examination After Treatment For Malignant Neoplasms (Z08-Z09)*

- Gunakan kode dalam kelompok Z08.- (*Follow-up examination after treatment for malignant neoplasms*) untuk pemeriksaan tindak lanjut setelah pengobatan neoplasma ganas (kanker).
- Gunakan kode dalam kelompok Z09.- (*Follow-up examination after treatment for conditions other than malignant neoplasms*) untuk Pemeriksaan tindak lanjut setelah pengobatan kondisi selain neoplasma ganas seperti hipertensi, diabetes, atau penyakit lain.
- Kode dalam kelompok Z08.- dan Z09.- hanya digunakan jika pemeriksaan tindak lanjut tidak menemukan penyakit atau kelainan dan dokter tidak memberikan layanan lain.

Contoh 1- 30	Pasien datang ke rumah sakit untuk kontrol hipertensi	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Kontrol ulang	Z09.8 <i>Follow-Up Examination After Other Treatment for Other Conditions</i>
Diagnosis sekunder	Hipertensi	I10 <i>Essential (primary) hypertension</i>

- Pada kasus pemeriksaan tindak lanjut dimana tidak ditemukan lagi penyakit atau kelainan, maka gunakan digit keempat yang sesuai dengan metode pengobatan yang diterima. Selain itu, tambahkan kode dari kelompok berikut:
 - Z85.- *Personal history of malignant neoplasm*
 - Z86.- *Personal history of certain other diseases*
 - Z87.- *Personal history of other diseases and conditions*
- Jika dokter yang mencatat adanya layanan tambahan yang diberikan kepada pasien (misalnya, pelepasan jahitan luka operasi), maka gunakan kode untuk perawatan tindak lanjut (*follow-up care*) yaitu kode dalam kelompok Z42 – Z50 sebagai gantinya.

- Apabila dalam pemeriksaan tindak lanjut yang diberikan kepada pasien setelah pengobatan dan dokter mendiagnosis bahwa penyakit yang diobati masih ada, maka gunakan kode penyakit tersebut sebagai diagnosis utama.

Contoh: dalam pemeriksaan tindak lanjut setelah operasi glaukoma (yang bertujuan untuk menurunkan tekanan mata), jika pasien masih memiliki glaukoma setelah operasi, maka gunakan kode untuk glaukoma sebagai diagnosis utama.

3.20.6 Routine General Health Check-Up Of Defined Subpopulation (Z10)

- Gunakan kode yang sesuai dari grup Z10.- (*Routine general health check-up of defined subpopulation*) untuk pemeriksaan kepada pasien yang tidak ditemukan adanya penyakit atau kelainan dan diagnosis dokter menunjukkan bagian dari pemeriksaan kesehatan umum untuk kelompok populasi tertentu yang mencakup pemeriksaan kesehatan rutin untuk subpopulasi spesifik.
- Identifikasi dokter menunjukkan adanya penyakit atau kelainan selama pemeriksaan, maka kode untuk kondisi tersebut harus digunakan sebagai diagnosis utama, dan tidak perlu mencantumkan kode dari grup Z10.-.
- Penggunaan kode Z10.- dimaksudkan untuk mendokumentasikan pemeriksaan kesehatan preventif atau rutin yang dilakukan tanpa indikasi adanya masalah medis. Sebaliknya, jika ditemukan kondisi patologis, fokus pengodean harus dialihkan pada penyakit atau kelainan yang terdiagnosis.

3.20.7 Special Screening Examination (Z11-Z13)

- Gunakan kode dari kelompok Z11.- (*Special screening examination for infectious and parasitic diseases*) untuk skrining penyakit infeksi dan parasit
- Gunakan kode dari kelompok Z12.- (*Special screening examination for neoplasms*) untuk skrining neoplasma (tumor)

- Gunakan kode dari grup Z13.- (*Special screening examination for other diseases and disorders*) untuk skrining penyakit serta gangguan lainnya.
- Kode dari kelompok Z11-Z13 digunakan untuk mendokumentasikan prosedur skrining yang dilakukan sebagai bagian dari upaya preventif atau deteksi dini, terutama ketika belum ada indikasi adanya penyakit atau kelainan. Selain itu, bertujuan untuk memastikan bahwa dokumentasi medis fokus pada kondisi patologis yang teridentifikasi, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan klinis lebih lanjut.
- Ketika selama proses skrining ditemukan adanya penyakit atau kelainan, maka kode untuk kondisi tersebut harus digunakan sebagai diagnosis utama, dan kode skrining dari kelompok Z11-Z13 tidak perlu lagi dicantumkan.

3.20.8 *Contact With And Exposure To Communicable Diseases (Z20.-)*

- Gunakan kode dalam kelompok Z20.- untuk mencatat situasi di mana seseorang memiliki riwayat kontak atau terpapar penyakit menular, sesuai dengan diagnosis yang ditetapkan oleh dokter.
- Kode dalam kelompok Z20.- berlaku ketika individu diketahui berada dalam kondisi yang berisiko terhadap penularan penyakit, meskipun belum ada bukti pasti terjadinya infeksi.
- Pemberian kode Z20.- bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko penularan dan membantu dalam merencanakan langkah-langkah pencegahan serta pemantauan yang diperlukan.
- Hasil pemeriksaan medis yang menunjukkan bahwa individu tersebut terinfeksi, maka kode untuk penyakit yang bersangkutan harus digunakan sebagai diagnosis utama, dan kode Z20.- tidak lagi relevan.

3.20.9 *Asymptomatic Human Immunodeficiency Virus [HIV] Infection Status (Z21)*

- Gunakan kode dalam kelompok Z21.- untuk mendokumentasikan status infeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) pada individu

yang tidak menunjukkan gejala atau manifestasi klinis terkait penyakit.

- Kode kelompok Z21.- secara khusus dirancang untuk mencatat kondisi seseorang yang telah dinyatakan positif HIV, tetapi belum mengalami komplikasi, perkembangan penyakit, atau gejala apa pun yang mengindikasikan penurunan sistem kekebalan tubuh. Oleh karena itu, penting bagi pemberi kode untuk memastikan bahwa diagnosis dokter secara eksplisit menyebutkan bahwa pasien berada dalam tahap asimtomatik agar penggunaan kode ini sesuai dengan kondisi medis yang sebenarnya.
- Penggunaan kode Z21.- memiliki peran penting dalam mendokumentasikan status kesehatan individu yang hidup dengan HIV tanpa gejala. Informasi ini berguna untuk mendukung pemantauan medis jangka panjang, perencanaan intervensi preventif, serta evaluasi risiko penularan kepada orang lain.
- Ketika pasien mulai menunjukkan gejala seperti infeksi oportunistik, penurunan kekebalan tubuh, atau komplikasi lain yang terkait dengan HIV/AIDS, maka kode lain yang lebih spesifik harus digunakan sesuai dengan kondisi yang terdiagnosis.

3.20.10 *Carrier Of Infectious Disease (Z22.-)*

- Gunakan kode dari kelompok Z22.- (*Carrier of infectious disease*) untuk mendokumentasikan status seseorang sebagai pembawa penyakit menular, sesuai dengan diagnosis yang diberikan oleh dokter.
Catatan: Kode dari kelompok Z22.- digunakan untuk mencatat individu yang secara medis diidentifikasi sebagai pembawa (*carrier*) patogen penyakit menular, meskipun tidak menunjukkan gejala.

3.20.11 *Immunization (Z23-Z28)*

- Gunakan kode berdasarkan jenis vaksin yang diberikan, dengan menggunakan kategori yang sesuai dari kode-kode berikut:
 - Z23 (*Need for immunization against single bacterial diseases*)
 - Z24 (*Need for immunization against certain single viral diseases*)
 - Z25 (*Need for immunization against other single viral diseases*)

- Z26 (*Need for immunization against other single infectious diseases*)
- Z27 (*Need for immunization against combinations of infectious diseases*)
- Tidak perlu menggunakan kode prosedur untuk mencatat pemberian vaksin itu sendiri.
- Ketika dokter menyatakan bahwa layanan imunisasi tidak dapat dilakukan, maka gunakan kode dari grup Z28.- (*Immunization not carried out*) atau "Imunisasi tidak dilakukan" sebagai diagnosis utama. Kode ini harus dipilih sesuai dengan alasan spesifik yang mendasari ketidakmampuan untuk memberikan layanan imunisasi, seperti penolakan pasien, kontraindikasi medis, atau kendala lainnya.
- Penggunaan kode-kode *Immunization* bertujuan untuk mendokumentasikan kebutuhan atau hambatan terkait imunisasi secara akurat, sehingga dapat mendukung pelacakan status vaksinasi individu serta perencanaan program kesehatan masyarakat.

3.20.12 *Need For Other Prophylactic Measures (Z29.-)*

- Gunakan kode dari kelompok Z29.- (*Need For Other Prophylactic Measures*) untuk mencatat kebutuhan tindakan pencegahan lainnya, sesuai dengan diagnosis yang ditetapkan oleh dokter.
- Kode dari grup Z29.- digunakan untuk mendokumentasikan berbagai langkah pencegahan yang tidak termasuk dalam kategori lain, seperti tindakan medis atau intervensi yang bertujuan untuk mencegah risiko kesehatan tertentu.
- Penggunaan kode Z29.- membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan spesifik terkait pencegahan penyakit atau komplikasi medis, sehingga dapat mendukung perencanaan penanganan yang lebih efektif.

3.20.13 *Contraceptive Management (Z30.-)*

Kode Z30.- (*Contraceptive management*), digunakan untuk prosedur seperti pemasangan, pelepasan, atau penggantian IUD.

- Gunakan kode Z30.0 (*general counselling and advice on contraception*) ketika diagnosis dokter menunjukkan pemberian

layanan berupa konsultasi atau saran tentang perencanaan keluarga atau kontrasepsi dan digunakan untuk kasus pemberian pil KB atau suntikan KB pertama kali kepada pasien di fasilitas kesehatan tertentu.

- Gunakan kode Z30.1 (*Insertion of (intrauterine) contraceptive device*) ketika diagnosis dokter menunjukkan pemberian layanan berupa pemasangan IUD.
- Gunakan kode Z30.5 (*Surveillance of (intrauterine) contraceptive device*) ketika diagnosis dokter menunjukkan pemberian layanan berupa pemeriksaan dalam untuk memeriksa IUD, melepas IUD yang sudah ada, atau mengganti IUD yang kadaluarsa atau hilang.

Catatan:

- Pada pelayanan pemeriksaan untuk memastikan posisi IUD tidak perlu menggunakan kode prosedur
- Pada pelayanan pemasangan atau pelepasan IUD perlu menggunakan kode prosedur.

Penjelasan Tambahan:

Prosedur	ICD 9 CM 2010
<i>Insertion of intrauterine contraceptive device</i>	69.7
<i>Removal of intrauterine contraceptive device</i>	97.71

Pada sistem ICD-9-CM, tidak ada kode prosedur khusus untuk penggantian alat kontrasepsi intrauterin (IUD) yang baru. Oleh karena itu, gunakan kombinasi kode 97.71 (*Removal of intrauterine contraceptive device*) dan kode 69.7 (*Insertion of intrauterine contraceptive device*). Namun, dalam sistem ICD-10-IM, terdapat kode khusus untuk penggantian IUD, yaitu 519-12-14 (*Replacement of intrauterine contraceptive device*).

- Untuk Layanan Kontrasepsi Lainnya:
 - Pemeriksaan pemantauan Obat Kontrasepsi, maka gunakan kode Z30.4 (*Surveillance of contraceptive drugs*).

Contoh: Dokter mencatat bahwa layanan berupa pemeriksaan pemantauan untuk pasien pengguna obat kontrasepsi (baik pil KB, suntikan, atau implan).

- Penanaman atau Pengangkatan Implan Kontrasepsi di Bawah Kulit, maka gunakan kode Z30.8 (*Other contraceptive management*)
Contoh: dokter mencatat bahwa layanan berupa penanaman implan kontrasepsi di lengan bawah atau pengangkatan implan yang sudah ditanamkan.
- Prosedur penanaman implan kontrasepsi, maka gunakan kode ICD-9-CM 99.23 (*Injection of steroid*) termasuk *subdermal implantation of progesterone*.
- Prosedur pengangkatan implan kontrasepsi, maka gunakan kode ICD-9-CM: 86.05 (*Incision with removal of foreign body from skin and subcutaneous tissue*).
- Pemberian kondom atau pemeriksaan jumlah sperma setelah sterilisasi pria, maka gunakan kode Z30.8 (*Other contraceptive management* sebagai diagnosis).

3.20.14 Sterilisasi (Z30.2)

- Gunakan kode Z30.2 (*Sterilization*) sebagai diagnosis utama untuk semua jenis sterilisasi, baik untuk pria maupun wanita ("sterilisasi kering").
- Gunakan kode Z30.2 (*Sterilization*) sebagai diagnosis tambahan untuk seorang pasien melahirkan dan menerima sterilisasi selama operasi caesar atau setelah melahirkan ("sterilisasi basah")
- Kode prosedur harus sesuai dengan teknik pembedahan yang dicatat oleh dokter.
- Kode Prosedur untuk Sterilisasi Wanita:
 - Tubal Ligation (TL), maka gunakan kode ICD-9-CM: 66.31 (*Other bilateral ligation and crushing of fallopian tubes*).
 - *Tubal Resection* (TR), *Postpartum TR*, *Interval TR*, *Operasi Pomeroy*, atau *Modified Pomeroy*, maka gunakan kode ICD-9-CM: 66.32 (*Other bilateral ligation and division of fallopian tubes*) (522-26-11).
- Sterilisasi melalui Laparoskopi:

- Penggunaan elektrokauter, maka gunakan kode ICD-10-IM: 522-28-20 (Penghancuran lesi tuba fallopi melalui laparoskopi dengan elektrokauterisasi).
- Penggunaan klip, maka gunakan kode ICD-10-IM: 522-30-25 (Penyumbatan tuba fallopi melalui laparoskopi dengan klip).
- Sterilisasi Umum (*Female Sterilization*):
 Pada tindakan untuk sterilization, seperti tubektomi MOW pada tindakan Sectio Caesaria, maka gunakan kode 66.39 (*Other bilateral destruction or occlusion of fallopian tubes*).
 Catatan:
 - Penggunaan kode 66.39 sebaiknya dihindari jika tersedia kode tindakan yang lebih spesifik, karena kode ini bersifat terlalu umum.
 - Kode prosedur sterilisasi satu sisi pada perempuan dalam ICD-9-CM, kode yang digunakan sama dengan sterilisasi dua sisi.
 - Namun untuk ICD-10-IM, ubah tiga digit pertama dari 522- (bilateral) menjadi 521- (unilateral)
- Kode Prosedur untuk Sterilisasi Pria:
 - *Vasectomy*, maka gunakan kode ICD-9-CM: 63.73 *Vasectomy*.
 - *Ligasi Vas Deferens*, maka gunakan kode ICD-9-CM: 63.71 *Ligasi vas deferens*.
 - Sterilisasi Umum (*Male Sterilization*), maka gunakan kode ICD-9-CM: 63.70 *Prosedur sterilisasi pria NOS*.

3.20.15 Procreative Management (Z31.-)

- Gunakan kode Z31.0 (*Tuboplasty or vasoplasty after previous sterilization*) ketika dokter mendiagnosis bahwa layanan adalah untuk memperbaiki sterilisasi (baik sterilisasi pria maupun wanita).
- Kode Prosedur untuk *Vasoplasty* (Pria), maka gunakan kode ICD-9-CM: 63.82 (*Reconstruction of surgically divided vas deferens*) (505-48-19).
- Kode Prosedur untuk *Tuboplasty* (Wanita), sebagian besar dokter mencatat prosedur ini sebagai *tubal reanastomosis*. Dalam ICD-9-CM, hanya ada satu kode untuk prosedur ini: 66.79 *Other repair of fallopian tube*.

Prosedur	ICD 9 CM 2010
Kode Prosedur untuk <i>Ovum Pick Up</i>	65.91 <i>Aspiration of ovary</i>
Kode Prosedur untuk <i>Embryo Transfer</i>	69.99 <i>Other operations on cervix and uterus</i>

- Diagnosis *ovum pick up* atau *embryo transfer* pada proses *Fertilisasi In Vitro* (IVF), maka gunakan kode diagnosis Z31.2 (*In vitro fertilization*) karena keduanya merupakan bagian dari proses *fertilisasi in vitro* (pembuahan di luar tubuh).

Catatan:

- *Ovum Pick Up* merupakan prosedur pengambilan sel telur (ovum) dari ovarium setelah stimulasi ovulasi.
- *Embryo Transfer* merupakan prosedur memindahkan embrio hasil fertilisasi ke dalam rahim untuk implantasi lebih lanjut.
- Pastikan dokumentasi medis mencatat langkah-langkah spesifik dari proses IVF agar pengodean dapat dilakukan secara akurat.

3.20.16 *Pregnancy Examination And Test (Z32.-)*

- Dokter menegaskan bahwa pasien tidak sedang hamil, maka gunakan kode Z32.0 (*Pregnancy, not (yet) confirmed*), yang menunjukkan bahwa kehamilan belum terkonfirmasi.
- Dokter menegaskan bahwa pasien hamil, maka gunakan kode Z32.1 (*Pregnancy confirmed*) untuk mencatat bahwa kehamilan telah dikonfirmasi.

Catatan: Kode Z32.- dirancang untuk mendokumentasikan status kehamilan secara jelas dan sesuai dengan hasil diagnosis medis.

3.20.17 *Pregnant State, Incidental (Z33)*

- Gunakan kode Z33 (*Pregnant state, incidental*) sebagai diagnosis tambahan untuk wanita hamil yang mengalami kondisi seperti cedera, keracunan, atau efek samping dari obat atau bahan kimia yang digunakan dalam pengobatan penyakit.

- Kode Z33 digunakan untuk mencatat status kehamilan secara insidental, tanpa menjadikannya fokus utama perawatan namun tetap memberikan informasi penting terkait kondisi pasien.
- Penggunaan kode Z33 bertujuan untuk mendokumentasikan status kehamilan sebagai faktor tambahan yang dapat mempengaruhi penanganan medis atau respons terhadap kondisi yang dialami.
- Pencatatan status kehamilan secara akurat, tenaga medis dapat mempertimbangkan risiko dan manfaat dari setiap tindakan medis yang dilakukan, sehingga dapat memberikan penanganan yang lebih aman dan tepat bagi ibu dan janin. Hal ini juga membantu memastikan bahwa rekam medis mencerminkan gambaran klinis secara komprehensif.

3.20.18 *Supervision Of Normal Pregnancy (Z34-Z35)*

- Gunakan kode dari kelompok Z34.- (*Supervision of normal pregnancy*) atau Z35.- (*Supervision of high-risk pregnancy*) sebagai diagnosis utama untuk pemeriksaan kehamilan yang tidak menunjukkan adanya penyakit atau kelainan.
- Kode (Z34-Z35) khusus digunakan untuk pasien rawat jalan dalam rangka pemantauan kehamilan, baik yang berisiko rendah maupun tinggi selama tidak ada kondisi patologis yang teridentifikasi.
- Selama pemeriksaan ditemukan penyakit atau kelainan tertentu, maka kode untuk kondisi tersebut harus digunakan sebagai diagnosis utama dan tidak perlu menggunakan kode Z34.- atau Z35.- sebagai diagnosis tambahan.

3.20.19 *Antenatal Screening (Z36)*

- Gunakan kode dari kelompok Z36.- (*Antenatal screening*) apabila hasil skrining menunjukkan tidak adanya kelainan.
- Penemuan proses skrining kelainan atau kondisi abnormal, maka kode untuk kelainan tersebut harus dijadikan sebagai diagnosis utama dan tidak perlu menggunakan kode Z36.- karena fokus dokumentasi medis beralih pada kondisi spesifik yang ditemukan.

- Pendekatan ini memastikan bahwa rekam medis mencerminkan informasi secara akurat dan relevan, sehingga dapat mendukung penanganan klinis yang tepat serta perencanaan tindakan lanjutan bagi pasien.

3.20.20 Outcome Of Delivery (Z37.-)

- Kode dari kelompok Z37.- (*Outcome of delivery*) digunakan sebagai diagnosis tambahan untuk mendokumentasikan hasil persalinan pada ibu yang melahirkan.
- Kode dari grup Z37.- (*Outcome of delivery*) tidak boleh digunakan sebagai diagnosis utama dalam kondisi apa pun.
- Dokter seringkali tidak mencatat secara eksplisit apakah ibu melahirkan satu anak atau lebih, atau apakah bayi lahir hidup atau mati, tetapi informasi tersebut dapat diperoleh dari catatan persalinan. Catatan tersebut biasanya mencakup jumlah bayi yang lahir serta skor Apgar untuk setiap bayi pada menit ke-1, ke-5, dan terkadang pada interval waktu lebih lama.
- Skor Apgar lebih besar dari 0 pada salah satu waktu pengukuran, maka bayi tersebut dianggap lahir hidup.
- Pemanfaatan informasi dari catatan persalinan, coder dapat menentukan kode yang paling tepat untuk mendokumentasikan hasil persalinan secara akurat. Pendekatan ini memastikan bahwa rekam medis mencerminkan informasi yang lengkap dan relevan, sehingga mendukung penanganan klinis dan analisis data kesehatan secara lebih efektif.

3.20.21 Liveborn Infants According To Place Of Birth (Z38.-)

- Gunakan kode dalam kelompok Z38.- (*Liveborn infants according to place of birth*) sebagai diagnosis untuk mendokumentasikan bayi yang dilahirkan hidup.
- Kode grup Z38.- bertujuan untuk mengidentifikasi dua aspek penting:
 1. Lokasi kelahiran, yaitu apakah bayi lahir di rumah sakit atau di luar rumah sakit

2. Status kelahiran, yaitu apakah bayi lahir tunggal atau termasuk dalam kelahiran kembar
- Penggunaan kode grup Z38.- sangat penting untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi kelahiran bayi, yang dapat digunakan dalam analisis data kesehatan dan perencanaan layanan neonatal.
 - Pembedaan antara tempat kelahiran serta jenis kelahiran (tunggal atau kembar), maka dokumentasi medis menjadi lebih terperinci dan berguna untuk mendukung penelitian, kebijakan kesehatan, serta peningkatan pelayanan kepada ibu dan bayi.

3.20.22 *Postpartum Care And Examination (Z39.-)*

- Gunakan kode dari kelompok Z39.0 (*Care and examination immediately after delivery*) sebagai diagnosis utama untuk ibu yang melahirkan sebelum tiba di fasilitas kesehatan (BBA) tanpa komplikasi dan tanpa prosedur terkait persalinan seperti pemotongan tali pusar, pengeluaran plasenta, atau penjahitan luka.
- Ibu yang melahirkan sebelum tiba di fasilitas kesehatan (BBA) dengan komplikasi persalinan dan ibu dirawat untuk penanganan lebih lanjut, maka gunakan kode untuk komplikasi tersebut sebagai diagnosis utama, bahkan jika dokter mencatat diagnosis sebagai *birth before arrival*.
- Prosedur terkait persalinan yang tetap dilakukan di fasilitas kesehatan, meskipun dokter mencatat diagnosis sebagai *birth before arrival*, maka gunakan kode seolah-olah persalinan terjadi di fasilitas kesehatan.
- Ibu dan bayi yang dirujuk dari fasilitas lain setelah melahirkan dengan kondisi bayinya yang sakit tetapi tidak memiliki komplikasi persalinan, dan dirawat untuk perawatan pasca persalinan, gunakan kode Z39.0 (*Care and examination immediately after delivery*).
- Ibu hanya dirawat untuk mendampingi bayi yang sakit tanpa menerima layanan perawatan pasca persalinan, maka gunakan kode Z76.3 (*Healthy person accompanying sick person*).

3.20.23 *Prophylactic Surgery (Z40.-)*

- Gunakan kode dari kelompok Z40.- (*Prophylactic surgery*) sebagai diagnosis utama bagi pasien yang menjalani tindakan operasi untuk tujuan preventif. Tidak perlu mencantumkan kode terkait penyakit yang ingin dicegah, mengingat penyakit tersebut belum terjadi atau belum terdiagnosis pada pasien.
- Kode dari grup Z40.- digunakan untuk mencatat bahwa prosedur operasi dilakukan sebagai upaya pencegahan, bukan sebagai respons terhadap kondisi medis yang sudah ada.
- Pendokumentasian membantu memberikan gambaran yang jelas tentang sifat preventif dari tindakan medis tersebut. Pendekatan ini memastikan bahwa rekam medis tetap akurat dan relevan, serta mendukung analisis data kesehatan tanpa menimbulkan asumsi keliru mengenai status klinis pasien saat ini. Ketepatan dalam penggunaan kode sangat penting untuk menjaga integritas informasi medis.

3.20.24 *Procedures For Purposes Other Than Remediating Health State (Z41.-)*

- Gunakan kode dari kelompok Z41.- (*Procedures for purposes other than remediating health state*) sesuai dengan diagnosis yang ditetapkan oleh dokter.
- Kode dari grup Z41.- secara khusus dirancang untuk mendokumentasikan prosedur medis yang dilakukan dengan tujuan di luar penanganan atau perbaikan kondisi kesehatan pasien. Contoh tindakan yang termasuk dalam kategori ini mencakup prosedur kosmetik, estetika, atau intervensi lain yang tidak bertujuan untuk mengobati penyakit atau gangguan medis tertentu.
- Penggunaan kode dari grup Z41.- memiliki peran penting dalam memastikan bahwa rekam medis mencerminkan dengan jelas alasan sebenarnya dari prosedur yang dilakukan. Hal ini membantu mencegah kesalahpahaman bahwa prosedur tersebut berkaitan dengan pengobatan atau penanganan kondisi patologis.
Contoh: jika seorang pasien menjalani operasi plastik untuk alasan estetika, bukan karena cedera atau cacat fisik, maka penggunaan kode

Z41.- akan menegaskan bahwa prosedur tersebut dilakukan semata-mata untuk tujuan non-medis.

- Dengan pendekatan ini, dokumentasi medis menjadi lebih akurat dan relevan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk analisis data kesehatan, perencanaan layanan medis, serta evaluasi tren terkait prosedur non-terapeutik. Ketelitian dalam memilih kode sangat diperlukan untuk memastikan bahwa informasi yang dicatat tidak hanya sesuai dengan situasi pasien, tetapi juga mendukung kebutuhan administrasi dan pelaporan medis secara menyeluruh. Hal ini juga membantu menjaga integritas data dalam sistem informasi kesehatan.

3.20.25 *Other Surgical Follow-Up Care (Z42-Z48)*

Ketika kode dalam kelompok Z42-Z48 digunakan, tidak perlu memberikan kode tambahan dari grup Z08-Z09. Berikut adalah panduan spesifik untuk penggunaan kode dalam grup Z42-Z48:

- Gunakan kode Z42.- (*Follow-up Care Involving Plastic Surgery*) apabila dokter memberikan layanan bedah plastik untuk memperbaiki bekas luka, setelah cedera sembuh sepenuhnya, atau untuk memperbaiki cacat estetika.

Contoh: Koreksi bekas luka, bedah rekonstruksi wajah.

Tidak termasuk: Bedah plastik untuk kondisi saat ini atau cedera aktif.

- Gunakan kode Z43.- (*Attention to Artificial Openings*) apabila dokter memberikan layanan terkait lubang buatan (*artificial openings*),
Contoh: Trakeostomi, gastrostomi, ileostomi, kolostomi, sistostomi, atau vagina buatan, menutup lubang buatan, membersihkan lubang buatan atau melepas selang dari lubang tersebut.

- Gunakan kode Z44.- (*Fitting and Adjustment of External Prosthetic Device*) apabila dokter memberikan layanan untuk memasang atau menyesuaikan alat prostetik eksternal.

Contoh: Lengan buatan, kaki buatan, mata buatan, atau payudara buatan

- Gunakan kode Z45.- (*Adjustment and Management of Implanted Device*) apabila dokter memberikan layanan untuk menyesuaikan atau mengelola alat implan.

Contoh: Alat pacu jantung (cardiac pacemaker), alat bantu dengar implan, atau port vena.

Tidak termasuk: Kasus kerusakan

- Gunakan kode Z46.- (*Fitting and Adjustment of Other Devices*) apabila dokter memberikan layanan untuk memasang atau menyesuaikan alat lain.

Contoh: Kacamata, lensa kontak, alat bantu dengar, gigi palsu, alat ortodontik, atau alat ortopedik (misalnya gips, sepatu khusus, atau kursi roda).

Tidak termasuk: Kerusakan alat atau komplikasi terkait alat tersebut.

- Gunakan kode Z47.- (*Other Orthopedic Follow-Up Care*) apabila dokter memberikan layanan tindak lanjut ortopedi lainnya.

Contoh: Melepas atau mengganti gips. Mengelola alat traksi atau fiksasi eksternal. Melepas alat internal seperti pin, pelat logam, atau sekrup.

Tidak termasuk: Pemasangan atau penyesuaian alat prostetik, fisioterapi, atau pemantauan patah tulang. Apabila episode perawatan hanya untuk pengangkatan fiksasi internal, kode diagnosis fraktur yang terkait tidak perlu digunakan

- Gunakan kode Z48.- (*Other Surgical Follow-Up Care*) apabila dokter memberikan layanan tindak lanjut bedah umum,

Contoh: Melepas jahitan. Mengganti perban atau balutan luka.

Tidak termasuk: Perawatan lubang buatan, penyesuaian alat, atau pemantauan pasca operasi.

3.20.26 *Care Involving Use Of Rehabilitation Procedures (Z50.-)*

Gunakan kode dari kelompok Z50.- (*Care involving use of rehabilitation procedures*) berdasarkan diagnosis yang ditetapkan oleh dokter.

- Kode dari grup Z50.- digunakan untuk mendokumentasikan layanan kesehatan yang mencakup prosedur rehabilitasi, seperti fisioterapi, terapi wicara, atau metode lain yang bertujuan membantu pemulihan fungsi fisik, mental, atau sosial pasien.
- Penggunaan kode dari grup Z50.- bertujuan untuk menegaskan bahwa perawatan yang diberikan difokuskan pada rehabilitasi, bukan pada penanganan kondisi medis akut atau penyakit tertentu.
- Pendokumentasian medis dapat secara jelas mencerminkan sifat dan tujuan intervensi yang dilakukan, sehingga mendukung perencanaan perawatan lebih lanjut serta evaluasi kemajuan pasien.

3.20.27 *Donors Of Organs And Tissues (Z52.-)*

Gunakan kode dari kelompok Z52.- (*Donors of organs and tissues*) sesuai dengan diagnosis yang diberikan oleh dokter.

- Kode dari grup Z52.- digunakan secara khusus untuk mendokumentasikan individu yang berperan sebagai donor organ atau jaringan.
- Penggunaan kode dari grup Z52.- bertujuan untuk mencatat secara rinci dan sistematis status seseorang sebagai donor, baik dalam konteks donor hidup maupun donor setelah meninggal dunia, serta jenis organ atau jaringan yang disumbangkan.
- Pengodean berperan penting dalam mencatat secara akurat dan terorganisir informasi proses donor, serta mendukung pelacakan data medis, koordinasi transplantasi, dan manajemen bank organ atau jaringan. Ketelitian pengodean diperlukan agar data dapat dimanfaatkan secara optimal untuk keperluan administrasi, penelitian, dan evaluasi program donor dan transplantasi guna meningkatkan sistem kesehatan terkait donor organ dan jaringan.

3.20.28 *Persons Encountering Health Services For Specific Procedures, Not Carried Out (Z53.-)*

Gunakan kode dari kelompok Z53.- (*Persons encountering health services for specific procedures, not carried out*) sesuai dengan alasan yang telah diidentifikasi oleh dokter.

- Prosedur yang dibatalkan atau ditunda karena adanya penyakit atau kondisi yang menjadi kontraindikasi medis, maka gunakan kode untuk penyakit atau kondisi tersebut sebagai diagnosis tambahan untuk memberikan gambaran lebih lengkap tentang situasi pasien.
- Kasus pasien rawat jalan yang tidak hadir saat dijadwalkan untuk pemeriksaan dan tidak ada informasi jelas mengenai alasannya, namun diasumsikan bahwa pasien memilih untuk tidak melanjutkan pemeriksaan, gunakan kode Z53.2 (*Procedure not carried out because of patient's decision for other and unspecified reasons*) sebagai diagnosis utama tunggal. Kode ini digunakan untuk mencatat secara spesifik bahwa prosedur tidak dilakukan karena keputusan dari pihak pasien, tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai alasan di baliknya.
- Penggunaan kode dari grup Z53.- bertujuan untuk mendokumentasikan secara akurat alasan pembatalan atau ketidakterlaksanaan prosedur medis, sehingga rekam medis mencerminkan konteks yang jelas terkait keputusan tersebut. Hal ini penting untuk mendukung analisis data kesehatan, perencanaan layanan medis, serta evaluasi tren dalam interaksi pasien dengan sistem pelayanan kesehatan.
- Ketelitian dalam pengodean sangat diperlukan untuk memastikan bahwa dokumentasi medis tetap relevan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan klinis maupun administratif.

3.20.29 Convalescence (Z54.-)

Gunakan kode dalam kelompok Z54.- (*Convalescence*) sesuai dengan jenis perawatan yang diterima pasien sebelum dirawat di fasilitas kesehatan saat ini.

3.20.30 Occupational Exposure To Risk Factors (Z57-Z58)

Gunakan kode dalam kelompok Z57.- (*Occupational exposure to risk factors*) atau kelompok Z58.- (*Problems related to physical environment*) sesuai dengan diagnosis dari dokter.

3.20.31 *Problems Related To Housing And Economic Circumstances (Z59)*

Gunakan kode dalam kelompok Z59.- (*Problems related to housing and economic circumstances*) sebagai kode diagnosis tambahan.

3.20.32 *Counselling Related To Sexual Attitude, Behavior And Orientation (Z70-Z71)*

Gunakan kode dalam kelompok Z70.- (*Counselling related to sexual attitude, behavior and orientation*) atau Z71. (*Person encountering health services for other than counselling and medical advice, not elsewhere classified*), sesuai dengan diagnosis dari dokter.

Contoh: Dokter mendiagnosis bahwa pasien datang untuk mendengarkan hasil pemeriksaan yang normal, berikan kode Z71.2 (*Person consulting for explanation of investigation findings*).

3.20.33 *Explanation Of Investigation Findings (Z71.2)*

Gunakan kode Z71.2 (*Explanation of investigation findings*) untuk mencatat bahwa pasien datang untuk mendengarkan hasil pemeriksaan yang normal atau untuk penjelasan hasil pemeriksaan tanpa temuan penyakit atau kelainan.

3.20.34 *Problems Related To Lifestyle (Z72.-)*

Gunakan kode dalam kelompok Z72.- (*Problems related to lifestyle*), sesuai diagnosis dokter, sebagai diagnosis tambahan.

3.20.35 *Problems Related To Life-Management Difficulty (Z73.-)*

Gunakan kode dalam kelompok Z73.- (*Problems related to life-management difficulty*), sesuai diagnosis dokter.

3.20.36 *Problems Related To Care-Provider Dependency (Z74.-)*

Gunakan kode dalam kelompok Z74.- (*Problems related to care-provider dependency*), sesuai diagnosis dokter.

3.20.37 *Problems Related To Medical Facilities And Other Health Care (Z75.-)*

Gunakan kode dalam kelompok Z75.- (*Problems related to medical facilities and other health care*), sesuai diagnosis dokter.

3.20.38 *Persons Encountering Health Services In Other Circumstances (Z76.-)*

- Diagnosis "resep ulang", maka gunakan kode Z76.0 (*Issue of repeat prescription*).
- Diagnosis "perawatan anak terlantar", maka gunakan kode Z76.1 (*Health supervision and care of foundling*).
- Diagnosis "perawatan bayi atau anak sehat" (misalnya, ibu sakit atau memiliki masalah lain), maka gunakan kode Z76.2 (*Health supervision and care of other healthy infant and child*).
- Diagnosis bahwa ibu sehat dirawat di rumah sakit untuk merawat anak yang sakit, maka gunakan kode Z76.3 (*Healthy person accompanying sick person*).

3.20.39 *Family History Of Certain Disabilities And Chronic Diseases Leading To Disablement (Z80-Z84)*

Gunakan kode dalam kelompok Z80-Z84, sesuai diagnosis dokter sebagai kode diagnosis tambahan.

3.20.40 *Personal History Of Malignant Neoplasm (Z85-Z88, Z91-Z92)*

Gunakan kode dalam kelompok Z85-Z88 atau Z91-Z92, sesuai diagnosis dokter. Misalnya jika pasien dirawat karena komplikasi akibat pengobatan kanker yang telah diobati hingga tidak ada sisa penyakit (sembuh), gunakan kode komplikasi tersebut sebagai diagnosis utama dan kode riwayat kanker (Z85.- (*Personal history of malignant neoplasm*)) sesuai jenis kanker yang pernah diderita sebagai diagnosis tambahan.

3.20.41 *Acquired Absence Of Limb (Z89-Z90)*

Gunakan kode dalam kelompok Z89.- (*Acquired absence of limb*) untuk anggota tubuh atau Z90.- (*Acquired absence of organs, not elsewhere classified*) untuk organ lainnya, sesuai dengan organ yang didiagnosis oleh dokter sebagai organ yang hilang baik karena cedera, operasi, atau kondisi medis lainnya.

3.20.42 Artificial Opening Status (Z93.-)

Gunakan kode dalam kelompok Z93.- (*Artificial opening status*), sesuai diagnosis dokter, sebagai kode diagnosis tambahan.

3.20.43 Transplanted Organ And Tissue Status (Z94.-)

Gunakan kode dalam kelompok Z94.- (*Transplanted organ and tissue status*) sesuai dengan diagnosis dokter sebagai diagnosis tambahan.

3.20.44 Presence Of Cardiac And Vascular Implants And Grafts (Z95.-)

Gunakan kode dalam kelompok Z95.- (*Presence of cardiac and vascular implants and grafts*) sesuai diagnosis dokter, sebagai kode diagnosis tambahan.

3.20.45 Presence Of Other Functional Implants (Z96-Z97)

Gunakan kode dalam kelompok Z96.- (*Presence of other functional implants*) dan Z97.- (*Presence of other devices*) sesuai diagnosis dokter, sebagai kode diagnosis tambahan.

Catatan Khusus:

Jika dokter mendiagnosis keberadaan alat kontrasepsi dalam rahim (IUD) secara tidak sengaja, misalnya pada kasus kehamilan dengan IUD, maka gunakan kode Z97.5 *Presence of (intrauterine) contraceptive device*.

3.20.46 Other Post Surgical Status (Z98.-)

Gunakan kode dalam kelompok Z98.- (*Other post surgical status*) sesuai diagnosis dokter, sebagai kode diagnosis tambahan.

3.20.47 Dependence On Enabling Machines And Devices, Not Elsewhere Classified (Z99)

Gunakan kode dalam kelompok Z99.- (*Dependence on enabling machines and devices, not elsewhere classified*), sesuai diagnosis dokter, sebagai kode diagnosis tambahan.

3.21 MDC 31 MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA

PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 31

- *Multiple significant trauma* merupakan kelompok diagnosis cedera pada regio luka lebih dari satu bagian tubuh. Sama seperti halnya pada MDC 33, kelompok *multiple significant trauma* tetap berlaku kaidah pengodean sesuai dengan kasus injuri/trauma yang membutuhkan sebab luar dan lokasinya.

- **Contoh :** pasien masuk dengan keluhan pasca jatuh dari pohon kelapa saat mengambil air nira untuk dibuat gula, terdapat luka terbuka pada tulang paha dan perdarahan aktif di kepala. Didiagnosis oleh dokter *traumatic subdural haemorrhage* dan *open fracture of shaft of femur*.

Kode DU : S06.5 (*Traumatic subdural haemorrhage*)

Kode DS : S72.391 (*Open Fracture of shaft of femur, unspecified*)^(IM)

Kode *External Cause* : W14.03 (*Fall from tree, home, while engaged in other types of work*).

- Kondisi *nonunion/malunion* fraktur dengan kondisi fraktur bersamaan. Kode *nonunion/malunion* fraktur merupakan salah satu kode yang di *exclude* pada ICD-10 chapter XIX. Jika episode perawatan merujuk pada kondisi untuk *malunion*, maka dikode M84.0- (*Malunion of fracture*) dan kode fraktur tidak dikode. (BA 2023)

- Dalam pengodean tindakan amputasi, penting untuk memastikan bahwa kode spesifik yang digunakan sesuai dengan lokasi amputasi. Penggunaan kode 84.91 (*Amputation, not otherwise specified*) seharusnya dihindari apabila informasi lokasi amputasi tersedia dalam dokumentasi medis.

- **Contoh:**

- Amputasi pada jari tangan selain ibu jari tangan, gunakan kode 84.01 (*Amputation and disarticulation of finger*).
- Amputasi pada ibu jari tangan, gunakan kode 84.02 (*Amputation and disarticulation of thumb*).

- Amputasi pada jari kaki, gunakan kode 84.11 (*Amputation of toe*).
- Dalam pengodean tindakan reduksi tertutup pada fraktur, penting untuk membedakan antara fraktur biasa dan fraktur yang melibatkan lempeng epifisis tulang yang terpisah. Kode 79.0- (*Closed reduction of fracture without internal fixation*) digunakan jika terdapat fraktur dengan lempeng epifisis yang terpisah pada hasil *imaging* dan laporan operasi. Sedangkan jika tidak ada lempeng epifisis yang terpisah, maka menggunakan kode 79.4- (*Closed reduction of separated epiphysis*).
- Dalam pengodean tindakan reduksi/manipulasi pada fraktur yang telah terpasang gips, gunakan kode 79.7- (*Closed reduction of dislocation*) dengan digit keempat mengikuti lokasi anatomis.
- Dalam pengodean tindakan pemasangan *cast*, penting untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan sesuai dengan laporan operasi atau tindakan yang memuat informasi ada atau tidaknya pemasangan *cast*. Jika tindakan yang dilakukan adalah *release clubfoot*, gunakan kode 83.84 (*Release of clubfoot, not elsewhere classified*). Jika dilakukan pemasangan *cast*, gunakan kode 93.53 (*Application of pressure dressing*).

PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 31

MDC CEDERA MULTIPLE

Dalam kasus terjadinya cedera di beberapa tempat secara bersamaan, dokter harus mencatat diagnosis semua cedera secara lengkap dan rinci. Cedera yang dianggap paling parah harus dicatat sebagai diagnosis utama, sedangkan cedera lainnya dicatat sebagai diagnosis tambahan.

Contoh 1-31	Pasien mengendarai mobil sedan dan menabrak pohon. Dokter mendiagnosis bahwa pasien mengalami kontusio serebral fokal (<i>focal cerebral contusion</i>), kehilangan kesadaran (<i>loss of consciousness</i>), amputasi traumatik telinga (<i>traumatic amputation of ear</i>), memar pada wajah, leher, dan kandung kemih (<i>contusion of face, neck, and bladder</i>), serta luka robek pada pipi dan paha (<i>laceration of cheek and thigh</i>).		
	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="443 2011 943 2016">Kesimpulan dokter</th><th data-bbox="943 2011 1511 2016">Coder memberi kode</th></tr> </table>	Kesimpulan dokter	Coder memberi kode
Kesimpulan dokter	Coder memberi kode		

Diagnosis utama	Kontusio serebral fokal	S06.3 <i>Focal brain injury</i>
Diagnosis tambahan	Kontusio serebral fokal Kehilangan kesadaran Amputasi traumatik telinga Laserasi pipi Laserasi paha Memar wajah Memar leher Memar bahu	S06.0 <i>Concussion</i> S08.1 <i>Traumatic amputation of ear</i> S01.40 <i>Open wound of cheek</i> ^(TM) S71.1 <i>Open wound of thigh</i> S00.8 <i>Superficial injury of other parts of head</i> S10.9 <i>Superficial injury of neck, part unspecified</i> S40.0 <i>Contusion of shoulder and upper arm</i>
Penyebab eksternal	Pengemudi mobil sedang terluka dalam tabrakan dengan benda tetap atau stasioner (pohon) dalam kecelakaan lalu lintas selama aktivitas yang tidak spesifik.	V47.59 <i>Car occupant injured in collision with fixed or stationary object</i>

3.21.1 Fracture of Skull and Facial Bones (S02.5)

Pemberi kode harus memberikan kode untuk semua lokasi cedera yang didiagnosis oleh dokter, serta menghindari penggunaan kode gabungan untuk cedera di beberapa tempat.

- Dalam contoh 1-31, terlihat bahwa pemberi kode memberikan kode untuk setiap lokasi cedera yang didiagnosis oleh dokter tanpa menggunakan kode S09.7 (*Multiple injuries of head*) atau kode T01.8 (*Open wounds involving other combinations of body regions*). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap cedera dicatat secara spesifik sesuai dengan lokasinya masing masing, sehingga diagnosis lebih rinci dan akurat.
- Fraktur tertutup pada rahang bawah merupakan kondisi yang jarang terjadi. Fraktur tertutup pada rahang bawah hanya ditemukan dalam kasus kasus tertentu, seperti fraktur di area *condyle* atau fraktur tanpa robekan gusi pada posisi tanpa gigi. Namun, jika terjadi fraktur tulang rahang bawah yang melalui soket gigi, dokter gigi harus mendiagnosis secara jelas bahwa fraktur tersebut adalah fraktur terbuka, karena adanya risiko kontaminasi dari rongga mulut.
- Fraktur rahang atas memiliki kriteria tersendiri, karena pola patahannya biasanya mengikuti garis horizontal pada tingkat berbeda,

seperti pada LeFort I, II, dan III. Fraktur ini biasanya tidak melewati area soket gigi, sehingga kemungkinan ditemukannya fraktur tertutup pada rahang atas lebih tinggi dibandingkan rahang bawah.

- Fraktur atau cedera pada gigi umumnya dikategorikan berdasarkan pedoman Andreasen, yang membagi cedera menjadi 4 kelompok:
 1. Cedera pada jaringan keras gigi dan jaringan dalam gigi
 2. Cedera pada jaringan periodontal
 3. Cedera pada jaringan lunak pendukung gigi (termasuk ligamen periodontal)
 4. Cedera pada jaringan lunak sekitar mulut (seperti bibir, lidah, atau gusi)
- Sindrom gigi retak (*cracked tooth syndrome*) adalah kondisi di mana pasien mengalami nyeri gigi akibat adanya retakan pada gigi. Istilah ini kadang digunakan dengan arti yang sama seperti fraktur gigi tidak lengkap (*incomplete tooth fracture*) atau *infracture enamel*, yaitu cedera pada jaringan keras dan jaringan dalam gigi yang tingkat keparahannya tergolong ringan. Fraktur jenis ini tidak melibatkan hilangnya jaringan keras gigi, sehingga berbeda dari jenis fraktur lainnya. Namun demikian, perlu dipertimbangkan apakah retakan tersebut menembus jaringan dalam gigi (pulpa). Jika menembus, disebut sebagai fraktur komplikata (*complicated fracture*). Jika tidak menembus, disebut sebagai fraktur tanpa komplikasi (*uncomplicated fracture*). Klasifikasi ini mirip dengan pembagian fraktur tulang menjadi fraktur terbuka (*open fracture*) dan fraktur tertutup (*closed fracture*).
- Dalam praktik klinis, terkadang dokter gigi mencatat diagnosis sebagai "*tooth fracture exposed pulp*", yang tidak sesuai dengan klasifikasi Andreasen maupun ICD-10. Oleh karena itu, harus ditentukan secara spesifik apakah fraktur terjadi pada mahkota gigi, akar gigi, atau kombinasi keduanya (*crownroot fracture*). Dalam proses pemberian kode diagnosis, informasi klinis yang rinci sangat diperlukan. Pemberi kode (coder) tidak dapat menentukan kode diagnosis yang akurat tanpa klarifikasi lebih lanjut dari dokter gigi. .

Oleh karena itu, komunikasi dengan dokter gigi untuk memastikan diagnosis sesuai dengan klasifikasi yang berlaku.

- Pada kasus fraktur tulang rahang, pemberi kode harus memberikan kode fraktur tulang rahang sebagai diagnosis utama. Untuk fraktur rahang atas, jika dokter gigi hanya mencatat diagnosis sebagai LeFort I, II, atau III *fracture*, maka pilih kode S02.420 (*Closed fracture of maxillary bone*) ^(IM) atau fraktur tertutup tulang maksila. Kode S02.421 (*Open fracture of maxillary bone*) ^(IM) atau fraktur terbuka tulang maksila hanya diberikan jika dokter gigi secara jelas menyatakan bahwa fraktur tersebut adalah fraktur terbuka.
- Pada kasus fraktur rahang bawah, pemberi kode harus mempertimbangkan lokasi fraktur sesuai diagnosis dokter gigi, seperti di *alveolar process, body, condyle, ramus, symphysis*, atau fraktur di beberapa lokasi. Pastikan apakah fraktur tersebut dinyatakan sebagai *closed fracture* atau *open fracture*. Jika tidak disebutkan secara spesifik, maka dianggap sebagai *closed fracture*.
- Pemeriksaan tambahan untuk gigi dan jaringan sekitar gigi dilakukan setelah memberikan kode untuk fraktur tulang rahang dengan memeriksa apakah ada catatan diagnosis tambahan mengenai cedera pada gigi atau jaringan periodontal. Untuk cedera pada gigi, gunakan kode dalam kelompok S02.5 (*Fracture of tooth*) [serta tambahkan kode untuk lateralisasi gigi \(KG11 - KG85\)](#). Untuk cedera pada jaringan periodontal, gunakan kode dalam kelompok S03.2 (*Dislocation of tooth*).
- Jika dokter gigi mendiagnosis *tooth fracture exposed pulp*, pemberi kode harus mengonfirmasi kembali kepada dokter gigi untuk mengetahui lokasi fraktur, apakah terjadi pada mahkota, akar, atau kombinasi keduanya (*crownroot fracture*), atau fraktur di beberapa lokasi.
- Kode untuk cedera jaringan lunak diberikan setelah memberikan kode untuk fraktur tulang rahang, cedera pada gigi, dan jaringan periodontal, selanjutnya pertimbangkan kode untuk cedera jaringan lunak, yang diklasifikasikan berdasarkan anatomi, seperti:

- S00.50 (*Superficial injury of internal cheek*) ^(IM) atau cedera superfisial pada pipi bagian dalam
- S00.51 (*Superficial injury of other parts of mouth, including tongue*) ^(IM) atau cedera superfisial pada bagian lain mulut, termasuk lidah
- S01.50 (*Open wound of oral cavity*) ^(IM) atau luka terbuka pada rongga mulut

3.21.2 Patah Tulang (Fracture) (S12, S22, S32, S42, S52, S62, S72, S82, S92)

Kode patah tulang yang disebabkan oleh faktor eksternal ditentukan berdasarkan lokasi patah tulang atau posisi tulang yang patah, jenis patah tulang apakah patah tulang terbuka atau tertutup, serta tipe atau karakteristik khusus dari patah tulang sesuai dengan diagnosis dokter. Jika dokter mencatat semua informasi secara lengkap sesuai standar, kode dapat diberikan dengan mudah. Namun, jika ditemukan bahwa catatan dokter tidak lengkap. Pemberi kode harus mencari informasi tambahan dari rekam medis. Jika diperlukan, pemberi kode harus berkonsultasi dengan dokter untuk meminta klarifikasi atau perbaikan diagnosis agar menjadi lebih lengkap dan sesuai standar. Hal ini penting untuk memastikan akurasi pengodean dan mendukung dokumentasi medis yang komprehensif.

Kode Prosedur untuk Perawatan Patah Tulang pada Anggota Tubuh (Ekstremitas):

78.5 *Internal fixation of bone without fracture reduction.*

Pemasangan alat metalik (seperti sekrup atau pelat) untuk menstabilkan tulang tanpa melakukan reposisi fraktur. Kasus patah tulang yang tidak bergeser dari posisinya (nondisplaced fracture).

79.0 *Closed reduction of fracture without internal fixation (CREF).*

Reposisi tulang secara eksternal tanpa operasi atau pemasangan alat fiksasi internal. Perawatan patah tulang pada anak-anak atau patah tulang di lengan yang dapat sembuh dengan bantuan gips saja.

79.1 *Closed reduction of fracture with internal fixation (CRIF)*

Reposisi tulang secara eksternal tanpa membuka tulang patah, namun memasukkan alat metalik (seperti sekrup, pelat, atau paku intramedular) melalui sayatan kecil di area yang tidak langsung berada di lokasi patah tulang. Prosedur ini minim invasif dan membantu tulang menyatu lebih cepat serta memberikan stabilitas yang kuat.

79.2 *Open reduction of fracture without internal fixation.*

Operasi untuk mereposisi tulang dengan membuka area patah tulang, tetapi tanpa menggunakan alat fiksasi internal seperti pelat atau sekrup. Kasus di mana ada hambatan dalam reposisi tulang secara normal, namun tidak memerlukan alat tambahan untuk stabilisasi.

79.3 *Open reduction of fracture with internal fixation (ORIF)*

Operasi untuk membuka area patah tulang, mereposisi tulang, dan memasang alat metalik (pelat, sekrup, atau paku intramedular) langsung di lokasi patah tulang untuk menstabilkannya. Fraktur kompleks atau fraktur dekat sendi yang membutuhkan stabilitas maksimal untuk penyembuhan yang optimal.

Kode prosedur untuk operasi patah tulang dan dislokasi dalam ICD-9-IM dan ICD-10 mencakup penjelasan kode operasi ICD-9-IM 79.6 (*Debridement of open fracture site*) yaitu pembersihan dan penanganan luka pada fraktur terbuka untuk mengurangi risiko infeksi pada tulang yang patah. Jika dokter mencatat bahwa operasi dilakukan menggunakan teknik MIPO (*Minimal Invasive Plate Osteosynthesis*) atau menggunakan alat *Carm*, ini menunjukkan bahwa prosedur tersebut adalah CRIF (*Closed Reduction of Fracture with Internal Fixation*).

Kode operasi dalam Grup 79 (*Reduction of Fracture and Dislocation*) harus selalu 4 digit. Digit keempat menunjukkan lokasi spesifik dari prosedur.

79.1 (*Closed reduction with internal fixation*) (CRIF)

79.3 (*Open reduction with internal fixation*) (ORIF).

Kode alat eksternal dan jenis fiksasi diperlukan sebagai kode tambahan untuk mencatat penggunaan alat eksternal fiksasi dan jenis fiksator jika informasi tersebut tersedia.

3.21.3 Fracture of Other Parts of Neck (S12.8)

Jika dokter mendiagnosis dislokasi tulang rawan *aritenoid*, kondisi ini dapat diberi kode S13.2 (*Dislocation of other and unspecified parts of neck*), yaitu kode untuk dislokasi lainnya atau cedera pada bagian leher yang tidak ditentukan secara spesifik. Jika dokter juga mencatat adanya kekambuhan dari kondisi ini, penting untuk mendokumentasikan secara rinci setiap gejala atau komplikasi tambahan yang menyertainya. Salah satu komplikasi serius yang dapat terjadi adalah kelumpuhan saraf laring, yang biasanya disebabkan oleh kerusakan atau cedera pada saraf perifer di area leher. Jika ditemukan diagnosis kelumpuhan saraf laring, maka perlu menambahkan kode S14.4 (*Injury of peripheral nerves of neck*) yang secara khusus menggambarkan cedera pada saraf tepi leher. Penambahan kode ini penting untuk mendokumentasikan kondisi pasien secara menyeluruh, memastikan penanganan medis yang tepat, serta memenuhi standar pelaporan internasional seperti ICD-10.

3.21.4 Ruptured, Slipped, and Herniated Disc (S13, S23, S33)

Kode ICD-10 tidak komprehensif. Semua jenis cedera Untuk cakram tulang belakang, hanya ada kode untuk trauma. Ruptur diskus intervertebralis, yang jarang terjadi

1. Jika dokter mendiagnosis cedera diskus serviks, gunakan kode S13.0 (*Traumatic rupture of cervical intervertebral disc*)
2. Jika dokter mendiagnosis cedera diskus toraks, gunakan kode S23.0 (*Traumatic rupture of thoracic intervertebral disc*)
3. Jika dokter mendiagnosis cedera diskus lumbal, gunakan kode S33.0 (*Traumatic rupture of lumbar intervertebral disc*)
4. Jika dokter mendiagnosis adanya herniasi diskus atau HNP tanpa mencatat penyebab cedera, berikan kode dari kelompok intervertebralis. kelainan diskus (M51.0 M51.3).

3.21.5 Sprain and Strain (S13, S23, S33, S43, S53, S63, S73, S83, S93)

Pemberi kode harus memeriksa apakah ada catatan tentang penyebab eksternal sebelum memberikan kode dalam Bab 19 ICD-10 IM (kode yang dimulai dengan huruf S). Jika dokter mendiagnosis *sprain of joint or ligament*, berikan kode sesuai lokasi sendi atau ligamen

1. Contoh *Sprain* pada Sendi:

- a. *Wrist sprain* (pergelangan tangan terkilir), gunakan kode S63.5 (*Sprain and strain of wrist*)
- b. *Ankle sprain* (pergelangan kaki terkilir), gunakan kode S93.4 (*Sprain and strain of ankle*)

2. Contoh *Sprain* pada Ligamen:

- a. *Sprain of MCL* (ligamen kolateral fibular/tibial lutut), gunakan kode S83.4 (*Sprain and strain involving (fibular) (tibial) collateral ligament of knee*).
- b. *Sprain of ACL* (*ligament cruciate anterior* lutut), gunakan kode S83.50 (*Avulsion of anterior cruciate ligament of knee*)^(IM).

Jika dokter mendiagnosis *strain of muscle and tendon* dan mencatat penyebab eksternal, maka kondisi ini dianggap sebagai cedera akut pada otot dan tendon, serta diberi kode sesuai lokasi otot atau tendon:

1. Contoh *Strain* pada Otot

- a. *Strain of quadriceps muscle of thigh* (regangan otot paha depan akibat terjatuh), gunakan kode S76.1 (*Injury of quadriceps muscle and tendon*).

2. Contoh Diagnosis dengan Penyebab Eksternal (Trauma)

Jika dokter mendiagnosis *strain* dengan mencatat penyebab eksternal, maka kondisi tersebut dianggap sebagai cedera akut pada otot atau tendon, dan kode diberikan sesuai lokasi spesifik:

a. Contoh *Neck Strain*

Neck strain dari kecelakaan mobil menabrak tiang listrik, gunakan kode S16 (*Injury of muscle and tendon at neck level*).

b. Contoh *Tendon Strain*

Strain of biceps tendon di area siku akibat lengan tertarik secara paksa, gunakan kode S46.2 (*Injury of muscle and tendon of other parts of biceps*).

3. Contoh Diagnosis tanpa Penyebab Eksternal (Trauma)

Jika dokter mendiagnosis *strain* tanpa mencatat penyebab eksternal, maka kondisi tersebut dianggap sebagai masalah nontraumatik (misalnya, ketegangan otot atau robekan tendon spontan), dan kode harus dicari dalam Bab 13 ICD 10 IM (kode yang dimulai dengan huruf M).

- a. *Muscle strain* (ketegangan otot tanpa trauma), gunakan kode M62.6 (*Muscle strain*)
- b. *Spontaneous rupture of flexor tendons* (robekan tendon fleksor spontan, gunakan kode M66.3 (*Spontaneous rupture of flexor tendons*)).

3.21.6 Injury Of Brachial Plexus (S14.3)

Cedera *plexus brachialis* sebagian besar disebabkan oleh kecelakaan. Ketika pasien datang untuk perawatan pada tahap awal setelah kecelakaan, yaitu pada fase cedera akut, berikan kode S14.3 (*Injury of brachial plexus*) sebagai diagnosis utama.

Setelah pasien melewati fase perawatan cedera akut, langkah selanjutnya adalah perawatan pemulihan untuk masalah yang muncul akibat cedera tersebut (seperti *neuropathic pain*, *monoplegia*, dan lain lain). Pada tahap ini, tidak perlu lagi memberikan kode dalam kelompok S14.3. Sebagai gantinya, gunakan kode untuk masalah yang menyebabkan pasien datang untuk perawatan, yang mungkin merupakan akibat lanjutan atau komplikasi dari cedera tersebut, sebagai diagnosis utama dan berikan kode T91.8 (*Sequelae of other specified injuries of neck and trunk*) sebagai diagnosis tambahan.

3.21.7 Cedera Sumsum Tulang Belakang (Spinal Cord Injury) (S24, S34, T90-T98)

Pada tahap awal setelah cedera (fase akut), gunakan kode dari Bab 19 (kode yang dimulai dengan huruf S) sebagai diagnosis utama. Berikan kode untuk kondisi patologis dan detail cedera sebagai diagnosis tambahan.

Sementara itu, pada fase lanjutan atau jika pasien datang untuk penanganan komplikasi serta sekuel (akibat lanjutan) dari cedera sebelumnya, gunakan kode dari Bab 19 (kode S) atau Bab 13 (kode M), tergantung pada kondisi spesifik yang sedang dihadapi. Misalnya, jika pasien mengalami kekakuan sendi atau gangguan fungsi sebagai akibat dari cedera lama, maka kode dari Bab 13 (M) dapat digunakan untuk mencerminkan kondisi kronis atau sekuel tersebut. Di sisi lain, jika komplikasi masih berkaitan langsung dengan cedera awal, seperti infeksi pada luka atau pembengkakan yang persisten, maka kode dari Bab 19 (S) tetap relevan. Pemilihan kode ini bertujuan untuk mencerminkan status klinis pasien saat ini dan memastikan bahwa dokumentasi medis sesuai dengan standar yang berlaku (ICD-10).

Setelah pasien melewati fase perawatan cedera akut, selanjutnya adalah perawatan untuk dampak lanjutan dari cedera sumsum tulang belakang (*sequelae of spinal injury*), seperti *neurogenic bladder*, *hemiplegia*, atau *quadriplegia* untuk pemulihan kondisi. Oleh karena itu, tidak perlu lagi memberikan kode untuk cedera tersebut. Gunakan kode untuk kondisi utama yang menjadi fokus perawatan saat ini sebagai diagnosis utama, dan gunakan kode T90-T98 (*Sequelae of injuries, of poisoning and of other consequences of external causes*) sebagai diagnosis tambahan.

3.21.8 Injuries To The Wrist And Hand (S60-S69)

Jika dokter mendiagnosis kontusio (memar) pada jari kelingking tanpa adanya kerusakan pada kuku, maka gunakan kode S60.0 (*Contusion of finger(s) without damage to nail*) untuk mencatat kondisi tersebut. Kode ini mencakup kontusio pada ibu jari atau jari lainnya yang tidak melibatkan kerusakan pada kuku. Penting untuk memastikan bahwa

deskripsi cedera sesuai dengan kriteria kode agar dokumentasi medis akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kasus lain yang memerlukan penetapan kode adalah ketika terdapat luka terbuka pada jari telunjuk yang disertai kerusakan pada kuku, maka gunakan kode S61.1 (*Open wound of finger(s) with damage to nail*), untuk menandai luka terbuka pada ibu jari atau jari lainnya dengan kerusakan pada kuku. Selain itu, jika dokter menemukan amputasi traumatik pada ibu jari, baik sebagian maupun seluruhnya, maka gunakan kode S68.0 (*Traumatic amputation of thumb (complete)(partial)*). Kode ini secara khusus dirancang untuk mencatat amputasi traumatik pada ibu jari.

Untuk fraktur pada falangs distal jari manis tanpa melibatkan cedera terbuka, kode yang tepat adalah S62.60 (*Close fracture of other finger*). Kode ini mencakup fraktur tertutup pada digit lain di tangan. Penetapan kode diagnosis harus dilakukan dengan hati-hati, memastikan bahwa informasi dari dokter sesuai dengan deskripsi kondisi yang terjadi.

3.21.9 Dislokasi Prostesis Hip (S73.0, T84.0)

Jika seorang dokter mendiagnosis dislokasi pada sendi pinggul buatan yang diakibatkan oleh cedera, maka kode diagnosis yang harus diberikan adalah S73.0 (*Dislocation of hip*), yang menandai dislokasi pada pinggul. Selain itu, perlu ditambahkan kode Z96.64, yang menunjukkan keberadaan prostesis sendi pinggul pada pasien. Kombinasi kedua kode tersebut memberikan informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi klinis pasien, baik terkait kejadian dislokasi maupun adanya riwayat pemasangan prostesis.

Apabila dokter menemukan bahwa kondisi pasien disebabkan oleh komplikasi mekanis dari sendi pinggul buatan, maka gunakan kode T84.0 (*Mechanical complication of internal joint prosthesis*). Kode ini digunakan secara khusus untuk mencatat adanya masalah atau komplikasi mekanis yang terjadi pada sendi prostetik internal. Penggunaan kode ini membantu mendokumentasikan situasi di mana

sendi buatan mengalami gangguan fungsional atau struktural yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

Pemberian kode diagnosis harus dilakukan dengan teliti dan sesuai dengan deskripsi kondisi medis yang diamati oleh dokter. Hal ini bertujuan untuk memastikan keakuratan dokumentasi medis serta mendukung proses klaim asuransi atau perencanaan perawatan selanjutnya. Dengan menggunakan kode yang tepat, tenaga medis dapat menyampaikan informasi yang jelas dan terstruktur mengenai kondisi pasien, sehingga mempermudah koordinasi antara berbagai pihak dalam sistem pelayanan kesehatan.

3.22 MDC 32 LUKA BAKAR

PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 32

Luka bakar dan korosi yang terjadi pada lokasi yang sama dengan beberapa tingkat keparahan harus dikodekan sesuai tingkat yang paling parah pada area tersebut, menggunakan kode dalam kategori T20-T32 (*Burn and Corrosion*).

Kode dari kategori T31.- (*Burns classified according to extent of body surface involved*) atau T32.- (*Corrosions classified according to extent of body surface involved*) harus ditetapkan sebagai kode tambahan dari kode dari kategori T20-T25 (*Burns and corrosions of external body surface, specified by site*). Jika luka bakar atau korosi melibatkan beberapa area tubuh atau didokumentasikan adanya persentase total luas permukaan tubuh yang terdampak, maka gunakan kode T29.- (*Burns and corrosions of multiple body regions*) sebagai kode utama.

Contoh 1-32	Pasien datang terkena luka bakar tingkat tiga pada tangan (2% dari permukaan tubuh). Dia terkena api unggun di perkemahan hutan pramuka, dirawat selama 3 hari dan dilakukan tindakan debridement 3x di ruang operasi untuk penanganan luka bakarnya.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Luka bakar tingkat tiga pada tangan (2% dari permukaan tubuh) dari api unggun di perkemahan hutan pramuka	T23.3 <i>Burn of third degree of wrist and hand</i>
Diagnosis Sekunder	-	T31.0 <i>Burns involving less than 10% of body surface</i> X03.89 <i>Exposure to controlled fire, not in building or structure, other specified area during unspecified activity</i>

Tindakan	Debridemen	86.22 <i>Excisional debridement of wound, infection, or burn</i> (dalam iDRG inputkan <i>multiplicity</i> kode dengan menuliskan 3 di kolom <i>multiplicity</i> atau menginput 86.22 sebanyak 3x)
-----------------	------------	--

- Informasi tambahan:

1. *Escharotomy* : Prosedur pembuatan sayatan pada area eskar (kulit kasar yang terbentuk akibat luka bakar thermal) dan merusaknya. Gunakan kode 83.15 (*Escharotomy*) ^(IM)
2. *Skin graft* : Penggunaan kode untuk *skin graft* disesuaikan dengan letak anatomi yang dilakukan *skin graft*

PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 32

3.22.1 Burns And Corrosions Of External Body Surface, Specified By Site (T20-T25)

Jika dokter memberikan diagnosis yang kurang rinci, misalnya hanya mencatat "*burn*" tanpa disertai keterangan lokasi, derajat luka, atau luas area luka bakar, maka pengode bertanggung jawab untuk konfirmasi kepada dokter. Diagnosis utama harus mencerminkan kondisi medis secara spesifik, seperti lokasi luka bakar (misalnya lengan, dada, atau tungkai) dan tingkat keparahannya (derajat satu, dua, atau tiga)

Perlu dicatat bahwa kode luka bakar yang merujuk pada luas area, seperti "*25% burn*", tidak boleh digunakan sebagai diagnosis utama. Kode semacam ini hanya berfungsi sebagai informasi tambahan untuk memberikan informasi tambahan terkait tingkat keparahan cedera, namun tetap harus disertai informasi yang lebih detail agar tidak menimbulkan ambiguitas dalam dokumentasi medis.

3.23 MDC 33 INJURIES, POISONING & CERTAIN OTHER CONSEQUENCES OF EXTERNAL CAUSES

PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 33

- Dalam kasus luka-luka atau keracunan yang disebabkan oleh faktor eksternal terdapat dalam kolom tabel obat-obatan untuk mengodekan kasus tersebut dengan menggunakan kode-kode berikut:
 - Kode yang sesuai dari kolom keracunan pada tabel obat-obatan dan bahan kimia ada pada seksi ketiga ICD-10 dan kode kekerasan sesuai yang terletak di Indeks Alfabetik dari Penyebab Eksternal pada seksi kedua.
 - Kode tambahan untuk tempat kejadian dan aktivitas juga ditetapkan sesuai dengan pedoman yang ada.

Contoh: seorang anak terjatuh dari tangga di sekolah saat sedang menuju ruang kelas, terdapat luka robek di pelipis kanan. Diberikan kode S01.8 (*Open wound of other parts of head*) sebagai diagnosis utama, ditambahkan sebab luarnya sebagai diagnosis sekunder W10.28 (*Fall on and from stairs and steps at School, other institution and public administrative area, While engaged in other specified activities*).

Contoh: laki-laki paruh baya patah tulang paha kanan tertutup setelah kecelakaan mengendarai sepeda motor menabrak mobil di jalan raya saat berangkat kerja. Diberikan kode S72.90 (*Fracture of femur, part unspecified, closed*) sebagai diagnosis utama, ditambahkan sebab luarnya sebagai diagnosis sekunder V23.42 (*Motorcycle rider injured in collision with car, pick-up truck or van, Driver injured in traffic accident, While working for income*).

- Catatan: Subdivisi karakter keempat berikut ini digunakan untuk kategori W00-Y34 kecuali Y06-Y07 untuk mengidentifikasi tempat kejadian penyebab eksternal yang relevan. Klasifikasi tambahan berikut disediakan untuk penggunaan opsional dalam posisi karakter tambahan dengan kategori V01-Y34 untuk menunjukkan aktivitas korban saat kejadian.
- Untuk kasus kecelakaan, lihat pada catatan sebelum blok kodenya. *The following fourth-character subdivisions are for use with categories V20-V28 :*

- .0 *Driver injured in nontraffic accident*
- .1 *Passenger injured in nontraffic accident*
- .2 *Unspecified motorcycle rider injured in nontraffic accident*
- .3 *Person injured while boarding or alighting*
- .4 *Driver injured in traffic accident*
- .5 *Passenger injured in traffic accident*
- .9 *Unspecified motorcycle rider injured in traffic accident*

PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 33

Ketika mengkode cedera, keracunan atau trauma lain (Bab XIX), penyebab eksternal (Bab XX) harus dicantumkan sebagai diagnosis sekunder untuk mengidentifikasi keadaan cedera, komplikasi, keracunan atau efek samping

Contoh:

Pasien dengan open fraktur radius distal sinistra akibat jatuh dari tempat tidur rumah

Diagnosis utama : S52.50 (*Closed fracture of lower end of radius*)

Diagnosis sekunder : W06.0 (*Fall involving bed, home*)

3.23.1 Poisoning By Drugs, Medicaments And Biological Substances (T36-T50)

Jika dokter mendiagnosis bahwa pasien mengalami keracunan akibat obat atau bahan kimia, gunakan kode pada kelompok T36 – T50 yang mencakup berbagai jenis zat penyebab keracunan. Selain itu, dokumentasikan penyebab eksternal (seperti keracunan disengaja, tidak disengaja, atau kontak dengan zat tertentu) dengan menggunakan kode dalam kelompok huruf X.

Akan tetapi, apabila dokter menegaskan bahwa pasien mengalami efek samping dari obat yang digunakan secara benar dan dalam dosis tepat, tidak perlu menggunakan kode dalam kelompok T36 – T50, karena kelompok tersebut hanya relevan untuk keracunan atau paparan berlebihan. Efek samping tersebut harus dikodekan sebagai diagnosis utama, dengan menggunakan kode yang spesifik untuk kondisi tersebut. Untuk melengkapi informasi ini, kode dalam kelompok huruf Y harus

digunakan sebagai penyebab eksternal, yang menunjukkan jenis obat yang menyebabkan efek samping. Pendekatan ini penting untuk membedakan antara keracunan akibat kesalahan penggunaan obat dengan reaksi tubuh yang tidak diinginkan meskipun obat digunakan sesuai prosedur.

Perbedaan yang jelas antara keracunan dan efek samping dalam pengodean medis sangat penting. Misalnya, keracunan seringkali menunjukkan adanya tindakan yang tidak sesuai, seperti overdosis atau paparan yang tidak disengaja, sehingga memerlukan penanganan darurat dan investigasi lebih lanjut. Di sisi lain, efek samping yang timbul dari penggunaan obat sesuai dosis menunjukkan respons biologis individu terhadap obat tersebut, yang mungkin memerlukan penyesuaian pengobatan atau pemantauan jangka panjang.

3.23.2 Angioedema (T78.3)

Jika seorang dokter mendiagnosis pasien dengan kondisi angioedema atau *Quincke's oedema*, maka pengodean medis yang tepat adalah T78.3 (*Angioneurotic oedema*). Kode ini mencakup kondisi pembengkakan akut pada lapisan kulit dalam atau jaringan subkutan, yang disebabkan oleh reaksi alergi atau faktor lain seperti keturunan.

Namun, perlu diperhatikan bahwa angioedema bukanlah kondisi yang homogen, sebab etiologinya beragam. Penyebabnya seperti reaksi alergi, efek samping obat, atau gangguan genetik seperti *angioedema hereditas*. Oleh karena itu, meskipun kode T78.3 digunakan sebagai diagnosis utama, penting untuk melengkapi dokumentasi dengan informasi tambahan yang menjelaskan faktor penyebab atau pemicu spesifik dari kondisi tersebut. Misalnya, jika angioedema disebabkan oleh reaksi alergi terhadap makanan tertentu atau obat-obatan, maka kode penyebab eksternal harus ditambahkan untuk memberikan konteks yang lebih jelas.

Penggunaan kode T78.3 juga harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan ambiguitas dalam dokumentasi medis. Dalam beberapa kasus, angioedema dapat menjadi gejala awal dari kondisi yang lebih serius, seperti anafilaksis, yang memerlukan penanganan darurat.

Jika dokter mencatat bahwa angioedema adalah bagian dari reaksi anafilaktik yang lebih luas, maka kode tambahan untuk anafilaksis (misalnya, T78.0) diperlukan untuk mencerminkan tingkat keparahan kondisi pasien sehingga sebagai kode tambahan. Perbedaan ini sangat penting, karena penanganan medis untuk angioedema yang berdiri sendiri berbeda dengan angioedema yang merupakan bagian dari reaksi sistemik seperti anafilaksis. Oleh karena itu, pengodean harus mencerminkan seluruh spektrum kondisi pasien untuk mendukung keputusan klinis yang tepat.

3.23.3 Post-Traumatic Wound Infection, Not Elsewhere Classified (T79.3)

Jika dokter mendiagnosis infeksi pada luka pasca operasi, gunakan kode T81.4 (*Infection following a procedure not elsewhere classified*) atau T85.7 (*Infection and inflammatory reaction due to other internal prosthetic devices, implants and grafts, not elsewhere classified*). Tambahkan kode penyebab eksternal dari kelompok Y60 – Y69 atau Y83 – Y84 yang menjelaskan konteks prosedur medis terkait.

Jika dokter mendiagnosis infeksi luka yang terjadi akibat trauma atau cedera, gunakan kode T79.3 (*Posttraumatic wound infection, not elsewhere classified*), dipasangkan dengan kode penyebab eksternal yang sesuai. Jika dokter mendiagnosis infeksi luka yang terjadi akibat kondisi medis tertentu seperti penyakit kulit, penyakit pembuluh darah, diabetes, atau luka dekubitus, pemilihan kode diagnosis harus disesuaikan dengan kondisi dasar pasien. Misalnya E11.5 untuk diabetes melitus tipe 2 dengan komplikasi sirkulasi perifer, I83.2 untuk varises ekstremitas bawah dengan ulkus dan inflamasi, L08.0 untuk pioderma, L08.8/L08.9 untuk infeksi lokal kulit dan jaringan subkutan, L89.- untuk ulkus dekubitus, atau R02 untuk gangren.

Oleh karena itu, dalam kasus dokter hanya mencatat diagnosis sebagai '*wound infection*', pemberi kode harus memeriksa informasi pasien dari rekam medis dan konfirmasi kepada dokter yang merawat untuk meminta diagnosis yang lebih rinci. Jika konfirmasi tidak dapat dilakukan atau tidak ditemukan informasi tambahan, gunakan kode T79.3 (*Posttraumatic wound infection, not elsewhere classified*),

dipasangkan dengan kode penyebab eksternal yang sesuai. Dalam kasus yang tidak mencantumkan informasi tentang penyebab eksternal, gunakan kode X59.99 (*Exposure to unspecified factor at unspecified place during unspecified activity*) sebagai kode penyebab eksternal.

3.23.4 Compartment Syndrome (T79.6, M62.2)

Jika dokter mendiagnosis *compartment syndrome* tanpa memberikan rincian apakah kondisi tersebut disebabkan oleh cedera atau tidak, maka pemberi kode perlu memastikan klarifikasi lebih lanjut. Namun, jika diagnosis dokter secara eksplisit menyebutkan *traumatic compartment syndrome* atau *Volkmann's ischemic contracture*, maka kode yang tepat adalah T79.6 (*Traumatic ischaemia of muscle*), yang merujuk pada iskemia otot akibat trauma. Tambahkan kode penyebab eksternal sebagai diagnosis sekunder, misalnya cedera fisik seperti fraktur, luka terbuka, atau kompresi jaringan lunak

Sebaliknya, jika dokter mendiagnosis *nontraumatic compartment syndrome*, maka kode yang digunakan adalah M62.2 (*Ischaemic infarction of muscle*), yang merujuk pada infark iskemik otot. Kondisi ini biasanya bukan disebabkan oleh trauma langsung, melainkan oleh faktor-faktor lain seperti gangguan sirkulasi darah, trombosis, atau kondisi sistemik seperti penyakit vaskular.

Perbedaan antara *compartment syndrome traumatik* dan *non traumatik* dalam pengodean medis memiliki implikasi yang signifikan dalam praktik klinis dan manajemen data kesehatan. *Traumatic compartment syndrome* seringkali memerlukan intervensi darurat untuk mencegah kerusakan permanen pada otot dan saraf, sedangkan *non traumatic compartment syndrome* mungkin memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebab mendasar seperti gangguan vaskular atau metabolik.

3.23.5 Mechanical Complication of Internal Fixation Device of Bones of Limb (T84.1)

- *Fatigue failure of implant/device without radiographic bone healing*, gunakan kode T84.1 (*Mechanical complication of internal fixation*)

device of bone of limb) sebagai diagnosis utama dan kode Y79.2 (*Orthopaedic devices associated with adverse incidents (prosthetic and other implants, materials and accessory devices)*) sebagai penyebab eksternal, tanpa memberikan kode untuk patah tulang.

- *Fatigue failure of implant/device with nonunion of bone*, gunakan kode T84.1 (*Mechanical complication of internal fixation device of bone of limb*) sebagai diagnosis utama, kode M96.0 (*Pseudarthrosis after fusion or arthrodesis*) sebagai diagnosis tambahan, dan kode Y79.2 (*Orthopaedic devices associated with adverse incidents (prosthetic and other implants, materials and accessory devices)*) sebagai penyebab eksternal.
- *Loaded failure of implant/device without radiographic bone healing*, gunakan kode T84.1 (*Mechanical complication of internal fixation device of bone of limb*) sebagai diagnosis utama dan berikan kode penyebab eksternal sesuai dengan kejadian yang terjadi.
- *Loaded failure of implant/device after bone union*, gunakan kode T84.1 (*Mechanical complication of internal fixation device of bone of limb*) sebagai diagnosis utama, kode untuk patah tulang saat ini sebagai diagnosis tambahan, dan berikan kode penyebab eksternal sesuai dengan kecelakaan yang terjadi.

3.23.6 Infection and Inflammatory Reaction due to Internal Fixation Device [Any Site] (T84.6)

Jika seorang dokter mendiagnosis infeksi yang terjadi setelah pemasangan fiksasi internal (seperti implan atau alat ortopedi lainnya), maka pengodean medis harus menggunakan T84.6 sebagai diagnosis utama. Tambahkan kode penyebab eksternal Y83.1 (*Surgical operation with implant of artificial internal device*) harus digunakan, yang menunjukkan bahwa infeksi tersebut berkaitan dengan operasi bedah yang melibatkan implantasi perangkat internal buatan.

Namun, jika infeksi terjadi pada luka atau tulang setelah pemasangan alat fiksasi eksternal (*external fixation*), yang biasanya digunakan untuk menangani patah tulang terbuka, maka infeksi tersebut dianggap sebagai infeksi luka akibat trauma dan gunakan kode T79.3

(*Post-traumatic wound infection, not elsewhere classified*) sebagai diagnosis utama. Selain itu, kode penyebab eksternal harus ditambahkan sesuai dengan jenis cedera yang menjadi penyebab utama pemasangan fiksasi eksternal.

Infeksi setelah fiksasi internal umumnya dihubungkan dengan komplikasi prosedur medis, sedangkan infeksi setelah fiksasi eksternal lebih erat kaitannya dengan trauma awal yang dialami pasien.

3.23.7 Reaksi Penolakan atau Gagalnya Transplantasi Kornea (T85.3, T85.7, T86.8)

Jika dokter mencatat terjadi reaksi penolakan transplantasi kornea sebagai diagnosis utama, maka pemberi kode harus memberikan kode yang secara spesifik merujuk pada kondisi tersebut. Selain itu, untuk melengkapi informasi medis, kode Z94.7 (*Corneal transplant status*) harus digunakan sebagai diagnosis tambahan, yang menunjukkan status pasien setelah menjalani transplantasi kornea.

Selain diagnosis utama dan tambahan, penyebab eksternal juga perlu dicantumkan untuk mendokumentasikan faktor yang berkontribusi terhadap komplikasi pasca-transplantasi. Dalam hal ini, kode Y83.8 (*Other surgical procedures*) digunakan untuk menunjukkan bahwa penolakan transplantasi atau komplikasi lanjutan adalah hasil dari prosedur bedah lainnya, tanpa adanya indikasi kesalahan selama prosedur. Penggunaan kode ini membantu membedakan antara komplikasi yang disebabkan oleh proses alami tubuh, seperti reaksi imunologis, dengan komplikasi yang mungkin disebabkan oleh kesalahan medis.

3.23.8 Penyebab Eksternal

3.23.8.2 Exposure to Inanimate Mechanical Forces (W20-W49)

- Cedera akibat peralatan olahraga (contoh: bola golf, tongkat golf, bola bowling, stik hoki) menggunakan kode W21. (*Striking against or struck by sports equipment*).

- Kecelakaan akibat menabrak atau tertabrak benda mati (contoh: tembok, tiang listrik) menggunakan kode W22. (*Striking against or struck by other objects*).
- Cedera dari peluru jenis lain (misal: senapan angin, pistol BB, kembang api) atau jika jenis peluru tidak diketahui, gunakan kode W34. (*Discharge from other and unspecified firearms*).
- Cedera akibat ledakan bahan peledak, alat militer, atau benda lain, gunakan kode W40. (*Explosion of other materials*).

3.23.8.3 Exposure to Animate Mechanical Forces (W50-W64)

- Cedera akibat kecelakaan yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain, seperti tertendang secara tidak sengaja saat bermain sepak bola, terkena pukulan atau gigitan tanpa niat jahat, gunakan kode W50. (*Hit, struck, kicked, twisted, bitten or scratched by another person*)
- Kasus kekerasan yang disengaja oleh orang lain, gunakan kode X85 – Y09 (*Intentional selfharm atau assault*).
- Cedera akibat terjepit, terinjak, atau terdorong oleh kerumunan manusia, gunakan kode W52. (*Crushed, pushed, or stepped on by crowd or human stampede*).
- Cedera akibat gigitan atau serangan hewan (misal: tikus, anjing, serangga tidak berbisa, reptil tidak berbisa, atau hewan laut) menggunakan kode W53–W59 sesuai jenis hewan.
 - Cedera akibat digigit anjing, gunakan kode W54. (*Bitten by dog*)
 - Cedera akibat digigit mamalia selain tikus dan anjing (misal: kucing, kerbau, kuda, harimau, atau gajah), gunakan kode W55. (*Bitten or struck by other mammals*), tetapi tidak termasuk mamalia laut (misal: paus atau lumba-lumba), yang menggunakan kode W56. (*Contact with marine animal*).
 - Cedera akibat hewan laut dan juga hewan air tawar, gunakan kode W56. (*Contact with marine animal*)

- Gigitan atau sengatan serangga tidak berbisa (misal: belalang, nyamuk), gunakan kode W57. (*Bitten or stung by nonvenomous insect and other nonvenomous arthropods*)
- Cedera akibat gigitan atau serangan buaya, gunakan kode W58. (*Bitten or struck by crocodile or alligator*)
- Cedera akibat reptil tidak berbisa seperti ular piton atau biawak, gunakan kode W59. (*Bitten or crushed by other reptiles*)

Pastikan kode disesuaikan dengan detail penyebab, lokasi, dan aktivitas yang tercatat dalam diagnosis dokter.

- Cedera akibat kontak dengan duri tumbuhan atau daun tajam, gunakan kode W60. (*Contact with plant thorns and spines and sharp leaves*). Pastikan kode disesuaikan dengan detail penyebab, lokasi, dan aktivitas yang tercatat dalam diagnosis dokter.
- Cedera akibat kontak dengan hewan seperti belut listrik, gunakan kode W64. (*Exposure to other and unspecified animate mechanical forces*). Pastikan kode disesuaikan dengan detail penyebab, lokasi, dan aktivitas yang tercatat dalam diagnosis dokter.

3.23.8.4 Accidental Drowning and Submersion (W65-W74)

- Tenggelam saat berada di dalam bak mandi, gunakan kode penyebab eksternal W65. (*Drowning and submersion while in bathtub*). Jika tenggelam setelah jatuh ke dalam bak mandi, gunakan kode penyebab eksternal W66. (*Drowning and submersion following fall into bathtub*).
- Tenggelam saat berada di kolam renang, gunakan kode penyebab eksternal W67. (*Drowning and submersion while in swimming pool*). Jika tenggelam setelah jatuh ke dalam kolam renang, gunakan kode penyebab eksternal W68. (*Drowning and submersion following fall into the swimming pool*).
- Jika tenggelam saat berada di air, gunakan kode penyebab eksternal W69. (*Drowning and submersion while in natural*

water). Jika tenggelam setelah jatuh ke dalam air, gunakan kode penyebab eksternal W70. (*Drowning and submersion following fall into natural water*).

- Tenggelam di tempat lain (misalnya di waduk, tangki air), gunakan kode penyebab eksternal W73. (*Other specified drowning and submersion*).
- Jika dokter tidak menyebutkan lokasi tenggelam, maka gunakan kode penyebab eksternal W74. (*Unspecified drowning and submersion*). Pastikan detail lokasi dan aktivitas tercatat dengan jelas untuk memilih kode yang sesuai.

3.23.8.5 Other Accidental Threats to Breathing (W75-W84)

- Jika kesulitan bernafas disebabkan oleh kecelakaan di tempat tidur, seperti seprai yang melilit leher, bantal menutupi hidung, atau ibu yang menindih bayi (korban sering kali adalah bayi), gunakan kode penyebab eksternal W75. (*Accidental suffocation and strangulation in bed*).
- Jika cedera disebabkan oleh jeratan leher akibat kecelakaan lain, gunakan kode W76. (*Other accidental hanging and strangulation*).
- Kondisi kekurangan oksigen akibat tertimbun tanah, lumpur, atau material lain yang menutupi tubuh (bukan bencana alam seperti gempa bumi), gunakan kode penyebab eksternal W77. (*Threat to breathing due to cave-in, falling earth and other substances*).
- Kekurangan oksigen atau kesulitan bernapas akibat tersedak muntah atau isi lambung yang masuk ke saluran pernapasan, gunakan kode penyebab eksternal W78. (*Inhalation of gastric contents*).
- Kekurangan oksigen atau kesulitan bernapas akibat tersedak atau menelan makanan, seperti permen, potongan buah, atau tulang yang menyumbat saluran pernapasan, gunakan kode penyebab eksternal W79. (*Inhalation and ingestion of food causing obstruction of respiratory tract*).

- Kekurangan oksigen atau kesulitan bernapas akibat tersedak atau menelan benda asing lainnya, seperti koin atau gigi palsu, yang menyumbat saluran pernapasan, gunakan kode penyebab eksternal W80. (*Inhalation and ingestion of other objects causing obstruction of respiratory tract*).
- Kekurangan oksigen akibat terjebak di lingkungan dengan kadar oksigen rendah, seperti terperangkap di ruangan tanpa ventilasi atau menyelam dengan pasokan udara yang tidak mencukupi, gunakan kode penyebab eksternal W81. (*Confined to or trapped in a low-oxygen environment*).
- Kekurangan oksigen disebabkan oleh kecelakaan akibat kantong plastik menutupi kepala, gunakan kode penyebab eksternal W82. (*Other specified threats to breathing*).

Catatan : Pastikan detail kejadian dan penyebab dicatat secara jelas untuk memilih kode yang sesuai.

3.23.8.6 Exposure to Electric Current, Radiation and Extreme Ambient Air Temperature and Pressure (W85-W99)

- Kasus pajanan disebabkan oleh kontak dengan kabel transmisi listrik, gunakan kode penyebab eksternal W85. (*Exposure to electric transmission lines*).
- Kasus pajanan disebabkan oleh faktor lain, seperti hubungan arus pendek dari perangkat listrik, gunakan kode W86. (*Exposure to other specified electric current*). Jika informasi hanya menyebutkan "tersengat listrik" tanpa rincian lebih lanjut, gunakan kode W87. (*Exposure to unspecified electric current*).
- Kasus pajanan terhadap radiasi pengion, seperti sinar gamma atau sinar X, gunakan kode W88 (*Exposure to ionizing radiation*).
- Kasus pajanan terhadap cahaya buatan manusia dan sinar ultraviolet, termasuk cahaya las atau lampu pengelasan logam, gunakan kode W89. (*Exposure to man-made visible and ultraviolet light*).

- Cedera akibat radiasi inframerah, laser, atau gelombang radio, gunakan kode W90. (*Exposure to nonionizing radiation*).
- Kontak dengan panas berlebih yang dihasilkan oleh manusia, bukan yang terjadi secara alami, gunakan kode W92. (*Exposure to excessive heat of man-made origin*)
- Kontak dengan dingin ekstrem yang dihasilkan oleh manusia, seperti nitrogen cair, es kering, atau paparan berkepanjangan di ruang pendingin, gunakan kode W93. (*Exposure to excessive cold of man-made origin*).
- Cedera akibat tekanan udara tinggi atau rendah, atau perubahan tekanan udara, seperti penyelaman mendadak ke kedalaman tertentu, naik ke permukaan air dengan cepat, tinggal di dataran tinggi dalam waktu lama, atau perubahan mendadak pada tekanan udara saat penerbangan, gunakan kode W94. (*Exposure to high and low air pressure and changes in air pressure*). Pastikan detail kejadian, lokasi, dan aktivitas dicatat dengan jelas untuk memilih kode yang sesuai.

3.23.8.7 Exposure to Smoke, Fire and Flames (X00-X09)

- Cedera disebabkan oleh kebakaran bangunan atau struktur (baik karena terbakar, menghirup asap, tertimpa reruntuhan, melompat, atau tertabrak benda yang jatuh), gunakan kode penyebab eksternal X00. (*Exposure to uncontrolled fire in building or structure*).
- Cedera disebabkan oleh kebakaran di luar bangunan atau kebakaran hutan, gunakan kode X01. (*Exposure to uncontrolled fire, not in building or structure*).
- Cedera terjadi akibat kontak dengan api yang terkendali di dalam bangunan atau struktur (misalnya api di perapian atau kompor), gunakan kode X02. (*Exposure to controlled fire in building or structure*).
- Cedera terjadi akibat kontak dengan api yang terkendali di luar bangunan (misalnya api unggun), gunakan kode X03. (*Exposure to controlled fire, not in building or structure*).

- Cedera disebabkan oleh kontak dengan zat mudah terbakar seperti bahan bakar, gunakan kode X04. (*Exposure to ignition of highly flammable material*).
- Cedera disebabkan oleh pakaian tidur yang terbakar atau meleleh, gunakan kode X05. (*Exposure to ignition or melting of nightwear*).
- Cedera disebabkan oleh pakaian lain atau aksesoris yang terbakar atau meleleh, gunakan kode X06. (*Exposure to ignition or melting of other clothing and apparel*).

3.23.8.8 Contact with Heat and Hot Substances (X10-X19)

- Kecelakaan akibat kontak dengan minuman panas, makanan panas, lemak panas, atau minyak goreng panas, baik akibat menyentuh, tumpah, percikan, atau menelan, gunakan kode X10. (*Contact with hot drinks, food, fats and cooking oils*).
- Kecelakaan akibat air panas di bak mandi atau keran air panas, gunakan kode X11. (*Contact with hot tap-water*).
- Kecelakaan disebabkan oleh cairan panas lainnya (misalnya air mendidih di panci), gunakan kode yang sesuai berdasarkan jenis cairan tersebut. Pastikan detail kejadian, lokasi, dan aktivitas dicatat dengan jelas untuk memilih kode yang tepat.
- Kecelakaan disebabkan oleh kontak dengan logam cair, gunakan kode X12. (*Contact with other hot fluids*).
- Paparan terhadap uap air panas atau gas panas, gunakan kode X13. (*Contact with steam and hot vapours*).
- Cedera disebabkan oleh angin panas atau gas panas, gunakan kode X14. (*Contact with hot air and gases*).
- Cedera akibat kontak dengan alat rumah tangga panas seperti kompor, peralatan dapur, ketel air, alat listrik, atau bohlam lampu, gunakan kode X15. (*Contact with hot household appliances*).
- Cedera disebabkan oleh kontak dengan pemanas, radiator, atau pipa air panas, gunakan kode X16. (*Contact with hot heating appliances, radiators and pipes*).

- Cedera akibat kontak dengan mesin, peralatan mekanis, atau alat yang panas, termasuk pipa knalpot, gunakan kode X17. (*Contact with hot engines, machinery and tools*).

3.23.8.9 Contact with Venomous Animals and Plants (X20-X29)

- Kode penyebab eksternal dalam kelompok X20 – X29 digunakan untuk kasus gigitan, sengatan, atau kontak dengan hewan atau tumbuhan beracun. Namun, tidak termasuk keracunan yang disebabkan oleh konsumsi hewan atau tumbuhan beracun, seperti ikan buntal atau jamur beracun. Pilih kode sesuai jenis hewan atau tumbuhan beracun yang disebutkan dokter, misalnya: Ular, labalaba beracun, kalajengking, tawon, lebah, kelabang, semut, Atau hewan dan tumbuhan laut seperti karang, ubur ubur.
- Kasus gigitan ular laut yang beracun, gunakan kode X20. (*Contact with venomous snakes and lizards*), sama seperti ular berbisa di darat. Jika dokter tidak mencatat jenis hewan atau tumbuhan yang menyebabkan kontak, gunakan kode X29. (*Contact with unspecified venomous animal or plant*). Pastikan detail kejadian, lokasi, dan aktivitas dicatat dengan jelas untuk memilih kode yang tepat.

3.23.8.10 Exposure to Forces of Nature (X30-X39)

Jika dokter mencatat bahwa cedera pasien disebabkan oleh kekuatan alam, pengodean penyebab eksternal harus menggunakan kode dalam kelompok X30 – X39, sesuai dengan jenis kekuatan alam yang terlibat. Penting untuk memastikan bahwa informasi terkait kejadian, lokasi, dan aktivitas korban saat cedera terjadi dicatat secara rinci. Hal ini diperlukan agar kode yang dipilih benar-benar mencerminkan kondisi yang menyebabkan cedera. Misalnya, jika korban mengalami cedera saat berada di kendaraan yang terjatuh dari jalan akibat angin badai, maka kejadian ini tidak dikategorikan sebagai kecelakaan transportasi, melainkan sebagai dampak dari badai. Dalam hal ini,

kode penyebab eksternal yang tepat adalah X37, yaitu (*Victim of cataclysmic storm*) karena badai adalah penyebab utama cedera.

Untuk kasus cedera akibat tsunami, penting untuk memahami bahwa kejadian ini dianggap disebabkan oleh gempa bumi, bukan oleh gelombang besar itu sendiri. Oleh karena itu, kode penyebab eksternal yang digunakan adalah X34.1 (*Victim of tsunami*). Pengklasifikasian ini didasarkan pada pemahaman bahwa tsunami merupakan konsekuensi dari aktivitas seismik, seperti gempa bumi, sehingga lebih tepat dikategorikan sebagai dampak dari gempa daripada fenomena gelombang semata. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa dokumentasi medis mencerminkan penyebab mendasar dari cedera, sehingga analisis data kesehatan dapat dilakukan secara lebih akurat.

Penggunaan kode penyebab eksternal yang tepat sangat penting untuk mendukung dokumentasi medis yang komprehensif dan akurat. Kode-kode ini tidak hanya membantu tenaga medis dalam memahami konteks cedera tetapi juga memfasilitasi pelaporan statistik yang dapat digunakan untuk analisis epidemiologi dan mitigasi bencana. Misalnya, data yang diperoleh dari penggunaan kode X37 atau X34.1 dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola cedera yang sering terjadi selama bencana alam tertentu. Informasi ini kemudian dapat digunakan untuk merancang strategi pencegahan dan penanganan yang lebih efektif, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko bencana atau memperkuat infrastruktur untuk mengurangi dampaknya.

Selain itu, penting bagi pemberi kode untuk bekerja sama dengan dokter dan tenaga medis lainnya guna memastikan bahwa semua informasi relevan telah dicatat dengan lengkap. Ketidakjelasan dalam deskripsi kejadian atau penyebab cedera dapat menyebabkan penggunaan kode yang tidak tepat, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas dokumentasi medis dan keputusan klinis. Oleh karena itu, pelatihan rutin dan pembaruan

pengetahuan tentang sistem pengodean sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat memiliki pemahaman yang sama tentang kriteria dan prosedur pengodean. Dengan demikian, dokumentasi medis tidak hanya akurat tetapi juga dapat digunakan sebagai alat yang andal untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan respons terhadap bencana alam.

3.23.8.11 Accidental Poisoning by and Exposure to Noxious Substances (X40-X49)

Pengodean untuk pasien yang mengalami keracunan melibatkan dua elemen penting yang harus dicatat secara bersamaan. Pertama adalah kode diagnosis, yang terdapat dalam Bab 19, dan kedua adalah kode penyebab eksternal, yang termasuk dalam Bab 20. Kedua kode ini saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi pasien, termasuk jenis zat yang menyebabkan keracunan serta konteks atau kejadian yang mendasari kejadian tersebut. Dengan menggunakan kedua kode ini, tenaga medis dapat memastikan bahwa dokumentasi medis mencerminkan situasi secara akurat.

Untuk menemukan kode yang sesuai, pemberi kode dapat merujuk pada tabel alfabetis obat dan zat kimia yang terdapat dalam *Section 3* buku ICD-10 volume 3. Tabel ini dirancang untuk membantu identifikasi kode diagnosis dan penyebab eksternal dengan lebih mudah berdasarkan jenis zat yang terlibat. Penggunaan tabel ini sangat penting untuk memastikan ketepatan pengodean, sehingga data yang dihasilkan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut, seperti pelaporan statistik kesehatan atau evaluasi risiko terkait obat dan bahan kimia. Ketelitian dalam memilih kode dari tabel ini akan mendukung kualitas dokumentasi medis dan keakuratan informasi yang direkam.

3.23.8.12 Overexertion, Travel and Privation (X50-X57)

- Cedera disebabkan oleh aktivitas fisik yang berlebihan atau gerakan berulang, seperti mengangkat beban berat,

mendayung, atau berlari marathon, gunakan kode X50. (*Overexertion and strenuous or repetitive movements*).

- Cedera disebabkan oleh kekurangan makanan atau air minum, gunakan kode X53. (*Lack of food*) atau X54. (*Lack of water*). Kondisi ini biasanya terkait dengan kelaparan, tetapi tidak termasuk kasus kelalaian diri sendiri atau orang lain.

3.23.8.13 Intentional Self-Harm (X60-X84)

- Keracunan diri sendiri dengan obat atau zat kimia, baik melalui konsumsi atau suntikan, maka gunakan kode penyebab eksternal dalam kelompok X60 – X69 sesuai jenis obat atau zat kimia yang dicatat dokter. Kode ini dapat ditemukan dalam tabel alfabetis obat dan zat kimia di buku ICD-10 IM berdasarkan nama generik atau kelompok obat/zat kimia.
- Upaya bunuh diri dengan gas buang kendaraan, gunakan kode X67. (*Intentional self poisoning by and exposure to other gases and vapours*).
- Upaya bunuh diri dengan pestisida, gunakan kode X68. (*Intentional self poisoning by and exposure to pesticides*), termasuk herbisida, fungisida, insektisida, racun tikus, penghilang rayap, dan bahan pengawet kayu.
- Upaya bunuh diri dengan senjata api diklasifikasikan berdasarkan jenis peluru yang digunakan.
 - Peluru pistol, gunakan kode X72. (*Intentional self harm by handgun discharge*).
 - Peluru senapan atau senapan laras panjang, gunakan kode X73. (*Intentional self harm by rifle, shotgun*). Pastikan informasi tentang metode, lokasi, dan aktivitas dicatat dengan jelas untuk memilih kode yang sesuai.
 - Jika jenis peluru tidak diketahui, gunakan kode X74.- (*Intentional self-harm by other and unspecified firearm discharge*).
- Upaya bunuh diri dengan cara melompat atau berbaring di depan objek yang sedang bergerak, atau dengan cara

menabrakkan diri ke kendaraan atau tertabrak kendaraan, hal ini tidak dianggap sebagai kecelakaan transportasi.

- Jika korban melompat atau berbaring di depan objek yang sedang bergerak, gunakan kode X81.- (*Intentional self-harm by jumping or lying before moving object*).
- Jika korban mencoba bunuh diri dengan cara menabrakkan diri ke kendaraan bermotor, gunakan kode X82.- (*Intentional self-harm by crashing of motor vehicle*).

Pastikan untuk mencatat detail metode dan kejadian secara jelas agar kode yang dipilih sesuai dengan situasi yang terjadi.

3.23.8.14 Assault (X85-Y09)

Berikan kode penyebab eksternal dalam kelompok X85 – Y09 sesuai dengan jenis penyerangan yang dicatat dokter, seperti penyerangan dengan obat-obatan, bahan kimia, air panas, tenggelam, senjata api, bahan peledak, benda tajam atau tumpul, kekuatan fisik, mendorong dari ketinggian, atau tabrakan kendaraan.

- Penyerangan dengan obat-obatan atau racun, tidak peduli jenis obat yang digunakan, gunakan kode X85.- (*Assault by drugs, medicaments and biological substances*). Kode ini tidak dapat ditemukan dalam tabel obat dan zat kimia.
- Penyerangan dengan rokok yang dibakar (membakar), gunakan kode X97.- (*Assault by smoke, fire and flames*).
- Penyerangan dengan kekuatan fisik tanpa senjata, misalnya meninju, menendang, mencakar, atau memukul, gunakan kode Y04.- (*Assault by bodily force*). Namun, ini tidak termasuk tindakan mencekik, membekap, atau menenggelamkan.
- Pelecehan seksual atau percobaan pemerkosaan, termasuk pelecehan melalui lubang tubuh (anus), gunakan kode Y05.- (*Sexual assault by bodily force*). Pastikan informasi tentang metode penyerangan, lokasi, dan aktivitas yang sedang

dilakukan korban dicatat dengan jelas untuk memilih kode yang sesuai.

3.23.8.15 Event of Undetermined Intent (Y10-Y34)

Kode penyebab eksternal dari kelompok Y10 – Y34 digunakan untuk mendokumentasikan kejadian yang niat atau motifnya tidak dapat dipastikan, maka dari itu penting bagi dokter untuk mencatat semua informasi relevan yang tersedia, meskipun data tersebut mungkin terbatas. Informasi ini akan menjadi dasar untuk memilih kode yang paling sesuai dengan kejadian yang dilaporkan, sehingga dokumentasi medis tetap akurat dan mencerminkan kondisi sebenarnya.

Ketelitian dalam mencatat detail kejadian sangat berperan dalam memastikan pemilihan kode yang tepat. Meskipun niat di balik kejadian tidak jelas, informasi seperti lokasi kejadian, jenis aktivitas yang sedang dilakukan korban, atau faktor-faktor lain yang terkait harus dicantumkan. Hal ini membantu pemberi kode untuk menentukan klasifikasi yang paling mendekati dengan menggunakan kelompok kode Y10 – Y34, sehingga data yang direkam tetap bermanfaat untuk analisis lebih lanjut, seperti pelaporan statistik atau evaluasi risiko.

3.23.8.16 Legal Intervention and Operations of War (Y35-Y36)

Gunakan kode penyebab eksternal dalam kelompok Y35.- (*Legal intervention*) atau Y36.- (*Operations of war*), sesuai dengan diagnosis dokter. Kode dalam kedua kelompok ini hanya memiliki 4 digit dan tidak memerlukan tambahan informasi tentang lokasi kejadian atau aktivitas, seperti pada kode penyebab eksternal dari V01.- hingga Y34.-.

- Eksekusi resmi oleh petugas pelayan masyarakat berdasarkan perintah pengadilan, misalnya hukuman mati dengan metode tertentu, gunakan kode Y35.5 (*Legal execution*).
- Cedera akibat kecelakaan ledakan peralatan militer sekutu sendiri selama operasi perang, gunakan kode Y36.2 (*War*

operations involving other explosions and fragments), sama seperti cedera akibat bom musuh. Pastikan informasi tentang jenis kejadian atau senjata dicatat dengan jelas untuk memilih kode yang sesuai.

3.23.8.17 Drugs, Medicaments and Biological Substances Causing Adverse Effects in Therapeutic Use (Y40-Y59)

Gunakan kode penyebab eksternal dalam kelompok Y40 – Y59, sesuai dengan nama obat, zat aktif, atau bahan biologis yang dicatat dokter. Kode ini dapat ditemukan dalam tabel alfabetis obat dan zat kimia di buku ICD-10-IM *section 3*, kolom kanan paling bawah (*adverse effect in therapeutic use*).

Contoh pengodean berdasarkan jenis obat:

1) Antibiotik

a) Obat Antituberkulosis

- Rifampicin, gunakan kode Y40.6 (*Rifamycins*).
- *Streptomycin*, gunakan kode Y40.5 (*Aminoglycosides*).
- *Isoniazid*, *ethambutol*, *pyrazinamide*, gunakan kode Y41.1 (*Antimycobacterial drugs*).

b) Obat Antijamur:

- Obat antijamur sistemik (misalnya *ketconazole*, *amphotericin B*), gunakan kode Y40.7 (*Antifungal antibiotics, systemically used*).
- Obat antijamur topikal (misalnya *miconazole cream*), gunakan kode Y56.0 (*Local antifungal, anti-infective and anti-inflammatory drugs, not elsewhere classified*).

c) Obat Antivirus

- Termasuk obat antivirus seperti *didanosine* (ddI), *stavudine* (d4T), *nevirapine* (NVP), *zidovudine* (AZT), *lamivudine*, *ribavirin*, *oseltamivir*, *acyclovir*, gunakan kode Y41.5 (*Antiviral drugs*).

2) Hormon

a) Glukokortikoid

- Obat injeksi atau oral seperti *prednisolone*, *dexamethasone*, gunakan kode Y42.0 (*Glucocorticoid and synthetic analogue*).
- Obat topikal, gunakan kode Y56.0 (*Local antifungal, anti-infective and anti-inflammatory drugs, not elsewhere classified*).
- Obat tetes mata, gunakan kode Y56.5 (*Ophthalmological drugs and preparations*).

b) Hormon Seksual Wanita

- Pil KB, gunakan kode Y42.4 (*Oral contraceptives*).
- Hormon lain, gunakan kode Y42.5 (*Other estrogens and progestogens*).

c) Obat Anti-Estrogen dan Anti-Androgen

- *Tamoxifen* (antiestrogen) atau *bicalutamide* (antiandrogen), gunakan kode Y42.6 (*Antigonadotrophins, antiestrogens, antiandrogens, not elsewhere classified*).

3) Agen Sistemik Primer

a) Antineoplastik

- Antimetabolit (misalnya *cytarabine*, *fluorouracil* [5FU], *methotrexate*), gunakan kode Y43.1 (*Antineoplastic antimetabolites*)
- Produk alami (misalnya *doxorubicin*, *vincristine*, *etoposide*), gunakan kode Y43.2 (*Antineoplastic natural products*)
- Lainnya (misalnya *cisplatin*, *cyclophosphamide*, *paclitaxel*), gunakan kode Y43.3 (*Other antineoplastic drugs*)

b) Imunosupresif: *azathioprine*, *cyclosporine*, gunakan kode Y43.4 (*Immunosuppressive agents*)

4) Agen yang Mempengaruhi Darah

a) Antikoagulan: *heparin*, *enoxaparin*, *warfarin*, gunakan kode Y44.2 (*Anticoagulants*).

- b) Penghambat agregasi trombosit
- *Clopidogrel, ticlopidine*, gunakan kode Y44.4 (*Antithrombotic drugs [platelet-aggregation inhibitors]*).
 - *Aspirin*, gunakan kode Y45.1 (*Salicylates*).
 - *Dipyridamole*, gunakan kode Y52.3 (*Coronary vasodilators, not elsewhere classified*).
- c) Thrombolitik: *streptokinase, alteplase*, gunakan kode Y44.5 (*Thrombolytic drugs*).
- 5) Obat Pereda Nyeri, Penurun Demam, dan Anti-Inflamasi
- a) Derivatif asam propionat: *ibuprofen, naproxen*, gunakan kode Y45.2 (*Propionic acid derivatives*).
- b) NSAID Lainnya: *diclofenac, celecoxib, parecoxib*, gunakan kode Y45.3 (*Other nonsteroidal anti-inflammatory drugs [NSAID]*).
- c) Antireumatik
- *Ulfasalazine, rituximab*, gunakan kode Y45.4 (*Antirheumatics*).
 - *Chloroquine*, gunakan kode Y41.2 (*Antimalarials and drugs acting on other blood protozoa*).
 - *Salisilat*, gunakan kode Y45.1 (*Salicylates*).
- 6) Obat untuk sistem kardiovaskular
- a) Beta Blocker: *atenolol, propranolol, metoprolol*, gunakan kode Y51.7 (*Beta-adrenoreceptor antagonists, not elsewhere classified*).
- b) ACE Inhibitor: *enalapril*, gunakan kode Y52.4 (*Angiotensin-converting-enzyme inhibitors*).
- c) *Antagonis Reseptor Angiotensin (ARB)*
- d) *Losartan*, gunakan kode Y52.5 (*Other antihypertensive drugs, not elsewhere classified*)
- 7) Diuretik
- a) Untuk *spironolactone*, gunakan kode Y54.1 (*Mineralocorticoid antagonists [aldosterone antagonists]*).

- b) Untuk *hydrochlorothiazide*, gunakan kode Y54.3 (*Benzothiadiazine derivatives*).
 - c) Untuk *furosemide*, gunakan kode Y54.4 (*Loop [high-ceiling] diuretics*).
- 8) Vitamin
- a) Untuk vitamin A, B (kecuali B12), C, E, gunakan kode Y57.7 (*Vitamins, not elsewhere classified*).
 - b) Untuk nicotinic acid, gunakan kode Y52.7 (*Peripheral vasodilators*).
 - c) Untuk vitamin B12, gunakan kode Y44.1 (*Vitamin B₁₂, folic acid and other anti-megaloblastic-anaemia preparations*).
 - d) Untuk vitamin D, gunakan kode Y54.7 (*Agents affecting calcification*).
 - e) Untuk vitamin K, gunakan kode Y44.3 (*Anticoagulant antagonists, vitamin K and other coagulants*).

Jika efek samping terjadi akibat penggunaan beberapa obat dan tidak diketahui jenis spesifiknya, gunakan kode Y57.9 (*Drug or medicament, unspecified*). Pastikan informasi tentang jenis obat dan efek samping dicatat secara rinci untuk memilih kode yang sesuai.

3.23.8.18 Unintentional Cut, Puncture, Perforation or Haemorrhage During Surgical and Medical Care (Y60.-)

Kode penyebab eksternal dalam kelompok Y60.- digunakan untuk mendokumentasikan kejadian seperti luka terpotong, tertusuk, terperforasi, atau pendarahan yang terjadi secara tidak disengaja selama prosedur bedah atau perawatan medis. Kode ini diberikan berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh dokter, sehingga penting bagi tenaga medis untuk mencatat semua informasi relevan terkait insiden tersebut. Dokumentasi yang rinci akan membantu pemberi kode memilih klasifikasi yang paling sesuai dengan kondisi yang dialami pasien

Penggunaan kode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang komplikasi yang muncul selama perawatan medis, meskipun kejadian tersebut bersifat tidak disengaja. Dengan mencantumkan detail seperti jenis cedera, lokasi, dan konteks kejadiannya, dokumentasi menjadi lebih akurat dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Hal ini juga mendukung evaluasi risiko serta peningkatan prosedur medis guna mencegah kejadian serupa di masa depan. Ketelitian dalam pengodean sangat penting untuk menjaga integritas data medis.

3.23.8.19 Foreign Object Accidentally Left in Body during Surgical and Medical Care (Y61.-)

Kode penyebab eksternal dalam kelompok Y61.- digunakan untuk mencatat kejadian di mana benda asing tertinggal secara tidak sengaja di dalam tubuh pasien selama prosedur bedah atau perawatan medis. Kode ini diberikan berdasarkan penilaian dan spesifikasi yang ditentukan oleh dokter, sehingga penting bagi tenaga medis untuk mendokumentasikan semua informasi relevan terkait insiden tersebut. Informasi seperti jenis benda asing, lokasi di mana benda tersebut tertinggal, serta konteks kejadiannya harus dicatat dengan jelas untuk memastikan pengodean yang akurat.

Penggunaan kode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang komplikasi yang terjadi selama perawatan medis. Meskipun kejadian ini bersifat tidak disengaja, dokumentasi yang rinci sangat penting untuk mendukung analisis lebih lanjut terkait keselamatan pasien dan kualitas pelayanan medis. Data yang dihasilkan dari pengodean ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola kejadian serupa, sehingga dapat dirancang strategi pencegahan yang lebih efektif guna meningkatkan standar keselamatan dalam praktik medis.

Selain itu, ketelitian dalam memberikan kode penyebab eksternal sangat penting untuk menjaga integritas data medis. Dokumentasi yang akurat tidak hanya membantu dalam

pelaporan statistik tetapi juga berfungsi sebagai alat evaluasi untuk memperbaiki prosedur operasi dan perawatan medis.

3.23.8.20 Failure of Sterile Precautions during Surgical And Medical Care (Y62.-)

Gunakan kode penyebab eksternal dari kelompok Y62.- untuk mencatat kegagalan dalam menjaga tindakan steril selama prosedur bedah atau perawatan medis. Kode ini diberikan sesuai dengan jenis perawatan yang diidentifikasi dan ditentukan oleh dokter. Oleh karena itu, penting bagi tenaga medis untuk mendokumentasikan secara rinci informasi terkait insiden tersebut, termasuk konteks kejadian dan jenis perawatan yang sedang dilakukan, agar pengodean dapat mencerminkan situasi dengan akurat.

Penggunaan kode ini bertujuan untuk memberikan gambaran jelas mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kegagalan sterilisasi, yang dapat mempengaruhi hasil perawatan pasien. Data yang dihasilkan dari pengodean ini dapat digunakan untuk evaluasi lebih lanjut, seperti analisis risiko infeksi atau peningkatan protokol sterilisasi. Dengan dokumentasi yang tepat, langkah ini akan membantu meningkatkan standar keselamatan pasien dan kualitas pelayanan medis secara keseluruhan.

3.23.8.21 Failure in Dosage during Surgical and Medical Care (Y63.-)

Gunakan kode penyebab eksternal dari kelompok Y63.- untuk mencatat kegagalan dalam penentuan dosis selama prosedur bedah atau perawatan medis. Kode ini diberikan berdasarkan spesifikasi yang ditetapkan oleh dokter, sehingga penting untuk mendokumentasikan secara detail informasi terkait insiden tersebut. Pastikan mencantumkan jenis perawatan, konteks kejadian, dan aspek lain yang relevan agar pengodean dapat secara akurat merepresentasikan situasi yang terjadi.

Penggunaan kode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kesalahan dalam penentuan dosis, yang dapat mempengaruhi hasil perawatan pasien. Data yang dihasilkan dari pengodean ini dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut, seperti evaluasi keselamatan pasien atau perbaikan prosedur medis. Dengan dokumentasi yang tepat, langkah ini akan membantu meningkatkan kualitas pelayanan medis dan mengurangi risiko kesalahan serupa di masa mendatang.

3.23.8.22 Contaminated Medical or Biological Substances (Y64.-)

Terapkan kode dari kategori Y64.- untuk mencatat kejadian yang melibatkan bahan medis atau biologis yang terkontaminasi, sesuai dengan detail yang disampaikan oleh dokter. Informasi seperti jenis bahan yang tercemar, kondisi saat pencemaran terjadi, dan faktor-faktor lain yang relevan harus dicatat dengan cermat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengodean mencerminkan situasi secara akurat.

Kode ini digunakan untuk mendokumentasikan insiden kontaminasi bahan medis atau biologis, yang dapat berdampak pada keselamatan pasien atau efektivitas perawatan. Data yang dihasilkan dari penggunaan kode ini dapat dimanfaatkan untuk menganalisis penyebab masalah dan meningkatkan standar keamanan dalam penanganan bahan medis. Dengan dokumentasi yang rinci dan tepat, langkah ini akan membantu meningkatkan mutu layanan kesehatan serta mengurangi risiko kejadian serupa di masa mendatang.

3.23.8.23 Other Misadventures during Surgical and Medical Care (Y65-)

Gunakan kode dari kelompok Y65.- untuk mencatat kesalahan lain yang terjadi selama prosedur bedah atau perawatan medis sebagai bagian dari kode penyebab eksternal. Pastikan bahwa dokumentasi mencakup detail terkait jenis kesalahan dan

konteks kejadiannya agar pengodean dapat merepresentasikan situasi dengan tepat.

Penggunaan kode ini bertujuan untuk mendokumentasikan berbagai insiden di luar kategori yang lebih spesifik, yang mungkin mempengaruhi hasil perawatan pasien. Data dari pengodean ini dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut guna meningkatkan standar keselamatan dan kualitas layanan medis. Dengan pendekatan yang teliti, langkah ini membantu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dalam praktik medis.

3.23.8.24 Medical Devices Associated with Adverse Incidents in Diagnostic and Therapeutic Use (Y70-Y82)

Gunakan kode dari kelompok Y70 – Y82 untuk mendokumentasikan kejadian yang melibatkan peralatan medis, dengan digit keempat pada kode utama secara spesifik menunjukkan jenis perangkat yang terlibat. Jenis perangkat ini mencakup berbagai kategori, seperti alat untuk diagnosis dan pemantauan (misalnya, monitor jantung atau alat pencitraan), peralatan untuk terapi dan rehabilitasi (seperti alat fisioterapi atau ventilator), serta instrumen bedah (contohnya, pisau bedah atau alat penjepit). Penting untuk memastikan bahwa jenis perangkat yang digunakan dicatat dengan sangat rinci, termasuk fungsi dan konteks penggunaannya, agar pengodean dapat merepresentasikan situasi secara tepat dan tidak menimbulkan ambiguitas.

Penggunaan kode ini memiliki implikasi penting dalam analisis insiden medis yang melibatkan peralatan tertentu. Setiap kejadian, baik berupa kerusakan alat, kesalahan pengoperasian, atau komplikasi selama penggunaan, harus didokumentasikan secara kritis dan detail guna mendukung evaluasi menyeluruh. Data yang dihasilkan dari pengodean ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola kegagalan atau risiko yang terkait dengan perangkat medis tertentu, sehingga memungkinkan dilakukannya tindakan korektif seperti pelatihan ulang tenaga medis,

pembaruan protokol penggunaan, atau peningkatan kualitas perangkat. Dengan pendekatan yang teliti dan kritis, dokumentasi ini menjadi alat penting untuk meningkatkan keselamatan pasien dan memastikan standar pelayanan medis yang lebih tinggi di masa depan.

3.23.8.25 Surgical and Other Medical Procedures as The Cause of Abnormal Reaction of The Patient, or of Later Complication, Without Mention of Misadventure at The Time of The Procedure (Y83-Y84)

Terapkan kode dari kelompok Y83 – Y84 sebagai penanda penyebab eksternal dalam rekam medis, dengan memastikan bahwa pemilihan kode mencerminkan secara tepat konteks dan detail kejadian yang terjadi. Kode ini dirancang untuk menggambarkan faktor-faktor eksternal yang secara langsung atau tidak langsung berkontribusi pada kondisi medis pasien, seperti komplikasi atau insiden selama perawatan. Oleh karena itu, dokumentasi harus disusun secara kritis dan rinci, mencakup informasi penting seperti jenis tindakan medis, waktu kejadian, dan situasi spesifik yang menyertainya.

Penggunaan kode ini memiliki peran strategis dalam analisis mendalam terhadap kasus-kasus yang melibatkan intervensi medis atau prosedur lainnya. Data yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola risiko, mengevaluasi efektivitas protokol medis, serta mengembangkan langkah-langkah mitigasi untuk mencegah terulangnya insiden serupa. Dengan pendekatan yang teliti dan terperinci, pengodean ini tidak hanya berfungsi sebagai alat dokumentasi tetapi juga sebagai dasar untuk meningkatkan standar keselamatan pasien dan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

3.23.8.26 Sequelae of External Causes of Morbidity and Mortality (Y85-Y89)

Gunakan kode dari kelompok Y85 – Y89 dengan tingkat kecermatan yang tinggi, sesuai dengan diagnosis spesifik yang telah ditetapkan oleh dokter. Kode-kode ini dirancang untuk mendokumentasikan kondisi medis yang terkait dengan komplikasi atau kejadian lanjutan akibat faktor eksternal tertentu, seperti cedera atau insiden sebelumnya. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap aspek diagnosis, termasuk kronologi kejadian, jenis cedera, dan konteks medis lainnya, dicatat secara rinci dan jelas. Hal ini bertujuan untuk menghindari ambiguitas dalam pengodean dan memastikan bahwa data yang dihasilkan mencerminkan situasi pasien secara akurat.

Penggunaan kode dalam kelompok ini memiliki dampak signifikan pada analisis klinis dan manajemen data kesehatan. Data yang diperoleh dari pengodean ini dapat digunakan untuk mengevaluasi tren kejadian, mengidentifikasi risiko jangka panjang akibat trauma atau penyakit sebelumnya, serta merancang strategi penanganan medis yang lebih tepat sasaran. Dengan pendekatan yang kritis dan detail, pengodean ini tidak hanya mendukung dokumentasi medis yang berkualitas tetapi juga berfungsi sebagai alat penting untuk meningkatkan keselamatan pasien, optimalisasi perawatan, dan pengambilan keputusan klinis yang lebih baik di masa mendatang.

3.23.8.27 Evidence of Alcohol Involvement (Y90-Y91)

Gunakan kode dari kelompok Y90.- untuk mencatat bukti keterlibatan alkohol berdasarkan kadar alkohol dalam darah atau Y91.- untuk mendokumentasikan bukti keterlibatan alkohol berdasarkan tingkat keracunan, sesuai dengan diagnosis yang ditentukan oleh dokter. Kode Y90.- digunakan ketika terdapat data laboratorium yang menunjukkan kadar alkohol dalam darah pasien, sementara kode Y91.- diterapkan untuk menggambarkan tingkat keracunan alkohol berdasarkan gejala klinis atau kondisi

pasien saat pemeriksaan. Penting untuk memastikan bahwa informasi terkait kadar alkohol atau tingkat keracunan dicatat secara rinci agar pengodean dapat merepresentasikan situasi medis dengan akurat.

Penggunaan kode ini memiliki peran penting dalam mendokumentasikan dampak alkohol terhadap kondisi pasien, baik dalam konteks kecelakaan, cedera, maupun komplikasi medis lainnya. Data yang dihasilkan dari pengodean ini dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara konsumsi alkohol dan insiden medis, membantu dalam penilaian risiko, serta merancang intervensi yang lebih tepat guna. Dengan pendekatan yang detail dan teliti, pengodean ini tidak hanya mendukung keakuratan dokumentasi medis tetapi juga memberikan dasar untuk evaluasi epidemiologi dan pengembangan strategi pencegahan yang lebih efektif terkait konsumsi alkohol.

3.23.8.28 Nosocomial Condition (Y95)

Gunakan kode Y95 untuk mendokumentasikan kondisi nosokomial sebagai faktor penyebab eksternal, dengan memastikan bahwa pengodean mencerminkan secara tepat konteks medis yang melatarbelakanginya. Kode ini digunakan untuk mengidentifikasi kondisi atau komplikasi yang terjadi akibat perawatan di fasilitas kesehatan, seperti infeksi nosokomial atau masalah lain yang timbul selama proses perawatan. Oleh karena itu, penting bagi pemberi kode untuk bekerja sama dengan tenaga medis dalam mengumpulkan informasi rinci tentang kronologi kejadian, jenis intervensi medis yang dilakukan, serta dampaknya terhadap pasien.

Penggunaan kode Y95 memiliki implikasi kritis dalam analisis keselamatan pasien dan evaluasi kualitas layanan kesehatan. Data yang dihasilkan dari pengodean ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola kejadian nosokomial, mengevaluasi efektivitas protokol keamanan, serta merancang strategi mitigasi untuk mencegah insiden serupa di masa depan.

Dengan pendekatan yang kritis dan detail, pengodean ini tidak hanya berfungsi sebagai alat dokumentasi tetapi juga sebagai dasar untuk meningkatkan standar pelayanan kesehatan, meminimalkan risiko, dan memastikan keselamatan pasien selama menjalani perawatan di fasilitas medis.

3.23.8.29 *Work-Related Condition (Y96)*

Gunakan kode Y96 untuk mendokumentasikan kondisi terkait pekerjaan sebagai faktor penyebab eksternal, jika dokter menetapkan bahwa penyakit atau masalah kesehatan pasien disebabkan oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan lingkungan kerja atau penyakit akibat kerja. Kode ini dirancang khusus untuk mencatat kondisi medis yang timbul akibat paparan risiko di tempat kerja, seperti bahan kimia berbahaya, aktivitas fisik berlebihan, atau paparan kondisi lingkungan tertentu. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa informasi terkait jenis pekerjaan, risiko spesifik yang dihadapi, serta hubungannya dengan kondisi pasien dicatat secara rinci dan jelas dalam dokumentasi medis.

Penggunaan kode Y96 memiliki peran penting dalam analisis penyakit akibat kerja dan evaluasi keselamatan kerja. Data yang dihasilkan dari pengodean ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola penyakit yang sering terjadi di industri tertentu, mengevaluasi keefektifan protokol keselamatan kerja, serta merancang strategi pencegahan yang lebih baik untuk melindungi pekerja dari risiko kesehatan. Dengan pendekatan yang detail dan teliti, pengodean ini tidak hanya membantu dalam mendukung dokumentasi medis yang akurat tetapi juga menjadi dasar untuk meningkatkan standar keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga dapat mengurangi insiden penyakit akibat pekerjaan di masa mendatang.

3.23.8.30 *Environmental-Pollution-Related Condition (Y97)*

Gunakan kode Y97 untuk mendokumentasikan kondisi terkait pencemaran lingkungan sebagai faktor penyebab eksternal, jika dokter menetapkan bahwa penyakit atau masalah kesehatan pasien diakibatkan oleh paparan terhadap polutan atau kondisi lingkungan yang tercemar. Kode ini secara khusus dirancang untuk mengidentifikasi dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh faktor-faktor seperti polusi udara, air tercemar, tanah terkontaminasi, atau paparan bahan kimia berbahaya di lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi pemberi kode untuk memastikan bahwa informasi terkait jenis pencemaran, sumber paparan, serta hubungannya dengan kondisi medis pasien dicatat secara rinci dan akurat.

Penggunaan kode Y97 memiliki implikasi yang signifikan dalam analisis dampak pencemaran lingkungan terhadap kesehatan masyarakat. Data yang dihasilkan dari pengodean ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola penyakit yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan, mengevaluasi risiko kesehatan di komunitas tertentu, serta merancang kebijakan dan intervensi yang lebih efektif untuk mengurangi paparan terhadap polutan. Dengan pendekatan yang kritis dan teliti, pengodean ini tidak hanya mendukung dokumentasi medis yang presisi tetapi juga menjadi dasar untuk advokasi lingkungan dan upaya perbaikan kualitas hidup masyarakat. Ketelitian dalam penerapan kode ini sangat penting untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan dapat digunakan secara optimal dalam mengatasi masalah kesehatan yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan.

3.24 MDC 34 NEOPLASMA

Pengkodean neoplasma dalam ICD-10 tahun 2010 dilakukan dengan menggabungkan kode topografi yang menunjukkan lokasi anatomis tumor (kode C00-C97 untuk neoplasma ganas dan kode D00-D48 untuk tumor jinak, in situ, dan tidak diketahui jenisnya (*uncertain behavior*)) dan menggunakan kode morfologi.

Pengkodean morfologi neoplasma diatur berdasarkan sistem ICD-O (International Classification of Diseases for Oncology) yang mengkategorikan neoplasma berdasarkan morfologinya (tipe histologis tumor) yang dapat ditemukan di volume 1 ICD10-2010 di bagian *Morphology Of Neoplasms* setelah chapter 22. kode *Indonesian Modification* (IM) untuk morfologi dan lokasi anatominya (topografis) dapat digunakan untuk kasus neoplasma yang sebelumnya tidak tersedia di ICD 10 versi 2010.

PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGINPUTAN iDRG MDC 34

- Pada kasus efusi pleura akibat kanker metastatik atau C78.2 (*Secondary malignant neoplasm of pleura*) hanya digunakan jika hasil pemeriksaan cairan pleura menunjukkan bukti keganasan. Perhatikan juga diagnosis utama atau sekunder lain, apakah sudah pernah ditegakkan *primary cancer* atau tidak. Jika tidak ada riwayat *primary cancer*, akan tetapi ditemukan keganasan pada cairan pleura, gunakan kode C38.- (*Malignant neoplasm of heart, mediastinum and pleura*) sebagai diagnosis utama dengan melakukan konfirmasi ke dokter penanggung jawab pasien.
- Pengodean tindakan biopsi dan eksisi harus disesuaikan dengan jenis prosedur yang benar-benar dilakukan berdasarkan dokumentasi medis. Jika tindakan yang dilakukan adalah biopsi, baik dengan jarum ataupun *open biopsy*, maka gunakan kode biopsi yang sesuai. Jika tindakan yang dilakukan adalah eksisi, maka gunakan kode eksisi. Dan apabila tindakan yang dilakukan adalah eksisi sekaligus diikuti dengan biopsi, maka kedua tindakan dikodekan secara terpisah sesuai dengan masing-masing jenis tindakan dan anatomi lokasinya.
 - Pada kasus tumor rongga pelvis (D36.7), jika prosedur yang dilakukan adalah eksisi (sebagai tindakan terapeutik) pada rongga pelvis daerah peritonium, gunakan kode 54.4 (*Excision or destruction of peritoneal tissue*). Jika prosedur yang dilakukan hanya untuk biopsi, gunakan kode 54.23 (*Biopsy of peritoneum*). Jika berdasarkan hasil patologi anatomi terdapat tindakan eksisi dan dilanjutkan dengan tindakan biopsi, maka menggunakan kode eksisi dan kode biopsi.
 - Pada prosedur eksisi tumor sinonasal, jika hanya dilakukan eksisi tumor sinonasal, gunakan kode 22.6 (*Other nasal sinusectomy*). Jika dilakukan

eksisi tumor sinonasal dan pengangkatan tulang wajah, tambahkan kode 76.39 (*Partial ostectomy of other facial bone*). Pada kasus tumor hemangioma yang berlokasi di kulit sebagai *soft tissue tumor*, pastikan kedalaman tindakan eksisi dan lokasi hemangioma pada laporan operasi. Jika eksisi lokal hemangioma pada kulit dan jaringan bawah kulit, gunakan kode tindakan 86.3 (*Other local excision or destruction of lesion or tissue of skin and subcutaneous tissue*). Jika eksisi luas hemangioma pada kulit dengan melibatkan struktur yang mendasari atau berdekatan, gunakan kode tindakan 86.4 (*Radical excision of skin lesion*).

- Pada kasus ekstirpasi tumor mammae, jika prosedur yang dilakukan hanya biopsi dengan jarum, menggunakan kode 85.11 (*Closed [percutaneous] [needle] biopsy of breast*). Apabila prosedur biopsi yang dilakukan adalah open biopsi, gunakan 85.12 (*Open biopsy of breast*). Jika prosedur tersebut adalah eksisi tumor atau bagian lain pada payudara (sebagai tindakan terapeutik), gunakan kode 85.2- (*Excision or destruction of breast tissue*) disesuaikan dengan lokasi eksisinya. Jika pada hasil patologi anatomi dilakukan tindakan eksisi dilanjutkan dengan biopsi, gunakan kode eksisi dan kode biopsi.
- Pada kasus ekstirpasi besar tumor pedis, gunakan kode 77.68 (*Local excision of lesion or tissue of bone, tarsals and metatarsals*) apabila prosedur yang dilakukan adalah pengangkatan lesi/tumor yang berasal dari jaringan tulang tarsal dan metatarsal. Gunakan kode 77.48 (*Biopsy of bone, tarsals and metatarsals*) apabila prosedur yang dilakukan adalah prosedur eksisi dengan tujuan biopsi dari tulang tarsal dan metatarsal.
- Kemoterapi dalam iDRG terbagi menjadi dua pelayanan yaitu kemoterapi oral dan injeksi. Pasien yang datang baik ke rawat jalan dan mendapatkan obat kemoterapi oral ataupun mendapatkan kemoterapi injeksi, maka menggunakan kode Z51.1 (*Chemotherapy Session for Neoplasm*) sebagai diagnosis utama dan kode neoplasma dikode sebagai diagnosis sekunder.

Contoh 1:

Diagnosis utama : Kemoterapi oral di rawat jalan

Diagnosis sekunder: Ca Paru

Tindakan : -

Dikode Z51.1 (*Chemotherapy Session for Neoplasm*) sebagai diagnosis utama dan Ca Paru C34.9 (*Bronchus or lung, unspecified*) dikode sebagai diagnosis sekunder.

Contoh 2:

Diagnosis utama : Kemoterapi

Diagnosis sekunder: Ca. Payudara

Tindakan : injeksi kemoterapi

Dikode Z51.1 (*Chemotherapy Session for Neoplasm*) sebagai diagnosis utama, C50.9 (*Breast, Unspecified*) sebagai diagnosis sekunder dan 99.25 (*Injection or infusion of cancer chemotherapeutic substance*) sebagai kode Tindakan/prosedur.

- Pasien yang datang ke rawat jalan atau rawat inap hanya untuk radioterapi maka menggunakan kode Z51.0 (*Radiotherapy Session*) sebagai diagnosis utama dan neoplasma menjadi diagnosis sekunder.

Contoh 1:

Diagnosis utama : Radioterapi

Diagnosis sekunder: Ca. Payudara

Tindakan : Radioterapi dengan *Photon*

Dikode Z51.0 (*Radiotherapy Session*) sebagai diagnosis utama, C50.9 (*Breast, Unspecified*) sebagai diagnosis sekunder dan 92.24 (*Teleradiotherapy using photons*) sebagai kode prosedur.

- Pasien yang dirawat inap dilakukan tindakan operasi yang dilanjutkan dengan kemoterapi dan/atau radioterapi dalam satu episode perawatan maka yang menjadi diagnosis utama adalah yang berhubungan dengan tindakan utama.
- Pasien yang datang untuk dilakukan kemoterapi dan radioterapi dalam satu episode perawatan yang sama, gunakan kode Z51.0 dan Z51.1 serta kode diagnosis cancer nya, dilanjutkan dengan kode tindakan untuk kemoterapi dan radioterapinya misal 99.25 dan 92.2- harus dimasukkan keduanya untuk mendapatkan kelompok kemoterapi dan radioterapi.

Contoh 1

Diagnosis utama : Radioterapi dan Kemoterapi injeksi

Diagnosis sekunder : Ca. Paru metas ke Otak
Tindakan : Radioterapi dengan *Photon* dan injeksi kemoterapi

Kode :

Diagnosis utama : Z51.0 (*Radiotherapy Session*)
Diagnosis sekunder : Z51.1 *Chemotherapy Session for Neoplasm*
C34.9 *Bronchus or lung, unspecified*
C79.3 *Secondary malignant neoplasm of brain and cerebral meninges*
Prosedur : 99.25 *Injection or infusion of cancer chemotherapeutic substance*
92.24 *Teleradiotherapy using photons*

1. Anemia yang disebabkan oleh neoplasma dikodekan sebagai D63.0* (*Anaemia in neoplastic disease*), dengan kode yang tepat untuk neoplasma sebagai kode tambahan menggunakan (C00–D48†). Pasien pasca kemoterapi atau radioterapi yang datang untuk perbaikan keadaan/kondisi umum yang memerlukan transfusi bisa diberikan kode neoplasma-nya sebagai diagnosis utama dan D63.0* sebagai diagnosis sekunder ditambahkan kode tindakan transfusi darah 99.04 untuk mendapatkan kelompok *Neoplasma + Blood Transfusion*.

Contoh 1:

Diagnosis utama : Anemia
Diagnosis sekunder : Ca. Hati
Tindakan : Transfusi *PRC*

Dikode C22.9 (*Liver, unspecified*) sebagai diagnosis utama, D63.0* (*Anaemia in neoplastic disease*) sebagai diagnosis sekunder dan 99.04 (*Transfusion of packed cells*) sebagai kode prosedur.

2. Anemia tidak boleh dikodekan dalam gangguan darah neoplastik yang telah di exclude (dikecualikan) dalam ICD 10 dalam kasus diagnosis dan kode ICD berikut ini :

D46.- : Myelodysplastic syndromes

D47.1 : Chronic myeloproliferative disease

copyright@ Pusat pembiayaan kesehatan Kemenkes RI.

Dilarang mengcopy atau memperjualbelikan isi dan dokumen ini dalam bentuk apapun

C92.0 : Acute myeloblastic leukaemia [AML]

C92.1 : Chronic myeloid leukaemia [CML], BCR/ABL-positive

C92.2 : Atypical chronic myeloid leukaemia, BCR/ABL- negative

C93.1 : Chronic myelomonocytic leukaemia

C94.0 : Acute erythroid leukaemia

Selain kode - kode ICD diatas maka Anemia bisa dikode sebagai diagnosis sekunder

3. 99.25 sudah termasuk Chemoembolization, sehingga untuk TACE dibuat IM 99.250 (*Transcatheter Arterial Chemoembolization*) ^(IM)
4. Dalam hal dilakukan 3D CT Simulator sudah dibuatkan kode baru 88.380 jika menggunakan kontras tambahkan kode 99.290 .
5. Layanan Kedokteran Nuklir dibagi menjadi 2 kelompok, yang pertama adalah *Nuclear Medicine* dengan kode tindakan 92.28 *Injection or instillation of radioisotopes* dan 92.29 *Other radiotherapeutic procedure*. Yang kedua adalah *Nuclear Diagnostic* dengan kode tindakan 92.50 *Non-Imaging Nuclear Medicine Thyroid Function Test* (IM), 92.51 *Non-Imaging Nuclear Medicine Thyroid Cancer Marker* (IM), 92.52 *Non-Imaging Nuclear Medicine Thyroid Antibody Test* (IM) dan 92.01 sampai dengan 92.19. Tata cara pengodean pada pelayanan Kedokteran Nuklir harus ditambahkan dengan kode IM Farmakoterapinya **tanpa** diawali dengan kode Z51.0 *Radiotherapy Session*.

PENJELASAN KHUSUS KODE ICD DALAM KATEGORI MDC 34

3.24.1 Diagnosis keganasan

- Untuk pasien yang menjalani pengobatan kanker secara berkelanjutan, kode penyakit kanker harus dimasukkan sebagai diagnosis utama, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Jika perawatan diberikan untuk kanker primer (*malignant primary*), gunakan kode kanker primer tersebut sebagai diagnosis utama.
 - Jika ditemukan dua lokasi kanker primer secara bersama, masing masing dikodekan sebagai neoplasma primer. Jika perawatan lebih difokuskan ke salah satu lokasi, maka lokasi tersebut

ditetapkan sebagai diagnosis utama. Jika perawatan dilakukan secara seimbang pada keduanya, maka salah satu dari keduanya dapat ditetapkan sebagai diagnosis utama.

- Jika perawatan diberikan untuk kanker sekunder (*malignant secondary*), gunakan kode kanker sekunder tersebut sebagai diagnosis utama. Jika diketahui lokasi asal kanker tersebut, gunakan kode lokasi awal (*primary site*) sebagai diagnosis tambahan. Jika tidak diketahui lokasi asalnya, gunakan kode C80.0 (*Malignant neoplasm, primary site unknown, so stated*) sebagai diagnosis tambahan.
- Kode penyakit kanker harus selalu dimasukkan sebagai diagnosis utama setiap kali pasien menjalani perawatan, bahkan jika kanker tersebut telah diangkat selama proses pengobatan.
- Untuk lesi tumpang tindih (*overlapping lesion*) pada kanker ganas, yaitu lesi yang melibatkan dua atau lebih lokasi yang berdekatan tetapi tidak dapat ditentukan lokasi awalnya, termasuk dalam kelompok kode C00 – C75 dengan subcode .8. Contohnya, kanker yang tumpang tindih antara bagian ujung lidah dan sisi dorsal lidah diberi kode C02.8 (*Malignant neoplasm of overlapping lesion of tongue*).
- Selain itu, jika pasien datang ke rumah sakit untuk menjalani metode pengobatan, seperti kemoterapi, radioterapi, atau perawatan paliatif, maka gunakan kode yang sesuai dengan metode pengobatan yang dilakukan sebagai kode diagnosis utama. Dan tambahkan kode kankernya sebagai kode diagnosis sekunder.

Contoh 1-34	Pasien kanker payudara dirawat di rumah sakit untuk menerima kemoterapi injeksi	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Kemoterapi	Z51.1 <i>Chemotherapy session for neoplasm</i>
Diagnosis Sekunder	Kanker payudara	C50.9 <i>Breast, unspecified</i>
Prosedur	-	99.25 <i>Injection or infusion of cancer chemotherapeutic substance</i>

copyright@ Pusat pembiayaan kesehatan Kemenkes RI.

Dilarang mengcopy atau memperjualbelikan isi dan dokumen ini dalam bentuk apapun

Contoh 1-34	Pasien lansia dirujuk ke rumah sakit akibat kejang. CT-scan otak menunjukkan adanya massa berukuran 3 cm. Pemeriksaan radiologi thoraks menemukan massa paru berukuran 4 cm pada lobus superior kiri. Pasien menjalani biopsi otak terbuka, dan hasil histopatologi menunjukkan adenokarsinoma metastatik. Selanjutnya dilakukan bronkoskopi dengan biopsi, yang hasilnya mengonfirmasi adanya adenokarsinoma paru. Dokter menyimpulkan bahwa pasien mengalami kanker otak metastatik yang berasal dari kanker paru. Karena usia pasien lanjut, tidak dilakukan terapi kemoterapi maupun radioterapi, dan pasien dipulangkan untuk perawatan suportif di rumah.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Metastasis adenokarsinoma pada otak	C79.3 <i>Secondary malignant neoplasm of brain and cerebral meninges</i>
Diagnosis Sekunder	Kanker paru paru, lobus atas-kiri	C34.1 <i>Malignant neoplasm of upper lobe, bronchus or lung</i>
Prosedur	Biopsi otak terbuka bronkoskopi dengan biopsi	01.14 <i>Open brain biopsy</i> 33.24 <i>Closed (endoscopic) biopsy of bronchus</i>
Morfologi	<i>Adenocarcinoma, metastatic Adenocarcinoma</i>	M8140/6 <i>Adenocarcinoma, metastatic</i> M8140/3 <i>Adenoacrcinoma NOS</i>

Contoh 1-34	Pasien datang dengan keluhan wajah dan lengan bengkak. Dokter mendiagnosis obstruksi vena cava superior (SVCO) dan pasien dirawat di rumah sakit. CT-scan thoraks menunjukkan adanya massa di mediastinum serta massa di lobus bawah kanan paru dengan ukuran 3 cm. Biopsi melalui bronkoskopi dilakukan, dan hasil jaringan menunjukkan karsinoma sel kecil. Diagnosis akhir adalah SVCO akibat metastasis mediastinal dari kanker paru. Pasien menjalani pengobatan dengan radioterapi menggunakan sinar supervoltage.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	<i>Metastatic small cell carcinoma of mediastinum</i>	C78.1 <i>Secondary malignant neoplasm of mediastinum</i>
Diagnosis Sekunder	Kanker paru-paru, lobus bawah-kanan Radioterapi	C34.3 <i>Malignant neoplasm of lower lobe, bronchus or lung</i> Z51.0 <i>Radiotherapy session</i>
Prosedur	<i>Bronchoscopy with biopsy</i> <i>External radiation, supervoltage</i>	33.24 <i>Closed (endoscopic) biopsy of bronchus</i> 92.24 <i>Teleradiotherapy using photon</i>
Morfologi	<i>Small cell carcinoma</i>	M8041/3 <i>Small cell carcinoma NOS</i>

Contoh 1-34	Pasien dengan riwayat penyakit kanker kolorektal dua tahun lalu telah menjalani operasi pengangkatan tumor dengan batas bebas (<i>free margin</i>) dan tidak ditemukan metastasis kelenjar getah bening. Pada kunjungan saat ini, dokter menemukan adanya hepatomegali. Pemeriksaan CT-Scan menunjukkan terdapat tiga massa di hati. Pasien kemudian menjalani biopsi hati, dan hasilnya menunjukkan adanya adenokarsinoma metastatik.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Adenokarsinoma metastasis hati	C78.7 <i>Secondary malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile duct</i>
Diagnosis Sekunder	Riwayat kanker usus besar	Z85.0 <i>Personal history of malignant neoplasm of digestive organs</i>
Prosedur	<i>Needle biopsy of liver</i>	50.11 <i>Closed (percutaneous) (needle) biopsy of liver</i>
Morfologi	<i>Metastatic adenocarcinoma</i>	M8140/6 <i>Adenocarcinoma, metastatic</i>

Contoh 1-34	Pasien dengan riwayat sirosis hepatitis akibat konsumsi alkohol kronis datang dengan keluhan benjolan di daerah hepar. Ultrasonografi abdomen menunjukkan massa berukuran 3 cm di hati. Pemeriksaan MRI menunjukkan gambaran yang sangat mencurigakan ke arah hepatoma. Pemeriksaan serum alpha-fetoprotein menunjukkan kadar 250 IU/mL (nilai normal: 0–10 IU/mL). Dokter kemudian menegaskan diagnosis hepatoma dengan sirosis hepatitis akibat alkohol. Pasien dirawat dan mendapatkan terapi berupa chemoembolization intrahepatik dengan minyak.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Hepatoma	C22.0 <i>Liver cell carcinoma</i>
Diagnosis Sekunder	<i>Alcoholic cirrhosis of liver</i> Radioterapi	K70.3 <i>Alcoholic cirrhosis of liver</i> Z51.1 <i>Chemotherapy session for neoplasm</i>
Prosedur	<i>Intrahepatic oil chemoembolization</i>	99.25 <i>Injection or infusion of cancer chemotherapeutic</i>
Morfologi	<i>Metastatic adenocarcinoma</i>	M8140/6 <i>Adenocarcinoma, metastatic</i>

3.24.2 Komplikasi Terkait dengan Keganasan

Untuk pasien yang dirawat hanya untuk menangani komplikasi yang disebabkan oleh kanker, jika kanker masih ada dalam tubuh pasien, gunakan kode kanker sebagai diagnosis utama dan kode komplikasi tersebut sebagai diagnosis tambahan.

- Jika terdapat anemia pada pasien yang masih memiliki kanker, gunakan kode kanker sebagai diagnosis utama dan kode D63.0* (*Anaemia in neoplastic disease*) sebagai diagnosis tambahan. Perhatikan bahwa kode D63.0* adalah kode yang memiliki tanda asterisk (*), yang berarti tidak dapat digunakan sebagai diagnosis utama, melainkan harus digunakan sebagai diagnosis tambahan bersama dengan kode dari kelompok C00 – D48.

Contoh 2-34	Pasien dengan Kanker Payudara dengan jenis Adenoid cystic carcinoma diperiksa oleh dokter dan ditemukan anemia. Pasien dirawat untuk diberikan <i>transfusi packed red cells</i> , kemudian dipulangkan ke rumah.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Kanker Payudara	C50.9† <i>Malignant neoplasm of breast, Unspecified</i>
Diagnosis Sekunder	Anemia	D63.0* <i>Anaemia in neoplastic disease</i>
Prosedur	Transfusi <i>packed red cells</i>	99.04 <i>Transfusion of packed cells</i>
Morfologi	Adenoid cystic carcinoma	M8200/3 <i>Adenoid cystic carcinoma</i>

- Jika terdapat paraneoplastik polineuropati pada pasien yang masih memiliki kanker, gunakan kode kanker sebagai diagnosis utama dan kode G63.1 (*Polyneuropathy in neoplastic disease*) sebagai diagnosis tambahan.
- Jika terdapat sindrom Cushing akibat sekresi ACTH ektopik pada pasien yang masih memiliki kanker, gunakan kode kanker sebagai diagnosis utama dan kode E24.3 (*Ectopic ACTH syndrome*) sebagai diagnosis tambahan.
- Jika terdapat kolangitis pada pasien dengan kolangiokarsinoma, gunakan kode C22.1 (*Intrahepatic bile duct carcinoma*) sebagai diagnosis utama dan kode K83.0 (*Cholangitis*) sebagai diagnosis tambahan.
- Jika terdapat pendarahan intra-abdomen akibat ruptur hepatoma, gunakan kode C22.0 (*Liver cell carcinoma*) sebagai diagnosis utama dan kode K66.1 (*Haemoperitoneum*) sebagai diagnosis tambahan.

- Jika pasien dirawat karena komplikasi akibat pengobatan kanker, baik kanker tersebut masih ada maupun telah diobati hingga tidak ada sisa penyakit (sembuh), gunakan kode komplikasi tersebut sebagai diagnosis utama dan tambahkan kode kanker baik yang masih ada maupun kode riwayat kanker (Z85.- (*Personal history of malignant neoplasm*)) sesuai jenis kanker yang pernah diderita sebagai diagnosis tambahan.

Contoh 3-34	Pasien dengan <i>Non-Hodgkin's lymphoma</i> (tipe <i>diffuse large B-cell</i>) dirawat di rumah sakit karena mengalami demam tinggi setelah menjalani kemoterapi. Satu minggu sebelumnya, ditemukan <i>absolute neutrophil count</i> sebesar 500 sel/mm ³ , dengan suhu tubuh mencapai 39°C. Tidak ditemukan sumber infeksi pada pemeriksaan, sehingga dokter mendiagnosis pasien mengalami febrile neutropenia.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis primer	Neutropenia demam	D70 <i>Agranulositosis</i>
Diagnosis sekunder	<i>Limfoma non-Hodgkin</i> (sel B besar difus) Agen kemoterapi	C83.3 <i>Diffuse large B-cell lymphoma</i> R50.9 <i>Fever, unspecified</i> Y43.3 <i>Other antineoplastic drugs</i>
Prosedur	-	-
Morfologi	Limfoma non-Hodgkin (sel B besar difus)	M9680/3 Limfoma ganas, sel besar, NOS difus

Contoh 3-34	Pasien datang dengan gejala diare beberapa kali sehari, terkadang disertai darah. Pemeriksaan proktoskopi menemukan gambaran yang sesuai dengan proktitis radiasi. Pasien memiliki riwayat kanker serviks dan telah menerima terapi radiasi dua tahun lalu. Dari hasil pemeriksaan lanjutan, sudah tidak menunjukkan adanya sisa kanker.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis primer	Radiation proctitis	K62.7 <i>Radiation proctitis</i>
Diagnosis sekunder	Riwayat penyakit kanker serviks	Z85.4 <i>Personal history of malignant neoplasm of genital organ</i>
Morfologi	-	-

3.24.3 Kode Morfologi Neoplasma

Untuk pengodean yang tepat dari neoplasma, kode morfologi neoplasma harus diberikan berdasarkan daftar klasifikasi penyakit internasional untuk neoplasma (ICD-O), yang dicantumkan dalam buku volume 1 dari ICD-10.

Kode morfologi neoplasma dimulai dengan huruf "M", diikuti oleh 5 digit angka. Empat digit pertama menunjukkan jenis jaringan neoplasma, sedangkan digit kelima, yang dipisahkan oleh garis miring (/), menunjukkan perilaku neoplasma tersebut. Digit kelima terdiri dari:

Perilaku Kode	Deskripsi	Bab II Kategori
/0	<i>Benign neoplasms</i>	D10-D36
/1	<i>Neoplasms of uncertain and unknown behaviour</i>	D37-D48
/2	<i>In situ neoplasms</i>	D00-D09
/3	<i>Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary</i>	C00-C76; C80-C96
/6	<i>Malignant neoplasms, stated or presumed to be secondary</i>	C77-C79
/9	Neoplasma ganas, tidak pasti apakah situs primer atau metastasis	

/1 (*Neoplasms of uncertain and unknown behaviour*), mengacu pada neoplasma yang dokter belum yakin apakah bersifat jinak atau ganas, termasuk neoplasma yang didiagnosis sebagai *borderline malignancy* atau memiliki potensi keganasan rendah (*low malignant potential*). Namun, pengecualian diberikan untuk *borderline cystadenoma* pada ovarium (M844-M849), yang diberi kode sama seperti neoplasma ganas. Pengode dapat mencari kode morfologi neoplasma melalui indeks alfabetis dari kode diagnosis penyakit.

3.24.4 Mass, Cyst, Dan Tumor

Dalam pengodean kasus massa, kista, dan tumor, pengodean harus disesuaikan dengan istilah yang digunakan oleh dokter dalam diagnosis, dengan memperhatikan klarifikasi lebih lanjut jika diperlukan untuk memilih kode yang tepat.

Misalnya jika dokter mencatat diagnosis sebagai kista ovarium (*ovarian cyst*), pemberi kode harus meminta klarifikasi kepada dokter mengenai jenis kista ovarium untuk mempertimbangkan penggunaan salah satu dari kode berikut sesuai dengan jenis kista yang didiagnosis oleh dokter:

- N80.1 (*Endometriosis of ovary*)
- N83.0 (*Follicular cyst of ovary*)
- N83.1 (*Corpus luteum cyst*)
- N83.2 (*Other and unspecified ovarian cysts*)

Demikian pula pada kasus yang lain, misalnya sebagai berikut.

Diagnosis	Kode
Massa perut atau massa panggul	R19.0 <i>Intra-abdominal and pelvic swelling, mass and lump</i>
Massa payudara	N63 <i>Unspecified lump in breast</i>
Massa paru-paru	R91 <i>Abnormal findings on diagnostic imaging of lung</i>
Kista ovarium	N83.2 <i>Other and unspecified ovarian cysts</i>
Kista tiroid	E04.1 <i>Nontoxic single thyroid nodule</i>
Tumor ovarium	D39.1 <i>Ovary</i>
Tumor hati	D37.6 <i>Liver, gallbladder and bile ducts</i>
Tumor payudara	D48.6 <i>Breast</i>

Contoh 4-34	Pasien mengalami batuk darah. Pemeriksaan radiologi dada menunjukkan massa di paru-paru. Dokter mendiagnosis sebagai lung mass dan melakukan bronchoscopic biopsy. Hasil pemeriksaan patologi anatomi belum keluar.	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	Massa paru-paru	R91 <i>Abnormal findings on diagnostic imaging of lung</i>

Diagnosis Sekunder	-	-
Prosedur	Bronkoskopi dengan biopsi	33.24 <i>Closed [endoscopic] biopsy of bronchus</i>
Morfologi	-	-

3.24.5 Tumor Stroma Saluran Pencernaan (Gastrointestinal Stromal Tumor) C15-C26

Jika dokter mendiagnosis gastrointestinal stromal tumour dan tidak diketahui lokasi kanker primernya, gunakan kode D37.9 (*Digestive organ, unspecified*). Akan tetapi, jika lokasi kanker primer diketahui, kodekan berdasarkan lokasi kanker primer. Misalnya, jika dokter menyatakan bahwa kanker primer terletak di lambung, maka kode yang digunakan adalah C16.- (*Malignant neoplasm of stomach*). Jika dokter hanya menyebutkan bahwa kanker primer berada di rongga perut tetapi tidak merinci bagian mana, kode yang digunakan adalah C49.4 (*Malignant neoplasm of connective and soft tissue of abdomen*). Jika dokter tidak mengetahui lokasi kanker primer, namun diagnosis dibuat berdasarkan hasil liver biopsy yang menunjukkan bahwa kanker telah menyebar ke hati, maka kode yang digunakan adalah C78.7 (*Secondary malignant neoplasm of liver*).

3.24.6 Karsinoma Peri-Ampular (C17.0, C24.0, C24.1, C25.0)

Jika dokter mendiagnosis *periampullary carcinoma*, pengode harus berkonsultasi dengan dokter untuk menentukan jenis kanker spesifik dari daftar di atas agar kode yang diberikan lebih detail dan akurat:

- Jika kanker terletak di duodenum bagian atas, gunakan kode C17.0 (*Malignant neoplasm of duodenum*).
- Jika kanker terletak di saluran empedu ekstrahepatik distal, gunakan kode C24.0 (*Malignant neoplasm of extrahepatic bile duct*).
- Jika kanker terletak di *ampulla of Vater*, gunakan kode C24.1 (*Malignant neoplasm of ampulla of Vater*).
- Jika kanker terletak di kepala pankreas, gunakan kode C25.0 (*Malignant neoplasm of head of pancreas*).

- Jika dokter tidak dapat menentukan lokasi spesifik, gunakan kode C26.8 (*Malignant neoplasm of overlapping lesion of digestive system*).

3.24.7 Tumor Hati (C22.-)

- Jika dokter mendiagnosis hepatoma atau hepatocellular carcinoma, gunakan kode C22.0 (*Liver cell carcinoma*).
- Jika dokter mendiagnosis *intrahepatic cholangiocarcinoma* atau cholangiocarcinoma, dan diagnosis didukung oleh hasil biopsi jaringan, gunakan kode C22.1 (*Intrahepatic bile duct carcinoma*). Namun, jika tidak ada hasil biopsi jaringan, gunakan kode C22.9 (*Malignant neoplasm of liver, unspecified*).
- Jika dokter hanya menyebutkan *liver tumour*, gunakan kode D37.6 (*Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of liver, gallbladder, and bile ducts*).
- Jika dokter hanya menyebutkan *liver mass*, gunakan kode K76.9 (*Liver disease, unspecified*).

3.24.8 Ewing's Sarcoma (C40-C41)

- Jika dokter mendiagnosis *Ewing's sarcoma* atau PNET, kode harus diberikan sesuai dengan organ yang disebutkan dalam diagnosis.
- Jika dokter menyatakan bahwa tumor berada di tulang panggul, gunakan kode C41.4 (*Malignant neoplasm of pelvic bones, sacrum, and coccyx*).
- Jika dokter menyatakan bahwa tumor berada di jaringan lunak lengan atas, gunakan kode C49.1 (*Malignant neoplasm of connective and soft tissue of upper limb, including shoulder*), kemudian tambahkan kode morfologi berikut:
 - M9260/3 *Ewing's sarcoma*
 - M9473/3 *Primitive neuroectodermal tumor*
 - M9364/3 *Peripheral neuroectodermal tumor*

3.24.9 Kanker Payudara (C50.-)

- *Breast mass*, gunakan kode N63 (*Unspecified lump in breast*).

- *Breast tumour*, gunakan kode D48.6 (*Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of breast*).
- Kanker payudara, gunakan kode dalam grup C50.- (*Malignant neoplasm of breast*), dengan rincian lokasi tumor di payudara.
- Tindakan operasi untuk kanker payudara di Indonesia umumnya dilakukan dalam dua metode:
 1. *Modified radical mastectomy*. Pengangkatan seluruh payudara termasuk kelenjar getah bening aksila, gunakan kode prosedur 85.43 (*Unilateral extended simple mastectomy*) tanpa perlu menggunakan kode *axillary lymph node dissection*.
 2. *Lumpectomy dengan radical excision of axillary lymph nodes*: Pengangkatan hanya pada bagian payudara yang terkena tumor ditambah pengangkatan kelenjar getah bening aksila, gunakan dua kode prosedur:
 - 85.22 *Resection of quadrant of breast*
 - 40.51 *Radical excision of axillary lymph nodes*

3.24.10 Kanker Serviks (C53.-)

Kode untuk kanker serviks berada dalam grup C53.- (*Malignant neoplasm of cervix uteri*), dengan rincian berdasarkan lokasi anatomi:

- C53.0 (*Endocervix*)
- C53.1 (*Exocervix*)
- C53.8 (*Overlapping lesion of cervix*)
- C53.9 (*Cervix uteri, unspecified*)

3.24.11 Kanker Uterus (C54-C55)

Kode dalam grup C54.- (*Malignant neoplasm of corpus uteri*) dibagi berdasarkan lokasi anatomi:

- C54.0 (*Isthmus uteri*)
- C54.1 (*Endometrium*)
- C54.2 (*Myometrium*)
- C54.3 (*Fundus uteri*)
- C54.8 (*Overlapping lesion of corpus uteri*)
- C54.9 (*Corpus uteri, unspecified*)

Jika dokter mendiagnosis kanker endometrium, gunakan kode C54.1 (*Malignant neoplasm of endometrium*). Jika kanker berasal dari miometrium, gunakan kode C54.2 (*Malignant neoplasm of myometrium*). Jika dokter tidak merinci lokasi spesifik, gunakan kode C55 (*Malignant neoplasm of uterus, part unspecified*).

Beberapa dokter menggunakan istilah CA corpus untuk merujuk pada kanker endometrium, tetapi ini tidak tepat. Jika diagnosis adalah CA corpus, petugas pengode harus memverifikasi apakah ada bukti tambahan, seperti hasil histopatologi, yang menunjukkan bahwa kanker berasal dari endometrium. Jika ya, gunakan kode C54.1 (*Malignant neoplasm of endometrium*); jika tidak, gunakan kode C54.9 (*Malignant neoplasm of corpus uteri, unspecified*).

Untuk *endometrial stromal sarcoma*, meskipun merupakan sarkoma, karena berasal dari endometrium (bukan miometrium), gunakan kode C54.1 (*Malignant neoplasm of endometrium*).

3.24.12 Neoplasma Ovarium (C56, D27, D39.1)

- Jika dokter mendiagnosis *ovarian tumour*, gunakan kode D39.1 (*Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of ovary*).
- Jika dokter mendiagnosis *ovarian cancer*, gunakan kode C56 (*Malignant neoplasm of ovary*).
- Jika dokter mendiagnosis *benign neoplasm of ovary*, gunakan kode D27 (*Benign neoplasm of ovary*).
- Jika dokter mendiagnosis tumor ovarium jenis *cystadenoma* dengan *borderline malignancy* atau *low malignant potential*, gunakan kode C56 (*Malignant neoplasm of ovary*).
- Pecahnya atau robeknya tumor ovarium tidak mempengaruhi pengodean.

3.24.13 Keganasan pada Lokasi Tidak Jelas (C76)

Pilih kode dalam grup C76.- (*Malignant neoplasm of other and ill-defined sites*) sesuai dengan area yang didiagnosis oleh dokter. Contohnya Jika dokter mendiagnosis kanker di rongga perut, gunakan

kode C76.2 (*Malignant neoplasm of other and ill-defined sites, abdomen*).

3.24.14 Pengodean Kanker Primer dan Sekunder

Dalam pengodean diagnosis neoplasma menggunakan ICD 10, penting untuk membedakan antara kanker primer dan kanker sekunder atau metastasis. Ketika pasien didiagnosis memiliki kanker metastasis, maka kode kanker metastasis digunakan sebagai diagnosis utama jika kondisi tersebut yang menjadi alasan pasien dirawat atau menjadi fokus utama perawatan. Sedangkan kode kanker primer digunakan sebagai diagnosis tambahan sesuai dengan lokasi kanker primernya. Jika lokasi kanker primernya tidak diketahui, maka gunakan kode C80.0 (*Malignant neoplasm, primary site unknown, so stated*).

3.24.14.1 Karsinomatosis Peritoneal (C78.6)

- Jika terdapat *peritoneal carcinomatosis* atau *carcinomatosis peritonei*, gunakan kode C78.6 (*Secondary malignant neoplasm of retroperitoneum and peritoneum*) sebagai kode utama, serta gunakan kode kanker primer sebagai kode tambahan. Jika dokter tidak mengetahui lokasi kanker primer, gunakan kode C80.0 (*Malignant neoplasm, primary site unknown, so stated*) sebagai kode tambahan.
- Jika terdapat *primary peritoneal carcinomatosis*, gunakan kode C48.2 (*Malignant neoplasm of peritoneum, unspecified*).

3.24.14.2 Meningitis Karsinomatosa (C79.3)

Jika terdapat *carcinomatous meningitis* atau *leptomeningeal carcinomatosis*, gunakan kode C79.3 (*Secondary malignant neoplasm of brain and cerebral meninges*) sebagai kode utama, dan gunakan kode kanker primer sebagai kode tambahan.

3.24.15 Exostosis (D16)

- Jika terdapat *exostosis*, gunakan kode dalam grup D16.- (*Benign neoplasm of bone and articular cartilage*), dengan memilih kode utama berdasarkan lokasi penyakit.
- Jika terdapat *congenital multiple exostoses*, *hereditary multiple exostoses*, atau *multiple osteochondromatosis*, gunakan kode Q78.6 (*Multiple congenital exostoses*).

3.24.16 Leiomyoma of Uterus (D25.-)

Kode untuk myoma uteri diberikan sesuai dengan jenis yang didiagnosis oleh dokter. Namun, karena sebagian besar kasus myoma uteri melibatkan lebih dari satu tumor dan lebih dari satu jenis, jika dokter mendiagnosis myoma uteri dengan lebih dari satu jenis, gunakan kode D25.7 (*Leiomyoma of uterus, multiple sites*) ^(IM) yang merupakan kode baru dalam ICD-10-IM sebagai diagnosis utama. Kemudian tambahkan D25.0 (*Submucous leiomyoma of uterus*), D25.1 (*Intramural leiomyoma of uterus*), atau D25.2 (*Subserosal leiomyoma of uterus*) sebagai diagnosis tambahan.

3.24.17 Craniopharyngioma (D35.3, D44.4)

- Jika dokter mendiagnosis *craniopharyngioma* dan pasien belum menjalani operasi, gunakan kode D44.4 (*Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of craniopharyngeal duct*).
- Jika pasien telah menjalani operasi dan hasil patologi menegaskan bahwa itu adalah *craniopharyngioma*, gunakan kode D35.3 (*Benign neoplasm of craniopharyngeal duct*).

3.24.18 Gestational Trophoblastic Tumour (D39.2)

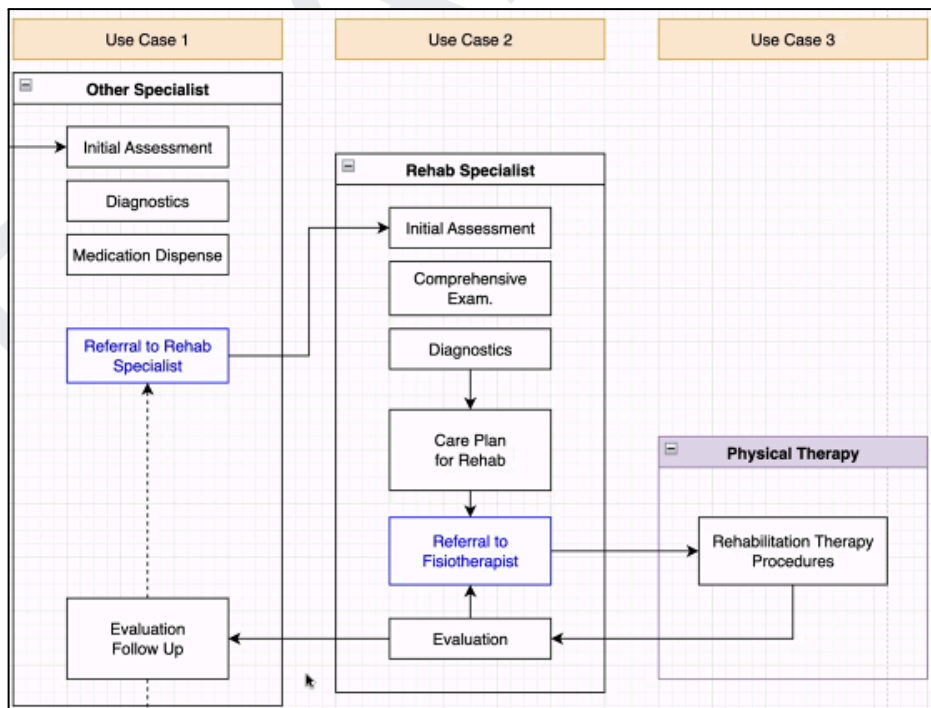
- Jika dokter mendiagnosis *gestational trophoblastic tumour (GTT)* atau *gestational trophoblastic neoplasia (GTN)*, baik metastatik maupun non-metastatik, atau persisten, termasuk *invasive hydatidiform mole* atau *chorioadenoma destruens*, gunakan kode D39.2 (*Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of placenta*).
- Jika dokter secara eksplisit mendiagnosis *choriocarcinoma*, gunakan kode C58 (*Malignant neoplasm of placenta*).

- Jika dokter hanya mendiagnosis *gestational trophoblastic disease (GTD)*, pengode harus berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis yang lebih spesifik agar dapat memberikan kode yang tepat.

3.25 MDC 35 REHABILITASI MEDIS

Kunjungan fisioterapi dalam satu hari yang sama dengan rehabilitasi medis memiliki iDRG yang berbeda dengan asesmen kunjungan awal maupun kontrol ulang pada poliklinik spesialis. Ketentuan rehabilitasi medis diatur sebagai berikut.

1. Kriteria pertama, pasien dalam satu hari yang sama berkunjung ke poliklinik spesialis untuk mendapatkan penegakan diagnosis dan terapi, kemudian dirujuk ke klinik rehabilitasi medis untuk konsultasi dan mendapatkan rekomendasi untuk fisioterapi.
2. Kriteria kedua, pasien yang dalam satu hari yang sama berkunjung ke klinik rehabilitasi medis untuk konsultasi dan mendapatkan layanan fisioterapi.
3. Kriteria ketiga, pasien yang berkunjung untuk mendapatkan layanan fisioterapi.
4. Kriteria keempat, pasien yang berkunjung ke klinik rehabilitasi untuk konsultasi dan/atau re-asesmen dan mendapatkan rekomendasi untuk fisioterapi.



Contoh kasus:

1. Pasien berkunjung ke klinik spesialis orthopedi dengan keluhan nyeri lutut memberat ketika beraktifitas. Dokter spesialis ortopedi mendiagnosis dengan OA Genu dan diberikan obat untuk mengurangi nyeri, foto lutut, cek darah lengkap, dan dirujuk ke dokter spesialis rehabilitasi medis pada hari yang sama.

Diagnosis Utama : OA Genu

Diagnosis Sekunder : konsultasi rehabilitasi medis

tindakan : Foto lutut, cek darah, dan konsultasi

Maka gunakan:

- Kode M17.9 (*Gonarthrosis, unspecified*) sebagai diagnosis utama
- Kode Z50.1 (*Other physical therapy*) sebagai diagnosis sekunder
- 89.07 (*Consultation, described as comprehensive*) sebagai kode tindakan
- 89.071 (*Other Specialist Consultation (IM)*) sebagai kode tindakan
- 90.59 (*Microscopic examination of blood, other microscopic examination*) sebagai kode tindakan
- 88.27 (*Skeletal x-ray of thigh, knee, and lower leg*) sebagai kode tindakan

2. Pasien berkunjung ke klinik spesialis rehabilitasi medis dengan keluhan nyeri tulang belakang setelah berkunjung ke dokter syaraf untuk dilakukan fisioterapi. Dokter spesialis rehabilitasi medis mendiagnosis LBP kemudian dilakukan uji fungsi dan asesmen untuk fisioterapi serta dilakukan tindakan US dan TENS di hari yang sama.

Diagnosis Utama : konsultasi rehabilitasi medis dan uji fungsi

Diagnosis Sekunder : LBP

tindakan : uji fungsi, fisioterapi US, dan TENS,

Maka gunakan:

- Kode Z50.1 (*Other physical therapy*) sebagai diagnosis utama
- Kode M54.5 (*Low back pain*) sebagai diagnosis sekunder
- 89.07 (*Consultation, described as comprehensive*) sebagai kode tindakan
- 93.01 (*Functional evaluation*) sebagai kode tindakan

- 93.35 (*Other heat therapy*) sebagai kode tindakan
 - 93.39 (*Other physical therapy*) untuk tindakan fisioterapinya.
3. Pasien berkunjung ke klinik fisioterapi setelah mendapatkan *advice* dari dokter rehabilitasi medis dengan keluhan nyeri tulang belakang untuk dilakukan tindakan US dan TENS.

Diagnosis Utama : fisioterapi

Diagnosis Sekunder : LBP

tindakan : US dan TENS

Maka gunakan:

- Kode Z50.1 (*Other physical therapy*) sebagai diagnosis utama
- Kode M54.5 (*Low back pain*) sebagai diagnosis sekunder
- 93.35 (*Other heat therapy*) sebagai kode tindakan
- 93.39 (*Other physical therapy*) sebagai kode tindakan

4. Pasien berkunjung ke klinik spesialis rehabilitasi medis dengan keluhan nyeri tulang belakang setelah berkunjung ke dokter syaraf untuk dilakukan fisioterapi. Dokter spesialis rehabilitasi medis mendiagnosis dengan LBP dan dilakukan uji fungsi dan asesmen untuk fisioterapi.

Diagnosis Utama : konsultasi rehabilitasi medis

Diagnosis Sekunder : LBP

tindakan : uji fungsi dan asesmen

Maka gunakan:

- Kode Z50.1 (*Other physical therapy*) sebagai diagnosis utama
- Kode M54.5 (*Low back pain*) sebagai diagnosis sekunder
- 93.01 (*Functional evaluation*) sebagai kode tindakan
- 89.07 (*Consultation, described as comprehensive*) sebagai kode tindakan

3.26 MDC 36 UNGROUPABLE ATAU UNRELATED

Ungroupable atau *unrelated* akan muncul ketika sistem grouper tidak bisa menemukan kecocokan antara kode diagnosis dan tindakan yang dimasukkan kedalam sistem. Sesuai dengan aturan pada ICD-10 diantaranya ada beberapa kode yang hanya bisa dipakai untuk laki-laki, perempuan, bayi baru lahir maupun berdasarkan rentang usia. Jika ditemukan ketidaksesuaian tersebut, maka sistem secara otomatis akan masuk ke MDC 36.

Dalam kondisi *error grouping* (*Ungroupable* atau *unrelated*), pengode (*coder*) dapat memperbaiki kesalahan tersebut dan menginputnya ke dalam sistem sesuai iDRG. Pengode (*coder*) diharapkan mampu menerapkan etika pengodingan sesuai dengan ICD-10 versi 2010 tidak hanya berdasarkan hafalan atau catatan dari kode yang sering muncul. Hal ini diharapkan mampu meminimalisir adanya *error grouping* karena yang paling sering terjadi, pengode (*coder*) tidak memasukkan *code also* atau *modifier* lain yang tidak berdampak signifikan pada *grouper* terdahulu.

3.26.1 Error Codes

3611199 *Primary Diagnosis code is not valid for Female or Male*

Error pada kasus ini terjadi karena kode yang dimasukkan tidak sesuai, yaitu terdapat ketidaksesuaian antara jenis kelamin pasien dan diagnosis yang dicatat. Perhatikan kesesuaian diagnosis dengan jenis kelamin, karena ada kode yang hanya bisa digunakan untuk satu jenis kelamin laki-laki atau perempuan saja.

Contoh:

MDC	Ungroupable or Unrelated
DRG	Primary Diagnosis code C56 is not valid for Male

atau

MDC	Ungroupable or Unrelated
DRG	Primary Diagnosis code N40 is not valid for Female

Apabila terjadi hal demikian, silahkan identifikasi terlebih dahulu apakah jenis kelamin pasien sudah sesuai dengan kode diagnosisnya:

- Jika jenis kelamin yang tidak sesuai, silahkan ganti terlebih dahulu jenis kelamin dalam sistemnya.
- Jika kode diagnosis yang kurang tepat, silahkan cek ke dokumen rekam medis dan konfirmasi terlebih dahulu kepada dokter untuk dilakukan perbaikan.

3611299 *Diagnosis code is not valid for patient's age*

Error pada kasus ini terjadi karena adanya kesalahan pemilihan kode diagnosis yang tidak sesuai dengan usia pasien. Perhatikan kesesuaian diagnosis dengan rentang usia, karena ada kode yang hanya bisa digunakan untuk usia <28 hari maupun rentang usia yang lain.

Contoh:

MDC	Ungroupable or Unrelated	36
DRG	Diagnosis code H25.9 is not valid for patient's age : 4 years 11322 1824 45290	3611299

Apabila terjadi hal demikian, silahkan cek terlebih dahulu kesesuaian usia pasien atau kode diagnosis yang kurang tepat:

- Jika data yang kurang tepat, silahkan perbaiki data pasiennya
- Jika kode diagnosis yang kurang tepat, silahkan cek ke dokumen rekam medis dan konfirmasi terlebih dahulu kepada dokter untuk dilakukan perbaikan.

3600019 *Unrelated OR Procedure*

Error pada kasus ini terjadi karena kode diagnosis yang dicatat tidak sesuai dengan tindakan medis yang diberikan. Perhatikan kesesuaian antara kode diagnosis dengan kode tindakan yang dipilih agar tidak terjadi *Unrelated OR Procedure*. Jika kombinasi antara diagnosis dan tindakan sudah sesuai, maka tidak akan terjadi *Unrelated OR Procedure*.

Contoh *Unrelated OR Procedure*:

Jika kode diagnosis N47.1 (*Phimosis*) ^(IM) dicantumkan sebagai diagnosis utama dengan kode prosedur berupa 58.0 (*Urethrotomy*) ^(IM), maka akan terjadi *Unrelated OR Procedure* seperti berikut:

MDC	Ungroupable or Unrelated
DRG	Unrelated OR Procedure

Contoh yang benar:

Jika kode diagnosis N47.1 (*Phimosis*)^(IM) dicantumkan sebagai diagnosis utama dengan kode prosedur berupa 64.0 (*Circumcision*)^(IM), maka tidak terjadi *Unrelated OR Procedure* seperti berikut:

MDC	Diseases and Disorders of the Male Reproductive System
DRG	Minor Penis Proc. w/ No CC

3614129 Error: Respiratory Drug Resistance TB w/o Drug Type

Error pada kasus ini terjadi karena kesalahan pengodean berupa kekurangan *code also* jenis obat resisten yang harus diperbaiki dengan cara melengkapi dengan kode sebagai berikut:

Drug Types

U82.20 (*Respiratory diseases with resistance of betalactamase (ESBL) resistance*)^(IM)

U82.80 (*Respiratory diseases with resistance of betalactam antibiotics*)^(IM)

U83.3 (*Respiratory diseases with resistance to other antibiotics*)^(IM)

U84.10 (*Respiratory diseases with resistance to antifungal drugs*)^(IM)

U84.20 (*Respiratory diseases with resistance to antiviral drugs*)^(IM)

U85.0 (*Respiratory diseases with resistance to antineoplastic drugs*)^(IM)

Contoh error:

Jika kode diagnosis A15.0 (*Tb lung confirm sputum microscopy with or without culture*) dicantumkan sebagai diagnosis utama dengan kode tambahan (*additional code*) berupa U84.31 (*Tuberculosis with multidrug resistance*)^(IM) tanpa menambahkan *code also* jenis obat resisten sebagai kode tambahan, maka akan terjadi *error* seperti berikut:

MDC	Ungroupable or Unrelated
DRG	Error: Respiratory Drug Resistance TB w/o Drug Type

Contoh yang benar:

copyright@ Pusat pembiayaan kesehatan Kemenkes RI.

Dilarang mengcopy atau memperjualbelikan isi dan dokumen ini dalam bentuk apapun

Jika kode diagnosis A15.0 (*Tb lung confirm sputum microscopy with or without culture*) dicantumkan sebagai diagnosis utama dengan kode tambahan (*additional code*) berupa U84.31 (*Tuberculosis with multidrug resistance*) ^(IM) dengan menambahkan *code also* jenis obat resisten berupa U83.3 (*Respiratory diseases with resistance to other antibiotics*) ^(IM) sebagai kode tambahan, maka tidak akan terjadi *error* seperti berikut:

MDC	Diseases and Disorders of the Respiratory System
DRG	Respiratory Drug Resistance TB

3614229 **Error: Respiratory Drug Resistance TB w/o Episode Type**

Error pada kasus ini terjadi karena kesalahan pengodean berupa kekurangan *code also* episode dari resisten yang harus diperbaiki dengan cara melengkapi dengan kode berikut:

TB Episode of Care

U84.31 (*Tuberculosis with multidrug resistance*) ^(IM)

U84.32 (*Tuberculosis with pre extreme drug resistance*) ^(IM)

U84.33 (*Tuberculosis with extreme drug resistance*) ^(IM)

U84.34 (*Tuberculosis with poly drug resistance*) ^(IM)

U84.35 (*Tuberculosis with mono drug resistance*) ^(IM)

Contoh error:

Jika kode diagnosis A15.0 (*Tb lung confirm sputum microscopy with or without culture*) dicantumkan sebagai diagnosis utama dengan kode tambahan (*additional code*) berupa U83.3 (*Respiratory diseases with resistance to other antibiotics*) ^(IM) tanpa menambahkan *code also* episode dari resisten sebagai kode tambahan, maka akan terjadi *error* seperti berikut:

MDC	Ungroupable or Unrelated
DRG	Error: Respiratory Drug Resistance TB w/o Episode Type

Contoh yang benar:

Jika kode diagnosis A15.0 (*Tb lung confirm sputum microscopy with or without culture*) dicantumkan sebagai diagnosis utama dengan kode tambahan (*additional code*) berupa U83.3 (*Respiratory diseases with resistance to other*

antibiotics) ^(IM) dengan menambahkan *code also* jenis obat resisten berupa berupa U84.31 (*Tuberculosis with multidrug resistance*) ^(IM) sebagai kode tambahan, maka tidak akan terjadi *error* seperti berikut:

MDC	Diseases and Disorders of the Respiratory System
DRG	Respiratory Drug Resistance TB

3615029 Error: Missing Code Also: Angiocardiography Proc.

Error pada kasus ini terjadi karena kesalahan pengodean berupa kekurangan *code also* prosedur angiokardiografi yang harus diperbaiki dengan cara melengkapi *coding* dengan kode berikut:

Angiocardiography Proc.

- 88.51 (*Angiocardiography of venae cavae*)
- 88.52 (*Angiocardiography of right heart structures*)
- 88.53 (*Angiocardiography of left heart structures*)
- 88.54 (*Combined right and left heart angiocardiography*)
- 88.55 (*Coronary arteriography using a single catheter*)
- 88.56 (*Coronary arteriography using two catheters*)
- 88.57 (*Other and unspecified coronary arteriography*)
- 88.58 (*Negative-contrast cardiac roentgenography*)

3615129 Error: Missing Code Also: Catheterization Proc.

Error pada kasus ini terjadi karena kesalahan pengodean berupa kekurangan *code also* prosedur kateterisasi yang harus diperbaiki dengan cara melengkapi *coding* dengan kode berikut:

Catheterization Procedures

- 37.21 (*Right heart cardiac catheterization*)
- 37.22 (*Left heart cardiac catheterization*)
- 37.23 (*Combined right and left heart cardiac catheterization*)

3615229 Error: Stent Insertion wo/ Number of Stent or Number of Vessels

Error pada kasus ini terjadi karena kesalahan pengodean berupa kekurangan *code also* dari prosedur pemasangan stent berupa jumlah stent yang

dipasang dan/atau jumlah pembuluh darah yang dilakukan tindakan dengan cara melengkapi kode berikut:

Number of Stents

- 00.45 (*Adjunct vascular system procedures, Insertion of one vascular stent*)
- 00.46 (*Adjunct vascular system procedures, Insertion of two vascular stents*)
- 00.47 (*Adjunct vascular system procedures, Insertion of three vascular stents*)
- 00.48 (*Adjunct vascular system procedures, Insertion of four or more vascular stents*)

Number of Vessels

- 00.40 (*Adjunct vascular system procedures, Procedure on single vessel*)
- 00.41 (*Adjunct vascular system procedures, Procedure on two vessels*)
- 00.42 (*Adjunct vascular system procedures, Procedure on three vessels*)
- 00.43 (*Adjunct vascular system procedures, Procedure on four or more vessels*)

Contoh error:

Jika kode diagnosis I25.1 (*Atherosclerotic heart disease*) dicantumkan sebagai diagnosis utama dengan kode prosedur utama berupa 00.66 (*Percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA) or coronary atherectomy*) dan menambahkan kode 36.07 (*Insertion of drug-eluting coronary artery stent(s)*) tanpa menambahkan *code also* dari prosedur pemasangan stent sebagai kode tambahan, maka akan terjadi *error* seperti berikut:

MDC	Ungroupable or Unrelated
DRG	Error coding: PTCA w/o Number of Vessels

Contoh yang benar:

Jika kode diagnosis I25.1 (*Atherosclerotic heart disease*) dicantumkan sebagai diagnosis utama dengan kode prosedur utama berupa 00.66 (*Percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA) or coronary atherectomy*) dan menambahkan kode 36.07 (*Insertion of drug-eluting coronary artery stent(s)*) dengan menambahkan *code also* dari prosedur pemasangan stent berupa kode 00.40 (*Adjunct vascular system procedures, Procedure on single vessel*) dan

kode 00.45 (*Adjunct vascular system procedures, Insertion of one vascular stent*) sebagai kode tambahan, maka tidak akan terjadi *error* seperti berikut:

MDC	Diseases and Disorders of the Circulatory System
DRG	PTCA (+Stent) w/ No CC

Jika kode diagnosis I25.1 (*Atherosclerotic heart disease*) sebagai diagnosis utama dicantumkan dengan kode prosedur utama berupa 00.66 (*Parcutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA) or coronary atherectomy*) dan menambahkan kode 36.07 (*Insertion of drug- eluting coronary artery stent(s)*) dengan menambahkan *code also* dari prosedur pemasangan stent berupa kode 00.40 (*Adjunct vascular system procedures, Procedure on single vessel*) sebagai kode tambahan tanpa menambahkan kode 00.45 (*Adjunct vascular system procedures, Insertion of one vascular stent*) sebagai kode tambahan karena tidak dilakukan pemasangan stent maka akan mendapatkan DRG PTCA seperti berikut:

MDC	Diseases and Disorders of the Circulatory System
DRG	PTCA w/ No CC

3615329 Error: Number of Stent wo/ Insertion Proc.

Error pada kasus ini terjadi karena kesalahan pengodean berupa kekurangan *code also* dari prosedur pemasangan stent dengan cara melengkapi *coding* dengan kode berikut:

Stents Insertion Procedure

00.55 (*Insertion of drug-eluting peripheral vessels stent(s)*)

39.90 (*Insertion of non-drug -eluting peripheral vessel stent(s)*)

3615429 Error: Angioplasty wo/ Number of Vessels

Error pada kasus ini terjadi karena kesalahan pengodean berupa kekurangan *code also* dari prosedur *angioplasty* berupa berapa banyak pembuluh darah yang dilakukan tindakan dengan cara melengkapi *coding* dengan kode berikut:

Number of Vessels

00.40 (*Adjunct vascular system procedures, Procedure on single vessel*)

00.41 (*Adjunct vascular system procedures, Procedure on two vessels*)

- 00.42 (Adjunct vascular system procedures, Procedure on three vessels)
- 00.43 (Adjunct vascular system procedures, Procedure on four or more vessels)

3615529 Error: Missing code also (00.56 or 00.57)

Error pada kasus ini terjadi karena kesalahan pengodean berupa kekurangan *code also* dari prosedur rangkaian pemasangan alat pacu jantung dengan cara melengkapi *coding* dengan kode berikut:

Implantation or Replacement of Defibrillator

- 00.56 (Insertion or replacement of implantable pressure sensor (lead) for intracardiac hemodynamic monitoring)
- 00.57 (Implantation or replacement of subcutaneous device for intracardiac hemodynamic monitoring)

3634819 Error blood transfusion for neoplasm without anemia

Error pada kasus ini terjadi karena kesalahan pengodean, yaitu tercantumnya kode tindakan untuk transfusi tanpa disertai input kode diagnosis anemia. Untuk memperbaikinya, perlu ditambahkan kode diagnosis anemia yang sesuai dengan kondisi keganasan dan diagnosis pasien.

Contoh error:

Jika kode diagnosis C20 (*Malignant neoplasm of rectum*) dicantumkan dengan kode prosedur berupa 99.04 (*Transfusion of packed cells*) tanpa disertai input kode diagnosis anemia sebagai kode diagnosis tambahan, maka akan terjadi *error* seperti berikut:

MDC	Ungroupable or Unrelated
DRG	Error blood transfusion for neoplasm without anemia

Contoh yang benar:

Jika kode diagnosis C20 (*Malignant neoplasm of rectum*) dicantumkan sebagai diagnosis utama dengan kode prosedur berupa 99.04 (*Transfusion of packed cells*) dengan disertai input kode diagnosis anemia berupa D63.0* (*Anaemia in neoplastic disease*) sebagai kode diagnosis tambahan, maka tidak akan terjadi *error* seperti berikut:

MDC	Neoplasm
DRG	Blood Transfusion for Neoplasm w/ Mild CC

36001x9 Ungroupable: Radiotherapy Session w/o Radiotherapy Proc

Error pada kasus ini terjadi karena kesalahan pengodean, yaitu terdapat kode diagnosis untuk radioterapi namun belum dilakukan input pada kode tindakan. Untuk memperbaikinya, tambahkan kode tindakan radioterapi yang sesuai dengan jenis radioterapi yang diberikan kepada pasien.

Therapeutic radiology

92.20 (*Infusion of liquid brachytherapy radioisotope*)

92.21 (*Superficial radiation*)

92.22 (*Orthovoltage radiation*)

92.23 (*Radioisotopic teleradiotherapy*)

92.24 (*Teleradiotherapy using photons*)

92.25 (*Teleradiotherapy using electrons*)

92.26 (*Teleradiotherapy of other particulate radiation*)

92.27 (*Implantation or insertion of radioactive elements*)

Contoh error:

Jika kode diagnosis Z51.0 (*Radiotherapy session*) dicantumkan sebagai diagnosis utama dengan kode diagnosis sekunder berupa C71.9 (*Malignant neoplasm, brain, unspecified*) tanpa disertai input kode tindakan radioterapinya, maka akan terjadi *error* seperti berikut:

MDC	Ungroupable or Unrelated
DRG	Ungroupable: Radiotherapy Session w/o Radiotherapy Proc.

Contoh yang benar:

Jika kode diagnosis Z51.0 (*Radiotherapy session*) dicantumkan sebagai diagnosis utama dengan kode diagnosis sekunder berupa C71.9 (*Malignant neoplasm, brain, unspecified*) dengan disertai input kode tindakan radioterapinya berupa 92.25 (*Teleraditherapy using electrons*), maka tidak akan terjadi *error* seperti berikut:

MDC	Neoplasm
DRG	Radiotherapy

36002x9 **Ungroupable: Radiotherapy w/o Z51.0**

Error pada kasus ini terjadi karena kesalahan pengkodean pada tindakan radioterapi berupa diagnosis radioterapi yang belum dilakukan input. Untuk memperbaiki kesalahan tersebut, tambahkan kode Z51.0 (*Radiotherapy Session*) seperti contoh diatas.

Contoh:

Jika kode diagnosis C71.9 (*malignant neoplasm, brain, unspecified*) dicantumkan sebagai diagnosis utama dengan menambahkan kode prosedur berupa 92.25 (*Teleradiotherapy using electrons*) tanpa menambahkan kode Z51.0 (*Radiotherapy session*) sebagai kode diagnosis sekunder, maka akan terjadi *error* seperti berikut:

MDC	Ungroupable or Unrelated
DRG	Ungroupable: Radiotherapy w/o Z51.0

36003x9 **Ungroupable: Chemotherapy Proc. without Z51.1**

Error pada kasus ini terjadi karena kesalahan pengodean, yaitu terdapat kode tindakan untuk kemoterapi namun kode diagnosis yang menyertainya belum dimasukkan. Untuk memperbaikinya, tambahkan kode diagnosis Z51.1 (*Chemotherapy Session for Neoplasm*) sesuai dengan prosedur yang dilakukan.

Contoh error:

Jika kode diagnosis C20 (*Malignant neoplasm of rectum*) dicantumkan sebagai diagnosis utama dengan menambahkan kode prosedur berupa 99.25 (*Injection or infusion of cancer chemotherapeutic substance*) tanpa disertai kode diagnosis Z51.1 (*Chemotherapy Session for Neoplasm*) sesuai dengan prosedur yang dilakukan, maka akan terjadi *error* seperti berikut:

MDC	Ungroupable or Unrelated
DRG	Ungroupable: Chemotherapy Proc. without Z51.1

Contoh yang benar:

Jika kode diagnosis C20 (*Malignant neoplasm of rectum*) dicantumkan sebagai diagnosis utama dengan menambahkan kode prosedur berupa 99.25 (*Injection or*

infusion of cancer chemotherapeutic substance) dengan ditambahkan kode diagnosis Z51.1 (*Chemotherapy Session for Neoplasm*) sebagai diagnosis tambahan sesuai dengan prosedur yang dilakukan, maka akan terjadi *error* seperti berikut:

MDC	Neoplasm
DRG	Chemotherapy (Injection)

3635129 Ungroupable: Rehabilitation without Procedures

Error pada kasus ini terjadi karena kesalahan pengodean berupa kekurangan kode dari tindakan rehabilitasi medis yang harus diperbaiki dengan cara melengkapi dengan kode berikut sesuai dengan tindakan yang diberikan kepada pasien:

Functional Diagnostic & Evaluation

- 88.79 (*Other diagnostic ultrasound*)
- 89.22 (*Cystometrogram*)
- 89.23 (*Urethral sphincter electromyogram*)
- 89.24 (*Uroflowmetry (UFR)*)
- 89.25 (*Urethral pressure profile (UPP)*)
- 89.34 (*Digital examination of rectum*)
- 89.37 (*Vital capacity determination*)
- 89.38 (*Other nonoperative respiratory measurements*)
- 89.41 (*Cardiovascular stress test using treadmill*)
- 89.42 (*Masters' two-step stress test*)
- 89.43 (*Cardiovascular stress test using bicycle ergometer*)
- 93.01 (*Functional evaluation*)
- 93.02 (*Orthotic evaluation*)
- 93.03 (*Prosthetic evaluation*)
- 93.04 (*Manual testing of muscle function*)
- 93.05 (*Range of motion testing*)
- 93.06 (*Measurement of limb length*)
- 93.08 (*Electromyography*)
- 93.09 (*Other diagnostic physical therapy procedure*)

Orthotic Prosthetic Proc.

- 84.40 *(Implantation or fitting of prosthetic limb device, not otherwise specified)*
- 84.41 *(Fitting of prosthesis of upper arm and shoulder)*
- 84.42 *(Fitting of prosthesis of lower arm and hand)*
- 84.43 *(Fitting of prosthesis of arm, not otherwise specified)*
- 84.45 *(Fitting of prosthesis above knee)*
- 84.46 *(Fitting of prosthesis below knee)*
- 84.47 *(Fitting of prosthesis of leg, not otherwise specified)*
- 93.23 *(Fitting of orthotic device)*
- 93.52 *(Application of neck support)*
- 93.53 *(Application of other cast)*
- 97.13 *(Replacement of other cast)*

Therapeutic Exercise Procedures

- 93.11 *(Assisting exercise)*
- 93.12 *(Other active musculoskeletal exercise)*
- 93.13 *(Resistive exercise)*
- 93.14 *(Training in joint movements)*
- 93.17 *(Other passive musculoskeletal exercise)*
- 93.18 *(Breathing exercise)*
- 93.19 *(Exercise, not elsewhere classified)*
- 93.22 *(Ambulation and gait training)*
- 93.24 *(Training in use of prosthetic or orthotic device)*
- 93.27 *(Stretching of muscle or tendon)*
- 93.28 *(Stretching of fascia)*
- 93.29 *(Other forcible correction of deformity)*
- 93.31 *(Assisted exercise in pool)*
- 93.32 *(Whirlpool treatment)*
- 93.33 *(Other hydrotherapy)*
- 93.36 *(Cardiac retraining)*
- 93.37 *(Prenatal training)*
- 93.38 *(Combined physical therapy without mention of the components)*

Therapeutic Procedures with Modality

- 93.34 (*Diathermy*)
- 93.35 (*Other heat therapy*)
- 99.27 (*Iontophoresis*)
- 99.81 (*Hypothermia (central) (local)*)
- 99.82 (*Ultraviolet light therapy*)
- 99.83 (*Other phototherapy*)

Therapeutic Manipulation Procedures

- 76.95 (*Other manipulation of temporomandibular joint*)
- 93.15 (*Mobilization of spine*)
- 93.16 (*Mobilization of other joints*)
- 93.21 (*Manual and mechanical traction*)
- 93.25 (*Forced extension of limb*)
- 93.26 (*Manual rupture of joint adhesions*)
- 93.61 (*Osteopathic manipulative treatment for general mobilization*)
- 93.62 (*Osteopathic manipulative treatment using high-velocity, low-amplitude forces*)
- 93.63 (*Osteopathic manipulative treatment using low-velocity, high-amplitude forces*)
- 93.64 (*Osteopathic manipulative treatment using isotonic, isometric forces*)
- 93.65 (*Osteopathic manipulative treatment using indirect forces*)
- 93.66 (*Osteopathic manipulative treatment to move tissue fluids*)
- 93.67 (*Other specified osteopathic manipulative treatment*)
- 99.93 (*Rectal massage (for levator spasm)*)

Interventional Rehabilitation Procedures

- 03.96 (*Percutaneous denervation of facet*)
- 04.2 (*Destruction of cranial and peripheral nerves*)
- 81.91 (*Arthrocentesis*)
- 93.91 (*Intermittent positive pressure breathing (IPPB)*)

Other Rehabilitation Procedures

- 93.39 (*Other physical therapy*)
- 93.54 (*Application of splint*)
- 93.59 (*Other immobilization, pressure, and attention to wound*)

- 93.71 (*Dyslexia training*)
- 93.72 (*Dysphasia training*)
- 93.73 (*Esophageal speech training*)
- 93.74 (*Speech defect training*)
- 93.75 (*Other speech training and therapy*)
- 93.89 (*Rehabilitation, not elsewhere classified*)
- 93.94 (*Respiratory medication administered by nebulizer*)
- 93.99 (*Other respiratory procedures*)
- 94.51 (*Referral for psychotherapy*)
- 97.88 (*Removal of external immobilization device*)

Contoh error:

Jika kode diagnosis Z50.1 (*Other physical therapy*) dicantumkan sebagai diagnosis utama dengan menambahkan kode diagnosis sekunder berupa M54.59 (*Low back pain, site unspecified*) tanpa disertai kode dari tindakan rehabilitasi medis, maka akan terjadi *error* seperti berikut:

MDC	Ungroupable or Unrelated
DRG	Ungroupable: Rehabilitation without Procedures

Contoh yang benar:

Jika kode diagnosis Z50.1 (*Other physical therapy*) dicantumkan sebagai diagnosis utama dengan menambahkan kode diagnosis sekunder berupa M54.59 (*Low back pain, site unspecified*) dengan disertai kode dari tindakan rehabilitasi medis berupa 93.32 (*Whirlpool treatment*), maka tidak akan terjadi *error* seperti berikut:

MDC	Rehabilitation
DRG	Therapeutic Exercise Procedures

3.27 MDC 90 PROSEDUR DIAGNOSIS

MDC 90 mencakup kelompok tindakan penunjang medis dan diagnosis yang dilakukan di layanan rawat jalan. Semua prosedur diagnosis yang memiliki tarif signifikan dikelompokkan menjadi satu grup.

Pada penggunaan kontras untuk tindakan CT scan dan MRI, untuk membedakan dengan atau tanpa kontras dibuat kode IM 99.290 (*Injection Of Contrast Agent*).

Contoh 1-90	Seorang pasien paruh baya hilang kesadaran sesaat setelah jatuh dari tempat tidur. dicurigai ada perdarahan otak dilakukan CT Scan kepala dengan kontras	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	-	-
Diagnosis Sekunder	-	-
Prosedur	CT Scan kepala kontras	87.03 <i>Computerized axial tomography of head</i> ditambah kode kontrasnya 99.290 <i>Injection Of Contrast Agent</i> .

Contoh 2-90	Seorang pasien paruh baya hilang kesadaran sesaat setelah jatuh dari tempat tidur. dicurigai ada perdarahan otak dilakukan MRI kepala dengan kontras	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	-	-
Diagnosis Sekunder	-	-
Prosedur	MRI kepala kontras	88.91 <i>Magnetic resonance imaging of brain and brain stem</i> ditambah kode kontrasnya 99.290 <i>Injection Of Contrast Agent</i> .

Tata cara pemberian kode untuk pasien yang dilakukan SPECT atau PET CT dibedakan menggunakan kode farmakoterapinya. Berikut merupakan daftar kode radiofarmaka :

SPECT CT	KND0101	Tc-99m-Pertechnetate
SPECT CT	KND0102	Tc-99m-DTPA
SPECT CT	KND0103	Tc-99m-MAG3
SPECT CT	KND0104	Tc-99m-DMSA

copyright@ Pusat pembiayaan kesehatan Kemenkes RI.

Dilarang mengcopy atau memperjualbelikan isi dan dokumen ini dalam bentuk apapun

SPECT CT	KND0105	Tc-99m-SestaMIBI
SPECT CT	KND0106	Tc-99m-Tetrofosmin
SPECT CT	KND0107	Tc-99m-MDP
SPECT CT	KND0108	Tc-99m-RBC
SPECT CT	KND0109	Tc-99m-MAA
SPECT CT	KND0110	Tc-99m-Pyrophosphate
SPECT CT	KND0111	Tc-99m-HMPAO
SPECT CT	KND0112	Tc-99m-ECD
SPECT CT	KND0113	Tc-99m-Ethambutol
SPECT CT	KND0114	Tc-99m-HIDA
SPECT CT	KND0115	Tc-99m-Mebrofenin
SPECT CT	KND0115	Tc-99m-Sulfur Colloid
SPECT CT	KND0116	Tc-99m-Nano Colloid
SPECT CT	KND0117	Tc-99m-Colloid
SPECT CT	KND0118	Tc-99m-Phyton
SPECT CT	KND0119	Tc-99m-Human Serum Albumin
SPECT CT	KND0120	Tc-99m-Ciprofloxacin
SPECT CT	KND0121	Tc-99m-UBI
SPECT CT	KND0122	Tc-99m-WBC
SPECT CT	KND0123	Tc-99m-Trodat
SPECT CT	KND0124	Tc-99m-PSMA
SPECT CT	KND0125	Other Pharmaceuticals
SPECT CT	KND0201	Na-I-131
SPECT CT	KND0202	I-131-mIBG
SPECT CT	KND0203	Other Pharmaceuticals
SPECT CT	KND0301	Na-I-123
SPECT CT	KND0302	I-123-mIBG
SPECT CT	KND0303	I-123-ioflupane
SPECT CT	KND0304	Other Pharmaceuticals
SPECT CT	KND0401	Lu-177-PSMA
SPECT CT	KND0402	Lu-177-DOTATATE
SPECT CT	KND0403	Lu-177-DOTATOC
SPECT CT	KND0404	Lu-177-DOTANOC
SPECT CT	KND0405	Other Pharmaceuticals
SPECT CT	KND0501	Ga-67-Citrate
SPECT CT	KND0502	Other Pharmaceuticals
SPECT CT	KND06	Thalium-201 (Tl-201)
SPECT CT	KND07	Indium-111 (In-111)
PET CT	KND0801	F-18-FDG
PET CT	KND0802	F-18-PSMA

PET CT	KND0803	F-18-FDOPA
PET CT	KND0804	F-18-FMISO
PET CT	KND0805	Na-F-18
PET CT	KND0806	Other Pharmaceuticals
PET CT	KND0901	Ga-68-PSMA
PET CT	KND0902	Ga-68-DOTATATE
PET CT	KND0903	Ga-68-DOTATOC
PET CT	KND0904	Ga-68-DOTANOC
PET CT	KND0905	Ga-68-FAPI
PET CT	KND0906	Other Pharmaceuticals
PET CT	KND10	NH3-Ammonia
PET CT	KND11	Rubidium-82 (Rb-82) - Chloride

Contoh 3.90	Seorang pasien akan dilakukan SPECT CT parathyroid menggunakan Thallium-201 (Tl-201)	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	-	-
Diagnosis Sekunder	-	-
Prosedur	SPECT CT parathyroid	92.13 <i>Parathyroid scan</i> ditambah dengan kode radiofarmakanya KND06 Thallium-201 (Tl-201)

Contoh 4.90	Seorang pasien akan dilakukan PET Scan parathyroid menggunakan Rubidium-82 (Rb-82) - Chloride	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	-	-
Diagnosis Sekunder	-	-

Prosedur	PET Scan parathyroid	92.13 <i>Parathyroid scan</i> ditambah dengan kode radiofarmakanya KND11 Rubidium-82 (Rb-82) - Chloride
-----------------	----------------------	---

Sedangkan untuk Radioimmunoassay (RIA) diberikan kode :

92.50 (*Non-Imaging Nuclear Medicine Thyroid Function Test (IM)*)

92.51 (*Non-Imaging Nuclear Medicine Thyroid Cancer Marker (IM)*)

92.52 (*Non-Imaging Nuclear Medicine Thyroid Antibody Test (IM)*)

Contoh 5.90	Seorang pasien akan dilakukan pemeriksaan RIA untuk memeriksa <i>Thyroid Cancer Marker</i>	
	Diagnosis Dokter	Koder Memberi Kode
Diagnosis Primer	-	-
Diagnosis Sekunder	-	-
Prosedur	RIA <i>Thyroid Cancer Marker</i>	92.51 <i>Non-Imaging Nuclear Medicine Thyroid Cancer Marker (IM)</i>